Material de estudo e consulta

SOS Farmácia Comercial

Material de estudo e consulta para alunos do 9º e 10º semestres de Farmácia e farmacêuticos recém-formados. Catorze módulos da rotina da farmácia comercial, cada um com resumo para leitura, mapas mentais e material de apoio.

1. Legislação farmacêutica

2. Portaria 344/98 e medicamentos controlados

3. RDC 471/2021: antimicrobianos

4. Medicamentos termolábeis e boas práticas de armazenamento

5. Passo a passo do SNGPC

6. Vigilância sanitária na farmácia: balanços, BMPO e relação mensal

7. Procedimentos operacionais padrão

8. Organização de prateleiras, validade e etiquetagem

9. Registro no Ministério da Saúde (código MS) e DCB

10. Trier Sistemas: o software de gestão por dentro

11. Serviços clínicos na farmácia comercial

12. Medicamentos isentos de prescrição

13. Calculadora de dose

14. Bulário

Módulo 1

Legislação farmacêutica

Hierarquia das normas e órgãos que regulam a farmácia comercial; Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974, Lei 6.360/1976 e Decreto 8.077/2013, Lei 6.437/1977, Lei 13.021/2014, genéricos e intercambialidade (Lei 9.787/1999, RDC 16/2007, RDC 58/2014), RDC 44/2009, AFE (RDC 275/2019), fracionamento, propaganda e venda remota, preços (Lei 10.742/2003, CMED) e CDC, LGPD e ética profissional (Res. CFF 724/2022 e 721/2022), conferidos em outubro de 2026.

- Hierarquia das normas e órgãos reguladores
- Comércio farmacêutico: Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974
- Registro, rotulagem e infrações sanitárias
- Lei 13.021/2014: a farmácia como unidade de saúde
- Genéricos, similares e intercambialidade
- Boas práticas, documentos e comercialização
- Preço de medicamentos e direitos do consumidor
- LGPD na farmácia
- Ética profissional e responsabilidade técnica

Hierarquia das normas e órgãos reguladores

A farmácia comercial obedece a um conjunto grande de normas, editadas por órgãos diferentes. Quem entende a hierarquia sabe qual regra prevalece quando duas parecem conflitar, a quem recorrer em caso de dúvida e quem pode fiscalizar e punir. A lógica é simples: a norma de nível inferior regulamenta a superior e não pode contrariá-la.

Hierarquia das normas

Nível	Quem edita	Exemplos na farmácia
Constituição Federal (1988)	Congresso, como poder constituinte	Saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196); SUS executa a vigilância sanitária (art. 200, II); defesa do consumidor (art. 5º, XXXII)
Lei federal	Congresso Nacional, com sanção do Presidente	Lei 5.991/1973, Lei 6.360/1976, Lei 6.437/1977, Lei 9.787/1999, Lei 13.021/2014, CDC, LGPD
Decreto	Presidente da República, para regulamentar lei	Decreto 74.170/1974 (regulamenta a Lei 5.991), Decreto 8.077/2013 (regulamenta a Lei 6.360), Decreto 85.878/1981 (atribuições do farmacêutico)
Resolução e instrução normativa da Anvisa	Diretoria Colegiada da Anvisa	RDC 44/2009 (boas práticas), RDC 275/2019 (AFE), RDC 96/2008 (propaganda), IN 285/2024 (lista de MIP)
Portaria	Ministério da Saúde e suas secretarias	Portaria SVS/MS 344/1998 (controlados), atualizada por RDC
Resolução de conselho profissional	Conselho Federal de Farmácia (CFF)	Res. CFF 724/2022 (Código de Ética), Res. CFF 721/2022 (responsabilidade técnica)
Norma estadual e municipal	Assembleias, câmaras, secretarias de saúde	Código sanitário, validade da licença, plantão por rodízio, regras locais de licenciamento

Duas consequências práticas. Primeiro, uma RDC não pode criar obrigação que contrarie lei; quando a lei muda, a RDC precisa ser lida à luz da nova redação. Segundo, as resoluções do CFF regulam o **exercício profissional** do farmacêutico, e não o funcionamento sanitário do estabelecimento. Uma resolução do CFF pode punir eticamente o profissional, mas quem interdita a loja é a vigilância sanitária.

Estados e municípios também legislam. A Constituição dá competência concorrente à União, aos estados e ao Distrito Federal sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII) e permite ao município legislar sobre assunto local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II). A Lei 5.991/1973 confirma esse desenho: o licenciamento é feito pelo órgão sanitário estadual conforme a legislação supletiva local (art. 21) e o plantão por rodízio segue normas estaduais e municipais (art. 56).

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é o conjunto de órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que regulam, normatizam, controlam e fiscalizam produtos e serviços de interesse da saúde (Lei 9.782/1999, art. 1º). A mesma lei criou a Anvisa, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde (art. 3º), a quem compete, entre outras coisas, autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação e de comercialização de medicamentos (art. 7º, VII). Daí vem a AFE da farmácia.

Órgão	Papel	O que significa para a farmácia
Anvisa	Coordena o SNVS, edita RDC e IN, registra medicamentos, concede AFE e AE	Define as regras nacionais de boas práticas, controlados, antimicrobianos e propaganda
VISA estadual e municipal	Licencia e inspeciona os estabelecimentos	Emite a licença (alvará) sanitária, inspeciona a loja, lavra auto de infração
CFF	Órgão supremo dos conselhos, edita resoluções e o Código de Ética (Lei 3.820/1960, arts. 2º e 6º)	Define atribuições e deveres éticos do farmacêutico
CRF	Registra profissionais, fiscaliza o exercício da profissão e pune infrações (Lei 3.820/1960, art. 10)	Emite a certidão de regularidade e verifica a presença do farmacêutico
CMED	Regula o mercado de medicamentos e fixa critérios de preço (Lei 10.742/2003, arts. 5º e 6º)	Publica o PMC; exige lista de preços à disposição do consumidor
Procon e ANPD	Defesa do consumidor; proteção de dados pessoais	Preço, informação, cadastro com CPF, uso de dados de saúde

O QUE DIZ A NORMA

"O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (Lei 9.782/1999, art. 1º).

Duas fiscalizações diferentes

A vigilância sanitária fiscaliza o **estabelecimento e os produtos**: estrutura, armazenamento, documentos, dispensação, receitas, escrituração. O CRF fiscaliza o **exercício profissional**: se há farmacêutico habilitado, se ele está presente no horário declarado, se cumpre o Código de Ética. Quando a VISA encontra infração ética, comunica o CRF (Lei 5.991/1973, art. 52). O CRF, por sua vez, envia às autoridades competentes os fatos que não sejam de sua alçada (Lei 3.820/1960, art. 10, c).

Somente quem está inscrito no CRF pode exercer atividade farmacêutica (Lei 3.820/1960, art. 13), e a empresa que explora serviço que exige farmacêutico precisa provar ao conselho que a atividade é

exercida por profissional habilitado e registrado (art. 24). Os temas de controlados e antimicrobianos têm módulos próprios (ver os módulos da Portaria 344/98 e da RDC 471/2021).

NO BALCÃO

Diante de uma regra que você não conhece, faça três perguntas: qual é a norma, quem a editou e se ela segue vigente. O texto consolidado das normas da Anvisa fica no AnvisaLegis; leis e decretos, no portal do Planalto; resoluções do CFF, no Diário Oficial da União e no site do conselho. Apostila e grupo de mensagens não são fonte.

CASO

Fiscal do CRF chega às 20h e encontra a drogaria aberta só com balconistas. A farmacêutica declarou ao CRF o horário das 8h às 18h. A loja responde perante a VISA por funcionar sem farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 6º, I), e a profissional não cometeu falta ética, porque o horário descoberto não era o dela. O problema está na escala: faltava um segundo farmacêutico anotado no CRF para cobrir o horário estendido (Res. CFF 721/2022, art. 3º).

Comércio farmacêutico: Lei 5.991/1973 e Decreto 74.170/1974

A Lei 5.991/1973 é a lei-base do comércio de medicamentos. Ela define os tipos de estabelecimento, diz quem pode dispensar, trata da responsabilidade técnica, do licenciamento e do receituário. Seu regulamento é o Decreto 74.170/1974, que segue em vigor com alterações. Parte dos dispositivos foi revogada ou ganhou nova redação ao longo de 50 anos, por isso a leitura deve ser feita no texto compilado do Planalto.

Definições que caem em prova

Estabelecimento	Definição legal (art. 4º)	Pode manipular?	Dispensa medicamento?
Farmácia	Manipulação de fórmulas magistrais e oficinais e comércio de drogas, medicamentos, insumos e correlatos, incluindo dispensação (inciso X)	Sim	Sim
Drogaria	Dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos e correlatos em suas embalagens originais (inciso XI)	Não	Sim, em embalagem original
Ervanaria	Dispensação de plantas medicinais (inciso XII)	Não	Só plantas medicinais
Posto de medicamentos e unidade volante	Venda exclusiva de industrializados em embalagem original, de relação oficial, em localidade sem farmácia ou drogaria (inciso XIII)	Não	Só os da relação

Estabelecimento	Definição legal (art. 4º)	Pode manipular?	Dispensa medicamento?
Dispensário de medicamentos	Setor de fornecimento de industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar (inciso XIV)	Não	Só aos pacientes da unidade

A Lei 13.021/2014 manteve a mesma divisão com outros nomes: farmácia sem manipulação ou drogaria e farmácia com manipulação (art. 3º, parágrafo único). **Dispensação** é o ato de fornecer ao consumidor drogas, medicamentos, insumos e correlatos, remunerado ou não (Lei 5.991/1973, art. 4º, XV).

> **O QUE DIZ A NORMA**
>
> "A dispensação de medicamentos é privativa de: a) farmácia; b) drogaria; c) posto de medicamento e unidade volante; d) dispensário de medicamentos." (Lei 5.991/1973, art. 6º). O comércio de drogas, medicamentos e insumos é privativo das empresas e estabelecimentos definidos na lei (art. 5º).

O que a drogaria pode vender e fazer

- Medicamentos industrializados em embalagem original, isentos ou sob prescrição, inclusive controlados, conforme as atividades da AFE e da licença.
- Correlatos permitidos por lei: aparelhos e acessórios, produtos para diagnóstico, higiene pessoal e de ambiente, cosméticos, perfumes, dietéticos, produtos óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários (Lei 5.991/1973, art. 5º, §1º; Decreto 74.170/1974, art. 4º).
- Medicamentos fracionados a partir de embalagem fracionável (Decreto 74.170/1974, art. 9º, parágrafo único, redação do Decreto 5.775/2006; RDC 80/2006, art. 1º).
- Serviços farmacêuticos previstos na RDC 44/2009 e indicados na licença sanitária (art. 61, §§3º e 4º).

A drogaria **não** manipula, não pode captar receitas de fórmulas magistrais e oficinais para outra empresa, nem mesmo para filial da mesma rede (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50), e não dispensa plantas medicinais, privativas de farmácias e ervanarias (Lei 5.991/1973, art. 7º). Para comércio de alimentos e serviços, a RDC 275/2019 remete à RDC 44/2009 e à IN 9/2009 (art. 7º). Artigos de conveniência dependem também de lei estadual; a resposta muda conforme o estado.

Supermercados: Lei 15.357/2026

A Lei 15.357, de 20 de março de 2026, acrescentou os §§2º a 7º ao art. 6º da Lei 5.991/1973. Ela permite instalar farmácia ou drogaria **na área de venda de supermercados**, em ambiente delimitado, segregado e exclusivo, operada diretamente pelo supermercado ou por contrato com farmácia licenciada. As exigências são as mesmas de qualquer farmácia:

- presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (§3º);
- controlado só é entregue após o pagamento, ou vai do balcão ao caixa em embalagem lacrada, inviolável e identificável (§4º);

- é vedado oferecer medicamento em bancadas, estandes ou gôndolas fora do espaço da farmácia (§5º);
- aplicam-se integralmente a Lei 5.991/1973, a Lei 13.021/2014 e a Lei 6.360/1976 (§7º).

A mesma lei permitiu que farmácias e drogarias licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para logística e entrega, desde que cumpram a regulamentação sanitária (§6º). Supermercado sem farmácia instalada continua sem poder vender medicamento: a dispensação segue privativa dos estabelecimentos do art. 6º.

Licença, endereço e funcionamento

Regra	Artigo da Lei 5.991/1973
Comércio e dispensação só por estabelecimento licenciado pelo órgão sanitário estadual, conforme legislação supletiva	Art. 21
Pedido de licença instruído com constituição da empresa, contrato com o responsável técnico e prova de habilitação expedida pelo CRF	Art. 22
Validade da licença fixada pela autoridade sanitária local conforme o risco das atividades	Art. 25 (redação da Lei 13.097/2015)
Mudança de endereço exige licença prévia	Art. 28
Estabelecimento fechado por mais de 120 dias tem a licença cancelada	Art. 33
Filial é considerada autônoma para licenciamento e responsabilidade	Art. 34
Proibido usar dependência da farmácia como consultório ou para fim diverso do licenciado	Art. 55
Plantão obrigatório por rodízio, conforme norma estadual e municipal	Art. 56

Receituário na lei

A receita só será aviada se estiver escrita no vernáculo, sem abreviações, legível, com nomenclatura e pesos e medidas oficiais; com nome e endereço do paciente e modo de usar; e com data, assinatura, endereço e inscrição do profissional no conselho (art. 35, I a III, redação da Lei 14.063/2020). O receituário vale em todo o território nacional, inclusive o de controlados, nos termos da regulação (§1º). Receita eletrônica exige assinatura eletrônica avançada ou qualificada, e a de controlados exige a qualificada (§§2º e 3º). Quando a dose ultrapassar os limites farmacológicos ou houver incompatibilidade, o responsável técnico solicita confirmação expressa ao prescritor (art. 41).

NO BALCÃO

Cliente apresenta receita de clínica de outro estado. A origem não invalida a receita (art. 35, §1º). Confira os requisitos do art. 35 e, se for controlado, as regras próprias da Portaria 344/98 e da RDC 1.000/2025 (ver o módulo da Portaria 344/98).

CASO

Uma drogaria de bairro recebe de uma cliente a receita de uma pomada manipulada e oferece "mandar fazer" na farmácia de manipulação parceira, devolvendo o produto pronto no dia seguinte. A prática é captação de receita magistral, vedada mesmo entre filiais da mesma empresa (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50). O correto é orientar a cliente a levar a receita diretamente a uma farmácia com manipulação.

Registro, rotulagem e infrações sanitárias

Antes de chegar à prateleira, o medicamento passa por duas exigências: a empresa precisa estar autorizada e o produto precisa estar registrado. Essas regras estão na Lei 6.360/1976, a lei da vigilância sanitária de produtos. As punições por descumprir qualquer norma sanitária estão na Lei 6.437/1977.

Lei 6.360/1976 e seu regulamento

A lei submete à vigilância sanitária medicamentos, drogas, insumos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes (art. 1º). Só empresas autorizadas e com estabelecimento licenciado podem fabricar, fracionar, embalar, armazenar ou expedir esses produtos (art. 2º). O regulamento vigente é o **Decreto 8.077/2013**, que revogou o antigo Decreto 79.094/1977 (art. 25). Ele exige autorização da Anvisa e licenciamento local para o funcionamento das empresas (art. 2º) e remete à Lei 6.437/1977 a responsabilização por infração (art. 24).

O QUE DIZ A NORMA

"Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde." (Lei 6.360/1976, art. 12). Hoje o registro é concedido pela Anvisa, com prazo de renovação definido por ela, não superior a 10 anos (art. 12, §1º).

Dispositivo	O que regula	Ponto que cai no balcão
Art. 3º, XX a XXV	Definições de similar, genérico, referência, intercambiável, bioequivalência e biodisponibilidade	Base legal da troca de medicamento (tópico de genéricos)
Art. 12	Registro prévio obrigatório	Produto sem registro não pode ser exposto nem vendido
Art. 57, §1º	DCB ou DCI com letras de tamanho nunca inferior à metade do nome comercial, inclusive em material promocional	Ajuda o cliente a identificar o princípio ativo
Art. 57, §2º	Rótulos que se diferenciem e inibam erro de dispensação	Embalagens parecidas exigem conferência dupla
Art. 57, §3º	Alerta para substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem (Lei 14.806/2024)	Orientar atletas que perguntam sobre doping

Dispositivo	O que regula	Ponto que cai no balcão
Art. 58, §1º	Propaganda de medicamento sob prescrição restrita a publicações para médicos, dentistas e farmacêuticos	Cartaz de tarjado na vitrine é irregular
Art. 59	Proíbe rotulagem ou propaganda que induza a erro sobre natureza, composição ou finalidade	Atenção a produtos com promessas terapêuticas
Art. 79	Informes de acidentes ou reações nocivas devem ser transmitidos à autoridade sanitária	Notificar no VigiMed

Consultar o registro é rotina simples: o número aparece na embalagem e pode ser conferido na consulta de medicamentos do portal da Anvisa, que informa titular, apresentações, categoria de venda e situação do registro. Isso resolve dúvidas sobre produto importado, cancelado ou vendido por fornecedor desconhecido.

Lei 6.437/1977: infrações e penalidades

Essa lei tipifica as infrações à legislação sanitária federal e fixa as penas. As regras de classificação, valores de multa e prazos do processo administrativo estão detalhadas no módulo da Portaria 344/98. Aqui interessam as infrações mais comuns no comércio farmacêutico.

Art. 10	Conduta	Exemplo na farmácia
I e IV	Fazer funcionar estabelecimento ou comercializar produto sem licença, registro ou autorização, ou contrariando a legislação	Loja aberta com licença vencida; venda de produto sem registro
X	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora	Recusar acesso ao estoque ou aos registros
XI	Aviar receita em desacordo com a prescrição ou com a norma	Trocar medicamento fora das regras de intercambialidade
XII	Vender medicamento que depende de prescrição sem observar essa exigência	Venda de tarjado sem receita
XVIII	Expor à venda ou entregar produto vencido, ou apor nova data	Vencido misturado ao estoque de venda
XXV e XXVI	Exercer profissão de saúde sem habilitação ou confiar o encargo a pessoa não habilitada	Balconista que indica e dispensa como se fosse farmacêutico
XXIX	Transgredir outras normas legais e regulamentares de proteção da saúde	Descumprir a RDC 44/2009 (art. 99 da própria RDC remete à Lei 6.437/1977)

As penas vão de advertência e multa a apreensão e inutilização de produto, interdição, cancelamento de autorização e de licença, aplicadas de forma isolada ou cumulativa (art. 2º). A responsabilidade sanitária não exclui a civil, a penal e a ética. O mesmo fato pode gerar auto de infração da VISA, processo ético no CRF e ação do consumidor.

ATENÇÃO

Produto vencido na área de venda é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII) e produto impróprio ao consumo pelo CDC (Lei 8.078/1990, art. 18, §6°, I). Além disso, a RDC 44/2009 proíbe dispensar medicamento cuja posologia não possa ser concluída dentro do prazo de validade (art. 51, §2°).

NO BALCÃO

Representante oferece lote de dermocosmético "importado direto" a preço muito baixo, sem nota fiscal. Recuse: o Código de Ética manda recusar produto sem registro ou notificação na Anvisa, sem rastreabilidade ou sem documento fiscal (Res. CFF 724/2022, art. 15, II), e a compra configura infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, IV).

Lei 13.021/2014: a farmácia como unidade de saúde

A Lei 13.021/2014 trata do exercício e da fiscalização das atividades farmacêuticas. Ela mudou o modo como a lei enxerga a farmácia: deixou de ser apenas um ponto de comércio e passou a ser uma unidade de prestação de serviços de saúde. Tramitou no Congresso de 1993 a 2014 (PL 41/1993 no Senado) e foi sancionada com vetos.

O QUE DIZ A NORMA

"Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos." (Lei 13.021/2014, art. 3°)

Dispositivos principais

Artigo	Conteúdo	Consequência prática
Art. 2°	Define assistência farmacêutica: ações e serviços para assistência terapêutica integral, com o medicamento como insumo essencial e visando ao uso racional	Base para os serviços clínicos na farmácia comercial
Art. 3°, parágrafo único	Classifica as farmácias em sem manipulação (drogaria) e com manipulação	Drogaria passa a ser uma espécie de farmácia
Art. 5°	Farmácia de qualquer natureza exige responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado	Não há farmácia sem farmacêutico
Art. 6°	Exige autorização e licenciamento, presença do farmacêutico durante todo o horário (I), localização sanitária conveniente (II), equipamentos para imunobiológicos (III) e equipamentos exigidos pela vigilância (IV)	Escala de farmacêuticos cobre 100% do horário

Artigo	Conteúdo	Consequência prática
Art. 7º	Farmácias podem dispor de medicamentos, vacinas e soros conforme o perfil epidemiológico da região	Fundamento para vacinação em farmácia, com a regulação sanitária própria
Art. 10	Farmacêutico e proprietário agem solidariamente pelo uso racional	Responsabilidade compartilhada
Art. 11	O proprietário não pode desautorizar ou desconsiderar orientações técnicas do farmacêutico; deve dar condições de trabalho	Meta de venda não se sobrepõe à decisão técnica
Art. 12	Na baixa do farmacêutico, contratar outro em até 30 dias	Prazo para substituir o profissional que saiu
Art. 13	Deveres do farmacêutico: notificar reações adversas e intoxicações, manter cadastro técnico, acompanhamento e perfil farmacoterapêutico, orientar o paciente	Farmacovigilância e orientação são obrigações legais
Art. 14	Na dispensação, observar os aspectos técnicos e legais do receituário	Conferência da receita é dever do farmacêutico
Art. 16	Fiscal farmacêutico não pode ser RT, proprietário ou sócio de estabelecimento farmacêutico	Imparcialidade da fiscalização

Vetos e o que ficou de fora

A Mensagem de veto nº 232/2014 vetou quatro artigos. Conhecer o veto ajuda a entender por que algumas regras que circulam como "previstas na lei" não existem.

Dispositivo vetado	O que dizia	Razão do veto
Art. 9º	Somente farmácias poderiam dispensar medicamentos, cosméticos com indicação terapêutica, fórmulas e fitoterápicos	Restringiria postos e dispensários em regiões isoladas; o conceito de cosmético com indicação terapêutica não existe na legislação
Art. 15	Fiscalização dos estabelecimentos exercida pelo fiscal farmacêutico	Interferiria na competência sanitária de estados e municípios
Art. 17	Postos, dispensários e unidades volantes teriam 3 anos para virar farmácia	Mesma razão do art. 9º
Art. 18	Vigência na data da publicação	Dar 45 dias de adaptação

Por causa do veto ao art. 9º, postos de medicamentos e dispensários continuam regidos pela Lei 5.991/1973. Por causa do veto ao art. 15, a fiscalização sanitária segue com a VISA; o CRF fiscaliza o exercício profissional.

Logo após a sanção, a Medida Provisória 653/2014 incluiu um parágrafo no art. 6º que estendia às farmácias enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte o art. 15 da Lei 5.991/1973 (técnico responsável). A MP não foi convertida em lei e sua vigência se encerrou; o texto compilado registra o dispositivo como sem vigência.

Relação com a Lei 5.991/1973

A Lei 13.021/2014 não revogou a Lei 5.991/1973; as duas convivem. Onde há sobreposição, a lei mais nova e mais específica orienta a leitura. A Lei 5.991/1973 ainda admite o funcionamento por até 30 dias sem responsável técnico ou substituto, período em que não podem ser vendidos medicamentos sujeitos a controle especial nem aviadas fórmulas (art. 17). A Lei 13.021/2014 exige farmacêutico presente durante todo o horário (art. 6º, I) e dá 30 dias para contratar novo profissional após a baixa (art. 12). Na prática da VISA e do CRF, a loja sem farmacêutico no horário está irregular.

PONTO-CHAVE

A lei chama a farmácia de unidade de assistência à saúde e impõe ao farmacêutico deveres clínicos (art. 13). Na fiscalização e na prova, a pergunta central costuma ser se havia farmacêutico presente, se ele orientou e se notificou o que devia notificar.

NO BALCÃO

O gerente pede para "segurar" a recusa de uma venda de antigripal a um hipertenso descompensado, porque a loja está abaixo da meta. A decisão técnica é sua: o proprietário não pode desautorizar a orientação do farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 11). Explique ao cliente o motivo, ofereça alternativa segura e registre o atendimento.

CASO

A única farmacêutica de uma drogaria pede demissão e sai no mesmo dia. O dono quer manter a loja aberta "vendendo só o que não precisa de receita" até contratar outra. A Lei 5.991/1973 proíbe vender controlados nesse intervalo (art. 17), mas a Lei 13.021/2014 exige farmacêutico durante todo o horário (art. 6º, I), inclusive para dispensar MIP. A conduta correta é contratar farmacêutico substituto ou reduzir o horário, comunicar o CRF e a VISA e contratar o novo RT em até 30 dias (art. 12).

Genéricos, similares e intercambialidade

A troca de um medicamento por outro na farmácia é ato regulado. Ela só é permitida entre produtos cuja equivalência terapêutica foi comprovada à Anvisa, e só o farmacêutico pode fazê-la. A Lei 9.787/1999 criou o medicamento genérico, alterando a Lei 6.360/1976, e mandou a Anvisa regulamentar inclusive os critérios de dispensação, "respeitada a decisão expressa de não intercambialidade do profissional prescritor" (art. 2º, IV).

Definições legais

Tipo	Definição (Lei 6.360/1976, art. 3º)	Como reconhecer na embalagem
Referência	Produto inovador registrado e comercializado no país, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas no registro (XXII)	Nome comercial; consta da lista de referência da Anvisa
Genérico	Similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende intercambiável, geralmente produzido após a expiração da patente, designado pela DCB ou DCI (XXI)	Sem nome comercial; identificado pela DCB, com a faixa amarela e a letra G
Similar	Mesmos princípios ativos, concentração, forma, via, posologia e indicação do registrado, podendo diferir em tamanho, forma, validade, embalagem, rotulagem e excipientes; sempre com nome comercial ou marca (XX, redação da Lei 13.235/2015)	Nome comercial
Similar intercambiável	Similar cujos estudos de equivalência farmacêutica, bioequivalência ou bioisenção foram aprovados pela Anvisa (RDC 58/2014, art. 2º)	Bula com a frase "MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA" (RDC 58/2014, art. 6º)

Produto farmacêutico intercambiável é o equivalente terapêutico de um referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança (art. 3º, XXIII). **Bioequivalência** é a demonstração de equivalência farmacêutica com biodisponibilidade comparável no mesmo desenho experimental (XXIV); **biodisponibilidade** indica velocidade e extensão da absorção (XXV).

Quais trocas são permitidas

Medicamento prescrito	Pode ser trocado por	Não pode ser trocado por
Referência, pelo nome comercial	Genérico correspondente; similar intercambiável com aquele referência	Similar não intercambiável; outro princípio ativo, dose ou forma
Genérico	Referência correspondente	Similar, mesmo intercambiável
Similar intercambiável, pelo nome comercial	Referência correspondente	Genérico; outro similar
Similar não intercambiável	Nenhum	Qualquer outro

Receita escrita pela DCB permite dispensar o genérico ou o medicamento de referência correspondente (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 2.3 e 2.3.1).

A intercambialidade é sempre estabelecida em relação ao **referência**. Genérico e similar intercambiável foram comparados ao referência, e não entre si. Por isso a Anvisa informa que a troca entre genérico e similar não é possível. A relação de similares intercambiáveis fica na consulta de medicamentos do portal da Anvisa, atualizada diariamente. A RDC 58/2014 não se aplica aos MIP (art. 1º, §2º).

O QUE DIZ A NORMA

"Será permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor" e, nesses casos, "o profissional farmacêutico deverá indicar a substituição realizada na prescrição, apor seu carimbo a seu nome e número de inscrição do Conselho Regional de Farmácia, datar e assinar" (RDC 16/2007, Anexo I, item VI, 2.1 e 2.2).

Quem pode trocar e como registrar

- **Quem**: o farmacêutico. O balconista não decide troca; a substituição é avaliação técnica do receituário (Lei 13.021/2014, art. 14; Decreto 85.878/1981, art. 1º, I).
- **Com quem**: com o usuário. O Código de Ética garante o direito de "realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato" (Res. CFF 724/2022, art. 12, IX).
- **Quando não**: se o prescritor vetou a troca. A manifestação de não intercambialidade é feita por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, de próprio punho, sem outras formas de impressão (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3).
- **Registro**: anotar a troca na receita, com carimbo, nome, CRF, data e assinatura (VI, 2.2), e orientar o paciente sobre a dispensação feita (VI, 2.4).

No SUS, prescrições e compras de medicamentos usam obrigatoriamente a DCB (Lei 9.787/1999, art. 3º). Nos serviços privados, o prescritor escolhe entre DCB e nome comercial (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.2). A farmácia deve manter à disposição dos usuários, em local visível, a lista atualizada de genéricos divulgada pela Anvisa (RDC 44/2009, art. 42, §1º).

ATENÇÃO

Trocar fora dessas regras é aviar receita em desacordo com a prescrição, infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XI). Exemplos de troca proibida: amoxicilina por cefalexina, comprimido por suspensão, similar não intercambiável por referência. Medicamento biológico não tem genérico, e a propaganda de biológico não pode comparar preços (RDC 96/2008, art. 11, §3º).

NO BALCÃO

Antes de oferecer a troca: confira se a receita tem veto de próprio punho, consulte a lista da Anvisa quando houver similar, mostre ao cliente as opções e o preço, deixe que ele escolha e registre a troca no verso da receita. A troca também se aplica a antimicrobianos, com o mesmo registro (ver o módulo da RDC 471/2021).

CASO

Receita particular de losartana potássica 50 mg pelo nome de marca do referência, sem restrição de troca. O cliente pergunta se pode levar um similar mais barato. O farmacêutico consulta o portal da Anvisa: o similar consta como intercambiável com aquele referência. Explica a diferença, o cliente escolhe o similar, e o farmacêutico anota a substituição na receita com carimbo, CRF, data e assinatura. Se a receita trouxesse o nome comercial de um similar e o cliente pedisse o genérico, a troca não seria possível.

Boas práticas, documentos e comercialização

As boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias estão na **RDC 44/2009**. Em outubro de 2026 ela consta no AnvisaLegis como vigente com alterações, entre elas as da RDC 41/2012 (MIP em autosserviço), da RDC 786/2023 (serviços e exames) e da RDC 812/2023 (venda remota de controlados). Não há norma substituta publicada até esta data. Infraestrutura, POPs e inspeção são tratados no módulo de procedimentos operacionais padrão; aqui ficam os documentos e as regras de comercialização.

Documentos do estabelecimento

Documento	Quem emite	Base legal	Observação
Autorização de Funcionamento (AFE)	Anvisa	RDC 44/2009, art. 2º, I; RDC 275/2019	Por estabelecimento; vale a partir da publicação no DOU
Autorização Especial (AE)	Anvisa	RDC 44/2009, art. 2º, II; RDC 275/2019, art. 2º, II	Só para farmácia que manipula substâncias da Portaria 344/98
Licença ou alvará sanitário	VISA estadual ou municipal	RDC 44/2009, art. 2º, III; Lei 5.991/1973, art. 21	Afixada em local visível; lista as atividades autorizadas
Certidão de Regularidade Técnica	CRF	RDC 44/2009, art. 2º, IV; Res. CFF 721/2022, art. 8º	Afixada; nome e horário de todos os farmacêuticos e do substituto
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	O próprio estabelecimento	RDC 44/2009, arts. 2º, V, e 85	Específico da loja, com POPs (art. 86)

Quando AFE, licença e certidão não trazem todos os dados, a loja afixa cartaz com razão social, CNPJ, número da AFE e da AE, nome e CRF do RT e dos substitutos, horário de cada farmacêutico e telefones do CRF e da VISA (RDC 44/2009, art. 2º, §2º).

AFE e AE: RDC 275/2019

A RDC 275/2019 rege a concessão, alteração e cancelamento da AFE e da AE de farmácias e drogarias. A AFE é ato privativo da Anvisa que autoriza o funcionamento (art. 2º, I); a AE autoriza a farmácia de manipulação a trabalhar com substâncias da Portaria 344/98 (art. 2º, II). Drogaria que só dispensa controlado industrializado opera com AFE. Pontos de prova:

- A AFE não permite atividade que não esteja na licença local; as atividades só podem ser executadas se também constarem da licença (art. 4º, §§4º e 5º).
- A Anvisa tem 30 dias para analisar o pedido de concessão; sem manifestação, a concessão é automática, sem impedir análise e cancelamento posteriores (art. 5º).
- O atesto de conformidade sanitária é do órgão sanitário local (art. 6º).
- Mudança de razão social, endereço, RT, representante legal e redução de atividades são alterações de implementação imediata após o protocolo, desde que contempladas na licença (art. 13, §1º).
- Quem vende pela internet informa o endereço do site na AFE (RDC 44/2009, art. 55).

Exposição e dispensação

Medicamentos ficam em área de circulação restrita aos funcionários; os isentos de prescrição podem ficar ao alcance do usuário em autosserviço (RDC 44/2009, art. 40, §§1º e 2º, redação da RDC 41/2012), agrupados por princípio ativo e identificados pela DCB, separados dos demais produtos, com o cartaz "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41). Os detalhes do autosserviço estão no módulo de MIP.

Na dispensação, medicamento sob prescrição só sai com a receita (art. 43); o farmacêutico avalia legibilidade, paciente, medicamento, posologia, duração, data e prescritor (art. 44) e não dispensa receita ilegível ou que induza a erro (art. 45). A intercambialidade, o fracionamento e os controlados seguem normas específicas (arts. 47 a 49).

Fracionamento: RDC 80/2006

Farmácias e drogarias podem fracionar medicamentos a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para isso, garantidas as características do produto registrado (RDC 80/2006, art. 1º). O fracionamento **não** se aplica a controlados (art. 1º, parágrafo único) e é responsabilidade do farmacêutico (art. 5º). A apresentação da prescrição é condição essencial, exceto para MIP, que podem ser fracionados sob orientação do farmacêutico (art. 8º e §§1º e 2º). Os procedimentos de rotulagem e prevenção de trocas estão no módulo de POPs.

Propaganda e publicidade: RDC 96/2008

- Propaganda de medicamento sob prescrição só em meios destinados a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar (art. 27; Lei 6.360/1976, art. 58, §1º).
- Programas de fidelidade da farmácia não podem usar medicamento como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio, e o regulamento deve informar essa restrição (art. 10).
- Comparação de preços dirigida ao consumidor só entre intercambiáveis (art. 11); ao anunciar desconto, informar também o preço integral (art. 11, §4º).
- Empresas não podem dar brindes ou vantagens a prescritores, dispensadores e balconistas (art. 5º).

Venda remota e entrega em domicílio

Só farmácia ou drogaria **aberta ao público**, com farmacêutico presente durante todo o horário, pode dispensar medicamento pedido por telefone ou internet; o estoque tem de estar em farmácia aberta ao público (RDC 44/2009, art. 52, caput e §3º). Medicamento sob prescrição exige apresentação e avaliação

da receita pelo farmacêutico (§1º). Controlado pedido a distância é vedado, salvo as permissões da legislação específica (§2º, redação da RDC 812/2023). Essa legislação é a própria RDC 812/2023, que incluiu na Portaria 344/98 os arts. 34-A e 34-B sobre a entrega remota de controlados, com regras próprias (ver o módulo da Portaria 344/98).

Exigência	Artigo da RDC 44/2009
Pedido pelo site da própria farmácia ou rede, domínio ".com.br"	Art. 53, caput e §1º
Página principal com razão social, CNPJ, endereço, horário, telefone, RT e CRF, licença, AFE e AE	Art. 53, §1º, I a V
Proibida oferta de medicamento em site que não pertença a farmácia ou drogaria licenciada	Art. 53, §2º
Sem imagem, propaganda ou promoção de tarjado no site; lista de preços só com nome, DCB, apresentação, registro, detentor e preço	Art. 54
Transporte sob responsabilidade da farmácia, com controle de temperatura e POP	Art. 56
Canal direto com o farmacêutico e cartão com nome, telefone e endereço junto ao produto	Art. 58
Sigilo dos dados; vedado usá-los para promover consumo de medicamentos	Art. 59

A Lei 15.357/2026 autorizou a farmácia licenciada a contratar plataformas digitais para **logística e entrega**, mantida a regulamentação sanitária (Lei 5.991/1973, art. 6º, §6º). A interpretação de como isso convive com o art. 53 da RDC 44/2009 ainda depende de posicionamento da Anvisa; até lá, a dispensação, a avaliação da receita e a responsabilidade continuam da farmácia licenciada.

NO BALCÃO

Pedido por aplicativo de amoxicilina com foto da receita. Antes de separar o produto, o farmacêutico avalia a receita e confirma como a via original será retida no ato da entrega, conforme a regra do antimicrobiano (ver o módulo da RDC 471/2021). Junto com o pacote vai o cartão com nome do farmacêutico e telefone da loja (RDC 44/2009, art. 58, §2º).

CASO

Na renovação da licença, a VISA constata que a drogaria aplica injetáveis, mas a licença lista só dispensação. O serviço é irregular, porque só são regulares os serviços indicados no licenciamento (RDC 44/2009, art. 61, §3º), e a AFE não supre a falta da atividade na licença (RDC 275/2019, art. 4º, §4º). A farmácia suspende o serviço, pede a inclusão na licença e atualiza a AFE.

Preço de medicamentos e direitos do consumidor

O preço do medicamento no Brasil é regulado. A **Lei 10.742/2003** criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que define critérios de preço e de margem de comercialização para fabricantes, distribuidores, farmácias e drogarias (arts. 5º e 6º, II e V). O ajuste anual segue um modelo de

teto baseado no IPCA, num fator de produtividade e num fator de ajuste de preços relativos (art. 4º, §§1º a 4º).

Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor

Sigla	O que é	Quem deve respeitar
PF	Preço Fábrica: teto de venda do laboratório e do distribuidor	Indústria e distribuidoras
PMC	Preço Máximo ao Consumidor: teto de venda na farmácia, que varia conforme a alíquota de ICMS do estado	Farmácias e drogarias

Para 2026, a Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026, autorizou ajuste máximo a partir de 31 de março de 3,81% no nível 1, 2,47% no nível 2 e 1,13% no nível 3, tendo como referência o PF publicado na lista da CMED (arts. 2º e 3º). O ajuste é teto: a farmácia pode cobrar menos e conceder desconto. Alguns grupos, como homeopáticos, fitoterápicos e parte dos MIP, seguem critérios próprios da CMED; a lista publicada no portal da Anvisa mostra os preços de cada apresentação.

O QUE DIZ A NORMA

"As unidades de comércio varejista deverão manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas, não podendo ser superiores aos preços publicados pela CMED no Portal da Anvisa." E a divulgação do PMC "deverá contemplar os diferentes preços decorrentes da incidência das cargas tributárias do [...] ICMS praticadas nos estados de destino" (Resolução CM-CMED nº 4/2026, art. 6º e parágrafo único).

Descumprir ato da CMED sujeita o infrator às sanções administrativas do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 10.742/2003, art. 8º). Cobrar acima do PMC é a infração mais comum no varejo, e acontece quando o sistema da loja não é atualizado depois do ajuste ou quando se usa a tabela de outro estado.

Código de Defesa do Consumidor no balcão

Regra	Base legal	Aplicação na farmácia
Informação adequada e clara sobre produto, preço e riscos	CDC, art. 6º, III; art. 31	Preço visível; orientação sobre uso e riscos faz parte do produto
Proteção contra publicidade enganosa e práticas abusivas	CDC, art. 6º, IV	Promessa de cura, "leve 3" de medicamento
Vedado condicionar a venda de um produto a outro (venda casada)	CDC, art. 39, I	Exigir compra de vitamina para vender o antibiótico

Regra	Base legal	Aplicação na farmácia
Vedado prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor por idade, saúde ou condição social	CDC, art. 39, IV	Empurrar produto caro a idoso confuso
Produto vencido ou alterado é impróprio ao consumo	CDC, art. 18, §6º, I e II	Troca imediata; vencido não pode estar à venda
Cadastro não solicitado deve ser comunicado por escrito; consumidor tem acesso aos seus dados	CDC, art. 43, caput e §2º	Cadastro de fidelidade e de desconto
Preço por etiqueta, código de barras ou relação de preços; havendo divergência, vale o menor	Lei 10.962/2004, arts. 2º, 3º e 5º	Gôndola com um preço e caixa com outro: cobra-se o menor
Desconto por forma de pagamento deve ser informado em local visível	Lei 10.962/2004, art. 5º-A	Preço diferente para PIX ou cartão
Exemplar do CDC em local visível e de fácil acesso	Lei 12.291/2010, art. 1º	Item conferido pelo Procon

O direito à informação do CDC e o dever de orientar da Lei 13.021/2014 (art. 13, VI) se somam. Orientação insuficiente sobre uso e riscos pode gerar responsabilidade civil da farmácia, além da ética do profissional.

ATENÇÃO

Desconto em medicamento não pode virar estímulo ao uso. A RDC 96/2008 proíbe usar medicamento como prêmio ou pontuação em programa de fidelidade (art. 10) e só permite comparação de preço ao consumidor entre intercambiáveis (art. 11).

NO BALCÃO

Cliente reclama que o preço do caixa está acima do da etiqueta. Cobre o menor (Lei 10.962/2004, art. 5º). Se reclamar de preço alto, mostre a lista de preços da CMED com o PMC do seu estado; ela precisa estar disponível na loja (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º).

CASO

Fiscal do Procon pede a lista de preços de uma drogaria em abril. O sistema ainda usa a tabela de PMC do ano anterior, e dois produtos estão acima do PMC vigente porque a loja aplicou um ajuste maior que o autorizado para o nível 3. A drogaria responde pelas sanções do CDC (Lei 10.742/2003, art. 8º) e precisa corrigir o preço e atualizar a lista.

LGPD na farmácia

A **Lei Geral de Proteção de Dados** (LGPD, Lei 13.709/2018) vale para toda pessoa física ou jurídica que trata dados pessoais. A farmácia trata dados o dia inteiro: cadastro de cliente, CPF no caixa, receitas, registros de serviços farmacêuticos, escrituração de controlados, programas de desconto, entrega em domicílio. A autoridade fiscalizadora passou a se chamar Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com a MP 1.317/2025, convertida na Lei 15.352/2026.

Conceitos aplicados

Conceito (art. 5º)	Na farmácia
Dado pessoal: informação de pessoa identificada ou identificável (I)	Nome, CPF, telefone, endereço, e-mail
Dado pessoal sensível: inclui dado referente à saúde (II)	Receita, medicamento comprado, resultado de glicemia, pressão aferida
Controlador: quem decide sobre o tratamento (VI)	A empresa dona da farmácia
Encarregado: canal entre controlador, titulares e ANPD (VIII)	Pessoa indicada pela empresa, com contato público (art. 41)
Tratamento: qualquer operação com dados (X)	Coletar, consultar, guardar, enviar ao laboratório, apagar

O histórico de compras de medicamentos revela informação de saúde. Por isso as regras de dado sensível se aplicam a qualquer tratamento que revele dados sensíveis e possa causar dano ao titular (art. 11, §1º). Saber que alguém compra antirretroviral, antidepressivo ou anticoncepcional é saber algo sobre a saúde dessa pessoa.

Bases legais mais usadas

Situação	Base legal possível	Artigo
Retenção e escrituração de receita de controlado e de antimicrobiano	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	Art. 11, II, a
Registro de serviço farmacêutico (aferição, acompanhamento)	Tutela da saúde por profissional ou serviço de saúde; a RDC 44/2009 exige consentimento expresso para esse registro (art. 64, §1º)	Art. 11, II, f
Cadastro em programa de desconto ou de fidelidade com histórico de compras	Consentimento específico e destacado, para finalidade específica	Art. 11, I
Envio de ofertas por mensagem	Consentimento; dados de saúde não podem ser usados para induzir consumo de medicamento	Art. 7º, I; RDC 44/2009, art. 59, parágrafo único

O QUE DIZ A NORMA

"É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde [...] em benefício dos interesses dos titulares de dados", para permitir a portabilidade pedida pelo titular ou as transações financeiras e administrativas desses serviços (LGPD, art. 11, §4º, redação da Lei 13.853/2019).

CPF no balcão e programas de desconto

Fora das situações em que a norma sanitária manda identificar o comprador (controlados, por exemplo), o CPF pedido no caixa serve a uma finalidade comercial: desconto, programa de fidelidade, programa de benefício do laboratório. Os princípios da finalidade, necessidade e transparência (art. 6º, I, III e VI) pedem que o cliente saiba para que o dado será usado, com quem será compartilhado e por quanto tempo será guardado (art. 9º). O consentimento precisa ser para finalidade determinada; autorização genérica é nula (art. 8º, §4º), e pode ser revogado a qualquer momento (art. 8º, §5º).

- Explique a finalidade antes de pedir o CPF e informe se o dado será compartilhado com laboratório ou administradora do programa.
- Não condicione a venda do medicamento ao cadastro; o desconto do programa é uma oferta, e o cliente pode recusar.
- Não fale em voz alta o nome do medicamento, o diagnóstico ou o CPF do cliente na fila.
- Atenda o pedido do titular: confirmação, acesso, correção, eliminação dos dados tratados com consentimento, informação sobre compartilhamento e revogação (art. 18).
- Confira se o seu estado ou município tem lei própria sobre a exigência de CPF no comércio.

Segurança, incidentes e sanções

A farmácia deve adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acesso não autorizado, perda ou vazamento (art. 46) e comunicar à ANPD e ao titular incidente de segurança que possa causar risco ou dano relevante (art. 48). As sanções vão de advertência a multa simples de até 2% do faturamento no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração, além de publicização da infração e bloqueio ou eliminação dos dados (art. 52). No plano profissional, o Código de Ética proíbe fornecer a terceiros dados que identifiquem paciente, prescritor ou estabelecimento em desacordo com a LGPD (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII) e impõe o sigilo (art. 15, VI). A RDC 44/2009 manda tratar com sigilo os dados dos serviços farmacêuticos (art. 82).

NO BALCÃO

Login e senha do sistema e do certificado digital são pessoais. Emprestar a senha do SNGPC ou o certificado a um colega é proibido pelo Código de Ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XXIX) e deixa rastro de acesso no seu nome.

CASO

Um laboratório propõe à rede pagar por relatório mensal com CPF dos clientes e medicamentos de uso contínuo comprados, para "ações de adesão". O farmacêutico RT alerta que se trata de compartilhamento de dados de saúde para vantagem econômica, vedado fora das exceções da lei (LGPD, art. 11, §4º), e que fornecer dados identificáveis a terceiros é falta ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII). A alternativa possível é relatório anonimizado ou programa em que o próprio paciente adere com consentimento específico.

Ética profissional e responsabilidade técnica

A ética do farmacêutico está no **Código de Ética da Profissão Farmacêutica**, aprovado pela Resolução CFF 724/2022, que também traz o Código de Processo Ético e as regras de sanção. Ela revogou a Resolução CFF 711/2021 e segue em vigor em outubro de 2026, citada como vigente em resoluções do CFF publicadas em 2026. A responsabilidade técnica é regulada pela Resolução CFF 721/2022, que revogou a Resolução CFF 577/2013.

Atividades privativas

O Decreto 85.878/1981 regulamenta a Lei 3.820/1960 e lista as atribuições privativas do farmacêutico. Para a farmácia comercial, as que importam são a dispensação ou manipulação de fórmulas quando a serviço do público (art. 1º, I) e o assessoramento e a responsabilidade técnica em depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza (art. 1º, II, d). O art. 2º lista atividades afins, não privativas, como análises clínicas e fabricação de cosméticos.

O QUE DIZ A NORMA

"São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: I - desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada" (Decreto 85.878/1981, art. 1º, I).

Direção técnica, assistência e substituição

Função	O que é	Base
Diretor ou responsável técnico (RT)	Farmacêutico que realiza, supervisiona e coordena os serviços técnico-científicos no horário declarado e representa a empresa nos aspectos técnicos	Res. CFF 721/2022, arts. 2º, §1º, e 10, §1º
Farmacêutico assistente	Os "quantos outros forem necessários" para cobrir todo o horário, com função e horário anotados no CRF	Res. CFF 721/2022, arts. 3º e 9º
Farmacêutico substituto	Cobre impedimentos e ausências do RT, requerido ao CRF, com horário compatível	Lei 5.991/1973, art. 15, §2º; Res. CFF 721/2022, art. 2º, §2º

- A responsabilidade técnica é indelegável e exige participação efetiva e pessoal (Res. CFF 721/2022, art. 10). A RDC 44/2009 permite delegar algumas atribuições a outro farmacêutico, menos a supervisão e a responsabilidade pela assistência técnica (art. 20, parágrafo único).
- Cada farmacêutico responde pelos atos do horário que assumiu, com responsabilidade solidária quando comprovada (Res. CFF 721/2022, art. 10, §2º).
- Mudança de horário da loja ou do farmacêutico deve ser comunicada **previamente** ao CRF; sem isso, a certidão perde a validade (art. 11).
- O farmacêutico declara ao CRF que tem disponibilidade de horário; informação falsa gera sanção (art. 12).
- Ao sair da empresa, o profissional responde pelos atos do período em que deu assistência, por um ano após o fim do vínculo (Lei 5.991/1973, art. 16, §§1º e 2º), e comunica o CRF em até 5 dias úteis (Res. CFF 724/2022, art. 15, XII).
- A Lei 5.991/1973 limita a direção técnica a duas farmácias, uma comercial e uma hospitalar (art. 20).

Direitos, deveres e proibições mais cobrados

Tipo	Dispositivo (Res. CFF 724/2022)	Conteúdo resumido
Direito	Art. 12, IV	Negar-se a atos contrários à ciência, à ética e à técnica
Direito	Art. 12, IX	Fazer a intercambialidade respeitando a decisão do usuário e documentando
Direito	Art. 12, XIV	Decidir, justificadamente, sobre dispensar ou não qualquer prescrição
Dever	Art. 14, II e XII	Supervisionar colaboradores; supervisionar o conteúdo publicado pela loja em redes sociais e sites
Dever	Art. 14, IV e X	Avaliar a prescrição; orientar sobre benefícios, riscos, interações e uso
Dever	Art. 15, II	Recusar produto sem registro, sem rastreabilidade ou sem nota fiscal
Proibição	Art. 17, VIII	Delegar ou permitir que outros pratiquem atos privativos do farmacêutico
Proibição	Art. 17, XI e XVII	Intitular-se RT sem certidão do CRF; deixar de prestar assistência no horário declarado
Proibição	Art. 18, V	Permitir o uso do nome em estabelecimento onde não trabalha de fato
Proibição	Art. 18, XVII	Aceitar interferência de leigos nas decisões técnicas
Proibição	Art. 18, XXIV e XLI	Submeter-se a fins mercantilistas que comprometam a técnica; receber vantagem indevida

As sanções disciplinares, conforme a Lei 3.820/1960, são advertência (com ou sem a palavra "censura"), multa de 1 a 3 salários mínimos regionais, dobrada na reincidência, suspensão de 3 meses a 1 ano e

eliminação (Res. CFF 724/2022, art. 24). A competência para julgar é do CRF em que o profissional estava inscrito na época do fato, com recurso ao CFF (Lei 3.820/1960, art. 6º, e).

ATENÇÃO

Emprestar o nome para a loja abrir, sem trabalhar nela, é a falta conhecida como "farmacêutico de placa". Fere o Código de Ética (art. 18, V; art. 17, XVII) e deixa a loja sem farmacêutico, infração sanitária. O profissional responde nos dois planos.

NO BALCÃO

Quando for assumir uma loja, peça ao CRF a anotação de função e horário de cada farmacêutico, confira se a certidão afixada mostra os nomes e horários corretos e guarde cópia do contrato. Se a escala mudar, comunique antes (Res. CFF 721/2022, arts. 8º, 9º e 11).

CASO

A RT trabalha das 8h às 14h e o substituto das 14h às 22h. Num sábado, o substituto falta e o gerente mantém a loja aberta "só com o caixa". Um cliente compra um tarjado sem receita. A loja responde pela infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XII) e por funcionar sem farmacêutico. O substituto que faltou ao horário declarado responde eticamente (Res. CFF 724/2022, art. 17, XVII); a RT não, pois não estava em seu horário, salvo se tivesse ciência e tolerasse a prática.

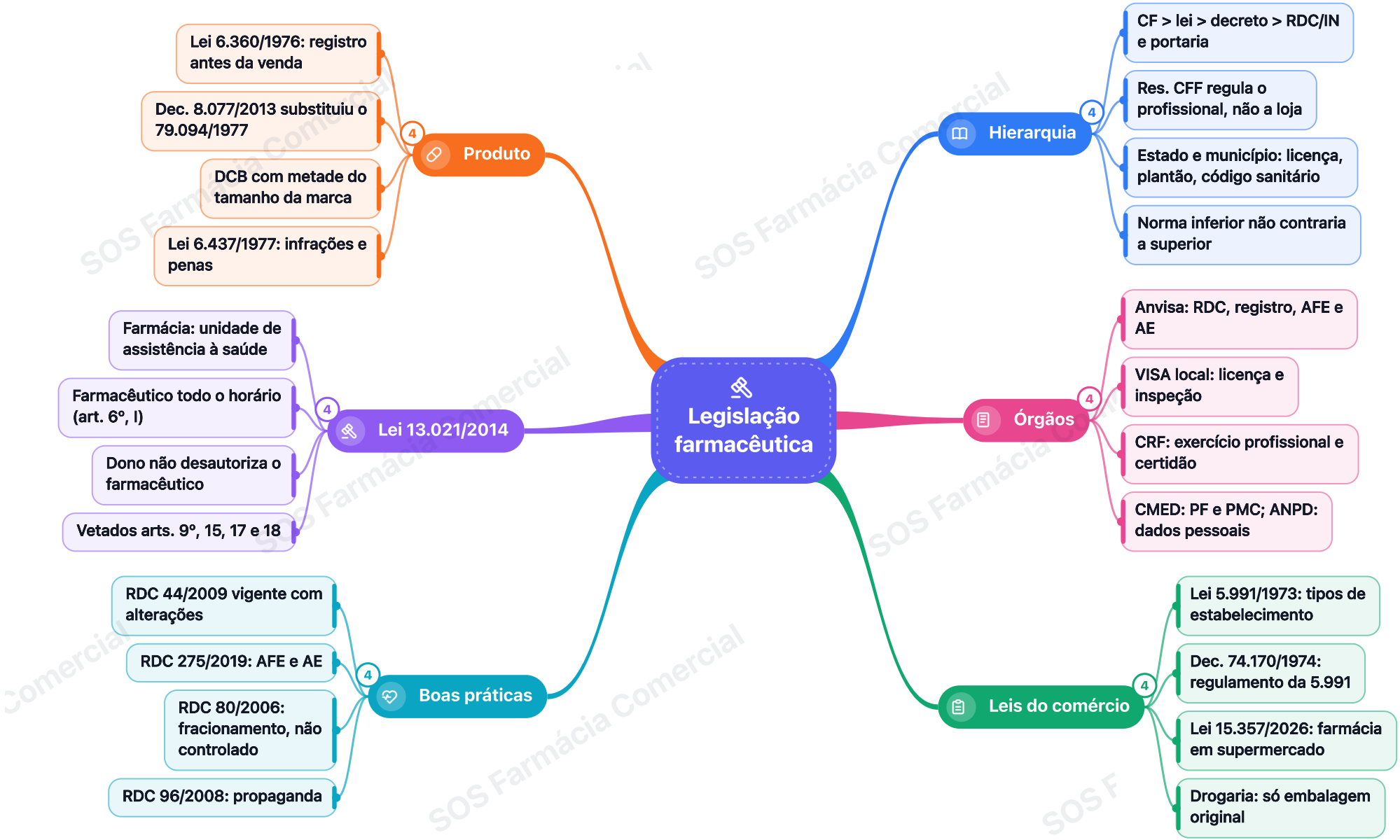
Fontes consultadas

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (arts. 5º, 22, 24, 30, 196 e 200), texto compilado. planalto.gov.br, consultado em 15/10/2026.
2. Brasil. Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. Texto compilado, planalto.gov.br.
3. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, texto compilado com alterações até a Lei nº 15.357/2026. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
4. Brasil. Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974. Regulamenta a Lei nº 5.991/1973. Texto compilado, planalto.gov.br.
5. Brasil. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, texto compilado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
6. Brasil. Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013. Regulamenta a Lei nº 6.360/1976 e revoga o Decreto nº 79.094/1977. planalto.gov.br.
7. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, texto compilado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm
8. Brasil. Decreto nº 85.878, de 7 de abril de 1981. Normas para execução da Lei nº 3.820/1960. planalto.gov.br.
9. Brasil. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), texto compilado. planalto.gov.br.
10. Brasil. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o SNVS e cria a Anvisa. Texto compilado, planalto.gov.br.
11. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm
12. Brasil. Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003 (regulação do setor farmacêutico e CMED). planalto.gov.br.
13. Brasil. Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004 (oferta e afixação de preços), texto compilado. planalto.gov.br.

14. Brasil. Lei nº 12.291, de 20 de julho de 2010 (exemplar do CDC nos estabelecimentos). planalto.gov.br.
15. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, e Mensagem de veto nº 232, de 8 de agosto de 2014. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
16. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), texto compilado com alterações até a Lei nº 15.352/2026. planalto.gov.br.
17. Brasil. Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026 (Agência Nacional de Proteção de Dados). planalto.gov.br.
18. Brasil. Lei nº 15.357, de 20 de março de 2026. Altera a Lei nº 5.991/1973 (farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados). DOU de 23/03/2026. planalto.gov.br.
19. Anvisa. RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 (Boas Práticas Farmacêuticas), texto consolidado no AnvisaLegis (vigente com alterações), consultado em 15/10/2026.
20. Anvisa. RDC nº 275, de 9 de abril de 2019 (AFE e AE de farmácias e drogarias), texto consolidado no AnvisaLegis, consultado em 15/10/2026.
21. Anvisa. RDC nº 17, de 28 de março de 2013, revogada pela RDC nº 275/2019 (AnvisaLegis).
22. Anvisa. RDC nº 16, de 2 de março de 2007 (Regulamento técnico de genéricos), texto consolidado no AnvisaLegis, Anexo I, item VI.
23. Anvisa. RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014 (intercambialidade de similares), texto consolidado no AnvisaLegis.
24. Anvisa. Medicamentos similares: intercambialidade. Portal gov.br/anvisa, consultado em 15/10/2026.
25. Anvisa. RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 (fracionamento de medicamentos). Texto original na BVS/MS.
26. Anvisa. RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008 (propaganda de medicamentos), texto consolidado no AnvisaLegis.
27. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026. DOU de 31/03/2026, Seção 1, p. 33. gov.br/anvisa.
28. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 721, de 24 de fevereiro de 2022 (direção ou responsabilidade técnica). DOU, 2022. in.gov.br
29. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 724, de 29 de abril de 2022 (Código de Ética, Código de Processo Ético e sanções). DOU, 2022. in.gov.br
30. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 6, de 25 de junho de 2026 (cuidado paliativo), cujos considerandos citam a Resolução CFF nº 724/2022 como norma em vigor. DOU, 03/07/2026.

Quem regula a farmácia

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 1



Legislação no balcão

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 1

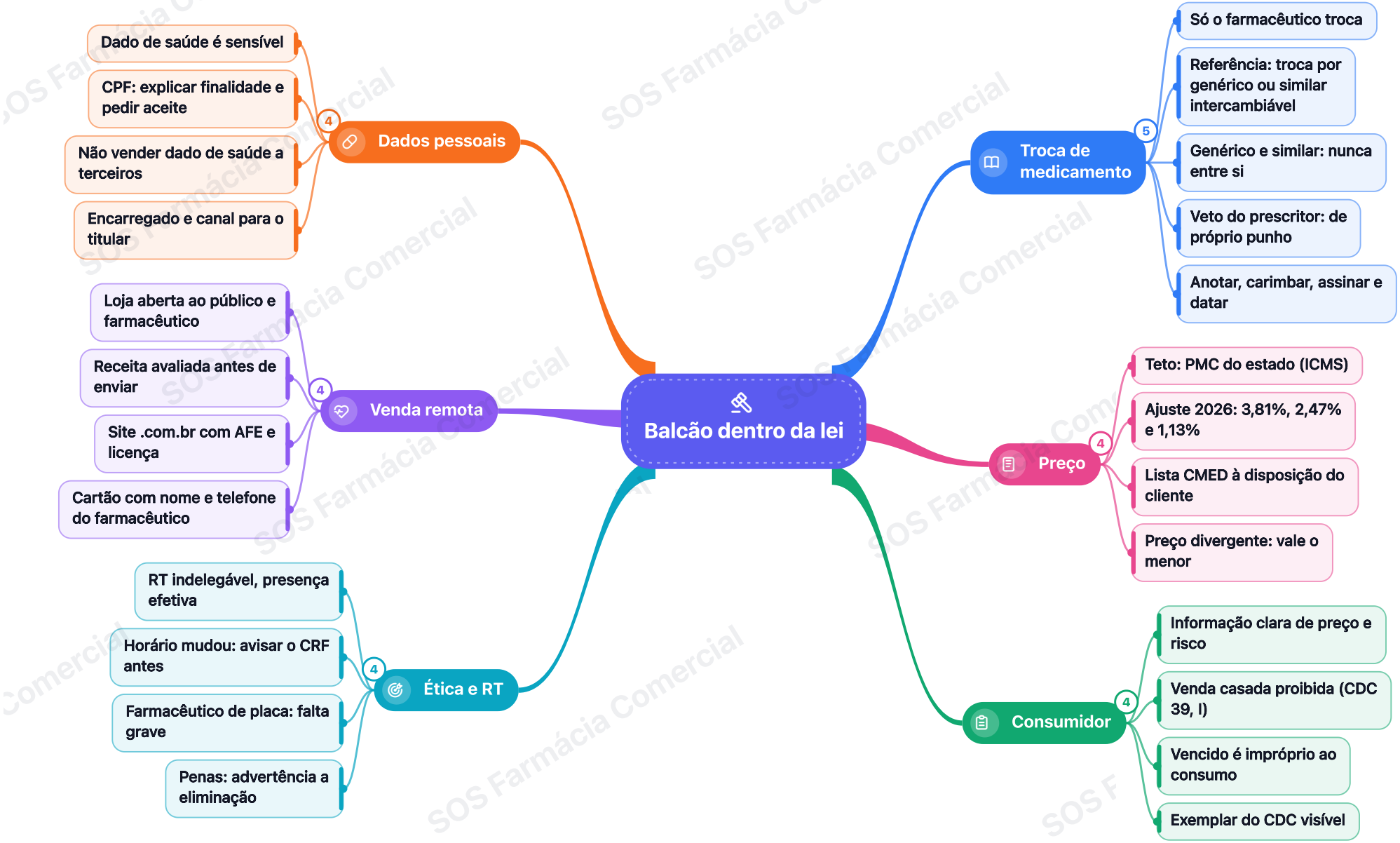


Tabela-mestra: norma, assunto e o que o farmacêutico precisa saber

Norma	Assunto	O que o farmacêutico precisa saber
Constituição Federal, arts. 196, 200 e 24, XII	Saúde e vigilância sanitária	Vigilância sanitária é ação do SUS; União, estados e municípios legislam sobre saúde
Lei 3.820/1960	Cria CFF e CRFs	Só inscrito no CRF exerce a profissão (art. 13); empresa prova ter farmacêutico (art. 24)
Lei 5.991/1973	Comércio de medicamentos	Farmácia, drogaria, posto, dispensário; licença local; receituário (art. 35)
Decreto 74.170/1974	Regulamenta a Lei 5.991	Correlatos permitidos (art. 4º); fracionamento (art. 9º, parágrafo único)
Lei 6.360/1976	Vigilância sanitária de produtos	Registro antes da venda (art. 12); definições de genérico e similar (art. 3º)
Decreto 8.077/2013	Regulamenta a Lei 6.360	Autorização da Anvisa e licença local para funcionar (art. 2º)
Lei 6.437/1977	Infrações e penalidades sanitárias	Vender tarjado sem receita (art. 10, XII); aviar receita em desacordo (XI)
Decreto 85.878/1981	Atribuições do farmacêutico	Dispensação é privativa do farmacêutico (art. 1º, I)
Lei 8.078/1990 (CDC)	Defesa do consumidor	Informação clara, sem venda casada, vencido é impróprio
Lei 9.782/1999	SNVS e Anvisa	Anvisa autoriza o funcionamento de quem comercializa medicamentos (art. 7º, VII)
Lei 9.787/1999	Genéricos	Prescrição pela DCB no SUS (art. 3º); respeitar veto de não intercambialidade
RDC 16/2007, Anexo I, item VI	Prescrição e dispensação de genéricos	Farmacêutico troca e registra na receita; veto de próprio punho
RDC 58/2014	Similar intercambiável	Lista no portal da Anvisa; frase na bula; não vale para MIP
Lei 10.742/2003	CMED e preços	Teto de preço; descumprimento sujeita às sanções do CDC (art. 8º)
Resolução CM-CMED 4/2026	Ajuste anual de 2026	Lista de preços atualizada à disposição do consumidor (art. 6º)

Norma	Assunto	O que o farmacêutico precisa saber
Lei 10.962/2004	Afixação de preços	Divergência de preço: o consumidor paga o menor (art. 5º)
RDC 80/2006	Fracionamento	Só de embalagem fracionável; nunca controlado; responsabilidade do farmacêutico
RDC 96/2008	Propaganda de medicamentos	Medicamento não é prêmio de fidelidade (art. 10)
RDC 44/2009	Boas práticas em farmácias e drogarias	Documentos (art. 2º), dispensação (arts. 43 a 51), venda remota (arts. 52 a 59)
Lei 13.021/2014	Exercício das atividades farmacêuticas	Farmacêutico todo o horário; dono não desautoriza; deveres do art. 13
LGPD, Lei 13.709/2018	Proteção de dados	Dado de saúde é sensível (art. 5º, II); vedado compartilhar para vantagem econômica (art. 11, §4º)
RDC 275/2019	AFE e AE de farmácias e drogarias	AFE não autoriza atividade fora da licença (art. 4º, §4º)
Res. CFF 721/2022	Responsabilidade técnica	Certidão com todos os farmacêuticos e horários; avisar mudança antes
Res. CFF 724/2022	Código de Ética	Direito de recusar dispensação justificadamente; proibição de delegar ato privativo
Lei 15.357/2026	Farmácia em supermercado e entrega	Espaço exclusivo; controlado só após pagamento ou lacrado; plataformas para entrega

Normas de controlados (Portaria 344/98, RDC 1.000/2025), antimicrobianos (RDC 471/2021) e MIP (RDC 882/2024, IN 285/2024) têm módulos próprios.

Quem fiscaliza o quê

Fiscal	O que verifica	Base	Consequência típica
Vigilância sanitária (VISA)	Licença, AFE, armazenamento, receitas, escrituração, serviços, validade	Lei 5.991/1973, art. 44; RDC 44/2009	Termo de inspeção, auto de infração, interdição (Lei 6.437/1977)
CRF	Farmacêutico presente, certidão, horários, conduta ética	Lei 3.820/1960, art. 10; Lei 13.021/2014	Auto do CRF, processo ético, multa ao estabelecimento
Procon	Preço acima do PMC, informação, venda casada, exemplar do CDC	CDC; Lei 10.742/2003, art. 8º	Sanções do art. 56 do CDC
ANPD	Tratamento de dados pessoais e incidentes	LGPD, arts. 52 e seguintes	Advertência, multa, bloqueio de dados

Linha do tempo da legislação farmacêutica

Ano	Norma	O que mudou
1960	Lei 3.820	Cria o CFF e os CRFs
1973	Lei 5.991	Define farmácia, drogaria e regras do comércio de medicamentos
1974	Decreto 74.170	Regulamenta a Lei 5.991
1976	Lei 6.360	Registro e rotulagem de produtos sujeitos à vigilância sanitária
1977	Lei 6.437	Infrações sanitárias e penalidades
1981	Decreto 85.878	Atribuições privativas do farmacêutico
1988	Constituição Federal	Saúde como direito; vigilância sanitária no SUS
1990	Lei 8.078 (CDC)	Direitos do consumidor
1998	Portaria SVS/MS 344	Medicamentos sujeitos a controle especial
1999	Lei 9.782 e Lei 9.787	Cria a Anvisa e o medicamento genérico
2003	Lei 10.742	Cria a CMED e a regulação de preços
2006	RDC 80	Fracionamento em farmácias e drogarias
2007	RDC 16	Regulamento de genéricos (critérios de dispensação ainda vigentes)
2008	RDC 96	Propaganda de medicamentos
2009	RDC 44	Boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias
2012	RDC 41	MIP em autosserviço
2013	Decreto 8.077	Novo regulamento da Lei 6.360
2014	Lei 13.021 e RDC 58	Farmácia como unidade de saúde; similar intercambiável
2018	Lei 13.709 (LGPD)	Proteção de dados pessoais
2019	RDC 275	AFE e AE de farmácias e drogarias
2022	Res. CFF 721 e 724	Responsabilidade técnica e Código de Ética vigentes
2023	RDC 812	Entrega remota de controlados
2024	RDC 882	Novos critérios de enquadramento de MIP
2025	RDC 978 e RDC 1.000	Exames em farmácia; receituários de controlados

Ano	Norma	O que mudou
2026	Lei 15.352, Lei 15.357 e Res. CM-CMED 4	ANPD vira agência; farmácia em supermercado; ajuste de preços de 2026

Documentos que a farmácia precisa ter em dia

- ◯ AFE publicada no DOU, com as atividades que a loja realmente exerce (RDC 275/2019)
- ◯ AE, se a farmácia manipula substâncias da Portaria 344/98
- ◯ Licença sanitária vigente, afixada, com todos os serviços prestados listados (RDC 44/2009, arts. 2º e 61)
- ◯ Certidão de Regularidade do CRF afixada, com nome e horário de todos os farmacêuticos e do substituto (Res. CFF 721/2022, art. 8º)
- ◯ Cartaz com razão social, CNPJ, AFE, RT, horários e telefones do CRF e da VISA, se faltarem nos documentos afixados (RDC 44/2009, art. 2º, §2º)
- ◯ Manual de Boas Práticas e POPs assinados pelo RT (RDC 44/2009, arts. 85 e 86)
- ◯ Lista atualizada de genéricos visível ao usuário (RDC 44/2009, art. 42, §1º)
- ◯ Lista de serviços públicos de saúde próximos, com endereço e telefone (RDC 44/2009, art. 62)
- ◯ Cartaz "Medicamentos podem causar efeitos indesejados" na área de medicamentos (RDC 44/2009, art. 41)
- ◯ Lista de preços da CMED atualizada, com o PMC do estado (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º)
- ◯ Exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível (Lei 12.291/2010)
- ◯ Contratos e anotação de função e horário de cada farmacêutico no CRF (Res. CFF 721/2022, art. 9º)
- ◯ Escrituração de controlados e antimicrobianos em dia e receitas retidas arquivadas
- ◯ Site com os dados obrigatórios e endereço informado na AFE, se vende pela internet (RDC 44/2009, arts. 53 e 55)
- ◯ Aviso de privacidade e contato do encarregado de dados publicados (LGPD, arts. 9º e 41)

Posso substituir este medicamento?

Cliente pede para trocar o medicamento da receita

DECISÃO

Quem vai decidir é farmacêutico?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Chamar o farmacêutico; balconista não decide troca

DECISÃO

O prescritor vetou a troca de próprio punho naquele item?

- **SIM** — Não trocar; dispensar o prescrito ou contatar o prescritor
- **NÃO** — Seguir

DECISÃO

Mesmo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica e via?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não trocar; só o prescritor muda substância, dose ou forma

DECISÃO

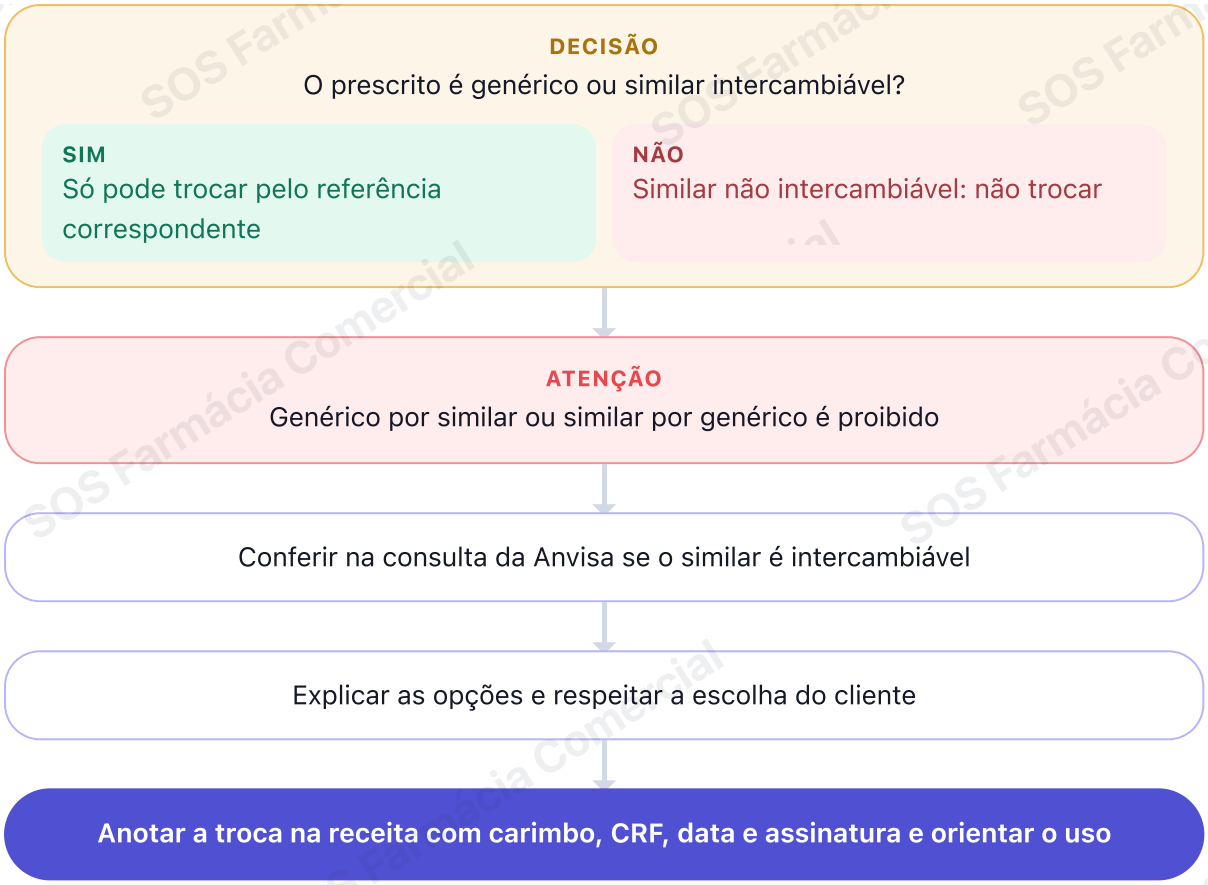
A receita está escrita pela DCB?

- **SIM** — Dispensar o genérico ou o referência correspondente
- **NÃO** — Seguir

DECISÃO

O prescrito é o referência?

- **SIM** — Pode trocar pelo genérico ou por similar intercambiável com esse referência
- **NÃO** — Seguir



Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual lei define farmácia e drogaria?	Lei 5.991/1973, art. 4º, X e XI; a Lei 13.021/2014 fala em farmácia com e sem manipulação.
Drogaria pode manipular ou captar receita magistral?	Não. Captar receita magistral é vedado mesmo entre filiais (Lei 5.991/1973, art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50).
O que a Lei 15.357/2026 permitiu?	Farmácia em área de supermercado, em espaço exclusivo, com farmacêutico todo o horário, e uso de plataformas para entrega.
Qual decreto regulamenta hoje a Lei 6.360/1976?	Decreto 8.077/2013, que revogou o Decreto 79.094/1977.
Qual artigo da Lei 13.021/2014 exige farmacêutico durante todo o horário?	Art. 6º, I.
Quais artigos da Lei 13.021/2014 foram vetados?	Arts. 9º, 15, 17 e 18 (Mensagem de veto 232/2014).
Prazo para contratar novo farmacêutico após a baixa?	30 dias (Lei 13.021/2014, art. 12).
Genérico pode ser trocado por similar intercambiável?	Não. Ambos foram comparados ao referência, não entre si.

Pergunta	Resposta
Como o prescritor veta a troca?	Por item, de forma clara e legível, de próprio punho (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3).
Quem pode fazer a substituição na farmácia?	O farmacêutico, que anota na receita com carimbo, CRF, data e assinatura.
Qual norma trata da AFE de farmácias e drogarias?	RDC 275/2019. A AE só é exigida de farmácia que manipula substâncias da Portaria 344/98.
Controlado pode ser fracionado?	Não (RDC 80/2006, art. 1º, parágrafo único).
Que domínio o site da farmácia deve usar?	".com.br" (RDC 44/2009, art. 53, §1º).
Teto de ajuste de preços em 2026?	3,81%, 2,47% e 1,13% conforme o nível (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 3º).
Preço da gôndola diferente do caixa: qual vale?	O menor (Lei 10.962/2004, art. 5º).
Dado de compra de medicamento é sensível?	Sim, revela dado de saúde (LGPD, art. 5º, II, e art. 11, §1º).
Qual resolução do CFF trata da responsabilidade técnica?	Res. CFF 721/2022, que revogou a 577/2013.
Sanções éticas da Res. CFF 724/2022?	Advertência, multa de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano e eliminação (art. 24).

Questões de fixação

1. Uma drogaria quer ampliar o negócio. Entre as atividades abaixo, qual ela pode exercer sem mudar de natureza, desde que conste da licença sanitária?

A Manipular cremes a partir de receitas de dermatologistas.

B Receber receitas magistrais e repassá-las a uma farmácia de manipulação da mesma rede.

C Dispensar medicamentos fracionados a partir de embalagem fracionável.

D Dispensar plantas medicinais a granel.

E Manipular substâncias da Portaria 344/98 com AE.

2. Receita particular traz o nome comercial de um similar intercambiável de anlodipino 5 mg, sem veto de troca. O cliente pede o genérico, que é mais barato. O farmacêutico deve:

A dispensar o genérico, pois genéricos e similares são intercambiáveis entre si.

B dispensar o genérico, desde que anote a troca no verso da receita.

C recusar a dispensação, pois toda receita com nome comercial de similar exige contato prévio com o prescritor.

D dispensar o genérico se o cliente assinar declaração de ciência.

E explicar que a troca só é possível pelo referência e oferecer o similar prescrito ou o referência.

3. Sobre a Lei 13.021/2014, assinale a alternativa correta.

A Revogou integralmente a Lei 5.991/1973.

B Atribuiu ao fiscal farmacêutico do CRF a fiscalização sanitária das farmácias.

C Determinou que postos de medicamentos se transformassem em farmácia em 3 anos.

D Proíbe que o proprietário desautorize as orientações técnicas do farmacêutico.

E Restringiu às farmácias a venda de cosméticos com indicação terapêutica e de fitoterápicos.

4. Farmacêutico assume a RT de uma drogaria que abre das 7h às 23h. Ele trabalhará das 7h às 15h. Segundo a Res. CFF 721/2022 e a Lei 13.021/2014, é necessário:

A que outro farmacêutico, com função e horário anotados no CRF, cubra o restante do horário.

B que o gerente assine termo de responsabilidade para o período sem farmacêutico.

C apenas que o RT deixe os POPs assinados para os balconistas seguirem.

D que a loja não venda controlados após as 15h, liberando os demais.

E nada, pois a responsabilidade técnica do RT abrange todo o horário de funcionamento, mesmo na sua ausência.

5. Na fiscalização do Procon, constata-se que uma drogaria do Ceará cobra por um anti-hipertensivo valor acima do PMC publicado para o estado. Assinale a afirmativa correta.

A O PMC é sugestão do fabricante e não obriga a farmácia.

B A farmácia pode cobrar acima do PMC se oferecer desconto no cartão fidelidade.

C O PMC é único no país, sem variação de ICMS.

D A farmácia descumpre ato da CMED e fica sujeita às sanções do art. 56 do CDC.

E Só a Anvisa pode autuar, pois preço é assunto sanitário.

6. Uma rede quer vender medicamentos por site e aplicativo. Qual exigência decorre da RDC 44/2009?

A O estoque pode ficar em um centro de distribuição fechado ao público, sem farmácia.

B O site pode exibir banners de anti-hipertensivos em promoção.

C Tarjados exigem que o farmacêutico receba e avalie a receita.

D O site pode usar domínio ".com" se a empresa tiver CNPJ.

E Controlados podem ser vendidos livremente após o pagamento on-line.

7. Cliente de 52 anos recusa informar CPF no caixa. A atendente diz que sem CPF "o sistema não deixa vender" a dipirona. Com base na LGPD e no CDC, a melhor conduta do farmacêutico é:

A confirmar a exigência, pois todo medicamento, inclusive isento de prescrição, exige identificação do comprador.

B vender sem CPF, explicando que o cadastro serve ao programa de desconto e é opcional.

C pedir RG no lugar do CPF, para cumprir a escrituração sanitária.

D registrar a venda no CPF de outro cliente cadastrado.

E vender e registrar o CPF depois, a partir de consulta pública.

8. Paciente apresenta receita de omeprazol 20 mg pelo nome do referência. Ao lado do item, há carimbo impresso com a frase "não autorizo a substituição". O farmacêutico deve considerar que:

A o veto é válido, pois está escrito de forma legível.

B o carimbo vale como veto para todos os itens da receita, inclusive os genéricos.

C o veto não vale, porque deve ser escrito de próprio punho.

D a troca está proibida para qualquer medicamento de referência.

E basta o paciente concordar para afastar qualquer veto do prescritor.

9. Durante inspeção, o fiscal da VISA verifica que a drogaria tem AFE com a atividade "prestação de serviços farmacêuticos", mas a licença sanitária não lista esse serviço. A drogaria aplica injetáveis. Assinale a correta.

A A AFE basta, pois é ato da Anvisa, de âmbito federal, e prevalece sobre a licença sanitária local.

B O serviço é irregular, pois só são regulares os serviços indicados no licenciamento.

C O serviço é regular se houver POP assinado pelo RT.

D Basta comunicar o CRF para regularizar.

E A aplicação de injetáveis independe de licença por ser ato do farmacêutico.

10. Uma farmacêutica aceita constar como RT de uma drogaria em outra cidade, onde nunca vai, em troca de pagamento mensal. Essa conduta:

A é permitida se ela visitar a loja ao menos uma vez por mês e assinar os POPs.

B é infração apenas da empresa, e não da profissional contratada.

C é regular se houver contrato de trabalho registrado.

D só é proibida se a drogaria vender controlados.

E é falta ética, pois ela permite o uso do nome onde não exerce a função.

11. Um laboratório oferece pagamento a uma rede de farmácias em troca da lista de clientes que compram seu antidiabético, com CPF e frequência de compra, para enviar publicidade. À luz da LGPD, essa operação:

A é permitida, pois o CPF é um dado público e de livre circulação.

B é permitida se a farmácia tiver encarregado nomeado.

C é vedada, pois compartilha dado de saúde para vantagem econômica.

D é permitida se os dados forem enviados criptografados ao laboratório.

E é vedada apenas se os clientes forem menores de idade.

Gabarito comentado

1. **C**. Correta C: farmácias e drogarias podem fracionar a partir de embalagem fracionável (RDC 80/2006, art. 1º; Decreto 74.170/1974, art. 9º, parágrafo único). A e E: manipulação é própria da farmácia (Lei 5.991/1973, art. 4º, X e XI). B: captação de receita magistral é vedada, mesmo entre filiais (art. 36, §1º; RDC 44/2009, art. 50). D: plantas medicinais são privativas de farmácias e ervanarias (art. 7º).
2. **E**. Correta E: o similar intercambiável é equivalente ao referência, e a Anvisa informa que a troca entre similar e genérico não é possível, porque os dois não foram comparados entre si (RDC 58/2014, art. 2º). A, B e D permitem troca não admitida; anotar ou colher assinatura não a torna regular. C: a receita é válida e pode ser dispensada como está.
3. **D**. Correta D (art. 11). A: a Lei 5.991/1973 segue vigente. B, C e E correspondem aos arts. 15, 17 e 9º, vetados pela Mensagem 232/2014; a fiscalização sanitária continua com a VISA.
4. **A**. Correta A: farmácia de qualquer natureza deve ter quantos farmacêuticos forem necessários para cobrir todo o horário, com horários anotados no CRF (Res. CFF 721/2022, arts. 3º e 9º; Lei 13.021/2014, art. 6º, I). B e C delegam a leigos ato do farmacêutico (Res. CFF 724/2022, art. 17, VIII). D aplica fora de contexto o art. 17 da Lei 5.991/1973. E confunde responsabilidade com presença; a RT exige participação efetiva (Res. CFF 721/2022, art. 10).
5. **D**. Correta D: o varejo não pode praticar preço superior ao publicado pela CMED (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º), e o descumprimento sujeita às sanções do CDC (Lei 10.742/2003, art. 8º). A e B: o PMC é teto obrigatório. C: o PMC varia conforme o ICMS do estado (art. 6º, parágrafo único). E: Procon é órgão de defesa do consumidor e pode fiscalizar.
6. **C**. Correta C (art. 52, §1º). A: o estoque deve estar em farmácia ou drogaria aberta ao público (art. 52, §3º). B: é vedada propaganda de tarjado no site (art. 54). D: o domínio deve ser ".com.br" (art. 53, §1º). E: controlados pedidos a distância são vedados, salvo as exceções da legislação específica (art. 52, §2º, redação da RDC 812/2023).
7. **B**. Correta B: fora das hipóteses sanitárias de identificação, o CPF tem finalidade comercial; o tratamento exige finalidade informada e consentimento específico (LGPD, arts. 6º, 8º, §4º, e 11, I), e a venda não deve ser condicionada ao cadastro. A e C: MIP não exige identificação do comprador. D e E violam a LGPD e falseiam registros.
8. **C**. Correta C: a não intercambialidade deve ser manifestada por item, de forma clara, legível e inequívoca, de próprio punho, não sendo permitidas outras formas de impressão (RDC 16/2007, Anexo I, VI, 1.3). A e B ignoram a forma exigida. D: não existe proibição geral. E: veto válido do prescritor prevalece sobre a vontade do paciente (Lei 9.787/1999, art. 2º, IV).
9. **B**. Correta B: RDC 44/2009, art. 61, §§3º e 4º; a AFE não autoriza atividade que não esteja na licença (RDC 275/2019, art. 4º, §§4º e 5º). A, C, D e E: POP, AFE e comunicação ao CRF não substituem a licença sanitária com o serviço incluído após inspeção prévia.
10. **E**. Correta E: Res. CFF 724/2022, art. 18, V, e art. 17, XVII; a RT é indelegável e exige participação efetiva e pessoal (Res. CFF 721/2022, art. 10). A, C e D: contrato ou visita eventual não suprem a presença (Lei 13.021/2014, art. 6º, I). B: a profissional responde eticamente e a empresa, sanitariamente.
11. **C**. Correta C: LGPD, art. 11, §4º; o uso de dados para induzir consumo de medicamento também é vedado pela RDC 44/2009 (art. 59, parágrafo único), e fornecer dado identificável a terceiros é falta ética (Res. CFF 724/2022, art. 18, XLIII). A: dado de compra de medicamento é sensível. B e D: encarregado e criptografia não criam base legal. E: a vedação não depende da idade.

Módulo 2

Portaria 344/98 e medicamentos controlados

Regras vigentes em outubro de 2026 para prescrição, dispensação, guarda e escrituração de medicamentos controlados: listas do Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998 (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026), Portaria SVS/MS 6/1999, receituários físicos e eletrônicos da RDC 1.000/2025, SNCR (RDC 873/2024), SNGPC (RDC 22/2014) e penalidades da Lei 6.437/1977.

- Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos
- Listas do Anexo I e adendos
- Receituários de controle especial
- Dispensação de controlados no balcão
- Escrituração, guarda e inventário
- SNGPC
- SNCR
- Infrações e penalidades

Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos

A **Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998**, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Ela foi editada pela antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e, desde a criação da Anvisa (Lei nº 9.782/1999), é atualizada por Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC). Quem trabalha no balcão lida com ela todos os dias: é a 344 que define o que é controlado, qual receituário cada medicamento exige, quanto pode ser dispensado, por quanto tempo a receita vale e como a farmácia guarda e registra tudo.

A 344 não anda sozinha. A **Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999**, é a instrução normativa que detalha a execução (como preencher campos, como retirar numeração, como escriturar, o que fazer no encerramento de atividades). Em volta das duas existem normas específicas que o farmacêutico precisa conhecer pelo nome:

Norma	Assunto	Por que importa no balcão
Portaria SVS/MS 344/1998	Regulamento técnico e listas do Anexo I	Define lista, receituário, validade e quantidade
Portaria SVS/MS 6/1999	Instrução normativa da 344	Campos do dispensador, carimbo, verso, fracionamento
RDC 58/2007	Notificação de Receita B2 (anorexígenos)	Modelo próprio para a lista B2
RDC 11/2011	Talidomida	Notificação própria, só em unidade pública credenciada
RDC 22/2014	SNGPC	Escrituração eletrônica obrigatória em farmácias e drogarias
RDC 50/2014	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Dose diária máxima e termo do prescritor
RDC 873/2024	Institui o SNCR	Numeração nacional e validade nacional das notificações
RDC 1.000/2025	Receituários eletrônicos e novos modelos físicos	Notificação eletrônica, CPF do paciente, registro de uso
Lei 6.437/1977	Infrações sanitárias	Penalidades por descumprimento

Como o regulamento é organizado

O texto da 344 segue uma ordem lógica que ajuda a estudar: definições (capítulo I), autorização (II), comércio e transporte, prescrição (V, com Notificação de Receita e Receita de Controle Especial), escrituração (VI), guarda (VII), balanços (VIII), embalagem (IX), controle e fiscalização (X) e disposições finais (XI). O **Anexo I** traz as listas de substâncias. Os anexos que traziam os modelos de talonários (IX a

XII) foram revogados pela RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025 (art. 25): os modelos oficiais passaram a ser publicados no portal da Anvisa, na página do SNCR.

O Anexo I muda com frequência. A versão consolidada no sistema de legislação da Anvisa registra, em outubro de 2026, a **Atualização nº 101**, feita pela RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026, que incluiu a MMDPPA na lista D1 e a dimetocaína na lista F1. Antes dela vieram, em 2026, a RDC 1.011 (30/01/2026), a RDC 1.017 (20/02/2026), a RDC 1.021 (09/04/2026) e a RDC 1.023 (11/05/2026). Na prática: antes de responder a um paciente ou a uma prova, confira a lista consolidada no portal da Anvisa, porque uma substância pode ter mudado de lista há poucas semanas.

> **ATENÇÃO**
>
> Apostilas, sites de telemedicina e bancos de questões antigos costumam trazer regras revogadas: zolpidem até 10 mg em receita branca, lista C4 de antirretrovirais, visto da Vigilância Sanitária para notificação de outro estado e talonário amarelo fornecido só pela VISA. Nenhuma delas vale em outubro de 2026.

Conceitos que caem no dia a dia

- **Medicamento sujeito a controle especial**: medicamento que contém substância, planta ou fungo das listas do Anexo I da 344 (RDC 1.000/2025, art. 3º, III).
- **Notificação de Receita (NR)**: documento padronizado, numerado pela autoridade sanitária, que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de medicamentos das listas A1, A2, A3, B1, B2 e C2 (Portaria 344, art. 35, redação da RDC 1.000/2025). A talidomida (lista C3) tem notificação própria na RDC 11/2011.
- **Receita de Controle Especial (RCE)**: receita em duas vias, sem numeração oficial no papel, para as listas C1 e C5 e para os adendos das listas A1, A2 e B1 que mandam usar RCE (Portaria 344, art. 55; Portaria 6/1999, art. 84).
- **Autorização Especial (AE)**: licença da Anvisa para atividades como extrair, produzir, fabricar, manipular, fracionar, importar, exportar ou distribuir substâncias das listas (Portaria 344, art. 2º). A drogaria que só dispensa medicamento industrializado em embalagem original opera com a Autorização de Funcionamento (AFE); a farmácia que manipula substâncias controladas precisa da AE.
- **Adendo**: parágrafo ao final de cada lista que cria exceções, por exemplo preparações de baixa concentração que passam a exigir receita mais simples, ou formas farmacêuticas que ficam proibidas.
- **Escrituração**: registro de toda entrada, saída e perda. Em farmácias e drogarias é feita no SNGPC (RDC 22/2014, art. 35).
- **SNCR**: Sistema Nacional de Controle de Receituários, instituído pela RDC nº 873, de 27 de maio de 2024. Gera e distribui a numeração das notificações e, desde 30/09/2026, registra a utilização das receitas eletrônicas.

Quem pode prescrever

A 344 prevê três prescritores: **médico**, **cirurgião-dentista** e **médico-veterinário**. O dentista e o veterinário só podem prescrever para uso odontológico e veterinário, respectivamente (Portaria 344, art. 38; art. 55, § 1º). Algumas regras restringem ainda mais:

Situação	Quem prescreve	Base
Listas A, B, C1, C5	Médico; dentista (uso odontológico); veterinário (uso veterinário)	Portaria 344, arts. 38 e 55
Retinoides sistêmicos (C2)	Médico	Portaria 344, art. 50
Talidomida (C3)	Médico cadastrado na autoridade sanitária	RDC 11/2011, arts. 11 e 24
Notificações (A, B, B2, C2)	Profissional com numeração concedida pela VISA	Portaria 344, art. 35, § 1º
Médico do Programa Mais Médicos	Registro Único do Ministério da Saúde (RMS) substitui o CRM	RDC 52/2013, citada no Perguntas e Respostas da Anvisa

A 344 não prevê enfermeiro, farmacêutico ou nutricionista como prescritores de medicamentos das suas listas. O campo do Coren que a Anvisa incluiu no SNGPC em 2025 refere-se a antimicrobianos (receita sujeita à retenção da RDC 471/2021), prescritos nos casos amparados por protocolo.

O QUE DIZ A NORMA

"As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 38)

Validade nacional da receita

A Lei nº 13.732/2018 alterou o art. 35 da Lei nº 5.991/1973: o receituário vale em todo o território nacional, inclusive o de controle especial. A Anvisa, no Ofício nº 39/2019/GPCON, esclareceu que a validade nacional diz respeito à dispensação e que o prescritor precisa estar regular no conselho do estado onde atua. Em 2024 a RDC 873 reescreveu os arts. 41 e 50 da 344 (Notificação A e notificação de retinoides valem 30 dias em todo o território) e revogou as regras que obrigavam a farmácia a levar à VISA, em 72 horas, a Notificação A e a RCE de outro estado para visto. Em 2025 a RDC 1.000 deu a mesma redação nacional à Notificação B (art. 45).

NO BALCÃO

Receita de outro estado é aceita normalmente, com os mesmos critérios de uma receita local. Confira o conselho e a UF do prescritor, a numeração (quando for notificação) e os demais campos. Não exija carimbo de visto: essa exigência foi revogada em 2024. A única situação que ainda pede visto em 72 horas é a receita de emergência em papel não oficial.

Tarjas e embalagens

Os medicamentos das listas A e B saem com tarja preta; os das listas C1, C2 de uso sistêmico e C5, com tarja vermelha e a frase de venda sob prescrição com retenção da receita. As frases de alerta de bula e rótulo hoje seguem as RDC 768/2022 e 770/2022, que reescreveram a parte de rotulagem da 344. A

drogaria vende controlado só na embalagem original, intacta e inviolável, e não pode fracioná-la (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109). A tarja ajuda a triagem, mas quem manda é a lista: o zolpidem, por exemplo, passou de tarja vermelha para preta com a mudança de 2024, e embalagens antigas ainda podem aparecer.

CASO

Um dentista prescreve, em Receita de Controle Especial, carbamazepina para um paciente com neuralgia do trigêmeo. A dispensação é possível: a indicação tem relação com a odontologia e a carbamazepina está na lista C1. Se o mesmo dentista prescrevesse sertralina para depressão, a farmácia deveria recusar, porque o uso não é odontológico (Portaria 344, art. 55, § 1º).

Listas do Anexo I e adendos

O **Anexo I** da Portaria 344 reúne as listas de substâncias sob controle. Cada lista tem um título que já diz o receituário exigido, e cada uma termina com um adendo de exceções. Para o balcão, o raciocínio é sempre o mesmo: identificar a substância pela DCB, achar a lista, ler o adendo e só então decidir qual documento aceitar. A versão usada aqui é a consolidada pela Anvisa com a Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9 de julho de 2026).

Visão geral das listas

Lista	Conteúdo	Exemplos de balcão	Receituário
A1	Entorpecentes	Morfina, metadona, oxicodona, fentanila, tapentadol, buprenorfina, petidina, hidromorfona	Notificação A (amarela)
A2	Entorpecentes permitidos em concentrações especiais	Codeína, tramadol, nalbufina, diidrocodeína	Notificação A (com adendos para RCE)
A3	Psicotrópicos	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina, dronabinol, produtos de Cannabis regularizados	Notificação A
B1	Psicotrópicos	Alprazolam, clonazepam, diazepam, bromazepam, lorazepam, midazolam, zolpidem, zopiclona, eszopiclona, modafinila, fenobarbital	Notificação B (azul)
B2	Psicotrópicos anorexígenos	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 (azul)
C1	Outras substâncias sujeitas a controle especial	Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio, pregabalina, gabapentina, bupropiona, coxibes, canabidiol sintético	Receita de Controle Especial em 2 vias
C2	Retinoides	Isotretinoína e acitretina orais; tretinoína e adapaleno tópicos	Notificação especial (branca) para uso sistêmico

Lista	Conteúdo	Exemplos de balcão	Receituário
C3	Imunossupressores	Talidomida, lenalidomida, pomalidomida	Notificação própria (normas específicas)
C5	Anabolizantes	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina, gestrinona	Receita de Controle Especial em 2 vias
D1	Precursoras	Efedrina, pseudoefedrina, ergotamina, ergometrina	Receita médica sem retenção
D2	Insumos químicos	Acetona, ácido clorídrico	Controle da Polícia Federal
E	Plantas e fungos proscritos	Cannabis sativa (com exceções), Erythroxylum coca, Papaver somniferum	Proibidas, salvo exceções do adendo
F1 a F4	Substâncias de uso proscrito	F1 entorpecentes; F2 psicotrópicos; F3 precursores (fenilpropanolamina); F4 outras (dexfenfluramina, etretinato, terfenadina, lindano)	Proibidas

Situação da lista C4

A lista C4 (antirretrovirais) **não existe mais** no Anexo I. A RDC nº 103, de 31 de agosto de 2016 (Atualização nº 52), retirou os antirretrovirais do controle da 344. Os artigos 54 e 58 da Portaria, que falam em C4, permanecem no texto mas ficaram sem objeto. No SUS, a dispensação de antirretrovirais segue o formulário e o sistema do programa (SICLOM); em farmácia privada, segue a regra de medicamento sob prescrição.

O que cada lista significa na prática

- **A1 e A2**: opioides. A A1 reúne os de maior potencial de abuso. A A2 traz os que só ficam na Notificação A acima de certas concentrações: abaixo do limite do adendo, passam à RCE.
- **A3**: estimulantes e outros psicotrópicos de alto risco. Desde 2026 inclui os produtos de Cannabis regularizados pela RDC 1.015, de 2 de fevereiro de 2026, e os medicamentos registrados com derivados de Cannabis (adendos 2, 10 e 12).
- **B1**: benzodiazepínicos, hipnóticos não benzodiazepínicos, barbitúricos e afins. Lista longa, com muitos adendos.
- **B2**: anorexígenos. Além da Notificação B2 (RDC 58/2007), seguem a RDC 50/2014: dose diária máxima e Termo de Responsabilidade do Prescritor.
- **C1**: a lista mais movimentada do balcão. Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, anestésicos gerais, inibidores seletivos da COX-2, misoprostol (só hospitalar) e outros.
- **C2**: retinoides. Os de uso sistêmico (isotretinoína, acitretina, bexaroteno) exigem notificação especial e termo; os tópicos são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **C3**: imunossupressores teratogênicos. A talidomida não é vendida em drogaria; vai só por unidades públicas credenciadas (RDC 11/2011). Lenalidomida e pomalidomida têm norma própria (adendo 4 da

C3; a cartilha da Anvisa de setembro de 2026 cita a RDC 735/2022 para a lenalidomida).

- **C5**: anabolizantes e hormônio do crescimento. Os de uso tópico são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **D1**: precursores. Os medicamentos são vendidos com receita médica sem retenção, como diz o título da lista.
- **E e F**: proscritos. Não podem ser prescritos nem manipulados (Portaria 344, art. 61), com as exceções da Cannabis tratadas em normas próprias.

Adendos mais cobrados

Os adendos são o ponto em que mais se erra no balcão e nas provas. A tabela traz os vigentes na Atualização nº 101, com o efeito prático.

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
A1, adendo 3	Preparações de ópio com até 5 mg de morfina anidra por mL (até 50 mg de ópio)	RCE (ex.: elixir paregórico)
A1, adendo 5	Oxicodona em comprimido de liberação controlada com até 40 mg por unidade	RCE; acima de 40 mg, Notificação A
A1, adendo 8	Buprenorfina em adesivo transdérmico de matriz (sem reservatório)	RCE
A1, adendo 2	Difenoxilato até 2,5 mg por unidade com atropina (no mínimo 1% do difenoxilato)	RCE
A1, adendo 4	Ópio, derivados sintéticos e difenoxilato em forma líquida ou xarope de uso pediátrico	Proibido
A2, adendo 2	Codeína, diidrocodeína, etilmorfina, folcodina e afins: até 100 mg por unidade posológica e até 2,5% nas formas indivisíveis, isoladas ou associadas	RCE (ex.: paracetamol com codeína 30 mg)
A2, adendo 3	Tramadol até 100 mg por unidade posológica, isolado ou associado	RCE
A2, adendo 5	Nalbufina até 10 mg de cloridrato por unidade posológica	RCE
A3, adendo 2	Medicamento registrado com derivados de Cannabis até 30 mg/mL de THC e 30 mg/mL de canabidiol	Notificação A
A3, adendo 12	Produto de Cannabis (RDC 1.015/2026) com THC até 0,2%	RCE
B1, adendo 2	Fenobarbital, metilfenobarbital, barbital e barbexaclona	RCE
B1, adendo 9	Perampanel	RCE

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
B1, adendos 14 e 15	Cetamina e escetamina: dispensação e uso só em estabelecimento de saúde; escetamina nasal administrada sob observação	Não se dispensa em drogaria
B1, adendo 16	Carisoprodol	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 2	Loperamida	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 4	Misoprostol	Compra e uso só em hospital cadastrado
C1, adendo 5	Tetracaína: tópico odontológico isolado sem prescrição; otológico com prescrição sem retenção; oftálmico com retenção	Depende da forma
C1, adendos 7 e 10	Benzidamina em spray, pastilha, colutório, gel e afins; prometazina	Fora do controle da 344
C2, adendo 2	Retinoides de uso tópico	Prescrição sem retenção
C5, adendo 2	Anabolizantes de uso tópico	Prescrição sem retenção

ATENÇÃO

O zolpidem está na lista B1 **sem adendo**. O antigo adendo que permitia receita de controle especial para apresentações de até 10 mg foi excluído pela Anvisa em 2024; desde 1º de agosto de 2024 qualquer medicamento com zolpidem exige Notificação de Receita B, e as embalagens passaram a ter tarja preta. Metilfenidato e lisdexanfetamina não têm adendo de concentração: qualquer apresentação exige Notificação A.

Como raciocinar com o adendo

Três perguntas resolvem quase todo caso: qual é a substância e a quantidade por unidade posológica; o produto é isolado ou associado; qual é a forma farmacêutica. Um comprimido de paracetamol 500 mg com fosfato de codeína 30 mg tem 30 mg de entorpecente por unidade, abaixo de 100 mg, e cai no adendo 2 da A2: RCE em duas vias. Uma ampola de tramadol 100 mg/2 mL tem 100 mg por unidade, o limite do adendo, e também vai em RCE. Já um comprimido de oxicodona de liberação controlada de 80 mg passa do limite de 40 mg e exige Notificação A.

NO BALCÃO

Quando a apresentação for nova ou rara, pesquise a DCB na lista consolidada da Anvisa e leia o adendo inteiro antes de recusar ou aceitar. O sistema de gestão da loja costuma classificar o produto pela lista, mas pode estar desatualizado depois de uma RDC recente: a decisão final é do farmacêutico.

Termos exigidos além da receita

Alguns medicamentos pedem um termo assinado por prescritor e paciente. O termo é documento separado da receita: pode ser eletrônico (assinatura avançada basta) mesmo quando a receita é de papel, e vice-versa. O que muda para a farmácia é se o termo precisa ser apresentado e se uma via fica retida. A tabela resume o quadro da cartilha da Anvisa de setembro de 2026.

Medicamento	Receituário	Termo e norma	Na farmácia
Sibutramina	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo I)	Apresentado; 1 via retida
Anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo II)	Apresentado; 1 via retida
Isotretinoína e outros retinoides sistêmicos	Notificação especial C2	Termo de Consentimento Pós-Informação (Portaria 344, anexos XV e XVI)	Apresentado; 1 via retida
Fenfluramina	Notificação A	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Apresentado; sem via para a farmácia
Cenobamato	RCE	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Não exigido na dispensação
Mavacanteno	RCE	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 784/2023)	Apresentado; 1 via retida
Produtos de Cannabis	NR A ou RCE, conforme o THC	TCLE (RDC 1.015/2026)	Não exigido nem retido
Talidomida	Notificação de talidomida	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 11/2011)	Apresentado; 1 via na unidade pública

Cannabis em 2026

A regulação mudou em 2026. A RDC 1.011/2026 (vigência em 4 de agosto de 2026) incluiu na lista C1 a Cannabis sativa com THC até 0,3%, e a lista E passou a ter adendos que remetem os produtos de Cannabis regularizados (RDC 1.015/2026) e os medicamentos registrados para a lista A3. Pelo adendo 12 da A3, incluído pela RDC 1.023/2026, os produtos com THC até 0,2% são prescritos em RCE; acima disso, em Notificação A. A cartilha da Anvisa de setembro de 2026 registra que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desses produtos fica com prescritor e paciente e não é retido pela farmácia.

CASO

Cliente de 52 anos apresenta Receita de Controle Especial de tramadol 50 mg com paracetamol 325 mg, 60 comprimidos, posologia de 1 comprimido a cada 8 horas. O tramadol está na A2, mas o adendo 3 permite RCE porque há 50 mg por unidade. A quantidade corresponde a 20 dias, dentro do limite de 60 dias da RCE. A dispensação é regular, conferidos os demais campos.

Receituários de controle especial

Cada lista tem um receituário próprio. Saber reconhecer o modelo, quem o fornece, quanto tempo vale e quanto pode ser dispensado é o núcleo da conferência no balcão. Em 2024 e 2025 houve três mudanças grandes: a numeração passou a ser nacional, gerada pelo SNCR (RDC 873/2024); as notificações passaram a valer em todo o território; e a RDC 1.000/2025 revogou os modelos dos anexos da 344, criou os modelos físicos novos e abriu a via eletrônica.

Quadro geral

Receituário	Listas	Validade	Quantidade máxima	Substâncias por receita
Notificação A (amarela)	A1, A2, A3	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias de tratamento	1
Notificação B (azul)	B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias de tratamento	1
Notificação B2 (azul)	B2	30 dias	30 dias; sibutramina 60 dias	1
Notificação especial de retinoides (branca)	C2 sistêmicos	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias	1
Notificação de talidomida (branca)	C3 (talidomida)	20 dias, todo o país	30 dias de tratamento	Só talidomida
Receita de Controle Especial (branca, 2 vias)	C1, C5 e adendos de A1, A2, B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses	Até 3

Fontes da tabela: Portaria 344, arts. 35, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57 e 59 (redações das RDC 873/2024 e 1.000/2025); RDC 58/2007; RDC 50/2014, art. 5º (redação da RDC 133/2016); RDC 11/2011, art. 21.

Quem fornece a numeração e quem imprime

Até 2025 a Notificação A era impressa e entregue pela Vigilância Sanitária, com carimbo nas folhas. Isso mudou. Desde 13 de fevereiro de 2026, data de vigência da RDC 1.000/2025, **todos os talonários de controlados podem ser impressos em gráfica pelo próprio prescritor ou pela instituição, à sua custa**, seguindo o modelo oficial do portal da Anvisa (Portaria 344, arts. 40 e 45, redação da RDC 1.000/2025). O que continua obrigatório é a **numeração fornecida pela autoridade sanitária local**, que desde 1º de julho de 2025 é gerada no SNCR.

- **Notificação A e talidomida**: o prescritor se cadastra na VISA, recebe a numeração pelo SNCR (com comprovante eletrônico) e manda imprimir. A VISA pode continuar imprimindo, se quiser: virou faculdade, não obrigação. Blocos já impressos pela VISA valem por prazo indeterminado (RDC 1.000/2025, art. 19).

- **Notificação B, B2 e retinoides**: o profissional retira a numeração na VISA do local do consultório ou da instituição e imprime em gráfica (Portaria 6/1999, art. 75).
- **Receita de Controle Especial física**: não tem numeração oficial. Pode usar o modelo da Anvisa ou outro leiaute, desde que traga escrito "Receita de Controle Especial" e todos os campos obrigatórios. Receita comum com os dados da RCE não é mais aceita para novas prescrições.

A numeração do SNCR tem 14 dígitos no padrão AAMM, tipo de notificação, código IBGE da UF e sequencial (exemplo da cartilha da Anvisa: 2509.1-53.0012345). Por isso a sigla da UF deixou de ser um campo impresso separado (RDC 1.000/2025 revogou a alínea "a" do art. 36). Numeração física só serve para papel e numeração eletrônica só serve para receita eletrônica.

Modelos físicos em circulação

Versão	Período de impressão	Uso
Modelos dos anexos da Portaria 344	Até 12/02/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 1 dos novos modelos	13/02/2026 a 17/05/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 2 (vigente)	Desde 18/05/2026	Obrigatória para novas impressões

A cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) orienta: usar modelo anterior não é, sozinho, motivo de recusa, desde que tenha sido impresso quando estava vigente. A data de impressão não é campo obrigatório.

Campos obrigatórios da Notificação de Receita

O art. 36 da 344, com a redação da RDC 1.000/2025, lista os campos. Os itens de numeração e de identificação do emitente vêm impressos; o restante é preenchido pelo prescritor e, no verso ou por carimbo, pela farmácia.

- Identificação numérica: sequência concedida pela autoridade sanitária.
- Emitente: nome do profissional, inscrição no conselho com a sigla da UF, endereço completo e telefone; ou nome da instituição, CNPJ (ou CNES, se pública), endereço e telefone. O endereço do consultório ou da residência do profissional é obrigatório nos modelos da versão 2 (Lei 5.991/1973, art. 35).
- Paciente: nome e **CPF**, ou passaporte se estrangeiro; no uso veterinário, nome e CPF do proprietário e identificação do animal. Sem CPF, o prescritor pode anotar "não possui" (Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a RDC 1.000/2025). Os modelos da versão 2 trazem também o endereço do paciente.
- Medicamento ou substância pela DCB, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, **quantidade em algarismos arábicos e por extenso** e posologia.
- Símbolo de gestante cortada ao meio e a advertência sobre defeitos no feto, nas notificações de retinoides.
- Data da emissão e assinatura do prescritor (se o nome não estiver impresso, identificação legível ou carimbo).

- Identificação do comprador: nome e CPF, ou passaporte; endereço completo e telefone.
- Identificação do estabelecimento dispensador: nome, CNPJ (ou CNES), endereço, nome do responsável pela dispensação e data.
- Identificação da gráfica: nome, endereço e CNPJ no rodapé.
- Quantidade aviada anotada no verso e, em fórmula magistral, o número de registro da receita.

PONTO-CHAVE

A Notificação é **personalizada e intransferível** e contém uma única substância ou um único medicamento (Portaria 344, art. 35, § 7º). Precisa estar legível, sem emenda ou rasura, com a quantidade em algarismos e por extenso (§ 3º). A farmácia só dispensa com todos os itens preenchidos (§ 4º). A notificação fica retida e a receita que a acompanha volta ao paciente carimbada (§ 5º).

Notificação de Receita A

Cor amarela, para as listas A1, A2 e A3. Vale 30 dias a partir da emissão em todo o território nacional (art. 41, redação da RDC 873/2024). Pode conter até 5 ampolas ou, nas demais formas, a quantidade para 30 dias de tratamento (art. 43). Acima disso, o prescritor entrega justificativa com CID ou diagnóstico, posologia, data e assinatura, e a farmácia a envia junto com a notificação à VISA na Relação Mensal de Notificações de Receita A (art. 43, §§ 1º e 2º). Quando em papel, a notificação vem acompanhada de receita (art. 35).

Notificação de Receita B e B2

Cor azul. A **B** serve à lista B1: 30 dias em todo o território (art. 45, redação da RDC 1.000/2025), até 5 ampolas ou 60 dias de tratamento (art. 46). A **B2** é a notificação dos anorexígenos (RDC 58/2007): até 30 dias de tratamento, com exceção da sibutramina, que pode chegar a 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º, §§ 1º e 2º). Os medicamentos da RDC 50/2014 têm dose diária máxima (sibutramina 15 mg/dia; anfepramona 120 mg/dia; femproporex 50 mg/dia; mazindol 3 mg/dia) e exigem **Termo de Responsabilidade do Prescritor** em 3 vias: prontuário, farmácia e paciente (art. 6º). É proibido associar anorexígenos entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes e outras substâncias (Portaria 344, art. 47).

Notificação de Receita Especial para retinoides

Cor branca, para retinoides de **uso sistêmico** da lista C2 (isotretinoína, acitretina, bexaroteno). Vale 30 dias em todo o território e cobre até 5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, redação da RDC 873/2024). É acompanhada do Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344), que pode ser eletrônico com assinatura avançada (art. 50, § 3º). A cartilha da Anvisa indica termo em 3 vias, uma retida pela farmácia. No modelo novo não há mais o campo "tratamento inicial ou subsequente" nem a substância pré-impressa: o prescritor escreve o nome.

Notificação de Receita de Talidomida

Cor branca, em 2 vias, regida pela RDC 11/2011. Vale 20 dias em todo o território (art. 21, § 2º, redação da RDC 873/2024) e cobre no máximo 30 dias de tratamento (§ 3º). Só pode conter talidomida e vem com o Termo de Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias (prontuário, unidade dispensadora, paciente). A

talidomida não tem venda comercial; a dispensação ocorre apenas em unidades públicas credenciadas, o que tira esse modelo da rotina da drogaria. Mesmo assim cai em prova.

Receita de Controle Especial

Branca, em 2 vias: a 1ª fica retida na farmácia e a 2ª volta ao paciente com o carimbo do atendimento (Portaria 344, arts. 52 e 53; Portaria 6/1999, art. 84). Vale 30 dias em todo o território. Até 3 substâncias da C1 por receita (art. 57), cada uma limitada a 5 ampolas ou 60 dias; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, até 6 meses (art. 59). Acima disso, justificativa com CID ou diagnóstico e posologia, datada e assinada nas duas vias (art. 60). Serve para C1, C5 e para os adendos que mandam usar RCE (codeína, tramadol, fenobarbital e outros).

O QUE DIZ A NORMA

"A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente uma substância das listas [...] ou um medicamento que as contenham." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 35, § 7º)

Receita eletrônica de controlados

A RDC 1.000/2025 permite emitir em meio eletrônico as Notificações A, B e B2, a de retinoides, a de talidomida, a RCE e a receita sujeita à retenção (art. 2º). As regras centrais:

- Emissão só em serviço de prescrição eletrônica integrado ao SNCR por API; serviço não integrado não pode emitir (art. 4º).
- Cada receita tem numeração individual concedida pelo SNCR e segue o modelo eletrônico da Anvisa (art. 7º). Para notificações, o prescritor pede a cota de numeração eletrônica à VISA; o serviço de prescrição consome essa cota. Para RCE e receita sujeita à retenção, o SNCR gera o número automaticamente.
- Notificação e RCE eletrônicas exigem **assinatura qualificada ICP-Brasil** (art. 8º; Lei 14.063/2020, art. 13). Receita sujeita à retenção aceita assinatura avançada, como a do gov.br (art. 11).
- A notificação eletrônica dispensa a receita que acompanhava a de papel (art. 9º). RCE e receita de retenção eletrônicas não têm duas vias (art. 10).
- A data da assinatura eletrônica é a data de emissão, de onde conta a validade (art. 12).
- Papel escaneado, foto de receita ou documento físico assinado digitalmente depois **não** são receita eletrônica (art. 2º, parágrafo único).

O SNCR passou a oferecer a numeração eletrônica e o registro de uso em 30 de setembro de 2026 (art. 16, redação da RDC 1.028, de 1º de junho de 2026). Antes dessa data só RCE e receita de retenção podiam ser eletrônicas; as notificações eram apenas em papel. Pelo art. 18, RCE e receita de retenção eletrônicas sem número do SNCR ainda foram aceitas por 30 dias a partir dessa data, ou seja, até o fim de outubro de 2026; uma receita assim emitida dentro da janela continua dispensável enquanto estiver no prazo de validade.

NO BALCÃO

Paciente mostra no celular uma "Notificação B" em PDF. Antes de tudo, confirme se é nato-digital: tem número do SNCR, QR Code e assinatura ICP-Brasil validável no Validar do ITI. Se for foto de um talão azul, não é receita eletrônica e não pode ser aceita; peça a via original em papel.

Receita de emergência

Em emergência, medicamento sujeito a notificação pode ser aviado com receita em papel não oficial, desde que traga diagnóstico ou CID, justificativa do caráter emergencial, data, inscrição no conselho e assinatura identificada. A farmácia anota a identificação do comprador e apresenta a receita à VISA em até 72 horas para visto (art. 36, § 2º). A regra existe também para a C1 (art. 55, § 2º). A RDC 1.000/2025 manteve essa via só para o papel e deixou claro que ela não substitui a obtenção regular de numeração.

CASO

Médica prescreve clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, em Notificação B. São 90 dias de tratamento, acima do limite de 60 dias. Sem justificativa com CID ou diagnóstico, data e assinatura entregue junto (art. 46, § 1º), a farmácia não deve dispensar a quantidade integral. Com a justificativa, a dispensação dos 90 comprimidos é regular.

Dispensação de controlados no balcão

Dispensar um controlado é uma sequência de conferências. Cada etapa tem base normativa, e o erro em qualquer uma delas transforma a venda em infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XI). A ordem abaixo segue a lógica da cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) e os arts. 35, 36, 52 e 55 da Portaria 344.

Conferência passo a passo

1. **Identificar o medicamento e a lista.** DCB, concentração por unidade, forma farmacêutica e adendo. Isso define o receituário exigido.
2. **Conferir o tipo de documento.** Notificação da cor e do modelo certos; RCE identificada como "Receita de Controle Especial". Receita comum não serve para medicamento da 344 (Perguntas e Respostas da Anvisa, 2ª edição, perguntas 67 e 68).
3. **Verificar o modelo.** Modelo antigo, versão 1 ou versão 2, desde que impresso no período em que estava vigente.
4. **Conferir a numeração** (notificações). Se tiver o padrão do SNCR, consultar na base nacional: número idêntico, situação "autorizada", tipo correto, meio "físico" para papel, prescritor ou instituição iguais aos do documento. Numeração anterior ao SNCR não aparece no sistema e isso, sozinho, não invalida.
5. **Conferir o prescritor.** Nome, conselho e UF, endereço, assinatura. Dentista e veterinário só para uso odontológico ou veterinário.
6. **Conferir o paciente.** Nome e CPF (ou passaporte; "não possui" é aceito). No uso veterinário, proprietário e animal.

7. **Conferir a prescrição.** DCB ou nome do medicamento, concentração, forma, quantidade em algarismos e por extenso, posologia. Uma substância por notificação; até três na RCE.
8. **Conferir data e validade.** Contar os dias a partir da emissão (no eletrônico, da assinatura).
9. **Conferir a quantidade.** Dentro do limite de dias ou ampolas, ou acompanhada de justificativa.
10. **Conferir exigências específicas.** Termos (retinoides, B2, talidomida, fenfluramina), receita que acompanha a notificação em papel, restrições de local (cetamina e escetamina só em estabelecimento de saúde; misoprostol só hospitalar).
11. **Identificar o comprador** com documento.
12. **Dispensar, anotar, carimbar, reter e escriturar.**

Rasura, legibilidade e quantidade

A Notificação e a RCE devem estar legíveis, com quantidade em algarismos arábicos e por extenso, **sem emenda ou rasura** (art. 35, § 3º; art. 52, § 1º). Divergência entre o número e o extenso, corretivo, letra sobreposta ou campo em branco impedem a dispensação, porque a farmácia só pode aviar com todos os itens preenchidos (art. 35, § 4º; art. 52, § 2º). Não cabe ao balconista completar ou corrigir: o paciente volta ao prescritor.

> **ATENÇÃO**
>
> Dispensar notificação rasurada, ilegível ou incompleta é aviar receita em desacordo com a norma, infração prevista na Lei 6.437/1977 (art. 10, XI), com pena que vai de advertência a cancelamento da licença e multa.

Identificação do comprador

Quem compra pode ser o próprio paciente ou outra pessoa. Na Notificação, a farmácia registra nome e CPF (ou passaporte) do comprador, endereço completo e telefone (art. 36, "i"; Portaria 6/1999, art. 82, "a"). Na RCE, os dados do comprador e do estabelecimento podem ser apostos por carimbo e preenchidos pela farmácia (Portaria 6/1999, art. 85, "c"). Peça documento oficial com foto e confira com o que será escrito. Em receita eletrônica, o SNCR exige CPF válido do comprador para registrar a utilização; estrangeiro sem CPF não consegue comprar com receita puramente eletrônica e deve trazer receita em papel (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 73).

Carimbo, verso e destino das vias

Os modelos novos tiraram do corpo da notificação os campos do estabelecimento dispensador: tudo vai para o verso ou para o carimbo. A Portaria 6/1999, art. 82, define o que a farmácia registra:

- carimbo do estabelecimento com CNPJ (ou CNES), nome e endereço completo, data e nome legível do responsável pelo atendimento abaixo do carimbo;
- carimbo próprio no verso com a **quantidade dispensada** e, em fórmula magistral, o número de registro da receita;
- para medicamento genérico, o nome do fabricante no campo de dispensação da RCE (Perguntas e Respostas, 1ª edição, pergunta 33).

Documento	Fica na farmácia	Volta ao paciente
Notificação em papel (A, B, B2, retinoides)	A notificação	A receita que a acompanha, carimbada
Receita de Controle Especial em papel	1ª via	2ª via, carimbada
Termo da RDC 50/2014 (B2)	1 via	1 via (a outra fica no prontuário)
Termo de retinoides (3 vias)	1 via	Demais vias conforme o termo
Receita eletrônica com número SNCR	Registro de utilização no SNCR, guardado em meio eletrônico	O arquivo continua com o paciente, já marcado como utilizado

Receita de outra UF

Desde a RDC 873/2024 não há visto para receita de outro estado: a Notificação A, a de retinoides e a RCE valem em todo o país, e a RDC 1.000/2025 estendeu a redação à Notificação B. A Anvisa reforça que prescrições de outros municípios e estados, inclusive de sistemas públicos como o e-SUS, seguem os mesmos critérios das locais (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 72). Normas estaduais complementares podem existir; o Ofício 39/2019 da Anvisa admite que o estado aplique regras próprias desde que não inviabilizem a validade nacional.

Emergência, internação e entrega remota

- **Emergência**: receita em papel não oficial com CID ou diagnóstico, justificativa, data, inscrição e assinatura; a farmácia anota o comprador e leva à VISA em 72 horas (art. 36, § 2º; art. 55, § 2º).
- **Paciente internado**: dispensa a notificação; vale a prescrição do estabelecimento (art. 35, § 6º). Na alta, volta a exigência do receituário próprio.
- **Entrega remota**: permitida pela RDC 812/2023 (arts. 34-A e 34-B da 344). A farmácia busca a notificação ou a RCE no endereço do paciente, ou recebe a receita eletrônica, e só entrega o medicamento depois que o farmacêutico confere a regularidade. Compra e venda de controlados pela internet continuam proibidas (art. 34-B, § 1º).

Quantidade dispensada e fracionamento

A farmácia dispensa até a quantidade prescrita e registra no verso o que entregou. A drogaria não fraciona embalagem de controlado (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109, § 1º); injetável pode ser dispensado pelo número de unidades da prescrição (art. 109, § 2º). Fracionamento só em farmácia, por farmacêutico, conforme legislação específica (art. 110). Notificação e RCE são de **uso único**: retida a via, não há saldo para buscar depois, e o SNCR não admite registro parcelado de notificação ou RCE eletrônica (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 74).

CASO

RCE de escitalopram 10 mg, 1 comprimido ao dia, 60 comprimidos. A loja tem só caixas de 30. O farmacêutico dispensa 2 caixas (60 comprimidos), anota "60 comprimidos" no verso da 1ª via, carimba as duas vias, retém a 1ª e devolve a 2ª. Se o paciente quisesse levar só uma caixa, a 1ª via seria retida do mesmo jeito e a segunda caixa exigiria nova receita.

Devolução e troca

Medicamento controlado que saiu da farmácia não volta para o estoque de venda. A orientação do CFF ao divulgar a retomada do SNGPC é que troca e devolução de controlados não são permitidas, salvo desvio de qualidade comprovado. Quando o tratamento é interrompido, a Portaria 6/1999 (art. 90) prevê que o paciente entregue as sobras à Vigilância Sanitária, que dá o destino (inutilização ou doação). Na prática, oriente o paciente a procurar a VISA ou o ponto de descarte indicado por ela.

NO BALCÃO

Antes de recusar uma receita, diga ao cliente exatamente o que está errado e o que ele deve pedir ao prescritor ("falta a quantidade por extenso", "a validade venceu ontem", "esta substância exige notificação azul"). A recusa bem explicada evita a ida a outra farmácia com o mesmo documento irregular e protege o paciente.

CASO

Rapaz de 19 anos traz Notificação A de metilfenidato 10 mg emitida há 32 dias, em nome da mãe, com CPF dela. A notificação venceu (30 dias, art. 41). O fato de o comprador ser outra pessoa não é problema: basta registrar os dados dele. A dispensação deve ser recusada pelo vencimento, com orientação para nova consulta.

Escrituração, guarda e inventário

Dispensar é metade do controle. A outra metade é provar, a qualquer momento, que o estoque físico de cada controlado bate com o que entrou, saiu e foi perdido. A Portaria 344 trata disso nos capítulos de escrituração (VI), guarda (VII) e balanços (VIII); a RDC 22/2014 trouxe a escrituração para o SNGPC; e a Portaria 6/1999 detalha a rotina e a troca de responsável técnico.

Guarda

Substâncias e medicamentos das listas devem ficar **sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo**, sob responsabilidade do farmacêutico (Portaria 344, art. 67). Na drogaria isso significa armário ou sala trancados, de uso só para controlados, com a chave sob controle do farmacêutico. O local de guarda da talidomida deve armazenar exclusivamente substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial (RDC 11/2011).

- Controlado não fica em gôndola, vitrine nem no balcão de atendimento.
- A chave não circula entre atendentes sem controle do farmacêutico.

- Medicamento vencido, avariado ou recolhido sai do estoque de venda, mas continua sob chave, segregado e identificado, até a destinação.

ATENÇÃO

Controlado fora do armário, sem nota fiscal ou documento hábil, pode ser apreendido, e o portador responde administrativamente (Portaria 344, art. 33). Nas listas A, B e D1, a VISA encaminha cópia do processo à autoridade policial.

Responsabilidade técnica

A escrituração é de responsabilidade do farmacêutico responsável técnico ou do substituto cadastrado e associado no SNGPC (RDC 22/2014, art. 10, § 1º). O RT pode delegar a digitação a terceiros, sob sua responsabilidade, mas a geração e o envio dos arquivos são funções dele (art. 18). A senha é pessoal e intransferível; o uso indevido recai sobre o RT e o responsável legal (art. 7º).

A troca de RT tem rito próprio. O farmacêutico que sai apresenta à VISA o levantamento do estoque de controlados até o último dia de trabalho (Portaria 6/1999, art. 113). No SNGPC, a substituição é precedida da finalização do inventário; o novo RT confere o inventário, corrige divergências antes de começar e informa a VISA (RDC 22/2014, art. 12). Na ausência do RT sem substituto, as transmissões continuam com arquivos sem movimentação de controlados ao fim do período (art. 11).

Livros e escrituração eletrônica

O texto original da 344 exige Livro de Registro Específico para farmácias e drogarias e Livro de Receituário Geral para farmácias magistrais, com termos de abertura e encerramento lavrados pela VISA (arts. 62 e 63). Cada página do livro registra uma só substância ou medicamento, pela DCB combinada com o nome comercial, em ordem cronológica de estoque, entradas, saídas e perdas (arts. 63, § 3º, e 65). A escrituração deve ser legível, sem rasuras, atualizada semanalmente (art. 64, § 1º).

Para farmácias e drogarias, a RDC 22/2014 substituiu o livro pela escrituração no SNGPC (art. 35). O livro só sobrevive em exceções: município sem acesso à internet, com autorização da VISA (art. 35, § 1º); e, no sistema informatizado da loja, apresentações fracionáveis e medicamentos com inconsistência cadastral (§ 3º). As farmácias públicas que dispensam com ressarcimento, como as do Farmácia Popular, escrituram antimicrobianos em livro ou sistema aprovado pela VISA em até 7 dias (RDC 471/2021, art. 15, redação da RDC 973/2025).

PONTO-CHAVE

O estoque físico de cada controlado deve ser **qualitativa e quantitativamente idêntico** ao escriturado no SNGPC e no sistema da loja, respeitado o prazo de escrituração (RDC 22/2014, art. 15). Todo estoque movimentado deve estar escriturado, comercializável ou não (art. 16).

Balanços e relações

A 344 ainda prevê documentos periódicos enviados à VISA. Na drogaria, dois interessam:

Documento	Conteúdo	Prazo na Portaria 344
BMPO (Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros Sujeitos a Controle Especial)	Vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2	Trimestral, até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro; anual até 31 de janeiro (art. 69)
RMNRA (Relação Mensal de Notificações de Receita A)	Notificações A retidas, entregues com as próprias notificações	Mensal, até o dia 15; VISA devolve as notificações em 30 dias (art. 72)

Esses artigos continuam no texto da 344, e a própria Anvisa, no Perguntas e Respostas de 2026, fala em "balanços periódicos" das listas A e B2 e admite que a VISA local peça vias impressas ou relatórios das receitas eletrônicas para conferi-los. A forma de entrega (papel, sistema estadual, relatório do SNGPC) varia entre as VISAs. Confirme a rotina com a vigilância do seu município. A falta de remessa no prazo é infração (art. 73). Notificações A eletrônicas podem ser enviadas à VISA em meio eletrônico (art. 72, § 2º-A, incluído pela RDC 1.000/2025).

Prazos de guarda

- Livros, balanços e demais documentos de movimentação de estoque: **2 anos** no estabelecimento (Portaria 344, art. 64). Inclui notificações e RCE retidas.
- Cópia de segurança da escrituração do SNGPC: 2 anos (RDC 22/2014, art. 19, I).
- Registros de utilização de receitas eletrônicas: em meio eletrônico, pelo prazo da 344 e da RDC 11/2011, disponíveis à fiscalização (RDC 1.000/2025, art. 14).
- Talidomida: prazos maiores da RDC 11/2011 (livro da unidade pública dispensadora).

Perda, furto e roubo

O SNGPC trata como **perda** a saída por vencimento, apreensão ou recolhimento pela VISA, roubo ou furto, avaria, desvio de qualidade, exclusão da lista, amostra para controle de qualidade ou análise fiscal e devolução ao fabricante (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV). Cada uma é escriturada como perda, com o motivo.

- **Furto ou roubo de medicamento**: registrar boletim de ocorrência, comunicar a VISA, escriturar a perda com o motivo e guardar o B.O. como justificativa. A Portaria 6/1999 lista o boletim de ocorrência entre as justificativas de perda por extravio.
- **Furto, roubo ou extravio de talonário de notificação**: obrigação do responsável (prescritor ou instituição) de informar imediatamente a VISA com o B.O. (Portaria 344, art. 39). Se a farmácia souber do fato, a VISA também costuma divulgar a numeração cancelada. No SNCR, número cancelado aparece como "cancelada" e não pode ser usado.

Vencidos e inutilização

O medicamento controlado vencido é baixado como perda por vencimento e segregado sob chave. A Portaria 6/1999 cita o termo de inutilização expedido pela VISA entre os documentos que justificam a perda. A destinação final segue o plano de gerenciamento de resíduos do estabelecimento e a orientação da VISA local, que em muitos municípios exige comunicação prévia ou termo para inutilizar controlados. Não descarte em lixo comum nem devolva ao distribuidor sem documento fiscal.

NO BALCÃO

Faça contagem cega dos controlados de maior giro (clonazepam, alprazolam, zolpidem, metilfenidato) com frequência fixa, por exemplo semanal, e compare com o saldo do sistema. Divergência descoberta cedo tem explicação rastreável: nota não lançada, receita escriturada com quantidade errada, perda não registrada.

Inventário na prática

Inventário é a contagem física de todo o estoque de controlados e antimicrobianos, item a item, por lote e validade. Ele aparece em três momentos obrigatórios: no credenciamento do SNGPC (inventário inicial), na troca de responsável técnico (finalização pelo que sai e conferência pelo que entra) e no retorno às transmissões depois de um período de suspensão, quando a orientação divulgada pelo CFF foi fechar o inventário anterior e abrir um novo com contagem física. Além desses, a contagem periódica por amostragem é a ferramenta de controle interno.

1. Escolher um horário sem movimento e suspender as dispensações de controlados durante a contagem.
2. Imprimir do sistema a posição de estoque por produto, lote e validade.
3. Contar sem olhar o saldo do sistema (contagem cega), de preferência em dupla.
4. Comparar e investigar cada divergência: notas fiscais não lançadas, receitas escrituradas com erro, perdas não baixadas.
5. Corrigir os lançamentos que tiverem documento; o que não tiver explicação segue o caminho de perda, com boletim de ocorrência e comunicação à VISA quando houver suspeita de desvio.
6. Assinar e arquivar a folha de contagem com data e responsáveis.

Vencidos, avariados e recolhidos entram na contagem, porque continuam no estoque escriturado até a baixa como perda.

Encerramento de atividades

Ao fechar a loja, o estabelecimento entrega os controlados à VISA com relação em 2 vias (quantidades, lotes, validades) ou transfere a outro estabelecimento por nota fiscal visada pela VISA do remetente; nota ao consumidor não serve (Portaria 6/1999, art. 115). Pela RDC 22/2014 (art. 13), a transferência por encerramento, mudança de atividade ou junção é escriturada no SNGPC, e quem recebe escritura a entrada pela nota do estabelecimento que encerrou.

CASO

Na contagem de segunda-feira faltam 2 caixas de alprazolam 1 mg. O farmacêutico revisa as dispensações e acha uma Notificação B escriturada como 1 caixa quando foram entregues 3. Corrige o lançamento no sistema e no SNGPC dentro do prazo e registra a correção. Se a diferença não tivesse explicação, o caminho seria boletim de ocorrência, comunicação à VISA e escrituração da perda.

SNGPC

O **Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)** é o sistema da Anvisa em que farmácias e drogarias escrituram eletronicamente a movimentação de medicamentos da Portaria 344 e de antimicrobianos. Ele substitui o livro de registro e permite à vigilância acompanhar, quase em tempo real, quanto de cada controlado entra e sai de cada loja.

Histórico curto

- **2007**: criado pela RDC 27/2007 para farmácias e drogarias.
- **2011**: antimicrobianos passam a ser escriturados, com a RDC 20/2011 (hoje substituída pela RDC 471/2021).
- **2014**: a RDC nº 22, de 29 de abril de 2014, revoga a RDC 27/2007 e passa a regular o sistema. Continua vigente.
- **2021**: por instabilidade técnica, a RDC 586/2021 suspende por tempo indeterminado os prazos de transmissão. As farmácias continuam obrigadas a escriturar nos registros internos.
- **2025 e 2026**: a Anvisa restabelece a transmissão obrigatória por região: Sudeste desde 1º/09/2025; Sul e Norte desde 1º/11/2025; Centro-Oeste e Nordeste desde 02/01/2026. Em 2025 o sistema ganhou o campo de inscrição no Coren para antimicrobianos prescritos por enfermeiro com amparo legal.

Em outubro de 2026, portanto, **a transmissão é obrigatória em todo o país**, e o descumprimento do cronograma é infração sanitária. A Anvisa não divulgou cronograma de integração entre SNGPC e SNCR (Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025, 2ª edição).

Abrangência

O SNGPC abrange os medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria 344 e os antimicrobianos da RDC 471/2021, cuja lista está na IN nº 360, de 23 de abril de 2025, e, desde 23/06/2025, os agonistas de GLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida, lixisenatida) incluídos na RDC 471/2021 pela RDC 973/2025 (RDC 22/2014, art. 2º). Todas as farmácias e drogarias são obrigadas (art. 3º). Farmácias públicas e de hospital ficam fora enquanto não houver módulo específico (art. 3º, parágrafo único). O adendo 14 da C1 é um exemplo de exceção pontual: molnupiravir apenas com autorização de uso emergencial fica fora do SNGPC e vai para livro.

Acesso e credenciamento

1. Cadastro do estabelecimento, do gestor de segurança, do farmacêutico RT e do responsável legal na Anvisa (art. 6º).
2. Acesso por senha pessoal e intransferível (art. 7º).
3. **Inventário inicial**: o RT declara todo o estoque de controlados e antimicrobianos em arquivo XML; isso credencia o estabelecimento (arts. 5º, XIX, e 8º).
4. Emissão do **Certificado de Escrituração Digital**, que fica impresso à disposição da fiscalização (art. 9º).

O **Certificado de Transmissão Regular** é o documento que a VISA e as distribuidoras podem pedir para atestar que a loja transmite em dia (art. 5º, VI). Algumas VISAs já o exigem na renovação da licença

sanitária.

Regras de transmissão

O QUE DIZ A NORMA

"Os dados da escrituração sanitária devem ser transmitidos eletronicamente em arquivos no intervalo de, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 7 (sete) dias consecutivos, ainda que nenhuma movimentação no estoque do estabelecimento tenha ocorrido no respectivo período." (RDC 22/2014, art. 10, § 3º)

- A transmissão é atualizada no mínimo uma vez por semana (art. 10, § 4º).
- Semana sem movimento também gera arquivo.
- Um arquivo novo só pode ser enviado depois que o anterior estiver "aceito" (a sequência é recebido, validado, aceito).
- Inconsistência que impeça o envio é notificada no próprio SNGPC; enquanto isso, as movimentações ficam no sistema da loja (art. 14).
- Instabilidade do próprio SNGPC não gera autuação por atraso (art. 33).

O que se escritura

Entradas (compra, transferência entre lojas da mesma raiz de CNPJ), saídas (venda ou dispensação, transferência, perda) e, nas farmácias de manipulação, transformação. Para insumos, o lote do fabricante (art. 10, § 5º). Na venda, os dados da receita: tipo, número, data, prescritor e conselho, paciente, comprador, medicamento, lote e quantidade. Na receita eletrônica a Anvisa manda informar o número do receituário no mesmo campo usado para o papel (Perguntas e Respostas, pergunta 35 da 2ª edição). O número do SNCR tem 14 dígitos, e o CFF divulgou a orientação de excluir os quatro primeiros dígitos (ano e mês) ao lançar números do SNCR. Siga o leiaute vigente do sistema da loja e a orientação da VISA.

Rotina diária e semanal

Quando	O que fazer
A cada dispensação	Lançar no sistema da loja os dados da receita, do comprador, lote e quantidade; conferir antes de salvar
Ao receber mercadoria	Lançar a entrada pela nota fiscal, com lote e validade, no mesmo dia
Diariamente	Revisar pendências e inconsistências; separar receitas retidas do dia por tipo
Até 7 dias do último envio	Gerar o XML, transmitir e acompanhar até "aceito"
Semanalmente	Contagem por amostragem dos itens de maior giro e comparação com o saldo
Mensalmente	Conferir arquivamento das receitas; RMNRA quando exigida pela VISA

Quando	O que fazer
Troca de RT	Finalizar inventário; novo RT confere e corrige antes de transmitir

NO BALCÃO

Lance a dispensação no momento do atendimento, com a receita na mão. Deixar para o fim do dia é a origem mais comum de quantidade errada, comprador trocado e lote inexistente. Se perceber erro depois de transmitido, corrija pelo procedimento do sistema e registre o motivo.

Sigilo dos dados

O sistema da loja deve garantir sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade, e é vedado repassar a terceiros dados capazes de identificar padrões de prescrição, dispensação ou consumo (RDC 22/2014, art. 21). Vender ou ceder relatórios de prescrição por médico, por exemplo, é proibido. A LGPD (Lei 13.709/2018) se soma a essa regra.

CASO

Drogaria de Fortaleza transmitiu o último arquivo numa quinta-feira e só voltou a transmitir na sexta da semana seguinte: 8 dias. Mesmo sem venda de controlado no período, o arquivo deveria ter sido enviado até a quinta. Desde 02/01/2026 a obrigatoriedade vale para o Nordeste, e o atraso pode gerar autuação, salvo se a causa for instabilidade comprovada do próprio SNGPC (art. 33).

SNCR

O **Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR)** é o sistema da Anvisa que gera, distribui e controla a numeração das receitas de controlados. Ele foi instituído pela **RDC nº 873, de 27 de maio de 2024** (DOU de 03/06/2024), entrou em funcionamento em 18 de julho de 2024 e, desde 1º de julho de 2025, é de uso obrigatório pelas Vigilâncias Sanitárias para gerar a numeração das notificações. Em 30 de setembro de 2026 começou a etapa eletrônica: o SNCR passou a numerar receitas eletrônicas e as farmácias passaram a registrar nele a utilização dessas receitas (RDC 1.000/2025, art. 16, com a data dada pela RDC 1.028/2026).

PONTO-CHAVE

O SNCR controla **a receita** (numeração, autenticidade, uso único). O SNGPC controla **o medicamento** (entradas, saídas, estoque). Os dois coexistem e um não substitui o outro.

Normas que regem o SNCR

Norma	Data	O que trouxe
RDC 873/2024	27/05/2024	Institui o SNCR; numeração nacional; validade nacional da Notificação A, de retinoides e de talidomida; fim do visto para receita de outro estado
RDC 1.000/2025	11/12/2025 (DOU 15/12/2025; vigência 13/02/2026)	Receituários eletrônicos integrados ao SNCR; novos modelos físicos; CPF do paciente; impressão em gráfica pelo prescritor; registro de uso pela farmácia
RDC 1.028/2026	01/06/2026 (DOU 02/06/2026)	Adia para 30/09/2026 a disponibilização das funções eletrônicas

Para quais receituários vale

- **Notificações físicas (A, B, B2, retinoides, talidomida)**: numeradas pelo SNCR desde 1º/07/2025. A farmácia consulta o número na base nacional para conferir, mas **não registra uso** de receita em papel.
- **Notificações eletrônicas**: existem desde 30/09/2026. Número do SNCR, emissão por serviço integrado, consulta e registro de uso obrigatório pela farmácia.
- **RCE e receita sujeita à retenção eletrônicas** (antimicrobianos, agonistas do receptor de GLP-1): passaram a receber número automático do SNCR; sem número, só foram aceitas as emitidas até o fim da janela de transição de 30 dias (RDC 1.000/2025, art. 18).
- **RCE e receita de retenção em papel**: continuam **sem número** do SNCR.

Como o prescritor obtém a numeração

Para o papel, o prescritor (ou a instituição) se cadastra na Vigilância Sanitária do local onde atende e pede a numeração. A VISA gera e atribui os números no SNCR; o comprovante eletrônico do sistema formaliza a entrega, sem necessidade de comparecer para carimbar talões (Portaria 344, art. 40, § 4º; Portaria 6/1999, arts. 69, § 3º, e 75, § 2º, redação da RDC 1.000/2025). Depois, ele manda imprimir em gráfica, no modelo oficial. Quem atende em vários estados, inclusive por telemedicina, pede numeração na VISA de cada estado onde atua (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 54).

Para o eletrônico, o prescritor pede à VISA uma cota de numeração eletrônica de notificações. O serviço de prescrição integrado consome essa cota ao emitir. O prescritor não acessa o SNCR diretamente e não pode digitar um número num modelo e gerar o documento por conta própria: notificação emitida fora de serviço integrado não deve ser aceita (pergunta 49). A emissão é pessoal: instituições e terceiros não emitem em nome do prescritor (RDC 1.000/2025, art. 6º).

Situações do número na consulta

Situação	Significado	Conduta
Autorizada	Número válido e disponível	Prosseguir com as demais conferências

Situação	Significado	Conduta
Não atribuída ao prescritor	Número de Notificação A ou talidomida gerado mas não vinculado	Não dispensar; orientar o prescritor a regularizar com a VISA
Cancelada	Cancelada pela VISA (ex.: talão furtado)	Não dispensar
Inválida	Número digitado errado ou fora do padrão	Redigitar; se for numeração anterior ao SNCR, conferir com a VISA em caso de dúvida
Receita utilizada	Receita eletrônica já registrada	Não dispensar
Receita utilizada parcialmente	Só em receita de retenção com parcelamento permitido	Dispensar o saldo se a norma específica admitir

Fonte: cartilha da Anvisa "SNCR e receituários controlados" (setembro de 2026) e Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025.

O que a farmácia confere

1. Número idêntico ao do documento.
2. Situação "autorizada".
3. Tipo de receituário igual ao apresentado.
4. Meio de emissão: físico para papel, eletrônico para receita eletrônica. Número de um meio não serve no outro.
5. Prescritor ou instituição vinculados ao número iguais ao emitente.
6. No eletrônico, também: assinatura válida no Validar do ITI (ICP-Brasil para notificação e RCE) e data da assinatura dentro da validade.

A tela do SNCR não mostra paciente nem prescrição: esses dados continuam sendo conferidos no próprio documento (pergunta 79). "Autorizada" não dispensa a conferência da validade e dos campos obrigatórios.

Registro de utilização

Na dispensação de receita eletrônica, a farmácia valida a assinatura no serviço do ITI, confere a numeração e registra a utilização no SNCR preenchendo todos os campos (RDC 1.000/2025, art. 13). O registro substitui o carimbo e a anotação no verso (Portaria 344, art. 36, § 3º; Portaria 6/1999, art. 82, parágrafo único). A guarda é eletrônica, pelo prazo da 344 (art. 14). Cada receita é usada uma única vez (art. 15). O registro pode ser cancelado pelo mesmo estabelecimento em até 30 minutos. Com o SNCR fora do ar, não há como dispensar receita eletrônica numerada: o paciente aguarda o restabelecimento (pergunta 75).

Acesso da farmácia

O acesso é pelo Cadastro Anvisa, com login gov.br individual. A farmácia privada é identificada pela **AFE** ativa; o responsável legal atribui aos colaboradores os perfis de farmácia do SNCR. Farmácias públicas e dispensários são identificados pelo CNES (perguntas 58 a 65). Sem AFE publicada no DOU não há acesso nem dispensação. A norma não fixa prazo para o primeiro acesso, mas sem cadastro a loja não consegue atender receita eletrônica.

Transição das receitas brancas eletrônicas

Receita de Controle Especial e receita sujeita à retenção já podiam ser emitidas eletronicamente antes de 30/09/2026, sem número do SNCR. Nesse formato antigo, a farmácia guarda o arquivo eletrônico original e mantém uma cópia impressa só para anotar a dispensação (comprador, fornecedor, quantidade e carimbo). A impressão não transforma a receita em papel: o documento de referência continua sendo o eletrônico. Depois do fim da janela de transição de outubro de 2026, toda nova RCE ou receita de retenção eletrônica precisa ter número do SNCR, com consulta e registro de uso no sistema. Uma receita emitida sem número durante a janela continua válida até o fim do seu prazo; a cartilha da Anvisa dá o exemplo de uma RCE emitida em 02/10/2026 que pode ser dispensada até 01/11/2026.

Proteção de dados

Receita eletrônica é dado pessoal sensível. Prescritor, plataforma e farmácia são agentes de tratamento pela LGPD (Lei 13.709/2018) e devem limitar o acesso ao necessário para a finalidade sanitária. No balcão isso significa não fotografar a receita no celular pessoal, não encaminhar o arquivo por aplicativo de mensagem fora do fluxo da loja e conceder perfil no SNCR só a quem atende controlados.

NO BALCÃO

Deixe pelo menos dois colaboradores habilitados no SNCR em cada turno, com o farmacêutico sempre entre eles, e um computador ou celular com leitor de QR Code no balcão. Receita eletrônica de controlado que chega sem conferência no SNCR é receita que não pode ser dispensada.

CASO

Paciente apresenta Notificação B em papel com número de 14 dígitos. Na consulta, o SNCR mostra "autorizada", tipo B, meio eletrônico. A dispensação deve ser recusada: um número destinado ao meio eletrônico não pode estar impresso num talão de papel.

Infrações e penalidades

Descumprir a Portaria 344, a RDC 22/2014 ou a RDC 1.000/2025 é infração sanitária. A lei que tipifica as infrações e fixa as penas é a **Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977**. As próprias normas remetem a ela (RDC 22/2014, art. 39; RDC 50/2014, art. 13; RDC 1.000/2025, art. 26), e a Portaria 344 (art. 73) trata como infração a falta de remessa de balanços e relações no prazo.

Infrações mais ligadas a controlados

Lei 6.437/1977, art. 10	Conduta	Penas previstas
Inciso XI	Aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou com determinação expressa de lei e normas regulamentares	Advertência, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XII	Fornecer ou vender medicamento cuja venda dependa de prescrição sem observar essa exigência	Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa
Inciso X	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora	Advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XXIX	Transgredir outras normas legais e regulamentares de proteção da saúde	Advertência a cancelamento de autorização e/ou multa

Penalidades e multas

O art. 2º lista as penas, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: advertência, multa, apreensão, inutilização e interdição de produto, suspensão de vendas, cancelamento de registro, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da autorização de funcionamento e do alvará, entre outras. As multas (art. 2º, § 1º, incluído pela MP 2.190-34/2001):

Classificação	Critério (art. 4º)	Multa
Leve	Infrator beneficiado por circunstância atenuante	R$ 2.000 a R$ 75.000
Grave	Uma circunstância agravante	R$ 75.000 a R$ 200.000
Gravíssima	Duas ou mais agravantes	R$ 200.000 a R$ 1.500.000

A multa dobra na reincidência (§ 2º) e considera a capacidade econômica do infrator (§ 3º). São agravantes, entre outras: reincidência, infração para obter vantagem pecuniária, dolo ou má-fé, e deixar de agir diante de ato lesivo conhecido (art. 8º). São atenuantes: ação não fundamental para o evento, erro escusável de compreensão, reparação espontânea e infrator primário em falta leve (art. 7º). A reincidência específica permite enquadrar como gravíssima (art. 8º, parágrafo único).

Responsabilidade além da multa

- **Empresa e profissionais**: a empresa responde administrativa e civilmente; o RT e o responsável legal podem responder também (RDC 22/2014, art. 39). A VISA pode comunicar o fato ao Conselho Regional de Farmácia (art. 34), o que abre processo ético.
- **Penal**: substâncias das listas sem documento hábil são apreendidas e, nas listas A, B e D1, a VISA envia cópia do processo à polícia (Portaria 344, art. 33). Vender ou entregar droga "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" é conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.

- **SNCR**: o serviço de prescrição que descumpre os requisitos tem o acesso suspenso de imediato (RDC 1.000/2025, art. 17).

O QUE DIZ A NORMA

"São infrações sanitárias: [...] XI - aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e normas regulamentares." (Lei 6.437/1977, art. 10, XI)

Erros comuns que geram autuação

Erro	Norma descumprida
Dispensar controlado com receita vencida	Portaria 344, arts. 41, 45, 50, 52; RDC 11/2011
Aceitar notificação rasurada, sem quantidade por extenso ou com campo vazio	Portaria 344, art. 35, §§ 3º e 4º
Aceitar receita comum para medicamento da 344	Portaria 344, arts. 35 e 55; Portaria 6/1999, art. 84
Dispensar zolpidem com RCE (regra anterior a agosto de 2024)	Anexo I, lista B1
Dispensar quantidade acima do limite sem justificativa	Portaria 344, arts. 43, 46, 59 e 60
Não reter a notificação ou a 1ª via da RCE	Portaria 344, arts. 35, § 5º, e 53
Não identificar comprador ou não anotar quantidade no verso	Portaria 344, art. 36; Portaria 6/1999, art. 82
Controlado fora do armário com chave	Portaria 344, art. 67
Estoque físico diferente do SNGPC	RDC 22/2014, art. 15
Atraso de mais de 7 dias na transmissão	RDC 22/2014, art. 10, §§ 3º e 4º
Fracionar embalagem de controlado em drogaria	Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109
Vender controlado pela internet	Portaria 344, art. 34-B, § 1º
Dispensar receita eletrônica sem consultar e registrar no SNCR	RDC 1.000/2025, art. 13
Não arquivar receitas e documentos por 2 anos	Portaria 344, art. 64
Ceder dados de prescrição a terceiros	RDC 22/2014, art. 21, parágrafo único

Processo administrativo sanitário

A infração é apurada em processo administrativo próprio, que começa com o auto de infração lavrado pela autoridade sanitária. Os prazos principais da Lei 6.437/1977 são:

- Defesa ou impugnação do auto: 15 dias da notificação (art. 22).
- Pagamento da multa em até 20 dias da notificação: redução de 20%, com desistência tácita de defesa ou recurso (art. 21).
- Recurso contra decisão condenatória: mesmo prazo da defesa; mantida a decisão, recurso à autoridade superior em 20 dias (art. 30).
- Obrigação que subsiste após a autuação: edital com prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária (arts. 18 e 19).
- Prescrição das infrações sanitárias: 5 anos, interrompida pela notificação ou por ato de apuração (art. 38).

Na defesa, a farmácia organizada leva vantagem: receitas arquivadas por mês e tipo, relatórios do SNGPC, registros de contagem e de treinamento mostram boa-fé e podem enquadrar a falta como leve, com atenuantes do art. 7º.

Como reduzir o risco

Boa parte das autuações nasce de rotina frouxa. Um procedimento operacional padrão de dispensação de controlados, treinamento periódico da equipe com casos reais, checklist no balcão, contagem regular e transmissão do SNGPC com dia fixo resolvem a maior parte. Diante de dúvida sobre uma receita, a decisão é do farmacêutico, que deve registrar o motivo de uma recusa quando houver risco de questionamento.

NO BALCÃO

Na inspeção, apresente com tranquilidade o Certificado de Escrituração Digital, o relatório do SNGPC, as receitas retidas organizadas por mês e tipo, e o armário trancado. Dificultar o acesso do fiscal é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, X).

CASO

Na fiscalização, a VISA encontra 3 caixas de clonazepam 2 mg a mais no armário do que o saldo do SNGPC e transmissões atrasadas há 20 dias. Há duas infrações: divergência de estoque (RDC 22/2014, art. 15) e atraso na transmissão (art. 10). Se a farmácia já tivesse sido autuada pela mesma conduta, a reincidência agravaria a classificação e dobraria a multa (Lei 6.437/1977, art. 2º, § 2º, e art. 8º).

Fontes consultadas

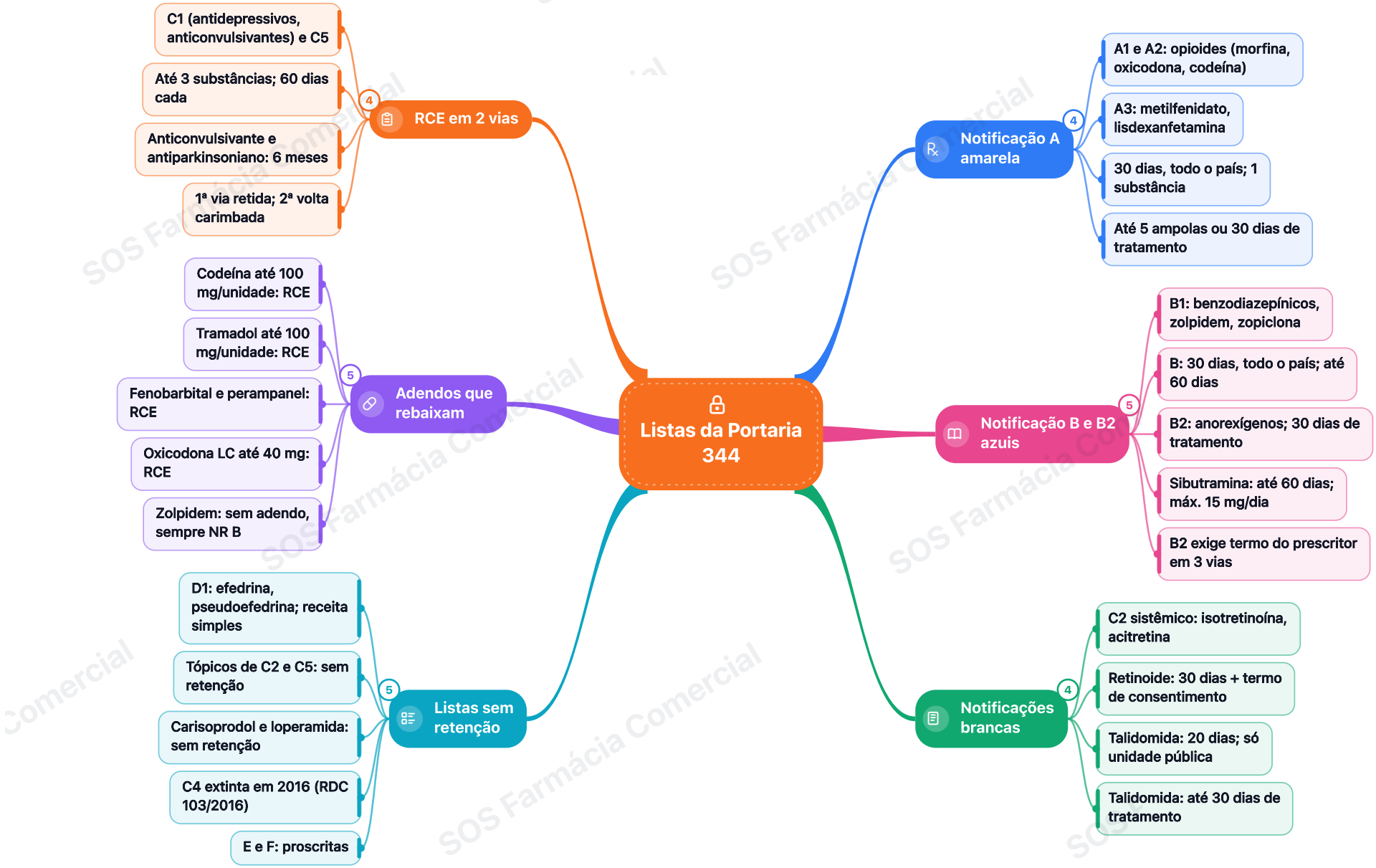
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (texto consolidado pela Anvisa até a Atualização nº 101, RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026). anvisalegis.datalegis.net
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 (texto consolidado pela Anvisa). anvisalegis.datalegis.net
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025. Diário Oficial da União, 15 dez. 2025. in.gov.br
4. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.028, de 1º de junho de 2026. Diário Oficial da União, 2 jun. 2026.

5. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 873, de 27 de maio de 2024 (institui o SNCR). Diário Oficial da União, 3 jun. 2024 (dispositivos conferidos no texto consolidado da Portaria 344 e da RDC 11/2011).
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 22, de 29 de abril de 2014 (SNGPC), texto consolidado. anvisalegis.datalegis.net
7. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 11, de 22 de março de 2011 (talidomida), texto consolidado. anvisalegis.datalegis.net
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 50, de 25 de setembro de 2014 (anorexígenos), texto consolidado com a RDC 133/2016. anvisalegis.datalegis.net
9. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 973, de 23 de abril de 2025 (altera a RDC 471/2021). anvisalegis.datalegis.net
10. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025 (lista de antimicrobianos). Diário Oficial da União, 24 abr. 2025.
11. Anvisa. Perguntas e Respostas: RDC nº 1.000/2025, 1ª edição (fevereiro de 2026) e 2ª edição. gov.br/anvisa
12. Anvisa. SNCR e receituários controlados: cartilha para farmácias. 1ª ed. Brasília, setembro de 2026. gov.br/anvisa
13. Anvisa. Webinar RDC 1.000/2025: receituários eletrônicos e físicos (Vigilâncias, fevereiro de 2026; farmácias, março de 2026). gov.br/anvisa
14. Anvisa. Início de nova etapa do SNCR: o que muda a partir de 30 de setembro. Notícia, 2026. gov.br/anvisa
15. Anvisa. Ofício nº 39/2019/SEI/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA ao Conselho Federal de Farmácia: esclarecimentos sobre a Lei nº 13.732/2018. Março de 2019.
16. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações à legislação sanitária federal), texto compilado. planalto.gov.br
17. Brasil. Lei nº 13.732/2018 (altera o art. 35 da Lei nº 5.991/1973), conforme Ofício Anvisa nº 39/2019.
18. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia, 24 out. 2025; Anvisa restabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos ao SNGPC, 6 maio 2025. cff.org.br
19. Conselho Federal de Farmácia. Qualquer medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B. Notícia, 16 maio 2024. cff.org.br
20. Ministério da Saúde. Nota Informativa nº 75/2016 (exclusão dos antirretrovirais da lista C4 pela RDC nº 103/2016), citada em gov.br/aids.

SOS Farmácia Comercial

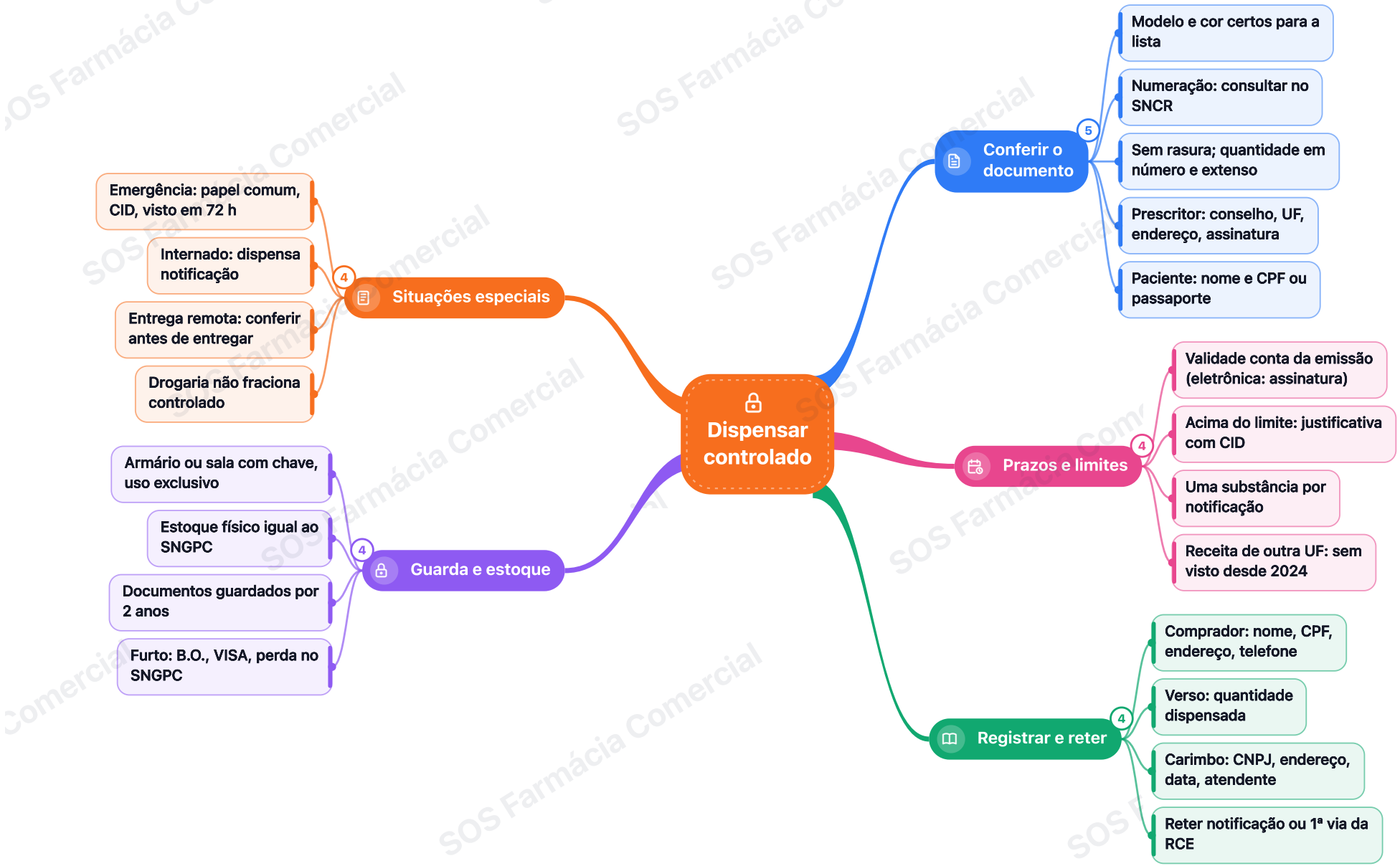
Listas e receituários

6 ramos · 27 itens · mapa mental do módulo 2



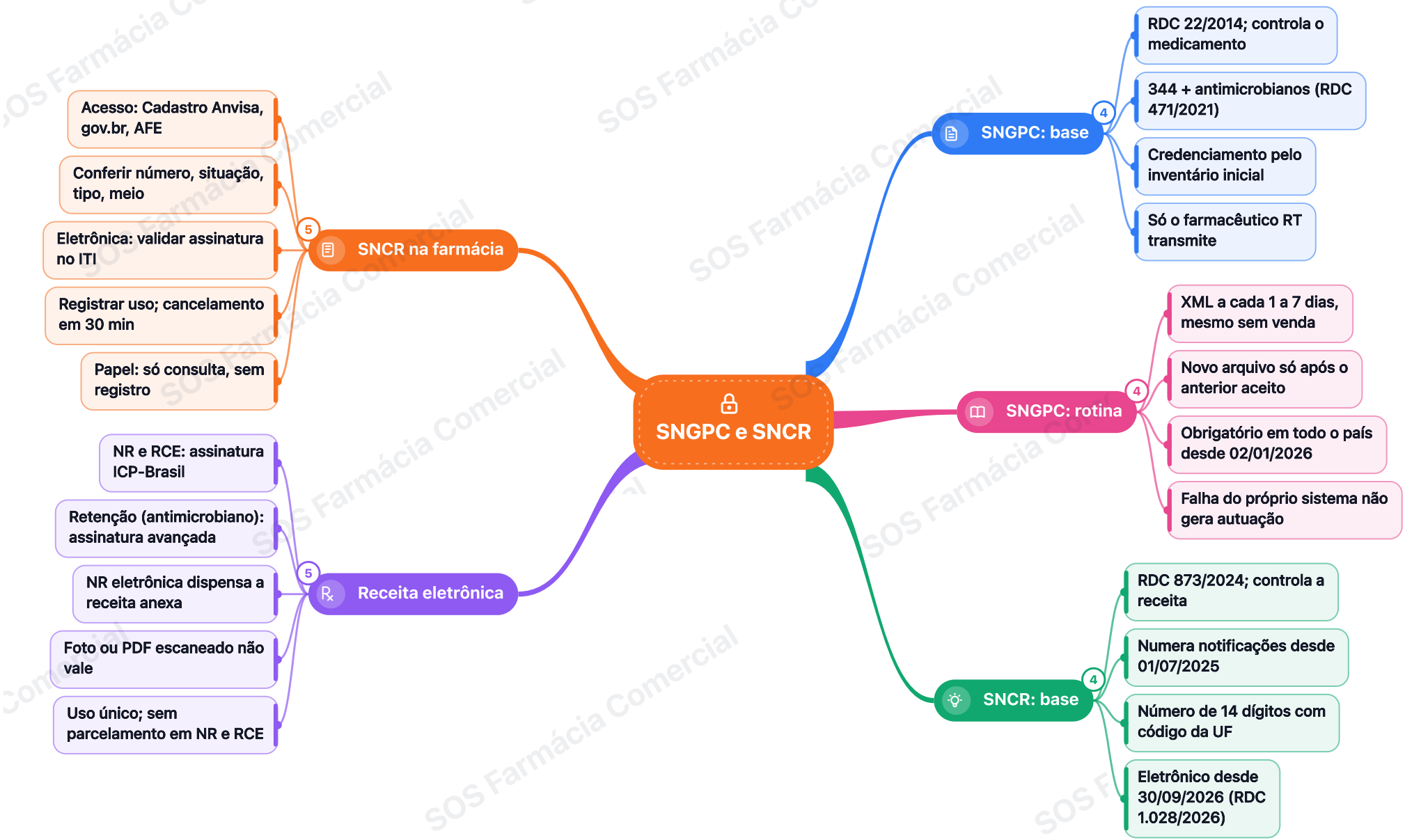
Dispensação e guarda

5 ramos · 21 itens · mapa mental do módulo 2



SNGPC e SNCR

5 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 2



Notificação de Receita A

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A
Listas A1, A2 e A3

Nº _____
Numeração concedida pela VISA local e gerada no SNCR (14 dígitos). Impressão em gráfica pelo prescritor ou instituição; a VISA pode imprimir, se quiser (RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso, sem símbolos adicionais: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor (com identificação legível ou carimbo se o nome não estiver impresso): _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 41)
Abrangência	Todo o território nacional, sem visto (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 43)
Substâncias	Uma por notificação (art. 35, § 7º)
Acompanhamento	Em papel, vem com a receita, que volta carimbada ao paciente
Destino	Retida na farmácia; relação mensal (RMNRA) à VISA até o dia 15 (art. 72)

Modelo vigente para novas impressões: versão 2 (desde 18/05/2026). Blocos antigos impressos na vigência anterior continuam válidos. Confira o leiaute no portal da Anvisa.

SOS Farmácia Comercial

Notificação de Receita B

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B

Lista B1 (psicotrópicos)

Nº _____

Numeração retirada na VISA do local do consultório ou instituição, gerada no SNCR. Impressão às expensas do profissional ou da instituição, em gráfica.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

SOS Farmácia Comercial

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 45)
Abrangência	Todo o território nacional (redação da RDC 1.000/2025)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 60 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 46)
Substâncias	Uma por notificação
Exemplos	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem (qualquer dose)
Destino	Retida na farmácia; escriturada no SNGPC

Existe modelo de Notificação B para uso veterinário, com identificação do proprietário e do animal.

SOS Farmácia Comercial

Notificação de Receita B2

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2

Lista B2 (anorexígenos)

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão pelo prescritor em gráfica, no modelo da Anvisa (RDC 58/2007, art. 1º, redação da RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

Dose diária dentro do limite da RDC 50/2014: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

ANEXO OBRIGATÓRIO

Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexos I e II), 3 vias: _____

SOS Farmácia Comercial

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão
Abrangência	Todo o território nacional (Lei 13.732/2018)
Quantidade máxima	30 dias de tratamento; sibutramina até 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º)
Dose diária máxima	Sibutramina 15 mg; anfepramona 120 mg; femproporex 50 mg; mazindol 3 mg
Associação	Proibida com outros anorexígenos, ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes (Portaria 344, art. 47)
Termo	Farmácia preenche seus campos, retém 1 via e entrega 1 ao paciente (RDC 50/2014, art. 11)

Manipulação de anorexígenos só nas condições da RDC 50/2014 (arts. 4º e 9º).

Notificação de Receita Especial para retinoides

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL PARA RETINOIDES

Lista C2, uso sistêmico

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão às expensas do médico ou da instituição.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Substância escrita pelo prescritor (sem campo pré-impresso): _____

Dosagem e forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

ADVERTÊNCIA

Símbolo de gestante cortada ao meio: _____

Alerta de graves defeitos na face, orelhas, coração e sistema nervoso do feto: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do médico: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 50)

Regra	Como é
Abrangência	Todo o território nacional (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, § 1º)
Prescritor	Médico
Termo	Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344); cartilha da Anvisa: 3 vias, 1 retida pela farmácia
Tópicos	Retinoide tópico não usa esta notificação: prescrição sem retenção

No modelo novo não há mais marcação de tratamento inicial ou subsequente. Normas estaduais podem fixar validade menor para mulheres em idade fértil.

SOS Farmácia Comercial

Notificação de Receita de Talidomida

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA

Lista C3, talidomida (RDC 11/2011)

Nº _____

Numeração distribuída pela autoridade sanitária via SNCR ao médico cadastrado; impressão no modelo da Anvisa, em 2 vias.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número concedido pela autoridade sanitária: _____

DIAGNÓSTICO

CID: _____

ADVERTÊNCIAS IMPRESSAS

"Proibida para mulheres grávidas ou com chance de engravidar": _____

"Talidomida causa o nascimento de crianças sem braços e sem pernas": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome completo: _____

Endereço: _____

Especialidade: _____

CPF: _____

Número do cadastro na autoridade sanitária: _____

Data, assinatura e carimbo: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo: _____

Documento oficial e órgão emissor: _____

Data de nascimento: _____

Sexo: _____

Endereço e telefone: _____

RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (SE HOUVER)

Nome: _____

Documento oficial: _____

Endereço e telefone: _____

MEDICAMENTO

Quantidade de comprimidos em algarismos e por extenso: _____

Dose por unidade: _____

Posologia: _____

Tempo de tratamento: _____

DISPENSAÇÃO (FARMACÊUTICO)

Quantidade e lote: _____

Nome, CRF, assinatura, carimbo e data: _____

Carimbo da unidade pública dispensadora: _____

Regra	Como é
Validade	20 dias a contar da emissão (RDC 11/2011, art. 21, § 2º)

Regra	Como é
Abrangência	Todo o território nacional (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	30 dias de tratamento (art. 21, § 3º)
Conteúdo	Somente talidomida
Termo	Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias: prontuário, unidade dispensadora, paciente
Onde dispensar	Somente unidade pública credenciada; venda proibida

Ordem dos campos segundo o art. 22 da RDC 11/2011. Não circula em drogaria comercial.

Receita de Controle Especial

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL
Listas C1 e C5 e adendos de A1, A2 e B1

Nº _____
Em papel não tem numeração oficial. Na via eletrônica integrada, o SNCR gera o número automaticamente.

CABEÇALHO

Dizer "Receita de Controle Especial": _____

Indicação das vias: "1ª via: retenção da farmácia" e "2ª via: orientação ao paciente": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional ou da instituição: _____

Inscrição no conselho e UF: _____

Endereço completo e telefone (CNPJ ou CNES, se instituição): _____

Cidade: _____

PRESCRIÇÃO

Paciente: nome completo e CPF (ou passaporte): _____

Medicamento ou fórmula, dosagem, quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia ou modo de usar: _____

Data: _____

Assinatura: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Documento de identificação: _____

Endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Carimbo da farmácia (nome, CNPJ, endereço): _____

Data e nome do atendente: _____

Genérico: nome do fabricante: _____

Verso: quantidade dispensada: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 52, § 1º)
Abrangência	Todo o território nacional
Quantidade máxima	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses (art. 59)
Substâncias	Até 3 por receita (art. 57)
Vias	Papel: 2 vias, 1ª retida; eletrônica: via única com registro no SNCR
Leiaute	Pode diferir do modelo da Anvisa se trouxer o título e todos os campos; receita comum não serve

Campos conforme Portaria 344, art. 55, e Portaria 6/1999, art. 85, com redação da RDC 1.000/2025. Os campos do comprador e do fornecedor podem vir por carimbo.

Tabela-mestra: lista, receituário, validade e limites

Lista	Exemplos	Receituário	Validade	Quantidade máxima	Abrangência
A1	Morfina, metadona, oxicodona, fentanila, tapentadol	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A2	Codeína, tramadol, nalbufina (acima dos adendos)	Notificação A; RCE nos adendos	30 dias	NR A: 5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A3	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
B1	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem	Notificação B azul	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
B2	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 azul + termo	30 dias	30 dias; sibutramina 60	Nacional
C1	Sertralina, quetiapina, carbamazepina, pregabalina, celecoxibe	RCE em 2 vias	30 dias	3 substâncias; 60 dias cada; 6 meses p/ anticonvulsivante	Nacional
C2	Isotretinoína, acitretina (sistêmicos)	Notificação especial branca + termo	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional

Lista	Exemplos	Receituário	Validade	Quantidade máxima	Abrangência
C3	Talidomida	Notificação de talidomida branca + termo	20 dias	30 dias	Nacional; só unidade pública
C5	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina	RCE em 2 vias	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
D1	Pseudoefedrina, efedrina, ergotamina	Receita sem retenção	Conforme receita comum	Sem limite da 344	Nacional
E, F	Plantas e substâncias proscritas	Proibidas	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Base: Portaria 344, arts. 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59 e Anexo I (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026); RDC 50/2014; RDC 11/2011. Validade nacional: Lei 13.732/2018, RDC 873/2024 e RDC 1.000/2025. A lista C4 foi extinta pela RDC 103/2016.

Adendos que mudam o receituário

Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Codeína e afins	A2	Até 100 mg por unidade e até 2,5% em forma indivisível	RCE	Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg
Tramadol	A2	Até 100 mg por unidade, isolado ou associado	RCE	Tramadol 50 mg cápsula
Nalbufina	A2	Até 10 mg de cloridrato por unidade	RCE	Ampola de 10 mg
Ópio	A1	Até 5 mg de morfina anidra por mL	RCE	Elixir paregórico
Oxicodona	A1	Comprimido de liberação controlada até 40 mg	RCE (acima: NR A)	Oxicodona LC 20 mg
Buprenorfina	A1	Adesivo transdérmico de matriz	RCE	Adesivo de buprenorfina
Fenobarbital, barbexaclona	B1	Qualquer apresentação	RCE	Fenobarbital 100 mg
Perampanel	B1	Qualquer apresentação	RCE	Perampanel 4 mg
Carisoprodol	B1	Medicamentos com carisoprodol	Prescrição sem retenção	Associações miorrelaxantes

Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Zolpidem	B1	Sem adendo desde 01/08/2024	Notificação B	Zolpidem 5 mg, 10 mg ou 12,5 mg
Cetamina, escetamina	B1	Uso só em estabelecimento de saúde	Não se dispensa em drogaria	Escetamina spray nasal
Produtos de Cannabis	A3	THC até 0,2% (RDC 1.015/2026)	RCE (acima: NR A)	Produto de canabidiol
Medicamento com Cannabis	A3	Até 30 mg/mL de THC e de canabidiol	Notificação A	Spray oromucoso registrado
Loperamida	C1	Qualquer apresentação	Prescrição sem retenção	Loperamida 2 mg
Tetracaína	C1	Odontológico tópico; otológico; oftálmico	Isento; sem retenção; com retenção	Colírio anestésico: retenção
Retinoides tópicos	C2	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Tretinoína creme, adapaleno gel
Anabolizantes tópicos	C5	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Conforme registro do produto

Texto dos adendos conferido na Portaria 344 consolidada pela Anvisa (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026). Confirme sempre na lista vigente antes de decidir.

SOS Farmácia Comercial

Fluxo de dispensação de controlado

Cliente apresenta receita de medicamento controlado

Identificar substância, concentração por unidade, lista e adendo

DECISÃO

O documento é o exigido pela lista (cor, modelo, título)?

SIM
Seguir para a conferência

NÃO
Recusar e explicar qual receituário é necessário

DECISÃO

A receita é eletrônica?

SIM
Validar assinatura no ITI e consultar o número no SNCR (meio eletrônico, situação autorizada)

NÃO
Se a notificação tiver número do SNCR, consultar (meio físico, prescritor correto)

DECISÃO

Todos os campos preenchidos, legíveis, sem rasura e com quantidade por extenso?

SIM
Conferir prazo e quantidade

NÃO
Recusar e orientar retorno ao prescritor

DECISÃO

Dentro da validade e do limite de quantidade (ou com justificativa)?

SIM
Conferir termos e restrições específicas

NÃO
Recusar ou dispensar só o permitido, conforme o caso

ATENÇÃO

Receita rasurada, número cancelado ou divergente do prescritor indicam possível fraude

Identificar o comprador com documento e registrar nome, CPF, endereço e telefone

Dispensar, anotar quantidade no verso, carimbar e reter a via da farmácia (ou registrar uso no SNCR)

Lançar no sistema da loja e transmitir ao SNGPC no prazo

Orientar o paciente sobre uso, riscos e guarda do medicamento

Checklist de conferência da Notificação de Receita

- ◯ Confirmar que a cor e o tipo da notificação correspondem à lista do medicamento
- ◯ Verificar se o modelo é oficial (antigo, versão 1 ou versão 2 impressos na vigência)
- ◯ Consultar no SNCR o número de padrão nacional: idêntico, autorizado, tipo e meio corretos
- ◯ Conferir se o prescritor vinculado ao número é o emitente do documento
- ◯ Conferir nome, conselho, UF, endereço e assinatura do prescritor
- ◯ Conferir nome e CPF do paciente (ou passaporte ou "não possui")
- ◯ Conferir DCB, concentração, forma farmacêutica e posologia
- ◯ Conferir quantidade em algarismos e por extenso, iguais entre si
- ◯ Verificar ausência de emenda, rasura ou corretivo
- ◯ Confirmar uma única substância na notificação
- ◯ Contar os dias desde a emissão: até 30 dias (talidomida: 20)
- ◯ Calcular os dias de tratamento e comparar com o limite da lista
- ◯ Exigir justificativa com CID se a quantidade passar do limite
- ◯ Verificar termos obrigatórios (B2, retinoides, talidomida, fenfluramina)
- ◯ Em papel, conferir a receita que acompanha a notificação e devolvê-la carimbada
- ◯ Registrar nome, CPF, endereço e telefone do comprador

- ◯ Anotar no verso a quantidade dispensada e carimbar com dados da farmácia, data e atendente
- ◯ Reter a notificação e arquivá-la por tipo e mês

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma regulamenta os medicamentos controlados no Brasil?	Portaria SVS/MS 344/1998, detalhada pela Portaria SVS/MS 6/1999, com listas atualizadas por RDC.
Qual RDC fez a atualização mais recente do Anexo I até outubro de 2026?	RDC 1.036, de 9 de julho de 2026 (Atualização nº 101).
Validade e abrangência da Notificação A?	30 dias da emissão, em todo o território nacional.
Quantidade máxima na Notificação A?	5 ampolas ou 30 dias de tratamento.
Quantidade máxima na Notificação B?	5 ampolas ou 60 dias de tratamento.
Quantas substâncias cabem numa notificação?	Uma substância ou um medicamento.
Quantas substâncias da C1 cabem numa RCE?	Até 3, cada uma limitada a 60 dias (anticonvulsivantes e antiparkinsonianos: 6 meses).
Validade da notificação de talidomida?	20 dias, em todo o território nacional (RDC 11/2011, redação da RDC 873/2024).
Receituário do zolpidem 10 mg?	Notificação de Receita B, desde 1º de agosto de 2024, em qualquer concentração.
Receituário de paracetamol + codeína 30 mg?	RCE em 2 vias (adendo 2 da lista A2).
O que aconteceu com a lista C4?	Foi extinta pela RDC 103/2016; antirretrovirais saíram da 344.
Receita de controlado de outro estado precisa de visto da VISA?	Não. A RDC 873/2024 revogou o visto. Só a receita de emergência vai à VISA em 72 horas.
Quem imprime o talonário amarelo desde fevereiro de 2026?	O prescritor ou a instituição, em gráfica, com numeração da VISA gerada no SNCR.
Qual assinatura exige a Notificação eletrônica?	Assinatura qualificada ICP-Brasil.
Desde quando há Notificação de Receita eletrônica?	30 de setembro de 2026 (RDC 1.000/2025, art. 16, redação da RDC 1.028/2026).
O que a farmácia faz com receita eletrônica no SNCR?	Valida a assinatura no ITI, confere o número e registra a utilização.
Prazo de transmissão do SNGPC?	Arquivos a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação (RDC 22/2014, art. 10).

Pergunta	Resposta
Por quanto tempo guardar receitas e documentos de controlados?	2 anos (Portaria 344, art. 64).
Onde guardar os controlados?	Sob chave ou dispositivo seguro, em local exclusivo, sob responsabilidade do farmacêutico (art. 67).
Faixa de multa de infração grave na Lei 6.437/1977?	R$ 75.000 a R$ 200.000; dobra na reincidência.

Questões de fixação

1. Cliente apresenta Receita de Controle Especial em duas vias com zolpidem 10 mg, 30 comprimidos, emitida há 5 dias. Qual a conduta correta em outubro de 2026?

A Dispensar, porque apresentações de até 10 mg seguem em RCE

B Dispensar metade e reter a 1ª via

C Recusar, porque o zolpidem exige Notificação de Receita B

D Dispensar e comunicar a VISA em 72 horas

E Recusar, porque o zolpidem exige Notificação A

2. Sobre a Notificação de Receita A após a RDC 1.000/2025, assinale a correta.

A Continua impressa exclusivamente pela Vigilância Sanitária, que carimba cada folha

B Pode ser impressa em gráfica pelo prescritor, com numeração da VISA

C Dispensa numeração oficial quando impressa em gráfica privada

D Passou a ter validade de 60 dias para todas as listas A

E Só vale na unidade federativa que concedeu a numeração

3. Paciente traz Notificação B de clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, sem nenhum documento adicional. O farmacêutico deve:

A Dispensar os 90 comprimidos, pois a Notificação B não tem limite de quantidade

B Dispensar, porque a Notificação B vale 60 dias e cobre o tratamento

C Exigir que o paciente traga uma Notificação A no lugar da B

D Exigir justificativa com CID ou diagnóstico para os 90 comprimidos

E Dispensar os 90 e reter também a receita comum que acompanha

4. Uma drogaria em Recife recebe Receita de Controle Especial de sertralina emitida por médico de São Paulo. Qual procedimento está correto?

A Levar a 1ª via à VISA em 72 horas para visto

B Recusar, porque a RCE só vale no estado de emissão

C Exigir notificação azul por ser de outro estado

D Pedir carimbo da VISA de São Paulo

E Conferir os requisitos e dispensar normalmente, sem visto

5. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o medicamento e o receituário.

A Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg: Receita de Controle Especial

B Metilfenidato 10 mg comprimido: Receita de Controle Especial

C Fenobarbital 100 mg comprimido: Notificação de Receita B

D Isotretinoína 20 mg cápsula: Receita de Controle Especial

E Tretinoína creme 0,05%: Notificação especial de retinoides

6. Sobre a validade das notificações vigente em 2026, é correto afirmar:

A Notificação de talidomida: 30 dias, só na unidade federativa de emissão

B Notificação de talidomida: 20 dias, em todo o território nacional

C Notificação B: 60 dias, em todo o território nacional

D Notificação de retinoides: 15 dias, em todo o território nacional

E Notificação A: 30 dias, só na UF de emissão e com visto da VISA

7. Uma farmácia recebe Notificação B eletrônica em 05/10/2026. Qual sequência atende à RDC 1.000/2025?

A Imprimir o PDF, carimbar o verso e reter a cópia, sem consulta a sistema

B Exigir a via em papel, porque notificação não pode ser eletrônica

C Validar a assinatura no ITI, consultar o número no SNCR e registrar o uso

D Aceitar assinatura gov.br e registrar a venda somente no SNGPC

E Dispensar e registrar o uso apenas no sistema da plataforma emissora

8. Em relação ao SNGPC, assinale a correta.

A. A transmissão é mensal, até o dia 15

B. Semanas sem venda de controlados dispensam envio de arquivo

C. Qualquer atendente pode gerar e enviar o XML

D. O SNCR substituiu o SNGPC a partir de 30/09/2026

E. Os arquivos devem ser enviados a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação

9. Na consulta de uma Notificação A em papel, o SNCR exibe a situação "não atribuída ao prescritor". O farmacêutico deve:

A. Não dispensar e orientar a regularização da numeração com a VISA

B. Dispensar, porque a numeração existe na base nacional do SNCR

C. Dispensar e registrar a utilização da notificação no SNCR

D. Dispensar metade da quantidade até a regularização

E. Reter a notificação e enviá-la ao Conselho de Medicina

10. Durante inspeção, a VISA verifica que o estoque físico de alprazolam diverge do saldo no SNGPC e que a última transmissão foi há 15 dias. A farmácia já havia sido multada pela mesma conduta. Sobre a penalidade, é correto:

A. Cabe apenas advertência, por ser infração leve

B. A multa máxima possível é de R$ 75.000

C. A reincidência é agravante e a multa é aplicada em dobro

D. Não há infração, pois o SNGPC está suspenso desde 2021

E. Só o Conselho Regional de Farmácia pode punir

11. Sobre a guarda e a escrituração de controlados em drogaria, assinale a correta.

A. Podem ficar em gôndola fechada com vidro, longe do balcão

B. O livro de registro específico continua obrigatório junto com o SNGPC

C. Os documentos de controlados podem ser descartados após 6 meses

D. Ficam sob chave em local exclusivo, com estoque idêntico ao do SNGPC

E. A drogaria pode fracionar a embalagem se o paciente pedir

12. Paciente de 24 anos apresenta Notificação de Receita B2 de sibutramina 15 mg, 1 cápsula ao dia, 60 cápsulas, com o Termo de Responsabilidade do Prescritor. Qual a conduta?

A Recusar, porque a B2 permite só 30 dias para qualquer substância

B Recusar, porque a dose diária máxima é 10 mg

C Dispensar sem reter o termo

D Dispensar, preencher os campos da farmácia no termo e reter uma via

E Exigir Notificação A

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **C**. O zolpidem está na lista B1 sem adendo desde 1º/08/2024, quando a Anvisa excluiu a exceção para até 10 mg; toda apresentação exige Notificação B. A alternativa A descreve a regra revogada. Não há dispensação parcial nem comunicação que corrija o receituário errado. Notificação A é para as listas A.
2. **B**. A RDC 1.000/2025 deu ao art. 40 da 344 a redação que permite a impressão em gráfica pelo profissional ou instituição; a impressão pela VISA virou faculdade. A numeração continua obrigatória e vem do SNCR. A validade segue em 30 dias e é nacional desde a RDC 873/2024.
3. **D**. A Notificação B cobre até 60 dias de tratamento; 90 comprimidos a 1 por dia são 90 dias. Acima do limite, o prescritor deve entregar justificativa (Portaria 344, art. 46, § 1º). A validade da Notificação B é de 30 dias, não de 60. Clonazepam é B1, não A.
4. **E**. A RCE vale em todo o território nacional, e a RDC 873/2024 revogou o § 3º do art. 52 da 344, que exigia visto para receitas de outra UF. Sertralina é C1 e usa RCE. Visto em 72 horas permanece apenas para a receita de emergência.
5. **A**. Codeína até 100 mg por unidade cai no adendo 2 da A2 e usa RCE. Metilfenidato (A3) exige Notificação A. Fenobarbital tem adendo na B1 e usa RCE. Isotretinoína oral exige notificação especial de retinoides. Retinoide tópico é prescrição sem retenção (adendo 2 da C2).
6. **B**. A RDC 873/2024 deu ao art. 21, § 2º, da RDC 11/2011 a redação de 20 dias em todo o território para a talidomida. A Notificação B vale 30 dias. Retinoides: 30 dias. A Notificação A vale 30 dias em todo o país desde a mesma RDC.
7. **C**. O art. 13 da RDC 1.000/2025 manda verificar a assinatura pelo ITI, conferir a numeração concedida no SNCR e registrar a utilização. Desde 30/09/2026 notificações podem ser eletrônicas. Notificação exige assinatura ICP-Brasil; gov.br é avançada. O registro na plataforma emissora não substitui o SNCR, e o SNGPC continua obrigatório em paralelo.
8. **E**. RDC 22/2014, art. 10, § 3º: intervalo mínimo de 1 e máximo de 7 dias, ainda que sem movimentação. A geração e o envio são funções do farmacêutico RT (art. 18). O SNCR controla a receita e coexiste com o SNGPC. Envio mensal até o dia 15 é a regra da RMNRA, não do SNGPC.
9. **A**. Número gerado mas não atribuído a prescritor ou instituição não pode ser usado (cartilha da Anvisa, 2026). A existência do número não basta. Receita em papel não tem registro de uso no SNCR. Não existe dispensação parcial como saída para numeração irregular.
10. **C**. A Lei 6.437/1977 aplica a multa em dobro na reincidência (art. 2º, § 2º), e a reincidência é agravante (art. 8º, I). A suspensão da RDC 586/2021 terminou com o cronograma de 2025 e 2026. A VISA aplica a sanção sanitária; o conselho pode abrir processo ético à parte.
11. **D**. Portaria 344, art. 67 (guarda sob chave em local exclusivo) e RDC 22/2014, art. 15 (estoque idêntico ao escriturado). O SNGPC substitui o livro (art. 35). Documentos ficam 2 anos (art. 64 da 344). Drogaria não fraciona controlado (art. 79).
12. **D**. A RDC 50/2014 (redação da RDC 133/2016) permite à sibutramina até 60 dias de tratamento e fixa dose máxima de 15 mg/dia. A farmácia preenche seus campos no termo, retém uma via e entrega outra ao paciente (art. 11). Sibutramina é B2, não A.

Módulo 3

RDC 471/2021: antimicrobianos

Regras vigentes em outubro de 2026 para prescrição, receita, dispensação, retenção, escrituração e guarda de antimicrobianos (e, desde 2025, agonistas do GLP-1): RDC 471/2021 com a redação da RDC 973/2025, IN 360/2025, RDC 22/2014 (SNGPC) e orientações da Anvisa, do CFF e do CRF-SP.

- Histórico e objetivo da norma
- Abrangência: substâncias, formas e estabelecimentos
- Receita: requisitos, validade e quantidade
- Dispensação e retenção da receita
- Escrituração no SNGPC e guarda das receitas
- Infrações e erros comuns
- Orientação ao paciente na dispensação

Histórico e objetivo da norma

Antimicrobiano é a substância que impede a proliferação de microrganismos ou os mata, e assim previne a disseminação da infecção (RDC 471/2021, art. 4º, I). Penicilinas, cefalosporinas, macrolídeos, quinolonas, tetraciclinas, sulfonamidas, nitroimidazólicos e tuberculostáticos estão nesse grupo. Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum no balcão (como fluconazol, aciclovir e albendazol) não constam da lista que a Anvisa vinculou à norma e seguem as regras gerais dos medicamentos de venda sob prescrição.

Por décadas, a venda de antibiótico no Brasil exigiu receita apenas no papel: a tarja vermelha dizia "venda sob prescrição médica", mas a farmácia não guardava nada e não havia como fiscalizar. O resultado era a automedicação com amoxicilina para dor de garganta viral, azitromicina "para gripe" e ciprofloxacino guardado em casa para qualquer ardor ao urinar. Esse uso alimenta a **resistência antimicrobiana**, que a Organização Mundial da Saúde trata como ameaça global à saúde pública.

A sequência das normas

A primeira norma com retenção de receita para antimicrobianos foi a RDC nº 44, de 26 de outubro de 2010. Ela foi substituída poucos meses depois pela RDC nº 20, de 5 de maio de 2011, que consolidou o modelo que o balcão conhece: receita em duas vias, validade de 10 dias, retenção de uma via pela farmácia e escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). A lista de substâncias ficava em anexo da própria resolução.

Em 23 de fevereiro de 2021 a Anvisa publicou a RDC nº 471, que revogou expressamente a RDC 20/2011 e as resoluções nº 68/2014 e nº 174/2017 (RDC 471/2021, art. 26). A principal mudança de técnica normativa foi tirar a lista de substâncias do corpo da resolução e colocá-la em Instrução Normativa (IN) específica. Assim a lista pode ser atualizada sem reabrir a RDC inteira.

Norma	O que fez	Situação em outubro de 2026
RDC 44/2010	Primeira exigência de retenção de receita de antimicrobianos	Revogada pela RDC 20/2011
RDC 20/2011	Consolidou duas vias, validade de 10 dias, retenção e SNGPC; lista em anexo	Revogada (RDC 471/2021, art. 26, I)
RDC 471/2021	Regra vigente; lista passa para IN específica	Vigente, com redação alterada pela RDC 973/2025
RDC 973/2025	Altera a RDC 471 e amplia o alcance para "medicamentos de uso sob prescrição e retenção da receita"	Vigente desde 23/06/2025
IN 360/2025	Lista atual de antimicrobianos e de agonistas do GLP-1; fixa validades	Vigente desde 23/06/2025; revogou a IN 244/2023

A reforma de 2025

A RDC nº 973, de 23 de abril de 2025, mudou a ementa e o art. 1º da RDC 471. O texto deixou de falar só em antimicrobianos e passou a tratar de "medicamentos à base de substâncias isoladas ou em associação, de uso sob prescrição e retenção da receita, listadas na Instrução Normativa específica". A IN nº 360, publicada no mesmo dia, trouxe duas listas: a dos antimicrobianos (art. 1º) e a dos agonistas do receptor do GLP-1 (art. 2º: semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida). As duas normas entraram em vigor em 23 de junho de 2025.

Outra mudança de 2025: o prazo de validade da receita saiu do corpo da RDC. O art. 7º agora diz que a receita "terá validade conforme os prazos estabelecidos na Instrução Normativa específica". Para antimicrobianos, a IN 360/2025 manteve os 10 dias (art. 1º, § 2º). Para os agonistas do GLP-1, a validade é de 90 dias (art. 2º, § 1º).

O QUE DIZ A NORMA

"Esta Resolução dispõe sobre os critérios para a prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias isoladas ou em associação, de uso sob prescrição e retenção da receita, listadas na Instrução Normativa específica." (RDC 471/2021, art. 1º, com redação da RDC 973/2025)

Objetivo sanitário

A norma tem três finalidades práticas. A primeira é garantir que o antimicrobiano chegue ao paciente com diagnóstico feito por profissional habilitado. A segunda é permitir a fiscalização, porque a via retida e a escrituração deixam rastro de cada venda. A terceira é gerar dados de consumo: a RDC prevê monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico pelos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (art. 17). Em 2025, o Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a reforma reafirmou que a RDC 471 nasceu para promover o uso racional e evitar a resistência aos antimicrobianos.

No plano profissional, o Conselho Federal de Farmácia definiu a dispensação e o controle de antimicrobianos como atribuições privativas do farmacêutico (Resolução CFF nº 542/2011, art. 1º). O balconista pode separar o produto, mas a conferência da receita, o registro da dispensação e a orientação são atos do farmacêutico.

Resistência no cotidiano da farmácia

A resistência aparece no balcão de forma concreta. A cistite que não melhora com o antibiótico de sempre, a otite da criança que volta depois de vários ciclos de amoxicilina, a gonorreia que já não responde a esquemas antigos. Parte desse problema vem de doses insuficientes, tratamentos interrompidos e antibiótico usado em infecção viral, situações em que o farmacêutico tem papel direto. Por isso a norma combina controle de acesso (receita e retenção) com dever de orientação (art. 4º, IV): o antimicrobiano certo, usado do jeito errado, também seleciona bactérias resistentes.

PONTO-CHAVE

Para saber se um produto exige retenção de receita, consulte a lista da IN vigente (hoje a IN 360/2025), não a memória da época da RDC 20/2011. A RDC 471 é a regra de procedimento; a IN é a lista e a validade.

NO BALCÃO

Quando o cliente disser que "antes não precisava de receita" para determinado antibiótico, explique em uma frase o motivo (resistência bacteriana e segurança do próprio paciente) e ofereça o encaminhamento: unidade básica, consulta ou teleconsulta. A recusa educada, com alternativa, reduz conflito.

Abrangência: substâncias, formas e estabelecimentos

A RDC 471 vale para medicamentos que contenham as substâncias listadas na IN específica, **isoladas ou em associação**, e também para seus sais, éteres, ésteres e isômeros (art. 1º, parágrafo único). Basta um componente da fórmula estar na lista para o produto inteiro ficar sujeito à retenção.

A lista de antimicrobianos da IN 360/2025

O art. 1º da IN 360/2025 enumera as substâncias em itens numerados até 132. Os grupos que mais aparecem no balcão estão abaixo. Confira sempre o texto integral da IN ao classificar um produto novo.

Grupo	Exemplos listados na IN 360/2025
Penicilinas e inibidores de betalactamase	amoxicilina, ampicilina, ácido clavulânico, penicilina G, penicilina V, oxacilina, dicloxacilina, sulbactam, sultamicilina, tazobactam
Cefalosporinas	cefalexina, cefadroxil, cefaclor, cefuroxima, axetilcefuroxima, cefprozil, cefpodoxima, ceftriaxona
Macrolídeos e lincosamidas	azitromicina, claritromicina, eritromicina, roxitromicina, espiramicina, clindamicina, lincomicina
Quinolonas	ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacino, norfloxacina, ofloxacina, ácido nalidíxico, ácido pipemídico, besifloxacino, gatifloxacina
Tetraciclinas	doxiciclina, minociclina, limeciclina, tetraciclina, oxitetraciclina
Sulfonamidas e afins	sulfametoxazol, trimetoprima, sulfadiazina, sulfacetamida, dapsona
Urinários e outros orais	nitrofurantoína, fosfomicina, metronidazol, mandelamina, linezolida
Tuberculostáticos e hansênicos	rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, rifabutina, rifapentina, clofazimina
Uso tópico frequente	neomicina, bacitracina, mupirocina, ácido fusídico, gramicidina, tirotricina, retapamulina, nitrofural, polimixina B

Grupo	Exemplos listados na IN 360/2025
Aminoglicosídeos	gentamicina, tobramicina, amicacina, estreptomicina

Ficam de fora os antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar (IN 360/2025, art. 1º, § 1º). Também ficam de fora classes que não estão na lista, como antifúngicos (nistatina, fluconazol, cetoconazol, clotrimazol), antivirais (aciclovir, oseltamivir) e anti-helmínticos (albendazol, ivermectina). Esses produtos podem ser de venda sob prescrição, mas sem retenção pela RDC 471.

Formas farmacêuticas e vias de administração

Nem a RDC 471 nem a IN 360/2025 fazem distinção por via de administração. O critério é a substância. Por isso, pomadas, cremes, colírios, pomadas oftálmicas, gotas otológicas, óvulos e géis vaginais que contenham substância listada entram na regra, assim como comprimidos, suspensões e injetáveis. A própria lista confirma essa leitura ao incluir substâncias que no Brasil só existem para uso tópico ou oftálmico, como mupirocina, retapamulina, besifloxacino, sulfacetamida, gramicidina e tirotricina.

Produto no balcão	Substância listada	Retém receita?
Pomada de neomicina com bacitracina	neomicina, bacitracina	Sim
Creme de mupirocina	mupirocina	Sim
Colírio de tobramicina com dexametasona	tobramicina	Sim (a associação não exclui)
Gel vaginal de metronidazol	metronidazol	Sim
Creme de nistatina com óxido de zinco	nenhuma	Não pela RDC 471
Comprimido de fluconazol	nenhuma	Não pela RDC 471 (é de venda sob prescrição)

ATENÇÃO

A embalagem ajuda, mas não decide. Os medicamentos abrangidos devem trazer na bula e no rótulo a frase "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA" (RDC 471/2021, art. 18). Lotes antigos sem a frase podem ser dispensados até o fim da validade, mas sempre com receita retida (art. 20, parágrafo único). Quem decide é a lista da IN.

Agonistas do GLP-1

Desde 23/06/2025, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida também seguem a RDC 471 (IN 360/2025, art. 2º). Valem os mesmos requisitos de receita, duas vias, retenção, anotações e escrituração. A diferença é a validade: 90 dias a contar da emissão (art. 2º, § 1º). O tema clínico desses medicamentos é tratado em outro módulo; aqui importa saber que o procedimento de balcão é o mesmo.

Quem está sujeito

O art. 2º obriga à retenção e à escrituração as farmácias e drogarias privadas e as unidades públicas de dispensação que fornecem medicamentos mediante ressarcimento, como as unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil. O art. 3º trata das unidades públicas que não comercializam e das farmácias hospitalares: elas mantêm os controles de prescrição e dispensação que já tinham. Farmácias de manipulação também estão alcançadas, já que o art. 21 menciona medicamentos "industrializados ou manipulados".

A RDC não proíbe a venda por meio remoto (telefone, aplicativo, site), desde que se cumpram as Boas Práticas Farmacêuticas da RDC 44/2009 (art. 12). Na prática, a farmácia precisa receber e reter a via exigida, ou acessar o documento eletrônico original, antes de entregar o produto.

Medicamentos manipulados

Na farmácia de manipulação, a receita de antimicrobiano segue os mesmos requisitos. A fórmula manipulada (por exemplo, um creme com ácido fusídico ou uma cápsula de doxiciclina) contém substância listada, e por isso exige receita em duas vias, retenção e escrituração. A vedação de devolução do art. 21 também alcança expressamente os manipulados.

CASO

Cliente de 41 anos pede uma pomada de neomicina com bacitracina "para um machucado" e diz que nunca precisou de receita. O farmacêutico confere que neomicina e bacitracina estão na IN 360/2025 e explica que o produto exige receita retida. Avalia a ferida: escoriação limpa, sem sinais de infecção. Orienta limpeza com água e sabão e curativo, e encaminha para avaliação se surgirem vermelhidão que se espalha, pus, febre ou dor crescente.

NO BALCÃO

Antes de dizer "não precisa de receita" para qualquer produto com nome terminado em "-micina", "-floxacino" ou "-ciclina", leia a composição completa na embalagem e compare com a lista. Associações com corticoide, anestésico ou antifúngico continuam sujeitas à retenção se tiverem um antimicrobiano listado.

Receita: requisitos, validade e quantidade

Não existe modelo oficial de receita de antimicrobiano. A prescrição é feita em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde (RDC 471/2021, art. 6º). O papel é comum, branco, mas o conteúdo tem campos obrigatórios e a receita precisa ter **duas vias**.

Dados obrigatórios

O QUE DIZ A NORMA

"A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados obrigatórios: I - identificação do paciente: nome completo, idade e sexo; II - nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos); III - identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo); e IV - data da emissão." (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único)

Bloco	O que conferir	Erro frequente
Paciente	Nome completo, idade, sexo	Só o primeiro nome; idade e sexo ausentes
Medicamento	DCB ou nome do medicamento, dose ou concentração, forma farmacêutica	"Amoxicilina" sem concentração
Posologia	Dose, intervalo e duração	"Tomar 1 cp" sem intervalo ou sem dias
Quantidade	Em algarismos arábicos	"1 caixa" sem número de unidades
Emitente	Nome, inscrição no conselho ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura, carimbo	Receituário sem telefone ou sem endereço
Data	Data da emissão	Receita sem data, que impede contar a validade

A receita pode conter outros medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial (art. 8º). Não há limite de itens abrangidos pela RDC na mesma receita (art. 8º, parágrafo único). Um clonazepam, por exemplo, não pode estar na mesma folha de um antibiótico: ele exige receita própria da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Legibilidade, rasura e duas vias

O farmacêutico só pode dispensar receitas legíveis e sem rasuras (art. 10, § 2º). A RDC não define o meio de produzir a segunda via (carbono, segunda impressão ou cópia). O essencial é que ela reproduza todos os dados obrigatórios e traga a assinatura do prescritor; em caso de dúvida sobre cópias, siga a orientação da VISA local. Se o paciente chega com uma só via, a dispensação não deve ser feita como se houvesse duas: a farmácia não pode reter a única via do paciente sem deixar com ele um documento do tratamento, e a RDC exige a devolução da primeira via. Nesses casos, a conduta é contatar o prescritor ou orientar o paciente a obter a segunda via.

Quem pode prescrever

A RDC exige apenas que o prescritor seja "profissional legalmente habilitado" (art. 5º), dentro das suas competências. No balcão, os casos mais frequentes são:

- **Médico**: prescreve qualquer antimicrobiano.
- **Cirurgião-dentista**: prescreve medicamentos indicados em odontologia (Lei nº 5.081/1966). Amoxicilina, clindamicina, metronidazol e azitromicina são comuns em receitas odontológicas.
- **Enfermeiro**: prescreve medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde (Lei nº 7.498/1986). Em setembro de 2025, a Anvisa incluiu no SNGPC o campo de registro profissional do enfermeiro, permitindo escriturar receitas de antimicrobianos emitidas por enfermeiros "com o devido amparo legal" (Cofen, 12/09/2025).

Fora de programas e protocolos institucionais, a prescrição pelo farmacêutico não alcança antimicrobianos no balcão (Resolução CFF nº 586/2013 regula a prescrição farmacêutica).

Receita eletrônica

Segundo a Anvisa, as receitas de antimicrobianos e de agonistas do GLP-1 podem ser emitidas eletronicamente, desde que tenham ao menos **assinatura eletrônica avançada** do prescritor, nos termos da Lei nº 14.063/2020 (Anvisa, Perguntas e Respostas sobre RDC 471 e IN 360, 2025, item 5). A assinatura qualificada, com certificado ICP-Brasil, é de nível superior e também é aceita; ela é a exigida para receitas de controle especial. A farmácia precisa ter como acessar o documento original e verificar a validade da assinatura, por exemplo pelo validador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Todos os campos, inclusive a data, devem estar preenchidos eletronicamente.

ATENÇÃO

Foto da receita no celular, captura de tela ou PDF sem assinatura verificável não são receita eletrônica. Imprimir uma foto não cria a segunda via. Sem acesso ao original assinado, a dispensação não tem amparo.

Validade

A receita de antimicrobiano vale **10 dias** a contar da data de emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º, para o qual remete o art. 7º da RDC 471). O farmacêutico não pode aceitar receita fora do prazo (RDC 471, art. 10, § 1º). A redação original do art. 7º dizia expressamente que a receita era válida "em todo o território nacional". O texto de 2025 apenas remete à IN e não cria restrição territorial; o Perguntas e Respostas de 2025 confirma a aceitação da receita eletrônica em todo o país.

Situação	Validade	Fonte
Antimicrobiano, tratamento comum	10 dias da emissão; aviada uma única vez	IN 360/2025, art. 1º, § 2º; RDC 471, art. 13

Situação	Validade	Fonte
Antimicrobiano, tratamento prolongado (uso contínuo)	Aquisições posteriores em até 90 dias da emissão; quantidade para cada 30 dias indicada	RDC 471, art. 9º
Programas do Ministério da Saúde (ex.: tuberculose, hanseníase)	Segue a diretriz do programa	RDC 471, art. 9º, § 2º
Agonistas do GLP-1	90 dias da emissão	IN 360/2025, art. 2º, § 1º

Para contar o prazo, considere o dia da emissão como ponto de partida e confira se a dispensação está dentro dos 10 dias. Receita emitida em 1º de outubro, por exemplo, está no prazo até 11 de outubro. Como as vigilâncias sanitárias locais podem ter orientação própria sobre a forma de contagem, siga a da sua VISA quando houver.

Tratamento prolongado

Tratamento prolongado é a terapia por período superior a 30 dias (art. 4º, XIV). Exemplos: doxiciclina ou limeciclina para acne, nitrofurantoína em profilaxia de infecção urinária de repetição, azitromicina em uso prolongado prescrito por pneumologista. Nesse caso a receita pode ser usada para compras posteriores em até 90 dias da emissão, desde que contenha a indicação de **uso contínuo** e a quantidade para cada 30 dias (art. 9º, § 1º). Sem essas duas informações, vale a regra geral: 10 dias e uma única dispensação (art. 13).

Quantidade e fracionamento

A dispensação deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante apresentação comercial fracionável" (art. 11), nos termos da RDC 80/2006 sobre fracionamento. Se o médico prescreveu amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias, o tratamento pede 21 cápsulas. Se houver apresentação fracionável registrada, a farmácia autorizada a fracionar pode entregar exatamente 21. Se não houver, entrega a menor quantidade de embalagens que cubra o tratamento e orienta o paciente a descartar as sobras em ponto de coleta, nunca a guardar para "a próxima vez".

CASO

Receita de cefalexina 500 mg, 1 cápsula de 6 em 6 horas por 10 dias, quantidade "40 cápsulas", emitida há 12 dias. O farmacêutico não dispensa: a receita está vencida (IN 360/2025, art. 1º, § 2º). Orienta o paciente a voltar ao prescritor ou à unidade de saúde para nova receita e pergunta se o tratamento chegou a ser iniciado, para avaliar se há interrupção de terapia em curso.

NO BALCÃO

Ao receber a receita, confira nesta ordem: data (validade), duas vias, legibilidade, paciente, medicamento e posologia, quantidade, emitente e assinatura. Se faltar dado do emitente, do medicamento ou a data, contate o prescritor pelo telefone da receita antes de dispensar.

Dispensação e retenção da receita

A dispensação de antimicrobiano é ato privativo do farmacêutico (Resolução CFF nº 542/2011, art. 1º). Ela inclui conferir a receita, avaliar o tratamento, entregar o medicamento, registrar o atendimento nas duas vias, reter a via certa e orientar o paciente (RDC 471/2021, art. 4º, IV).

Qual via fica na farmácia

O QUE DIZ A NORMA

"A dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a retenção da 2ª (segunda) via da receita, devendo a 1ª (primeira) via ser devolvida ao paciente." (RDC 471/2021, art. 10)

A primeira via, a original, volta com o paciente: é o documento dele, com a posologia e a duração do tratamento. A segunda via fica retida para fiscalização e escrituração. A inversão (reter a original e devolver a cópia) é erro comum, herdado do costume com outras receitas.

Anotações obrigatórias

No ato da dispensação, o farmacêutico registra nas duas vias da receita (art. 10, § 3º):

1. a data da dispensação;
2. a quantidade aviada do medicamento abrangido pela RDC;
3. o **número do lote** do medicamento dispensado;
4. a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da receita.

O número do lote é exigência expressa e permite rastrear o produto em caso de desvio de qualidade ou recolhimento. Quando houver mais de um lote na mesma dispensação (duas caixas de lotes diferentes), anote os dois. Muitas farmácias usam carimbo de dispensação com campos para esses dados e para identificação do estabelecimento.

Idade, sexo e dados do comprador

Idade e sexo do paciente são dados obrigatórios da receita (art. 6º, I) e alimentam o SNGPC. No documento de 2025, a Anvisa orientou que o farmacêutico anote idade e sexo no verso do receituário, considerando o retorno do SNGPC como escrituração oficial (Perguntas e Respostas, item 11). A RDC 471 não exige identificação do comprador, ao contrário das notificações da Portaria 344/98. Para receitas eletrônicas, porém, a Anvisa orienta que a cópia impressa guardada tenha carimbo ou registro com os dados do comprador e da farmácia (item 5). Siga também a orientação da VISA local.

Receitas de outros estados

A RDC 471 não restringe receita de antimicrobiano por unidade da federação. Receita emitida em outro estado, dentro da validade e com todos os dados, pode ser atendida. Para a receita eletrônica, a Anvisa afirma que ela pode ser aceita em todo o território nacional desde que a farmácia consiga acessar o original e verificar a assinatura (Perguntas e Respostas, 2025, item 5).

Uso prolongado em mais de uma compra

No tratamento prolongado, cada atendimento dentro dos 90 dias repete as anotações do art. 10, § 3º (art. 13, parágrafo único). A Anvisa orienta que cada dispensação cubra no mínimo 30 dias de tratamento, sendo permitido entregar a quantidade para os 90 dias de uma vez (Perguntas e Respostas, 2025, item 6). Se o paciente comprar sempre na mesma farmácia, a segunda via é retida no primeiro atendimento e cada dispensação mensal é atestada em ambas as vias. Se comprar em outra farmácia, o farmacêutico confere as dispensações anteriores anotadas, faz cópia da via do paciente, atesta o novo atendimento nas duas e retém a cópia (item 7). Em todos os casos, ao menos uma via fica retida em cada estabelecimento que dispensou.

Dispensação da receita eletrônica

Com a receita eletrônica, o paciente costuma mostrar um código, um link ou um QR Code. O passo a passo prático é: abrir o documento original pelo link ou pela plataforma emissora; verificar a assinatura do prescritor em validador oficial; conferir os dados obrigatórios como em qualquer receita; verificar no próprio documento ou na plataforma se já houve dispensação anterior; registrar a dispensação, quando a plataforma permitir; baixar a cópia eletrônica e imprimir uma cópia para o arquivo, com os dados da farmácia, do comprador e a quantidade anotada no verso (Perguntas e Respostas, 2025, item 5). Como a receita eletrônica não tem duas vias físicas, o arquivo eletrônico e a cópia impressa cumprem o papel da via retida.

Entrega em domicílio e venda remota

No pedido por telefone ou aplicativo, a farmácia só pode separar o antimicrobiano depois de receber o documento que permita a retenção. Com receita em papel, o entregador recolhe a segunda via no ato da entrega e a traz para o farmacêutico conferir e registrar; o ideal é que o farmacêutico tenha visto uma imagem da receita antes da saída, para não mandar o produto com receita vencida ou incompleta. Com receita eletrônica, a conferência é feita antes do envio. A orientação ao paciente não desaparece: pode ser feita por telefone ou por escrito, junto com o produto.

Substituição e intercambialidade

O farmacêutico pode trocar o medicamento de referência pelo genérico correspondente, e por similar intercambiável, conforme as regras de intercambialidade, registrando a troca na receita. Não pode trocar uma substância por outra (amoxicilina por cefalexina, por exemplo), nem mudar dose, forma farmacêutica ou duração. Mudança de antimicrobiano é decisão do prescritor.

Prazos e recusas

- Receita fora dos 10 dias: recusar (art. 10, § 1º).

- Receita ilegível ou rasurada: recusar ou confirmar com o prescritor e solicitar nova receita (art. 10, § 2º).
- Receita sem a segunda via: não reter a única via do paciente; solicitar segunda via ao prescritor.
- Receita com antimicrobiano e medicamento de controle especial na mesma folha: o antimicrobiano pode ser atendido se a receita cumprir o art. 6º; o controlado segue a Portaria 344/98 e exige receituário próprio.

Devolução e troca

Pessoa física não pode devolver à farmácia medicamento com substância da lista (art. 21). A exceção é o desvio de qualidade ou de quantidade, ou a divergência com a rotulagem, avaliada e documentada pelo farmacêutico. Aceita a devolução, o produto nunca volta ao estoque e a autoridade sanitária deve ser notificada imediatamente (art. 21, §§ 1º e 2º).

CASO

Mãe apresenta receita de amoxicilina 250 mg/5 mL suspensão para a filha de 4 anos, emitida ontem, em duas vias, com posologia de 5 mL de 8 em 8 horas por 10 dias, quantidade "2 frascos". O farmacêutico confere os dados, calcula que o tratamento usa 150 mL e verifica o volume do frasco disponível. Dispensa os dois frascos, anota data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias, devolve a primeira via e retém a segunda. Orienta a reconstituição, a conservação conforme a bula e o uso da seringa dosadora.

NO BALCÃO

Monte uma rotina fixa: conferir, separar, conferir de novo contra a receita, anotar nas duas vias, reter a segunda, orientar. Deixar a anotação "para depois" é a causa mais comum de via retida sem lote ou sem rubrica na hora da fiscalização.

Escrituração no SNGPC e guarda das receitas

Escriturar é registrar a movimentação dos medicamentos sujeitos a controle sanitário: entradas (compras, transferências recebidas), saídas (vendas, transferências enviadas) e perdas (RDC 471/2021, art. 4º, VI). Para os medicamentos da RDC 471, o credenciamento e a escrituração de compra e venda devem ser feitos no SNGPC, conforme a RDC nº 22/2014 (art. 14).

Situação do SNGPC

Em dezembro de 2021, a RDC nº 586/2021 suspendeu temporariamente, e por tempo indeterminado, os prazos de transmissão de arquivos ao SNGPC. Durante a suspensão, as farmácias continuaram obrigadas a registrar toda a movimentação em sistema informatizado interno ou livro, que servia de instrumento oficial para a fiscalização. A retenção da receita nunca foi suspensa.

Em 2025, a Anvisa restabeleceu a transmissão obrigatória em cronograma regional:

Região	Início da transmissão obrigatória
Sudeste	1º de setembro de 2025
Sul e Norte	1º de novembro de 2025
Centro-Oeste e Nordeste	2 de janeiro de 2026

Em outubro de 2026, portanto, a transmissão ao SNGPC é obrigatória em todas as regiões. O SNGPC abrange medicamentos da Portaria 344/98, antimicrobianos e agonistas do GLP-1 (CFF, 24/10/2025). Os arquivos XML devem ser enviados com intervalo mínimo de 1 e máximo de 7 dias consecutivos, conforme os §§ 3º e 4º do art. 10 da RDC 22/2014 (CFF, 06/05/2025). O descumprimento é infração sanitária.

PONTO-CHAVE

Só o farmacêutico responsável técnico, com cadastro válido na Anvisa, faz o inventário inicial e transmite os arquivos. O inventário inicial exige contagem física, e um novo arquivo só pode ser enviado depois que o anterior estiver com status "Aceito" (CFF, 24/10/2025).

Livro de registro específico

Em localidades sem internet, a vigilância sanitária local pode autorizar a escrituração em livro de registro específico, para cada categoria listada na IN, ou em sistema informatizado previamente avaliado e aprovado. Nesse caso, o prazo máximo para escriturar é de 7 dias a contar da dispensação (art. 14, parágrafo único, e art. 16). As farmácias públicas que dispensam mediante ressarcimento, como as do Programa Farmácia Popular, escrituram em livro ou sistema aprovado pela VISA local, com o mesmo prazo de 7 dias (art. 15).

O que entra na escrituração de saída

Cada venda de antimicrobiano gera um registro com o medicamento, a quantidade, o lote, a data, os dados do prescritor (inclusive o conselho e o número de inscrição, agora com campo para o Coren) e os dados do paciente exigidos pelo leiaute do sistema, como idade e sexo. Por isso a receita precisa estar completa: o que falta nela falta no arquivo.

Entradas, perdas e transferências

A escrituração não se limita às vendas. Toda nota fiscal de compra de medicamento abrangido gera uma entrada, com o produto, o lote e a quantidade. Perdas também são escrituradas: produto vencido, frasco quebrado, embalagem violada, medicamento recolhido por determinação sanitária. A perda precisa de documento que a comprove (registro interno assinado pelo farmacêutico e, quando for o caso, o comprovante de destinação a empresa de resíduos de serviços de saúde). Transferências entre filiais da mesma rede saem de um estabelecimento e entram no outro, cada qual com sua nota.

O objetivo do sistema é que o estoque escriturado bata com o estoque físico. Se a farmácia tem registradas 12 caixas de azitromicina 500 mg do lote X e a prateleira mostra 10, alguma movimentação ficou sem registro: uma venda sem receita, uma perda não lançada ou um erro de digitação. Por isso, a

contagem periódica dos antimicrobianos de maior giro é uma boa prática, mesmo sem exigência de frequência na RDC.

Sistema interno e período de transição

Durante a suspensão da transmissão (2021 a 2025), o sistema informatizado interno ou o livro era o instrumento oficial de escrituração. No retorno, a Anvisa orientou que não era preciso encerrar inventários em andamento para incluir os agonistas do GLP-1: bastava lançar as entradas ocorridas a partir de 23/06/2025 e seguir com as transmissões normais (Perguntas e Respostas, 2025, item 10). Para a farmácia que abre agora, o caminho é cadastrar o estabelecimento e o responsável técnico, fazer o inventário inicial com contagem física e iniciar as transmissões.

Guarda das receitas e documentos

O QUE DIZ A NORMA

"Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 2 (dois) anos a documentação referente à compra, venda, transferência, perda e devolução das substâncias bem como dos medicamentos que as contenham substâncias listadas na Instrução Normativa específica, objeto dessa norma." (RDC 471/2021, art. 22)

As segundas vias retidas, as notas fiscais de compra, as notas de transferência, os registros de perda (vencimento, quebra) e de devolução formam esse arquivo. Organize por mês e por ordem de data de dispensação; a fiscalização costuma cruzar receitas com saídas registradas.

Guarda da receita eletrônica

Para receitas eletrônicas, a Anvisa orienta guardar uma cópia eletrônica baixada, que serve de comprovante, e uma cópia impressa para consulta, com carimbo ou registro dos dados do comprador e da farmácia e a quantidade anotada no verso (Perguntas e Respostas, 2025, item 5).

ATENÇÃO

Venda registrada no caixa sem receita retida correspondente, ou receita retida sem lançamento no SNGPC, gera divergência de estoque. Divergência de estoque de medicamento controlado é um dos achados mais comuns em inspeção e pode levar a autuação do estabelecimento e a processo ético do responsável técnico.

NO BALCÃO

Ao fim de cada turno, confira se cada antimicrobiano que saiu no caixa tem a segunda via retida com lote e rubrica, e se o lançamento foi feito no sistema. Resolver no mesmo dia é muito mais fácil do que reconstruir a movimentação na semana seguinte.

Infrações e erros comuns

O descumprimento da RDC 471 é infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437/1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal (RDC 471/2021, art. 25). A Lei 6.437/1977 prevê penalidades como advertência, multa, apreensão de produto, interdição e cancelamento de autorização ou licença. Para o farmacêutico, a mesma conduta pode gerar processo ético no Conselho Regional de Farmácia.

Responsabilidade ética

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 724/2022) proíbe ao farmacêutico dispensar ou aviar prescrições em desacordo com a técnica farmacêutica, as boas práticas ou a legislação vigente (art. 17, XII), e expor, comercializar, dispensar ou entregar medicamento em contrariedade à legislação, ou permitir que isso seja feito (art. 17, VI). A Lei nº 13.021/2014 determina que o proprietário não pode desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico (art. 11).

Erros mais frequentes

Erro	Por que é infração	Conduta correta
Vender sem receita, "o cliente traz depois"	Dispensação sem retenção (art. 2º)	Não dispensar; encaminhar
Aceitar receita com mais de 10 dias	Receita vencida (art. 10, § 1º)	Recusar; orientar nova consulta
Reter a 1ª via e devolver a 2ª	Contraria o art. 10	Reter a 2ª, devolver a 1ª
Não anotar lote ou rubrica	Falta registro obrigatório (art. 10, § 3º)	Anotar nas duas vias no ato
Atender receita rasurada ou ilegível	Vedado (art. 10, § 2º)	Confirmar com prescritor; nova receita
Reutilizar receita comum em nova compra	Receita é aviada uma vez (art. 13)	Só reutilizar no uso contínuo do art. 9º
Aceitar foto de receita	Sem original e sem segunda via	Exigir papel em 2 vias ou original eletrônico verificável
Trocar antimicrobiano por outro	Altera a prescrição	Contatar prescritor
Aceitar devolução e revender	Vedado (art. 21)	Só desvio de qualidade, sem reintegrar ao estoque
Atrasar a escrituração	Prazo do SNGPC ou de 7 dias no livro	Escriturar na rotina diária
Balconista dispensando sozinho	Ato privativo (Res. CFF 542/2011)	Farmacêutico confere e registra

Como a fiscalização costuma agir

Na inspeção, o fiscal da vigilância sanitária costuma pedir as segundas vias retidas de um período, os relatórios de movimentação do SNGPC ou do sistema interno e as notas fiscais de compra. Depois confere, por amostragem, se cada saída tem receita correspondente, se as receitas estavam dentro da validade no dia da dispensação, se trazem lote e rubrica e se o estoque físico confere. O fiscal do Conselho Regional de Farmácia, por sua vez, verifica a presença do farmacêutico e se a dispensação foi feita por ele. O CRF-SP, por exemplo, mantém um termo de orientação específico para dispensação de antimicrobianos com receituário incompleto ou inadequado.

Para o farmacêutico, a melhor defesa é a rotina documentada: receitas organizadas por data, anotações completas, intervenções registradas e escrituração em dia. Uma farmácia que mostra procedimento escrito (POP de dispensação de antimicrobianos) e registros consistentes demonstra controle mesmo quando aparece um erro isolado.

Receitas incompletas: o que dá para resolver

Falha na receita	Conduta sugerida
Sem data	Não dispensar; sem data não há como contar a validade
Sem concentração ou forma farmacêutica	Confirmar com o prescritor antes de dispensar
Sem quantidade em algarismos	Confirmar com o prescritor; calcular pela posologia e duração não substitui o dado
Sem idade e sexo do paciente	Perguntar e anotar no verso, conforme orientação da Anvisa de 2025
Sem telefone ou endereço do emitente	Avaliar com a VISA local; o dado é obrigatório (art. 6º, III)
Sem assinatura	Não dispensar

As condutas acima são práticas de segurança. Quando o dado faltante é obrigatório e não pode ser obtido com o prescritor, a dispensação fica sem amparo na norma.

Situações de pressão no balcão

As infrações quase nunca nascem de desconhecimento da regra. Nascem de pressão: o cliente conhecido, o gerente preocupado com a venda perdida, o paciente que "já toma esse remédio há anos". Ter um roteiro de recusa ajuda: explicar a regra em uma frase, mostrar que a recusa protege o próprio paciente, oferecer o caminho (unidade básica, pronto atendimento, teleconsulta) e, quando cabível, oferecer alívio sintomático com medicamento isento de prescrição e critérios claros de retorno.

CASO

Homem de 52 anos pede ciprofloxacino "porque sempre toma quando o xixi arde" e se irrita com a recusa. O farmacêutico explica que, em homem, infecção urinária pede avaliação médica, inclusive por possível acometimento da próstata, e que a automedicação pode mascarar o quadro. Pergunta por febre, dor lombar e retenção urinária. Sem sinais de alarme, orienta procurar a unidade básica no mesmo dia. Com febre ou dor lombar, orienta pronto atendimento.

ATENÇÃO

A venda sem receita de antimicrobiano costuma ser descoberta pelo cruzamento entre notas de compra, estoque físico e saídas escrituradas. Uma única venda "por fora" desequilibra o estoque e deixa rastro.

NO BALCÃO

Combine com a equipe uma frase padrão para a recusa e deixe a decisão final com o farmacêutico. Registre as intervenções relevantes (contato com prescritor, recusa por receita vencida com encaminhamento) para documentar a conduta técnica.

Orientação ao paciente na dispensação

A RDC 471 define a dispensação como o ato em que o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento, com ênfase no cumprimento do regime posológico, na influência dos alimentos, nas interações, nas reações adversas e na conservação (art. 4º, IV). A farmacologia completa dos antimicrobianos fica no SOS Farmacologia; aqui fica o roteiro mínimo do balcão.

Roteiro mínimo

1. **Horários**: transformar "de 8 em 8 horas" em horários concretos (por exemplo, 6 h, 14 h e 22 h) e escrever na embalagem.
2. **Duração**: tomar até o fim do período prescrito, mesmo com melhora, salvo orientação contrária do prescritor.
3. **Alimentos e outros medicamentos**: avisar quando o antimicrobiano deve ser separado de leite, antiácidos, cálcio, ferro ou zinco (tetraciclinas e quinolonas); o detalhamento está no módulo de interações.
4. **Álcool**: evitar com metronidazol durante o tratamento e após o fim (a bula brasileira pede pelo menos 1 dia; a bula norte-americana, 3 dias).
5. **Reações adversas**: diarreia leve é comum; diarreia intensa, com sangue ou febre, e qualquer sinal de alergia (urticária, inchaço de lábios, falta de ar) exigem procurar atendimento.
6. **Conservação**: suspensões reconstituídas seguem o prazo e a temperatura da bula; descartar a sobra no fim do tratamento.
7. **Retorno**: sem melhora em 48 a 72 horas, ou com piora, procurar o prescritor.

Antimicrobiano	Orientação específica de balcão
Doxiciclina	Tomar com um copo cheio de água e não deitar logo após; proteger-se do sol
Quinolonas	Separar de antiácidos, cálcio, ferro e zinco; procurar atendimento se houver dor em tendão
Metronidazol	Evitar álcool; gosto metálico é esperado
Amoxicilina com clavulanato	Tomar no início da refeição para reduzir desconforto gastrointestinal
Nitrofurantoína	Tomar com alimento; urina pode escurecer

Situações que pedem atenção redobrada

- **Criança**: conferir se a dose prescrita em mg/kg é compatível com o peso informado; ensinar a medir na seringa dosadora, nunca em colher de cozinha.
- **Gestante**: tetraciclinas e quinolonas costumam ser evitadas na gestação; diante de prescrição dessas classes para gestante, confirmar com o prescritor.
- **Idoso**: perguntar pela função renal conhecida (nitrofurantoína, por exemplo, perde eficácia e ganha toxicidade com função renal reduzida) e pelos medicamentos de uso contínuo.
- **Alergia relatada a penicilina**: diante de amoxicilina ou ampicilina, perguntar qual foi a reação e contatar o prescritor quando a alergia for provável.

A orientação deve caber em dois ou três minutos e terminar com uma pergunta de checagem ("Como o senhor vai tomar?"). Quando há muita informação, escreva os horários na caixa ou entregue um cartão de horários.

NO BALCÃO

Pergunte sempre se o paciente usa varfarina, anticoncepcional, antiácido, suplemento de cálcio ou ferro, levotiroxina ou estatina, e se tem alergia conhecida. Essas quatro perguntas pegam a maior parte das interações relevantes com antimicrobianos orais.

CASO

Mulher de 29 anos recebe azitromicina 500 mg, 1 comprimido ao dia por 3 dias. Ela pergunta se pode parar no segundo dia, porque já melhorou. O farmacêutico explica que a dose total prescrita faz parte do tratamento, que o esquema curto já é o completo e que interromper antes aumenta o risco de falha. Confirma que ela não usa outros medicamentos que prolongam o intervalo QT.

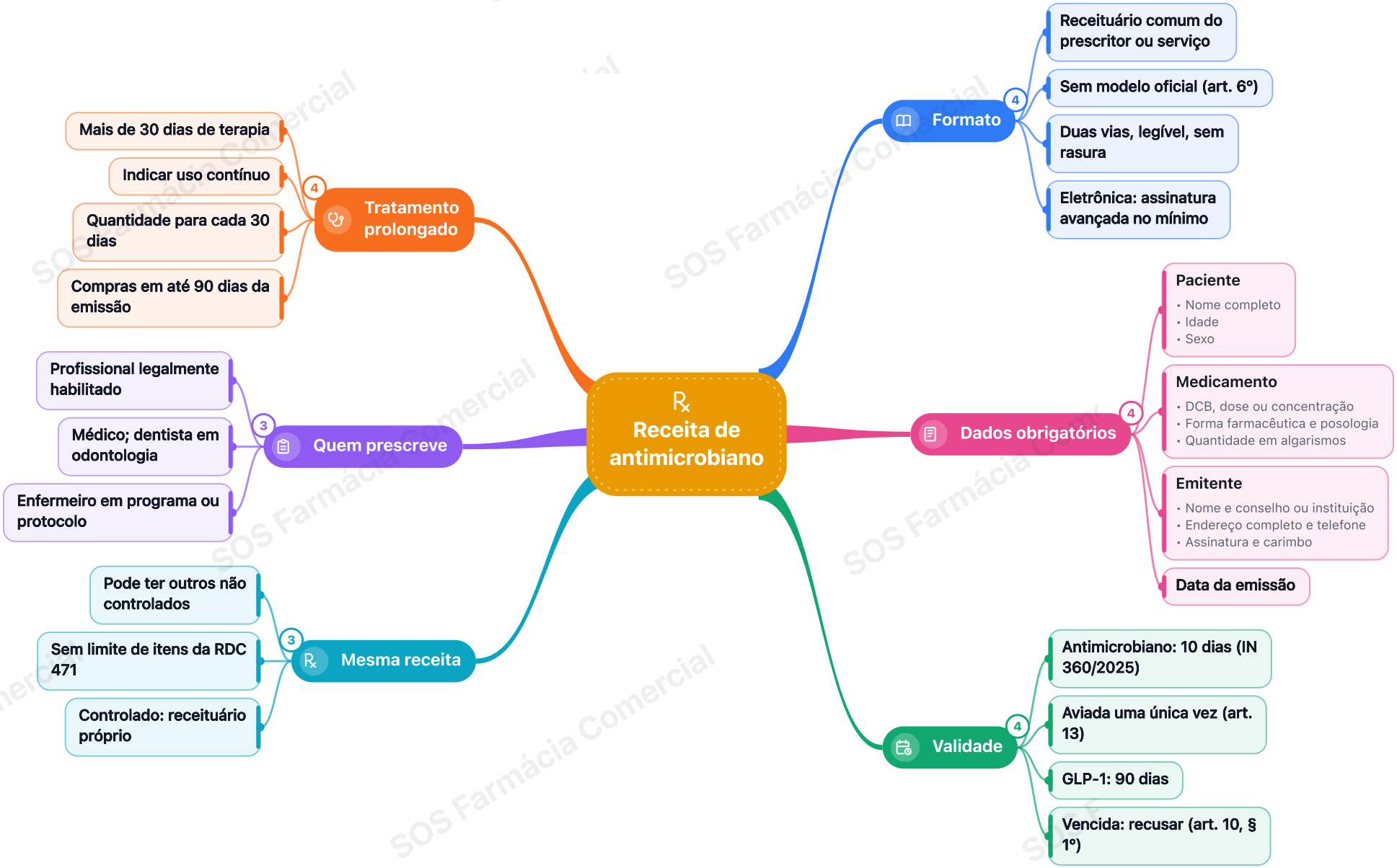
Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021. Diário Oficial da União, 24/02/2021, Seção 1, p. 85. Texto consolidado com alterações da RDC nº 973/2025 e da Resolução nº 768/2022 (consultado em legisweb.com.br, out. 2026).
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Altera a RDC nº 471/2021. Diário Oficial da União, 24/04/2025, Seção 1, p. 226.
3. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025. Define a lista de substâncias de uso sob prescrição e retenção da receita de que trata a RDC nº 471/2021. Diário Oficial da União, 24/04/2025, Seção 1, p. 225.
4. Anvisa (GGMON/GPCON). Perguntas & Respostas: Mudanças na comercialização e escrituração de medicamentos agonistas do receptor do GLP-1. RDC nº 471/2021 e IN nº 360/2025. 1ª ed., versão de 30/06/2025. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/monitoramento/farmacovigilancia/perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-mudancas-na-comercializacao-e-escrituracao-dos-medicamentos-inibidores-glp-1
5. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa reestabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos eletrônicos ao SNGPC. Notícia de 06/05/2025. https://site.cff.org.br
6. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia de 24/10/2025. https://site.cff.org.br
7. Conselho Federal de Enfermagem. Notícia sobre a inclusão do registro do enfermeiro no SNGPC para receitas de antimicrobianos, 12/09/2025. https://www.cofen.gov.br
8. CRF-SP. Orientação Farmacêutica: Dispensação de antimicrobianos sujeitos ao controle da RDC nº 471/21 mediante receituários com preenchimento inadequado/incompleto. 2023 (inclui trechos da Res. CFF 542/2011, Res. CFF 724/2022 e Lei 13.021/2014).
9. Bulas brasileiras de metronidazol comprimido (seção de interações: álcool), consultadas em out. 2026.

SOS Farmácia Comercial

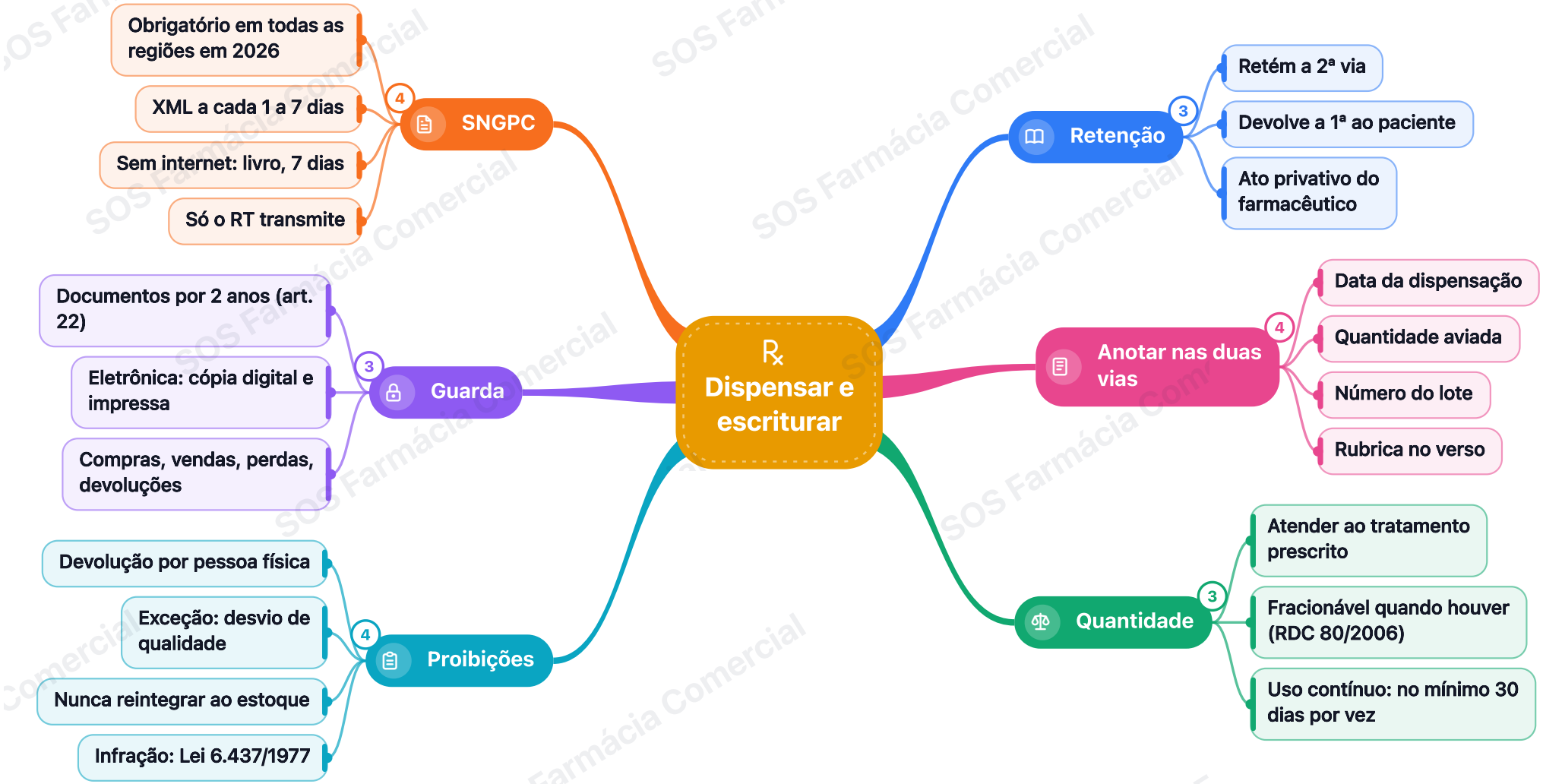
Receita e validade

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 3



Dispensação e escrituração

6 ramos · 21 itens · mapa mental do módulo 3



Receita de antimicrobiano (RDC 471/2021)

RECEITA DE ANTIMICROBIANO (RDC 471/2021)

Receituário comum do prescritor ou do estabelecimento, em duas vias

Nº _____

Não há numeração oficial nem talonário fornecido pela vigilância sanitária; a receita não depende de cadastro prévio do prescritor.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional ou nome da instituição: _____

Inscrição no Conselho Regional: _____

Endereço completo: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo: _____

Idade: _____

Sexo: _____

PRESCRIÇÃO

Nome do medicamento ou substância (DCB): _____

Dose ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Posologia: _____

Quantidade em algarismos arábicos: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

Marcação gráfica (carimbo): _____

REGISTRO DA DISPENSAÇÃO (NAS DUAS VIAS)

Data da dispensação: _____

Quantidade aviada: _____

Número do lote: _____

Rubrica do farmacêutico no verso: _____

Regra	Como é
Vias	Duas: a 2ª fica retida na farmácia, a 1ª volta ao paciente (art. 10)
Validade	10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º)
Tratamento prolongado	Até 90 dias da emissão, com uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º)
Abrangência	Sem restrição por estado; eletrônica aceita em todo o país se verificável
Outros itens	Pode incluir medicamentos não sujeitos a controle especial (art. 8º)

Regra	Como é
Guarda	2 anos à disposição da vigilância sanitária (art. 22)

A RDC 471/2021 não tem modelo oficial (art. 6º); a ordem dos campos acima segue o parágrafo único do art. 6º e o § 3º do art. 10.

Requisitos da receita e da dispensação

Item	Exigência	Artigo
Prescritor	Profissional legalmente habilitado	RDC 471, art. 5º
Receituário	Privativo do prescritor ou do estabelecimento; sem modelo específico	art. 6º
Forma	Legível, sem rasuras, em 2 vias	art. 6º, parágrafo único
Paciente	Nome completo, idade e sexo	art. 6º, I
Medicamento	DCB, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia, quantidade em algarismos	art. 6º, II
Emitente	Nome e inscrição no conselho ou instituição, endereço, telefone, assinatura, carimbo	art. 6º, III
Data	Data da emissão	art. 6º, IV
Validade	Conforme a IN: 10 dias para antimicrobianos	art. 7º; IN 360/2025, art. 1º, § 2º
Outros medicamentos	Permitidos se não forem de controle especial; sem limite de itens	art. 8º
Tratamento prolongado	Até 90 dias; uso contínuo e quantidade por 30 dias	art. 9º
Retenção	Reter a 2ª via e devolver a 1ª	art. 10
Anotações	Data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias	art. 10, § 3º
Quantidade	Atender ao tratamento; fracionável quando houver	art. 11
Uso único	Receita aviada uma vez, salvo art. 9º	art. 13
Escrituração	SNGPC; livro ou sistema aprovado só onde não há internet (7 dias)	arts. 14 a 16
Devolução	Vedada, salvo desvio de qualidade documentado	art. 21
Guarda	2 anos	art. 22

Artigos da RDC 471/2021 com a redação dada pela RDC 973/2025.

SOS Farmácia Comercial

Dispensação de antimicrobiano

Paciente apresenta receita com antimicrobiano

DECISÃO

A substância está na lista da IN 360/2025?

- **SIM** — Seguir o fluxo da RDC 471
- **NÃO** — Dispensar pelas regras gerais da receita comum

DECISÃO

Receita dentro de 10 dias, ou no prazo de uso contínuo?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Recusar e orientar nova consulta

DECISÃO

Há duas vias legíveis, sem rasura, ou original eletrônico com assinatura verificável?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não dispensar; solicitar segunda via ou nova receita

DECISÃO

Dados do paciente, do medicamento, do emitente e data completos?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Contatar o prescritor; não dispensar com dado essencial faltando

Avaliar dose, duração, alergias e interações

DECISÃO

Problema clínico relevante encontrado?

- **SIM** — Contatar o prescritor e registrar a intervenção
- **NÃO** — Separar a quantidade que atende ao tratamento

Anotar data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias

↓

Reter a 2ª via e devolver a 1ª ao paciente

↓

Orientar horários, duração, alimentos, álcool e sinais de alerta

↓

ATENÇÃO

Lançar a saída no SNGPC dentro do prazo

↓

Arquivar a 2ª via por 2 anos

Conferência da receita de antimicrobiano

- ◯ Conferir na IN 360/2025 se alguma substância da fórmula está listada
- ◯ Conferir a data de emissão e contar os 10 dias
- ◯ Verificar se há indicação de uso contínuo e quantidade por 30 dias, quando for tratamento prolongado
- ◯ Confirmar duas vias legíveis e sem rasuras
- ◯ Na receita eletrônica, abrir o original e validar a assinatura
- ◯ Conferir nome completo, idade e sexo do paciente
- ◯ Conferir DCB, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade em algarismos
- ◯ Conferir nome, conselho e número, endereço, telefone, assinatura e carimbo do emitente
- ◯ Verificar se não há medicamento de controle especial na mesma folha
- ◯ Calcular a quantidade que atende ao tratamento
- ◯ Perguntar por alergias, gestação e medicamentos em uso
- ◯ Anotar data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias

- ◯ Reter a 2ª via e devolver a 1ª
- ◯ Lançar a saída no SNGPC

RDC 20/2011 e RDC 471/2021 comparadas

Aspecto	RDC 20/2011	RDC 471/2021 (texto vigente)
Situação	Revogada (RDC 471, art. 26, I)	Vigente, alterada pela RDC 973/2025
Lista de substâncias	Anexo da própria resolução	Instrução Normativa específica (hoje IN 360/2025)
Alcance	Somente antimicrobianos	Antimicrobianos e, desde 23/06/2025, agonistas do GLP-1
Validade da receita	10 dias	Definida na IN: 10 dias (antimicrobianos), 90 dias (GLP-1)
Vias e retenção	Duas vias, com retenção de uma pela farmácia	Retém a 2ª via e devolve a 1ª (art. 10)
Tratamento prolongado	Até 90 dias	Até 90 dias, com uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º)
Fracionamento	Possível conforme RDC 80/2006	Dispensação deve atender ao tratamento, inclusive por apresentação fracionável (art. 11)
Escrituração	SNGPC	SNGPC (RDC 22/2014); livro só sem internet, com autorização (art. 14)
Venda remota	Seguia a RDC 44/2009	Não vedada, observada a RDC 44/2009 (art. 12)
Rotulagem	Frase de retenção na embalagem	Frase em caixa alta na bula e no rótulo (art. 18)

A coluna da RDC 20/2011 é histórica e resumida; para a prática, vale apenas a coluna da direita. Confira o texto da RDC 20/2011 se precisar de detalhe de artigo.

Cartões de revisão: RDC 471/2021

Pergunta	Resposta
Validade da receita de antimicrobiano?	10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º).
Qual via fica retida na farmácia?	A 2ª via; a 1ª é devolvida ao paciente (art. 10).
Quatro anotações obrigatórias nas duas vias?	Data da dispensação, quantidade aviada, número do lote e rubrica do farmacêutico (art. 10, § 3º).

Pergunta	Resposta
Dados obrigatórios do paciente?	Nome completo, idade e sexo (art. 6º, I).
Existe modelo oficial de receita de antimicrobiano?	Não. Receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento, em duas vias (art. 6º).
O que é tratamento prolongado na RDC 471?	Terapia por mais de 30 dias (art. 4º, XIV).
Regra da receita de uso contínuo?	Compras em até 90 dias da emissão, com uso contínuo e quantidade por 30 dias indicados (art. 9º).
Pomada com neomicina exige retenção?	Sim. A regra segue a substância listada, independentemente da via.
Antimicrobianos fora da lista da IN 360?	Os de uso exclusivo hospitalar (art. 1º, § 1º).
Assinatura mínima da receita eletrônica, segundo a Anvisa?	Assinatura eletrônica avançada (Lei 14.063/2020), com acesso ao original para verificação.
Prazo de guarda dos documentos?	2 anos (art. 22).
Prazo de escrituração em livro onde não há internet?	Até 7 dias da dispensação (art. 14, parágrafo único).
Intervalo de envio de arquivos ao SNGPC?	Mínimo de 1 e máximo de 7 dias consecutivos (RDC 22/2014, art. 10).
Quem dispensa e controla antimicrobianos?	O farmacêutico, como atribuição privativa (Res. CFF 542/2011).
Validade da receita de semaglutida?	90 dias, com retenção (IN 360/2025, art. 2º, § 1º).

Questões: RDC 471/2021

1. Paciente apresenta receita de cefalexina 500 mg emitida há 12 dias, sem indicação de uso contínuo. Conforme a norma vigente, o farmacêutico deve:

A dispensar, pois a validade é de 30 dias

B recusar, pois a validade é de 10 dias

C dispensar metade da quantidade prescrita

D dispensar e anotar o atraso no verso

E dispensar se a receita for do mesmo estado

2. Sobre a retenção da receita de antimicrobiano em drogaria, é correto afirmar que:

A) a 1ª via fica retida e a 2ª volta ao paciente

B) as duas vias ficam retidas

C) a 2ª via fica retida e a 1ª volta ao paciente

D) nenhuma via é retida se houver SNGPC

E) retém-se uma cópia simples da 1ª via

3. Na dispensação de amoxicilina, NÃO é anotação exigida nas duas vias pela RDC 471/2021:

A) data da dispensação

B) quantidade aviada

C) número do lote

D) rubrica do farmacêutico

E) CPF do comprador

4. Cliente pede pomada de neomicina com bacitracina sem receita, alegando ser de uso tópico. A conduta correta é:

A) vender, pois os produtos de uso tópico estão excluídos da norma

B) exigir receita, porque as substâncias estão listadas na IN

C) vender, desde que anote nome e documento do cliente no caixa

D) exigir receita só se for para criança

E) vender a menor embalagem disponível

5. Receita de limeciclina para acne, com 'uso contínuo' e quantidade para cada 30 dias, emitida há 50 dias. A paciente já comprou o primeiro mês na mesma farmácia. Agora:

A) pode comprar o segundo mês, com novas anotações nas vias

B) precisa de nova receita, pois já se passaram mais de 10 dias

C) pode comprar, mas a farmácia fica dispensada de anotar o lote

D) só pode comprar mediante notificação de receita do tipo B

E) pode comprar apenas em outra farmácia, com cópia da receita

6. Sobre a receita eletrônica de antimicrobiano, segundo a Anvisa (2025):

A só vale com certificado ICP-Brasil emitido para o paciente

B não é aceita para antimicrobianos, só para GLP-1

C vale com foto enviada pelo aplicativo de mensagens

D exige assinatura avançada e acesso ao original

E só vale no estado onde o prescritor está inscrito

7. Por quanto tempo a drogaria deve manter as segundas vias de receitas de antimicrobianos à disposição da vigilância sanitária?

A 6 meses

B 1 ano

C 2 anos

D 5 anos

E 10 anos

8. Em outubro de 2026, uma drogaria do Nordeste que vende antimicrobianos deve:

A usar só sistema interno, pois o SNGPC segue suspenso

B transmitir ao SNGPC apenas medicamentos da Portaria 344

C transmitir ao SNGPC a cada 30 dias

D escriturar em livro, sem autorização da VISA

E transmitir ao SNGPC com intervalo de 1 a 7 dias

9. Paciente quer devolver uma caixa fechada de azitromicina porque o médico trocou o antibiótico. O farmacêutico deve:

A aceitar e devolver o produto ao estoque comercializável

B aceitar e trocar pelo novo antibiótico prescrito

C aceitar, desde que o cliente apresente a nota fiscal

D recusar, pois a norma veda a devolução nesse caso

E aceitar e registrar a entrada no SNGPC como devolução

10. Receita traz, na mesma folha, amoxicilina e clonazepam. Sobre a amoxicilina:

A pode ser dispensada se a receita cumprir a RDC 471

B nunca pode ser dispensada a partir dessa receita

C passa a exigir notificação de receita do tipo B

D só pode ser dispensada junto com o clonazepam

E deve ser dispensada sem retenção de nenhuma via

11. Uma receita de semaglutida emitida há 60 dias, em duas vias e completa, pode ser atendida?

A Não, pois vale 10 dias

B Não, pois exige notificação azul

C Sim, pois vale 90 dias, com retenção

D Sim, sem retenção de via

E Só com laudo médico anexo

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **B**. A IN 360/2025 (art. 1º, § 2º), à qual remete o art. 7º da RDC 471/2021, fixa validade de 10 dias para receitas de antimicrobianos, e o art. 10, § 1º, proíbe aceitar receita vencida. Não há validade de 30 dias, dispensação parcial ou ressalva por estado.
2. **C**. O art. 10 da RDC 471/2021 determina a retenção da 2ª via e a devolução da 1ª ao paciente. Reter a original ou as duas vias contraria a norma, e a escrituração no SNGPC não dispensa a retenção.
3. **E**. O art. 10, § 3º, exige data, quantidade, lote e rubrica no verso. A RDC 471 não exige identificação do comprador; essa exigência é típica das notificações de receita da Portaria 344/98.
4. **B**. A RDC 471/2021 abrange medicamentos com substâncias listadas na IN, isoladas ou em associação (art. 1º), sem exclusão por via. Neomicina e bacitracina estão na IN 360/2025. A única exclusão expressa é a dos antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar.
5. **A**. No tratamento prolongado, a receita vale para aquisições em até 90 dias da emissão, se indicar uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º). Cada atendimento repete as anotações do art. 10, § 3º (art. 13, parágrafo único).
6. **D**. O Perguntas e Respostas da Anvisa sobre RDC 471 e IN 360 (2025) admite receita eletrônica com assinatura avançada do prescritor (Lei 14.063/2020), aceita em todo o país se a farmácia puder acessar o original e verificar a assinatura. Foto não é documento eletrônico assinado.
7. **C**. O art. 22 da RDC 471/2021 determina manter por 2 anos a documentação de compra, venda, transferência, perda e devolução.
8. **E**. A Anvisa restabeleceu a transmissão obrigatória com início em 02/01/2026 para Centro-Oeste e Nordeste; o SNGPC abrange antimicrobianos, e o intervalo de envio é de 1 a 7 dias (RDC 22/2014, art. 10). Livro só onde não há internet e com autorização da VISA (RDC 471, art. 14).
9. **D**. O art. 21 da RDC 471/2021 veda a devolução por pessoa física. A exceção é desvio de qualidade ou de quantidade, ou divergência com a rotulagem; mesmo aceita, o produto nunca volta ao estoque e a autoridade sanitária deve ser notificada.
10. **A**. O art. 8º permite outros medicamentos na receita de antimicrobiano, desde que não sejam de controle especial. O clonazepam exige receituário próprio da Portaria 344/98 e não pode ser atendido assim; a amoxicilina segue a RDC 471 se a receita estiver completa.
11. **C**. Desde 23/06/2025, os agonistas do GLP-1 seguem a RDC 471/2021 com validade de 90 dias (IN 360/2025, art. 2º, § 1º), com retenção da receita e escrituração. Os 10 dias valem para antimicrobianos.

Módulo 4

Medicamentos termolábeis e boas práticas de armazenamento

Faixas de temperatura da Farmacopeia Brasileira, termolábeis, fotossensíveis e higroscópicos; estrutura e equipamentos de frio, monitorização e registro, excursão de temperatura e plano de contingência; conservação, conferida em bula, dos termolábeis comuns na farmácia comercial; recebimento, transporte e orientação ao paciente; boas práticas gerais de armazenamento. Fontes centrais: RDC 44/2009, RDC 430/2020, RDC 197/2017, Manual de Rede de Frio do PNI (6ª ed., 2025), Farmacopeia Brasileira (6ª ed.), OMS e bulas brasileiras.

- Faixas de temperatura, estabilidade e sensibilidade
- Área de armazenamento e equipamentos de frio
- Monitorização e registro da temperatura
- Excursão de temperatura e plano de contingência
- Termolábeis comuns na farmácia comercial
- Recebimento, transporte e orientação ao paciente
- Boas práticas gerais de armazenamento

Faixas de temperatura, estabilidade e sensibilidade

Todo medicamento tem um prazo de validade, e esse prazo só vale se o produto ficar nas condições declaradas pelo fabricante. A validade impressa na embalagem é resultado de estudos de **estabilidade**: o fabricante testa o produto em temperatura, umidade e luz definidas e mostra que, nessas condições, ele mantém identidade, teor, pureza, características físicas e segurança até a data indicada. Fora dessas condições, a data deixa de ser garantia.

O calor acelera reações químicas como hidrólise e oxidação, que reduzem o teor do fármaco e podem gerar produtos de degradação. Em medicamentos de origem biológica (insulinas, análogos de GLP-1, anticorpos monoclonais, vacinas), o problema é ainda maior: proteínas perdem a estrutura com calor, congelamento e agitação, formam agregados e perdem atividade, às vezes sem nenhuma mudança visível. Por isso, nesses produtos, o aspecto normal não prova que o medicamento está bom.

Faixas de temperatura da Farmacopeia Brasileira

A Farmacopeia Brasileira, 6ª edição (Volume I, Generalidades), define os termos usados nas monografias e nas bulas:

Termo	Faixa
Em congelador	Entre -20 °C e 0 °C
Em refrigerador	Entre 2 °C e 8 °C
Local frio	Não excede 8 °C
Local fresco	Entre 8 °C e 15 °C
Temperatura ambiente	A normalmente encontrada em ambiente de trabalho, entre 15 °C e 30 °C
Local quente	Entre 30 °C e 40 °C
Calor excessivo	Acima de 40 °C

Duas regras da mesma seção ajudam no dia a dia. Produto que deve ficar em local fresco pode ser conservado em refrigerador, se a monografia não disser o contrário. E, quando nada é especificado, as condições de conservação incluem proteção contra umidade, congelamento e calor excessivo.

Como as bulas expressam a conservação

- **"Conservar em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C)"**: é a maioria dos comprimidos, cápsulas e líquidos orais. O limite de 30 °C é real; vitrine ao sol ou depósito sem ventilação no verão podem ultrapassá-lo.
- **"Conservar abaixo de 25 °C"** ou "até 25 °C": limite mais estreito, comum em alguns colírios após abertos, cremes e supositórios. Em cidades quentes, exige ambiente climatizado.

- **"Conservar sob refrigeração (entre 2 °C e 8 °C). Não congelar"**: produtos termolábeis. As duas partes da frase importam igualmente.
- **"Proteger da luz"** e "manter na embalagem original": a embalagem secundária faz parte da proteção.
- **"Após aberto, válido por..."**: prazo de uso que começa na abertura, independentemente da validade impressa. A data de abertura deve ser anotada.

Termolábil, fotossensível e higroscópico

A RDC 430/2020 define **medicamento termolábil** como aquele "cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8°C" (art. 3º, XVI). Um produto com limite de 25 °C, portanto, não é termolábil por essa definição, mas é sensível à temperatura e precisa de controle.

Característica	O que degrada o produto	Exemplos verificados em bula	Cuidado no armazenamento
Termolábil	Temperatura acima de 8 °C; muitos também não toleram congelamento	Insulinas fechadas, semaglutida, adalimumabe, vacinas	Refrigerador exclusivo, 2 °C a 8 °C, longe do congelador
Fotossensível	Luz visível ou ultravioleta	Dulaglutida (bula: "fotossensível"), latanoprosta, canetas de insulina (tampa colocada)	Embalagem original, recipiente opaco; tampa da caneta
Higroscópico	Umidade do ar, que é absorvida pelo produto	Amoxicilina com clavulanato comprimido (Clavulin BD) em envelope com dessecante, usar em até 14 dias após abrir o envelope	Embalagem fechada, sem retirar o dessecante; ambiente seco

A Farmacopeia esclarece que "proteger da luz" significa conservar em recipiente opaco ou capaz de impedir a ação da luz. Muitos produtos combinam as três sensibilidades: a insulina é termolábil, deve ser protegida da luz e não pode ser congelada.

Prazo após aberto

Muitos produtos têm dois prazos: a validade impressa, que vale para a embalagem fechada nas condições indicadas, e o prazo de uso depois de aberto, preparado ou retirado da geladeira. O segundo começa a contar no momento da abertura e prevalece se terminar antes da validade impressa. Exemplos verificados em bula: suspensões de antibióticos reconstituídas (7 a 14 dias em geladeira, conforme o produto), canetas de insulina em uso (4 a 8 semanas, conforme a marca), colírio de latanoprosta aberto (10 semanas na bula brasileira do Xalatan) e o comprimido de amoxicilina com clavulanato em envelope (14 dias após abrir o envelope). Na orientação ao paciente, o farmacêutico pede que ele escreva a data de abertura na embalagem.

Umidade

A umidade relativa do ar afeta sobretudo pós, comprimidos efervescentes, cápsulas gelatinosas e produtos higroscópicos. Por isso a RDC 44/2009 manda proteger o ambiente de armazenamento da umidade (art. 35, §2º) e pede que o POP inclua a metodologia de verificação da umidade, e não só da

temperatura (art. 35, §4º). A norma não fixa um valor; o POP define a faixa aceitável a partir das especificações dos produtos e do mapeamento do ambiente. Sinais de umidade excessiva no estoque são caixas amolecidas, rótulos descolando, mofo nas paredes e comprimidos manchados.

PONTO-CHAVE

A geladeira só entra quando a bula manda. Produto de temperatura ambiente não vai para o refrigerador sem indicação do fabricante, e algumas canetas de insulina em uso não devem voltar ao refrigerador por orientação do fabricante (por exemplo, insulina glargina 300 U/mL, glargina biossimilar e lispro em caneta KwikPen, conforme as bulas brasileiras).

NO BALCÃO

Mãe pergunta se pode guardar o xarope de ibuprofeno na geladeira "para durar mais". O farmacêutico explica que o prazo de uso depende do que a bula diz, não da geladeira, e que guardar em local diferente do indicado pode alterar o produto. Mostra na bula a frase de conservação e a validade após aberto.

Área de armazenamento e equipamentos de frio

A farmácia precisa de ambiente para recebimento e armazenamento (RDC 44/2009, art. 5º), com capacidade suficiente para estocar de forma ordenada as diversas categorias de produtos, limpo e protegido da luz solar direta, da umidade e do calor (art. 35, §§ 1º e 2º). Os produtos ficam em prateleiras, gavetas ou suporte equivalente, afastados do piso, das paredes e do teto, para permitir limpeza e inspeção (art. 36). A Lei 13.021/2014 acrescenta que a farmácia deve dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos (art. 6º, III).

Estrados, distância e luz

Caixas de estoque não ficam no chão. A RDC 430/2020, escrita para distribuidoras e útil como referência, diz que os medicamentos não devem ficar diretamente no chão nem encostados nas paredes, devem guardar distância do telhado e ficar longe da luz solar direta (art. 51), e que os estrados (paletes) devem ser de material que permita limpeza, como madeira tratada, alumínio ou plástico (art. 52). A RDC 44/2009 não fixa distância em centímetros; o POP de armazenamento define a da loja.

Refrigerador: o que as normas dizem

Situação	Exigência	Fonte
Vacinas	Equipamento de refrigeração exclusivo, regularizado na Anvisa, com termômetro de momento, máxima e mínima. Proibido refrigerador doméstico e frigobar	RDC 197/2017, art. 10, III, f, e §2º; Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025
Reagentes de exames (glicemia, testes rápidos) que exigem frio	Equipamento exclusivo, com registro de máxima, mínima e momento; compartilhamento só com medicamentos que não exijam equipamento exclusivo	RDC 978/2025, art. 14, V, e §1º

Situação	Exigência	Fonte
Demais medicamentos termolábeis	Obedecer à embalagem e medir e registrar a temperatura diariamente; a norma federal não especifica o tipo de equipamento	RDC 44/2009, art. 35, §3º

Para os termolábeis em geral, a escolha do equipamento é técnica e também depende da vigilância sanitária local, que pode ter exigências próprias. O Manual de Rede de Frio explica por que o refrigerador doméstico é inadequado para vacinas: as paredes não têm espessura suficiente para o isolamento térmico, o que facilita a troca de calor com o ambiente e desestabiliza a temperatura interna. A **câmara refrigerada científica** tem circulação forçada de ar, temperatura uniforme entre as prateleiras, alarme e registrador eletrônico. Para farmácias que estocam insulinas, análogos de GLP-1 e biológicos de alto custo, ela reduz muito o risco de perda.

Organização interna da geladeira

Quando a farmácia usa refrigerador que não é científico para termolábeis que não são vacinas, as boas práticas abaixo diminuem a variação de temperatura. Elas derivam do funcionamento desses aparelhos e da orientação do CRF-SP sobre armazenamento de termolábeis:

- **Uso exclusivo.** Nada de alimentos, bebidas, itens pessoais ou amostras. Cada abertura extra expõe os medicamentos a variação (orientação do CRF-SP).
- **Porta vazia.** A porta é a região que mais aquece a cada abertura.
- **Sem medicamento na gaveta inferior** (de verduras) nem encostado no evaporador ou no fundo, onde a temperatura pode cair abaixo de 2 °C e congelar o produto.
- **Circulação de ar.** Caixas com espaço entre si, sem lotar o aparelho e sem colocar os produtos dentro de caixas de isopor, potes ou sacolas, que funcionam como barreira térmica (CRF-SP).
- **Sensor no centro**, entre os produtos, e não encostado em parede ou em bobina de gelo.
- **Mapa da geladeira** afixado: o que fica em cada prateleira, com lote e validade, para abrir a porta já sabendo onde pegar (o Manual de Rede de Frio recomenda esse "mapa ilustrativo").
- **PVPS**: validade mais curta à frente.

Instalação

O Manual de Rede de Frio orienta posicionar câmaras longe da luz solar direta, em ambiente ventilado, com pelo menos 15 cm livres ao redor para circulação de ar, verificar o fechamento da porta a cada abertura e identificar o equipamento de forma visível. A tomada deve ser identificada para que ninguém desligue o aparelho por engano, e a farmácia deve ter alternativa para falta de energia, prevista no plano de contingência.

Instrumentos de medição

- **Termômetro de momento, máxima e mínima**, de preferência digital com cabo extensor: mostra a temperatura atual e os extremos desde a última reinicialização.

- **Registrador eletrônico (datalogger)**: grava a temperatura em intervalos programados e permite saber quando e por quanto tempo houve desvio, inclusive à noite e nos fins de semana.
- **Registrador do próprio equipamento**, nas câmaras científicas.
- **Termo-higrômetro** para o ambiente de estoque e dispensação, que mede temperatura e umidade relativa.

Todo instrumento de monitoramento deve ter certificado de calibração e ser recalibrado periodicamente, em frequência que depende do uso e do tipo, podendo variar de alguns meses a um ano (Manual de Rede de Frio, 2025). Os alarmes de temperatura, nas câmaras de vacinas, são programados entre 3 °C e 7 °C para dar margem de segurança antes de sair da faixa de 2 °C a 8 °C.

Mapeamento térmico

Mapear é medir a temperatura em vários pontos de uma área ou equipamento, em horários diferentes, para descobrir onde e quando ela fica mais alta ou mais baixa. Distribuidoras fazem estudos formais de qualificação térmica (RDC 430/2020, art. 3º, XXIII, e art. 43, §1º). Na farmácia, um mapeamento simples, com termômetros em pontos diferentes do estoque durante alguns dias quentes, mostra qual prateleira esquenta mais e em que horário. Esse dado sustenta a escolha do ponto e do horário de leitura que o POP precisa definir (RDC 44/2009, art. 35, §4º).

ATENÇÃO

Vacina guardada em geladeira doméstica ou frigobar é irregularidade sanitária, independentemente da temperatura registrada (RDC 197/2017, art. 10, §2º; Manual de Rede de Frio, 2025).

NO BALCÃO

Ao pegar uma caneta de insulina na geladeira, o balconista abre a porta já sabendo a prateleira (mapa afixado), retira o item com validade mais curta e fecha a porta em seguida. Se a porta ficar aberta para reposição, anota o horário e confere a temperatura depois.

Monitorização e registro da temperatura

Monitorar a temperatura é a única forma de provar que os produtos ficaram nas condições do fabricante. A RDC 44/2009 exige que a temperatura do local dos produtos que precisam de armazenamento abaixo da temperatura ambiente seja "medida e registrada diariamente" (art. 35, §3º), que o POP defina a metodologia de verificação de temperatura e umidade e a faixa de horário de maior probabilidade de temperatura e umidade altas (§4º) e que ele preveja as medidas quando as condições forem inadequadas (§5º).

Frequência de leitura

Ponto	Frequência mínima recomendada	Base
Geladeira de medicamentos	Duas vezes ao dia, na abertura e no fechamento, com momento, máxima e mínima	RDC 44/2009, art. 35, §3º (diário); Manual de Rede de Frio, 2025 (duas vezes ao dia)
Ambiente de estoque e dispensação	Diária, no horário de maior temperatura definido no POP	RDC 44/2009, art. 35, §4º
Caixa térmica em transporte ou entrega	Registro contínuo (datalogger) ou leitura na saída e na chegada	RDC 44/2009, art. 56; RDC 197/2017, art. 12, §2º
Loja fechada (noite, fim de semana, feriado)	Datalogger ou leitura de máxima e mínima na reabertura	Boa prática; Manual de Rede de Frio, 2025

Como ler o termômetro de máxima e mínima

1. Ler a temperatura de **momento**, a **máxima** e a **mínima** registradas desde a última reinicialização.
2. Anotar as três na planilha, com data, hora e rubrica.
3. Reiniciar o termômetro (botão "reset" ou "clear") logo após anotar, para que a próxima leitura mostre só o intervalo seguinte.
4. Avaliar: se a máxima ou a mínima saíram de 2 °C a 8 °C, houve desvio no intervalo, mesmo que a temperatura de momento esteja normal.

Esse último ponto é o mais negligenciado. Uma leitura de abertura com momento de 5 °C e máxima de 13 °C mostra que a geladeira esquentou durante a noite. Se ninguém reinicia o termômetro, a máxima fica "presa" no valor antigo e perde o sentido; se ninguém olha a máxima, a excursão passa despercebida.

Datalogger e alarmes

O registrador eletrônico grava a temperatura em intervalos programados (o Manual de Rede de Frio usa intervalo de 10 minutos para caixas térmicas) e permite reconstruir o início, a duração e o pico de qualquer desvio, informação que o fabricante pede para avaliar o produto. O alarme sonoro ou visual só ajuda se alguém o ouvir: o POP diz quem recebe o aviso fora do horário (por mensagem no celular, quando o equipamento permite) e como testar o alarme periodicamente. O Manual programa os alarmes entre 3 °C e 7 °C.

Calibração

Um termômetro descalibrado registra uma temperatura falsa com toda a aparência de controle. O POP exige certificado de calibração emitido por laboratório competente (o Manual de Rede de Frio indica a Rede Brasileira de Calibração do Inmetro), com o erro do instrumento na faixa de uso, e define a periodicidade. Troca de bateria, queda do aparelho ou leitura incoerente com outro instrumento justificam verificação antes do prazo.

Ambiente de estoque e dispensação

O ambiente também tem limite: a maioria dos produtos é de temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), e alguns têm limite de 25 °C. O termo-higrômetro fica no ponto mais quente identificado no mapeamento, longe de janela, lâmpada e saída de ar-condicionado. Se a loja desliga a climatização à noite, a leitura na abertura mostra a máxima noturna. Quando o limite é ultrapassado com frequência, a solução é estrutural (climatização, mudança de leiaute, isolamento do telhado), e não apenas anotar o desvio. Produtos com limite mais estreito (até 25 °C) podem precisar de local específico, identificado no POP.

Boas práticas de registro

- Preencher no momento da leitura, nunca depois, e com caneta.
- Não usar corretivo. Erro de escrita recebe um traço simples que deixe o valor original legível, com a correção, data e rubrica. A RDC 978/2025 traz regra semelhante para os registros dos exames: alterações com data e identificação do responsável, preservando o dado original (art. 116).
- Toda leitura fora da faixa tem ação registrada na mesma linha ou em formulário anexo.
- Dias sem leitura (loja fechada) são indicados como tais, com os dados do datalogger anexados.
- O farmacêutico revisa a planilha, no mínimo, semanalmente e assina; mensalmente, observa tendências (por exemplo, máximas que sobem aos poucos indicam vedação gasta ou sobrecarga).
- Guardar as planilhas pelo prazo mínimo de 5 anos (RDC 44/2009, art. 89).

O QUE DIZ A NORMA

"Para aqueles produtos que exigem armazenamento em temperatura abaixo da temperatura ambiente, devem ser obedecidas as especificações declaradas na respectiva embalagem, devendo a temperatura do local ser medida e registrada diariamente" (RDC 44/2009, art. 35, §3º).

CASO

Segunda-feira, 8h. A planilha de sexta mostra 5 °C no fechamento. Na abertura, momento 6 °C, máxima 11 °C, mínima 4 °C. O datalogger revela que a temperatura passou de 8 °C às 2h de domingo e voltou à faixa às 9h, após queda de energia no bairro. A farmacêutica registra a excursão (cerca de 7 horas, pico de 11 °C), segrega insulinas e canetas de GLP-1 do lote exposto, mantém tudo em 2 °C a 8 °C com etiqueta "aguardando avaliação" e consulta os fabricantes antes de liberar qualquer unidade.

NO BALCÃO

A leitura de fechamento é feita por quem fecha a loja, e não "pelo farmacêutico do dia seguinte". O POP nomeia o cargo responsável em cada turno e prevê substituto em folgas.

Excursão de temperatura e plano de contingência

O Manual de Rede de Frio do PNI (6ª ed., 2025) define **excursão de temperatura** como qualquer variação fora do intervalo recomendado pelo fabricante, mantida por determinado período, capaz de comprometer a qualidade, a eficácia e a segurança do produto. Duas observações do Manual valem para qualquer

termolábil: as exposições são **cumulativas** (cada excursão consome parte de uma tolerância limitada) e produtos que passaram por excursão, foram avaliados e liberados devem ter prioridade de uso.

Calor e congelamento

A excursão pode ser para cima (acima de 8 °C) ou para baixo (abaixo de 2 °C). O congelamento costuma ser mais grave para insulinas, análogos de GLP-1, anticorpos e vacinas adsorvidas: as bulas consultadas de todas as insulinas e análogos de GLP-1 citadas neste material trazem "não congelar" e mandam descartar o produto que congelou. Entre as falhas mais frequentes na cadeia de frio, o Manual cita exposição a altas temperaturas, congelamento acidental de vacinas adsorvidas, equipamento sem controle efetivo de temperatura, falha de leitura e de registro e armazenamento junto com medicamentos, alimentos ou bebidas.

Causas comuns na farmácia

- queda de energia, disjuntor desarmado ou aparelho desligado da tomada;
- porta mal fechada, vedação gasta, abertura prolongada na reposição;
- termostato mal ajustado, gelo acumulado, aparelho encostado na parede ou exposto ao sol;
- sobrecarga com produtos recém-chegados ainda quentes;
- limpeza da geladeira no fim do expediente, sem tempo para a temperatura se estabilizar (o Manual recomenda limpar no início da semana e não na véspera de feriado nem no fim da jornada).

Plano de contingência

A RDC 430/2020 manda as distribuidoras elaborarem planos de contingência para proteger termolábeis em falha de energia ou de equipamentos (art. 80) e prever fonte alternativa de energia (art. 79). A RDC 197/2017 exige dos serviços de vacinação meios eficazes de conservação "mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica" (art. 11, I). Para a farmácia, o plano de contingência é o desdobramento do art. 35, §5º, da RDC 44/2009 e deve conter:

- riscos identificados (falta de energia, pane, furto, incêndio, atraso de entrega);
- contatos atualizados: farmacêutico RT e substituto, concessionária de energia, assistência técnica, SAC dos fabricantes, vigilância sanitária;
- recurso de reserva: outro equipamento, nobreak ou gerador, ou caixas térmicas com bobinas e termômetro, prontas para uso;
- ponto de decisão para transferir os produtos;
- como registrar e comunicar.

Conduta passo a passo

1. **Não abrir a porta** sem necessidade. Em falta de energia, o equipamento fechado segura a temperatura por mais tempo. Monitorar pelo termômetro ou datalogger.
2. **Avisar o farmacêutico RT**, inclusive fora do horário, e verificar a causa (tomada, disjuntor, porta, concessionária).

3. **Transferir** os produtos para outro equipamento em 2 °C a 8 °C ou para caixa térmica preparada se a energia não voltar ou se a temperatura se aproximar de 7 °C, como orienta o Manual de Rede de Frio para vacinas.
4. **Registrar** início, fim (ou estimativa pelo datalogger), temperatura máxima ou mínima atingida e produtos afetados, com lotes.
5. **Segregar e identificar** os produtos expostos, mantendo-os em 2 °C a 8 °C, com etiqueta "aguardando avaliação, não dispensar". O Manual orienta exatamente isso para as vacinas: segregar, identificar com clareza e manter na temperatura recomendada até a decisão.
6. **Consultar o fabricante** (detentor do registro), informando produto, lote, validade, temperaturas, duração e excursões anteriores do mesmo lote. Para vacinas da rede privada, o Manual manda encaminhar a ocorrência ao laboratório produtor ou ao detentor do registro e manter POP com o fluxo e os contatos dos responsáveis técnicos de cada laboratório.
7. **Documentar a decisão**: liberado (com prioridade de saída) ou reprovado (descarte conforme PGRSS e baixa no estoque).
8. **Corrigir a causa** e revisar o POP, se necessário.

O que perguntar ao fabricante e o que registrar

O serviço de atendimento ou a farmacovigilância do fabricante avalia a excursão com base nos estudos de estabilidade do produto. A resposta depende da qualidade da informação enviada. O registro da excursão contém: identificação do equipamento; data e hora de início e de fim; temperatura máxima ou mínima atingida e o gráfico do datalogger, se houver; produtos afetados com lote, validade e quantidade; se algum produto já tinha passado por excursão anterior; providências tomadas; nome de quem fez o contato, protocolo e data; decisão final e destino de cada lote. Esse registro fica junto da planilha de temperatura e é guardado pelo mesmo prazo. Respostas por telefone devem ser confirmadas por escrito sempre que possível.

ATENÇÃO

Nunca dispensar produto exposto a excursão sem avaliação documentada. Algumas bulas informam tolerâncias para o paciente (por exemplo, canetas de dulaglutida podem ficar até 14 dias sem refrigeração até 30 °C), mas a decisão sobre estoque exposto em condição desconhecida, ou abaixo de 2 °C, é do fabricante. Produto que congelou não é liberado.

PONTO-CHAVE

A sequência é sempre: proteger (fechar, transferir), registrar, segregar, consultar, decidir, corrigir. Vender antes de consultar transfere ao paciente um risco que a farmácia não sabe medir.

NO BALCÃO

Cliente chega para buscar a caneta de semaglutida reservada no dia seguinte a uma excursão. O farmacêutico explica que o lote está em avaliação com o fabricante, oferece outro lote não exposto, se houver, ou combina a retirada após a resposta, sem minimizar o motivo.

Termolábeis comuns na farmácia comercial

As regras abaixo foram conferidas nas bulas brasileiras das apresentações citadas (texto das bulas reproduzido em compêndio de bulas, consultado em outubro de 2026) e, quando indicado, na informação europeia do produto. Cada marca, concentração e dispositivo (frasco, refil, caneta) pode ter regra própria: o que vale é a bula da apresentação dispensada.

Insulinas

Fechadas, todas ficam em refrigerador, de 2 °C a 8 °C, longe do congelador, sem congelar. Em uso, o prazo e a temperatura variam:

Insulina (apresentação)	Em uso	Geladeira em uso?
NPH humana, frasco (Novolin N)	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
NPH humana, refil (Humulin N)	28 dias, abaixo de 30 °C	Não
Regular humana (Novolin R)	6 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
Glargina 100 U/mL (Lantus)	28 dias; sem refrigeração, abaixo de 30 °C	Opcional para frasco de 10 mL e refil, conforme bula
Glargina 300 U/mL (Toujeo)	6 semanas (42 dias), até 30 °C	Não; nunca voltar à geladeira
Degludeca (Tresiba FlexTouch)	8 semanas, abaixo de 30 °C	Pode (2 °C a 8 °C)
Asparte (NovoRapid, frasco)	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
Lispro (Humalog KwikPen)	28 dias, até 30 °C	Não

A mesma substância pode ter regras diferentes em marcas diferentes. A insulina NPH de um fabricante vale 4 semanas após aberta; a de outro, 28 dias, e o refil em caneta não vai à geladeira. Por isso a orientação ao paciente se faz com a bula do produto na mão.

Agonistas de GLP-1 e tirzepatida

Antes do primeiro uso, refrigerador de 2 °C a 8 °C, longe do congelador, sem congelar. Depois: semaglutida (Ozempic e Wegovy), 6 semanas abaixo de 30 °C ou em geladeira; liraglutida, 1 mês (Victoza) ou 4 semanas (Saxenda), de 15 °C a 30 °C ou em geladeira; dulaglutida (Trulicity), fotossensível, pode

ficar até 14 dias sem refrigeração até 30 °C; tirzepatida (Mounjaro, apresentação consultada), até 21 dias fora de refrigeração abaixo de 30 °C. Desde a RDC 973/2025, esses medicamentos seguem a RDC 471/2021: receita em duas vias, retenção, validade de 90 dias e escrituração no SNGPC (lista na IN 360/2025).

Biológicos de uso domiciliar e hormônios

- **Adalimumabe (Humira)**: 2 °C a 8 °C, na embalagem original, sem congelar. A bula brasileira consultada não traz período fora da geladeira; a informação europeia admite até 14 dias a até 25 °C. Diante de dúvida, consultar o fabricante.
- **Dupilumabe (Dupixent)**: 2 °C a 8 °C, protegido da luz; se necessário, até 14 dias a até 30 °C, anotando a data de retirada.
- **Denosumabe (Prolia)**: 2 °C a 8 °C; pela bula brasileira, depois que a seringa sai da geladeira e atinge a temperatura ambiente, deve ser aplicada ou descartada. A informação europeia admite 30 dias a até 25 °C, o que mostra por que a bula nacional é a referência.
- **Etanercepte, pó liófilo (Enbrel)**: 2 °C a 8 °C; reconstituído, até 6 horas em geladeira.
- **Teriparatida (Fortéo)**: sempre em refrigerador, descartar 28 dias após a primeira aplicação; se a caneta ficar fora da geladeira, a bula orienta devolvê-la ao refrigerador e contatar o fabricante.
- **Somatropina (Genotropin)**: 2 °C a 8 °C, protegida da luz; preparada, até 28 dias sob refrigeração.

Colírios

Latanoprosta (Xalatan): até a abertura, refrigerador de 2 °C a 8 °C, protegido da luz; após aberto, temperatura ambiente até 25 °C, válido por 10 semanas, segundo a bula brasileira. A informação de outros países fala em 4 semanas. Genéricos e similares podem ter outras condições, inclusive temperatura ambiente desde o início: confira cada um.

Antibióticos em suspensão

O pó para suspensão fica em temperatura ambiente; após a reconstituição, a regra muda: amoxicilina (Amoxil), 14 dias em geladeira; amoxicilina com clavulanato (Clavulin BD), 7 dias em geladeira, e a bula informa que, fora da geladeira, a suspensão escurece em 48 horas; cefalexina (Keflex), 14 dias em geladeira. Outras marcas e outros antibióticos têm prazos próprios.

Vacinas, probióticos e supositórios

- **Vacinas**: de 2 °C a 8 °C, em equipamento próprio, sem congelar, conforme bula e Manual de Rede de Frio.
- **Probióticos**: a maioria fica em temperatura ambiente, mas alguns produtos exigem refrigeração; confira o rótulo de cada um e armazene conforme indicado.
- **Supositórios e óvulos**: geralmente em temperatura ambiente com limite máximo; o calor amolece e deforma a base, o que prejudica a aplicação. Seguir a bula.

Ocitocina injetável é usada em ambiente hospitalar e não faz parte do estoque usual da farmácia comercial; se for necessária, segue a bula do produto.

ATENÇÃO

"Não use se tiver sido congelado" aparece nas bulas de todas as insulinas e análogos de GLP-1 consultados. Insulina congelada não volta a ser boa depois de descongelar, mesmo com aspecto normal.

NO BALCÃO

Cliente leva a primeira caneta de semaglutida. O farmacêutico orienta: transportar em bolsa térmica, guardar na geladeira até o primeiro uso, longe do congelador; depois de começar, a caneta pode ficar abaixo de 30 °C ou na geladeira por até 6 semanas; anotar a data do primeiro uso na embalagem; manter a tampa para proteger da luz; nunca usar se congelou; descartar a agulha em recipiente rígido. Lembra que a receita fica retida.

Recebimento, transporte e orientação ao paciente

A cadeia de frio só é tão forte quanto o elo mais fraco. Um produto bem guardado na distribuidora e na farmácia pode se perder em 20 minutos esquecido no balcão ou em uma tarde no porta-luvas do carro do cliente.

Recebimento de termolábeis

A farmácia só pode receber produtos transportados conforme as especificações do fabricante (RDC 44/2009, art. 33) e deve verificar o bom estado de conservação no recebimento (art. 34). A RDC 430/2020, que obriga distribuidoras e transportadoras, ajuda a entender o que a farmácia pode cobrar delas: o recebimento verifica e registra as condições de transporte, incluindo temperatura (art. 56, I); cargas que não cumprem os requisitos são devolvidas no ato ou ficam em quarentena até decisão (art. 57); a exposição dos termolábeis à temperatura ambiente durante recebimento e expedição deve ser mínima, e o tempo total, registrado (art. 77); e a montagem da carga deve evitar contato direto dos medicamentos com os agentes refrigerantes (art. 85, parágrafo único).

- abrir primeiro os volumes refrigerados, assim que chegam;
- observar a integridade da caixa térmica, o estado das bobinas e o indicador ou registrador de temperatura, quando houver;
- medir a temperatura entre os produtos ao abrir, com termômetro de cabo extensor;
- procurar sinais de congelamento (cristais, frasco trincado, suspensão com grumos) e de aquecimento;
- conferir nota fiscal, lote e validade e guardar imediatamente;
- registrar hora de chegada, temperatura e tempo até a guarda;
- havendo divergência, manter o produto em 2 °C a 8 °C, separado e identificado como quarentena, e acionar o distribuidor antes de qualquer venda.

A RDC 430/2020 permite que a transportadora deixe de monitorar temperatura e umidade quando o transporte dura menos de 8 horas, termina no ponto de dispensação e usa embalagem térmica qualificada para o tempo e as condições do trajeto (art. 64, §2º). Por isso, nem toda entrega vem com registrador. Nesses casos, a farmácia pode pedir ao distribuidor a comprovação da qualificação da embalagem.

Entrega em domicílio

Na dispensação remota, o transporte é responsabilidade da farmácia e deve respeitar a temperatura e a umidade da embalagem; termossensíveis seguem em embalagens especiais que mantenham a temperatura, sem misturar com produtos que possam afetá-los, e o POP de transporte faz parte da rotina (RDC 44/2009, art. 56, §§ 1º a 3º). Na prática: caixa térmica com bobinas de gelo reciclável ambientadas, separadas dos produtos por material isolante, tempo máximo de trajeto definido no POP, entrega em mãos com orientação e cartão com o contato do farmacêutico (art. 58, §2º).

Montagem da caixa térmica

O Manual de Rede de Frio (2025) descreve o preparo da caixa térmica para vacinas, e o método serve de modelo para qualquer termolábil:

- retirar as bobinas reutilizáveis do congelador e deixá-las sobre a superfície até desaparecer a névoa, conferindo com termômetro de cabo extensor que chegaram a 0 °C (ambientação); bobina recém-saída do congelador, muito abaixo de 0 °C, pode congelar o produto;
- secar as bobinas e posicioná-las no fundo, nas laterais e entre os produtos e a tampa, conforme a validação da caixa;
- usar barreira entre produtos e bobinas (plástico bolha, papelão);
- colocar o sensor no centro da caixa e só acondicionar os produtos quando a temperatura interna estiver adequada (o Manual cita o mínimo de 1 °C para vacinas);
- trocar as bobinas quando a temperatura máxima chegar a 7 °C e manter a caixa longe do sol e de fontes de calor.

Orientação para levar para casa

- levar em bolsa térmica, com gelo reciclável envolvido em papel ou pano, sem contato direto com a caneta ou o frasco;
- ir direto para casa; não deixar o produto no carro, no sol ou no porta-malas;
- guardar na geladeira, na prateleira do meio, longe do congelador, fora da porta e da gaveta de verduras, na embalagem original;
- anotar na embalagem a data de abertura ou do primeiro uso;
- seguir a bula para o produto em uso: algumas canetas devem ficar fora da geladeira depois de abertas;
- descartar o produto que congelou ou que ficou exposto a calor excessivo;
- guardar agulhas e lancetas usadas em frasco rígido com tampa.

Viagens

- levar os termolábeis na **bagagem de mão**, nunca despachados: no porão a temperatura não é controlada pelo passageiro e a mala pode extraviar;
- carregar a receita ou relatório médico e confirmar com a companhia aérea as regras para líquidos e agulhas;

- usar bolsa térmica; em viagem curta, a caneta em uso costuma tolerar a temperatura ambiente pelo prazo da bula, mas as de reserva ficam refrigeradas;
- levar quantidade extra para atrasos;
- no destino, guardar na geladeira do hotel, longe do congelador, e conferir se ela não congela os produtos;
- em lugares muito quentes, evitar deixar a bolsa ao sol.

CASO

Entregador da farmácia chega ao cliente com atraso de 3 horas por pane da moto. A caixa térmica tem datalogger, que mostra 12 °C na última hora. O farmacêutico não entrega o produto: recolhe a caixa, segrega a caneta como "aguardando avaliação", consulta o fabricante e envia outra unidade em condição correta. A ocorrência entra no registro de não conformidades e leva à revisão do tempo máximo de trajeto no POP.

NO BALCÃO

Ao entregar insulina, o farmacêutico pergunta: "quanto tempo até sua casa?" e "vai a algum outro lugar antes?". Se o trajeto for longo, oferece bolsa térmica ou orienta adquirir uma, e explica a diferença entre a caneta fechada (geladeira) e a caneta em uso (conforme a bula da marca).

Boas práticas gerais de armazenamento

Além da temperatura, o armazenamento cuida de ordem, separação e segurança. A RDC 44/2009 exige que todos os produtos sejam armazenados de forma ordenada, conforme as especificações do fabricante e em condições que garantam identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade (art. 35).

Organização e endereçamento

O critério de organização é escolhido pela farmácia e descrito no Manual: ordem alfabética pelo nome comercial ou pela denominação comum brasileira, separação por forma farmacêutica (sólidos, líquidos, injetáveis, tópicos) ou por classe terapêutica. O que importa é que cada item tenha lugar fixo e identificado. A RDC 430/2020 chama isso de endereçamento lógico, que evita trocas e dá localização inequívoca (art. 53), e pede inventários periódicos com investigação de discrepâncias (art. 55). Na farmácia, inventário rotativo por seção e conferência de controlados com a escrituração fazem esse papel.

PVPS e FEFO

PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai), em inglês FEFO (*first expired, first out*), manda dispensar antes o lote com validade mais curta, colocando-o à frente. É diferente de PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai, ou FIFO), que olha a data de chegada; como lotes novos podem vencer antes de lotes antigos, o PVPS é o critério adequado para medicamentos. O Manual de Rede de Frio também adota o PVPS para imunobiológicos.

Validade próxima

A política para produtos próximos do vencimento é escrita no Manual e conhecida por todos (RDC 44/2009, art. 38, §4º) e também detalhada em POP (art. 51). O usuário é alertado quando recebe produto com validade próxima (art. 51, §1º), e é vedado dispensar medicamento cuja posologia não possa ser concluída dentro da validade (art. 51, §2º). Exemplo: caixa de 30 comprimidos de uso diário com validade até o fim do mês corrente, faltando 10 dias, não serve para um tratamento de 30 dias.

Segregação

Situação	O que fazer	Base
Vencido, violado, avariado	Retirar do estoque utilizável, guardar em área segura fora da dispensação, identificado quanto à condição e ao destino	RDC 44/2009, art. 38
Suspeito de falsificação, adulteração ou alteração	Segregar com identificação de que não se destina à venda; farmacêutico notifica a autoridade sanitária imediatamente	Art. 34, §§ 1º e 2º
Recolhido por ato da vigilância ou do fabricante	Bloquear, segregar como "recolhido" e seguir as instruções do recolhimento	Art. 38, §3º
Quarentena (aguardando decisão)	Separar e identificar, nas condições de conservação do produto, até a liberação ou reprovação	Boa prática; RDC 430/2020, arts. 42, VI, e 57
Devolvido por cliente	Não reintegrar termolábil nem produto de integridade incerta; nunca armazenar medicamento com embalagem primária violada	RDC 44/2009, art. 76, §2º; RDC 430/2020, arts. 34 e 35 como referência

Controlados, inflamáveis e exposição

Medicamentos sujeitos a controle especial ficam em sistema segregado (armário resistente ou sala própria) com chave, sob guarda do farmacêutico (RDC 44/2009, art. 37). Corrosivos, inflamáveis e explosivos têm armazenamento justificado em POP, longe de fontes de calor e de materiais que provoquem faíscas (art. 39). Medicamentos permanecem em área restrita aos funcionários, salvo os isentos de prescrição autorizados ao alcance do usuário (art. 40). Na área de dispensação, produtos sensíveis ao calor não ficam em vitrines ensolaradas nem perto de lâmpadas ou equipamentos que aquecem.

Medicamentos potencialmente perigosos e nomes parecidos

Medicamentos potencialmente perigosos (ou de alta vigilância) são os que causam dano grave quando há erro. O ISMP Brasil mantém lista de uso ambulatorial em que aparecem, por exemplo, insulinas, anticoagulantes orais, metotrexato de uso oral e opioides. No armazenamento, eles ficam em local sinalizado, separados de apresentações parecidas, com dupla checagem na separação. Para nomes e embalagens semelhantes, as medidas são: separar fisicamente os pares de risco, destacar com letras maiúsculas a parte diferente do nome nas etiquetas das prateleiras e configurar alertas no sistema.

Exemplos clássicos de confusão no balcão incluem concentrações diferentes do mesmo fármaco (insulina 100 U/mL e 300 U/mL) e embalagens de mesma cor do mesmo fabricante.

Limpeza e pragas

O ambiente de armazenamento é mantido limpo e protegido contra insetos, roedores e outros animais (RDC 44/2009, art. 6º, §2º). O programa de desratização e desinsetização é executado por empresa licenciada, com registros guardados no estabelecimento (art. 7º). Caixas de papelão vazias acumuladas, comida no estoque e frestas sem vedação atraem pragas e geram não conformidade.

CASO

Na conferência mensal, o auxiliar encontra duas caixas de anticoagulante oral de concentrações diferentes lado a lado, com embalagens quase idênticas. O farmacêutico separa as apresentações em prateleiras diferentes, coloca etiqueta de alta vigilância, destaca a concentração nas etiquetas e inclui o par na lista de dupla checagem do POP de dispensação.

NO BALCÃO

Cliente devolve uma caixa de insulina comprada ontem, ainda lacrada, dizendo que o médico mudou a prescrição. O farmacêutico explica que não pode reintegrar ao estoque um termolábil cuja conservação fora da farmácia não é conhecida e registra a ocorrência conforme a política da loja.

Fontes consultadas

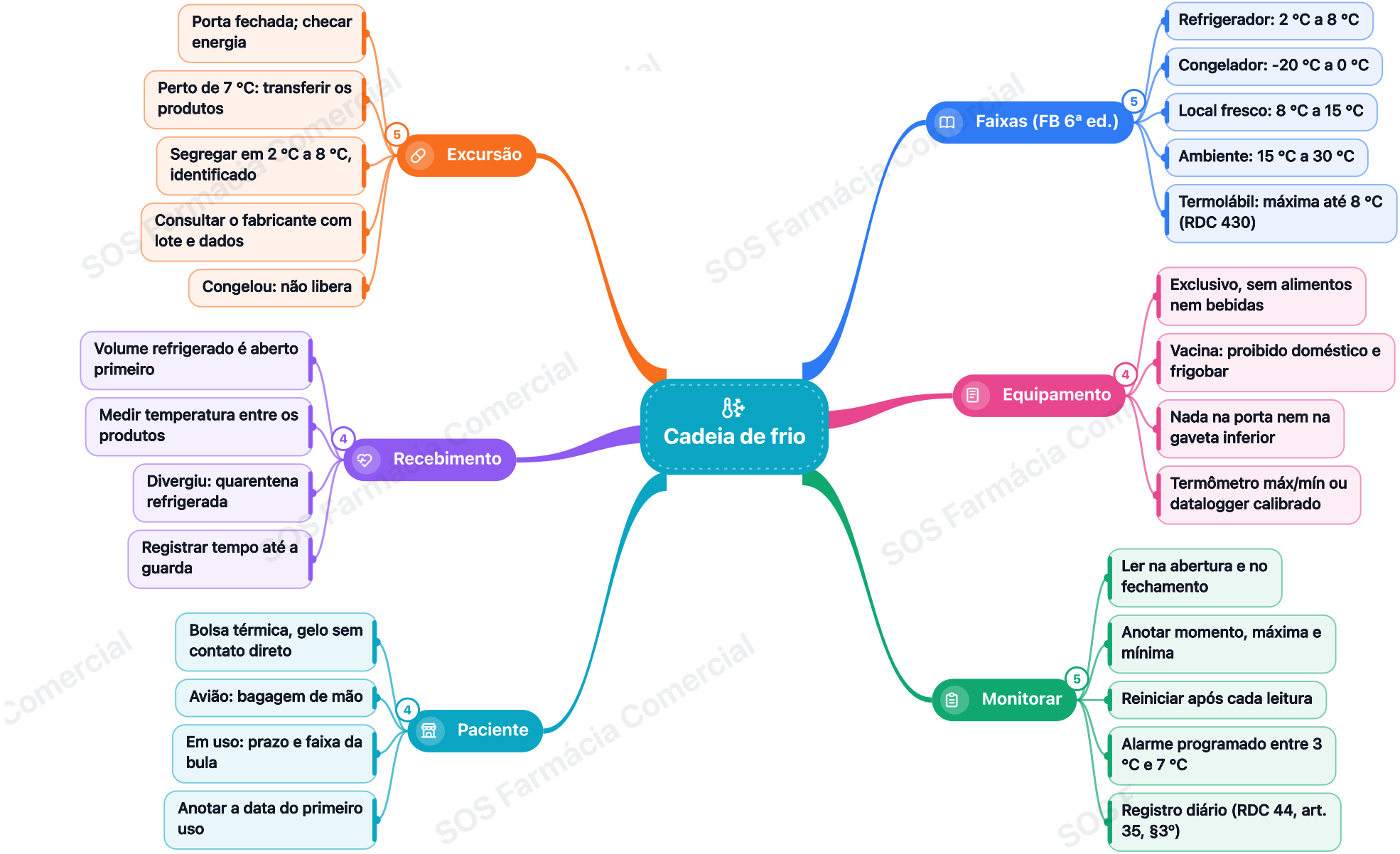
1. Anvisa. Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, Volume I. Generalidades: conservação e faixas de temperatura. Brasília, 2019 (com erratas).
2. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias (arts. 5º, 6º, 7º, 31 a 40, 51, 56, 58, 76 e 89). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
3. Anvisa. Resolução RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos (arts. 3º, 34 a 36, 42, 43, 49 a 57, 64, 77 a 85). Diário Oficial da União, 9 out. 2020.
4. Anvisa. Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017. Serviços de vacinação humana (arts. 10 a 12).
5. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Serviços que executam exames de análises clínicas (arts. 14 e 116). Diário Oficial da União, 10 jun. 2025.
6. Anvisa. Resolução RDC nº 471/2021, alterada pela RDC nº 973/2025; Instrução Normativa nº 360/2025 (agonistas de GLP-1).
7. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, art. 6º, III.
8. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 6ª ed. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, 2025.
9. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 5ª ed. Brasília, 2017 (comparação sobre refrigeradores domésticos).
10. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Orientação Farmacêutica: armazenamento inadequado de termolábeis em farmácias privadas e públicas. 2023.

11. Organização Mundial da Saúde. Model guidance for the storage and transport of time- and temperature-sensitive pharmaceutical products. WHO Technical Report Series nº 961, Annex 9, 2011.
12. Bulas brasileiras (texto reproduzido em compêndio de bulas, consultado em out. 2026): Novolin N, Novolin R, NovoRapid, Fiasp, Tresiba, Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda (Novo Nordisk); Lantus, Toujeo, Apidra (Sanofi); Humulin N, Humalog, Basaglar, Trulicity, Mounjaro, Fortéo (Eli Lilly); Humira (AbbVie); Dupixent (Sanofi); Prolia (Amgen); Enbrel e Genotropin (Pfizer); Xalatan (Pfizer/Viatris); Amoxil e Clavulin BD (GSK); Keflex.
13. European Medicines Agency. Product information (seções 6.3 e 6.4) de Humira, Prolia, Lantus, Toujeo, Tresiba, NovoRapid, Humalog, Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda, Trulicity, Mounjaro, Dupixent, Enbrel, Forsteo e Omnitrope. https://www.ema.europa.eu, consultado em out. 2026.

SOS Farmácia Comercial

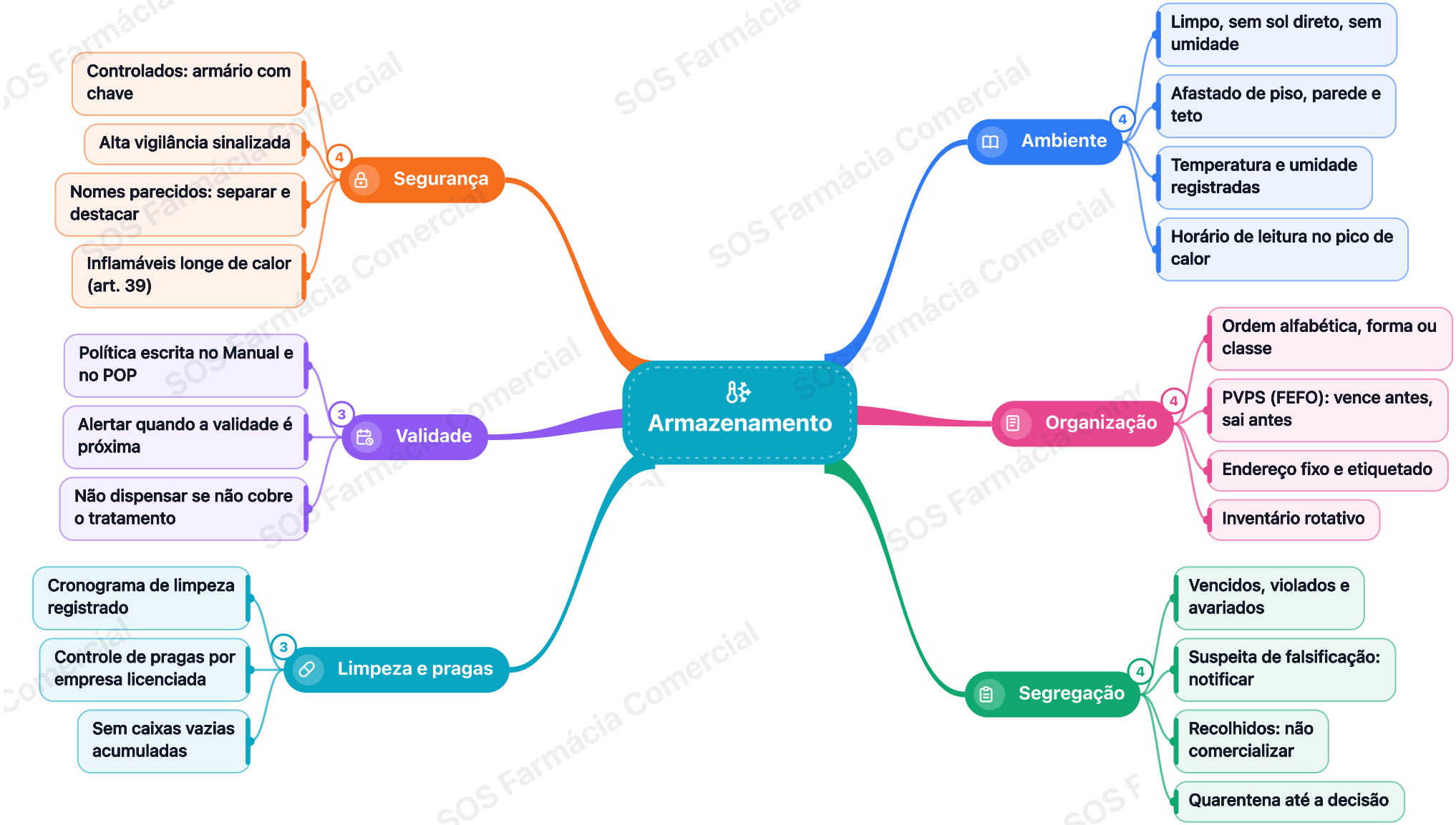
Cadeia de frio

6 ramos · 27 itens · mapa mental do módulo 4



Boas práticas de armazenamento

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 4



Termolábeis e conservação conforme bula

Medicamento (apresentação)	Fechado	Após aberto ou em uso	Observação
Insulina NPH humana, frasco (Novolin N)	2 °C a 8 °C, longe do congelador	Até 4 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira; proteger da luz
Insulina NPH humana, refil (Humulin N)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Não refrigerar em uso; não usar se congelou
Insulina regular humana (Novolin R)	2 °C a 8 °C	Até 6 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira
Insulina glargina 100 U/mL (Lantus)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	28 dias; sem refrigeração, abaixo de 30 °C	Descartar se congelou; evitar contato com congelador
Insulina glargina 300 U/mL (Toujeo)	2 °C a 8 °C	6 semanas (42 dias), até 30 °C	Caneta em uso nunca volta à geladeira
Insulina glargina (Basaglar)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Não refrigerar em uso
Insulina degludeca (Tresiba FlexTouch)	2 °C a 8 °C	8 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Penfill em uso: não refrigerar
Insulina asparte (NovoRapid, frasco)	2 °C a 8 °C	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira
Insulina asparte (Fiasp)	2 °C a 8 °C	4 semanas, até 30 °C	Frasco e caneta podem ir à geladeira; carpule não
Insulina lispro (Humalog KwikPen)	2 °C a 8 °C	28 dias, até 30 °C	Caneta em uso fora da geladeira
Insulina glulisina (Apidra)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Caneta com refil não vai à geladeira
Semaglutida (Ozempic)	2 °C a 8 °C, longe do congelador	6 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Receita retida (RDC 973/2025)
Semaglutida (Wegovy)	2 °C a 8 °C	6 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Proteger do calor e da luz; receita retida
Liraglutida (Victoza)	2 °C a 8 °C	1 mês, 15 °C a 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Tampa colocada para proteger da luz
Liraglutida (Saxenda)	2 °C a 8 °C	4 semanas, 15 °C a 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Não congelar

Medicamento (apresentação)	Fechado	Após aberto ou em uso	Observação
Dulaglutida (Trulicity)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Até 14 dias sem refrigeração, até 30 °C	Fotossensível
Tirzepatida (Mounjaro, apresentação consultada)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Até 21 dias fora da geladeira, abaixo de 30 °C	Não congelar; receita retida
Adalimumabe (Humira)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Dose única; bula brasileira sem período fora da geladeira	Informação europeia: 14 dias até 25 °C; consultar fabricante
Dupilumabe (Dupixent)	2 °C a 8 °C, protegido da luz	Se necessário, até 14 dias até 30 °C	Anotar a data de retirada da geladeira
Denosumabe (Prolia)	2 °C a 8 °C, protegido da luz	Após atingir temperatura ambiente: aplicar ou descartar	Bula brasileira mais restritiva que a europeia
Etanercepte, pó liófilo (Enbrel)	2 °C a 8 °C	Reconstituído: até 6 horas em geladeira	Não congelar
Teriparatida (Fortéo)	2 °C a 8 °C	28 dias após a primeira aplicação, sempre refrigerada	Se ficou fora, voltar à geladeira e contatar o SAC
Somatropina (Genotropin)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	Preparada: até 28 dias em refrigeração	Não congelar
Latanoprosta colírio (Xalatan)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	Até 25 °C, válido por 10 semanas	Genéricos e similares: conferir bula de cada um
Amoxicilina pó para suspensão (Amoxil)	15 °C a 30 °C, protegido da umidade	14 dias em geladeira	Prazo começa na reconstituição
Amoxicilina + clavulanato suspensão (Clavulin BD)	15 °C a 30 °C, local seco	7 dias em geladeira	Fora da geladeira escurece em 48 horas
Cefalexina pó para suspensão (Keflex)	15 °C a 30 °C, ao abrigo da luz	14 dias em geladeira	Descartar a sobra após o prazo
Vacinas	2 °C a 8 °C, equipamento próprio	Conforme bula e Manual de Rede de Frio	Não congelar; geladeira doméstica proibida
Probióticos	Conforme rótulo; alguns exigem refrigeração	Conforme rótulo	Conferir produto a produto

Dados das bulas brasileiras das apresentações citadas, consultadas em outubro de 2026 em compêndio que reproduz o texto das bulas; adalimumabe e denosumabe também comparados com a informação europeia (EMA). Outras marcas, concentrações e dispositivos podem ter regras diferentes: oriente sempre pela bula da apresentação dispensada.

Modelo de planilha de temperatura do refrigerador

Equipamento: _____ **Local:** _____ **Mês/ano:** ____ **Faixa aceitável:** 2 °C a 8 °C
Termômetro nº: _____ **Calibração válida até:** __/__/____

Data e hora	Atual (°C)	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Responsável	Ação (se fora da faixa)
__/__ ____h (abertura)					
__/__ ____h (fechamento)					
__/__ ____h (abertura)					
__/__ ____h (fechamento)					
__/__ ____h (abertura)					
__/__ ____h (fechamento)					

Como preencher: anotar no momento da leitura; reiniciar o termômetro após anotar; qualquer valor abaixo de 2 °C ou acima de 8 °C (atual, máxima ou mínima) exige ação descrita na última coluna e comunicação ao farmacêutico; dias com a loja fechada são indicados e os dados do datalogger anexados.

Revisão do farmacêutico: semana 1 ____ semana 2 ____ semana 3 ____ semana 4 ____ (data e assinatura)

Excursão de temperatura no refrigerador

Leitura ou alarme mostra temperatura fora de 2 °C a 8 °C (atual, máxima ou mínima)

Manter a porta fechada; verificar tomada, disjuntor, energia e vedação; avisar o farmacêutico

DECISÃO

A causa foi corrigida e a temperatura está voltando à faixa?

SIM
Acompanhar até estabilizar e seguir para o registro

NÃO
Transferir os produtos para outro equipamento ou caixa térmica em 2 °C a 8 °C

Registrar início, fim, temperatura máxima ou mínima atingida e produtos e lotes afetados

Segregar os produtos expostos em 2 °C a 8 °C, com etiqueta "aguardando avaliação, não dispensar"

DECISÃO

Houve temperatura abaixo de 0 °C ou sinais de congelamento?

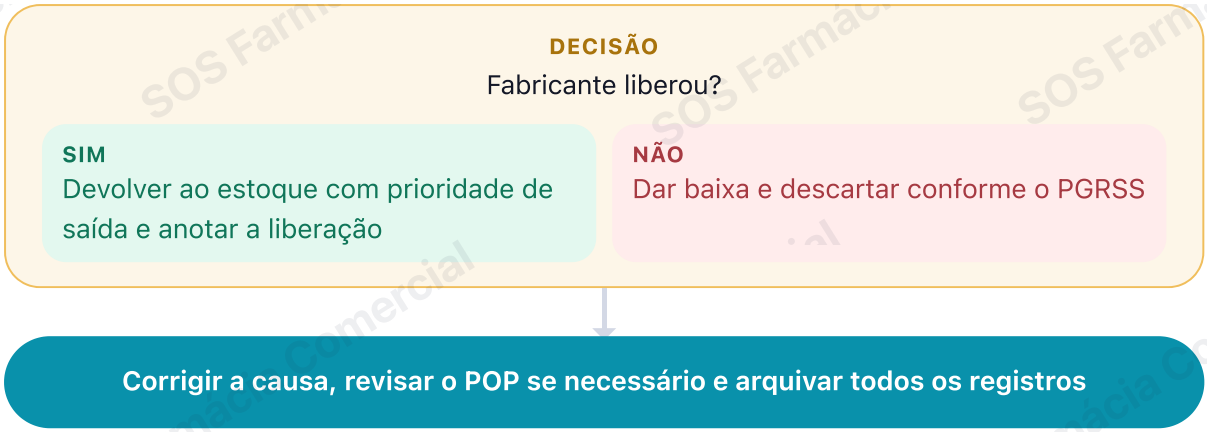
SIM
Reprovar: produtos congelados não são liberados

NÃO
Consultar o fabricante

Consultar o fabricante com produto, lote, validade, temperaturas, duração e excursões anteriores

ATENÇÃO

Nunca dispensar antes da resposta documentada



Verificação diária e semanal do armazenamento

- ◯ Diário: temperatura da geladeira registrada na abertura (momento, máxima, mínima) e termômetro reiniciado
- ◯ Diário: temperatura da geladeira registrada no fechamento
- ◯ Diário: temperatura e umidade do ambiente registradas no horário de maior calor
- ◯ Diário: porta da geladeira bem fechada ao fim do expediente e alarme ativo
- ◯ Diário: nenhum termolábil esquecido no balcão, no recebimento ou na sala de serviços
- ◯ Diário: volumes refrigerados recebidos guardados com temperatura de chegada anotada
- ◯ Diário: sala de serviços e área de dispensação limpas e registradas
- ◯ Diário: leituras fora da faixa com ação registrada e farmacêutico ciente
- ◯ Semanal: farmacêutico revisou e assinou as planilhas de temperatura
- ◯ Semanal: geladeira sem alimentos, bebidas, isopor ou objetos pessoais
- ◯ Semanal: porta e gaveta inferior da geladeira sem medicamentos
- ◯ Semanal: produtos com espaço para circulação de ar e sensor no centro
- ◯ Semanal: mapa da geladeira atualizado
- ◯ Semanal: PVPS conferido nas prateleiras e na geladeira
- ◯ Semanal: área segregada identificada e sem produto sem destino definido

- [ ] Semanal: controlados conferidos e armário trancado
- [ ] Semanal: estoque afastado de piso, parede e teto; nada sob sol direto
- [ ] Semanal: produtos em quarentena ou aguardando avaliação com prazo de resposta acompanhado
- [ ] Mensal: relatório de validade emitido e conferido
- [ ] Mensal: certificado de calibração dos termômetros dentro do prazo
- [ ] Mensal: teste do alarme e da bateria do termômetro
- [ ] Mensal: contatos do plano de contingência atualizados

SOS Farmácia Comercial

Controle de temperatura do refrigerador de medicamentos

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Controle de temperatura do refrigerador de medicamentos**	Código: **POP-TEMP-02** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Manter os termolábeis entre 2 °C e 8 °C, com monitoramento registrado e resposta imediata a desvios.

Abrangência

Refrigerador de medicamentos da farmácia; todos os dias de funcionamento.

Responsáveis

- Responsável pela abertura e pelo fechamento da loja: leituras
- Farmacêutico do turno: análise e ações corretivas
- Farmacêutico RT: calibração, revisão semanal e plano de contingência

Materiais

- Termômetro de momento, máxima e mínima calibrado, com cabo extensor
- Registrador eletrônico (datalogger) com alarme, quando disponível
- Planilha de temperatura
- Etiquetas "aguardando avaliação"
- Caixa térmica com bobinas e termômetro para contingência

Procedimento

1. Conferir se a geladeira é exclusiva para medicamentos e se não há alimentos, bebidas ou objetos pessoais.
2. Manter o sensor do termômetro no centro do compartimento, entre os produtos, sem contato com paredes ou bobinas.
3. Na abertura da loja, ler e anotar temperatura de momento, máxima e mínima, com hora e rubrica.
4. Reiniciar o termômetro logo após a anotação.
5. Se o datalogger estiver em uso, verificar se houve alarme ou registro fora da faixa desde a última leitura.
6. Comparar as três leituras com a faixa de 2 °C a 8 °C.
7. Se tudo estiver na faixa, conferir a vedação da porta e seguir a rotina.
8. Se qualquer leitura estiver fora da faixa, comunicar o farmacêutico imediatamente e aplicar o fluxo de excursão.
9. Abrir a porta apenas o necessário, com o mapa da geladeira afixado para localizar os produtos.

10. Organizar os produtos fora da porta e da gaveta inferior, com espaço entre as caixas e validade mais curta à frente.
11. No fechamento, repetir a leitura, anotar, reiniciar e confirmar que a porta está fechada e o alarme ativo.
12. Limpar a geladeira no início da semana, com os produtos transferidos para equipamento ou caixa térmica monitorados, nunca na véspera de feriado ou no fim do expediente.
13. O farmacêutico revisa e assina a planilha semanalmente e arquiva.

Cuidados

- Leitura com máxima acima de 8 °C indica excursão no intervalo, mesmo com momento normal.
- Produto que congelou não é liberado.
- Não desligar a geladeira da tomada para limpeza sem plano de transferência.

Registros

- Planilha diária de temperatura
- Relatórios do datalogger
- Registro de excursões e decisões
- Certificados de calibração

Referências

- RDC 44/2009, art. 35, §§ 3º a 5º
- Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025
- RDC 197/2017, arts. 10 e 11 (vacinas)
- Orientação Farmacêutica CRF-SP: armazenamento inadequado de termolábeis

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Recebimento de medicamentos termolábeis

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Recebimento de medicamentos termolábeis**	Código: **POP-REC-02** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Receber termolábeis somente quando transportados na faixa do fabricante e guardá-los sem demora.

Abrangência

Recebimento de mercadorias; entregas de distribuidores com volume refrigerado.

Responsáveis

- Responsável pelo recebimento: abertura, medição e guarda
- Farmacêutico: decisão sobre divergências e contato com o distribuidor

Materiais

- Termômetro com cabo extensor calibrado
- Formulário de recebimento de termolábeis
- Etiqueta de quarentena
- Nota fiscal

Procedimento

1. Separar os volumes refrigerados da carga e abri-los antes dos demais (RDC 430/2020, art. 77, como referência).
2. Verificar a integridade da caixa térmica e a presença de indicador ou registrador de temperatura.
3. Ler o indicador ou registrador e anotar o resultado.
4. Medir a temperatura entre os produtos com o termômetro de cabo extensor e anotar.
5. Verificar se os produtos estavam em contato direto com as bobinas de gelo.
6. Inspecionar sinais de congelamento (cristais, frasco trincado, grumos) e de dano à embalagem.
7. Conferir nome, apresentação, quantidade, lote, validade e fabricante contra a nota fiscal (RDC 44/2009, art. 31, §2º).
8. Se tudo estiver conforme, guardar imediatamente no refrigerador, com validade mais curta à frente.
9. Registrar hora de chegada, hora da guarda e temperatura medida.
10. Se a temperatura estiver fora de 2 °C a 8 °C, houver sinal de congelamento ou faltar evidência de transporte adequado, manter o produto refrigerado, separado e identificado como quarentena.

11. Comunicar o distribuidor no mesmo dia e solicitar avaliação; não dispensar até a resposta documentada.
12. Devolver ou dar baixa conforme a decisão e arquivar os registros.

Cuidados

- Só receber produto transportado conforme o fabricante (RDC 44/2009, art. 33).
- Volume refrigerado não espera a conferência da carga seca.
- Produto congelado é recusado.

Registros

- Formulário de recebimento de termolábeis
- Registro de não conformidade e resposta do distribuidor
- Nota fiscal conferida

Referências

- RDC 44/2009, arts. 31 a 34
- RDC 430/2020, arts. 56, 57, 64, §2º, 77 e 85
- Bulas dos produtos recebidos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Falhas frequentes na cadeia de frio e correção

Falha	Risco	Correção
Termômetro nunca reiniciado	Máxima antiga mascara novas excursões	Reiniciar após cada leitura; treinar a equipe
Só a temperatura de momento é anotada	Excursão noturna passa despercebida	Registrar momento, máxima e mínima
Medicamentos na porta da geladeira	Aquecimento a cada abertura	Porta vazia; produtos nas prateleiras centrais
Caixa encostada no fundo ou no congelador	Congelamento	Afastar do evaporador; sensor no centro
Alimentos ou bebidas na geladeira	Aberturas extras, contaminação, autuação	Uso exclusivo
Produtos dentro de isopor na geladeira	Barreira térmica	Retirar recipientes; permitir circulação de ar
Limpeza no fim do expediente	Temperatura instável durante a noite	Limpar no início da semana, com produtos monitorados

Falha	Risco	Correção
Termolábil esquecido no balcão	Perda de estabilidade	Guardar logo; separar só no momento da entrega
Venda de lote exposto sem consulta	Produto ineficaz ao paciente	Segregar e consultar o fabricante
Termômetro sem calibração	Registro falso de controle	Certificado válido e calibração periódica

Cartões de revisão: termolábeis e armazenamento

Pergunta	Resposta
Faixa "em refrigerador" na Farmacopeia Brasileira	Entre 2 °C e 8 °C.
Faixa de "temperatura ambiente" na Farmacopeia Brasileira	Entre 15 °C e 30 °C.
Faixa de "local fresco"	Entre 8 °C e 15 °C; pode ser substituído por refrigerador se a monografia não proibir.
Definição de medicamento termolábil (RDC 430/2020)	Aquele cuja especificação de temperatura máxima é igual ou inferior a 8 °C.
Frequência de registro exigida pela RDC 44/2009 para termolábeis	Diária (art. 35, §3º); o Manual de Rede de Frio recomenda duas vezes ao dia.
Por que reiniciar o termômetro de máxima e mínima?	Para que a próxima leitura mostre os extremos apenas do intervalo seguinte.
Vacina pode ficar em geladeira doméstica?	Não. Exige equipamento regularizado na Anvisa (RDC 197/2017, art. 10, §2º); doméstico e frigobar são proibidos.
Faixa de alarme usada pelo Manual de Rede de Frio	Entre 3 °C e 7 °C.
Em falta de energia, o que fazer primeiro com a geladeira?	Manter fechada, monitorar e avisar o RT; transferir se a temperatura se aproximar de 7 °C.
Produto exposto a excursão pode ser vendido?	Só após avaliação documentada do fabricante; até lá, segregado em 2 °C a 8 °C.
Toujeo em uso	6 semanas (42 dias), até 30 °C, sem voltar à geladeira.
Ozempic após o primeiro uso	6 semanas, abaixo de 30 °C ou em geladeira.
Clavulin BD suspensão após preparo	7 dias em geladeira (2 °C a 8 °C).
Xalatan após aberto (bula brasileira)	Até 25 °C, válido por 10 semanas.

Pergunta	Resposta
PVPS	Primeiro que vence, primeiro que sai: lote de validade mais curta à frente.

Questões: termolábeis e armazenamento

1. A bula de um produto indica "conservar em local fresco". Pela Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, essa expressão corresponde a:

A Entre 2 °C e 8 °C, obrigatoriamente em refrigerador

B Entre 8 °C e 15 °C

C Entre 15 °C e 25 °C

D Entre 15 °C e 30 °C

E Abaixo de 0 °C

2. Segundo a RDC 430/2020, um medicamento é classificado como termolábil quando:

A Deve ser protegido da luz durante toda a validade do produto

B A bula proíbe temperatura acima de 30 °C

C A bula proíbe temperatura acima de 25 °C

D Sua temperatura máxima é de até 8 °C

E É de origem biológica, qualquer que seja a faixa

3. Drogaria licenciada para vacinação pretende guardar as vacinas em geladeira doméstica nova, exclusiva e com termômetro calibrado. Conforme a RDC 197/2017 e o Manual de Rede de Frio (2025):

A Não é permitido: o equipamento deve ser regularizado na Anvisa

B É permitido se a geladeira for exclusiva e tiver registro diário

C É permitido se houver também um datalogger com alarme

D É permitido para vacinas inativadas, não para vacinas vivas

E É permitido se a vigilância local autorizar por escrito

4. Ao escrever o POP de controle de temperatura do estoque, o farmacêutico deve definir o horário da leitura diária. A RDC 44/2009 orienta escolher:

A. O horário de abertura da loja, quando há menos movimento no balcão
B. Qualquer horário, desde que seja sempre o mesmo
C. A faixa de horário de maior temperatura e umidade
D. O horário em que o farmacêutico RT estiver presente
E. O horário indicado pelo fabricante do termômetro

5. Na segunda-feira, a leitura da geladeira mostra momento 5 °C, máxima 12 °C e mínima 4 °C. O datalogger confirma 6 horas acima de 8 °C no domingo. A conduta correta é:

A. Liberar os produtos, porque a temperatura atual está normal
B. Descartar todo o conteúdo da geladeira imediatamente
C. Liberar apenas os produtos com validade superior a 6 meses
D. Transferir para temperatura ambiente até a vinda da assistência técnica
E. Segregar refrigerado, registrar e consultar o fabricante

6. Paciente começou hoje a usar insulina glargina 300 U/mL (Toujeo). Pela bula brasileira, a caneta em uso deve ficar:

A. Na geladeira entre as aplicações, por até 28 dias
B. Até 30 °C por 6 semanas, sem voltar à geladeira
C. Na porta da geladeira, por até 8 semanas
D. No congelador, para prolongar a validade após aberta
E. Em temperatura ambiente por até 14 dias, depois na geladeira

7. Mãe recebe amoxicilina com clavulanato em suspensão (Clavulin BD) já reconstituída na farmácia. A orientação de conservação, conforme a bula, é:

A. Temperatura ambiente por 14 dias, protegida da luz
B. Geladeira por 14 dias, como as demais amoxicilinas
C. Geladeira de 2 °C a 8 °C por 7 dias, sem congelar
D. Congelador, descongelando cada dose antes do uso
E. Temperatura ambiente por 7 dias, depois geladeira

8. Paciente que usa insulina vai viajar de avião por uma semana. A orientação adequada sobre o transporte é:

A Levar na bagagem de mão, em bolsa térmica, com a receita

B Despachar na mala, bem embalada, para evitar a inspeção

C Levar em contato direto com gelo comum para garantir o frio

D Congelar as canetas de reserva antes da viagem

E Deixar as canetas fora da embalagem para economizar espaço

9. Farmacêutico orienta um paciente sobre Xalatan (latanoprosta) colírio recém-aberto. Segundo a bula brasileira consultada:

A Deve permanecer na geladeira e vale 4 semanas após aberto

B Pode ficar em temperatura ambiente e vale até o fim da validade impressa

C Deve ser congelado entre as aplicações

D Após aberto, pode ficar até 25 °C e vale 10 semanas

E Após aberto, deve ficar abaixo de 8 °C e vale 28 dias

10. Chega à farmácia caixa térmica com canetas de semaglutida. O termômetro de cabo extensor marca 11 °C entre os produtos. Pela RDC 44/2009 e pelas boas práticas de recebimento, o responsável deve:

A Guardar normalmente na geladeira, porque logo voltará à faixa

B Recusar todas as mercadorias do pedido, inclusive as não refrigeradas

C Colocar à venda com desconto para girar o estoque rapidamente

D Guardar em temperatura ambiente até a resposta do distribuidor

E Manter refrigerado em quarentena e acionar o distribuidor

Gabarito comentado

1. **B**. A Farmacopeia Brasileira define local fresco como ambiente entre 8 °C e 15 °C e admite conservar em refrigerador quando a monografia não disser o contrário, mas sem obrigar. Entre 2 °C e 8 °C é "em refrigerador"; 15 °C a 30 °C é temperatura ambiente; abaixo de 0 °C corresponde ao congelador.
2. **D**. O art. 3º, XVI, da RDC 430/2020 define termolábil como o medicamento cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8 °C. Proteção da luz caracteriza fotossensibilidade; limites de 25 °C ou 30 °C indicam sensibilidade à temperatura, não termolabilidade; a origem biológica não define a categoria.
3. **A**. A RDC 197/2017 exige equipamento de refrigeração exclusivo e regularizado na Anvisa (art. 10, III, f, e §2º), e o Manual de Rede de Frio, 6ª ed., afirma ser proibido o uso de refrigeradores domésticos e frigobares para imunobiológicos, por isolamento térmico inadequado. Exclusividade, datalogger ou tipo de vacina não mudam a regra.
4. **C**. O art. 35, §4º, exige que o POP defina a metodologia de verificação de temperatura e umidade, especificando a faixa de horário em que há maior probabilidade de encontrar a maior temperatura e umidade do dia. Abertura da loja, horário fixo qualquer, presença do RT ou orientação do fabricante do instrumento não atendem ao critério da norma.
5. **E**. Houve excursão no intervalo, revelada pela máxima e pelo datalogger. O Manual de Rede de Frio e o art. 35, §5º, da RDC 44/2009 levam a segregar, identificar, manter na faixa correta, registrar e consultar o fabricante antes de qualquer decisão. Liberar pela temperatura atual ignora a excursão; descartar tudo sem avaliação pode desperdiçar produto aprovável; validade longa não protege contra degradação; retirar da geladeira agrava o problema.
6. **B**. A bula brasileira do Toujeo orienta manter a caneta em uso em temperatura até 30 °C e usar por até 6 semanas (42 dias), nunca colocando-a de volta na geladeira. Os 28 dias correspondem a outras insulinas; 8 semanas é o prazo da degludeca; congelar inutiliza a insulina; o esquema de 14 dias não existe para esse produto.
7. **C**. A bula do Clavulin BD informa que a suspensão preparada fica estável por 7 dias em refrigerador (2 °C a 8 °C), sem congelar, e que fora da geladeira escurece em 48 horas. A amoxicilina isolada (Amoxil) tem prazo de 14 dias em geladeira, o que mostra que cada produto tem regra própria.
8. **A**. Termolábeis viajam na bagagem de mão: no porão, a temperatura não é controlada pelo passageiro e há risco de extravio. A bolsa térmica protege do calor, e a receita ou relatório facilita a inspeção. Contato direto com gelo pode congelar, e congelar inutiliza a insulina; a embalagem original protege da luz.
9. **D**. A bula brasileira do Xalatan indica refrigeração de 2 °C a 8 °C até a abertura e, depois de aberto, temperatura ambiente até 25 °C, válido por 10 semanas. O prazo de 4 semanas aparece em informações de outros países, por isso a bula da apresentação vendida no Brasil é a referência. Congelar não é permitido.
10. **E**. A RDC 44/2009 só admite receber produto transportado conforme o fabricante (art. 33). A boa prática, refletida no art. 57 da RDC 430/2020, é devolver no ato ou manter em quarentena até a decisão, sempre nas condições de conservação do produto. Guardar como se nada tivesse ocorrido, vender com desconto ou deixar em temperatura ambiente expõem o paciente a risco; recusar a carga seca não tem relação com o desvio.

Módulo 5

Passo a passo do SNGPC

Guia prático para o farmacêutico que assume uma drogaria operar o SNGPC desde o primeiro dia: cadastro, credenciamento, inventário, escrituração, transmissão, correção de erros e fiscalização, com base na RDC 22/2014, na RDC 471/2021 com a RDC 973/2025 e nos documentos técnicos vigentes da Anvisa.

- O que é o SNGPC e quem é obrigado
- Pré-requisitos e papéis
- Credenciamento, acesso e troca de RT
- Inventário inicial
- Rotina diária de escrituração
- Transmissão do arquivo XML
- Erros, recusas e correções
- Fiscalização, relatórios e penalidades
- O SNGPC por dentro, tela a tela

O que é o SNGPC e quem é obrigado

O **Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)** é o sistema da Anvisa em que farmácias e drogarias fazem a escrituração sanitária dos medicamentos controlados. Escrituração sanitária é o registro de cada entrada e de cada saída desses produtos (RDC 22/2014, art. 5º, IX). Na prática, o software de gestão da loja registra a movimentação, gera um arquivo XML no padrão da Anvisa e o farmacêutico transmite esse arquivo. O sistema monta, a partir dos arquivos, o estoque oficial de cada lote em cada loja do país.

O SNGPC controla **o medicamento**. O Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR) controla **a receita** (numeração, autenticidade e uso único). Os dois convivem e um não substitui o outro.

O que entra no SNGPC

Grupo	Norma de base	Desde quando no SNGPC
Medicamentos e insumos das listas da Portaria 344/1998	RDC 22/2014, art. 2º	Desde a criação do sistema (2007)
Antimicrobianos de uso sob prescrição (lista na IN 360/2025, art. 1º)	RDC 471/2021, art. 14; RDC 22/2014, art. 2º	Desde a versão 2.0 do SNGPC (2013)
Agonistas do receptor de GLP-1: semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida	RDC 471/2021 com a RDC 973/2025; IN 360/2025, art. 2º	Retenção e escrituração desde 23/06/2025; SNGPC obrigatório conforme o cronograma de retomada

Os agonistas de GLP-1 seguem no XML o mesmo padrão de preenchimento dos antimicrobianos (Anvisa, Perguntas e Respostas GLP-1, junho de 2025). A receita deles vale 90 dias (IN 360/2025, art. 2º, § 1º); a de antimicrobiano vale 10 dias (IN 360/2025, art. 1º, § 2º).

Quem é obrigado

- **Farmácias e drogarias privadas**: todas (RDC 22/2014, art. 3º). Isso inclui a farmácia de manipulação, que escritura também insumos com o lote do fabricante (art. 10, § 5º) e a operação de transformação.
- **Farmácias públicas e farmácias de hospital**: ficam fora do SNGPC enquanto não houver módulo específico (art. 3º, parágrafo único).
- **Unidades públicas que dispensam com ressarcimento**, como as do Farmácia Popular: escrituram antimicrobianos e agonistas de GLP-1 em livro de registro específico ou em sistema aprovado pela VISA, em até 7 dias da dispensação (RDC 471/2021, art. 15, redação da RDC 973/2025).
- **Município sem internet**: a VISA local pode autorizar o livro de registro (RDC 22/2014, art. 35, § 1º; RDC 471/2021, art. 14, parágrafo único).

O QUE DIZ A NORMA

"Todas as farmácias e drogarias devem, obrigatoriamente, utilizar o SNGPC para escrituração sanitária dos medicamentos, insumos farmacêuticos e preparações e/ou especialidades farmacêuticas de que trata esta Resolução." (RDC 22/2014, art. 3º)

Histórico curto

1. 2007: o SNGPC começa a operar para farmácias e drogarias (RDC 27/2007).
2. 2013: versão 2.0 inclui os antimicrobianos; o inventário passa a ser enviado por arquivo XML (Nota Técnica 003/2013).
3. 2014: a RDC 22/2014 revoga a RDC 27/2007 e passa a regular o sistema. Continua vigente, sem alterações no texto consolidado da Anvisa.
4. 2021: por instabilidade, a RDC 586/2021 suspende por tempo indeterminado os prazos de transmissão do art. 10, §§ 3º e 4º. A falta de envio deixa de ser infração a partir de 5 de outubro de 2021. A escrituração interna continua obrigatória (art. 4º).
5. 2024: a Anvisa abre testes ampliados com farmácias privadas; transmissões da fase de teste não servem de base para fiscalização.
6. 2025: em 5 de maio a Anvisa divulga o cronograma de retomada. Pela própria RDC 586/2021 (art. 5º), a suspensão termina na data divulgada, sem necessidade de nova resolução. Em agosto, o acesso passa a ser possível também pela conta gov.br.

Região	Transmissão obrigatória desde
Sudeste	1º/09/2025
Sul e Norte	1º/11/2025
Centro-Oeste e Nordeste	02/01/2026

ATENÇÃO

Nem durante a suspensão de 2021 a 2025 a escrituração deixou de ser obrigatória: a RDC 586/2021 suspendeu só o prazo de transmissão e manteve o registro interno e a guarda dos documentos (art. 4º). Loja que "não escriturou porque o SNGPC estava parado" não tem como provar o estoque.

O que o SNGPC não faz

- Não avalia a receita. Validade, campos obrigatórios e quantidade continuam sendo conferidos pelo farmacêutico no balcão.
- Não substitui a consulta e o registro de uso da receita eletrônica no SNCR.
- Não guarda a receita. Notificações e receitas retidas ficam arquivadas na loja, e as eletrônicas, em meio eletrônico.

- Não corrige o estoque sozinho. O saldo oficial é o resultado dos arquivos aceitos; arquivo não enviado é movimento que não existe para o sistema.

Situação em outubro de 2026

A transmissão é obrigatória em todo o país. Valem os prazos da RDC 22/2014: arquivos a cada 1 a 7 dias consecutivos, mesmo sem movimento (art. 10, § 3º). Descumprir é infração sanitária (RDC 586/2021, art. 5º, parágrafo único). Desde 30/09/2026 o SNCR numera receitas eletrônicas e a farmácia registra nele o uso dessas receitas, mas não há cronograma de integração entre SNCR e SNGPC (Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025). Por isso a escrituração de cada dispensação continua sendo feita no software da loja e transmitida ao SNGPC.

NO BALCÃO

No primeiro dia, pergunte ao responsável legal três coisas: qual software gera o XML, quando foi o último arquivo aceito e quem estava associado como RT no SNGPC. As três respostas dizem se a loja está em dia ou se o seu primeiro trabalho é regularizar.

CASO

Recém-formada assume uma drogaria em Teresina em outubro de 2026. O dono diz que "o SNGPC voltou só para o Sudeste". A informação está desatualizada: no Nordeste a transmissão é obrigatória desde 02/01/2026. Ela verifica no sistema a data do último arquivo aceito e, como há meses sem envio, trata a loja como estabelecimento em atraso, com inventário novo e comunicação à VISA.

Pré-requisitos e papéis

O SNGPC só funciona depois que a empresa e as pessoas estão cadastradas na Anvisa. O acesso pressupõe o cadastro atualizado do estabelecimento, do gestor de segurança, do farmacêutico RT e do responsável legal (RDC 22/2014, art. 6º). Faltando qualquer um, o sistema não libera o acesso ou não deixa transmitir.

O que precisa existir

Item	Para que serve	Base
CNPJ ativo e CNAE de farmácia ou drogaria	Identifica o estabelecimento; o SNGPC recusa acesso a CNAE de outra atividade	RDC 22/2014, art. 5º, XI; Nota Técnica 003/2013
Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa	Permite à farmácia ou drogaria exercer a atividade	RDC 17/2013
Autorização Especial (AE)	Só para farmácia que manipula substâncias da Portaria 344; drogaria não precisa	RDC 17/2013, art. 2º, II
Licença sanitária local	Funcionamento perante a VISA do município ou do estado	RDC 17/2013, art. 2º, XIII

Item	Para que serve	Base
Cadastro da empresa na Anvisa	Porta de entrada para os sistemas da Anvisa, inclusive SNGPC	Anvisa, Cadastro de Empresas
RT com inscrição ativa no CRF	Único profissional que inventaria e transmite	RDC 22/2014, arts. 5º, XXVI, e 18, § 2º
Software de gestão que gere o XML no padrão SNGPC	Escritura, guarda a cópia de segurança e gera os arquivos	RDC 22/2014, arts. 10, 17 a 20

A RDC 22/2014 não exige certificado digital ICP-Brasil para o SNGPC: o acesso é por senha pessoal e intransferível (art. 7º) ou, desde agosto de 2025, pela conta gov.br do próprio RT ou responsável legal. O SNCR, que a loja também precisa usar, exige login gov.br individual e AFE ativa.

ATENÇÃO

A Anvisa não indica nem homologa software de farmácia. A escolha, a compra e a manutenção do sistema são responsabilidade do estabelecimento (RDC 22/2014, art. 20). Se o software gera XML fora do padrão, quem responde pela falta de transmissão é a loja.

Os papéis

Papel	Quem é	O que faz no SNGPC
Responsável legal (RL)	Pessoa designada no contrato social para representar a empresa (art. 5º, XXV)	Mantém o cadastro da empresa e associa o RT ao estabelecimento; responde junto com o RT pelo uso da senha (art. 7º, parágrafo único)
Gestor de segurança	Pessoa que administra os usuários da empresa nos sistemas da Anvisa (art. 5º, XII)	Cadastra usuários e atribui perfis de acesso; pode ser o RL, o RT ou outra pessoa
Farmacêutico RT	Farmacêutico inscrito no CRF, com assistência técnica à loja (art. 5º, XXVI)	Faz o inventário, gera e envia os XML, responde pela escrituração (arts. 8º, 10, § 1º, e 18, § 2º)
Farmacêutico substituto	Farmacêutico que cobre ausências do RT	Pode escriturar e transmitir se estiver cadastrado e associado no SNGPC (art. 10, § 1º)
Atendentes e auxiliares	Equipe do balcão e do estoque	Digitam dados no software, com acesso parcial delegado pelo RT, sob responsabilidade dele (art. 18, § 1º)

O QUE DIZ A NORMA

"O sistema informatizado do estabelecimento, que gera os arquivos XML para envio ao SNGPC, deve ter acesso restrito ao farmacêutico responsável técnico ou seu substituto legal devidamente cadastrado e associado no SNGPC." (RDC 22/2014, art. 18). "É função do farmacêutico responsável técnico a geração e envio dos arquivos XML ao SNGPC." (art. 18, § 2º)

Ausência do RT e substituto

A farmácia deve ter farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (Lei 13.021/2014, art. 6º, I). Sem RT nem substituto, a lei permite funcionar por até 30 dias, mas sem vender medicamentos sujeitos a controle especial (Lei 5.991/1973, art. 17). No SNGPC, a falta de substituto não interrompe a obrigação: ao fim da ausência, transmitem-se os arquivos do período sem movimentação de medicamentos da Portaria 344 (RDC 22/2014, art. 11).

A troca de quem transmite, mesmo temporária, exige finalizar o inventário antes (art. 12). Por isso o arranjo mais simples para férias e folgas é ter o substituto já cadastrado, com perfil atribuído, e planejar a passagem com antecedência. O sistema tem a função no menu Informar Ausência: o RT registra início e fim do afastamento, com início a partir da data atual (não se informa ausência passada) e no máximo 30 dias por período, sem sobrepor o período anterior (tela consultada em 10/10/2026; Nota Técnica 003/2013). Confirme com a sua VISA como ela trata o afastamento sem substituto.

1. Pedir ao responsável legal o contrato social e conferir quem é o RL e quem é o gestor de segurança.
2. Conferir no cadastro da empresa na Anvisa se o seu CPF aparece como responsável técnico e se os dados do CRF estão completos.
3. Confirmar com o gestor de segurança que o perfil de acesso ao SNGPC foi atribuído ao seu usuário.
4. Pedir ao fornecedor do software a versão do leiaute que o sistema gera e um teste de geração de arquivo.
5. Definir por escrito quem pode lançar dados no software e com qual perfil; só o RT e o substituto geram e enviam.
6. Combinar com o RL como será a cobertura de férias: substituto cadastrado ou loja sem venda de controlados no período.

NO BALCÃO

Senha do SNGPC não se empresta, nem para o gerente "só mandar o arquivo de hoje". O Código de Ética proíbe permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais (Resolução CFF 724/2022, art. 18, XXIX), e o uso indevido recai sobre o RT e o RL (RDC 22/2014, art. 7º).

CASO

O gerente pede ao farmacêutico que deixe a senha do SNGPC salva no computador do caixa para o software transmitir de madrugada. O farmacêutico recusa, explica o art. 7º e o art. 18, § 2º, e combina com o fornecedor do sistema uma rotina em que ele próprio dispara o envio ao chegar, todos os dias.

Credenciamento, acesso e troca de RT

Credenciamento é a adesão do estabelecimento ao SNGPC, que se completa quando o RT envia o inventário inicial e a base da Anvisa o recebe (RDC 22/2014, art. 5º, IV, e art. 8º). Depois disso o sistema emite o **Certificado de Escrituração Digital**, que deve ser impresso e ficar à disposição da fiscalização (art. 9º).

Cadastro da empresa e das pessoas

1. O responsável legal acessa o Cadastro de Empresas da Anvisa (www9.anvisa.gov.br/recadastramento) com CNPJ, CNAE e senha da empresa. Empresa nova usa a opção "Cadastrar Nova Empresa".
2. Na opção "Associar Representante/Responsável", informa o CPF do farmacêutico. Se a pessoa não existir na base, cadastra os dados, inclusive e-mail e senha pessoais.
3. Escolhe o tipo "Responsável Técnico" e completa os dados profissionais pedidos na tela.
4. Cadastra ao menos um gestor de segurança da empresa.
5. Usa "Verificar Cadastro". Item marcado como "Falhou" indica o que falta; volta-se à matriz para completar.
6. O gestor de segurança entra no Sistema de Segurança da Anvisa, em "Manter Usuários" confere o usuário e em "Atribuir Perfis aos Usuários" concede o perfil do SNGPC ao RT.

O e-mail de cada pessoa deve ser diferente do e-mail de qualquer outro usuário e de qualquer empresa (Anvisa, Passo a passo do Cadastro de Empresa, 2023). E-mail repetido é causa frequente de cadastro travado.

Entrar no sistema

1. Acessar sngpc.anvisa.gov.br.
2. Entrar com o e-mail e a senha cadastrados ou com a conta gov.br pessoal. O acesso pelo gov.br não exige mudar o cadastro existente (CFF, notícia de 20/08/2025).
3. Ao entrar pela primeira vez, conferir se o sistema mostra o CNPJ certo e o seu nome como RT.
4. Se o sistema disser que o CPF não tem perfil para acesso ao SNGPC, voltar ao gestor de segurança. Persistindo, abrir chamado na Anvisa (0800 642 9782 ou Fale Conosco).
5. Se a mensagem disser que o acesso só é permitido a empresas com CNAE de farmácia ou drogaria, conferir o CNAE no cartão do CNPJ e no cadastro da Anvisa.

Senha: no Cadastro de Empresas há a opção "Esqueci minha senha" para a senha da empresa; no Sistema de Segurança, o próprio usuário troca a senha em "Alterar Senha". Quem entra pelo gov.br gerencia a credencial no próprio gov.br. Senha bloqueada pela Anvisa só se libera pela central de atendimento.

ATENÇÃO

A mensagem "An attack was detected, originating from your system" indica bloqueio do endereço IP pela segurança da Anvisa. A orientação oficial é pedir o desbloqueio à Anvisa (Nota Técnica 003/2013, item 8.5). Não adianta tentar de novo várias vezes.

Troca de responsável técnico

A troca é o momento de maior risco de perder a continuidade da escrituração. A regra está no art. 12 da RDC 22/2014: a substituição, definitiva ou eventual, é precedida da finalização do inventário; o novo RT confere o inventário finalizado e, se houver divergência com o estoque físico, corrige antes de começar e informa a VISA.

> **O QUE DIZ A NORMA**
>
> "A substituição definitiva ou eventual do farmacêutico responsável técnico no SNGPC deve ser precedida de finalização do inventário, de modo que as transmissões da escrituração possam ter continuidade pelo substituto ou pelo novo farmacêutico responsável técnico." (RDC 22/2014, art. 12)

RT que sai

1. Transmitir todos os arquivos até o último dia de trabalho e conferir que o último está aceito.
2. Fazer o levantamento do estoque de controlados até o último dia e apresentá-lo à VISA (Portaria 6/1999, art. 113).
3. Finalizar o inventário no SNGPC, escolhendo o motivo de saída do RT.
4. Pedir a baixa da responsabilidade técnica no CRF e comunicar a VISA, guardando os protocolos.
5. Guardar cópia do último relatório de estoque e do comprovante de finalização.

Responsável legal

1. Associar o novo RT no cadastro da empresa e pedir ao gestor de segurança o perfil do SNGPC.
2. Associar o novo RT ao estabelecimento no SNGPC. Se o RT anterior não finalizou, o inventário é finalizado automaticamente quando o RL associa o novo RT (Anvisa, Perguntas e Respostas sobre instabilidade do SNGPC, 2021, pergunta 9).
3. Até a associação, não há transmissão: sem RT transmissor o sistema não recebe movimentos.

RT que entra

1. Entrar no SNGPC e conferir o inventário finalizado. Na versão 2.0, após a finalização o sistema permite obter o arquivo com a situação do estoque, para conferir e reaproveitar (Guia do padrão SNGPC, versão 2.3).
2. Fazer contagem física completa, por registro, lote e quantidade.
3. Comparar contagem, inventário finalizado e saldo do software. Divergência corrigida antes de começar e comunicada à VISA (art. 12, § 2º).
4. Gerar no software o XML de inventário com a data da contagem. A data pode ser até 7 dias anterior à transmissão (Nota Técnica 003/2013, item 1).
5. Transmitir e acompanhar até o inventário ser aceito; conferir em Inventário Inicial, linha a linha, e confirmar com o número verificador; depois de confirmado, o inventário não pode ser modificado.
6. Imprimir o novo Certificado de Escrituração Digital, com os dados atualizados (art. 9º, parágrafo único).
7. Retomar os arquivos de movimentação a partir da data do inventário, em ordem e sem lacuna.

Os movimentos ocorridos entre a finalização e a data do novo inventário ficam escriturados no software e documentados (notas e receitas) para a fiscalização (Nota Técnica 003/2013, item 1).

NO BALCÃO

Combine a troca para um dia de pouco movimento e faça a contagem com o RT que sai, se ele aceitar. Assinem juntos a folha de contagem. Divergência descoberta na passagem fica claramente separada entre a gestão de um e a do outro.

CASO

RT pede demissão na sexta e não finaliza o inventário. Na segunda, a nova farmacêutica não consegue transmitir. O responsável legal associa a nova RT no SNGPC, o que finaliza o inventário anterior automaticamente. Ela conta o estoque, encontra 3 frascos de fenobarbital gotas a menos que o saldo, comunica a VISA com a folha de contagem e envia o inventário com o estoque real, datado do dia da contagem.

Inventário inicial

Inventário inicial é a declaração de todo o estoque de medicamentos e insumos sujeitos ao SNGPC, enviada em arquivo XML (RDC 22/2014, art. 5º, XIX). Desde a versão 2.0 não existe digitação de inventário em tela: a única forma de enviá-lo é pelo XML gerado no software, e o inventário passa a valer quando o arquivo é validado (Guia do padrão SNGPC, versão 2.3, item 3.1.1).

Quando fazer

Situação	O que acontece	Base
Loja nova ou primeiro credenciamento	Inventário inicial credencia o estabelecimento	RDC 22/2014, art. 8º
Troca de RT, definitiva ou eventual	Inventário finalizado; novo RT confere e envia o seu	RDC 22/2014, art. 12
Erro de estoque que não se corrige por arquivo	Finalização pela opção de ajuste, com justificativa, e novo inventário	Perguntas e Respostas Anvisa, 2021
Retorno depois de período sem transmissão	Novo XML de inventário com a data do retorno	Perguntas e Respostas Anvisa, 2021, perguntas 3 e 4
Classe terapêutica informada errada	Finalizar o inventário para ajuste	Nota Técnica 003/2013, item 6

Na retomada de 2025 e 2026, o CFF orientou: finalizar o inventário anterior, se houver; fazer o inventário com conferência física; e, depois do aceite, enviar os arquivos de movimentação a cada 1 a 7 dias (CFF, 24/10/2025). A inclusão dos agonistas de GLP-1 não exigiu finalizar inventário: bastou lançar as entradas ocorridas a partir de 23/06/2025 (Perguntas e Respostas GLP-1, pergunta 10).

O que o arquivo de inventário contém

Parte	Medicamento industrializado	Insumo (manipulação)
Cabeçalho	CNPJ do estabelecimento, CPF do RT transmissor e data do inventário	
Classe terapêutica	1 = antimicrobiano; 2 = sujeito a controle especial	Mesma codificação
Identificação	Número de registro do medicamento na Anvisa	Código DCB e CNPJ do fornecedor
Lote	Lote impresso na embalagem	Lote do fabricante
Quantidade e unidade	Quantidade em caixas ou frascos	Grama, mililitro ou unidade

Fonte: Guia para geração do padrão de transmissão SNGPC, versão 2.3 (setembro de 2025). O arquivo segue compactado em ZIP.

Como montar

1. Escolher um horário sem movimento e suspender a venda de controlados, antimicrobianos e GLP-1 durante a contagem.
2. Imprimir do software a posição de estoque por produto, registro e lote, mas contar sem olhar o saldo (contagem cega), de preferência em dupla.
3. Separar fisicamente por número de registro e lote. Produtos iguais com lotes diferentes são linhas diferentes.
4. Contar na unidade que o SNGPC usa para medicamento industrializado: caixa ou frasco, e não comprimido. Apresentações fracionáveis seguem regra própria (RDC 22/2014, art. 35, § 3º).
5. Incluir vencidos, avariados, recolhidos e segregados: todo estoque movimentado deve estar escriturado, comercializável ou não (art. 16).
6. Conferir para cada linha a classe terapêutica correta (antimicrobiano ou controle especial). GLP-1 segue o padrão dos antimicrobianos.
7. Comparar a contagem com o saldo do software e investigar cada diferença antes de gerar o arquivo.
8. Ajustar o software ao estoque real, com registro do motivo de cada ajuste.
9. Gerar o XML de inventário com a data da contagem. Transmitir em até 7 dias dessa data (Nota Técnica 003/2013, item 1).
10. Acompanhar até o arquivo ser aceito e conferir no sistema o inventário recebido.
11. Assinar e arquivar a folha de contagem, o relatório do software e o comprovante de envio.

O QUE DIZ A NORMA

"O estoque físico dos medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial deve ser qualitativa e quantitativamente idêntico ao escriturado no SNGPC, bem como no sistema informatizado do estabelecimento, observando-se o prazo de escrituração." (RDC 22/2014, art. 15)

ATENÇÃO

A opção de finalizar encerra o inventário em curso. A Anvisa registrou como erro frequente finalizar logo depois de confirmar: a finalização encerra o inventário e o sistema deixa de receber arquivos até que um novo inventário seja aceito (Anvisa, SNGPC passo a passo, 2009). Finalização serve para saída de RT, ajuste e as demais situações previstas.

Quando começar as movimentações

Depois que o inventário é aceito, o primeiro arquivo de movimentação cobre o período que começa na data do inventário. A partir daí os arquivos seguem em ordem cronológica, sem lacunas, a cada 1 a 7 dias (RDC 22/2014, art. 10, § 3º). Movimentos ocorridos entre a data do inventário e a data do envio entram no primeiro arquivo; por isso a contagem e o envio devem ficar próximos.

Erros comuns no inventário

- **Data antiga**: inventário com data mais de 7 dias anterior à transmissão é recusado. A mensagem documentada pela Anvisa informa que a data deve ser anterior ao máximo sete dias da data de transmissão (Nota Técnica 003/2013). Refazer com a contagem atualizada.
- **Lote com espaço**: para o sistema, "ABC " é diferente de "ABC". Depois, a saída do lote é recusada como lote não encontrado (Nota Técnica 003/2013, item 12).
- **Classe trocada**: controlado lançado como antimicrobiano passa a ter saída recusada após 10 dias da prescrição (Nota Técnica 003/2013, item 6).
- **Unidade errada**: contar comprimidos em vez de caixas multiplica o estoque.
- **Esquecer item parado**: vencido no armário de segregados não declarado vira divergência na fiscalização.
- **Medicamento que o sistema não encontra**: é inconsistência cadastral. Notificar pela funcionalidade do SNGPC e escriturar no software até a correção (RDC 22/2014, art. 14).

NO BALCÃO

Faça o inventário com a caixa na mão e o número do lote lido da embalagem, não copiado da nota fiscal. Nota e embalagem às vezes divergem num caractere, e o SNGPC compara texto exato.

CASO

Farmacêutico conta o estoque numa terça, mas só consegue enviar o inventário na quarta da semana seguinte, oito dias depois. O arquivo é recusado pela data. Ele refaz a contagem no mesmo dia, aproveitando a separação por lote já feita, gera novo inventário com a data dessa contagem e transmite antes de fechar a loja.

Rotina diária de escrituração

A escrituração acontece no software da loja, no momento de cada movimentação. O SNGPC só recebe o resultado, no arquivo. Escriturar bem é lançar com o documento na mão: nota fiscal na entrada, receita na saída, boletim ou termo na perda.

Movimentação, para o SNGPC, é a entrada (compra ou transferência) e a saída (venda ou dispensação, transformação, transferência ou perda) (RDC 22/2014, art. 5º, XXII).

Entradas

1. Conferir a mercadoria contra a nota fiscal: produto, apresentação, lote, validade e quantidade.
2. Conferir na nota o CNPJ de destino. Ele precisa ser o CNPJ da sua loja; o SNGPC recusa entrada com destino diferente do CNPJ transmissor (Nota Técnica 003/2013, item 8.2).
3. Lançar no software: número da nota, tipo de operação (compra ou transferência), data da nota, CNPJ de origem e de destino, data do recebimento.
4. Lançar cada item com registro, lote exatamente como na embalagem, quantidade em caixas ou frascos e classe terapêutica.
5. Guardar a nota no arquivo de controlados, em ordem de data.

Saída por dispensação

Os dados exigidos no arquivo dependem da classe do produto (Guia do padrão SNGPC, versão 2.3):

Campo	Portaria 344	Antimicrobiano e GLP-1
Tipo de receituário	1 RCE; 2 Notificação B; 3 Notificação Especial; 4 Notificação A	5 Receita antimicrobiano em 2 vias
Número da notificação	Obrigatório nos tipos 2, 3 e 4	Não obrigatório
Data da prescrição	Obrigatória	Obrigatória
Prescritor	Nome, número, conselho e UF; uso humano: CRM, CRO, CRF ou RMS	Nome, número, conselho e UF; admite também COREN
Uso	Humano ou veterinário (veterinário só com CRMV)	Humano ou veterinário
Comprador	Obrigatório: nome e documento	Não obrigatório
Paciente	Não obrigatório	Obrigatório: nome, idade e sexo; não informar em uso veterinário
Uso prolongado	Não se informa	Sim ou não

Em todas as saídas entram registro, lote, quantidade, unidade e data da venda. O campo de quantidade de venda aceita até 999 unidades. O CID é opcional.

1. Avaliar a receita pelas regras do receituário (validade, campos, quantidade). Receita irregular não chega ao software.
2. Na receita eletrônica numerada pelo SNCR, consultar o número, validar a assinatura e registrar o uso no SNCR antes de entregar.
3. No software, escolher o tipo de receituário correto e informar o número. Para receita eletrônica, o número vai no mesmo campo usado para o papel (Perguntas e Respostas RDC 1.000/2025, pergunta 31). Para números do SNCR, o CFF divulgou a orientação de excluir os quatro primeiros dígitos ao lançar no sistema interno (CFF, 24/10/2025); confirme com o fornecedor do software e a VISA.
4. Lançar prescritor com conselho e UF exatamente como na receita.
5. Lançar comprador (controlados) com documento conferido no balcão, ou paciente com idade e sexo (antimicrobianos e GLP-1). Se a receita de GLP-1 não trouxer idade e sexo, a Anvisa orienta o farmacêutico a anotá-los no verso (Perguntas e Respostas GLP-1, pergunta 11).
6. Escolher na tela o lote que está saindo de fato, com a caixa na mão.
7. Anotar nas duas vias da receita de antimicrobiano ou GLP-1 a data, a quantidade aviada, o lote e a rubrica (RDC 471/2021, art. 10, § 3º).
8. Reter a via devida e arquivar no lote do dia.

O QUE DIZ A NORMA

A notificação em papel continua sem registro de uso no SNCR: "o procedimento de retenção da notificação de receita e sua posterior escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) permanece inalterado." (Anvisa, Perguntas e Respostas RDC 1.000/2025, pergunta 24)

Perdas

Perda é saída por vencimento, apreensão ou recolhimento pela VISA, roubo ou furto, avaria, desvio de qualidade, exclusão da lista, coleta de amostra, erro de manipulação, análise fiscal ou devolução e recolhimento ao fabricante (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV). No arquivo, cada perda leva um motivo codificado:

Código	Motivo da perda	Documento que justifica
1	Furto ou roubo	Boletim de ocorrência; comunicação à VISA
2	Avaria	Registro interno com descrição; produto segregado
3	Vencimento	Relação dos itens; termo ou orientação da VISA para inutilização
4	Apreensão ou recolhimento pela VISA	Termo da VISA
5	Perda no processo	Registro de manipulação (farmácia magistral)
6	Coleta para controle de qualidade	Termo de coleta

Código	Motivo da perda	Documento que justifica
7	Exclusão da Portaria 344	Norma que excluiu a substância
8	Desvio de qualidade	Notificação e comunicação ao fornecedor
9	Recolhimento do fabricante	Comunicado de recolhimento e nota de devolução

Transferências e devoluções

- **Transferência** só entre estabelecimentos da mesma rede, com a mesma raiz de CNPJ (RDC 22/2014, art. 5º, XXXI), sempre com nota fiscal. Quem envia escritura a saída por transferência; quem recebe, a entrada.
- **Encerramento, mudança de atividade ou junção**: a transferência de estoque é permitida e escriturada; quem recebe lança a entrada pela nota do estabelecimento que encerrou (art. 13).
- **Devolução pelo cliente**: é vedada para medicamentos com antimicrobianos e agonistas de GLP-1 (RDC 471/2021, art. 21). Para controlados da Portaria 344, o CFF lembra que troca e devolução são proibidas, salvo desvio de qualidade comprovado.
- **Devolução ao fornecedor** por desvio de qualidade ou recolhimento: escriturada como perda com o motivo correspondente e a nota de devolução.

Unidade de medida

Para medicamento industrializado, o padrão SNGPC aceita duas unidades: caixa e frasco. A quantidade é o número de embalagens. Venda de 2 caixas com 30 comprimidos é quantidade 2, e não 60. Para insumos, a unidade é grama, mililitro ou unidade, conforme o insumo. Apresentações fracionáveis seguem escrituradas no sistema interno, fora do SNGPC (RDC 22/2014, art. 35, § 3º).

ATENÇÃO

Dado errado lançado no balcão vira dado errado no SNGPC e, se o arquivo for aceito, vira estoque oficial errado. Cada dispensação deve ser lançada com a receita na mão, antes de o cliente ir embora. Deixar para o fim do dia é a causa mais comum de lote trocado e quantidade errada.

NO BALCÃO

Ao fim de cada turno, separe as receitas retidas do dia por tipo e confira, uma a uma, contra a lista de saídas do software. Cinco minutos de conferência evitam semanas de investigação de divergência.

CASO

Cliente apresenta receita de semaglutida de 40 dias atrás, com indicação de uso por 3 meses e quantidade para cada 30 dias. A receita é válida (90 dias). O farmacêutico dispensa o mês, anota data, quantidade e lote no anverso das duas vias, retém a segunda via e lança a saída com tipo de receituário de antimicrobiano, uso prolongado "sim", paciente com idade e sexo.

Transmissão do arquivo XML

Transmitir é enviar ao SNGPC o arquivo XML com todas as movimentações de um período. O período de cada arquivo tem data inicial e data final, e os arquivos precisam se encadear em ordem, sem buracos.

Periodicidade e prazo

O QUE DIZ A NORMA

"Os dados da escrituração sanitária devem ser transmitidos eletronicamente em arquivos no intervalo de, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 7 (sete) dias consecutivos, ainda que nenhuma movimentação no estoque do estabelecimento tenha ocorrido no respectivo período." (RDC 22/2014, art. 10, § 3º). "A transmissão eletrônica deve ser realizada e atualizada, no mínimo, uma vez por semana." (§ 4º)

- Cada arquivo cobre de 1 a 7 dias.
- Semana sem movimento também gera arquivo.
- Um arquivo novo só é liberado depois que o anterior está "Aceito" (CFF, 24/10/2025).
- Os arquivos seguem ordem sequencial e cronológica, sem lacunas (informes de inconsistência da Anvisa).

Transmitir todos os dias é a forma mais segura: o erro aparece no dia seguinte, com a receita ainda à mão, e a loja nunca fica perto do limite de 7 dias.

Contagem do prazo na prática

Último arquivo aceito	Próximo arquivo	Situação
Segunda a domingo (7 dias)	Começa na segunda seguinte	Regular: período no limite máximo
Período até quinta-feira	Período de sexta em diante, enviado até a quinta seguinte	Regular
Período até quinta-feira	Primeiro envio só na sexta da semana seguinte	Atraso: mais de 7 dias consecutivos
Loja fechada no feriado	Os dias entram no período, sem movimento	Regular, desde que dentro dos 7 dias

Como o arquivo chega à Anvisa

1. O software gera o XML do período, com cabeçalho (CNPJ, CPF do RT transmissor, data inicial e data final) e corpo (entradas, saídas, perdas, transferências).
2. O arquivo é compactado em ZIP. A partir da versão 2.0 só são aceitos arquivos compactados (Guia do padrão SNGPC, versão 2.3, item 5).
3. O envio pode ser feito pelo próprio software, ligado ao webservice ou à API da Anvisa, ou manualmente, no menu Transmissão de arquivos do SNGPC (arquivo ZIP, e-mail e senha do farmacêutico, botão Enviar).
4. No envio, o sistema calcula um código de identificação do arquivo (hash) e responde que o arquivo foi recebido, com data, hora e o hash (Manual do Desenvolvedor, versão 2.0.1). Anote ou guarde esse código: é por ele que se consulta a situação do arquivo.

A Anvisa publicou uma API nova para transmissão e consulta e avisou que o webservice antigo será descontinuado (página Desenvolvedores do SNGPC). Peça ao fornecedor do software a confirmação de que o sistema já usa a API.

ATENÇÃO

Arquivo mandado por e-mail, CD ou pen drive não conta. Só vale o que entra na base do SNGPC pelos canais do sistema. O mesmo vale para o arquivo gerado e esquecido na pasta do computador.

Situações do arquivo

Situação	Significado	O que fazer
Recebido	O arquivo chegou à base	Aguardar a validação
Validado	Estrutura conferida	Aguardar o aceite
Aceito	Movimentações integradas ao estoque oficial	Liberado o próximo período
Recusado	Erro impediu o registro	Ler o motivo, corrigir no software e reenviar o mesmo período

Fonte: CFF, campanha sobre o SNGPC (24/10/2025) e Perguntas e Respostas sobre instabilidade do SNGPC (Anvisa, 2021).

Passo a passo do envio diário

1. Antes de gerar, revisar no software as pendências do dia: dispensação sem lote, entrada sem nota, perda sem motivo.
2. Conferir no SNGPC a data final do último arquivo aceito (Visualizar Inventário, campo Data final do último período informado).
3. Gerar no software o arquivo cujo período começa no dia seguinte a essa data final.

4. Transmitir e guardar a resposta de recebimento com o hash.
5. Consultar a situação do arquivo em Relatórios > Status de Transmissão (Validação executada e Foi aceito?) ou pelo próprio software.
6. Se estiver aceito, registrar no controle diário e seguir.
7. Se estiver recusado, ler o motivo, corrigir o lançamento na origem e gerar de novo o mesmo período.
8. Se o sistema estiver fora do ar, registrar as tentativas e tentar de novo mais tarde.

Quando o sistema está fora do ar

Falta de transmissão causada estritamente por instabilidade do próprio SNGPC não deve ser autuada (RDC 22/2014, art. 33). Para provar, a Anvisa orientou imprimir a página que mostra a tentativa e registrar protocolo na central de atendimento (Nota Técnica 003/2013, item 3). Mensagens como tempo esgotado, serviço indisponível ou erro HTTP 500 no login foram descritas pela Anvisa como sinais de instabilidade (item 2). A escrituração no software continua normalmente; quando o sistema volta, os arquivos são enviados em ordem.

Se um medicamento não é encontrado na base da Anvisa (inconsistência), o RT notifica pela funcionalidade do SNGPC, escritura as movimentações no software e retoma o envio desse produto quando a Anvisa corrigir (RDC 22/2014, art. 14).

NO BALCÃO

Crie uma planilha simples com uma linha por arquivo: período, data do envio, hash, situação e rubrica. Na fiscalização ela mostra a regularidade em segundos, e no dia a dia avisa quando algum arquivo ficou para trás.

CASO

Na quinta-feira o arquivo de quarta volta recusado. O farmacêutico não envia o arquivo de quinta "para não atrasar", porque o sistema não libera o novo enquanto o anterior não estiver aceito. Ele corrige o erro de quarta, reenvia o mesmo período, espera o aceite e só então transmite quinta.

Erros, recusas e correções

Um arquivo recusado avisa que algo na escrituração está errado. A infração começa quando o erro não é corrigido e a loja passa do prazo de 7 dias, ou quando o estoque físico deixa de bater com o escriturado (RDC 22/2014, arts. 10, § 3º, e 15).

Os três grupos de erro

Grupo	Exemplos	Quem resolve
Acesso	Sem perfil, CNAE, IP bloqueado, senha	Gestor de segurança, RL, central da Anvisa

Grupo	Exemplos	Quem resolve
Estrutura do arquivo	Caractere inválido, elemento fora do padrão, arquivo não compactado	Suporte do software
Conteúdo da escrituração	Lote não encontrado, falta de estoque, classe trocada, CNPJ de destino, número de notificação ausente, conselho incompatível	Farmacêutico, com correção na origem

Como corrigir um arquivo recusado

1. Ler a mensagem completa do motivo e identificar o produto, o lote e a data citados.
2. Localizar no software o lançamento de origem: a nota, a receita ou a perda.
3. Comparar com o documento físico. Corrigir o que estiver errado no lançamento, não no arquivo.
4. Se o erro for de estrutura (mensagem técnica sobre elemento ou caractere), abrir chamado com o suporte do software, enviando a mensagem.
5. Gerar novamente o arquivo do mesmo período.
6. Transmitir e acompanhar até o aceite.
7. Registrar no controle diário o que foi corrigido e por quê.

Erro em arquivo já aceito

A RDC 22/2014 não prevê edição de movimento já integrado. O caminho documentado pela Anvisa para corrigir quantidade de estoque no SNGPC é a **finalização do inventário pela opção de ajuste**, com uma justificativa que permita identificar o motivo, seguida do envio de novo XML de inventário (Anvisa, Perguntas e Respostas sobre instabilidade do SNGPC, 2021). Todas as finalizações e reaberturas ficam registradas no histórico da empresa e podem ser vistas pelas VISAs. Por isso o ajuste é recurso de exceção, documentado, e não rotina.

1. Corrigir o lançamento no software e guardar o documento que prova o valor certo.
2. Avaliar se a diferença afeta o estoque oficial. Erro sem efeito de estoque (por exemplo, grafia do nome do comprador) fica corrigido no software e documentado.
3. Se o estoque do SNGPC ficou diferente do físico, contar o produto afetado e confirmar a diferença.
4. Finalizar o inventário com motivo de ajuste e justificativa objetiva: produto, lote, diferença, causa e documentos.
5. Enviar novo inventário com o estoque real, datado em até 7 dias antes da transmissão.
6. Comunicar a VISA local quando houver divergência de controlado sem explicação documental, e seguir os procedimentos adicionais que ela determinar.

O QUE DIZ A NORMA

"Quando houver inconsistências que impeçam o envio de arquivo XML, as movimentações desta inconsistência devem ser escrituradas no sistema informatizado do estabelecimento para controle e fiscalização pela autoridade sanitária." (RDC 22/2014, art. 14, § 1º)

ATENÇÃO

Entrada fictícia, perda sem fato real ou venda sem escrituração para "acertar" o saldo são infrações e escondem a causa da diferença. Diferença de estoque se resolve com documento, ajuste pelo procedimento da Anvisa e, quando não há explicação, comunicação à VISA.

Situações sem mensagem padrão

Algumas falhas não têm texto de recusa documentado em norma ou nota técnica, mas aparecem na rotina:

- **Período fora de ordem ou com lacuna**: a Anvisa exige envio em ordem sequencial e cronológica, sem lacunas. Gerar o arquivo a partir do dia seguinte ao último aceito.
- **Mesmo movimento em dois arquivos** (duplicidade): pode aparecer como baixa de estoque em dobro e, depois, falta de estoque. Conferir períodos sobrepostos no software antes de gerar.
- **CPF, CRM ou número de documento digitado errado**: o arquivo pode até ser aceito e o erro só aparecer na fiscalização. Conferir no balcão, com o documento na mão.
- **Estoque negativo no software**: sinal de entrada não lançada ou saída em lote errado. Resolver antes de gerar o arquivo.

Prevenção

- Cadastrar no software cada produto com o número de registro e a classe terapêutica certos uma única vez, na primeira entrada.
- Bloquear no software a venda de lote que não tem entrada lançada.
- Configurar o software para exigir número de notificação nos tipos 2, 3 e 4 e paciente com idade e sexo em antimicrobianos e GLP-1.
- Conferir o CNPJ de destino em toda nota de controlado antes de dar entrada.
- Fazer contagem cega semanal dos itens de maior giro e comparar com o estoque do SNGPC.
- Pedir ao fornecedor do software que avise com antecedência qualquer atualização do leiaute ou da forma de envio.

Quando procurar a VISA

- Divergência de controlado sem explicação documental: boletim de ocorrência quando houver suspeita de desvio, comunicação à VISA e escrituração da perda.
- Troca de RT com divergência entre inventário e estoque (RDC 22/2014, art. 12, § 2º).
- Furto, roubo ou extravio de medicamentos ou de receitas retidas.
- Atraso de transmissão por qualquer motivo que não seja instabilidade comprovada do SNGPC.
- Município sem acesso à internet, para autorização de livro (art. 35, § 1º).
- Caso não previsto: comunicar a VISA municipal e, além disso, a Anvisa pelos canais de atendimento (Perguntas e Respostas, 2021, pergunta 13).

NO BALCÃO

Quando o motivo da recusa citar um lote, vá ao armário antes de mexer no software. Muitas vezes a própria caixa mostra o problema: lote com letra O no lugar de zero, sufixo esquecido ou caixa de outro lote vendida no lugar.

CASO

Arquivo recusado por falta de estoque do lote 2405B de clonazepam 2 mg. O farmacêutico consulta o histórico de movimentações do produto no SNGPC e vê que a entrada daquele lote nunca foi transmitida: a nota foi lançada no software com o lote "2405 B". Ele corrige o lote na entrada, gera de novo o período e o arquivo é aceito.

Fiscalização, relatórios e penalidades

A fiscalização do cumprimento da RDC 22/2014 cabe às vigilâncias sanitárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (art. 32). Cada VISA acessa no SNGPC os dados dos estabelecimentos da sua área: a estadual vê o estado, a regional vê a regional, a municipal vê o município; o RT vê só a própria loja (página da Anvisa sobre o SNGPC para vigilâncias).

O que a vigilância confere

1. Certificado de Escrituração Digital impresso e atualizado com o RT atual (art. 9º).
2. Regularidade das transmissões, que pode ser atestada pelo Certificado de Transmissão Regular (art. 5º, VI, e art. 36). No sistema ele fica em Relatórios e só é emitido com pelo menos quatro arquivos validados e aceitos nos últimos 30 dias e o último período informado com até dez dias de diferença da data de geração.
3. Estoque físico de controlados igual ao do SNGPC e ao do software (art. 15). Na comparação, a VISA considera arquivos ainda não enviados ou não validados dentro do prazo (art. 36, parágrafo único).
4. Escrituração mantida no software, com cópia de segurança guardada por 2 anos (art. 10, § 6º, e art. 19, I).
5. Relatórios de estoque e movimentação gerados pelo software (art. 19, II).
6. Notas fiscais, receitas e notificações retidas, boletins e termos que justificam cada movimento, guardados por 2 anos (Portaria 344/1998, art. 64; RDC 471/2021, art. 22).
7. Guarda dos controlados sob chave, em local exclusivo (Portaria 344/1998, art. 67).
8. Balanços e relações periódicas exigidos pela Portaria 344, na forma que a VISA local adotar.
9. Restrição de acesso ao software que gera o XML (art. 18) e sigilo dos dados (art. 21).

O QUE DIZ A NORMA

"Durante a inspeção sanitária local, caso seja verificada divergência entre o estoque físico e o estoque no SNGPC, deverá ser considerada a existência de arquivos não enviados e/ou não validados no prazo previsto pelo § 4º do art. 10." (RDC 22/2014, art. 36, parágrafo único)

Relatórios do SNGPC

O sistema tem uma área de relatórios, de onde se emitem os certificados e se consulta o histórico de movimentações por produto e lote (documentos da Anvisa de 2009, 2020 e 2021). O RT deve usá-la como ferramenta de conferência: comparar periodicamente o estoque oficial dos itens de maior giro com o software e com a prateleira.

Relação com os balanços da Portaria 344

O SNGPC substituiu o livro de registro de farmácias e drogarias (RDC 22/2014, art. 35), mas não revogou os balanços e relações da Portaria 344. Durante a suspensão das transmissões, a Anvisa reafirmou que BSPO, BMPO, RMNRA e RMNRB2 mantinham os prazos dos arts. 68, 69 e 72 da Portaria 344 e que a VISA local pode definir procedimentos próprios (Perguntas e Respostas, 2021, pergunta 12). A falta de remessa no prazo é infração (Portaria 344, art. 73).

Documento	Conteúdo	Prazo na Portaria 344
BMPO	Vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2	Trimestral, até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro; anual até 31 de janeiro (art. 69)
RMNRA	Notificações A retidas	Mensal, até o dia 15 (art. 72)

Sigilo dos dados

O software da loja deve garantir sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade dos dados, e é proibido repassar a terceiros não autorizados informações capazes de identificar padrões de prescrição, dispensação ou consumo (RDC 22/2014, art. 21). Os dados do SNGPC recebem tratamento sigiloso também dentro da vigilância (art. 31). A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) se soma a essas regras. Na prática: relatório de vendas de controlados por médico não sai da loja, o acesso ao módulo de controlados é restrito e o computador do RT não fica aberto no balcão.

Penalidades

A empresa responde administrativa e civilmente pela inobservância da RDC 22/2014, nos termos da Lei 6.437/1977, sem prejuízo das responsabilidades do RT e do responsável legal (RDC 22/2014, art. 39). A VISA pode também comunicar o fato ao conselho profissional (art. 34).

Ponto	Regra	Base
Enquadramento usual	Transgredir normas destinadas à proteção da saúde; aviar receita em desacordo com a norma	Lei 6.437/1977, art. 10, XXIX e XI
Penas possíveis	Advertência, multa, apreensão, interdição, cancelamento de autorização ou de licença, entre outras	Lei 6.437/1977, art. 2º
Multa leve	R$ 2.000 a R$ 75.000	Lei 6.437/1977, art. 2º, § 1º, I
Multa grave	R$ 75.000 a R$ 200.000	Art. 2º, § 1º, II

Ponto	Regra	Base
Multa gravíssima	R$ 200.000 a R$ 1.500.000	Art. 2º, § 1º, III
Reincidência	Multa em dobro	Art. 2º, § 2º
Classificação	Leve com atenuante; grave com uma agravante; gravíssima com duas ou mais	Art. 4º

ATENÇÃO

Instabilidade do SNGPC só afasta a autuação quando o motivo é estritamente a falha do próprio sistema (RDC 22/2014, art. 33). Problema no software da loja, falta de internet da loja ou RT de férias sem substituto não entram nessa exceção.

NO BALCÃO

Monte uma pasta da fiscalização: Certificado de Escrituração Digital, último Certificado de Transmissão Regular, controle diário de arquivos, último relatório de estoque, protocolos de chamados na Anvisa e comunicações à VISA. Na visita, o fiscal recebe a pasta e você ganha tempo para a contagem.

CASO

Na inspeção, o fiscal conta 14 caixas de metilfenidato 10 mg e o SNGPC mostra 16. A farmacêutica mostra que duas dispensações de ontem estão no software e no arquivo de hoje, enviado de manhã e ainda não aceito. O fiscal considera o arquivo em trânsito (art. 36, parágrafo único), confere as duas notificações retidas e encerra o item sem divergência.

O SNGPC por dentro, tela a tela

O SNGPC tem duas partes que o recém-formado costuma confundir. A **escrituração** (cada entrada, saída, perda ou transferência de controlado) é feita no *software de gestão* da farmácia, que gera um arquivo XML no leiaute da Anvisa. O **site do SNGPC** recebe esse arquivo, valida e guarda o estoque oficial. No site não existe tela para digitar uma dispensação: ali o farmacêutico confere, confirma, informa e consulta.

PONTO-CHAVE

Se o estoque do site não bate com o do software, o problema quase sempre está no arquivo que não foi enviado ou foi recusado. Sempre confira o Status de Transmissão antes de procurar erro no balcão.

Entrada no sistema

Endereço: sngpc.anvisa.gov.br. A tela de entrada tem e-mail e senha com reCAPTCHA, o link "Esqueci minha senha" e o botão "Entrar com gov.br". O botão "Entrar como Anvisa" é para servidores da agência. O acesso é pessoal: tudo o que é transmitido, confirmado ou finalizado fica em nome de quem entrou.

O menu principal

Menu	Para que serve	Quando usar
Dados da Empresa	Mostra o cadastro do estabelecimento (razão social, CNPJ, AFE, AE) e quem tem acesso: responsáveis técnicos e responsável legal	Primeiro dia; depois de qualquer mudança de RT
Alterar Dados CRF	Completa número, data de expedição e UF da carteira do CRF	Quando o sistema avisa que os dados do CRF estão pendentes
Inventário Inicial	Mostra o inventário recebido do software e permite confirmá-lo com o código verificador	Ao assumir a escrituração (começo, troca de RT, ajuste)
Finalizar Inventário	Encerra o inventário em curso, com motivo, justificativa (no ajuste) e código	Saída do RT, substituição, encerramento das atividades, ajuste, ordem da VISA
Informar Ausência	Registra afastamento temporário do RT (início e fim)	Antes de um afastamento curto, sempre com data futura e até 30 dias por período
Visualizar Inventário	Posição atual do estoque segundo a Anvisa, por apresentação e lote, com as datas do último arquivo	Conferência semanal por amostragem; antes da fiscalização
Transmissão de arquivos	Envio manual do XML compactado em ZIP	Quando o software não transmite sozinho
Relatórios	Abre o submenu de relatórios e certificados	Todo dia (Status de Transmissão) e quando precisar comprovar regularidade
Sair do Sistema	Encerra a sessão	Sempre ao terminar

O submenu Relatórios

- **Status de Transmissão**: cada arquivo enviado, com período (data inicial e final), data de recebimento, data de validação, "Validação executada" e "Foi aceito?". É a conferência diária.
- **Certificado de transmissão regular**: só é emitido se a farmácia está em dia. A regra exibida pelo próprio sistema é ter pelo menos quatro arquivos validados e aceitos nos últimos 30 dias e o último período informado com até dez dias de diferença da data de geração.
- **Histórico de Inventários**: cada inventário com data de início e de finalização, motivo, RT da época, último arquivo, ausências e quantidades no início e no fim.
- **Histórico de Movimentações**: extrato por tipo (medicamento, insumo, transformado), período, registro, lote e nome. É onde se investiga uma divergência.
- **Certificado de Escrituração Digital**: comprovante em PDF.

ATENÇÃO

Três ações do site não têm volta: confirmar o inventário ("Uma vez confirmado este inventário não poderá ser modificado"), finalizar o inventário e transmitir um arquivo. Leia a tela inteira antes do OK, e nunca use a conta real para "testar".

Tarefas do RT no site, passo a passo

Conferir a transmissão do dia

1. Entrar no sistema.
2. Relatórios.
3. Status de Transmissão.
4. Na primeira linha, conferir se o período (data inicial e final) é o do último dia de movimento.
5. Conferir "Validação executada = SIM" e "Foi aceito? = SIM".
6. Se "Foi aceito? = NÃO": corrigir no software e reenviar o mesmo período; se ainda estiver "NÃO" na validação, aguardar e consultar de novo.
7. Voltar e Sair do Sistema.

Enviar o arquivo manualmente

1. No software, gerar o arquivo de movimentação do período (XML) e compactar em ZIP, se o software não fizer isso.
2. No site, Transmissão de arquivos.
3. Escolher o arquivo .zip.
4. Informar e-mail e senha.
5. Enviar.
6. Conferir o resultado em Relatórios > Status de Transmissão.

Conferir o estoque oficial

1. Visualizar Inventário.
2. Ver a data da validação do último arquivo e a data final do último período informado.
3. Escolher alguns itens e contar o físico (por lote, clicando no medicamento).
4. Se divergir: Relatórios > Histórico de Movimentações, filtrando o medicamento e o lote no período, para achar a entrada ou saída que faltou.

Avisar um afastamento curto

1. Informar Ausência.
2. Data de início (hoje ou futura) e data final (no máximo 30 dias depois).
3. Incluir Ausência e conferir a lista "Ausências do Responsável Técnico".

Sair da responsabilidade técnica

1. Transmitir todas as movimentações até o último dia e conferir no Status de Transmissão que foram aceitas.
2. Conferir o estoque em Visualizar Inventário contra o físico.
3. Finalizar Inventário com o motivo correto (por exemplo, desligamento do RT ou substituição temporária).
4. Digitar o código verificador e confirmar.
5. Imprimir ou guardar o Histórico de Inventários com a finalização.
6. O farmacêutico que assume abre e confirma o inventário dele a partir dessa contagem.

NO BALCÃO

Combine com o dono da farmácia quem transmite quando você não estiver e deixe isso escrito no POP. Senha não se empresta: cada farmacêutico vinculado tem acesso próprio.

CASO

Recém-formada assume uma drogaria e, em Relatórios, o Certificado de transmissão regular é recusado: o último arquivo é de 20 dias atrás. Ela não finaliza nem confirma nada no primeiro dia. Primeiro confere em Dados da Empresa se o nome dela já consta como RT com acesso, depois vê no Status de Transmissão quais períodos faltam, pede ao suporte do software que gere os arquivos pendentes, transmite, confere que foram aceitos e só então trata do inventário com a VISA e o RT anterior.

Fontes consultadas

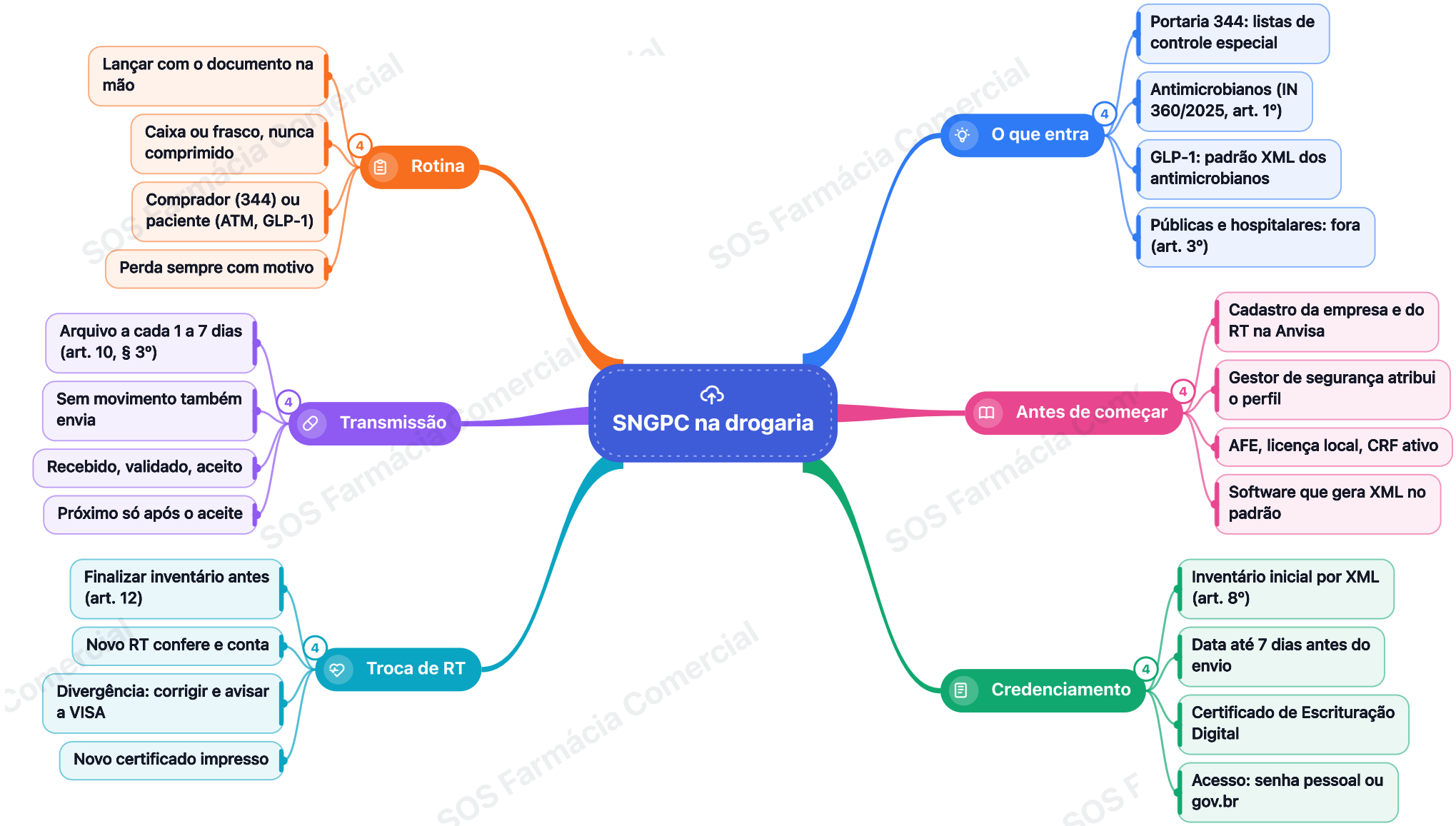
1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 22, de 29 de abril de 2014 (SNGPC). Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net; texto original, Saúde Legis.
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 586, de 17 de dezembro de 2021. Diário Oficial da União nº 238, 20 dez. 2021, Seção 1, p. 287.
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, com a redação da RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
4. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025. Texto vigente, anvisalegis.datalegis.net.
5. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 17, de 28 de março de 2013 (AFE e AE de farmácias e drogarias), e RDC nº 16, de 1º de abril de 2014. Textos consolidados, anvisalegis.datalegis.net.
6. Anvisa. SNGPC: retorno da transmissão regular obrigatória. Notícia, 5 maio 2025. gov.br/anvisa.
7. Anvisa. Páginas do SNGPC: Farmácias e drogarias; Desenvolvedores; Legislação; Vigilâncias sanitárias; Informes. gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/sngpc (consulta em 10 out. 2026).
8. Anvisa. Guia para geração do padrão de transmissão SNGPC: evolução para escrituração de medicamentos antimicrobianos. Versão 2.3, setembro de 2025.
9. Anvisa. Conexão ao Webservice do SNGPC: manual do desenvolvedor. Versão 2.0.1, outubro de 2013.
10. Anvisa. Nota Técnica nº 003/2013: orientações de procedimentos referentes à versão 2.0 SNGPC. 17 jun. 2013.
11. Anvisa. Perguntas e Respostas: instabilidade do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). 1ª ed., 17 dez. 2021.

12. Anvisa. Perguntas e Respostas: mudanças na comercialização e escrituração de medicamentos agonistas do receptor do GLP-1. 1ª ed., junho de 2025.
13. Anvisa. Perguntas e Respostas: RDC nº 1.000/2025. 1ª ed., 2026 (perguntas 24, 25, 31 e 52).
14. Anvisa. Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados: passo a passo 2 de 3. 2009. Biblioteca Digital da Anvisa.
15. Anvisa. Guia de credenciamento no SNGPC. Novembro de 2006. Biblioteca Digital da Anvisa.
16. Anvisa. Passo a passo: cadastramento de empresa e sistema de segurança. 27 mar. 2023. gov.br/anvisa.
17. Anvisa. Cadastro de Empresas. gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/cadastro/cadastro-de-empresas.
18. Conselho Federal de Farmácia. Acesso ao SNGPC será facilitado pela plataforma Gov.Br. Notícia, 20 ago. 2025. cff.org.br.
19. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia, 24 out. 2025. cff.org.br.
20. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Orientação farmacêutica: fornecimento da senha de acesso ao SNGPC a terceiros. 2023. crfsp.org.br.
21. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações à legislação sanitária federal), texto compilado. planalto.gov.br.
22. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, art. 17, texto compilado. planalto.gov.br.
23. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, art. 6º. planalto.gov.br.
24. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 (dispositivos conforme o módulo da Portaria 344/98 deste material).
25. Anvisa. SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados: telas do módulo de farmácias e drogarias (sngpc.anvisa.gov.br), consultadas em 10/10/2026.

SOS Farmácia Comercial

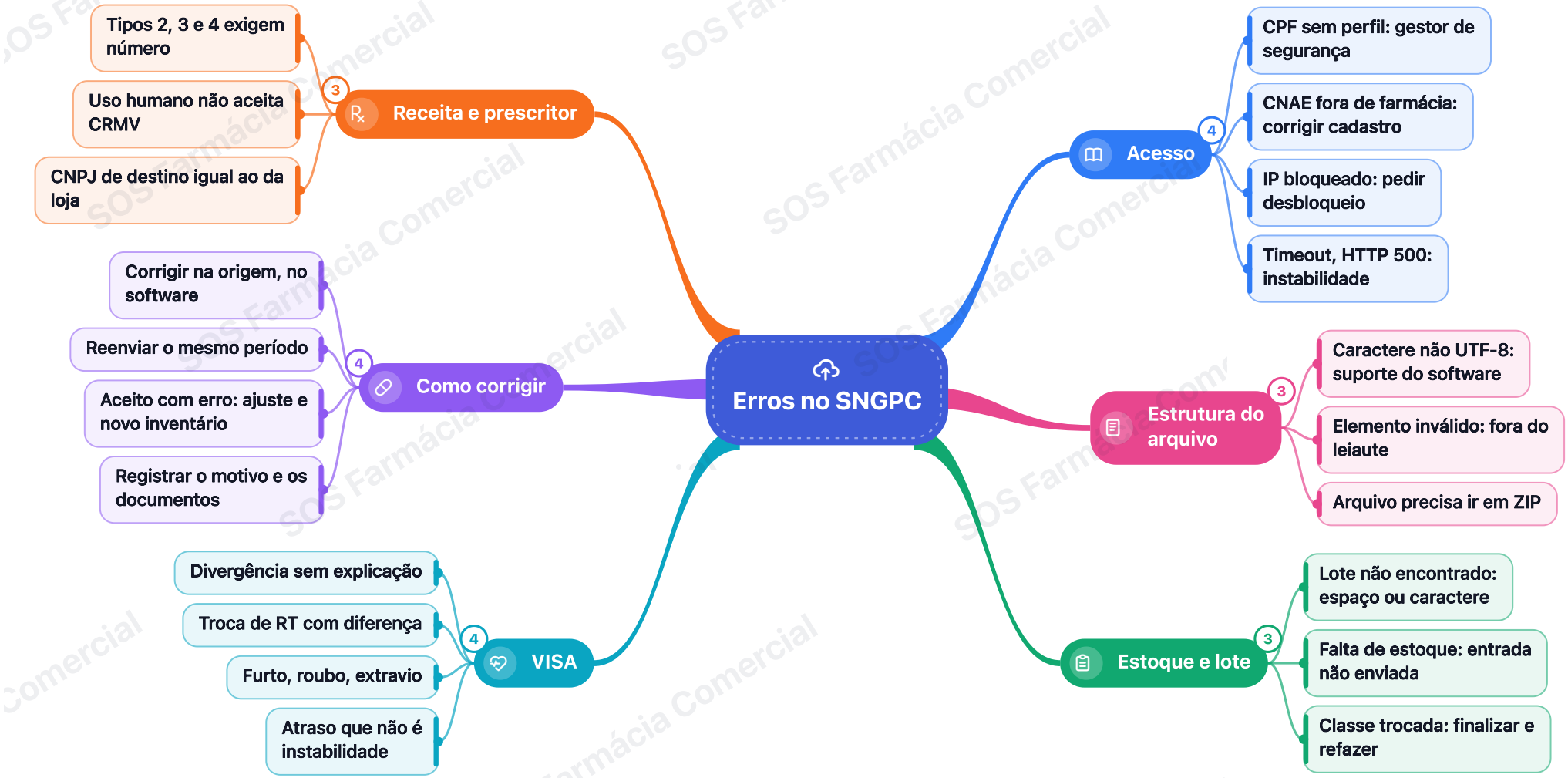
SNGPC: do credenciamento ao dia a dia

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 5



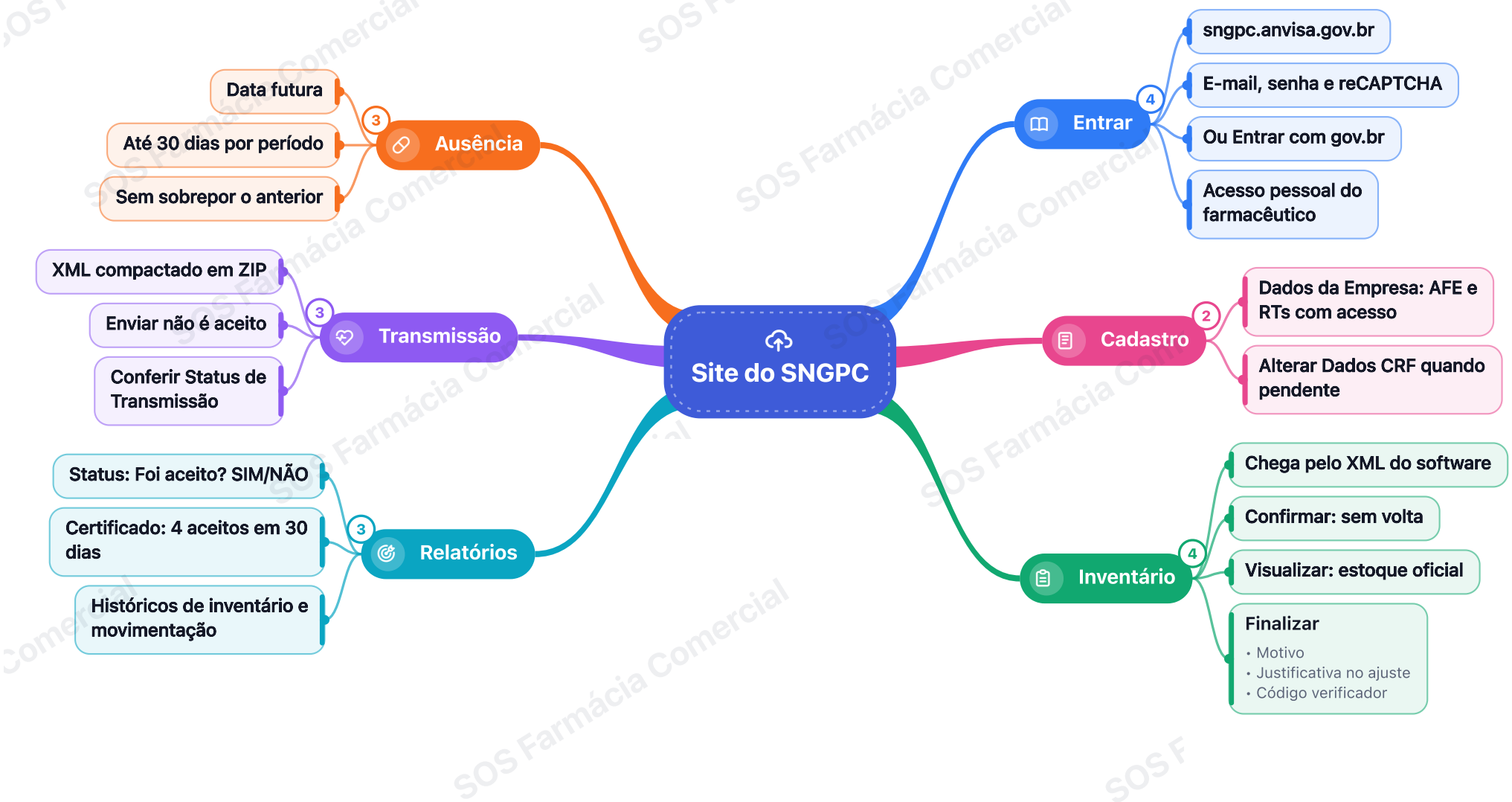
Erros e correções

6 ramos · 21 itens · mapa mental do módulo 5

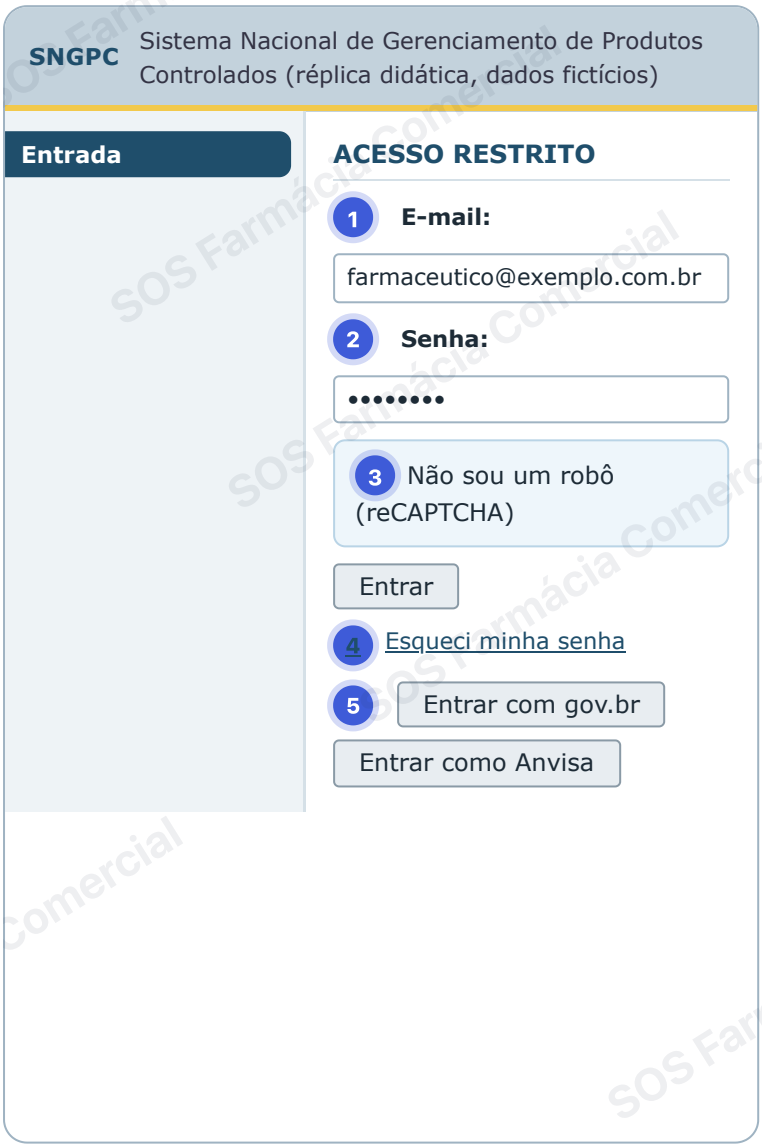


O SNGPC na tela

6 ramos · 19 itens · mapa mental do módulo 5



Simulador: o SNGPC tela a tela



Tela de entrada

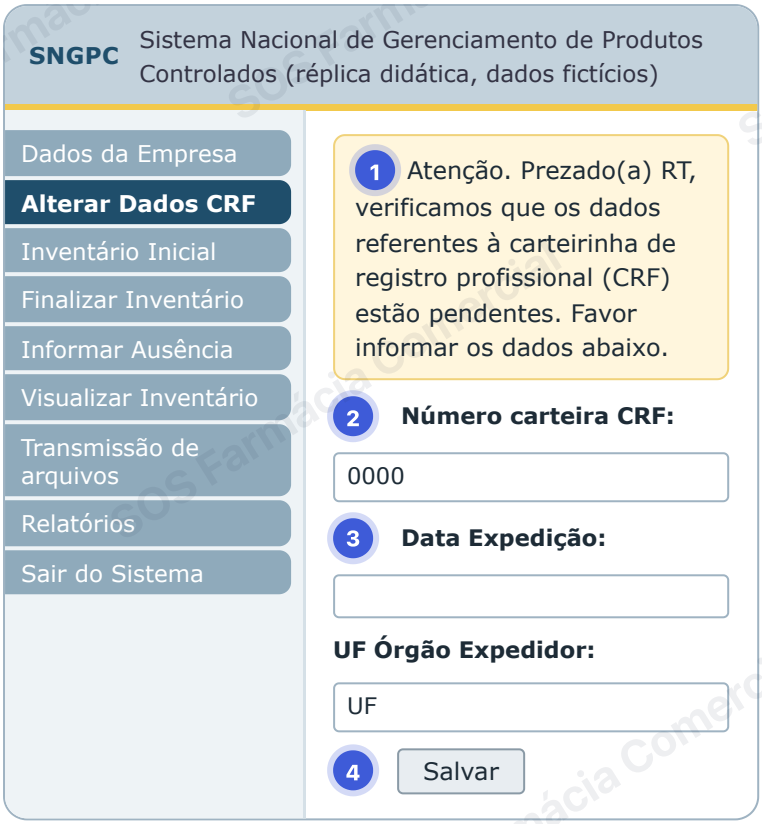
Endereço: sngpc.anvisa.gov.br. Use o Chrome ou o Edge atualizados. O acesso é pessoal: cada farmacêutico entra com o próprio login.

1. E-mail cadastrado do responsável técnico ou do responsável legal. O acesso é nominal: não empreste a senha a balconista nem a outro farmacêutico, porque tudo o que é feito fica registrado no seu nome.
2. Senha pessoal do SNGPC. Em caso de troca de RT, o novo farmacêutico recebe acesso próprio; não se herda a senha do anterior.
3. O reCAPTCHA é marcado pela própria pessoa. Sem ele o botão Entrar não funciona.
4. Recupera a senha pelo e-mail cadastrado. Se o e-mail mudou, é preciso atualizar o cadastro antes.
5. Entrar com gov.br usa a conta gov.br do farmacêutico. "Entrar como Anvisa" é para servidores da Anvisa, não para a farmácia.

Dados da Empresa

Primeira tela a conferir no primeiro dia: confirma que você está no estabelecimento certo e que o seu nome aparece como responsável técnico com acesso.

1. Nome fantasia, razão social, CNPJ, CNAE e endereço vêm do cadastro da empresa na Anvisa. Se algo estiver errado, a correção é feita no cadastro da empresa (e na AFE), não nesta tela.
2. Autorização de Funcionamento da Empresa. Sem AFE válida a drogaria não opera com controlados.
3. Autorização Especial: exigida de quem manipula ou fabrica controlados. Para drogaria que só dispensa medicamento industrializado costuma aparecer "Inexistente".
4. Todos os farmacêuticos vinculados com acesso aparecem aqui, cada um com nome, CRF e e-mail. No primeiro dia, confira se o seu nome está na lista.
5. O responsável legal (sócio ou administrador) também pode ter acesso, mas a escrituração e as decisões técnicas são do farmacêutico.



Alterar Dados CRF

Quando os dados da carteira profissional estão incompletos, o sistema mostra um aviso e pede que o RT os informe.

1. Se este aviso aparecer, resolva no primeiro acesso. Os três campos são obrigatórios.
2. Número da carteira de identidade profissional emitida pelo CRF (não confundir com o número de inscrição, se forem diferentes).
3. Data de expedição que está na carteira do CRF.
4. Salvar grava os dados no seu cadastro de RT. Confira antes de salvar.

SOS Farmácia Comercial

SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (réplica didática, dados fictícios)

- Dados da Empresa
- Alterar Dados CRF
- **Inventário Inicial**
- Finalizar Inventário
- Informar Ausência
- Visualizar Inventário
- Transmissão de arquivos
- Relatórios
- Sair do Sistema

INVENTÁRIO INICIAL

Empresa:

DROGARIA EXEMPLO LTDA (dados fictícios)

1

Data de confirmação do inventário:

(em branco até confirmar)

2

Registro	Medicament
1.0000.0000.001-1	CLONAZEPAM 2 MG COM
1.0000.0000.002-2	ALPRAZOLAM 0,5 MG COM
1.0000.0000.003-3	AMOXICILINA 500 MG CAP

3 Inventário Inicial do Estoque de Insumos Farmacêuticos: Não foram localizados dados!

4 **Número verificador:**

Confirmar

5 Uma vez confirmado este inventário não poderá ser modificado. Deseja realmente confirmar este inventário? [OK] [Cancelar]

Inventário Inicial

O inventário inicial é a fotografia do estoque de controlados no dia em que o farmacêutico assume. Ele chega pelo arquivo do software e é CONFIRMADO nesta tela; depois de confirmado, não se altera.

1. Fica em branco enquanto o inventário não é confirmado. A data de confirmação marca o início da sua escrituração.
2. Cada linha é um lote: registro do medicamento na Anvisa, nome e apresentação, lote e quantidade em unidades. Confira linha a linha contra a contagem física da gaveta e do armário de controlados.
3. Insumos farmacêuticos só aparecem em farmácia com manipulação. Em drogaria esta parte fica vazia.
4. Código mostrado na tela para comprovar que é uma pessoa confirmando. Digite exatamente como aparece.
5. Atenção: depois de confirmado, o inventário não muda. Se houver erro de quantidade ou lote, não confirme: corrija no software, gere o arquivo de novo e só então confirme. Erro descoberto depois de confirmado só se corrige com finalização por "Ajuste de inventário" e novo inventário.

Finalizar Inventário

Encerra a escrituração em curso. Usa-se quando o farmacêutico deixa a responsabilidade, quando a empresa para de trabalhar com controlados, para ajuste ou por ordem da vigilância.

1. Mostra o estoque que o sistema calculou (inventário inicial mais entradas menos saídas transmitidas). É esse saldo que fica registrado na finalização: confira com o estoque físico antes.
2. Sete motivos. Desligamento do RT: o farmacêutico sai da empresa ou dá baixa na responsabilidade. Férias, Licença e Substituição temporária: outro farmacêutico assume a escrituração por um período. Encerramento: a empresa deixa de trabalhar com controlados. Determinação da autoridade sanitária: quando a VISA ordena. Ajuste de inventário: para corrigir divergência e abrir inventário novo.
3. A justificativa é obrigatória quando o motivo é Ajuste de inventário. Escreva o que aconteceu de forma objetiva (por exemplo: divergência de lote apurada na contagem de 10/10).
4. Código verificador exibido na tela; digite exatamente.
5. Finalizar encerra a sua escrituração. Depois disso, quem assumir precisa abrir inventário novo. Nunca finalize "para testar".

5 Deseja realmente finalizar este inventário? [OK] [Cancelar]

SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (réplica didática, dados fictícios)

- Dados da Empresa
- Alterar Dados CRF
- Inventário Inicial
- Finalizar Inventário
- **Informar Ausência**
- Visualizar Inventário
- Transmissão de arquivos
- Relatórios
- Sair do Sistema

INFORMAR AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa:

DROGARIA EXEMPLO LTDA (dados fictícios)

1 **Data Início da Ausência:**

15/10/2026

2 **Data Final da Ausência:**

29/10/2026

Incluir Ausência

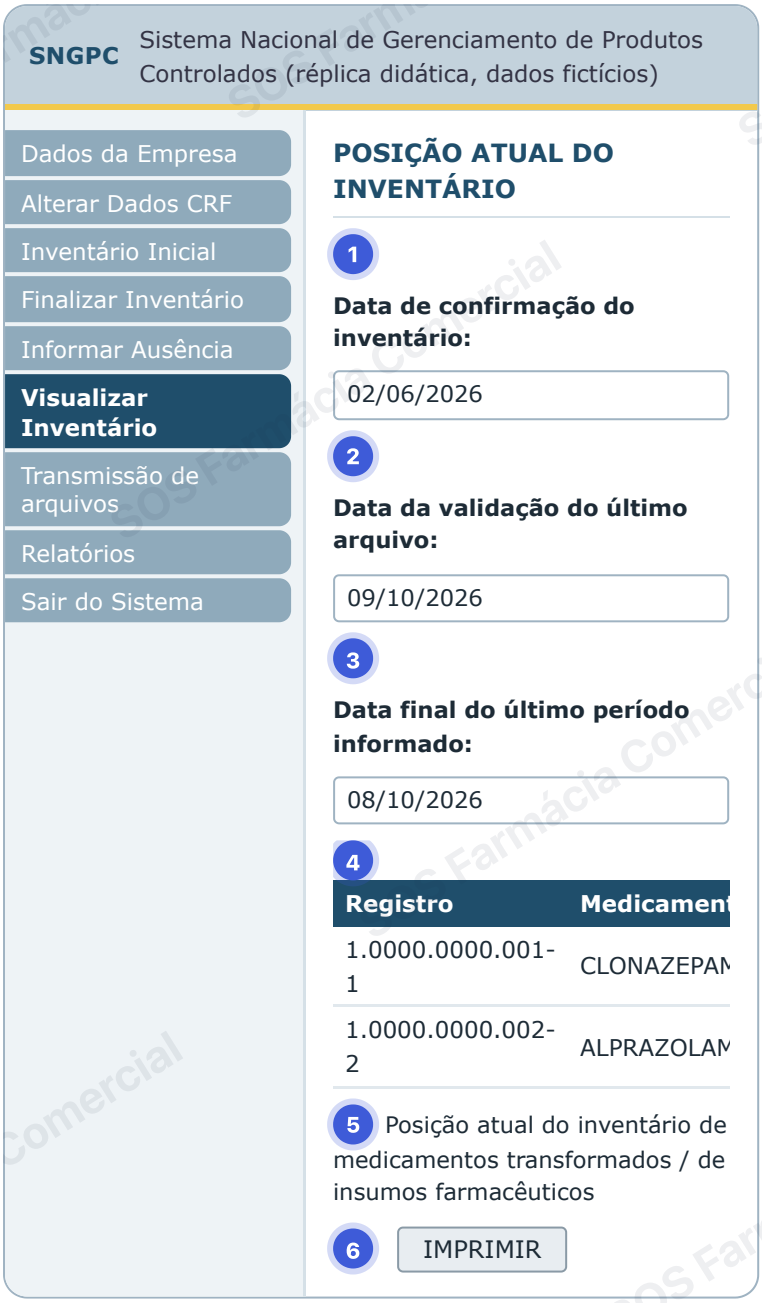
AUSÊNCIAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

3 Não foram localizados dados !!!

Informar Ausência

Registra um afastamento temporário do responsável técnico, com início e fim, sem encerrar o inventário.

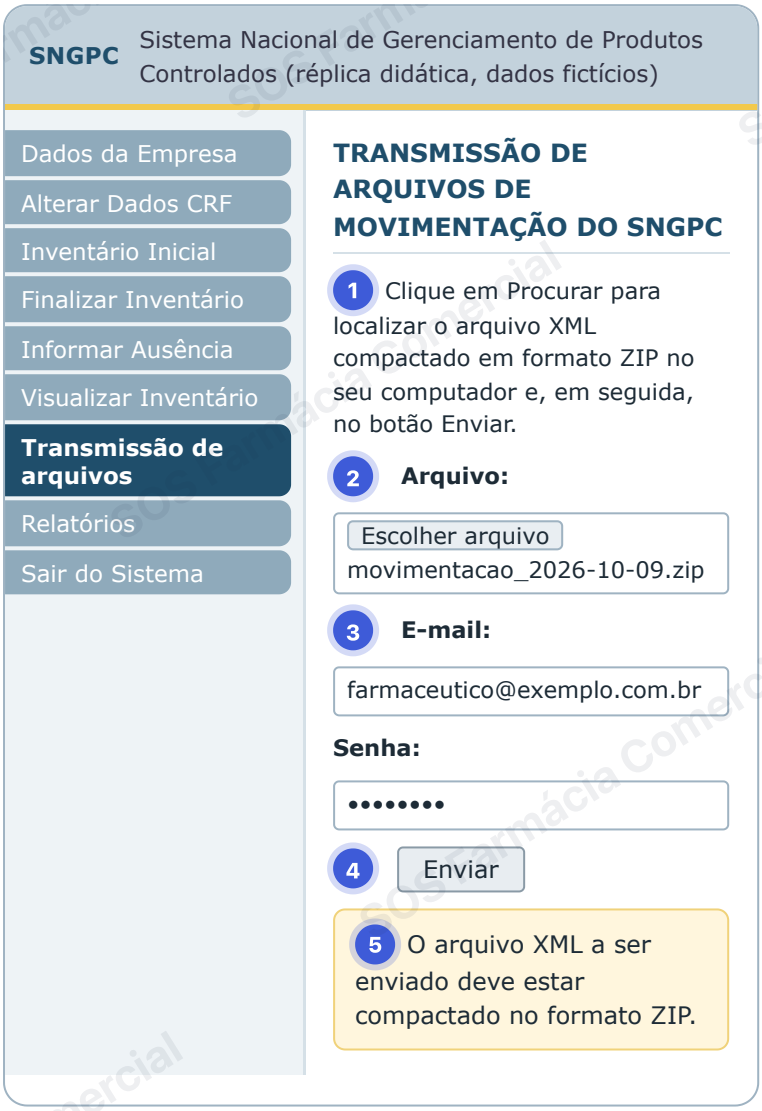
1. A data de início não pode ser anterior a hoje: a ausência é informada antes de acontecer, não depois.
2. O período tem no máximo 30 dias, o fim tem de ser depois do início e o novo período não pode começar antes do fim do último já cadastrado. Para afastamento maior, avalie a substituição (Finalizar Inventário com o motivo adequado).
3. Lista das ausências já informadas. Elas também aparecem no Histórico de Inventários.



Visualizar Inventário

É o estoque de controlados que a Anvisa enxerga hoje. Se não bate com a gaveta, há erro de escrituração.

1. Dia em que o inventário em curso foi confirmado.
2. Último arquivo que a Anvisa validou. Se estiver muito antiga, a farmácia está atrasada na transmissão.
3. Até que dia as movimentações já foram informadas. Compare com hoje: é o "atraso" da escrituração.
4. Saldo por apresentação. Passar o mouse mostra fabricante e classe; clicar abre a janela do medicamento com a escolha do lote. Use esta tela para conferir o estoque físico por amostragem toda semana.
5. Transformados e insumos só existem em farmácia com manipulação.
6. Imprime a posição para conferência ou para mostrar à fiscalização.



Transmissão de arquivos

Aqui se envia o arquivo de movimentação gerado pelo software da farmácia. Muitos softwares transmitem sozinhos; esta tela é o caminho manual.

1. O site não tem tela para digitar entradas e saídas. Toda movimentação sai do software de gestão em um arquivo XML no leiaute da Anvisa.
2. Escolha o arquivo .zip que o software gerou (o XML vai dentro do ZIP). Confira o período no nome ou no relatório do software antes de enviar.
3. E-mail e senha do farmacêutico que está transmitindo: a transmissão fica registrada em nome dele.
4. Enviar não significa aceito. O arquivo vai para validação; o resultado aparece em Relatórios > Status de Transmissão.
5. Mensagem que aparece se o arquivo não for ZIP. Outra mensagem comum: "Informar localização do arquivo compactado no formato ZIP" (nenhum arquivo escolhido).

Relatórios (submenu)

Ao clicar em Relatórios, o menu da esquerda muda para estas seis opções.

1. Certificado de transmissão regular: prova de que a farmácia está em dia. Histórico de Inventários: todos os inventários, com quem era RT e por que foram finalizados. Histórico de Movimentações: extrato por medicamento, lote e período. Certificado de Escrituração Digital: PDF de comprovação. Status de Transmissão: resultado de cada arquivo enviado. Voltar: retorna ao menu principal.

Relatórios > Status de Transmissão

A tela mais importante da rotina: confirma se o arquivo do dia foi validado e aceito.

1. Cada linha é um arquivo. Data inicial e final mostram o período de movimentação que ele cobre. "Validação executada = SIM" significa que a Anvisa já processou; "Foi aceito? = NÃO" significa que o arquivo foi recusado e nada daquele período entrou: corrija no software e envie de novo o mesmo período. O hash identifica o arquivo se você precisar falar com a VISA ou com o suporte do software.
2. Imprimir guarda o comprovante; Mais carrega os arquivos anteriores.

SOS Farmácia Comercial

SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (réplica didática, dados fictícios)

- **Certificado de transmissão regular**
- Histórico de Inventários
- Histórico de Movimentações
- Certificado Escrituração Digital
- Status de Transmissão
- Voltar

CONSULTAR CERTIFICADO DE TRANSMISSÃO REGULAR

Razão Social:

DROGARIA EXEMPLO LTDA (dados fictícios)

1 A referida empresa não está regular na transmissão de arquivos, estando impossibilitada de emitir o Certificado de Regularidade de Transmissão. A emissão do certificado só é possível após regularização da empresa junto ao SNGPC.

2

Data do último arquivo enviado:

21/09/2026

3 Nota: a empresa é considerada regular quando possui pelo menos quatro arquivos validados e aceitos nos últimos trinta dias e quando a data final do período de movimentação do último arquivo enviado for menor ou igual a dez dias da diferença da data de geração do certificado.

Relatórios > Certificado de transmissão regular

Emite o certificado de regularidade. Se a farmácia está atrasada, o sistema recusa e explica a regra.

1. Mensagem de quem está irregular. Quando está em dia, o sistema gera o certificado para imprimir.
2. Ajuda a ver há quanto tempo não se transmite.
3. A regra do próprio sistema: pelo menos 4 arquivos aceitos nos últimos 30 dias E o último período informado com no máximo 10 dias de atraso. Transmitir todo dia útil resolve as duas condições com folga.

Relatórios > Histórico de Inventários

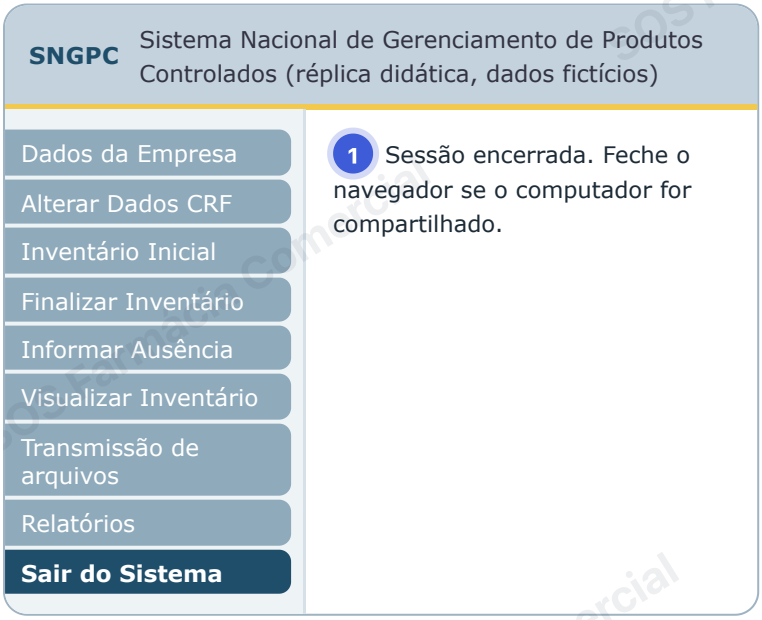
Linha do tempo da responsabilidade técnica no SNGPC: cada inventário, quem respondia e como terminou.

1. O inventário aberto aparece como "Inventário em andamento". Os anteriores mostram data de finalização, motivo e o RT da época. Também podem aparecer motivos gerados pelo sistema (por exemplo, alteração de RT feita pelo sistema de segurança).
2. Para cada inventário: a justificativa (quando houve ajuste), as ausências informadas e quantos itens havia no início e no fim. É o que a fiscalização olha numa troca de RT.

Relatórios > Histórico de Movimentações

Extrato de entradas e saídas, como um extrato bancário do medicamento. Serve para achar onde o estoque divergiu.

1. Em drogaria, escolha Medicamento. Insumo e Transformado são da farmácia de manipulação.
2. Período da consulta. A data de início não pode ser maior que a de fim.
3. Filtre pelo registro do medicamento (número do registro na Anvisa) e, se quiser, pelo lote ou pelo nome. Abaixo dos filtros aparece a lista dos medicamentos do inventário para ajudar a escolher.
4. Aparece quando o registro digitado não existe no seu inventário. Confira o número ou procure pelo nome.



Sair do Sistema

Encerra a sessão.

1. Sempre saia ao terminar, principalmente no computador do balcão. Sessões abertas permitem que outra pessoa transmita ou finalize em seu nome.

Primeiro dia como RT no SNGPC

Assumir a responsabilidade técnica: contrato assinado e RT registrado no CRF

Conferir no Cadastro de Empresas da Anvisa se o seu CPF está associado como responsável técnico

Pedir ao gestor de segurança o perfil de acesso ao SNGPC para o seu usuário

Entrar no SNGPC com e-mail e senha ou com o gov.br

DECISÃO

Há inventário em curso de outro RT?

SIM
Pedir ao RL que associe você; o inventário anterior é finalizado e você confere

NÃO
Seguir para a contagem do inventário inicial

Contar fisicamente controlados, antimicrobianos e GLP-1 por registro, lote e quantidade

Comparar contagem, saldo do software e inventário anterior

ATENÇÃO

Divergência de controlado sem explicação: corrigir antes de começar e comunicar a VISA

Gerar e transmitir o XML de inventário com a data da contagem (até 7 dias)

DECISÃO

Inventário aceito?

SIM
Imprimir o Certificado de Escrituração Digital

NÃO
Ler o motivo, corrigir e reenviar

Combinar com a equipe a rotina de lançamento e definir o horário do envio diário

Primeiro arquivo de movimentação enviado a partir da data do inventário

SOS Farmácia Comercial

Transmissão diária

Fim do expediente ou início do dia seguinte

Revisar pendências no software: saída sem lote, entrada sem nota, perda sem motivo

Conferir a data final do último arquivo aceito

Gerar o XML do período seguinte, sem lacuna e sem sobreposição

Transmitir e guardar a resposta com o hash

DECISÃO

O sistema respondeu?

SIM
Consultar Relatórios > Status de Transmissão

NÃO
Registrar a tentativa, guardar o comprovante e tentar mais tarde (art. 33)

DECISÃO

Arquivo aceito?

SIM
Anotar no controle diário e encerrar

NÃO
Ler o motivo, corrigir o lançamento na origem e reenviar o mesmo período

ATENÇÃO

Prazo de 7 dias se aproximando sem aceite: acionar suporte do software e documentar

Período registrado como aceito

Troca de responsável técnico

RT comunica a saída e a data do último dia

RT que sai transmite tudo até o último dia e confere o aceite

Levantamento do estoque de controlados até o último dia, apresentado à VISA (Portaria 6/1999, art. 113)

RT que sai finaliza o inventário no SNGPC (RDC 22/2014, art. 12)

Baixa da responsabilidade técnica no CRF e comunicação à VISA

RL associa o novo RT no cadastro e no SNGPC; gestor de segurança atribui o perfil

ATENÇÃO

Sem RT associado não há transmissão nem venda de controlados

Novo RT confere o inventário finalizado e conta o estoque

DECISÃO

Há divergência?

SIM

Corrigir o inventário antes de começar e informar a VISA (art. 12, § 2º)

NÃO

Seguir com o inventário conferido

Enviar o XML de inventário do novo RT e acompanhar até o aceite

Imprimir novo Certificado de Escrituração Digital e retomar os arquivos em ordem

Checklist de abertura (antes do primeiro envio)

- [ ] CNPJ ativo com CNAE de farmácia ou drogaria
- [ ] AFE publicada e licença sanitária local válida
- [ ] Cadastro da empresa na Anvisa completo em Verificar Cadastro
- [ ] RT associado no cadastro da empresa, com dados do CRF completos
- [ ] Gestor de segurança cadastrado e perfil do SNGPC atribuído ao RT
- [ ] E-mails distintos para empresa, RT, RL e gestor
- [ ] Acesso ao SNGPC testado com senha e com gov.br
- [ ] Software gera XML no padrão vigente, compactado em ZIP
- [ ] Fornecedor do software confirmou envio pela API da Anvisa
- [ ] Produtos cadastrados no software com registro e classe terapêutica corretos
- [ ] Contagem física completa assinada, por registro e lote
- [ ] Vencidos, avariados e recolhidos incluídos no inventário
- [ ] Inventário transmitido em até 7 dias da data da contagem
- [ ] Inventário aceito e conferido no sistema
- [ ] Certificado de Escrituração Digital impresso
- [ ] Acesso ao software de controlados restrito e perfis de digitação definidos
- [ ] Rotina de cópia de segurança do software configurada
- [ ] Pasta da fiscalização montada

Checklist diário do RT

- [ ] Conferir a situação do último arquivo enviado
- [ ] Receitas retidas do dia separadas por tipo e conferidas contra as saídas do software

- ◯ Notas de controlados recebidas lançadas com lote e CNPJ de destino conferidos
- ◯ Perdas do dia lançadas com motivo e documento
- ◯ Nenhum lote com saldo negativo no software
- ◯ Arquivo do período gerado sem lacuna nem sobreposição
- ◯ Arquivo transmitido e hash guardado
- ◯ Aceite confirmado ou recusa tratada no mesmo dia
- ◯ Controle diário de arquivos preenchido e rubricado
- ◯ Receitas eletrônicas do SNCR com uso registrado
- ◯ Armário de controlados trancado e chave sob controle do farmacêutico
- ◯ Contagem por amostragem dos itens de maior giro no dia programado

Erro ou recusa: causa provável e correção

Erro ou recusa	Causa provável	Como corrigir
Inventário recusado: data informada deve ser anterior ao máximo sete dias da transmissão	Contagem antiga demais	Refazer a contagem e enviar inventário com data de até 7 dias antes do envio (NT 003/2013)
Lote não encontrado nem no inventário inicial nem nas transações de entrada	Lote digitado diferente, com espaço ou caractere trocado; entrada não transmitida	Conferir o lote na caixa e na entrada; corrigir; se o erro estiver no inventário, finalizar e reenviar (NT 003/2013, item 12)
Medicamento de entrada: não é possível inserir classe terapêutica distinta	Produto cadastrado com classe errada (controlado como antimicrobiano ou o inverso)	Corrigir o cadastro no software e finalizar o inventário para ajuste (NT 003/2013, item 6)
Número de notificação deve ser informado para tipo de receituário 2, 3 e 4	Notificação B, Especial ou A lançada sem número	Lançar o número da notificação retida e reenviar (NT 003/2013, item 8.1)
CNPJ de destino não pode ser diferente do CNPJ de transmissão	Nota fiscal de outra loja ou digitação errada	Conferir a nota; lançar com o CNPJ do estabelecimento; nota de outra filial exige transferência formal (NT 003/2013, item 8.2)

Erro ou recusa	Causa provável	Como corrigir
Arquivo XML inválido: existem caracteres não UTF-8	Software inclui caractere fora da codificação aceita	Chamado ao suporte do software com a mensagem (NT 003/2013, item 8.3)
Uso humano: conselho deve ser CRM ou CRO e não CRMV	Receita veterinária lançada como uso humano	Marcar uso veterinário e conselho CRMV; não informar paciente (NT 003/2013, item 8.4)
Mensagem técnica de elemento inválido no XML	Arquivo fora do esquema da Anvisa	Suporte do software analisa e corrige o gerador (NT 003/2013, item 8.6)
Recusa por falta de estoque do produto ou lote	Entrada não enviada, saída em lote errado ou movimento duplicado	Consultar o histórico de movimentações; corrigir na origem e reenviar (Perguntas e Respostas 2021, pergunta 7)
Saída de antimicrobiano recusada após 10 dias da prescrição	Receita vencida ou controlado cadastrado como antimicrobiano	Não dispensar receita vencida; se a classe estiver errada, ajustar o inventário (NT 003/2013, item 6)
CPF sem perfil para acesso ao SNGPC	Perfil não atribuído ou vínculo incompleto	Gestor de segurança atribui o perfil; persistindo, central da Anvisa (NT 003/2013, item 2)
Acesso só permitido a empresas com CNAE de farmácia ou drogaria	CNAE errado no cadastro ou instabilidade	Conferir CNAE; se estiver certo, tratar como instabilidade (NT 003/2013, item 2)
An attack was detected, originating from your system	IP bloqueado pela segurança da Anvisa	Pedir desbloqueio do IP à Anvisa (NT 003/2013, item 8.5)
Time out, Service Unavailable, HTTP 500 no acesso	Instabilidade do SNGPC	Tentar mais tarde, guardar prova da tentativa e protocolo (RDC 22/2014, art. 33)
Medicamento não localizado na base da Anvisa	Inconsistência cadastral do produto	Notificar inconsistência no SNGPC; escriturar no software até a correção (RDC 22/2014, art. 14)
Novo arquivo não liberado	Arquivo anterior ainda não aceito ou recusado	Resolver o anterior e só depois enviar o seguinte (CFF, 2025)

Mensagens transcritas ou resumidas de documentos oficiais da Anvisa (Nota Técnica 003/2013; Perguntas e Respostas sobre instabilidade do SNGPC, 2021). O texto exato na tela pode variar com a versão do sistema.

Prazos e periodicidades do SNGPC

Obrigação	Prazo ou periodicidade	Norma
Transmissão do XML de movimentação	Arquivos de 1 a 7 dias consecutivos, mesmo sem movimento	RDC 22/2014, art. 10, § 3º

Obrigação	Prazo ou periodicidade	Norma
Atualização mínima da transmissão	Uma vez por semana	RDC 22/2014, art. 10, § 4º
Data do XML de inventário	Até 7 dias antes da transmissão	Nota Técnica 003/2013; Guia SNGPC 2.3
Cópia de segurança da escrituração	Guardar por 2 anos	RDC 22/2014, art. 19, I
Documentos de movimentação de controlados	Guardar por 2 anos	Portaria 344/1998, art. 64
Documentos de antimicrobianos e GLP-1	Guardar por 2 anos	RDC 471/2021, art. 22
Escrituração em livro (sem internet ou farmácia pública com ressarcimento)	Até 7 dias da dispensação	RDC 471/2021, arts. 14, parágrafo único, e 15
Receita de antimicrobiano	Válida por 10 dias	IN 360/2025, art. 1º, § 2º
Receita de agonista de GLP-1	Válida por 90 dias	IN 360/2025, art. 2º, § 1º
Uso prolongado (antimicrobiano e GLP-1)	Até 90 dias, com quantidade para cada 30 dias	RDC 471/2021, art. 9º
Funcionamento sem farmacêutico	Até 30 dias, sem venda de controlados	Lei 5.991/1973, art. 17
BMPO	Trimestral até o dia 15 do mês seguinte ao trimestre; anual até 31 de janeiro	Portaria 344/1998, art. 69
RMNRA	Mensal, até o dia 15	Portaria 344/1998, art. 72
Obrigatoriedade regional da transmissão	Sudeste 1º/09/2025; Sul e Norte 1º/11/2025; Centro-Oeste e Nordeste 02/01/2026	Anvisa, 05/05/2025; RDC 586/2021, art. 5º

Escrituração e transmissão no SNGPC

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Escrituração e transmissão no SNGPC**	Código: **POP-SNGPC-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Escriturar toda movimentação de controlados, antimicrobianos e agonistas de GLP-1 e transmitir ao SNGPC dentro do prazo, com estoque físico igual ao escriturado.

Abrangência

Entradas, dispensações, perdas e transferências de medicamentos sujeitos ao SNGPC na drogaria; todos os dias de funcionamento.

Responsáveis

- Farmacêutico RT: geração e envio dos arquivos, conferência e correções
- Farmacêutico substituto cadastrado e associado: mesmas funções na ausência do RT
- Equipe de balcão e estoque: digitação no software com perfil delegado pelo RT
- Responsável legal: cadastro da empresa, associação do RT e software adequado

Materiais

- Software de gestão que gera XML no padrão SNGPC
- Acesso pessoal do RT ao SNGPC (senha ou gov.br)
- Notas fiscais, receitas e notificações retidas
- Controle diário de arquivos (período, envio, hash, situação)
- Folha de contagem

Procedimento

1. Conferir cada entrada contra a nota fiscal: produto, lote, validade, quantidade e CNPJ de destino.
2. Lançar a entrada no software no dia do recebimento, com lote igual ao da embalagem e classe terapêutica correta.
3. Na dispensação, avaliar a receita; na receita eletrônica numerada, consultar e registrar o uso no SNCR.
4. Lançar a saída com tipo de receituário, número da notificação quando exigido, prescritor com conselho e UF, lote e quantidade em caixas ou frascos.
5. Lançar comprador para controlados e paciente com idade e sexo para antimicrobianos e GLP-1.
6. Anotar a dispensação na receita, conforme o tipo, e reter a via devida.
7. Lançar perdas com o motivo e anexar o documento que justifica.
8. Ao fim do dia, conferir as receitas retidas contra as saídas do software.

9. Conferir no SNGPC a data final do último arquivo aceito (Visualizar Inventário, campo Data final do último período informado).
10. Gerar o XML do período seguinte, sem lacuna nem sobreposição, e transmitir.
11. Guardar a resposta de recebimento com o hash e anotar no controle diário.
12. Consultar Relatórios > Status de Transmissão até o aceite.
13. Em caso de recusa, corrigir o lançamento na origem e reenviar o mesmo período no mesmo dia.
14. Fazer contagem cega semanal dos itens de maior giro e comparar com software e SNGPC.
15. Registrar e comunicar à VISA divergências sem explicação documental.

Cuidados

- Senha do SNGPC é pessoal; não salvar no computador nem compartilhar
- Nunca enviar arquivo novo antes do aceite do anterior
- Não ultrapassar 7 dias entre arquivos, mesmo sem movimento
- Instabilidade do SNGPC: guardar prova da tentativa e protocolo
- Finalização de inventário só por motivo previsto e com justificativa

Registros

- Controle diário de arquivos transmitidos
- Folhas de contagem assinadas
- Certificado de Escrituração Digital
- Protocolos de chamados na Anvisa e comunicações à VISA
- Cópia de segurança do software (2 anos)

Referências

- RDC 22/2014
- Portaria SVS/MS 344/1998
- RDC 471/2021 com a RDC 973/2025
- IN 360/2025
- RDC 1.000/2025
- Guia para geração do padrão de transmissão SNGPC, versão 2.3
- Nota Técnica 003/2013

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Cartões do SNGPC

Pergunta	Resposta
Qual norma regula o SNGPC?	RDC 22/2014, vigente e sem alterações no texto consolidado.

Pergunta	Resposta
Intervalo de cada arquivo de movimentação	De 1 a 7 dias consecutivos, mesmo sem movimento (art. 10, § 3º).
O que é credenciamento no SNGPC?	Adesão do estabelecimento pelo envio do inventário inicial pelo RT (art. 5º, IV, e art. 8º).
Documento impresso após o credenciamento	Certificado de Escrituração Digital (art. 9º).
Quem gera e envia os arquivos XML?	O farmacêutico RT ou o substituto cadastrado e associado (art. 18, § 2º).
Data máxima do XML de inventário	Até 7 dias antes da transmissão do arquivo.
O que precede a troca de RT no SNGPC?	A finalização do inventário (art. 12).
Unidades de medicamento no SNGPC	Caixa ou frasco; a quantidade é o número de embalagens.
Comprador ou paciente?	Comprador para Portaria 344; paciente com idade e sexo para antimicrobianos e GLP-1.
Tipos de receituário que exigem número de notificação	2 (Notificação B), 3 (Notificação Especial) e 4 (Notificação A).
Situações do arquivo	Recebido, validado e aceito; ou recusado.
Quando o SNGPC voltou a ser obrigatório no Nordeste?	Em 02/01/2026.
Instabilidade do SNGPC gera autuação por atraso?	Não, se o motivo for estritamente a falha do sistema (art. 33).
Como corrigir estoque errado já aceito?	Finalizar o inventário por ajuste, com justificativa, e enviar novo inventário.
Lei das penalidades sanitárias	Lei 6.437/1977; multa de R$ 2.000 a R$ 1.500.000 conforme a gravidade.

Questões sobre o SNGPC

1. Drogaria em Recife transmitiu o último arquivo aceito com período até quinta-feira, dia 8. Não houve venda de controlados nos dias seguintes. Pela RDC 22/2014, a conduta correta é:

A Aguardar a próxima venda de controlado para então transmitir

B Transmitir arquivo sem movimento em até 7 dias

C Transmitir só no fim do mês, junto com a RMNRA da loja

D Transmitir apenas quando a VISA local solicitar

E Dispensar o envio, porque o Nordeste está fora do cronograma

2. Farmacêutica assume uma drogaria e descobre que o RT anterior saiu sem finalizar o inventário. O que permite a ela começar a transmitir?

A Usar a senha do RT anterior até o fim do mês corrente

B Enviar os arquivos de movimentação dentro do inventário dele

C Pedir ao RL que a associe no SNGPC e conferir o inventário

D Abrir nova empresa, com outro CNPJ, para começar do zero

E Mandar o inventário por e-mail à Anvisa para registro

3. Arquivo recusado com a mensagem de que o lote não foi encontrado nem no inventário inicial nem nas transações de entrada. A causa mais provável a investigar primeiro é:

A Grafia do lote diferente entre entrada e saída

B Receita de controle especial apresentada vencida

C Instabilidade momentânea do próprio SNGPC

D Ausência do CID na receita do paciente

E CNAE da drogaria desatualizado no cadastro

4. Sobre a unidade de medida de medicamento industrializado no arquivo do SNGPC, é correto afirmar:

A Deve ser informada em comprimidos ou mililitros

B Deve ser informada em miligramas do princípio ativo

C É livre, desde que constante em todo o arquivo

D É informada em caixas ou frascos

E Só é exigida para antimicrobianos

5. Na dispensação de amoxicilina com receita de antimicrobiano, quais dados de identificação são obrigatórios no arquivo do SNGPC?

A Nome e documento de identidade do comprador

B Nome, idade e sexo do paciente

C CPF do paciente e também do comprador

D Apenas o número do CRM do prescritor

E CID da doença e endereço do paciente

6. Uma drogaria descobre que um arquivo já aceito baixou 3 caixas de alprazolam quando foram vendidas 2. O estoque oficial ficou menor que o físico. Segundo a orientação da Anvisa, o caminho é:

A Enviar outro arquivo com entrada fictícia de 1 caixa

B Vender uma caixa sem escriturar para igualar os estoques

C Aguardar a próxima fiscalização e explicar ao fiscal

D Finalizar o inventário por ajuste e enviar novo inventário

E Excluir o arquivo aceito usando o próprio software da loja

7. Durante três dias o SNGPC apresentou erro HTTP 500 no login e a drogaria passou do prazo de 7 dias. Qual a situação?

A Infração automática, porque o prazo de 7 dias é absoluto

B Escrituração em livro, de forma definitiva, a partir de então

C Envio do arquivo por e-mail para garantir a data

D Suspensão da venda de antimicrobianos até o retorno do sistema

E Sem autuação por instabilidade comprovada; guardar provas

8. Em relação ao alcance do SNGPC, assinale a alternativa correta:

A Farmácias de hospital escrituram no SNGPC desde 2014

B Drogarias privadas escrituram apenas os itens da Portaria 344

C GLP-1 é escriturado no padrão XML dos antimicrobianos

D Farmácias de manipulação estão dispensadas do sistema

E A lista de antimicrobianos fica na própria Portaria 344

9. Ao lançar a entrada de clonazepam, o arquivo é recusado porque o CNPJ de destino é diferente do CNPJ de transmissão. A nota foi emitida para a matriz e a mercadoria chegou na filial. A conduta é:

A Trocar o CNPJ de destino no software para o da filial

B Não lançar a entrada, pois a mercadoria já está na prateleira

C Lançar a quantidade como perda no estoque da matriz

D Pedir à VISA que altere o CNPJ que consta na nota

E Entrar na matriz e transferir à filial com nota fiscal

10. O farmacêutico RT vai tirar 15 dias de férias e a drogaria tem substituto. Para o SNGPC, a providência correta é:

A Substituto cadastrado e associado, com passagem pelo art. 12

B Substituto usando o login do RT durante as férias

C Suspensão das transmissões durante os 15 dias de férias

D Autorização da VISA para uso de livro no período

E Transmissão pelo RT, de casa, com o gov.br do gerente

11. Na inspeção, a VISA encontra 12 caixas de metilfenidato e o SNGPC mostra 14. O arquivo da véspera, com 2 saídas, foi enviado hoje e ainda não foi aceito. Qual dispositivo orienta a avaliação?

A Lei 5.991/1973, art. 17, caput

B RDC 471/2021, art. 9º, § 1º

C RDC 22/2014, art. 36, parágrafo único

D Portaria SVS/MS 344/1998, art. 73

E Lei 6.437/1977, art. 4º, inciso II

Gabarito comentado

1. **B**. O art. 10, § 3º, da RDC 22/2014 manda transmitir em arquivos de 1 a 7 dias consecutivos, ainda que não haja movimentação. Esperar venda, enviar mensalmente ou só a pedido da VISA descumpre o prazo. O Nordeste está obrigado desde 02/01/2026.
2. **C**. A senha é pessoal e intransferível (art. 7º). Quando o RL associa o novo RT, o inventário anterior é finalizado automaticamente (Perguntas e Respostas Anvisa, 2021, pergunta 9). Depois, a nova RT confere, corrige divergências, informa a VISA (art. 12) e envia o próprio inventário. Arquivo por e-mail não tem valor.
3. **A**. A Nota Técnica 003/2013 (item 12) explica que o sistema compara o lote como texto exato: 'ABC ' é diferente de 'ABC'. Receita vencida não gera essa mensagem; o CID é opcional; CNAE e instabilidade afetam o acesso, não a saída de um lote específico.
4. **D**. O Guia para geração do padrão SNGPC (versão 2.3) prevê para medicamentos as unidades 1 (caixas) e 2 (frascos). Grama, mililitro e unidade são unidades de insumos da manipulação. A unidade é exigida em todas as operações e classes.
5. **B**. Pelo Guia SNGPC 2.3, para a classe antimicrobiano os dados do paciente (nome, idade, sexo) são obrigatórios; os do comprador, não. Para a Portaria 344 é o inverso. O CID é opcional. Os mesmos padrões valem para agonistas de GLP-1 (Perguntas e Respostas GLP-1, 2025).
6. **D**. A RDC 22/2014 não prevê edição de movimento já integrado. A Anvisa documentou a finalização do inventário pela opção de ajuste, com justificativa, seguida de novo XML de inventário (Perguntas e Respostas, 2021). Entrada fictícia e venda sem escrituração são infrações; esperar a fiscalização mantém a divergência (art. 15).
7. **E**. O art. 33 da RDC 22/2014 afasta a autuação quando a falta de regularidade decorre estritamente de instabilidade do SNGPC. A Nota Técnica 003/2013 orienta guardar prova da tentativa e protocolo. Livro só com autorização da VISA em município sem internet (art. 35, § 1º); e-mail não vale; a venda continua com escrituração no software.
8. **C**. A RDC 973/2025 e a IN 360/2025 incluíram os agonistas de GLP-1 na RDC 471/2021, com retenção de receita e escrituração; a Anvisa orientou seguir o padrão XML dos antimicrobianos. Hospitalares e públicas estão fora (RDC 22/2014, art. 3º, parágrafo único); manipulação está incluída (art. 10, § 5º); a lista de antimicrobianos está na IN 360/2025.
9. **E**. O SNGPC exige que o destino da entrada seja o CNPJ transmissor (Nota Técnica 003/2013, item 8.2). Mercadoria faturada para a matriz entra na matriz; a passagem à filial da mesma raiz de CNPJ é transferência, com nota (RDC 22/2014, art. 5º, XXXI). Alterar o CNPJ no software falseia o documento fiscal.
10. **A**. A escrituração pode ser feita pelo substituto devidamente cadastrado e associado no SNGPC (art. 10, § 1º), e a substituição eventual também é precedida de finalização do inventário (art. 12). Senha é pessoal (art. 7º); suspender transmissões descumpre o art. 10; livro só no caso do art. 35, § 1º.
11. **C**. O parágrafo único do art. 36 manda a autoridade considerar, na divergência entre estoque físico e SNGPC, a existência de arquivos não enviados ou não validados dentro do prazo. O art. 17 da Lei 5.991 trata da ausência do RT; o art. 9º da RDC 471, do uso prolongado; o art. 73 da 344, dos balanços; o art. 4º da Lei 6.437, da classificação das infrações.

Telas do SNGPC: pergunta do dia a dia e onde responder

Pergunta	Caminho no site	O que olhar
O arquivo de ontem entrou?	Relatórios > Status de Transmissão	Período, Validação executada e Foi aceito?

Pergunta	Caminho no site	O que olhar
Estamos em dia com a Anvisa?	Relatórios > Certificado de transmissão regular	Certificado emitido ou mensagem de irregularidade
O estoque oficial bate com a gaveta?	Visualizar Inventário	Qtd por apresentação e lote; datas do último arquivo
Onde está a saída que sumiu?	Relatórios > Histórico de Movimentações	Filtro por registro, lote e período
Quem era RT em tal data?	Relatórios > Histórico de Inventários	Datas, motivo da finalização, RT
Meu nome está vinculado?	Dados da Empresa	Lista de responsáveis técnicos com acesso
Vou me afastar alguns dias	Informar Ausência	Início a partir de hoje, até 30 dias
Vou deixar a farmácia	Finalizar Inventário	Motivo, código verificador, confirmação

Cartões: as telas do SNGPC

Pergunta	Resposta
Onde se digita uma dispensação de controlado?	No software de gestão; o SNGPC recebe o XML
Formato do arquivo na transmissão manual	XML compactado em ZIP
Onde ver se o arquivo foi aceito?	Relatórios > Status de Transmissão (Foi aceito? SIM/NÃO)
O que acontece ao confirmar o inventário inicial?	Ele não pode mais ser modificado
Motivo de finalização que exige justificativa	Ajuste de inventário
Período máximo de uma ausência informada	30 dias, com início a partir de hoje
Regra do certificado de transmissão regular	4 arquivos aceitos em 30 dias e último período até 10 dias
Onde investigar divergência de estoque?	Relatórios > Histórico de Movimentações, por registro e lote
O que mostra Visualizar Inventário?	O estoque oficial e as datas do último arquivo e do último período
Para que serve Dados da Empresa?	Conferir cadastro, AFE e quem é RT com acesso

Questões sobre as telas do SNGPC

1. Recém-formada quer registrar no site do SNGPC a venda de uma caixa de clonazepam feita hoje. Onde ela faz isso?

A Em Inventário Inicial, somando a saída ao estoque do dia anterior

B No software de gestão da farmácia, que gera o XML transmitido ao SNGPC

C Em Visualizar Inventário, editando a quantidade do lote vendido

D Em Informar Ausência, registrando a saída feita fora do horário do RT

E Em Dados da Empresa, na área de movimentação do responsável técnico

2. Em Relatórios > Status de Transmissão, o arquivo de ontem aparece com "Validação executada: SIM" e "Foi aceito?: NÃO". O que isso significa?

A O arquivo foi aceito, mas com observações que devem ser lidas no histórico

B O arquivo ainda não foi processado e deve ser reenviado no dia seguinte

C O arquivo foi recusado e o período não entrou no estoque oficial

D O inventário foi finalizado automaticamente por falta de transmissão regular

E A farmácia teve o certificado de regularidade suspenso pelos próximos 30 dias

3. Segundo a regra exibida no próprio SNGPC, quando a farmácia consegue emitir o Certificado de transmissão regular?

A Um arquivo validado e aceito por mês, enviado até o quinto dia útil

B Quatro arquivos aceitos em 30 dias e último período com até 10 dias

C Inventário inicial confirmado, independentemente das transmissões feitas

D Somente depois de inspeção presencial da vigilância sanitária local

E Um arquivo enviado nos últimos 10 dias, mesmo que tenha sido recusado

4. O RT vai tirar 12 dias de folga a partir da semana que vem e não haverá outro farmacêutico assumindo a escrituração. Qual tela registra isso?

A Finalizar Inventário com o motivo Férias, abrindo novo inventário na volta

B Alterar Dados CRF, registrando o período de afastamento na carteira

C Informar Ausência, com data de início futura e fim até 30 dias depois

D Transmissão de arquivos, enviando um arquivo vazio para cada dia de folga

E Inventário Inicial, confirmando de novo o estoque no dia do retorno

5. Ao conferir o inventário inicial que veio do software, o farmacêutico percebe um lote com quantidade errada. O que fazer?

A Confirmar e corrigir depois a quantidade em Visualizar Inventário

B Não confirmar; corrigir no software, gerar o arquivo de novo e então confirmar

C Confirmar e informar ausência até o suporte do software corrigir o lote

D Confirmar e finalizar no mesmo dia pelo motivo Licença, sem justificativa

E Confirmar e enviar e-mail à Anvisa pedindo a edição do inventário confirmado

6. Na tela Finalizar Inventário, qual motivo exige o preenchimento da justificativa?

A Férias

B Licença

C Encerramento das atividades com produtos controlados

D Ajuste de inventário

E Substituição temporária de Responsável Técnico

Gabarito comentado

1. **B**. O site não tem tela de digitação de movimentações. Entradas e saídas são escrituradas no software de gestão, que gera o arquivo XML enviado ao SNGPC (pelo próprio software ou em Transmissão de arquivos). As outras telas servem para confirmar inventário, consultar estoque, registrar ausência e ver o cadastro.
2. **C**. Validação executada SIM indica que a Anvisa processou o arquivo; Foi aceito NÃO indica recusa. Nada daquele período entrou: é preciso corrigir no software e reenviar o mesmo período. Não há aceite parcial nem finalização automática.
3. **B**. A nota da tela de certificado define regularidade pelas duas condições: quatro arquivos validados e aceitos nos últimos 30 dias e último período informado até dez dias da data de geração. Arquivo recusado não conta, e o inventário confirmado sozinho não basta.
4. **C**. Informar Ausência registra afastamento temporário sem encerrar o inventário; o formulário só aceita início a partir de hoje e período de até 30 dias. Finalizar Inventário encerra a escrituração e serve quando outro farmacêutico assume ou o RT sai.
5. **B**. A própria tela avisa que o inventário confirmado não pode ser modificado. O erro se corrige antes, na origem (software). Depois de confirmado, só resta finalizar por ajuste de inventário com justificativa e abrir outro.
6. **D**. O formulário só obriga a justificativa quando o motivo é Ajuste de inventário, porque é a finalização usada para corrigir divergência e o registro precisa explicar o que aconteceu.

Módulo 6

Vigilância sanitária na farmácia: balanços, BMPO e relação mensal

A relação do farmacêutico com a vigilância sanitária em outubro de 2026: licença, inspeção, termos e processo da Lei 6.437/1977, livro de registro e guarda de documentos, balanços BMPO e BSPO, RMNRA, RMNRB2 e demais relações da Portaria SVS/MS 344/1998 e da Portaria SVS/MS 6/1999 com o SNGPC obrigatório em todo o país, calendário de obrigações do RT, farmacovigilância (VigiMed e Notivisa) e recolhimentos (RDC 44/2009, RDC 22/2014, RDC 625/2022).

- Sistema de vigilância sanitária e licenciamento
- Inspeção sanitária na farmácia
- Termos fiscais e processo administrativo sanitário
- Livro de registro e guarda de documentos
- Balanços BMPO e BSPO
- RMNRA e demais relações periódicas
- Calendário de obrigações do responsável técnico
- Farmacovigilância, queixa técnica e alertas sanitários

Sistema de vigilância sanitária e licenciamento

A **vigilância sanitária** é o conjunto de ações do SUS capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde ligados à produção e à circulação de bens e à prestação de serviços (Lei 8.080/1990, art. 6º, § 1º). Para a farmácia, isso significa que alguém de fora vai conferir, com poder de polícia, se a loja guarda, vende e registra medicamentos do jeito que a norma manda. Esse alguém é a VISA.

Quem é quem no sistema

O **Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)** reúne órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que regulam, normatizam, controlam e fiscalizam na área (Lei 9.782/1999, art. 1º). Cada esfera tem um papel diferente na vida da farmácia.

Esfera	Órgão	O que faz para a farmácia
Federal	Anvisa	Edita as RDC e as listas da Portaria 344, concede a AFE e a AE, mantém o SNGPC, o SNCR, o VigiMed e o Notivisa, publica alertas e determina recolhimentos
Estadual	VISA estadual (secretaria de saúde)	Fiscaliza onde a ação não foi descentralizada, coordena os municípios, recebe balanços em alguns estados
Municipal	VISA municipal	Na maioria das cidades: licença sanitária, inspeção de rotina, recebimento de balanços e relações, visto em receitas de emergência, abertura de livros

Quem inspeciona a sua loja depende da pactuação entre estado e município. Em São Paulo capital, por exemplo, a COVISA municipal recebe balanços e relações de drogarias pelo portal SP156 (Nota Técnica 03/DVPSIS/COVISA/2021); em Minas Gerais, o estado orienta procurar primeiro a VISA municipal para saber a quem cabe a fiscalização e só então peticionar no SEI estadual. Por isso, a primeira tarefa do RT novo é descobrir **qual VISA tem competência sobre a loja** e por qual canal ela recebe documentos.

Documentos que a farmácia precisa ter

A RDC 44/2009 (art. 2º) lista o que deve existir no estabelecimento:

- Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), concedida pela Anvisa.
- Autorização Especial (AE), para farmácias, quando aplicável (a farmácia de manipulação que trabalha com substâncias da Portaria 344 precisa dela).
- Licença ou alvará sanitário, expedido pela VISA estadual ou municipal.
- Certidão de Regularidade Técnica, emitida pelo CRF.
- Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, próprio da loja.

A licença sanitária e a Certidão de Regularidade Técnica ficam afixadas em local visível ao público (art. 2º, § 1º). Se esses documentos não trouxerem razão social, CNPJ, número da AFE e da AE, nome e CRF do RT

e dos substitutos, horário de cada farmacêutico e telefones do CRF e das VISAs, a loja precisa de um cartaz com essas informações (art. 2º, § 2º).

PONTO-CHAVE

A AFE é federal e única para a empresa naquele endereço; a licença sanitária é local e tem validade e rito definidos pelo código sanitário do estado ou do município. Uma não substitui a outra.

Licença sanitária

A licença (em alguns lugares chamada alvará sanitário, cadastro sanitário ou CMVS) é o ato da VISA local que autoriza aquele estabelecimento a funcionar. A norma federal manda tê-la, mas quem define validade, documentos para concessão e renovação, taxa e necessidade de inspeção prévia é a legislação do estado ou do município. Confirme a validade e o prazo de renovação no código sanitário da sua cidade.

Na prática, os pedidos de concessão e renovação costumam exigir: requerimento do responsável legal, contrato social e CNPJ, comprovante de AFE, Certidão de Regularidade Técnica do CRF, planta ou croqui, Manual de Boas Práticas e POPs, plano de gerenciamento de resíduos e comprovante de controle de pragas. Algumas VISAs passaram a pedir também o Certificado de Transmissão Regular do SNGPC.

ATENÇÃO

Funcionar sem licença ou com licença vencida é infração da Lei 6.437/1977 (art. 10, IV: armazenar, comprar ou vender medicamentos sem licença ou autorização do órgão sanitário competente) e pode levar a interdição. Em vários municípios, o protocolo de renovação feito dentro do prazo serve de comprovante enquanto a VISA analisa (a capital paulista, por exemplo, aceita o protocolo de renovação do cadastro sanitário para abrir livros); confirme a regra local.

O que mudou com o SNGPC em todo o país

Desde 02/01/2026, com o fim do escalonamento regional, a transmissão ao SNGPC é obrigatória em todas as regiões (detalhes nos módulos da Portaria 344/98 e do SNGPC). Para a VISA, isso significa enxergar no sistema, de qualquer lugar, o estoque oficial de controlados de cada loja da sua área. Para o RT, significa que a inspeção já começa com o fiscal sabendo o que deveria estar no armário. O SNGPC substituiu o livro de registro das farmácias e drogarias privadas (RDC 22/2014, art. 35), mas **não revogou** os balanços e as relações periódicas da Portaria 344, que seguem exigidos na forma que cada VISA define (tópicos seguintes).

NO BALCÃO

No primeiro dia como RT, fotografe e arquive a licença, a AFE, a AE (se houver) e a certidão do CRF, anote as datas de vencimento e descubra o canal da VISA da sua cidade para protocolos, balanços e dúvidas (e-mail, portal, SEI ou balcão). Guarde esse contato no POP de documentação.

CASO

Farmacêutica assume drogaria em Sobral (CE). A licença afixada venceu há dois meses e o dono diz que "a renovação é automática". Ela consulta a VISA municipal, descobre que a renovação depende de requerimento e inspeção, protocola no mesmo dia e guarda o comprovante na pasta da fiscalização. Na inspeção seguinte, o fiscal lavra apenas notificação para apresentar a licença renovada em prazo.

Inspeção sanitária na farmácia

Inspeção sanitária é a visita da autoridade sanitária ao estabelecimento para verificar, no local, se as normas estão sendo cumpridas. Ela pode ser de rotina (programada pela VISA), para concessão ou renovação de licença, por denúncia, para apurar notificação de queixa técnica ou por demanda da Anvisa, como um recolhimento. Em geral não é avisada com antecedência.

Base do que o fiscal confere

O fiscal usa um roteiro, que varia entre estados e municípios, mas sai das mesmas normas federais:

Área	O que costuma ser verificado	Norma
Documentos	AFE, AE, licença, certidão do CRF afixadas; cartaz informativo	RDC 44/2009, art. 2º
Responsável técnico	Farmacêutico presente em todo o horário de funcionamento	RDC 44/2009, art. 3º; Lei 13.021/2014, art. 6º, I
Manual e POPs	Manual próprio; POPs aprovados, assinados e datados pelo RT; registro de divulgação à equipe	RDC 44/2009, arts. 85 a 88
Treinamentos	Registros de treinamento inicial e continuado	RDC 44/2009, arts. 24 a 28
Armazenamento	Produtos afastados de piso, parede e teto; temperatura da geladeira medida e registrada diariamente	RDC 44/2009, arts. 35 e 36
Vencidos e suspeitos	Segregados, fora da área de dispensação, identificados quanto à condição e ao destino	RDC 44/2009, art. 38
Controlados	Armário ou sala com chave, sob guarda do farmacêutico; estoque físico igual ao SNGPC; receitas retidas	Portaria 344, art. 67; RDC 44, art. 37; RDC 22/2014, art. 15
Escrituração	Certificado de Escrituração Digital, transmissões em dia, cópia de segurança	RDC 22/2014, arts. 9º, 10 e 19
Balanços e relações	Comprovantes de entrega de BMPO, BSPO, RMNRA e RMNRB2	Portaria 344, arts. 68 a 73
Serviços farmacêuticos	Sala, POPs, Declaração de Serviço Farmacêutico, descarte de perfurocortantes	RDC 44/2009, arts. 61 a 84

Área	O que costuma ser verificado	Norma
Resíduos e pragas	Plano de gerenciamento de resíduos, comprovante de controle de pragas	RDC 44/2009, arts. 26 e 88

Controlados: onde a inspeção aperta

Com o SNGPC obrigatório em todo o país, o fiscal costuma imprimir o estoque oficial antes de sair e contar alguns itens no armário. A divergência entre físico e SNGPC é a infração mais fácil de constatar. A RDC 22/2014 manda considerar, na comparação, os arquivos ainda não enviados ou não validados dentro do prazo (art. 36, parágrafo único). Por isso o RT precisa saber, a qualquer momento, quais dispensações estão no software e ainda não foram aceitas pela Anvisa.

Além da contagem, o fiscal pede receitas e notificações retidas de um período, confere se a quantidade do verso bate com a escrituração, se o comprador foi identificado e se a notificação estava dentro da validade. As regras de dispensação estão no módulo da Portaria 344/98.

PONTO-CHAVE

A documentação de Boas Práticas (manual, POPs e registros) deve ficar no estabelecimento por no mínimo 5 anos, à disposição da VISA (RDC 44/2009, art. 89). Os documentos de movimentação de controlados têm prazo próprio de 2 anos (Portaria 344, art. 64). Organize as pastas pensando no prazo de cada um.

Postura do farmacêutico durante a visita

- Receba o fiscal, peça a identificação funcional e pergunte o motivo da inspeção. Se você não for o RT, chame-o ou avise-o.
- Acompanhe todo o percurso. Responda com objetividade e mostre os documentos pedidos. Não invente procedimento que não existe: o fiscal vai pedir o registro dele.
- Não impeça nem atrase o acesso a armário, depósito, computador ou documentos. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, X), e desacato ou embaraço à fiscalização sujeita a multa (art. 20).
- Se houver contagem, acompanhe e anote os números você mesmo. Se faltar algo, procure a explicação na hora (arquivo em trânsito, nota não lançada) e mostre o documento.
- Leia cada termo antes de assinar. A assinatura significa ciência, não confissão. Se discordar, peça para registrar a sua observação no próprio termo ou faça a defesa depois, no prazo.
- Peça a sua via de todo termo lavrado e anote prazos.

ATENÇÃO

Recusar-se a assinar não impede o processo: a recusa é mencionada no auto, que pode ser assinado por testemunhas (Lei 6.437/1977, art. 13, VI e parágrafo único). Assinar e apresentar defesa é quase sempre melhor do que recusar.

NO BALCÃO

Deixe uma pasta da fiscalização pronta, na mesma gaveta, com cópias dos documentos da loja, os POPs vigentes, os últimos registros de temperatura e treinamento, o Certificado de Escrituração Digital, o último Certificado de Transmissão Regular, os comprovantes de entrega de balanços e relações dos últimos 2 anos e o contato da VISA. Ensine o substituto e o gerente a abri-la.

CASO

Fiscal chega numa terça às 16h e pede o registro de temperatura da geladeira de insulinas. O RT mostra a planilha, mas os dias de sábado estão vazios porque a loja abre com outro farmacêutico. A falha vira notificação para corrigir. O RT revisa o POP, inclui o substituto na escala do registro e treina a equipe, com lista de presença.

Termos fiscais e processo administrativo sanitário

Tudo o que o fiscal constata vira documento escrito. Esses documentos são os **termos**. Os nomes e os modelos variam entre os códigos sanitários estaduais e municipais, mas a lógica é nacional e o processo das infrações federais segue a **Lei 6.437/1977**.

Os termos mais comuns

Termo	Para que serve	O que fazer
Termo de inspeção (ou relatório de inspeção)	Registra a visita e o que foi visto	Ler, conferir, guardar a via
Termo de notificação ou de intimação	Exige que a loja corrija algo em prazo determinado, sem multa naquele momento	Cumprir no prazo escrito e comprovar à VISA; pedir prorrogação por escrito antes do vencimento, se precisar
Auto de infração	Abre o processo administrativo sanitário pela infração constatada	Defesa em 15 dias, ou pagamento com redução
Termo de apreensão	Retira produto da loja, como prova ou para análise fiscal	Conferir quantidade, lote e descrição; guardar a contraprova quando houver
Termo de interdição	Impede o uso ou a venda de produto, ou o funcionamento de setor ou do estabelecimento	Cumprir de imediato; não mexer no que foi lacrado
Termo de inutilização	Registra a destruição de produto impróprio	Guardar como justificativa de perda

O prazo de uma notificação ou intimação é o que está escrito no termo e no código sanitário local. Não existe um prazo federal único para isso.

Auto de infração e defesa

A infração sanitária é apurada em processo administrativo próprio, que começa com a lavratura do **auto de infração** (Lei 6.437/1977, art. 12). O auto deve conter, entre outros, o nome do infrator, local, data e hora, a descrição da infração e o dispositivo legal transgredido, a penalidade possível, a ciência do autuado e o prazo de recurso (art. 13).

Etapa	Prazo	Base
Defesa ou impugnação do auto	15 dias da notificação	Lei 6.437/1977, art. 22
Pagamento da multa com redução de 20%	20 dias da notificação; implica desistir da defesa	Art. 21
Recurso contra decisão condenatória	Mesmo prazo da defesa (15 dias)	Art. 30
Recurso à autoridade superior, mantida a condenação	20 dias da ciência ou publicação	Art. 30, parágrafo único
Pagamento da multa aplicada	30 dias da notificação	Art. 33
Cumprir obrigação que subsiste após o auto	30 dias, por edital; descumprir gera multa diária	Arts. 18 e 19
Prescrição da infração	5 anos, interrompida por notificação ou ato de apuração	Art. 38

Infrações que não dependem de análise ou perícia seguem rito sumaríssimo: o processo é considerado concluso se o infrator não recorrer em 15 dias (art. 29). Os recursos só suspendem o pagamento da multa; a obrigação de corrigir continua exigível (art. 32).

O QUE DIZ A NORMA

"O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de quinze dias contados de sua notificação." (Lei 6.437/1977, art. 22)

Apreensão e interdição

Quando há suspeita sobre o produto, a VISA colhe amostra para **análise fiscal**. A amostra é dividida em três partes invioláveis: uma fica com o detentor como contraprova e duas vão ao laboratório oficial (art. 27). A apreensão de amostra, sozinha, não interdita o lote, salvo indício flagrante de alteração ou adulteração, quando a interdição tem caráter cautelar (art. 23, §§ 1º e 2º). A **interdição cautelar** de produto ou estabelecimento dura o tempo das análises e não pode passar de 90 dias; depois disso, a liberação é automática (art. 23, § 4º).

Se o laudo for condenatório, a empresa pode pedir perícia de contraprova com a amostra que ficou com ela, indicando perito próprio (art. 27, § 4º). Por isso, a contraprova deve ser guardada intacta, nas condições de conservação do produto.

Penalidades e termo de compromisso

As penas vão de advertência a multa, apreensão, inutilização, interdição e cancelamento de licença ou autorização, com classificação da infração em leve, grave ou gravíssima conforme atenuantes e agravantes (arts. 2º, 4º, 7º e 8º; valores e exemplos no módulo da Portaria 344/98). Desde a Lei 14.671/2023, os órgãos do SNVS podem celebrar **termo de compromisso** com o infrator, na forma de regulamento. O requerimento é analisado em até 90 dias, e o termo firmado suspende a aplicação de sanções sobre os fatos que o motivaram, exceto as de caráter preventivo e cautelar (art. 28-A). Pergunte à sua VISA se ela já regulamentou essa via.

ATENÇÃO

Muitos estados e municípios têm código sanitário próprio, com prazos e valores diferentes para as infrações que eles tipificam. O auto de infração diz qual lei foi aplicada. Conte o prazo pela lei citada no auto, a partir da data de ciência.

NO BALCÃO

Recebeu auto de infração: anote no calendário a data final da defesa (15 dias, se for a Lei 6.437), avise o responsável legal no mesmo dia, reúna a prova documental (receitas, relatórios do SNGPC, registros de treinamento, POP) e escreva a defesa ponto a ponto, com cópia dos documentos. Defesa genérica, sem documento, tem pouca chance de reduzir a penalidade.

CASO

Drogaria recebe auto por não ter entregue a RMNRA de agosto. O RT tinha protocolado no dia 14 de setembro pelo portal da VISA, mas o protocolo ficou no e-mail do dono. Ele recupera o comprovante, junta à defesa no 10º dia e o auto é arquivado. Depois disso, o POP passa a exigir que todo comprovante seja salvo na pasta da fiscalização no mesmo dia.

Livro de registro e guarda de documentos

Escriturar é registrar cada entrada, saída e perda de um produto controlado, de forma que o estoque possa ser reconstituído a qualquer momento. Antes do SNGPC, isso era feito em livros com termo da VISA. Hoje, nas farmácias e drogarias privadas, a escrituração é eletrônica, mas o livro continua existindo em situações que o RT precisa reconhecer.

O livro na Portaria 344/98

A Portaria 344 (arts. 62 a 66) exige **Livro de Registro Específico** para indústrias, distribuidoras, farmácias e drogarias, e **Livro de Receituário Geral** para farmácias magistrais. O Livro de Registro Específico é dividido por grupo de listas:

- Entorpecentes: listas A1 e A2.
- Psicotrópicos: listas A3, B1 e B2.

- Controle especial: listas C1, C2 e C5 (o texto original cita também a C4, extinta em 2016), e os medicamentos dos adendos das listas A1, A2 e B1 vendidos com Receita de Controle Especial (Portaria 6/1999, art. 93, § 3º).
- Imunossupressores: lista C3.

Cada página registra uma só substância ou medicamento, pela DCB combinada com o nome comercial (Portaria 344, art. 63, § 3º), em ordem cronológica de estoque, entradas, saídas e perdas (art. 65). A escrituração é legível, sem rasuras ou emendas, e atualizada semanalmente (art. 64, § 1º). Se o livro for apreendido por autoridade sanitária ou policial, ficam suspensas as atividades com os produtos nele registrados até a liberação ou substituição (art. 66).

Termos de abertura e de encerramento

Os livros têm termo de abertura e de encerramento lavrados pela autoridade sanitária (Portaria 344, art. 63). A Portaria 6/1999 detalha:

Item	Regra	Base
Quem preenche e assina o termo de abertura	A autoridade sanitária	Portaria 6/1999, art. 94, § 2º
Dados do termo de abertura	Razão social, denominação comercial, endereço completo, finalidade do livro, CNPJ	Art. 94, § 2º
Termo de encerramento	No verso da última folha numerada, com os mesmos dados e a quantidade de folhas escrituradas; só depois de usado o livro	Art. 94, §§ 3º e 4º
Matriz e filiais	Cada estabelecimento com os próprios livros	Art. 95
Livro informatizado	Pedido por escrito à VISA, que avalia e defere ou não; formulário contínuo numerado	Arts. 96, 97 e 100
Troca de RT	O novo RT assina o livro logo abaixo da assinatura do anterior, com identificação e data	Art. 114

Antes de autenticar o livro, a VISA verifica se o estabelecimento está licenciado e se a taxa foi recolhida, quando houver (art. 93, § 6º). Na prática, cada VISA tem seu rito: em São Paulo capital, o termo vem preenchido e assinado pelo RT com o número de folhas, a abertura é agendada por e-mail e, no encerramento, as folhas em branco devem estar riscadas.

Quando o livro é dispensado

O QUE DIZ A NORMA

"A escrituração de medicamentos e insumos farmacêuticos sujeitos a esta Resolução substitui a escrituração realizada por meio de livro de registro ou sistema informatizado previamente autorizado pela autoridade sanitária competente, estabelecidos na Portaria SVS/MS nº 344/98, e na Portaria SVS/MS nº 6, de 1999, ou as que vierem substituí-las." (RDC 22/2014, art. 35)

Estabelecimento	Como escritura controlados em outubro de 2026
Drogaria privada	SNGPC, pelo software da loja; sem livro
Farmácia com manipulação privada	SNGPC, incluindo insumos com o lote do fabricante e a transformação; sem livro de registro específico
Município sem internet	Livro, com autorização da VISA (RDC 22/2014, art. 35, § 1º)
Farmácia pública e farmácia de hospital	Fora do SNGPC enquanto não houver módulo próprio (RDC 22/2014, art. 3º, parágrafo único): livro com termos da VISA
Unidade pública que dispensa talidomida	Livros próprios da RDC 11/2011

Desde 12/03/2020, a VISA da capital paulista deixou de analisar pedidos de livro informatizado de drogarias e farmácias de manipulação, justamente porque o SNGPC substitui o livro. O software da loja costuma ter um relatório chamado "Livro de Registro Específico", herança da exigência de que o sistema informatizado permitisse imprimir os livros (Portaria 6/1999, art. 101). Esse relatório é uma impressão da escrituração, útil para conferência e para mostrar ao fiscal; ele não tem termo de abertura da VISA. No Trier SNGPC Web, por exemplo, emitir esse relatório bloqueia o período para novos lançamentos (módulo do software de gestão).

ATENÇÃO

Durante a suspensão das transmissões (2021 a 2025), a escrituração no software nunca deixou de ser obrigatória. Loja que ficou sem registro nesse período não tem como provar o estoque e não pode alegar que "o SNGPC estava parado".

Documentos hábeis para escriturar

A Portaria 6/1999 (art. 93, § 4º) define o que justifica cada lançamento: na entrada, nota fiscal; na saída, receita ou notificação retida; na perda, a justificativa (vencimento, quebra, extravio com boletim de ocorrência, amostra para controle de qualidade, termo de inutilização da VISA). No SNGPC, apreensão ou recolhimento pela VISA e devolução ao fabricante também são lançados como perda, com o motivo (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV).

Prazos de guarda

Documento	Prazo	Base
Livros, balanços e comprovantes de movimentação de controlados (notas, notificações, receitas retidas)	2 anos	Portaria 344, art. 64
Livro e documentos do fornecedor de C3 e talidomida	5 anos	Portaria 344, art. 64, § 2º

Documento	Prazo	Base
Livro de registro de notificação de talidomida da unidade pública	10 anos	Portaria 344, art. 64, § 3º
Cópia de segurança da escrituração do SNGPC	2 anos	RDC 22/2014, art. 19, I
Registro de utilização de receitas eletrônicas	Em meio eletrônico, pelos prazos da Portaria 344 e da RDC 11/2011	RDC 1.000/2025, art. 14
Manual, POPs e registros de Boas Práticas	Mínimo de 5 anos	RDC 44/2009, art. 89

PONTO-CHAVE

Comprovante de entrega de balanço ou relação é documento de movimentação de controlado: guarde-o pelo menos 2 anos, junto com a via visada. Muitos RTs preferem guardar tudo por 5 anos, o que atende às duas normas de uma vez.

NO BALCÃO

Arquive as receitas e notificações retidas em caixas por mês e por tipo (A, B, B2, retinoides, RCE, antimicrobianos), com etiqueta de data de descarte possível. Na troca de RT, entregue ao sucessor o mapa das caixas e das pastas digitais.

Balanços BMPO e BSPO

Balanço, na Portaria 344, é um resumo periódico da movimentação de controlados que o estabelecimento entrega à VISA. Ele resume a escrituração por período, com assinatura do RT, para que a autoridade compare com o que vê na inspeção e no SNGPC. Existem dois balanços que interessam à farmácia comercial.

BMPO e BSPO lado a lado

Item	BMPO	BSPO
Nome	Balanço de Medicamentos Psicoativos e de outros Sujeitos a Controle Especial	Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial
O que registra	Vendas de **medicamentos** prontos	Movimentação de estoque de **substâncias** (insumos)
Listas	A1, A2, A3 e B2 (o texto cita também C4, lista extinta)	A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C5 e D1 (e C4 no texto original)

Item	BMPO	BSPO
Quem entrega, na farmácia comercial	Farmácias e drogarias	Farmácias com manipulação (e indústrias, distribuidoras de insumos, importadores)
Vias	2: uma fica na VISA, outra volta visada	3 no texto original; o destino da 1ª via foi alterado pela RDC 13/2009
Trimestral	Até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro	Até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro
Anual	Até 31 de janeiro do ano seguinte	Até 31 de janeiro do ano seguinte
Base	Portaria 344, art. 69; Portaria 6/1999, art. 104	Portaria 344, art. 68; Portaria 6/1999, art. 103

As farmácias de unidades hospitalares e as de clínicas médicas e veterinárias estão dispensadas do BMPO (Portaria 344, art. 69, § 3º). Para drogarias, distribuidoras e farmácias que só vendem produtos industrializados comprados no mercado nacional, a Anvisa esclarece que o BSPO não é exigido; a movimentação delas continua sendo informada à vigilância local (Anvisa, orientações de preenchimento do BSPO).

PONTO-CHAVE

A lista do BMPO é curta: **A1, A2, A3 e B2**. Clonazepam, alprazolam e zolpidem (B1), antidepressivos (C1) e isotretinoína (C2) não entram no BMPO da drogaria, embora sejam escriturados no SNGPC. Metilfenidato e lisdexanfetamina (A3), morfina, metadona e oxicodona (A1) e sibutramina (B2) entram.

Quem entrega o quê: a variação local

As VISAs não leem a regra de quem entrega da mesma forma. A VISA municipal de São Paulo indica BMPO para drogarias e farmácias de manipulação, e BSPO para farmácias de manipulação, distribuidoras, importadoras e indústrias (Nota Técnica 03/2021). O Rio de Janeiro define BMPO para drogarias (farmácias sem manipulação) e BSPO para farmácias com manipulação, incluindo as hospitalares (termo de uso do serviço de entrega, versão de outubro de 2025). O Paraná esclareceu em 2017 que o balanço da farmácia e da drogaria privada contém só as listas dos arts. 68 e 69, e não todas as listas da 344, como pedia uma resolução estadual antiga. Na farmácia com manipulação, confirme com a VISA se ela quer só o BSPO ou BSPO e BMPO.

O que o SNGPC mudou e o que não mudou

O SNGPC substituiu o livro (RDC 22/2014, art. 35), mas nenhuma norma federal revogou os arts. 68 e 69 da Portaria 344. Durante a suspensão das transmissões, a Anvisa reafirmou que BSPO, BMPO, RMNRA e RMNRB2 mantinham os prazos da 344 e que a VISA local podia definir procedimentos próprios (Perguntas e Respostas sobre a instabilidade do SNGPC, 2021). Com a transmissão obrigatória em todo o país desde 02/01/2026, o que muda é a origem dos números: o balanço sai do mesmo software que gera o XML, e a

VISA pode cruzá-lo com o estoque oficial do SNGPC. Divergência entre balanço, SNGPC e prateleira é sinal de escrituração com problema.

ATENÇÃO

O balanço deve ser cópia fiel da escrituração. No BSPO, a Portaria proíbe ajustes com fator de correção (art. 68, § 5º). Não "acerte" número no balanço para fechar com a prateleira: a correção se faz na escrituração, com documento, e o balanço sai depois.

Montagem do balanço

Para cada medicamento (BMPO) ou substância (BSPO), o raciocínio é o mesmo: estoque inicial do período, mais entradas, menos saídas e perdas, igual ao estoque final. O estoque final de um trimestre é o inicial do seguinte, e o estoque inicial do ano é o final do ano anterior. Na planilha digital do BSPO, a Anvisa orienta usar a mesma unidade em toda a linha (mg, g ou kg; entorpecentes sempre em grama), três casas decimais, zero em vez de célula em branco e detalhar perdas no campo de observação; o estoque final calculado não pode ser negativo.

CASO

BMPO do 3º trimestre de 2026 (julho a setembro), drogaria fictícia. Metilfenidato 10 mg, caixa com 30 comprimidos: estoque em 1º/07, 40 caixas; entradas por nota fiscal, 60; vendas com Notificação A, 72; perda por vencimento, 2. Estoque final: 40 + 60 – 72 – 2 = 26 caixas, que devem estar no armário e no SNGPC em 30/09. O prazo de entrega desse balanço é 15/10/2026.

Outras regras práticas: o novo RT deve apresentar balanço dos controlados quando a VISA pedir (Portaria 6/1999, art. 114, parágrafo único); o RT que sai apresenta levantamento do estoque até o último dia de trabalho (art. 113). Se o dia 15 cair em fim de semana ou feriado, siga a regra da VISA local; não presuma prorrogação.

NO BALCÃO

Gere o balanço no software na primeira semana do mês de entrega, confira três ou quatro itens contra a prateleira e o SNGPC, assine e protocole bem antes do dia 15. Guarde a via visada ou o protocolo eletrônico na pasta da fiscalização.

RMNRA e demais relações periódicas

As **relações mensais** são listas de receituários retidos que a farmácia entrega à VISA junto com os próprios receituários. Elas permitem que a autoridade audite quem prescreve, quem compra e em que quantidade os medicamentos de maior risco.

RMNRA

A **Relação Mensal de Notificações de Receita "A" (RMNRA)** registra as Notificações de Receita A retidas na dispensação de medicamentos das listas A1, A2 e A3 (Portaria 344, art. 72). As regras centrais:

- Quem faz: o farmacêutico responsável da farmácia ou drogaria.
- Prazo: até o dia 15 de cada mês, referente às notificações do mês anterior (arts. 42 e 72).
- Forma: em 2 vias; uma fica na VISA, a outra volta ao estabelecimento visada. A VISA recebe mediante recibo (art. 42).
- Anexos: as próprias Notificações A, com a justificativa do prescritor quando a quantidade passar do limite (art. 43, § 2º).
- Devolução: a VISA devolve as notificações em até 30 dias da entrega (art. 72, parágrafo único). Depois, elas ficam arquivadas na farmácia por 2 anos (art. 64).

O QUE DIZ A NORMA

"A Relação Mensal de Notificações de Receita "A" - RMNRA (ANEXO XXIV), destina-se ao registro das Notificações de Receita "A" retidas em farmácias e drogarias [...] a qual será encaminhada junto com as respectivas notificações à Autoridade Sanitária, pelo farmacêutico responsável, até o dia 15 (quinze) de cada mês [...]" (Portaria 344/1998, art. 72)

Ao receber a RMNRA, a VISA investiga o preenchimento, o uso e a venda corretos, e, se encontrar desvio ou uso irregular, elabora relatório sigiloso e o encaminha aos conselhos dos profissionais envolvidos e aos órgãos competentes (Portaria 6/1999, capítulo do balanço).

O que entra e o que não entra

- Entram: todas as Notificações A retidas no mês, de medicamentos das listas A1, A2 e A3.
- Não entram: preparações dos adendos das listas A1 e A2 vendidas com Receita de Controle Especial (por exemplo, associações de codeína dentro do limite do adendo). As VISAs de São Paulo e de Manaus deixam isso explícito.
- Notificação A de outro estado: desde a RDC 873/2024 não há visto da VISA em 72 horas para Notificação A de outra UF; ela entra na RMNRA do mês como as demais (detalhes no módulo da Portaria 344/98).
- Notificação A eletrônica (disponível desde 30/09/2026): a RDC 1.000/2025 incluiu o § 2º-A no art. 72, permitindo o envio à VISA em meio eletrônico. Combine com a sua VISA o formato (arquivo, relatório do software ou outro).

Campos da relação

O modelo é o Anexo XXIV da Portaria 344. Muitas VISAs aceitam o leiaute gerado pelo software (no Trier, "Padrão Portaria"), desde que traga a identificação do estabelecimento (razão social, CNPJ, endereço, número da licença), o mês de referência, o RT com inscrição no CRF e, para cada notificação, os dados que permitam conferi-la com o papel: número da notificação, data, medicamento, quantidade dispensada e prescritor com inscrição no conselho. Os campos exatos estão no quadro do material de apoio.

RMNRB2

Para os anorexígenos da lista B2 (sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol), existe a **Relação Mensal de Notificações de Receita "B2" (RMNRB2)**, prevista na RDC 58/2007 (art. 1º, § 4º, modelo do

anexo II), norma que segue vigente com as alterações posteriores, como a da RDC 689/2022, que deu validade nacional de 30 dias à receita B2. As VISAs de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus exigem a RMNRB2 mensalmente, até o dia 15, acompanhada das notificações B2.

Outros mapas e relações

Documento	Quem entrega	Periodicidade	Base
MCPM (Mapa do Consolidado das Prescrições de Medicamentos), lista C3	Farmácias de órgãos oficiais que dispensam imunossupressores	Trimestral, até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro	Portaria 344, art. 70
MTC (Mapa Trimestral Consolidado) de talidomida	Unidades públicas dispensadoras de talidomida	Trimestral	RDC 11/2011, anexo XI
RMV (Relação Mensal de Vendas)	Indústrias e distribuidoras	Mensal, até o dia 15	Portaria 344, art. 71
Receita de emergência para visto	Farmácia que aviou receita de emergência em papel não oficial	Por evento, em 72 horas	Portaria 344, art. 36, § 2º, e art. 55, § 2º

A drogaria não faz MCPM nem MTC: a talidomida é dispensada só por unidades públicas credenciadas (RDC 11/2011). A Portaria 344 também não prevê relação mensal específica de retinoides para farmácias; a notificação especial de retinoides é retida e escriturada no SNGPC.

ATENÇÃO

A forma de entrega varia entre as VISAs; o prazo da Portaria 344 é o mesmo em todo o país. Em São Paulo capital, balanços e receitas vão pelo portal SP156, em PDF de até 50 MB, e documentos fora do prazo são indeferidos sem possibilidade de reenvio pelo portal. Em Manaus, vão por e-mail em PDF único, com protocolo no SIGED. Em São José dos Campos (SP), a VISA pede até o dia 15 as imagens de todas as receitas de controlados do mês anterior com uma planilha assinada. Leia a orientação da sua VISA e transforme-a em POP.

NO BALCÃO

Separe as Notificações A e B2 em envelopes do mês, na ordem em que foram dispensadas. No dia 1º, gere as relações no software, confira uma a uma com o papel (número, quantidade, prescritor) e corrija a escrituração antes de imprimir. A VISA confere primeiro se a relação bate com as notificações anexadas.

CASO

No fechamento de setembro, o farmacêutico conta 18 Notificações A no envelope e 19 na relação do software. A diferença é uma venda de morfina lançada duas vezes no caixa. Ele estorna o lançamento duplicado pelo procedimento do sistema, retransmite a correção ao SNGPC, gera de novo a RMNRA e protocola em 08/10, dentro do prazo.

Calendário de obrigações do responsável técnico

Muitas autuações em farmácia nascem de prazo perdido: balanço entregue no dia 16, relação esquecida no mês de férias, arquivo do SNGPC com 8 dias. Um **calendário escrito**, compartilhado com o substituto, reduz esse risco. A tabela completa, com base legal, está no material de apoio; aqui está a lógica de cada periodicidade.

A cada atendimento e todo dia

- Conferir a receita, dispensar, anotar e reter conforme a Portaria 344 e a RDC 471/2021.
- Lançar a dispensação no software no momento do atendimento, com lote e quantidade, e registrar no SNCR o uso da receita eletrônica (RDC 1.000/2025, art. 13).
- Lançar as entradas pela nota fiscal no dia do recebimento, conferindo lote e validade (RDC 44/2009, art. 34).
- Medir e registrar a temperatura da geladeira de termolábeis (RDC 44/2009, art. 35, § 3º), no horário definido em POP.
- Separar receitas e notificações retidas por tipo, no envelope do mês.

Toda semana

- Transmitir o arquivo do SNGPC com intervalo de 1 a 7 dias, mesmo sem movimento, e acompanhar até "aceito" (RDC 22/2014, art. 10, §§ 3º e 4º).
- Contagem por amostragem dos controlados de maior giro, comparando prateleira, software e SNGPC.
- Revisar alertas sanitários da Anvisa e da VISA e comunicados de recolhimento de fornecedores.

Todo mês

- Até o dia 15: RMNRA com as Notificações A e RMNRB2 com as Notificações B2, na forma da VISA (Portaria 344, art. 72; RDC 58/2007).
- Conferir a devolução das notificações entregues no mês anterior (30 dias) e arquivá-las.
- Separar produtos com vencimento próximo conforme a política do Manual de Boas Práticas (RDC 44/2009, art. 38, § 4º) e baixar os vencidos como perda.
- Fechar o arquivo de receitas do mês e descartar, com registro, as caixas que já passaram do prazo de guarda.

Todo trimestre e todo ano

- BMPO (e BSPO, na farmácia com manipulação) até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro.

- Balanço anual até 31 de janeiro, no mesmo mês em que vence, no dia 15, o balanço do 4º trimestre.
- Renovação da licença sanitária e de outros documentos, no prazo do código sanitário local.
- Revisão dos POPs e do Manual de Boas Práticas, com registro da revisão e da divulgação (RDC 44/2009, art. 87, § 3º).
- Treinamento continuado da equipe, com lista de presença (RDC 44/2009, arts. 24 e 28).

PONTO-CHAVE

Outubro, janeiro, abril e julho são meses de pico: no dia 15 vencem, ao mesmo tempo, a relação mensal e o balanço trimestral. Em janeiro, ainda há o balanço anual até o dia 31. Planeje esses meses com antecedência.

Obrigações por evento

Evento	O que fazer	Prazo
Receita de emergência em papel não oficial	Anotar o comprador e apresentar à VISA para visto	72 horas (Portaria 344, art. 36, § 2º)
Suspeita de falsificação ou adulteração no recebimento	Segregar e notificar a autoridade sanitária	Imediatamente (RDC 44/2009, art. 34, §§ 1º e 2º)
Furto, roubo ou extravio de controlado	Boletim de ocorrência, comunicação à VISA, escrituração da perda	Assim que constatado
Saída do RT	Levantamento do estoque de controlados entregue à VISA; finalização do inventário no SNGPC	Até o último dia de trabalho (Portaria 6/1999, art. 113)
Entrada de novo RT	Conferir inventário, associar-se no SNGPC, apresentar balanço se a VISA pedir	Antes de começar a transmitir (RDC 22/2014, art. 12)
Evento adverso ou queixa técnica	Notificar no VigiMed ou no Notivisa	Assim que tiver os dados (RDC 44/2009, art. 67)
Alerta ou recolhimento de lote	Localizar o lote, segregar, suspender a venda, seguir a orientação	No mesmo dia

Como montar o calendário

Coloque as datas fixas (dia 15 de cada mês, dia 15 dos meses de trimestre, 31 de janeiro, vencimento da licença) numa agenda compartilhada com o substituto, com lembrete uma semana antes. Defina no POP quem gera, quem confere e quem protocola cada documento, e onde fica o comprovante. Nas férias do RT, o substituto precisa saber gerar e entregar as relações, porque os prazos não são suspensos.

NO BALCÃO

Use uma planilha simples de controle com uma linha por obrigação e uma coluna por mês, marcando data de entrega e número do protocolo. Na inspeção, ela mostra em segundos que as entregas estão em dia.

CASO

Hoje, 15/10/2026, uma drogaria de Fortaleza precisa protocolar a RMNRA e a RMNRB2 de setembro e o BMPO do 3º trimestre. A RT deixou tudo pronto no dia 6, protocolou no dia 7 pelo canal da VISA e arquivou os comprovantes.

Farmacovigilância, queixa técnica e alertas sanitários

A farmácia é a última barreira antes do paciente e, muitas vezes, o primeiro lugar onde aparece o problema com um medicamento: a reação que o cliente relata, o comprimido de cor diferente, a caixa com lote ilegível. A RDC 44/2009 manda o farmacêutico **contribuir para a farmacovigilância**, notificando a ocorrência ou suspeita de evento adverso ou queixa técnica às autoridades sanitárias (art. 67).

Evento adverso e queixa técnica

Situação	Exemplo de balcão	Onde notificar
Evento adverso a medicamento (reação, inefetividade, erro de medicação com medicamento)	Urticária após iniciar antibiótico; anticonvulsivante sem efeito após troca de fabricante	**VigiMed**
Desvio de qualidade de medicamento (queixa técnica)	Comprimidos esfarelados, solução turva, frasco com volume a menos, embalagem violada	**Notivisa**
Suspeita de falsificação ou produto sem registro	Lote que não existe no fabricante, embalagem diferente da original	Notivisa e comunicação à VISA
Problema com dispositivo médico, cosmético, saneante, suplemento	Lanceta que não dispara, glicosímetro com erro, protetor solar com reação	Notivisa (não é escopo do VigiMed)
Evento adverso a vacina (Esavi)	Reação após vacina aplicada na farmácia	e-SUS Notifica, para vacinas do Programa Nacional de Imunizações; VigiMed se o profissional não tiver acesso ao e-SUS Notifica

Essa divisão segue o manual da Anvisa para notificação no VigiMed por serviços de saúde (versão de 12/05/2026). O VigiMed recebe eventos adversos de medicamentos de qualquer categoria, inclusive fitoterápicos, manipulados, homeopáticos e produtos de cannabis; desvios de qualidade de medicamentos vão para o Notivisa. Em medicamento com dispositivo acoplado, como caneta aplicadora, o evento do fármaco vai ao VigiMed e o defeito da caneta, ao Notivisa.

O VigiMed tem três módulos: cidadãos e profissionais de saúde (sem cadastro prévio, notificação voluntária), profissionais de saúde cadastrados e empresas. Para o detentor do registro, a notificação é obrigatória pela RDC 406/2020. O farmacêutico da farmácia comercial pode notificar pelo módulo de profissionais e orientar o próprio paciente a notificar como cidadão.

PONTO-CHAVE

Notificação boa é notificação completa: medicamento com nome, fabricante, lote e validade; dose e data de início; descrição do evento e evolução; outros medicamentos em uso. Notificação sem lote não permite à Anvisa nem à empresa investigar.

No balcão, diante da queixa

- Registre o relato do cliente com data, produto, lote e validade, e guarde a embalagem e o produto restante, se o cliente concordar.
- Verifique se há outras unidades do mesmo lote no estoque; se houver suspeita de desvio de qualidade, segregue-as e identifique (RDC 44/2009, art. 38).
- Notifique no sistema certo e anote o número do protocolo no registro interno.
- Oriente o paciente sobre a conduta clínica e encaminhe ao prescritor ou ao serviço de saúde quando houver reação relevante.

NO BALCÃO

Cliente devolve um frasco de dipirona gotas dizendo que "está com cheiro estranho e mais escuro". O farmacêutico registra o lote, separa as outras unidades daquele lote, notifica queixa técnica no Notivisa, troca o produto por outro lote e contata o distribuidor. Se o cliente tivesse tomado e tido reação, faria também a notificação de evento adverso no VigiMed.

Recolhimento e alertas sanitários

O **recolhimento** de medicamentos (recall) é responsabilidade do detentor do registro, que deve comunicá-lo às autoridades sanitárias e aos consumidores quando há indício ou comprovação de desvio de qualidade com risco à saúde, ou cancelamento de registro por segurança e eficácia (RDC 625/2022, que revogou a RDC 55/2005). Os distribuidores enviam ao detentor o mapa de distribuição, e é por ele que a farmácia é avisada. Além disso, a Anvisa publica no Diário Oficial resoluções que determinam suspensão de comercialização, recolhimento, apreensão ou inutilização de lotes ou produtos, e divulga alertas no portal.

Para a farmácia, a RDC 44/2009 manda segregar, fora da área de dispensação, os produtos sob suspeita, identificados quanto à condição e ao destino; quando o impedimento de uso é determinado pela vigilância ou por iniciativa do fabricante, o recolhimento segue a regulamentação específica (art. 38, §§ 1º e 3º).

Passo	Ação
Identificar	Ler o alerta: produto, lote, medida determinada (suspensão, recolhimento, apreensão) e abrangência
Localizar	Buscar no estoque, na loja e no depósito, e nas transferências entre filiais
Bloquear	Retirar da área de venda e bloquear o lote no sistema
Segregar	Guardar identificado como "não comercializar"; controlado continua sob chave
Devolver ou aguardar	Seguir a orientação do detentor ou da VISA, com nota fiscal de devolução
Escriturar	Controlado ou antimicrobiano: lançar a saída como perda com o motivo (recolhimento ou devolução ao fabricante)
Registrar	Data, quantidades, destino e responsável, guardando o alerta e os comprovantes

ATENÇÃO

Vender produto com comercialização suspensa ou determinado para recolhimento expõe o paciente e configura infração sanitária. Se o paciente já levou o lote, a orientação depende do alerta: algumas medidas pedem contato com quem comprou; outras, só bloqueio do estoque.

CASO

Segunda-feira, a Anvisa determina recolhimento de dois lotes de losartana de um fabricante. A farmacêutica encontra 14 caixas de um dos lotes, bloqueia no sistema, separa com etiqueta, liga para o distribuidor, emite nota de devolução no dia seguinte e arquiva o alerta com a nota na pasta da fiscalização.

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, arts. 36, 41 a 43, 55 e 62 a 76 (texto original). bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 (Instrução Normativa da Portaria 344/98), capítulos da escrituração, do balanço e da responsabilidade (arts. 91 a 116). Cópia publicada pelo Conselho Federal de Farmácia, cff.org.br/userfiles/file/portarias/6.pdf
3. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações à legislação sanitária federal), texto compilado com a Lei nº 14.671/2023 (art. 28-A). planalto.gov.br
4. Brasil. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa), art. 1º. planalto.gov.br
5. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 (Boas Práticas Farmacêuticas), texto vigente com alterações, arts. 2º, 3º, 24 a 38, 67 e 85 a 89. anvisalegis.datalegis.net
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 22, de 29 de abril de 2014 (SNGPC), arts. 3º, 5º, 10, 12, 15, 19, 35 e 36 (conforme os módulos de Portaria 344/98 e SNGPC deste material e a transcrição do art. 35 pela VISA de São

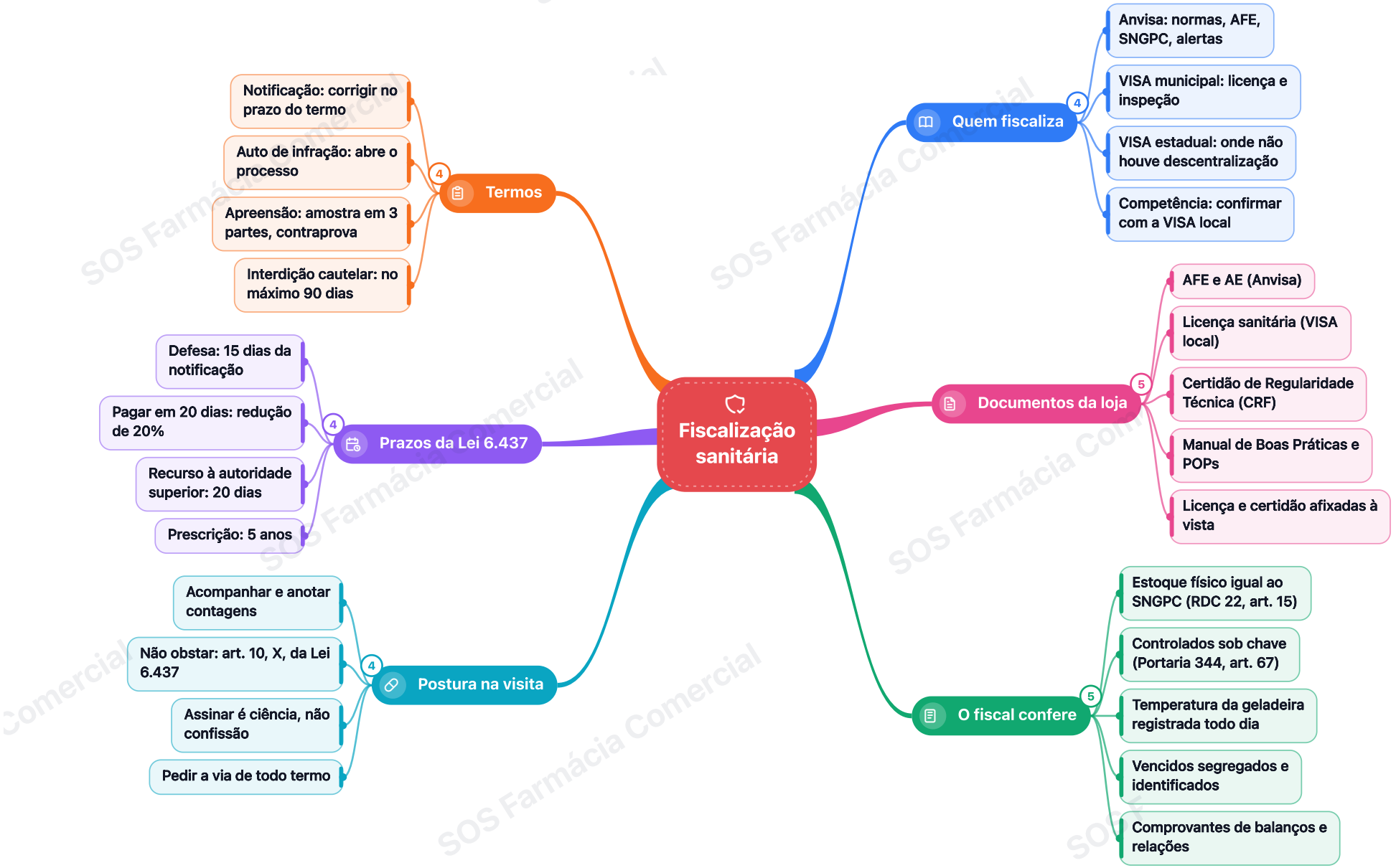
Paulo).

7. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 625, de 9 de março de 2022 (comunicação e recolhimento de medicamentos), em vigor desde 1º de abril de 2022, revogou a RDC nº 55/2005 (conferida por fontes secundárias).
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 58, de 5 de setembro de 2007 (anorexígenos), art. 1º, § 4º, e anexo II (RMNRB2), alterada pela RDC nº 689/2022 (citadas pelas VISAs do Paraná, de São Paulo, de Manaus e do Rio de Janeiro).
9. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025 (receituários eletrônicos; art. 72, § 2º-A, da Portaria 344), conforme o módulo da Portaria 344/98 deste material.
10. Anvisa. Orientações de preenchimento do Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Sujeitas a Controle Especial (BSPO). Publicação em gov.br/anvisa, modificada em 13 mar. 2026.
11. Anvisa. Manual de instruções de notificação no sistema VigiMed para serviços de saúde. MANUAL-F-ANVISA-034, versão 00, 12 maio 2026. gov.br/anvisa
12. Anvisa. Página de notificações (VigiMed, Notivisa, e-Notivisa). gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes (consulta em 15 out. 2026).
13. Prefeitura de São Paulo. COVISA/DVPSIS. Nota Técnica 03/2021: orientações referentes ao encaminhamento de balanços e receitas de substâncias e medicamentos constantes na Portaria SVS/MS nº 344/98. 5 abr. 2021.
14. Prefeitura de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde. Medicamentos sujeitos a controle especial: abertura e encerramento de livros, informatização e mapas (página consultada em 15 out. 2026).
15. Prefeitura do Rio de Janeiro. IVISA-Rio. Termo de uso e aviso de privacidade do serviço de entrega periódica de balanços, mapas e relações (versão de 24 out. 2025); Resolução SMSDC nº 1.483, de 7 de agosto de 2009.
16. Prefeitura de Manaus. SEMSA. Entrega de balanços, mapas e relações: controle especial (informações ao cidadão, 2021).
17. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. CEVS/DVVSP. Sobre os balanços de produtos controlados BSPO, BMPO, RMNRA e RMNRB2 para farmácias e drogarias privadas. Curitiba, 27 set. 2017.
18. Governo de Minas Gerais. Apresentar balanços, relações e mapas de medicamentos e substâncias à Vigilância Sanitária (carta de serviços, consulta em 15 out. 2026).
19. Prefeitura de Jundiaí. VISA. Informativo referente à Portaria SVS/MS nº 344/1998 (entrega eletrônica de BMPO, BSPO e RMV, 2023); Prefeitura de São José dos Campos. Mapas e balanços (consulta em 15 out. 2026).
20. Anvisa. Perguntas e Respostas: instabilidade do SNGPC, 1ª ed., 17 dez. 2021 (pergunta 12), conforme o módulo do SNGPC deste material.

SOS Farmácia Comercial

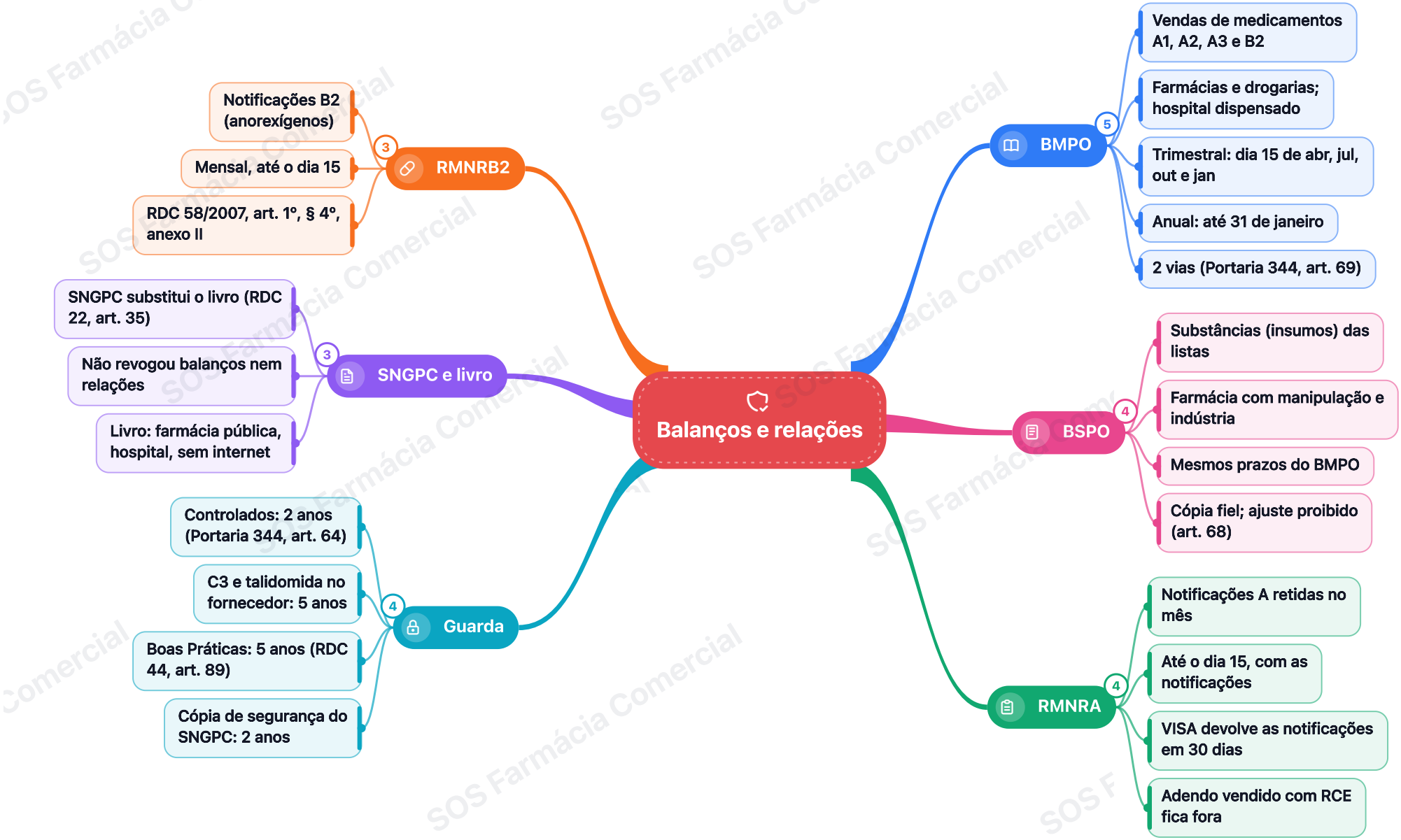
Fiscalização sanitária na farmácia

6 ramos · 26 itens · mapa mental do módulo 6



Balanços, relações e escrituração

6 ramos · 23 itens · mapa mental do módulo 6



Obrigação, periodicidade, prazo, para quem, base legal

Obrigação	Periodicidade	Prazo	Para quem	Base legal
Lançar dispensação e entrada de controlados e antimicrobianos no software	A cada movimento	No ato; entrada no dia do recebimento	Registro interno (base do SNGPC)	RDC 22/2014, arts. 10 e 15
Registrar o uso da receita eletrônica	A cada dispensação	No ato	SNCR	RDC 1.000/2025, art. 13
Registrar temperatura de produtos refrigerados	Diária	Horário definido em POP	Registro interno (fiscal confere)	RDC 44/2009, art. 35, §§ 3º e 4º
Transmitir arquivo ao SNGPC	No mínimo semanal	Intervalo de 1 a 7 dias, mesmo sem movimento	Anvisa (SNGPC)	RDC 22/2014, art. 10, §§ 3º e 4º
RMNRA com as Notificações A	Mensal	Até o dia 15 do mês seguinte	VISA local ou estadual	Portaria 344/1998, arts. 42 e 72
RMNRB2 com as Notificações B2	Mensal	Até o dia 15 do mês seguinte	VISA local ou estadual	RDC 58/2007, art. 1º, § 4º
BMPO trimestral (drogaria e farmácia)	Trimestral	Até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro	VISA local ou estadual	Portaria 344/1998, art. 69; Portaria 6/1999, art. 104
BSPO trimestral (farmácia com manipulação)	Trimestral	Até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro	VISA local ou estadual	Portaria 344/1998, art. 68; Portaria 6/1999, art. 103
Balanço anual (BMPO ou BSPO)	Anual	Até 31 de janeiro do ano seguinte	VISA local ou estadual	Portaria 344/1998, arts. 68, § 1º, e 69, § 1º
Receita de emergência para visto	Por evento	72 horas	VISA local	Portaria 344/1998, art. 36, § 2º, e art. 55, § 2º
Suspeita de falsificação no recebimento	Por evento	Imediatamente	Autoridade sanitária	RDC 44/2009, art. 34, § 2º
Evento adverso a medicamento	Por evento	Assim que houver dados	VigiMed	RDC 44/2009, art. 67

Obrigação	Periodicidade	Prazo	Para quem	Base legal
Queixa técnica (desvio de qualidade)	Por evento	Assim que houver dados	Notivisa	RDC 44/2009, art. 67
Levantamento de estoque na saída do RT	Por evento	Até o último dia de trabalho	VISA local	Portaria 6/1999, art. 113; RDC 22/2014, art. 12
Renovação da licença sanitária	Conforme norma local	Prazo do código sanitário	VISA local ou estadual	RDC 44/2009, art. 2º, III, e legislação local
Revisão de POPs e registro da divulgação	Periódica	Definida no próprio POP	Registro interno	RDC 44/2009, arts. 87 e 88
Guarda de documentos de controlados	Contínua	2 anos (C3 e talidomida no fornecedor: 5 anos)	Estabelecimento	Portaria 344/1998, art. 64
Guarda da documentação de Boas Práticas	Contínua	Mínimo de 5 anos	Estabelecimento	RDC 44/2009, art. 89

Forma de entrega (papel, e-mail, portal, SEI), número de vias e regra para prazo que cai em fim de semana variam entre VISAs. Os prazos da Portaria 344 são nacionais.

Modelo de campos do BMPO e do BSPO

BMPO (Portaria 344/1998, art. 69, modelo do Anexo XXI)

Bloco	Campos
Identificação	Razão social e endereço; CNPJ; número da licença de funcionamento; farmacêutico responsável e número no CRF
Período	Trimestre (1º, 2º, 3º ou 4º) ou balanço anual; ano
Escopo	Medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2
Por medicamento	Denominação (DCB e nome comercial), concentração e apresentação; estoque inicial; entradas (aquisições); saídas (vendas); perdas; estoque final
Fechamento	Data, assinatura do RT; visto ou protocolo da autoridade sanitária

BSPO (Portaria 344/1998, art. 68; planilha digital orientada pela Anvisa)

Formulário	Campos
Identificação	Razão social; endereço; CNPJ; número da Autorização Especial; exercício (ano); nome completo e CRF do responsável; data do preenchimento; telefone; e-mail

Formulário	Campos
Balanço completo de entrada e saída	Substância (nome exato, com o sal); unidade (mg, g ou kg); estoque inicial; importação; produção; aquisição; venda; transformação; fabricação de não psicotrópicos; fabricação de psicotrópicos; perda; exportação; estoque final calculado
Detalhamentos	Aquisições, vendas, importações e exportações, por operação
Observação	Motivo das perdas e outras explicações

Regra de conta: estoque inicial + entradas, menos saídas e perdas, igual ao estoque final. O estoque inicial do ano é o estoque final do ano anterior. Os campos de identificação do BMPO com CNPJ, licença e CRF são os que as VISAs de São Paulo e de Manaus exigem; confira o leiaute exato do Anexo XXI aceito pela sua VISA, que pode ter modelo próprio. Os campos do BSPO seguem as orientações de preenchimento publicadas pela Anvisa.

Modelo de campos da RMNRA

RMNRA (Portaria 344/1998, art. 72, modelo do Anexo XXIV)

Bloco	Campos
Identificação	Razão social e endereço; CNPJ; número da licença; farmacêutico responsável e número no CRF
Referência	Mês e ano das dispensações
Por notificação	Número da Notificação de Receita A; data da dispensação; medicamento (DCB, concentração, forma); quantidade dispensada; prescritor com inscrição no conselho e UF
Totais	Número de notificações relacionadas, igual ao número de notificações anexadas
Fechamento	Data, assinatura do RT; recibo da VISA na 2ª via

- Entregar em 2 vias, até o dia 15, com as Notificações A anexadas na ordem da relação e as justificativas de quantidade acima do limite (Portaria 344, arts. 42, 43, § 2º, e 72).
- Não incluir preparações dos adendos vendidas com Receita de Controle Especial.
- Notificações A eletrônicas podem ser enviadas em meio eletrônico (art. 72, § 2º-A, incluído pela RDC 1.000/2025).
- A RMNRB2 segue a mesma lógica para Notificações B2, no modelo do anexo II da RDC 58/2007.

O quadro reúne os dados que permitem à VISA conferir cada notificação com o papel. O leiaute exato do Anexo XXIV e eventuais campos extras pedidos pela VISA local devem ser conferidos antes do primeiro envio.

Dia da inspeção

- [ ] Licença sanitária e Certidão de Regularidade Técnica afixadas e dentro da validade
- [ ] Cartaz com razão social, CNPJ, AFE, AE, RT, substitutos, horários e telefones do CRF e da VISA
- [ ] Farmacêutico presente e identificado durante todo o horário
- [ ] Manual de Boas Práticas e POPs assinados, datados e com registro de divulgação
- [ ] Registros de treinamento com lista de presença
- [ ] Planilha de temperatura da geladeira preenchida todos os dias, inclusive fins de semana
- [ ] Produtos afastados de piso, parede e teto; área limpa e protegida de sol e umidade
- [ ] Vencidos, avariados e recolhidos segregados e identificados, fora da área de venda
- [ ] Armário de controlados trancado, chave com o farmacêutico, sem outros produtos
- [ ] Certificado de Escrituração Digital impresso com o RT atual
- [ ] Último arquivo do SNGPC aceito há no máximo 7 dias; lista de arquivos em trânsito à mão
- [ ] Contagem de três ou quatro controlados de giro conferida com o SNGPC no dia
- [ ] Receitas e notificações retidas arquivadas por mês e por tipo
- [ ] Comprovantes de entrega de BMPO, RMNRA e RMNRB2 dos últimos 2 anos
- [ ] Alertas e recolhimentos recentes tratados e registrados
- [ ] Comprovante de controle de pragas e plano de gerenciamento de resíduos
- [ ] Pasta da fiscalização acessível ao substituto e ao gerente

Chegou o fiscal

Fiscal se apresenta na loja

Pedir a identificação funcional e o motivo da inspeção

DECISÃO

O RT está na loja?

SIM
O RT recebe e acompanha toda a visita

NÃO
O farmacêutico presente acompanha e avisa o RT, que vem ou orienta por telefone

Entregar a pasta da fiscalização: documentos, POPs, registros, comprovantes

Abrir o armário de controlados e acompanhar a contagem, anotando os números

DECISÃO

A contagem diverge do SNGPC?

SIM
Procurar arquivo em trânsito, nota não lançada ou receita lançada com erro e mostrar o documento

NÃO
Seguir com o roteiro do fiscal

ATENÇÃO

Não impedir nem atrasar o acesso a áreas e documentos (Lei 6.437/1977, art. 10, X)

Ler cada termo antes de assinar e registrar a discordância no próprio termo

DECISÃO

Foi lavrado auto de infração?

SIM

Anotar o prazo de defesa (15 dias na Lei 6.437), avisar o responsável legal e reunir provas

NÃO

Cumprir as notificações no prazo escrito no termo e comprovar à VISA

Arquivar as vias, corrigir as falhas, revisar POP e registrar o treinamento

SOS Farmácia Comercial

Fechamento do mês

Último dia útil do mês

Resolver pendências do software: vendas sem dados da receita, entradas sem nota

Transmitir o arquivo do SNGPC e confirmar o status aceito

Contar as Notificações A e B2 do mês e gerar a RMNRA e a RMNRB2

DECISÃO

A relação bate com as notificações do envelope?

SIM
Gerar o PDF ou imprimir em 2 vias e assinar

NÃO
Corrigir a escrituração no software e no SNGPC e gerar a relação de novo

DECISÃO

O mês fecha um trimestre (março, junho, setembro, dezembro)?

SIM
Gerar o BMPO (e o BSPO, se houver manipulação) e conferir itens contra a prateleira; em dezembro, preparar também o anual

NÃO
Seguir para o protocolo

Protocolar na VISA antes do dia 15 e salvar o comprovante na pasta da fiscalização

ATENÇÃO

Falta de remessa no prazo é infração (Portaria 344, art. 73)

Arquivar receitas do mês por tipo e baixar vencidos como perda

Registrar a entrega na planilha de controle de obrigações

Elaboração e entrega da RMNRA, da RMNRB2 e dos balanços

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Elaboração e entrega da RMNRA, da RMNRB2 e dos balanços**	Código: **POP-VISA-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Padronizar a geração, a conferência, a entrega e o arquivamento das relações mensais de notificações e dos balanços de controlados exigidos pela Portaria 344/1998, garantindo entrega no prazo e coerência com a escrituração do SNGPC.

Abrangência

Farmacêutico responsável técnico e farmacêuticos substitutos da drogaria; aplica-se às Notificações de Receita A e B2 retidas e aos medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2.

Responsáveis

- Farmacêutico RT: gera, confere, assina e protocola
- Farmacêutico substituto: executa nas ausências do RT
- Responsável legal: garante acesso ao canal de entrega da VISA e guarda dos comprovantes

Materiais

- Software de gestão com módulo de controlados (relatórios de relação mensal e de balanço)
- Acesso ao SNGPC
- Envelopes mensais de Notificações A e B2
- Canal de entrega definido pela VISA (portal, e-mail, SEI ou balcão)
- Planilha de controle de obrigações
- Pasta da fiscalização (física e digital)

Procedimento

1. Durante o mês, guardar cada Notificação A e B2 retida no envelope do mês, na ordem de dispensação, com a justificativa do prescritor quando houver.
2. No último dia útil do mês, resolver as pendências de escrituração no software e transmitir o arquivo ao SNGPC até o status aceito.
3. No 1º dia útil do mês seguinte, gerar no software a RMNRA (listas A1, A2 e A3) e a RMNRB2 do mês anterior, no leiaute aceito pela VISA.
4. Conferir a relação contra o envelope, notificação por notificação: número, data, medicamento, quantidade e prescritor. Conferir o total.
5. Havendo divergência, corrigir primeiro a escrituração no software e no SNGPC, registrar o motivo da correção e gerar a relação de novo.
6. Nos meses de abril, julho, outubro e janeiro, gerar também o BMPO do trimestre anterior (listas A1, A2, A3 e B2); em janeiro, gerar ainda o balanço anual do ano anterior.

7. Conferir no balanço três ou quatro itens contra a prateleira e o estoque do SNGPC; estoque inicial do período deve ser igual ao final do período anterior.
8. Assinar e datar as relações e o balanço; montar o pacote com as notificações anexadas na ordem da relação, ou digitalizar em PDF conforme a VISA.
9. Protocolar pelo canal da VISA até o dia 10, garantindo margem antes do dia 15.
10. Salvar o comprovante de entrega e a via visada na pasta da fiscalização e lançar a data e o número do protocolo na planilha de controle.
11. Acompanhar a devolução das Notificações A pela VISA (até 30 dias da entrega) e arquivá-las na caixa do mês de origem.

Cuidados

- Não incluir na RMNRA as preparações dos adendos das listas A1 e A2 vendidas com Receita de Controle Especial.
- Não ajustar números no balanço para fechar com a prateleira; corrigir a escrituração com documento.
- Clonazepam, alprazolam, zolpidem (B1) e medicamentos das listas C não entram no BMPO.
- Confirmar com a VISA o formato de envio das Notificações A eletrônicas (art. 72, § 2º-A).
- Se o dia 15 cair em fim de semana ou feriado, seguir a regra da VISA local; não presumir prorrogação.
- Nas férias do RT, o substituto executa este POP; a obrigação não é suspensa.

Registros

- Vias visadas ou comprovantes eletrônicos de entrega
- Planilha de controle de obrigações
- Registro de correções de escrituração com motivo
- Notificações devolvidas, arquivadas por mês (2 anos)

Referências

- Portaria SVS/MS 344/1998, arts. 42, 43, 64, 68, 69, 72 e 73
- Portaria SVS/MS 6/1999, arts. 103 e 104
- RDC 58/2007, art. 1º, § 4º
- RDC 22/2014
- RDC 1.000/2025
- RDC 44/2009, arts. 86 a 89
- Orientação da VISA local sobre entrega de balanços e relações

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Cartões de vigilância sanitária

Pergunta	Resposta
O que o BMPO registra?	Vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2 (Portaria 344, art. 69).
Prazo do BMPO trimestral?	Até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro.
Prazo do balanço anual?	Até 31 de janeiro do ano seguinte.
BMPO e BSPO: qual a diferença?	BMPO: medicamentos vendidos. BSPO: substâncias (insumos), típico da farmácia com manipulação e da indústria.
Quem está dispensado do BMPO?	Farmácias de unidades hospitalares e de clínicas médicas e veterinárias (art. 69, § 3º).
O que é a RMNRA?	Relação mensal das Notificações A retidas, entregue com elas à VISA até o dia 15 (art. 72).
Em quanto tempo a VISA devolve as Notificações A?	Em até 30 dias da entrega (art. 72, parágrafo único).
Preparação de adendo vendida com RCE entra na RMNRA?	Não. Só entram Notificações de Receita A.
Base legal da RMNRB2?	RDC 58/2007, art. 1º, § 4º, modelo do anexo II.
O SNGPC acabou com os balanços?	Não. Substituiu o livro (RDC 22/2014, art. 35); balanços e relações da Portaria 344 continuam.
Prazo de guarda das notificações retidas?	2 anos (Portaria 344, art. 64).
Prazo de guarda de manual, POPs e registros?	No mínimo 5 anos (RDC 44/2009, art. 89).
Prazo de defesa contra auto de infração da Lei 6.437?	15 dias da notificação (art. 22).
Pagar a multa em 20 dias dá direito a quê?	Redução de 20%, com desistência da defesa (Lei 6.437, art. 21).
Duração máxima da interdição cautelar?	90 dias; depois disso, liberação automática (Lei 6.437, art. 23, § 4º).
Dificultar a inspeção é infração?	Sim: obstar ou dificultar a ação fiscalizadora (Lei 6.437, art. 10, X).
Evento adverso a medicamento: onde notificar?	VigiMed.
Desvio de qualidade de medicamento: onde notificar?	Notivisa, como queixa técnica.
Quem conduz o recolhimento de um lote?	O detentor do registro (RDC 625/2022); a farmácia localiza, segrega, bloqueia e devolve.

Pergunta	Resposta
Com que frequência registrar a temperatura da geladeira?	Diariamente (RDC 44/2009, art. 35, § 3º).

Questões de vigilância sanitária

1. Uma drogaria vendeu no trimestre metilfenidato, clonazepam, morfina, sertralina e sibutramina. Quais desses medicamentos entram no BMPO?

A Todos, porque todos são escriturados no SNGPC

B Clonazepam, sertralina e sibutramina

C Metilfenidato, morfina e sibutramina

D Apenas metilfenidato e morfina

E Apenas os das listas B1 e C1

2. Qual é o prazo de entrega do BMPO referente ao 3º trimestre (julho a setembro)?

A 15 de outubro do mesmo ano

B 31 de outubro do mesmo ano

C 15 de janeiro do ano seguinte

D 30 de setembro do mesmo ano

E 31 de janeiro do ano seguinte

3. Sobre a Relação Mensal de Notificações de Receita A (RMNRA), assinale a correta.

A É entregue a cada trimestre junto com o BMPO

B Inclui as Receitas de Controle Especial de codeína do adendo

C Dispensa o envio das notificações, que ficam na farmácia

D Vai à VISA até o dia 15, com as Notificações A do mês anterior

E É transmitida pelo SNGPC e dispensa qualquer entrega à VISA local

4. Uma farmácia recebe auto de infração lavrado com base na Lei 6.437/1977. Qual o prazo para apresentar defesa ou impugnação?

A 5 dias úteis da lavratura

B 15 dias da notificação

C 30 dias da lavratura

D 20 dias, só se pagar a multa

E 60 dias da notificação

5. A VISA interditou cautelarmente um lote de medicamento na farmácia enquanto aguarda a análise fiscal. Por quanto tempo, no máximo, essa interdição pode durar?

A 30 dias, prorrogáveis por igual período

B 60 dias corridos

C Até o julgamento do recurso

D Sem prazo, até sair o laudo

E Até 90 dias

6. Cliente devolve uma caixa de comprimidos que estão esfarelando e com manchas, sem relatar reação. Onde o farmacêutico deve notificar?

A No VigiMed, como evento adverso

B No e-SUS Notifica

C No Notivisa, como queixa técnica

D Somente ao fabricante, pelo serviço de atendimento

E No SNGPC, como perda

7. Em outubro de 2026, como uma drogaria privada de Teresina escritura os medicamentos da Portaria 344?

A No SNGPC, sem livro

B Em livro com termo da VISA, além do SNGPC

C Em livro informatizado aprovado pela VISA

D Em livro só para as listas A e no SNGPC para as demais

E Em livro, até a VISA autorizar o SNGPC

8. Por quanto tempo a drogaria deve guardar as Notificações de Receita B retidas?

A 6 meses

B 1 ano

C 5 anos

D 2 anos

E 10 anos

9. A Anvisa determina o recolhimento de um lote de metilfenidato que a drogaria tem em estoque. Qual conduta está correta?

A Vender o que restou no estoque e só depois avisar os clientes

B Segregar sob chave e lançar a saída como perda, com o motivo

C Descartar em lixo comum e dar baixa simples no sistema da loja

D Devolver ao distribuidor sem nota, para agilizar

E Manter na prateleira até a VISA aparecer

10. Durante a inspeção, o fiscal lavra termo com uma exigência da qual o farmacêutico discorda. Qual a conduta mais adequada?

A Recusar-se a assinar o termo, para não confessar a infração

B Impedir a contagem até a chegada do advogado

C Entregar só os documentos que o fiscal citar por número de artigo

D Pedir que o fiscal volte em outro dia

E Assinar e registrar a discordância ou defender-se no prazo

11. Uma farmácia com manipulação compra cloridrato de metilfenidato como matéria-prima. Qual documento periódico consolida a movimentação dessa substância para a VISA?

A BMPO

B RMNRA

C BSPO

D RMV

E MCPM

12. Em outubro de 2026, qual destes documentos ainda deve ser apresentado à VISA em até 72 horas para visto?

A Notificação A de outro estado

B Receita de emergência em papel não oficial

C Receita de Controle Especial de outro estado

D Notificação B2 acompanhada de termo

E Receita de antimicrobiano

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **C**. O BMPO registra vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2 (Portaria 344, art. 69; a C4 citada no texto foi extinta). Morfina é A1, metilfenidato é A3 e sibutramina é B2. Clonazepam (B1) e sertralina (C1) são escriturados no SNGPC, mas não entram no BMPO. Por isso A, B, D e E estão erradas.
2. **A**. O BMPO trimestral é entregue até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro (Portaria 344, art. 69). O trimestre de julho a setembro vence em 15 de outubro. 15 de janeiro é o prazo do 4º trimestre e 31 de janeiro é o do balanço anual (art. 69, § 1º).
3. **D**. A RMNRA é mensal e segue até o dia 15 junto com as respectivas notificações, que a VISA devolve em 30 dias (Portaria 344, arts. 42 e 72). Preparações do adendo vendidas com RCE não entram. O SNGPC não substitui a relação, que continua sendo entregue à VISA.
4. **B**. A defesa ou impugnação cabe em 15 dias contados da notificação (Lei 6.437/1977, art. 22). Os 20 dias do art. 21 são para pagar com redução de 20%, o que implica desistir da defesa. Os outros prazos não existem na lei.
5. **E**. A interdição cautelar dura o tempo necessário às análises e não pode passar de 90 dias; findo o prazo, o produto ou o estabelecimento é liberado automaticamente (Lei 6.437/1977, art. 23, § 4º). As demais alternativas não têm base na lei.
6. **C**. Desvio de qualidade de medicamento é queixa técnica e vai ao Notivisa; o VigiMed recebe eventos adversos (manual da Anvisa para notificação no VigiMed, 2026; RDC 44/2009, art. 67). O e-SUS Notifica é para eventos de vacinas do PNI. O contato com o fabricante não substitui a notificação, e o SNGPC só registra movimentação.
7. **A**. A escrituração no SNGPC substitui o livro de registro (RDC 22/2014, art. 35), e a transmissão é obrigatória em todo o país desde 02/01/2026. O livro sobrevive para farmácias públicas e de hospital, para municípios sem internet com autorização da VISA e para a talidomida em unidades públicas.
8. **D**. Livros, balanços e demais comprovantes de movimentação de controlados ficam no estabelecimento por 2 anos (Portaria 344, art. 64). Cinco anos é o prazo para documentos do fornecedor de C3 e talidomida (art. 64, § 2º) e para a documentação de Boas Práticas (RDC 44/2009, art. 89); dez anos é o do livro de notificação de talidomida da unidade pública.
9. **B**. Produtos sob impedimento de uso são segregados e identificados, e o recolhimento segue a regulamentação específica (RDC 44/2009, art. 38; RDC 625/2022). Sendo controlado, continua sob chave, e a saída é escriturada como perda com o motivo (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV). Vender, descartar em lixo comum ou devolver sem nota são irregulares.
10. **E**. A assinatura indica ciência; a discordância pode ser registrada no termo ou apresentada em defesa no prazo (Lei 6.437/1977, arts. 13 e 22). A recusa não impede o processo e é anotada no auto. Impedir ou atrasar a fiscalização é infração própria (art. 10, X).
11. **C**. O BSPO registra a movimentação de substâncias (insumos) das listas da Portaria 344 (art. 68) e é o balanço típico da farmácia com manipulação. O BMPO trata de vendas de medicamentos; a RMNRA lista Notificações A; a RMV é de indústrias e distribuidoras; o MCPM é de órgãos oficiais que dispensam C3.
12. **B**. A receita de emergência aviada em papel não oficial é apresentada à VISA em 72 horas para visto (Portaria 344, art. 36, § 2º, e art. 55, § 2º). O visto para Notificação A e RCE de outra UF foi revogado pela RDC 873/2024. Notificação B2 e receita de antimicrobiano não vão à VISA para visto.

Módulo 7

Procedimentos operacionais padrão

O que é POP e como se diferencia do Manual, da instrução de trabalho e do registro; estrutura e ciclo de vida; lista dos POPs exigidos na farmácia comercial com o artigo de cada norma; POPs dos serviços farmacêuticos, biossegurança, resíduos e preparo para a inspeção sanitária. Normas centrais: RDC 44/2009 (com as alterações da RDC 786/2023), RDC 978/2025, RDC 80/2006, RDC 197/2017, Lei 14.675/2023, RDC 222/2018, RDC 430/2020, Lei 13.021/2014 e Decreto 10.388/2020.

- Documentação da qualidade e o lugar do POP
- Estrutura e ciclo de vida do POP
- POPs exigidos pelas normas
- Serviços farmacêuticos e seus POPs
- Biossegurança e gerenciamento de resíduos
- Inspeção sanitária

Documentação da qualidade e o lugar do POP

A farmácia comercial funciona com muitas mãos: farmacêutico responsável técnico (RT), farmacêutico substituto, balconistas, operador de caixa, estoquista, entregador e equipe de limpeza. Para que todos façam a mesma tarefa do mesmo modo e com o mesmo cuidado, a tarefa precisa estar escrita. O documento que descreve, passo a passo, como uma atividade rotineira deve ser executada é o **Procedimento Operacional Padrão (POP)**.

A RDC 430/2020, norma de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte, traz uma definição que serve também para a farmácia: POP é o "procedimento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral" (RDC 430/2020, art. 3º, XIX). Três ideias saem dessa definição. O POP é *escrito* (não vale a tradição oral do "sempre fizemos assim"), é *autorizado* (alguém com responsabilidade técnica aprovou) e trata de *operações gerais* (receber mercadoria, limpar a sala de serviços, medir a pressão), e não de um único produto.

Níveis da documentação

Na farmácia, o POP convive com outros documentos. Cada um responde a uma pergunta diferente, e a confusão entre eles é causa frequente de não conformidade na inspeção.

Documento	Pergunta que responde	Exemplo	Base normativa
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	O que a farmácia faz, como se organiza e quais políticas adota	Organograma, atribuições de cada cargo, política para produtos próximos do vencimento	RDC 44/2009, arts. 2º, V; 19; 38, §4º; 85
POP	Como executar uma atividade, quem faz, quando e com que material	POP de recebimento de medicamentos	RDC 44/2009, arts. 86 e 87
Instrução de trabalho	Como operar um equipamento ou detalhar uma etapa	Como reiniciar o termômetro de máxima e mínima	Não citada pela RDC 44; complementa o POP
Registro	Prova de que a atividade aconteceu	Planilha de temperatura assinada; lista de presença do treinamento	RDC 44/2009, arts. 88 e 89

Uma forma simples de fixar: o **Manual** diz o quê e por quê; o **POP** diz como; a **instrução de trabalho** detalha um ponto do como; o **registro** prova que foi feito. O Manual é obrigatório no estabelecimento (RDC 44/2009, art. 2º, V) e deve ser específico para aquela farmácia, de acordo com as atividades que ela realiza (art. 85). Os POPs devem existir "de acordo com o previsto no Manual" (art. 86), ou seja, os dois documentos precisam conversar: se o Manual diz que a farmácia aplica injetáveis, tem de existir POP de administração de medicamentos.

O QUE DIZ A NORMA

"O estabelecimento deve manter Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), de acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, no mínimo, referentes às atividades relacionadas a:" higiene de cada ambiente; aquisição, recebimento e armazenamento; exposição e organização; dispensação; destino dos vencidos; destino dos próximos ao vencimento; serviços farmacêuticos, quando houver; materiais descartáveis e seu destino; e outros já exigidos na própria Resolução (RDC 44/2009, art. 86, I a IX).

Por que a vigilância sanitária cobra POP

A cobrança decorre de quatro amarras da própria RDC 44/2009:

- **Obrigação expressa.** O art. 86 lista os POPs mínimos e o art. 87 fixa como devem ser aprovados. O descumprimento de qualquer disposição da Resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 6.437/1977 (RDC 44/2009, art. 99).
- **Delegação segura.** Os técnicos auxiliares executam as atividades não privativas do farmacêutico "respeitando os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento", sob supervisão do RT ou do substituto (art. 22). Sem POP, não há limite claro do que o balconista pode fazer.
- **Capacitação comprovável.** Todos os funcionários devem ser capacitados na legislação sanitária e nos POPs (art. 24), com registro do treinamento (art. 28) e da divulgação dos POPs (art. 88, III).
- **Rastreabilidade.** Toda a documentação fica no estabelecimento por, no mínimo, 5 anos, à disposição da fiscalização (art. 89).

Na inspeção, o fiscal costuma cruzar três fontes: o POP escrito, a prática que ele observa e o registro que deveria existir. Se o POP diz que a temperatura da geladeira é registrada duas vezes ao dia e a planilha tem lacunas de uma semana, a não conformidade está na prática, mesmo com o POP impecável. Se a equipe faz tudo certo, mas nada está escrito nem registrado, a não conformidade está na documentação.

Características de um bom POP

- **Específico**: descreve a farmácia real, com os equipamentos, o leiaute e a equipe que ela tem.
- **Exequível**: quem executa consegue cumprir no tempo e com o material disponíveis.
- **Claro**: sem ambiguidade e compreensível para quem executa. A RDC 430/2020 (arts. 20 a 22), escrita para distribuidoras, resume bem a ideia: o POP deve estar disponível no local de trabalho, atualizado conforme a prática e sem ambiguidades.
- **Verificável**: diz que registro a atividade gera, de modo que se possa conferir depois.
- **Atual**: cita normas vigentes e é revisto periodicamente (RDC 44/2009, art. 87, §3º).

Quem escreve e quem usa

O farmacêutico RT responde pelo conjunto de POPs, mas o melhor rascunho costuma sair de quem executa a tarefa todos os dias. O estoquista descreve como a mercadoria chega; o farmacêutico confere se a descrição atende à norma e acrescenta os pontos de controle (o que conferir, o que fazer quando falha, o que registrar). Esse modo de trabalhar tem duas vantagens: o texto fica fiel à rotina, e a equipe se

reconhece no documento, o que facilita o cumprimento. Em redes de farmácias, é comum haver POPs corporativos; mesmo nesse caso, cada loja verifica se o texto corresponde aos seus equipamentos e serviços licenciados, porque o Manual e os POPs devem ser específicos para o estabelecimento (RDC 44/2009, art. 85).

Os usuários do POP são todos os que executam ou supervisionam a atividade, inclusive terceirizados. A equipe de limpeza, por exemplo, também recebe treinamento inicial e continuado sobre higiene, conduta e noções de microbiologia (art. 25), e por isso precisa conhecer o POP de limpeza.

ATENÇÃO

POP copiado de outra loja ou baixado da internet costuma citar equipamentos que a farmácia não tem, normas revogadas (por exemplo, a RDC 306/2004 de resíduos, revogada pela RDC 222/2018, art. 92) e responsáveis que não existem. Para o fiscal, isso mostra que o documento não descreve a rotina real.

CASO

Farmacêutica recém-formada assume a responsabilidade técnica de uma drogaria de bairro. Encontra uma pasta com 14 POPs datados de 2016, sem assinatura, um deles citando a RDC 306/2004. Conduta: listar os POPs existentes e as atividades reais da loja; comparar com o art. 86 da RDC 44/2009 e com os serviços licenciados; reescrever o que estiver desatualizado; aprovar, assinar e datar cada POP (art. 87); treinar a equipe e registrar o treinamento (art. 28); arquivar as versões antigas como obsoletas.

NO BALCÃO

Quando um balconista pergunta "o que eu faço se a geladeira apitar à noite?" ou "posso receber o pedido sem o farmacêutico?", a resposta deve estar em um POP que ele já leu e assinou. O RT deixa cópia controlada dos POPs de uso diário perto do ponto de uso (balcão, recebimento, sala de serviços) e orienta a equipe a consultar antes de improvisar.

Estrutura e ciclo de vida do POP

Não existe modelo oficial de POP para farmácias. A RDC 44/2009 diz o que o POP precisa ter em alguns casos (por exemplo, equipamentos, técnica, critérios de interpretação, referências e EPI nos serviços: arts. 72, 80 e 83) e como ele deve ser aprovado e mantido (art. 87). O formato fica a critério do estabelecimento. A estrutura abaixo reúne o que as normas pedem e o que a prática de gestão da qualidade consagrou.

Cabeçalho

Campo	O que escrever	Exemplo
Identificação do estabelecimento	Razão social ou nome fantasia, unidade	Drogaria Bairro Novo, loja 2

Campo	O que escrever	Exemplo
Título	Substantivo que nomeia a atividade	Recebimento de medicamentos
Código	Sigla do processo e número sequencial	POP-REC-01
Versão e vigência	Número da revisão e data a partir da qual vale	Versão 03, vigente desde 01/10/2026
Paginação	Página atual e total	Página 2 de 4
Elaboração, revisão e aprovação	Nome, cargo, data e assinatura; aprovação sempre do RT	Aprovado por: farmacêutica RT, CRF-XX 0000

Corpo do POP

1. **Objetivo**: uma frase com a finalidade. Exemplo: "Garantir que somente produtos regulares, íntegros e transportados nas condições do fabricante entrem no estoque".
2. **Abrangência**: onde e a quem se aplica (setor, turno, loja).
3. **Responsáveis**: por cargo, não por nome (quem executa, quem supervisiona, quem aprova exceções). Nomes mudam; cargos ficam.
4. **Definições e siglas**: PVPS, FEFO, DSF, EPI, quarentena.
5. **Materiais e equipamentos**: tudo o que precisa estar à mão, com especificação quando importa (termômetro calibrado, aparelho de pressão validado).
6. **Procedimento**: passos numerados, na ordem em que acontecem, cada um com uma ação.
7. **Cuidados e ações corretivas**: o que fazer quando algo foge do previsto. A RDC 44/2009 exige isso de forma expressa para o armazenamento: o POP "deverá definir medidas a serem tomadas quando forem verificadas condições inadequadas" (art. 35, §5º).
8. **Registros**: nome do formulário gerado, onde fica e por quanto tempo é guardado (mínimo de 5 anos, art. 89).
9. **Referências**: normas e bibliografia. Nos POPs de aferição de parâmetros e exames, e no de perfuração de lóbulo, a referência bibliográfica é exigência da norma (arts. 72 e 80, §1º).
10. **Anexos**: modelos de formulário, fluxogramas, tabelas de referência.
11. **Histórico de revisões**: versão, data, o que mudou e por quê.

Como escrever o procedimento

- Comece cada passo com verbo de ação: "Conferir", "Registrar", "Segregar", "Comunicar".
- Uma ação por passo. "Conferir a nota e guardar os produtos" são dois passos, porque podem falhar em momentos diferentes.
- Troque adjetivos vagos por critério verificável. "Manter em temperatura adequada" não serve; "manter entre 2 °C e 8 °C, conforme a embalagem" serve.
- Diga o que fazer quando o critério não é atendido. Todo "conferir" pede um "se não conferir, então".

- Teste o rascunho com quem executa. Se o estoquista não consegue seguir sem perguntar, o texto precisa mudar.
- Evite repetir a norma inteira. Cite o artigo e escreva a rotina da loja.

Compare duas versões do mesmo passo de um POP de recebimento:

Versão fraca	Versão adequada
Conferir a mercadoria com atenção.	Conferir, item a item, nome, apresentação, quantidade, lote e fabricante da nota fiscal contra o produto recebido.
Guardar a insulina rapidamente.	Abrir primeiro os volumes refrigerados, registrar a temperatura de chegada e guardar na geladeira em até 15 minutos após a abertura do volume.
Se houver problema, avisar.	Em divergência, preencher o formulário de não conformidade, colocar etiqueta de quarentena e comunicar o farmacêutico no mesmo turno.

O prazo de 15 minutos do exemplo é uma escolha do estabelecimento, não um número da norma. O POP pode e deve fixar limites internos quando a norma diz apenas "minimizar" ou "em tempo adequado", desde que o limite seja razoável e seguido.

Ciclo de vida

O POP nasce, é usado, envelhece e é substituído. A RDC 44/2009 (art. 87) estabelece os pontos obrigatórios desse ciclo:

Etapa	O que acontece	Exigência
Elaboração	Quem executa a atividade descreve a rotina; o farmacêutico ajusta à norma	Coerência com o Manual (art. 86)
Aprovação	RT aprova, assina e data	Art. 87, caput
Divulgação e treinamento	Equipe envolvida lê, recebe treinamento e assina	Art. 87, §2º; art. 88, III; art. 28
Uso	Cópia controlada no local de trabalho; registros preenchidos	Art. 88
Revisão periódica	Atualização ou correção	Art. 87, §3º (prazo definido pela farmácia)
Alteração	Nova versão que preserve o conhecimento do texto original e justifique a mudança	Art. 87, §1º
Obsolescência	Cópias antigas recolhidas; original arquivado	Guarda de 5 anos (art. 89)

A RDC 44/2009 não fixa a periodicidade da revisão. O usual é definir no Manual um prazo (anual ou a cada dois anos, por exemplo) e prever revisão extraordinária quando: muda a norma; troca o equipamento;

muda o leiaute; acontece um incidente, uma reclamação ou um erro de dispensação; a inspeção aponta falha; um novo serviço é licenciado.

Registro do treinamento

Treinamento sem registro não existe para a fiscalização. A RDC 44/2009 (art. 28) exige que o registro contenha, no mínimo: descrição da atividade de capacitação; data e carga horária; conteúdo ministrado; trabalhadores treinados e suas assinaturas; identificação e assinatura de quem ministrou; e resultado da avaliação. Uma lista de presença sem conteúdo e sem avaliação não atende ao artigo.

Controle de cópias

- Mantenha uma **lista mestra** com código, título, versão vigente, data de aprovação e data prevista de revisão de cada POP.
- Identifique as cópias de uso como "cópia controlada" e saiba onde cada uma está.
- Ao aprovar nova versão, recolha as cópias antigas no mesmo dia; versão obsoleta circulando é fonte clássica de erro.
- Se os POPs forem eletrônicos, controle quem pode editar e garanta que a versão impressa, quando houver, seja a vigente.

PONTO-CHAVE

POP válido é POP aprovado, assinado e datado pelo farmacêutico RT (RDC 44/2009, art. 87). Assinatura do gerente ou do proprietário não substitui a do RT. O RT pode delegar atribuições a outro farmacêutico, exceto as indelegáveis e as de supervisão da assistência técnica (art. 20, parágrafo único).

CASO

A farmácia troca o termômetro analógico da geladeira por um registrador eletrônico (datalogger) com alarme. O POP de controle de temperatura descrevia leitura manual e reinício do termômetro. Conduta: revisar o POP (nova versão, com motivo "troca de equipamento"), incluir como baixar e arquivar os dados, como responder ao alarme e quem recebe o aviso fora do horário; treinar a equipe; recolher a versão antiga.

NO BALCÃO

Farmacêutico substituto que cobre folgas e plantões precisa conhecer os POPs tanto quanto o RT. No primeiro dia, ele lê a lista mestra, assina o registro de divulgação e confere onde ficam as cópias e os formulários.

POPs exigidos pelas normas

O art. 86 da RDC 44/2009 traz a lista mínima de POPs, mas termina com o inciso IX, "outros já exigidos nesta Resolução". Isso obriga o farmacêutico a ler a Resolução inteira, porque vários artigos espalhados

pedem procedimento escrito. Outras normas acrescentam exigências conforme o que a farmácia faz: fracionamento, vacinação, exames de análises clínicas, resíduos, controlados.

RDC 44/2009: o que precisa estar escrito

Artigo	O que a norma exige	POP correspondente
Art. 12	Procedimentos escritos para limpeza da caixa d'água própria e registros da limpeza	Limpeza da caixa d'água
Arts. 16, 83 e 86, I	Higiene de cada ambiente; limpeza da sala de serviços registrada no início e no fim do dia	Limpeza e higienização
Arts. 31, 32 e 86, II	Critérios de aquisição; recebimento em área específica, por pessoa treinada, conforme POP	Aquisição e recebimento
Art. 35, §§ 4º e 5º	Metodologia de verificação de temperatura e umidade, faixa de horário de maior risco e medidas corretivas	Controle de temperatura e umidade
Art. 39	Justificativa e guarda de corrosivos, inflamáveis e explosivos, longe de calor e faíscas	Armazenamento de inflamáveis e corrosivos
Art. 86, III	Exposição e organização dos produtos	Exposição e organização
Art. 86, IV	Dispensação de medicamentos	Dispensação (geral, controlados, antimicrobianos)
Arts. 51 e 86, V e VI	Destino dos vencidos; política para próximos do vencimento, descrita em POP e no Manual	Controle de validade
Art. 56, §3º	Condições de transporte de medicamentos solicitados por meio remoto	Entrega e transporte
Arts. 64 e 65	Protocolos de atenção farmacêutica e metodologia de avaliação dos resultados	Serviços farmacêuticos
Art. 72	Instruções escritas para aferição de parâmetros fisiológicos e exames de análises clínicas: equipamento, técnica, interpretação, referências e EPI	Pressão arterial; temperatura; glicemia capilar
Art. 80	Antissepsia do lóbulo e das mãos, uso e assepsia do aparelho, EPI e referência bibliográfica	Perfuração de lóbulo auricular
Art. 86, VII e VIII	Serviços farmacêuticos prestados; uso e destino dos materiais descartáveis	Cada serviço; resíduos

A redação do art. 72 foi alterada pela RDC 786/2023 (art. 155), que passou a falar em "instruções escritas" e incluiu os exames de análises clínicas. Na prática, essas instruções escritas são os POPs dos serviços.

O QUE DIZ A NORMA

"Deve ser definida em Procedimento Operacional Padrão (POP) a metodologia de verificação da temperatura e umidade, especificando faixa de horário para medida considerando aquela na qual há maior probabilidade de se encontrar a maior temperatura e umidade do dia" (RDC 44/2009, art. 35, §4º).

Outras normas

Norma	Quando se aplica	O que pede por escrito
RDC 80/2006 (fracionamento)	Farmácia que fraciona a partir de embalagem fracionável	Procedimentos escritos para prevenir trocas ou misturas, com vedação de fracionar mais de um medicamento ao mesmo tempo (Anexo I, Parte II, item 4.6); procedimentos para rotulagem e embalagem dos fracionados (item 4.8.2)
RDC 222/2018 (resíduos)	Toda farmácia e drogaria (art. 2º, §1º)	PGRSS com procedimentos de geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, ações em emergências e acidentes, controle de pragas e capacitação (arts. 5º e 6º)
RDC 197/2017 (vacinação)	Farmácia licenciada para vacinar	Procedimentos para preservar as vacinas no transporte (art. 12); gerenciamento de tecnologias e processos, inclusive conservação em falta de energia e registro diário de máxima e mínima (art. 11)
Lei 14.675/2023	Serviços privados de vacinação	Gerenciar tecnologias, processos e procedimentos; adotar procedimentos para manter as vacinas na rede de frio, inclusive no transporte (art. 5º, II e III)
Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025	Serviços privados que armazenam vacinas	POP específico para excursão de temperatura, com fluxo de notificação e contatos dos laboratórios
RDC 978/2025 (exames de análises clínicas)	Farmácia licenciada como Serviço Tipo I	Instruções escritas de biossegurança (art. 110); de limpeza e desinfecção (art. 112); procedimentos de registro e liberação de resultados e de resultados potencialmente críticos (art. 119)
Decreto 10.388/2020 (logística reversa)	Farmácia que é ponto fixo de recebimento	Não exige POP nominalmente, mas exige armazenamento primário e registro da massa recebida no manifesto de transporte (art. 12)

POPs esperados pela boa prática

Alguns procedimentos não aparecem com o nome "POP" na norma, mas o fiscal espera encontrá-los porque a norma exige o resultado que eles produzem:

- **Reclamações, queixas técnicas e farmacovigilância**: o farmacêutico deve notificar evento adverso e queixa técnica (RDC 44/2009, art. 67; Lei 13.021/2014, art. 13, I); suspeita de falsificação exige segregação e notificação imediata (RDC 44/2009, art. 34, §§ 1º e 2º).

- **Recolhimento**: produtos recolhidos por ato da vigilância ou por iniciativa do fabricante seguem regulamentação específica (art. 38, §3º).
- **Dispensação de controlados e antimicrobianos**: Portaria SVS/MS 344/1998, RDC 22/2014 (SNGPC), RDC 471/2021 e suas alterações.
- **Higienização das mãos e conduta em acidentes**: antissepsia das mãos antes de qualquer serviço (art. 84) e instrução sobre acidentes (art. 27).
- **Calibração e manutenção de equipamentos**: registros obrigatórios (arts. 71 e 77, parágrafo único; art. 88, V).
- **Controle de pragas**: executado por empresa licenciada, com registros (art. 7º).
- **Contingência para termolábeis**: o que fazer em queda de energia ou pane da geladeira, como desdobramento do art. 35, §5º.

Fracionamento e dispensação remota

Duas atividades costumam ser esquecidas na lista de POPs porque nem toda farmácia as pratica. No **fracionamento**, a RDC 80/2006 exige que a operação ocorra só depois da apresentação da prescrição, na quantidade exata prescrita e com dispensação imediata, sendo vedado fracionar antecipadamente (Anexo I, Parte II, item 4.1), a partir de embalagem original fracionável (item 4.3), com registro prévio à dispensação (item 4.5). O POP descreve a prevenção de trocas, com um medicamento fracionado por vez (item 4.6), e a rotulagem da embalagem secundária para fracionados (item 4.8.2). Na **dispensação remota** (telefone, site, aplicativo), o transporte é responsabilidade da farmácia, com embalagem que mantenha a temperatura dos termossensíveis e sem misturar medicamentos com produtos que os afetem, e o POP de transporte precisa ser incorporado à rotina de maneira sistemática (RDC 44/2009, art. 56, §§ 1º a 3º). Junto do pedido vai cartão com nome do farmacêutico, telefone e endereço (art. 58, §2º).

CASO

Na inspeção de uma drogaria, o fiscal encontra álcool etílico 70% líquido e acetona estocados ao lado do quadro de energia. Não há POP sobre inflamáveis. Resultado: não conformidade pelo art. 39 da RDC 44/2009, que exige justificativa em POP e guarda longe de fontes de calor e de materiais que provoquem faíscas. Correção: mudar o local, escrever o POP e treinar o estoquista.

ATENÇÃO

Serviço farmacêutico só é regular se estiver indicado no licenciamento do estabelecimento (RDC 44/2009, art. 61, §3º). Ter POP de aplicação de injetáveis não autoriza o serviço; a licença sanitária precisa citá-lo, após inspeção prévia (art. 61, §4º).

NO BALCÃO

Antes de oferecer um serviço novo (por exemplo, teste rápido), o farmacêutico confere três coisas na ordem: se a norma permite, se a licença da loja inclui a atividade e se o POP está aprovado e a equipe treinada.

Serviços farmacêuticos e seus POPs

A Lei 13.021/2014 define a farmácia como "unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva" (art. 3º) e permite que ela disponha de vacinas e soros conforme o perfil epidemiológico da região (art. 7º). Os requisitos sanitários dos serviços estão na RDC 44/2009, com as mudanças feitas pela RDC 786/2023, e em normas específicas para exames, vacinas e resíduos.

Base legal atual

Desde a RDC 786/2023 (art. 155), a RDC 44/2009 diz que a atenção farmacêutica compreende "a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, a execução de Exames de Análises Clínicas nos termos da legislação vigente e a administração de medicamentos" (art. 61, §2º). Continuam serviços permitidos a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular (art. 61, §1º). Três regras valem para todos:

- só é regular o serviço indicado no licenciamento do estabelecimento (art. 61, §3º), permitido após inspeção prévia (§4º);
- é vedado prestar serviço não abrangido pela Resolução (§5º) e usar dependência da farmácia como consultório (art. 90);
- o ambiente de serviços é separado da área de dispensação, com privacidade, lavatório com sabonete líquido, toalha descartável, gel antisséptico, lixeira com pedal e tampa, e material de primeiros socorros (art. 15); a limpeza é registrada no início e no fim do funcionamento (art. 16).

Serviço	Base normativa	O POP precisa trazer	Registro
Pressão arterial	RDC 44/2009, arts. 69, §1º, 71 e 72	Aparelho, técnica, interpretação, referência, EPI, condutas	Ficha do atendimento e DSF
Temperatura corporal	RDC 44/2009, art. 69, §1º	Termômetro, local de medida, valores de referência	DSF
Glicemia capilar e outros exames	RDC 44/2009, art. 61, §2º; RDC 978/2025	Técnica, controle de qualidade, resultados críticos, biossegurança	Registro do exame e DSF
Administração de medicamentos	RDC 44/2009, arts. 74 a 77	Avaliação da receita, técnica por via, EPI, conduta em reação	DSF com lote e registro na Anvisa
Vacinação	RDC 197/2017; Lei 14.675/2023; Resolução CFF 654/2018	Rede de frio, triagem, preparo, aplicação, eventos adversos	Cartão, sistema do Ministério da Saúde, prontuário
Perfuração de lóbulo	RDC 44/2009, arts. 78 a 80	Antissepsia, aparelho, EPI, referência bibliográfica	DSF

Aferição de pressão arterial e temperatura

Os parâmetros fisiológicos permitidos continuam sendo a pressão arterial e a temperatura corporal (RDC 44/2009, art. 69, §1º). A aferição serve à assistência farmacêutica e à orientação sanitária, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (art. 69, caput, redação da RDC 786/2023). Diante de valor fora da referência, o usuário é orientado a procurar assistência médica (§3º), e o farmacêutico não pode indicar nem alterar medicamento de venda sob prescrição (§4º).

O POP de pressão arterial segue a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025: aparelho automático de braço validado (recomendação da diretriz para reduzir erros), manguito adequado à circunferência do braço, repouso sentado, três medidas com intervalo de 1 minuto e uso da média das duas últimas, com medidas adicionais se a diferença passar de 10 mmHg. Para interpretação, a diretriz classifica a PA de consultório em adultos como normal (abaixo de 120/80 mmHg), pré-hipertensão (120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg) e hipertensão a partir de 140 e/ou 90 mmHg. Valores iguais ou acima de 180/110 mmHg indicam elevação importante, e a presença de sintomas como dor no peito, falta de ar ou déficit neurológico pede encaminhamento de urgência.

Glicemia capilar e exames de análises clínicas

Esse é o ponto que mais mudou. A RDC 786/2023 revogou o §2º do art. 69 e o art. 70 da RDC 44/2009, que limitavam o parâmetro bioquímico à glicemia capilar por equipamento de autoteste. A própria RDC 786/2023 foi revogada e substituída pela **RDC 978/2025** (vigente desde 10/06/2025), que regula todos os serviços que executam exames de análises clínicas (EAC).

- A farmácia pode ser classificada como **Serviço Tipo I** (RDC 978/2025, art. 8º) se executar exames apenas em amostra obtida por punção capilar, coleta em cavidade oral ou swab de nasofaringe ou orofaringe (art. 10, I, com a redação da RDC 986/2025), fizer todas as etapas no próprio local, inclusive controle interno e externo da qualidade, não guardar nem transportar material biológico, não usar metodologia própria e não usar água reagente produzida no serviço (art. 10).
- O exame é feito exclusivamente por profissional legalmente habilitado (art. 11) e tem finalidade de triagem, sem fins confirmatórios (art. 60). O resultado consta na Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 60, §2º).
- A licença precisa indicar as atividades de EAC (art. 63). A sala de coleta e execução tem lavatório, bancada, mesa, cadeira, recipientes para perfurocortantes e resíduos e, se houver reagente que exija frio, refrigeração exclusiva com registro de máxima, mínima e momento (art. 14).
- Segundo o documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre a RDC 978/2025 (versão revisada de agosto de 2025), a glicemia capilar feita pelo farmacêutico é permitida em farmácia Serviço Tipo I que cumpra os requisitos; quando um autoteste é usado pelo farmacêutico dentro da farmácia, a atividade é EAC e exige controle interno e externo da qualidade. A venda de autoteste para uso do cliente em casa continua livre.

ATENÇÃO

Farmácia que mede glicemia sem licença que inclua EAC, sem controle de qualidade registrado e sem descarte correto das lancetas está irregular, ainda que o glicosímetro seja de autoteste. Confirme também a legislação estadual e municipal, que pode trazer exigências adicionais.

Administração de medicamentos

A farmácia pode administrar medicamentos no contexto do acompanhamento farmacoterapêutico, vedados os de uso exclusivo hospitalar (RDC 44/2009, art. 74). Medicamento de venda sob prescrição só é administrado com receita avaliada pelo farmacêutico, que contata o prescritor em caso de dúvida e confere a validade antes de aplicar (art. 75). Se o cliente comprou na loja um frasco de múltiplas doses, a sobra é entregue a ele, com orientação de conservação, e a farmácia não pode armazenar medicamento com embalagem primária violada (art. 76). Materiais e aparelhos devem ser regularizados na Anvisa, com registro de manutenção e calibração (art. 77).

Vacinação

A farmácia que vacina segue a RDC 197/2017 e a Lei 14.675/2023: licença sanitária para a atividade, inscrição no CNES, calendário do SUS afixado, responsável técnico e substituto (a lei admite RT com formação médica, farmacêutica ou de enfermagem, art. 2º), profissional habilitado durante todo o período do serviço, capacitação periódica registrada, sala de vacinação com refrigerador exclusivo regularizado na Anvisa, termômetro de momento com máxima e mínima e caixa térmica (RDC 197/2017, arts. 4º a 10). Vacinas fora do Calendário Nacional, em estabelecimento privado, só com prescrição médica (art. 14). O serviço registra a vacina no cartão e no sistema definido pelo Ministério da Saúde, mantém prontuário, notifica eventos adversos e erros de vacinação (art. 15; Lei 14.675/2023, art. 5º). O usuário tem direito de acompanhar a retirada da vacina da geladeira e conferir nome e validade (Lei 14.675/2023, art. 8º). A atuação do farmacêutico é disciplinada pela Resolução CFF 654/2018, mantida pelo TRF1 em 2026.

Perfuração de lóbulo auricular

Continua permitida (RDC 44/2009, art. 61, §1º). Exige aparelho específico que use o próprio brinco como material perfurante; é vedado usar agulha de injeção, agulha de sutura ou outro objeto (art. 78). Brincos e pistola regularizados na Anvisa, brinco estéril aberto só no ambiente do serviço, à vista do usuário, após a antissepsia (art. 79). O POP descreve a antissepsia do lóbulo e das mãos, o uso e a assepsia do aparelho, os EPIs e a referência bibliográfica (art. 80). Alguns estados têm lei própria, como São Paulo (Lei 16.660/2018) e Ceará (Lei 16.503/2017), que vedam a reutilização de brincos. A norma fala apenas em lóbulo; cartilagem não está incluída.

Registro do serviço e Declaração de Serviço Farmacêutico

As atividades de atenção farmacêutica são documentadas com consentimento expresso do usuário, com nome, endereço e telefone, orientações, intervenções, resultados e identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (art. 64). Após o serviço, o usuário recebe a **Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF)** (art. 81), em papel com identificação do estabelecimento (nome, endereço, telefone, CNPJ) e do usuário, contendo conforme o caso: medicamento prescrito e dados do prescritor; medicamento isento indicado e posologia; valores medidos e resultados de exames com os valores de referência; dados do medicamento administrado (nome comercial, exceto genérico; DCB; concentração e forma; via; lote; registro na Anvisa); orientação; plano de intervenção; data, assinatura e carimbo com o CRF. Quando houver aferição ou exame, entra a frase, na redação dada pela RDC 786/2023: "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA". Os dados são sigilosos (art. 82).

NO BALCÃO

Cliente de 58 anos, sem sintomas, mede a PA na farmácia: média de 168/102 mmHg. O farmacêutico registra, entrega a DSF com os valores e a referência, orienta procurar a unidade de saúde nos próximos dias e não sugere anti-hipertensivo. Se o mesmo cliente relatasse dor no peito ou fraqueza em um lado do corpo, a conduta seria acionar o SAMU (192) sem demora.

Biossegurança e gerenciamento de resíduos

Biossegurança é o conjunto de medidas que protege o trabalhador, o cliente e o ambiente dos riscos dos procedimentos. Na farmácia, os riscos mais comuns são a picada com lanceta ou agulha usada, o contato com sangue, a transmissão de microrganismos pelas mãos e o descarte errado de medicamentos e perfurocortantes. A RDC 44/2009 trata do tema nos serviços (arts. 18, 26, 27, 73, 83 e 84) e remete o descarte à RDC 222/2018.

Higienização das mãos

"A execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida da anti-sepsia das mãos do profissional, independente do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)" (RDC 44/2009, art. 84). Luva não substitui a higienização. O POP define:

- **quando**: antes de tocar o cliente, antes de procedimento que rompe a pele (punção, injeção, perfuração), depois de risco de contato com sangue, depois de tocar o cliente e depois de tocar superfícies próximas a ele (os momentos recomendados pela OMS e pela Anvisa);
- **como**: água e sabonete líquido quando as mãos estão visivelmente sujas; preparação alcoólica nas demais situações; técnica com todas as faces das mãos, entre os dedos, polegares e pontas dos dedos;
- **com quê**: lavatório com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e gel antisséptico na sala de serviços (art. 15, §2º).

Equipamentos de proteção individual

A farmácia disponibiliza EPI a quem presta serviços (art. 18) e oferece treinamento inicial e contínuo sobre uso e descarte, de acordo com o PGRSS (art. 26). Os POPs de serviços especificam o EPI de cada procedimento (arts. 72 e 80, §2º): luvas de procedimento para punção capilar, injeções e perfuração; jaleco; proteção ocular e máscara quando houver risco de respingo. Luvas são trocadas a cada cliente e descartadas como resíduo, e as mãos são higienizadas depois de retirá-las.

Procedimento	EPI mínimo sugerido	Observação
Pressão arterial e temperatura	Nenhum obrigatório; higienização das mãos	Luvas se houver lesão de pele ou secreção
Glicemia capilar e testes por punção	Luvas de procedimento, jaleco	Trocar luvas a cada cliente

Procedimento	EPI mínimo sugerido	Observação
Teste por swab nasal ou orofaríngeo	Luvas, jaleco, máscara, proteção ocular	Conforme instrução escrita de biossegurança (RDC 978/2025, art. 110)
Injetáveis e vacinas	Luvas de procedimento, jaleco	Proteção ocular se houver risco de respingo
Perfuração de lóbulo	Luvas de procedimento, jaleco	EPI especificado no POP (RDC 44/2009, art. 80, §2º)
Limpeza e manuseio de resíduos	Luvas de borracha, calçado fechado	Nunca manipular conteúdo de coletor de perfurocortantes

A tabela é um ponto de partida. O POP de cada serviço define o EPI com base no risco do procedimento e nas instruções dos fabricantes dos produtos usados.

Perfurocortantes

Lancetas, agulhas, ampolas de vidro e escalpes são resíduos do **Grupo E** (RDC 222/2018, Anexo I). Regras do POP:

- descartar em recipiente identificado, rígido, com tampa, resistente à punctura, ruptura e vazamento (art. 86), posicionado ao alcance da mão de quem aplica;
- substituir o recipiente quando atingir 3/4 da capacidade, ou conforme o fabricante, sendo proibido esvaziá-lo ou reaproveitá-lo (art. 87);
- não reencapar nem desconectar a agulha manualmente; a separação seringa e agulha só com dispositivo de segurança (art. 89, parágrafo único);
- agulhas de aplicação de vacinas, se não desconectadas, seguem o manejo de perfurocortante (art. 47, parágrafo único).

ATENÇÃO

Acidente com material perfurocortante é emergência. O POP de biossegurança (RDC 44/2009, art. 27) orienta: lavar o local com água e sabão, sem espremer; comunicar o farmacêutico RT; identificar, se possível, a fonte (o cliente atendido); encaminhar o trabalhador logo ao serviço de referência para avaliação de profilaxia; registrar o acidente e emitir a comunicação de acidente de trabalho quando cabível.

PGRSS

Farmácias e drogarias são geradoras de resíduos de serviços de saúde (RDC 222/2018, art. 2º, §1º) e devem possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o **PGRSS** (RDC 44/2009, art. 97; RDC 222/2018, art. 5º). Se a farmácia gera só resíduos do Grupo D (comuns), o PGRSS pode ser substituído por notificação à vigilância sanitária, conforme orientação local (art. 5º, §1º). O PGRSS estima a quantidade gerada por grupo, descreve o manejo da geração à disposição final, as ações em emergências, o controle de pragas e a capacitação, e traz cópia do contrato e da licença ambiental das empresas que coletam e tratam os resíduos (art. 6º). Ele é monitorado e atualizado (art. 7º).

Resíduo na farmácia	Grupo (RDC 222/2018)	Destino
Lancetas, agulhas, ampolas	E	Coletor rígido; troca a 3/4; coleta por empresa licenciada
Algodão e gaze com pequena quantidade de sangue (sem sangue livre)	A4	Saco branco leitoso; não exige tratamento prévio (art. 53)
Vacina vencida, com sobra ou frasco aberto	A1	Tratamento antes da disposição final (art. 47)
Medicamentos vencidos ou avariados do estoque	B	Conforme PGRSS e empresa licenciada; hormônios, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores e antirretrovirais vão para tratamento ou aterro Classe I (art. 59)
Embalagem secundária limpa (cartucho)	D	Descaracterizar a rotulagem; pode ir para reciclagem (art. 62)
Luvas sem contato com sangue, papel, copos	D	Lixo comum ou reciclável conforme PGRSS

Medicamentos vencidos da própria farmácia

Vencidos, violados e suspeitos de falsificação são segregados em ambiente seguro, fora da área de dispensação, identificados quanto à condição e ao destino, para que não voltem ao consumo (RDC 44/2009, art. 38). Não podem ser vendidos nem usados, e a inutilização segue a legislação de resíduos e as normas locais (art. 38, §§ 1º e 2º). Controlados vencidos seguem, além disso, as regras de baixa e inutilização da Portaria 344/1998 e da vigilância local. A política para produtos próximos do vencimento fica clara para todos e descrita no Manual (art. 38, §4º) e em POP (art. 51).

Medicamentos trazidos pelos clientes

O Decreto 10.388/2020 instituiu a logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. Farmácias e drogarias que são pontos fixos de recebimento mantêm, às suas expensas, **dispensador contentor** com sistema antirretorno, na proporção mínima de um ponto para cada 10 mil habitantes nos municípios com mais de 100 mil habitantes (art. 10). O dispensador traz a frase "Descarte aqui os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso" (art. 11). A farmácia disponibiliza local de armazenamento primário quando necessário e registra a massa recebida, em quilogramas, no manifesto de transporte de resíduos antes da transferência ao distribuidor (art. 12). Os distribuidores coletam (art. 14), e fabricantes e importadores custeiam a destinação final (arts. 15 e 18). A RDC 44/2009 também permite que farmácias participem de programas de coleta (art. 93).

PONTO-CHAVE

O Decreto 10.388/2020 não se aplica a medicamentos descartados por prestadores de serviços de saúde (art. 5º, III). O vencido do estoque da farmácia não vai para o coletor do cliente; ele segue o PGRSS, como resíduo do serviço.

NO BALCÃO

Cliente chega com uma sacola de remédios vencidos da mãe, incluindo canetas de insulina com agulha acoplada. O balconista orienta a depositar comprimidos, frascos e cartelas no dispensador contentor, conforme as instruções afixadas nele. As agulhas não vão soltas no coletor: o farmacêutico verifica se o ponto aceita perfurocortantes ou indica o serviço público que recebe, e orienta, nas próximas vezes, guardar as agulhas em frasco rígido com tampa.

Inspeção sanitária

A inspeção sanitária é a visita do fiscal da vigilância sanitária (municipal, estadual ou, em situações específicas, da Anvisa) para verificar se o estabelecimento cumpre as normas. Ela acontece antes da concessão ou renovação da licença, antes de liberar novo serviço (RDC 44/2009, art. 61, §4º), por denúncia, em ações programadas ou após alerta sanitário. O Conselho Regional de Farmácia faz uma fiscalização diferente, voltada ao exercício profissional (presença do farmacêutico, responsabilidade técnica, ética), com base na Lei 13.021/2014.

Documentos que devem estar à mão

Documento	Exigência
Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa; Autorização Especial (AE), quando aplicável	RDC 44/2009, art. 2º, I e II
Licença ou alvará sanitário, afixado em local visível	Art. 2º, III, e §1º
Certidão de Regularidade Técnica do CRF, afixada em local visível	Art. 2º, IV, e §1º
Cartaz com razão social, CNPJ, AFE, AE, nome e CRF do RT e substitutos, horário de cada farmacêutico, quando esses dados não constarem dos documentos afixados	Art. 2º, §2º
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	Arts. 2º, V, e 85
POPs aprovados, assinados e datados pelo RT	Arts. 86 e 87
Registros de treinamento e de divulgação dos POPs	Arts. 28 e 88, I e III
Registros de temperatura e umidade	Art. 35, §§ 3º e 4º
Registros de limpeza (incluindo sala de serviços e caixa d'água)	Arts. 12 e 16
Comprovantes de desratização e desinsetização por empresa licenciada	Arts. 7º e 88, IV
Registros de manutenção e calibração de equipamentos	Arts. 71, 77 e 88, V
Registros dos serviços farmacêuticos e cópias de DSF	Arts. 64, 81 e 88, II
Notas fiscais com nome, lote e fabricante dos produtos	Art. 31, §2º

Documento	Exigência
PGRSS e contrato com empresa de coleta	Art. 97; RDC 222/2018, art. 6º
Escrituração de controlados e antimicrobianos (SNGPC) e receitas retidas	Portaria 344/1998; RDC 22/2014; RDC 471/2021
Lista atualizada de genéricos e lista de serviços públicos de saúde próximos	Arts. 42, §1º, e 62

O SNGPC merece atenção especial em 2026. Depois de anos de suspensão, a transmissão obrigatória dos arquivos foi retomada de forma escalonada por região, a partir de 1º de setembro de 2025 no Sudeste, 1º de novembro de 2025 no Sul e no Norte e 2 de janeiro de 2026 no Centro-Oeste e no Nordeste, com envio em intervalos de 1 a 7 dias consecutivos (comunicado do CFF sobre o cronograma da Anvisa, 2025). Desde 30/09/2026, o Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR, RDC 873/2024) oferece funcionalidades para emissão e baixa eletrônica de receitas de controle especial; as receitas em papel continuam válidas.

O que o fiscal observa na loja

- presença do farmacêutico durante todo o horário (RDC 44/2009, art. 3º; Lei 13.021/2014, art. 6º, I) e identificação que o distinga dos demais (art. 17);
- medicamentos em área restrita aos funcionários, salvo os isentos de prescrição permitidos ao alcance do público, e cartaz "Medicamentos podem causar efeitos indesejados..." (arts. 40 e 41);
- produtos afastados de piso, parede e teto (art. 36), protegidos de sol, umidade e calor (art. 35);
- controlados em armário ou sala com chave, sob guarda do farmacêutico (art. 37);
- área segregada e identificada para vencidos, violados e suspeitos (art. 38);
- geladeira exclusiva com termômetro e registro em dia;
- sala de serviços limpa, com lavatório completo e coletor de perfurocortantes adequado;
- validade dos produtos expostos e dispensados (arts. 46 e 51).

Erros que mais geram autuação

- ausência do farmacêutico no horário declarado;
- POP inexistente, sem assinatura do RT, desatualizado ou que não corresponde à prática;
- planilha de temperatura em branco, preenchida de uma vez ("tudo 5 °C" em letra idêntica) ou sem ação registrada nas leituras fora da faixa;
- alimento ou bebida dentro da geladeira de medicamentos;
- vencidos misturados ao estoque ou sem identificação;
- serviço prestado sem constar da licença (por exemplo, teste rápido ou vacina);
- receitas de controlados ou de antimicrobianos sem os dados de dispensação, escrituração atrasada;
- perfurocortante em lixo comum ou coletor transbordando;
- treinamento sem registro, ou com registro sem conteúdo e sem avaliação.

Consequências e defesa

O descumprimento da RDC 44/2009 é infração sanitária nos termos da Lei 6.437/1977 (art. 99), sem prejuízo de responsabilidade civil, administrativa e penal. As penalidades previstas na lei vão de advertência e multa a apreensão de produtos, interdição e cancelamento de autorização e de licença, conforme a gravidade. O fiscal lavra os termos de inspeção e, se for o caso, o auto de infração; o autuado pode apresentar defesa ou impugnação no prazo de quinze dias contados da notificação (Lei 6.437/1977, art. 22). Problemas sem risco imediato costumam gerar exigência com prazo para adequação; risco iminente pode levar a interdição cautelar.

Postura durante a inspeção

- o farmacêutico acompanha o fiscal, com cordialidade e sem obstruir o trabalho;
- apresenta o que for pedido, sem improvisar documento na hora;
- responde com fatos e, quando não souber, diz que vai verificar;
- lê o termo antes de assinar, pede cópia e anota prazos;
- depois da visita, transforma cada exigência em ação com responsável e data, e revisa os POPs envolvidos.

Autoinspeção

Autoinspeção é a verificação interna, feita pela própria farmácia, com roteiro escrito, para encontrar falhas antes do fiscal. Um modo prático de organizar:

1. Definir no Manual a frequência (por exemplo, trimestral) e quem conduz. De preferência, alguém que não executa diariamente a atividade avaliada, como o farmacêutico de outro turno ou de outra loja da rede.
2. Usar um roteiro fixo, com itens verificáveis (documento existe, está assinado, registro está em dia, local está organizado).
3. Percorrer a loja na mesma ordem em que o fiscal costuma andar: fachada e documentos afixados, área de dispensação, estoque, geladeira, armário de controlados, sala de serviços, sanitário e área de resíduos.
4. Conferir uma amostra de registros: alguns dias da planilha de temperatura, algumas DSF, algumas receitas retidas contra a escrituração.
5. Registrar cada não conformidade com ação corretiva, responsável e prazo, e verificar o fechamento na autoinspeção seguinte.

Os resultados das autoinspeções alimentam a revisão dos POPs e o plano de treinamento. Falha que se repete em duas autoinspeções seguidas indica que o POP é inexequível ou que o treinamento não funcionou.

PONTO-CHAVE

A melhor preparação para a inspeção é a autoinspeção periódica com o mesmo roteiro que o fiscal usa. A RDC 430/2020 exige autoinspeções das distribuidoras (arts. 37 a 39); para a farmácia, é uma boa prática que o Manual pode prever, com frequência e responsável definidos.

CASO

Na renovação da licença, o fiscal encontra a planilha da geladeira com leituras de 10 °C em três dias seguidos e nenhuma anotação de ação. As insulinas continuaram sendo vendidas. Além da exigência de corrigir o equipamento e o POP, o fiscal pode determinar a segregação dos lotes expostos até avaliação do fabricante. A falha principal está na ausência de ação corretiva, que o art. 35, §5º, manda prever em POP.

NO BALCÃO

Fiscal chega e o RT está em horário de almoço, coberto pela farmacêutica substituta. Ela se identifica, mostra a escala de farmacêuticos afixada, acompanha a inspeção e liga para o RT apenas se o fiscal pedir algo que ela não consiga localizar.

Fontes consultadas

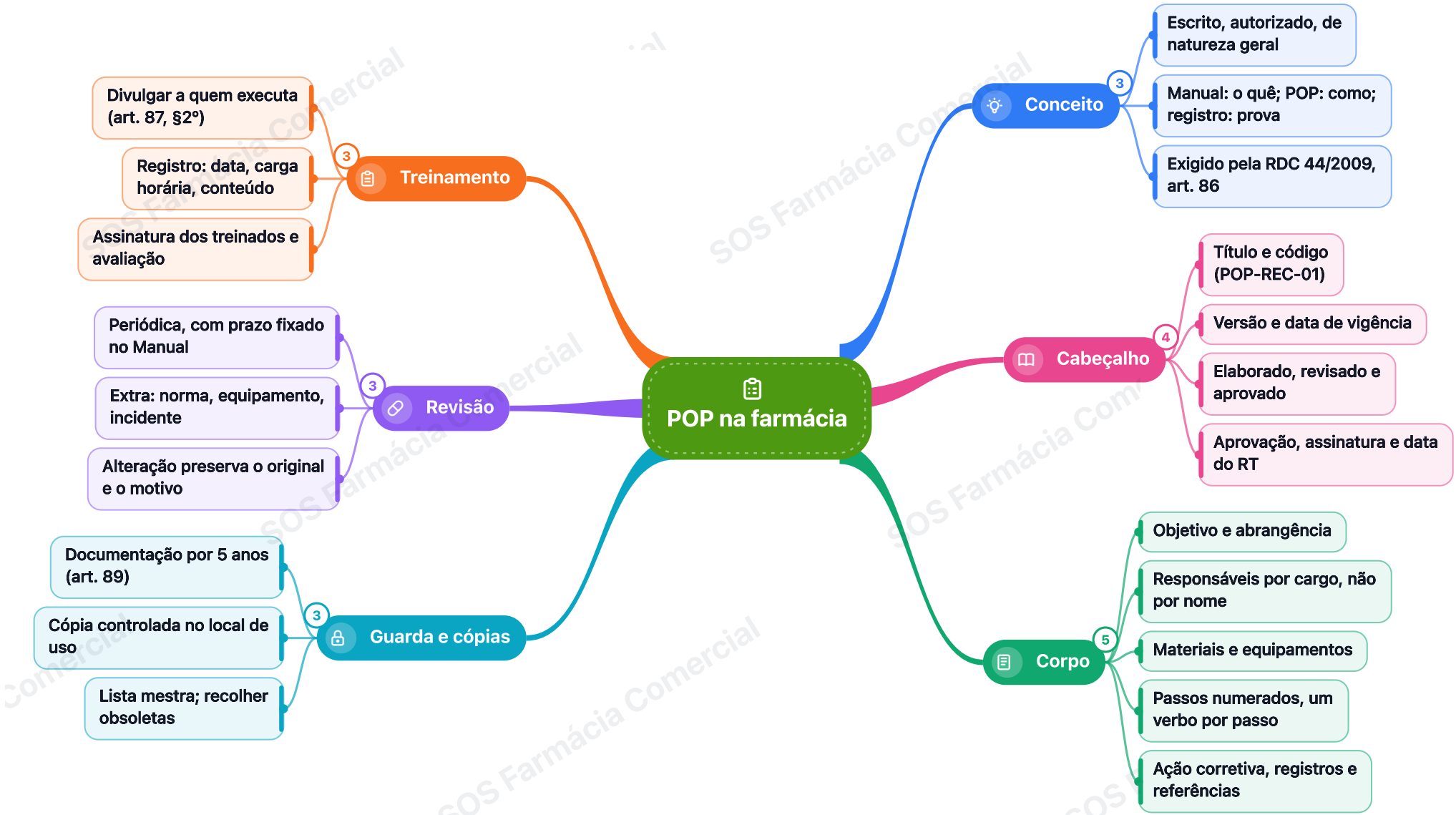
1. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União, 2009. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
2. Anvisa. Resolução RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Serviços que executam exames de análises clínicas; art. 155 altera a RDC 44/2009 e art. 157 revoga o §2º do art. 69 e o art. 70. Diário Oficial da União, 10 maio 2023. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-786-de-5-de-maio-de-2023-482394228
3. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Funcionamento de serviços que executam exames de análises clínicas. Diário Oficial da União, 10 jun. 2025. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anvisa-n-978-de-6-de-junho-de-2025-635044217
4. Anvisa. Perguntas e respostas: RDC nº 978/2025, 1ª versão revisada. Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, ago. 2025.
5. Anvisa. Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União, 2006. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/rdc0080_11_05_2006.html
6. Anvisa. Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017. Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. Diário Oficial da União, 2017.
7. Anvisa. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Diário Oficial da União, 2018.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. Diário Oficial da União, 9 out. 2020. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
9. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, e alteração pela RDC nº 973/2025 (agonistas de GLP-1); Instrução Normativa nº 360/2025.
10. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm

11. Brasil. Lei nº 14.675, de 14 de setembro de 2023. Funcionamento dos serviços privados de vacinação humana. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14675.htm
12. Brasil. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10388.htm
13. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Infrações à legislação sanitária federal e sanções.
14. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 6ª ed. Brasília, 2025.
15. Conselho Federal de Farmácia. Justiça mantém resolução do CFF sobre vacinação por farmacêuticos (Resolução CFF nº 654/2018). Notícia, 12 jun. 2026. https://site.cff.org.br
16. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa reestabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos eletrônicos ao SNGPC (2025) e SNCR: o que muda para farmácias e drogarias (2026). https://site.cff.org.br
17. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa estabelece novas regras para prescrição e dispensação de medicamentos agonistas de GLP-1. Notícia, 16 jan. 2026.
18. Conselho Federal de Farmácia. Farmacêuticos propõem norma para furo na orelha com foco em atendimento humanizado. Notícia, 28 jul. 2025.
19. São Paulo (Estado). Lei nº 16.660, de 12 de janeiro de 2018. Ceará (Estado). Lei nº 16.503, de 19 de dezembro de 2017.
20. Brandão AA et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025. Arq Bras Cardiol. 2025;122(9):e20250624. doi:10.36660/abc.20250624
21. Anvisa. VigiMed e Notivisa: sistemas de notificação. Portal gov.br/anvisa, consultado em out. 2026.

SOS Farmácia Comercial

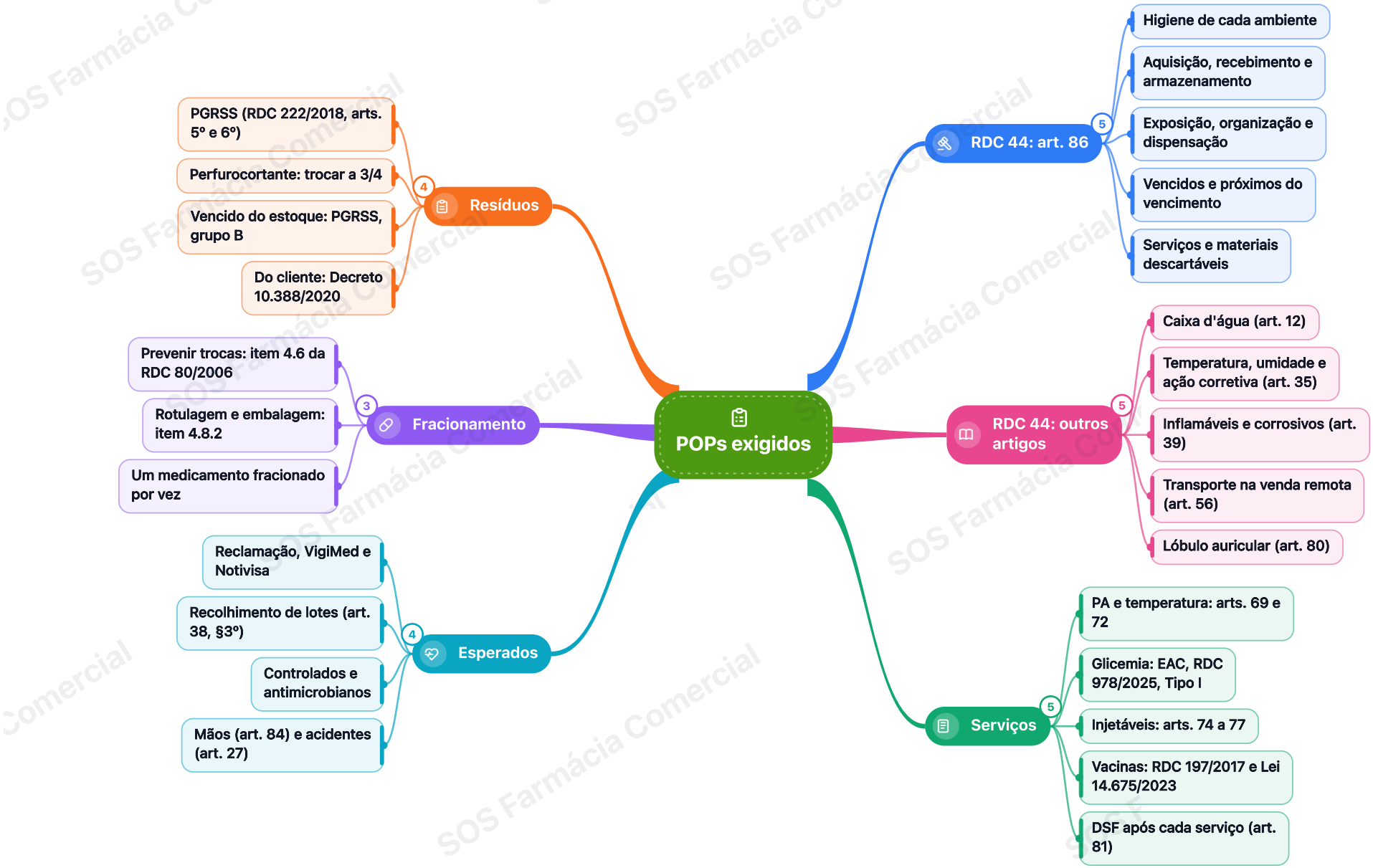
Estrutura e ciclo do POP

6 ramos · 21 itens · mapa mental do módulo 7



POPs obrigatórios

6 ramos · 26 itens · mapa mental do módulo 7



Norma, POP exigido e artigo

Norma	Artigo ou item	POP ou instrução escrita	Código sugerido	Registro gerado
RDC 44/2009	Art. 12	Limpeza da caixa d'água	POP-LIM-02	Comprovante de limpeza
RDC 44/2009	Arts. 16, 83 e 86, I	Limpeza e higienização dos ambientes	POP-LIM-01	Planilha de limpeza diária
RDC 44/2009	Arts. 31, 32 e 86, II	Aquisição e recebimento	POP-REC-01	Conferência da nota; não conformidades
RDC 44/2009	Art. 35, §§ 4º e 5º	Controle de temperatura e umidade	POP-TEMP-01	Planilha diária; ações corretivas
RDC 44/2009	Arts. 35 a 38 e 86, II	Armazenamento e controle de validade	POP-ARM-01	Relatório de validade; segregados
RDC 44/2009	Art. 39	Inflamáveis, corrosivos e explosivos	POP-ARM-02	Inventário do local
RDC 44/2009	Art. 86, III	Exposição e organização	POP-EXP-01	Não se aplica
RDC 44/2009	Arts. 43 a 47 e 86, IV	Dispensação de medicamentos	POP-DIS-01	Registro de intervenções
Portaria 344/1998; RDC 22/2014	Art. 49 da RDC 44/2009	Dispensação de controlados	POP-DIS-02	Receitas retidas; SNGPC
RDC 471/2021	Retenção e escrituração	Dispensação de antimicrobianos e agonistas de GLP-1	POP-DIS-03	2ª via retida; SNGPC
RDC 44/2009	Arts. 38, 51 e 86, V e VI	Vencidos e próximos do vencimento	POP-VAL-01	Termo de segregação e baixa
RDC 44/2009	Art. 56, §3º	Transporte na dispensação remota	POP-ENT-01	Registro de entrega
RDC 44/2009	Arts. 64, 65 e 72	Serviços: PA, temperatura, protocolos	POP-SF-01	Ficha do atendimento; DSF
RDC 978/2025	Arts. 10, 110, 112 e 119	Glicemia capilar e outros EAC	POP-SF-02	Resultados; CIQ e CEQ; DSF

Norma	Artigo ou item	POP ou instrução escrita	Código sugerido	Registro gerado
RDC 44/2009	Arts. 74 a 77	Administração de medicamentos	POP-SF-03	DSF com lote; registro
RDC 44/2009	Art. 80	Perfuração de lóbulo auricular	POP-SF-04	DSF
RDC 197/2017; Lei 14.675/2023	Arts. 11 e 12; art. 5º	Vacinação: rede de frio e transporte	POP-VAC-01	Mapa de temperatura; cartão
RDC 80/2006	Anexo I, Parte II, itens 4.6 e 4.8.2	Fracionamento: trocas, rotulagem e embalagem	POP-FRA-01	Registro do fracionamento
RDC 222/2018	Arts. 5º, 6º, 86 a 89	PGRSS e descarte de resíduos	POP-RES-01	Comprovantes de coleta
Decreto 10.388/2020	Arts. 10 a 12	Recebimento de medicamentos dos clientes	POP-RES-02	Massa no manifesto de transporte
RDC 44/2009; Lei 13.021/2014	Arts. 34, 38 e 67; art. 13, I	Reclamações, recolhimento e farmacovigilância	POP-QUA-01	Notificações; termo de recolhimento
RDC 44/2009	Arts. 24 a 28	Capacitação da equipe	POP-RH-01	Registro de treinamento

Códigos ilustrativos. A farmácia adapta a lista às atividades que constam do seu licenciamento e do Manual de Boas Práticas.

Modelo de cabeçalho e fechamento de POP

Campo	Preenchimento
Estabelecimento	Nome fantasia, CNPJ, unidade
Título	Recebimento de medicamentos
Código / versão	POP-REC-01 / versão 02
Vigência	A partir de __/__/____ ; próxima revisão até __/__/____
Página	__ de __
Elaborado por	Nome, cargo, data, assinatura
Revisado por	Nome, cargo, data, assinatura
Aprovado por	Farmacêutico RT, CRF, data, assinatura (RDC 44/2009, art. 87)

Seções do corpo: 1. Objetivo; 2. Abrangência; 3. Responsáveis; 4. Definições; 5. Materiais e equipamentos; 6. Procedimento; 7. Cuidados e ações corretivas; 8. Registros; 9. Referências; 10. Anexos.

Versão	Data	Alteração	Motivo
01	__/__/____	Emissão inicial	Implantação
02	__/__/____	Inclusão da conferência de termolábeis	Reclamação de cliente

Registro de divulgação: nome, função, data, assinatura de cada funcionário que leu e foi treinado nesta versão (RDC 44/2009, arts. 28 e 88, III).

Recebimento de medicamentos

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Recebimento de medicamentos**	Código: **POP-REC-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Garantir que somente produtos regularizados, íntegros, autênticos e transportados nas condições do fabricante entrem no estoque.

Abrangência

Área de recebimento da loja; todos os turnos; produtos adquiridos de distribuidores.

Responsáveis

- Estoquista ou auxiliar treinado: executa a conferência
- Farmacêutico: confere controlados, termolábeis e decide sobre não conformidades
- Farmacêutico RT: aprova o POP e os fornecedores qualificados

Materiais

- Nota fiscal e pedido de compra
- Lista de fornecedores qualificados com AFE e licença
- Termômetro ou leitor do indicador de temperatura da carga
- Etiquetas de quarentena e de devolução
- Formulário de não conformidade

Procedimento

1. Conferir se o fornecedor consta da lista de distribuidores autorizados e licenciados (RDC 44/2009, art. 31, §1º).
2. Receber a carga somente na área de recebimento e por pessoa treinada (art. 32).
3. Priorizar os volumes refrigerados: abrir primeiro, conferir a temperatura de chegada e guardar na geladeira em seguida.
4. Conferir a integridade dos volumes: caixas amassadas, molhadas, violadas ou com lacre rompido.
5. Confrontar nota fiscal e pedido: nome, apresentação, quantidade, lote e fabricante, que devem estar discriminados na nota (art. 31, §2º).
6. Para cada item, verificar bom estado, legibilidade de lote e validade e presença do mecanismo de autenticidade da embalagem (art. 34).
7. Conferir se a validade é compatível com a política de compra da loja e com o giro do produto.
8. Separar controlados para conferência pelo farmacêutico e guarda imediata no armário com chave (art. 37).

9. Em divergência (falta, sobra, lote diferente, avaria), registrar no formulário, identificar o item como quarentena e comunicar o farmacêutico.
10. Em suspeita de falsificação, adulteração ou alteração, segregar o produto fora da área de dispensação com identificação de que não se destina à venda e acionar o farmacêutico (art. 34, §1º).
11. Dar entrada no sistema somente dos itens aprovados.
12. Guardar os produtos seguindo PVPS/FEFO, com validade mais curta à frente.
13. Arquivar a nota fiscal e o registro de conferência.

Cuidados

- Não receber carga transportada fora das condições do fabricante (art. 33).
- Termolábil com temperatura de chegada fora da faixa fica em quarentena refrigerada até resposta do fornecedor.
- Suspeita de falsificação deve ser notificada pelo farmacêutico à autoridade sanitária imediatamente (art. 34, §2º).

Registros

- Nota fiscal conferida e rubricada
- Formulário de não conformidade no recebimento
- Registro de temperatura de chegada dos termolábeis
- Escrituração de entrada de controlados no SNGPC

Referências

- RDC 44/2009, arts. 30 a 34, 37
- RDC 430/2020, arts. 56 e 57 (referência de boas práticas)
- Portaria SVS/MS 344/1998
- RDC 22/2014

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Armazenamento e controle de validade

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Armazenamento e controle de validade**	Código: **POP-ARM-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Manter os produtos ordenados, nas condições do fabricante e dispensados antes do vencimento, segregando vencidos e avariados.

Abrangência

Estoque, prateleiras de dispensação e área de autosserviço.

Responsáveis

- Auxiliar de estoque: organização e verificação mensal de validade
- Farmacêutico: supervisão, decisão sobre próximos do vencimento e segregados

Materiais

- Relatório de validade do sistema
- Etiquetas de validade próxima
- Caixas identificadas para segregação
- Formulário de baixa por vencimento ou avaria

Procedimento

1. Armazenar os produtos em prateleiras, gavetas ou estrados, afastados do piso, das paredes e do teto (RDC 44/2009, art. 36).
2. Organizar por critério definido no Manual (ordem alfabética por DCB ou nome, por forma farmacêutica ou por classe), com etiqueta de endereço.
3. Separar fisicamente apresentações parecidas e nomes semelhantes; sinalizar medicamentos potencialmente perigosos.
4. Aplicar PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai) ou FEFO: validade mais curta à frente.
5. Emitir mensalmente o relatório de validades e conferir fisicamente por amostragem.
6. Identificar com etiqueta os produtos que vencem nos próximos meses, conforme a política do Manual (art. 38, §4º).
7. Na dispensação de produto com validade próxima, alertar o usuário (art. 51, §1º) e não dispensar se o tratamento não puder ser concluído antes do vencimento (art. 51, §2º).
8. Retirar no primeiro dia útil do mês os produtos vencidos ou que vencem naquele mês, conforme regra do Manual.
9. Levar vencidos, violados e avariados para a área segregada, identificados quanto à condição e ao destino (art. 38).

10. Dar baixa no sistema e, para controlados, seguir a rotina de baixa e inutilização prevista na Portaria 344/1998 e na vigilância local.
11. Encaminhar os segregados ao descarte conforme o PGRSS ou à devolução ao fornecedor, quando acordado.
12. Registrar quantidades, lotes e destino.

Cuidados

- Validade expressa em mês e ano vale até o último dia do mês, salvo indicação do fabricante.
- Vencido nunca volta à prateleira, nem para troca.
- Proteger do sol, da umidade e do calor (art. 35, §2º).

Registros

- Relatório mensal de validade com rubrica
- Formulário de baixa por vencimento ou avaria
- Comprovante de destinação pelo PGRSS

Referências

- RDC 44/2009, arts. 35 a 38 e 51
- RDC 222/2018
- Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Controle de temperatura e umidade

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Controle de temperatura e umidade**	Código: **POP-TEMP-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Monitorar e registrar a temperatura e a umidade do estoque, da área de dispensação e da geladeira, e agir quando saírem da faixa.

Abrangência

Áreas de armazenamento e dispensação; refrigerador de medicamentos.

Responsáveis

- Balconista ou auxiliar designado por turno: leitura e registro
- Farmacêutico: análise das leituras e ações corretivas
- Farmacêutico RT: aprovação, calibração e revisão

Materiais

- Termo-higrômetro calibrado no ambiente
- Termômetro de máxima e mínima calibrado ou registrador eletrônico na geladeira
- Planilha de registro
- Certificados de calibração

Procedimento

1. Identificar os pontos de medição: área de estoque, área de dispensação e geladeira.
2. Fazer a leitura do ambiente na faixa de horário de maior temperatura e umidade do dia, definida pela farmácia a partir do mapeamento (RDC 44/2009, art. 35, §4º); se a loja tiver ar-condicionado desligado à noite, incluir leitura na abertura.
3. Registrar temperatura e umidade do ambiente com hora e rubrica.
4. Ler a geladeira no mínimo duas vezes ao dia, na abertura e no fechamento, anotando temperatura de momento, máxima e mínima.
5. Reiniciar o termômetro de máxima e mínima após cada leitura.
6. Comparar as leituras com as faixas: ambiente de 15 °C a 30 °C (ou o limite mais restritivo dos produtos, como até 25 °C); geladeira de 2 °C a 8 °C.
7. Se o ambiente passar do limite, acionar ventilação ou climatização, afastar produtos da fonte de calor e comunicar o farmacêutico.
8. Se a geladeira sair de 2 °C a 8 °C, aplicar o fluxo de excursão: manter a porta fechada, verificar energia e vedação, comunicar o farmacêutico e registrar a hora.
9. Em excursão confirmada, segregar os produtos afetados dentro de equipamento na faixa correta, identificar "aguardando avaliação" e consultar o fabricante.

10. Registrar a ação tomada na própria planilha, com a decisão final e a assinatura do farmacêutico.
11. Calibrar os instrumentos na periodicidade definida e sempre que houver suspeita de erro.
12. Arquivar as planilhas e os certificados.

Cuidados

- Planilha é preenchida no momento da leitura, nunca depois.
- Leitura fora da faixa sem ação registrada é não conformidade.
- A umidade aceitável é definida no POP com base nas especificações dos produtos.

Registros

- Planilha diária de temperatura e umidade
- Registro de excursão e decisão
- Certificado de calibração dos instrumentos

Referências

- RDC 44/2009, art. 35, §§ 2º a 5º
- Farmacopeia Brasileira, 6ª ed., Generalidades: faixas de temperatura
- Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Limpeza e higienização do ambiente

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Limpeza e higienização do ambiente**	Código: **POP-LIM-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Manter cada ambiente da farmácia limpo e livre de contaminação, com registro da rotina.

Abrangência

Área de dispensação, estoque, sala de serviços, sanitário, depósito de material de limpeza e área administrativa.

Responsáveis

- Auxiliar de limpeza: execução
- Farmacêutico: supervisão e conferência do registro
- Farmacêutico RT: treinamento e aprovação

Materiais

- Saneantes regularizados na Anvisa (RDC 44/2009, art. 8º)
- Panos e baldes identificados por área
- Luvas de borracha, calçado fechado
- Álcool 70% para superfícies da sala de serviços
- Planilha de limpeza

Procedimento

1. Guardar materiais de limpeza no local designado e identificado (art. 8º).
2. Usar panos e baldes exclusivos por área, identificados por cor.
3. Limpar a sala de serviços no início e ao término do expediente e registrar (art. 16).
4. Verificar a necessidade de nova limpeza da sala após cada atendimento, garantindo ambiente limpo antes do próximo (art. 16, §§ 1º e 2º).
5. Na sala de serviços, limpar primeiro as superfícies mais limpas e depois as mais sujas, de cima para baixo, terminando pelo piso.
6. Desinfetar com álcool 70% bancada, maca e braçadeira entre atendimentos, conforme o POP do serviço.
7. Limpar prateleiras retirando os produtos, sem molhar embalagens, conforme cronograma do estoque.
8. Limpar piso da área de dispensação diariamente, sinalizando piso molhado.
9. Limpar o sanitário e repor sabonete líquido, papel toalha e lixeira com pedal e tampa (art. 9º).
10. Recolher resíduos comuns e encaminhar os de saúde conforme o PGRSS.

11. Limpar a geladeira de medicamentos conforme o POP de termolábeis, nunca no fim do expediente.
12. Registrar na planilha data, hora, área e assinatura.

Cuidados

- Não misturar saneantes.
- Não varrer a seco áreas de serviços.
- Caixa d'água própria tem POP e registro específicos (art. 12).

Registros

- Planilha de limpeza por ambiente
- Registro de limpeza da sala de serviços (início e fim)
- Comprovante de limpeza da caixa d'água

Referências

- RDC 44/2009, arts. 6º a 9º, 12, 16 e 83
- Fichas técnicas dos saneantes utilizados

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Dispensação de medicamentos

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Dispensação de medicamentos**	Código: **POP-DIS-01** Versão: _____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Entregar o medicamento correto, ao paciente correto, com orientação suficiente para o uso seguro.

Abrangência

Balcão de atendimento e dispensação remota.

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação da receita, orientação e intervenção
- Balconista: separação e conferência, sob supervisão (art. 22)

Materiais

- Sistema de vendas com alerta de interação e de validade
- Fontes de informação (bulário, compêndios)
- Lista atualizada de genéricos
- Formulário de intervenção farmacêutica

Procedimento

1. Acolher o cliente e identificar quem vai usar o medicamento.
2. Para medicamento de venda sob prescrição, exigir a receita (RDC 44/2009, art. 43).
3. Avaliar a receita: legibilidade, ausência de rasuras, identificação do usuário, medicamento, concentração, forma, quantidade, posologia, duração, local, data, assinatura e conselho do prescritor (art. 44).
4. Não dispensar receita ilegível ou que possa induzir a erro; contatar o prescritor em caso de dúvida (arts. 44, parágrafo único, e 45).
5. Verificar se o medicamento exige receituário especial ou retenção e aplicar o POP próprio (controlados, antimicrobianos).
6. Na intercambialidade, seguir a legislação de genéricos (art. 47).
7. Separar o produto e fazer inspeção visual: identificação, validade e integridade da embalagem (art. 46).
8. Conferir a separação contra a receita em dupla checagem para medicamentos potencialmente perigosos e nomes parecidos.
9. Orientar posologia, influência de alimentos, interações, reações adversas possíveis e conservação (art. 42, §2º).

10. Alertar se a validade estiver próxima e não dispensar se o tratamento não terminar antes do vencimento (art. 51).
11. Oferecer serviço ou encaminhamento quando identificar problema relacionado ao medicamento.
12. Registrar intervenções relevantes.

Cuidados

- Na venda remota, a receita é apresentada e avaliada pelo farmacêutico; controlados não podem ser vendidos por meio remoto (art. 52).
- Termolábil entregue com orientação de transporte e conservação.

Registros

- Registro de intervenção farmacêutica
- Receitas retidas, quando exigido

Referências

- RDC 44/2009, arts. 42 a 52
- Lei 13.021/2014, arts. 13 e 14
- Lei 9.787/1999 e normas de intercambialidade

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial**	Código: **POP-DIS-02** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Dispensar controlados somente diante de receituário válido, com retenção, registro e escrituração corretos.

Abrangência

Balcão; armário de controlados; dispensação presencial (vedada a remota).

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação, dispensação, guarda das chaves e escrituração
- Balconista: não dispensa controlado sem conferência do farmacêutico

Materiais

- Armário ou sala com chave (RDC 44/2009, art. 37)
- Portaria SVS/MS 344/1998 e listas atualizadas
- Acesso ao SNGPC e ao SNCR
- Carimbo e caneta

Procedimento

1. Identificar a substância e a lista a que pertence, consultando a versão atualizada das listas da Portaria 344/1998.
2. Verificar o tipo de receituário exigido para a lista (notificação de receita ou receita de controle especial).
3. Conferir validade, abrangência territorial, quantidade e campos obrigatórios do receituário, conforme a Portaria 344/1998.
4. Em receita eletrônica, validar autenticidade, dados do prescritor e numeração pelo SNCR e fazer a baixa no sistema.
5. Recusar receituário vencido, rasurado, incompleto ou com quantidade acima do permitido, explicando o motivo ao cliente.
6. Identificar o comprador com documento e registrar os dados exigidos.
7. Retirar o medicamento do armário trancado e conferir lote e validade.
8. Anotar no receituário os dados de dispensação exigidos e rubricar.
9. Reter a notificação ou a via destinada à farmácia e devolver a via do paciente, quando houver.
10. Orientar o uso, os riscos (sedação, dependência, interação com álcool) e a guarda segura em casa.
11. Escriturar a saída no SNGPC e transmitir dentro do prazo (intervalo de 1 a 7 dias).

12. Arquivar as receitas retidas em ordem e pelo prazo legal.

Cuidados

- Controlado não pode ser vendido por telefone, internet ou aplicativo (RDC 44/2009, art. 52, §2º).
- Chave do armário sob guarda do farmacêutico.
- Divergência de estoque é investigada e comunicada conforme a Portaria 344/1998.

Registros

- Receitas e notificações retidas
- Escrituração no SNGPC
- Registro de recusa, quando houver

Referências

- Portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações
- RDC 22/2014 (SNGPC)
- RDC 873/2024 (SNCR)
- RDC 44/2009, arts. 37, 49 e 52

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Dispensação de antimicrobianos

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Dispensação de antimicrobianos**	Código: **POP-DIS-03** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Dispensar antimicrobianos e demais medicamentos sujeitos à RDC 471/2021 com retenção da receita e escrituração.

Abrangência

Balcão; inclui agonistas de GLP-1 controlados pela RDC 471/2021 desde a RDC 973/2025.

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação, dispensação e escrituração
- Balconista: separação sob supervisão

Materiais

- Receita em duas vias
- Acesso ao SNGPC
- Carimbo

Procedimento

1. Conferir se a receita está legível, sem rasuras, em duas vias, com identificação do paciente e do prescritor e dados do medicamento.
2. Conferir a validade: 10 dias a contar da emissão para antimicrobianos, considerando o dia da emissão como dia 0.
3. Para agonistas de GLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida, lixisenatida), aplicar a validade de 90 dias definida pela RDC 973/2025.
4. Em tratamento prolongado de antimicrobiano, aceitar a receita por até 90 dias se ela indicar uso contínuo e a quantidade para cada 30 dias; a primeira compra ocorre nos 10 primeiros dias.
5. Recusar receita vencida.
6. Separar o medicamento e conferir lote e validade.
7. Registrar nas duas vias: data da dispensação, quantidade aviada, número do lote e rubrica do farmacêutico no verso.
8. Reter a segunda via e devolver a primeira ao paciente.
9. Orientar dose, intervalo, duração completa, interações e conservação (suspensão reconstituída: conforme bula).
10. Escriturar a saída no SNGPC no prazo.
11. Arquivar as segundas vias.

Cuidados

- Suspensões reconstituídas podem exigir geladeira; orientar conforme bula do produto.
- Não fracionar a quantidade prescrita fora das regras de fracionamento (RDC 80/2006).

Registros

- Segunda via retida com dados de dispensação
- Escrituração no SNGPC

Referências

- RDC 471/2021 e alterações, incluindo RDC 973/2025
- IN Anvisa 360/2025 (lista de agonistas de GLP-1)
- RDC 22/2014

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Aferição de pressão arterial

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Aferição de pressão arterial**	Código: **POP-SF-01** Versão: _____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Aferir a pressão arterial com técnica padronizada, interpretar conforme diretriz vigente e orientar ou encaminhar, sem finalidade diagnóstica.

Abrangência

Sala de serviços farmacêuticos licenciada.

Responsáveis

- Farmacêutico: aferição, interpretação, orientação e DSF

Materiais

- Aparelho automático de braço validado e calibrado
- Manguitos de tamanhos diferentes
- Fita métrica
- Álcool 70% e papel toalha
- Ficha de registro e DSF

Procedimento

1. Higienizar as mãos (RDC 44/2009, art. 84).
2. Explicar o procedimento e obter o consentimento do cliente para registro (art. 64, §1º).
3. Perguntar sobre sintomas no momento (dor no peito, falta de ar, fraqueza em um lado do corpo, alteração da fala ou da visão); se presentes, acionar o SAMU (192) sem atrasar o socorro.
4. Confirmar o preparo: sem fumar, sem cafeína e sem exercício nos minutos anteriores, bexiga vazia; se não, aguardar.
5. Manter o cliente sentado, em repouso, costas apoiadas, pernas descruzadas, pés no chão, sem falar, por pelo menos 5 minutos.
6. Medir a circunferência do braço e escolher o manguito adequado.
7. Posicionar o manguito sem folga, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, com a bolsa centralizada sobre a artéria braquial e o braço apoiado na altura do coração.
8. Fazer três medidas com intervalo de 1 minuto e usar a média das duas últimas; se a diferença passar de 10 mmHg, fazer medidas adicionais.
9. Classificar pela DBHA 2025: abaixo de 120/80 normal; 120 a 139 e/ou 80 a 89 pré-hipertensão; a partir de 140 e/ou 90, valor elevado.

10. Orientar procura de assistência médica quando o valor estiver fora da referência (art. 69, §3º), com urgência se 180/110 mmHg ou mais com sintomas.
11. Não indicar nem alterar medicamento de venda sob prescrição (art. 69, §4º).
12. Registrar valores e orientação e entregar a DSF com valores de referência e a frase obrigatória (art. 81).
13. Desinfetar a braçadeira e higienizar as mãos.

Cuidados

- Aparelho de pulso não é preferido para medida na farmácia.
- Manguito pequeno superestima a PA.
- A medida isolada não fecha diagnóstico.

Registros

- Ficha do atendimento
- Cópia ou registro da DSF
- Registro de calibração do aparelho (art. 71, parágrafo único)

Referências

- RDC 44/2009, arts. 69, 71, 72, 81 e 84 (redação da RDC 786/2023)
- Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, Arq Bras Cardiol 2025;122(9)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Glicemia capilar

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Glicemia capilar**	Código: **POP-SF-02** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Realizar a glicemia capilar como exame de triagem, com controle de qualidade, biossegurança e encaminhamento adequado.

Abrangência

Sala de coleta e execução de EAC da farmácia licenciada como Serviço Tipo I.

Responsáveis

- Farmacêutico: execução, interpretação, liberação do resultado e DSF
- Farmacêutico RT: controle interno e externo da qualidade

Materiais

- Glicosímetro regularizado na Anvisa
- Tiras reagentes dentro da validade e lote registrado
- Lancetas de uso único
- Algodão, álcool 70%, luvas de procedimento
- Coletor de perfurocortantes
- Material de controle de qualidade

Procedimento

1. Conferir o registro do controle interno da qualidade do glicosímetro no dia, conforme o fabricante e o programa da farmácia.
2. Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento (RDC 44/2009, art. 84).
3. Identificar o cliente, obter consentimento, perguntar horário da última refeição e medicamentos em uso.
4. Pedir que o cliente lave as mãos com água e sabão ou fazer antissepsia com álcool 70% e esperar secar.
5. Puncionar a face lateral da polpa digital com lanceta de uso único.
6. Desprezar a primeira gota se o fabricante orientar e aplicar a gota na tira conforme instrução.
7. Descartar a lanceta imediatamente no coletor rígido.
8. Fazer hemostasia com algodão seco; descartar o algodão conforme o PGRSS.
9. Ler e registrar o resultado com hora e condição (jejum ou pós-prandial).
10. Interpretar com os valores de referência citados no POP e aplicar o procedimento para resultado potencialmente crítico (RDC 978/2025, art. 119).
11. Orientar e encaminhar; o exame é de triagem, sem fins confirmatórios (art. 60).

12. Entregar a DSF com resultado, referência e frase obrigatória (RDC 44/2009, art. 81; RDC 978/2025, art. 60, §2º).
13. Retirar as luvas, higienizar as mãos e limpar a bancada.

Cuidados

- Resultado muito baixo com sintomas: oferecer carboidrato de absorção rápida se o cliente estiver consciente e acionar ajuda.
- Resultado muito alto com sintomas (sede intensa, vômitos, confusão): encaminhar com urgência.
- Tira fora da validade ou armazenada fora da faixa não é usada.

Registros

- Registro do exame
- Registros de controle interno e externo da qualidade
- DSF

Referências

- RDC 978/2025, arts. 8º a 14, 60, 63, 110 a 113 e 119
- Anvisa. Perguntas e respostas da RDC 978/2025, 2025
- RDC 44/2009, arts. 61, 69, 81 e 84
- Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes vigente

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Aplicação de medicamentos injetáveis

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Aplicação de medicamentos injetáveis**	Código: **POP-SF-03** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Administrar medicamentos injetáveis com segurança, mediante receita avaliada, técnica correta e registro.

Abrangência

Sala de serviços farmacêuticos licenciada para administração de medicamentos.

Responsáveis

- Farmacêutico ou profissional habilitado: avaliação da receita e aplicação
- Farmacêutico RT: aprovação e treinamento

Materiais

- Seringas e agulhas regularizadas, de calibre adequado à via
- Algodão, álcool 70%, luvas de procedimento
- Coletor de perfurocortantes
- Kit de primeiros socorros identificado (RDC 44/2009, art. 15, §4º)
- DSF

Procedimento

1. Avaliar a receita e confirmar que o medicamento não é de uso exclusivo hospitalar (RDC 44/2009, arts. 74 e 75).
2. Contatar o prescritor se houver dúvida sobre dose, via ou indicação (art. 75, §1º).
3. Perguntar sobre alergias, reações anteriores e uso de anticoagulantes.
4. Conferir nome, concentração, via, lote e validade do medicamento diante do cliente (art. 75, §2º).
5. Higienizar as mãos e calçar luvas (art. 84).
6. Preparar a dose com técnica asséptica, sem reencapar agulha com as mãos.
7. Escolher o local de aplicação conforme a via (intramuscular ou subcutânea) e o volume.
8. Fazer antissepsia da pele com álcool 70% e esperar secar.
9. Aplicar com técnica da via e observar a reação do cliente.
10. Descartar seringa e agulha juntas no coletor rígido.
11. Manter o cliente em observação pelo tempo definido no POP, com atenção a sinais de reação alérgica.
12. Entregar a sobra de frasco multidose ao cliente com orientação de conservação; não armazenar embalagem violada (art. 76).

13. Emitir a DSF com nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração, forma, via, lote e registro na Anvisa (art. 81).

Cuidados

- Reação grave (falta de ar, inchaço de face, queda de pressão): acionar o SAMU (192) e seguir o protocolo de primeiros socorros da farmácia.
- Medicamento trazido pelo cliente com conservação duvidosa (termolábil fora da geladeira) não é aplicado.

Registros

- Registro da administração
- DSF
- Registro de intercorrências

Referências

- RDC 44/2009, arts. 15, 74 a 77, 81, 83 e 84
- RDC 222/2018, arts. 86 a 89
- Bula do medicamento administrado

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Descarte de resíduos e de medicamentos vencidos

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Descarte de resíduos e de medicamentos vencidos**	Código: **POP-RES-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Segregar, acondicionar e destinar os resíduos da farmácia conforme o PGRSS e receber corretamente os medicamentos descartados pelos clientes.

Abrangência

Toda a loja; sala de serviços; área segregada; ponto de recebimento de descarte.

Responsáveis

- Toda a equipe: segregação na origem
- Auxiliar designado: acondicionamento e entrega à coleta
- Farmacêutico RT: PGRSS, contratos e registros

Materiais

- Coletor rígido para perfurocortantes
- Sacos brancos leitosos identificados
- Caixas identificadas para medicamentos vencidos
- Dispensador contentor (ponto fixo de recebimento)
- EPI: luvas de borracha

Procedimento

1. Segregar cada resíduo no momento em que é gerado, conforme o grupo definido no PGRSS.
2. Descartar lancetas, agulhas e ampolas no coletor rígido, sem reencapar (RDC 222/2018, arts. 86 e 89).
3. Fechar e substituir o coletor quando atingir 3/4 da capacidade (art. 87).
4. Descartar algodão e gaze com pequena quantidade de sangue em saco branco leitoso identificado.
5. Encaminhar vacinas vencidas ou com sobra como resíduo que exige tratamento (art. 47).
6. Retirar medicamentos vencidos ou avariados do estoque, registrar e acondicionar em caixa identificada na área segregada (RDC 44/2009, art. 38).
7. Descaracterizar a rotulagem das embalagens secundárias limpas antes da reciclagem (RDC 222/2018, art. 62).
8. Manter os resíduos no abrigo temporário até a coleta pela empresa licenciada.
9. Conferir e arquivar o comprovante de coleta e destinação.
10. No ponto de recebimento, orientar o cliente a usar o dispensador contentor conforme as instruções afixadas (Decreto 10.388/2020, art. 11).

11. Retirar o recipiente cheio do dispensador, lacrar, pesar e guardar no armazenamento primário (art. 12).
12. Registrar a massa em quilogramas no manifesto de transporte de resíduos antes da entrega ao distribuidor (art. 12, §§ 2º e 3º).

Cuidados

- Medicamento vencido do estoque não vai para o coletor dos clientes (Decreto 10.388/2020, art. 5º, III).
- Nunca jogar medicamentos na pia ou no vaso sanitário.
- Acidente com perfurocortante segue o POP de biossegurança.

Registros

- Planilha de resíduos por grupo
- Comprovantes de coleta e destinação
- Manifesto de transporte de resíduos (ponto fixo)

Referências

- RDC 222/2018
- RDC 44/2009, arts. 38, 73, 93 e 97
- Decreto 10.388/2020

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Reclamações, recolhimento e farmacovigilância

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Reclamações, recolhimento e farmacovigilância**	Código: **POP-QUA-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Registrar e investigar reclamações, notificar eventos adversos e queixas técnicas e executar recolhimentos de forma rastreável.

Abrangência

Todos os canais de atendimento (balcão, telefone, internet).

Responsáveis

- Qualquer funcionário: receber a reclamação e acionar o farmacêutico
- Farmacêutico: avaliação, notificação e comunicação com o cliente
- Farmacêutico RT: execução de recolhimentos e análise de tendências

Materiais

- Formulário de reclamação
- Acesso ao VigiMed e ao Notivisa
- Contatos do SAC dos fabricantes e da vigilância sanitária local
- Etiquetas de segregação

Procedimento

1. Registrar a reclamação: data, cliente, produto, lote, validade, onde foi comprado e descrição do problema.
2. Recolher, se possível, a amostra e a embalagem, sem descartar.
3. Classificar: evento adverso (dano ou efeito indesejado no paciente), queixa técnica (desvio de qualidade, defeito, rótulo, suspeita de falsificação) ou erro de dispensação.
4. Se houver risco clínico, orientar o cliente a procurar atendimento imediatamente.
5. Evento adverso suspeito: notificar no VigiMed; a suspeita basta (RDC 44/2009, art. 67).
6. Queixa técnica: notificar no Notivisa como profissional ou serviço cadastrado, comunicar o SAC do fabricante e a vigilância local conforme o caso.
7. Suspeita de falsificação ou adulteração: segregar o lote em estoque e notificar a autoridade sanitária imediatamente (art. 34, §2º).
8. Erro de dispensação: contatar o cliente, corrigir, registrar e investigar a causa para revisar o POP.
9. Ao receber alerta de recolhimento da Anvisa ou comunicado do detentor do registro, localizar lotes no sistema e no estoque e bloquear a venda no mesmo dia.

10. Segregar os itens recolhidos em área identificada como "recolhido, não comercializar" (art. 38, §3º).
11. Devolver ou destinar conforme as instruções do recolhimento e guardar o comprovante.
12. Dar retorno ao cliente com a conclusão.
13. Revisar mensalmente as reclamações para identificar repetição.

Cuidados

- Não trocar produto suspeito sem registrar o lote.
- Não descartar a amostra antes da conclusão.
- Usar iniciais do paciente nas notificações para proteger dados.

Registros

- Formulário de reclamação e conclusão
- Comprovantes de notificação (VigiMed, Notivisa)
- Termo de recolhimento com quantidades e lotes

Referências

- RDC 44/2009, arts. 34, 38 e 67
- Lei 13.021/2014, art. 13, I
- Anvisa: VigiMed e Notivisa (portal gov.br/anvisa)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

SOS Farmácia Comercial

Reclamação sobre medicamento

Cliente relata problema com medicamento comprado na loja

Registrar dados do cliente, produto, lote, validade e relato; guardar amostra e embalagem

DECISÃO

Há sintoma grave agora?

SIM
Orientar atendimento imediato ou acionar SAMU (192) e depois seguir

NÃO
Seguir para a classificação

DECISÃO

Houve efeito indesejado no paciente?

SIM
Notificar evento adverso no VigiMed

NÃO
Seguir

DECISÃO

Há defeito no produto ou suspeita de falsificação?

SIM
Segregar o lote em estoque; notificar queixa técnica no Notivisa e a vigilância local; SAC do fabricante

NÃO
Investigar erro de dispensação ou de uso

ATENÇÃO

Suspeita de falsificação exige notificação imediata à autoridade sanitária (RDC 44/2009, art. 34, §2º)

Dar retorno ao cliente e registrar a conclusão

Revisar POP envolvido se a causa for interna; arquivar por 5 anos

Autoinspeção para a vigilância sanitária

- ◯ AFE, AE (se aplicável), licença sanitária e certidão do CRF válidas
- ◯ Licença sanitária e certidão do CRF afixadas em local visível
- ◯ Cartaz com dados da empresa, RT, substitutos e horários de cada farmacêutico
- ◯ Farmacêutico presente e identificado em todo o horário de funcionamento
- ◯ Manual de Boas Práticas específico, atualizado e assinado
- ◯ Lista mestra de POPs com versão vigente e data de revisão
- ◯ Todos os POPs aprovados, assinados e datados pelo RT
- ◯ Registros de treinamento com conteúdo, carga horária, assinaturas e avaliação
- ◯ Registro de divulgação dos POPs para cada funcionário
- ◯ Planilha de temperatura e umidade do ambiente preenchida no horário definido
- ◯ Planilha da geladeira com leituras de abertura e fechamento, máxima e mínima
- ◯ Ações corretivas registradas nas leituras fora da faixa
- ◯ Certificados de calibração dos termômetros e aparelhos de serviços dentro do prazo
- ◯ Geladeira exclusiva, sem alimentos, com produtos fora da porta
- ◯ Produtos afastados de piso, parede e teto e protegidos do sol
- ◯ Controlados em armário com chave sob guarda do farmacêutico
- ◯ Área segregada identificada para vencidos, avariados, suspeitos e recolhidos
- ◯ Nenhum produto vencido na área de venda ou no estoque utilizável
- ◯ Inflamáveis e corrosivos longe de fonte de calor, com POP
- ◯ Cartaz sobre automedicação visível na área de medicamentos
- ◯ Lista de genéricos e de serviços públicos de saúde disponível

- ◯ Serviços prestados coincidem com os da licença sanitária
- ◯ Sala de serviços limpa, com registro de limpeza no início e no fim do dia
- ◯ Lavatório com sabonete líquido, toalha descartável, gel e lixeira com pedal e tampa
- ◯ Coletor de perfurocortantes abaixo de 3/4
- ◯ Cópias de DSF e registros de serviços com consentimento
- ◯ PGRSS atualizado, contrato e comprovantes de coleta arquivados
- ◯ Comprovante de desratização e desinsetização por empresa licenciada
- ◯ Comprovante de limpeza da caixa d'água, se houver
- ◯ SNGPC transmitido dentro do prazo; receitas retidas organizadas
- ◯ Notas fiscais com lote e fabricante arquivadas

Cartões de revisão: POPs

Pergunta	Resposta
Quem aprova o POP na farmácia?	O farmacêutico responsável técnico, que aprova, assina e data (RDC 44/2009, art. 87).
Diferença entre Manual de Boas Práticas e POP	O Manual diz o que a farmácia faz e suas políticas; o POP descreve como executar cada atividade.
Por quanto tempo a documentação fica na farmácia?	No mínimo 5 anos, à disposição da vigilância (RDC 44/2009, art. 89).
Conteúdo mínimo do registro de treinamento	Atividade, data e carga horária, conteúdo, treinados com assinatura, instrutor e resultado da avaliação (art. 28).
O que o POP de temperatura precisa definir, além da leitura?	A faixa de horário de maior temperatura e umidade e as medidas quando houver condição inadequada (art. 35, §§ 4º e 5º).
Que artigo da RDC 44/2009 exige POP para inflamáveis?	Art. 39: justificativa em POP e guarda longe de calor e faíscas.
Parâmetros fisiológicos permitidos na farmácia	Pressão arterial e temperatura corporal (RDC 44/2009, art. 69, §1º).
Que norma regula hoje a glicemia capilar feita pelo farmacêutico?	RDC 978/2025: a farmácia precisa ser Serviço Tipo I, com controle interno e externo da qualidade.

Pergunta	Resposta
Frase obrigatória na DSF após aferição ou exame	"ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (redação da RDC 786/2023).
Quando trocar o coletor de perfurocortantes?	Ao atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante; proibido esvaziar e reaproveitar (RDC 222/2018, art. 87).
Vencido do estoque vai para o coletor de descarte dos clientes?	Não. Segue o PGRSS; o Decreto 10.388/2020 não se aplica a serviços de saúde (art. 5º, III).
Frase obrigatória no dispensador contentor	"Descarte aqui os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso" (Decreto 10.388/2020, art. 11).
Validade da receita de antimicrobiano	10 dias a partir da emissão, que conta como dia 0 (RDC 471/2021).
Onde notificar evento adverso a medicamento?	No VigiMed, da Anvisa; a simples suspeita basta.
Prazo para defesa contra auto de infração sanitária	Quinze dias contados da notificação (Lei 6.437/1977, art. 22).

Questões: POPs, serviços e inspeção

1. Uma drogaria tem POPs elaborados pela gerente administrativa, assinados por ela e pelo proprietário. Segundo a RDC 44/2009, esses documentos:

A. Estão regulares, pois o responsável legal provê as condições de funcionamento
B. Estão regulares se a equipe tiver sido treinada e o treinamento registrado
C. Precisam ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico RT
D. Precisam ser homologados pela vigilância sanitária antes do uso
E. Precisam ser registrados no Conselho Regional de Farmácia

2. Farmacêutico de uma drogaria quer oferecer glicemia capilar usando glicosímetro de autoteste. Em outubro de 2026, a situação normativa é:

A. É exame de análise clínica: exige Serviço Tipo I e controle de qualidade
B. O autoteste nunca é considerado exame quando operado dentro da farmácia, por ser produto de venda livre
C. A glicemia capilar foi proibida em farmácias e drogarias pela RDC 786/2023
D. Basta constar em POP aprovado, pois a licença sanitária não precisa citar o serviço
E. O exame só pode ser feito por técnico de laboratório contratado

3. Na sala de serviços, o coletor de perfurocortantes está quase cheio. A conduta correta, segundo a RDC 222/2018, é:

A Usar até o limite da tampa e então lacrar

B Esvaziar o conteúdo em saco branco leitoso e reaproveitar o coletor

C Trocar uma vez por semana, independentemente do volume

D Substituir ao atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante

E Transferir o conteúdo para outro coletor maior, de uso exclusivo da sala

4. Drogaria em município de 600 mil habitantes é ponto fixo de recebimento de medicamentos domiciliares. Um cliente traz cartelas vencidas. Pelo Decreto 10.388/2020, a farmácia deve:

A Receber e incluir os produtos na caixa de vencidos do próprio estoque da loja

B Manter dispensador contentor e registrar a massa recebida

C Recusar, porque a logística reversa cabe só às unidades de saúde

D Receber apenas se o cliente apresentar a nota fiscal de compra

E Encaminhar o cliente diretamente ao distribuidor da região

5. Após aferir a pressão arterial de um cliente, o farmacêutico emite a Declaração de Serviço Farmacêutico. Com a redação atual da RDC 44/2009, ela deve conter:

A Diagnóstico provável e sugestão de anti-hipertensivo

B Apenas o valor medido, sem valores de referência, para não induzir interpretação do cliente

C Valor medido, referência e frase de que substitui exames laboratoriais

D Assinatura do cliente e do médico responsável pela farmácia

E Valores, referência, orientação e alerta de que não tem fim diagnóstico

6. Na documentação de uma farmácia, a planilha da geladeira preenchida e assinada pelo balconista é classificada como:

A Manual de Boas Práticas

B Procedimento operacional padrão

C Registro

D Instrução de trabalho

E Plano de gerenciamento

7. Receita de amoxicilina emitida em 03/03. A cliente chega à farmácia em 13/03, sem indicação de uso contínuo. Pela RDC 471/2021, o farmacêutico:

A Recusa, porque a receita venceu em 10/03, com 7 dias de validade

B Dispensa, porque 13/03 é o 10º dia, ainda dentro da validade

C Recusa, porque o dia da emissão conta como dia 1

D Dispensa somente metade da quantidade prescrita

E Dispensa, porque antimicrobiano oral não exige retenção

8. Durante a inspeção, o fiscal pergunta quais documentos precisam estar afixados em local visível ao público. Segundo a RDC 44/2009, art. 2º, §1º, são:

A Manual de Boas Práticas e lista de POPs

B Certificado de calibração dos aparelhos e o PGRSS completo

C AFE e notas fiscais de compra

D Licença ou alvará sanitário e Certidão de Regularidade Técnica

E Contrato de coleta de resíduos e laudo de dedetização do último semestre

9. Farmácia privada licenciada para vacinação recebe cliente que pede vacina não incluída no Calendário Nacional de Vacinação, sem prescrição. Conforme a RDC 197/2017:

A A aplicação exige prescrição médica nesse caso

B Pode aplicar, pois toda vacina registrada é de venda livre

C Pode aplicar se o cliente assinar termo de responsabilidade

D Pode dispensar a vacina para aplicação em outro local

E Deve recusar, porque farmácia só aplica vacinas do calendário

10. Sobre a perfuração de lóbulo auricular em farmácias, é correto afirmar:

A Foi excluída dos serviços permitidos pela RDC 786/2023

B Pode ser feita com agulha de injeção estéril de grosso calibre

C O brinco pode ser reutilizado se for esterilizado na própria farmácia, em estufa

D Dispensa POP, por ser procedimento estético

E Exige aparelho que use o próprio brinco como material perfurante

Gabarito comentado

1. **C**. O art. 87 da RDC 44/2009 exige que os POPs sejam aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico responsável técnico. O responsável legal provê recursos (art. 23), mas não aprova POP. Treinamento é obrigatório, porém não supre a aprovação. A norma não prevê homologação pela vigilância nem registro no CRF.
2. **A**. A RDC 786/2023 revogou o art. 70 da RDC 44/2009 e a RDC 978/2025 passou a regular os exames. Segundo as perguntas e respostas da Anvisa sobre a RDC 978/2025, o uso de autoteste pelo farmacêutico na farmácia caracteriza exame de análise clínica, com exigência de controle interno e externo da qualidade, e a glicemia é permitida em farmácia Serviço Tipo I. A licença precisa indicar a atividade (RDC 978/2025, art. 63; RDC 44/2009, art. 61, §3º). O exame é feito por profissional legalmente habilitado, como o farmacêutico.
3. **D**. O art. 87 da RDC 222/2018 determina a substituição quando o preenchimento atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante, sendo proibidos o esvaziamento manual e o reaproveitamento. Encher até a tampa aumenta o risco de acidente; troca por calendário fixo ignora o volume; transferir conteúdo equivale a esvaziamento manual.
4. **B**. Os arts. 10 a 12 do Decreto 10.388/2020 obrigam a farmácia ponto fixo a manter dispensador contentor, armazenamento primário quando necessário e registro da massa, em quilogramas, no manifesto de transporte de resíduos. Misturar com vencidos do estoque é errado, porque estes seguem o PGRSS (art. 5º, III). Não há exigência de nota fiscal, e a coleta pelo distribuidor ocorre a partir da farmácia (art. 14).
5. **E**. O art. 81 exige valores medidos seguidos dos valores de referência, orientação, data, assinatura e carimbo do farmacêutico, além da frase de alerta, que após a RDC 786/2023 diz: "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA". A aferição não tem finalidade diagnóstica (art. 69) e é vedado indicar medicamento de venda sob prescrição (art. 69, §4º). Não existe médico responsável pela farmácia.
6. **C**. Registro é o documento que prova que a atividade foi feita (RDC 44/2009, arts. 35, §3º, e 88). O POP descreve como fazer a leitura; o Manual traz políticas e organização; a instrução de trabalho detalha uma etapa, como operar o termômetro; o plano de gerenciamento refere-se a resíduos (PGRSS).
7. **B**. A receita de antimicrobiano vale por 10 dias a contar da emissão, e o dia da emissão é o dia 0. Assim, 13/03 é o dia 10, ainda válido. Não existe validade de 7 dias, a contagem não começa em 1, não há dispensação de metade como regra, e a retenção da segunda via é obrigatória.
8. **D**. O art. 2º, §1º, exige que a licença ou alvará sanitário e a Certidão de Regularidade Técnica fiquem afixados em local visível ao público. Os demais documentos devem existir no estabelecimento e ser apresentados quando solicitados, mas não precisam ficar expostos.
9. **A**. O art. 14 da RDC 197/2017 determina que a administração, em estabelecimento privado, de vacinas não contempladas no Calendário Nacional seja feita mediante prescrição médica, e a dispensação deve estar vinculada à administração. Termo de responsabilidade não supre a exigência. Farmácias podem aplicar vacinas fora do calendário com prescrição.
10. **E**. O art. 78 da RDC 44/2009 exige aparelho específico que use o brinco como material perfurante e veda agulhas de injeção, de sutura ou outros objetos. A RDC 786/2023 não retirou o serviço do art. 61, §1º. O art. 80 exige POP com antissepsia, assepsia do aparelho, EPI e referência. Leis estaduais como a de São Paulo vedam a reutilização de brincos.

Módulo 8

Organização de prateleiras, validade e etiquetagem

Onde cada produto pode ficar na farmácia e na drogaria, critérios de arrumação de gôndolas e prateleiras, PVPS e reposição, inspeção mensal de validade, destino de vencidos, avariados e recolhidos, afixação de preço, PMC e promoções, e a rotina de reposição e conferência. Normas centrais: RDC 44/2009 (com a RDC 41/2012), IN 9/2009, Portaria 344/1998, Lei 6.437/1977, Lei 10.962/2004, Decreto 5.903/2006, Resoluções CM-CMED 2/2018 e 4/2026, RDC 96/2008, RDC 768/2022 e RDC 222/2018.

- Áreas da loja e o que fica em cada uma
- Critérios de arrumação
- Gôndola, alturas e condições do ambiente
- Validade na prateleira e reposição
- Controle mensal de validade
- Produto vencido, avariado, interditado ou recolhido
- Preço, etiqueta de gôndola e promoções
- Rotina de reposição, ruptura e conferência

Áreas da loja e o que fica em cada uma

A Lei 5.991/1973 define a **drogaria** como o estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais (art. 4º, XI). Antes de arrumar a primeira prateleira, quem chega à loja precisa responder duas perguntas: o que a farmácia pode vender e em que área cada produto pode ficar. A RDC 44/2009 manda organizar os produtos em área de circulação comum ou em área de circulação restrita aos funcionários, conforme o tipo e a categoria de cada um (art. 40).

Área restrita aos funcionários

É o lugar padrão de todo medicamento. A norma é direta: os medicamentos "deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida sua exposição direta ao alcance dos usuários do estabelecimento" (RDC 44/2009, art. 40, §1º). Na loja, essa área é o espaço atrás do balcão: prateleiras de parede, gaveteiros, armários e o estoque. O cliente pode ver as embalagens, mas não pode pegá-las.

Ficam na área restrita os medicamentos de venda sob prescrição (com ou sem retenção de receita), os antimicrobianos, os agonistas de GLP-1, os injetáveis, os medicamentos de uso contínuo de tarja vermelha e qualquer MIP que a loja prefira não deixar no autosserviço. A RDC 471/2021 trata de receita, retenção e escrituração dos antimicrobianos; a guarda deles segue a regra geral da área restrita.

Área de livre acesso (autosserviço)

O medicamento isento de prescrição (MIP) é a única exceção. Desde a RDC 41/2012, que deu nova redação ao art. 40, §2º, da RDC 44/2009, os MIP podem permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por autosserviço. A mesma RDC 41/2012 reescreveu o art. 41 e fixou as condições:

- cartaz em local visível, legível a partir da área de circulação comum, com a frase "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41);
- MIP com o mesmo princípio ativo, ou a mesma associação, organizados em um mesmo local e identificados de forma visível pela DCB ou, na falta dela, pela DCI (art. 41, §1º);
- MIP dispostos separadamente dos demais produtos da área de autosserviço, como cosméticos e alimentos (art. 41, §2º).

Para saber se um produto é MIP, consulta-se a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (IN 285/2024, com anexos atualizados) e o enquadramento do registro. Um medicamento recém-enquadrado como MIP só vai para o autosserviço depois que a empresa adequar bula e rotulagem (RDC 882/2024, art. 19). O módulo de MIP detalha esses critérios.

Controlados e termolábeis

Medicamentos sujeitos a controle especial ficam "sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo" (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 67), em sistema segregado (armário resistente ou

sala própria) sob guarda do farmacêutico (RDC 44/2009, art. 37). Controlado não fica em prateleira aberta, nem solto atrás do balcão. Os termolábeis ficam no equipamento de refrigeração, com temperatura medida e registrada diariamente (art. 35, §3º); o módulo de termolábeis e armazenamento trata do equipamento, da leitura e da excursão de temperatura.

Outros produtos: o que a drogaria pode vender

A RDC 44/2009 permite estender às farmácias e drogarias o comércio de determinados correlatos, "conforme relação, requisitos e condições estabelecidos em legislação sanitária específica" (art. 29). Essa relação é a Instrução Normativa 9/2009, publicada junto com a RDC 44/2009. Até outubro de 2026 não localizamos ato que a revogue. Pontos que mais aparecem na arrumação:

Categoria	Regra	IN 9/2009
Cosméticos, perfumes, higiene pessoal	Permitidos, se regularizados na Anvisa	Art. 3º, caput e §4º
Produtos médicos	Só os de uso por leigos em ambiente doméstico	Art. 3º, §2º
Diagnóstico in vitro	Só autoteste	Art. 3º, §3º
Mamadeiras, chupetas, bicos	Permitidos, observada a NBCAL (Lei 11.265/2006)	Art. 4º, I
Brincos estéreis	Só se a loja presta o serviço de perfuração de lóbulo; piercing e brinco comum, não	Art. 4º, III, e §1º
Lentes de grau	Vedadas, salvo se não houver estabelecimento específico no município	Art. 5º
Alimentos para fins especiais, suplementos de vitaminas e minerais, chás, mel, própolis	Permitidos se regularizados; sem alegação terapêutica; alimentos para diabéticos em local exclusivo	Arts. 6º a 12

O parágrafo único do art. 13 da IN 9/2009 veda "comercializar, expor à venda, ter em depósito para vender" produtos não permitidos. Há leis estaduais e decisões judiciais, em casos concretos, que admitem artigos de conveniência em farmácias. Como a regra aplicada depende do estado e do município, a loja confirma com a vigilância sanitária local antes de expor produto fora da lista.

ATENÇÃO

Alimento exposto ao lado de medicamento, com cartaz dizendo que "ajuda a controlar a glicose", junta dois erros: mistura categorias que a norma manda separar (RDC 44/2009, art. 41, §2º; IN 9/2009, art. 6º, parágrafo único) e atribui finalidade terapêutica a alimento (IN 9/2009, art. 12).

NO BALCÃO

Cliente pega na gôndola um antigripal e pergunta se pode levar também "aquele remédio de pressão que fica atrás do balcão". O atendente explica que medicamentos sob prescrição ficam na área restrita justamente para passarem pela dispensação, pede a receita e chama o farmacêutico se houver dúvida sobre a associação com o antigripal (descongestionante sistêmico eleva a pressão arterial).

Critérios de arrumação

Arrumar bem é fazer com que qualquer pessoa da equipe encontre o produto certo em poucos segundos, sem confundir apresentações. A RDC 44/2009 exige armazenamento ordenado, que garanta identidade, integridade e rastreabilidade (art. 35), e pede POP para "exposição e organização dos produtos para comercialização" (art. 86, III). A norma não impõe um critério único: a loja escolhe, escreve no Manual de Boas Práticas e no POP e aplica igual em todas as seções.

Primeiro nível: categoria

A loja é dividida em blocos. Na área restrita, os blocos mais comuns são: medicamentos sólidos orais, líquidos orais, uso tópico, uso oftálmico e otológico, injetáveis, hormônios e contraceptivos, e os blocos que exigem separação física (controlados, termolábeis, inflamáveis). No autosserviço, os MIP costumam ser agrupados por indicação (dor e febre, gripe e resfriado, azia e má digestão, vitaminas) e, dentro de cada indicação, por princípio ativo, como manda o art. 41, §1º.

Segundo nível: ordem alfabética

Dentro de cada bloco, a ordem é alfabética. Há duas escolhas possíveis, e a loja precisa adotar uma só por bloco:

Critério	Como fica	Vantagem	Cuidado
Pela DCB (substância)	Referência, similares e genéricos da mesma substância ficam juntos	Facilita a troca por intercambiável e mostra de uma vez todas as opções e preços	Associações exigem regra (ordenar pela primeira substância do nome)
Pelo nome comercial	Cada marca em seu lugar; genéricos em bloco próprio, pela DCB	Rápido quando a receita traz a marca; parecido com o que o cliente pede	A mesma substância fica espalhada; marcas parecidas ficam vizinhas

Muitas lojas usam a combinação: marcas pela ordem do nome comercial e genéricos em bloco separado, pela DCB. Funciona, desde que o POP diga isso e a etiqueta de cada prateleira mostre a faixa alfabética ("A a C", "D a F").

Sentido de leitura

Como boa prática, a gôndola é lida como página de livro: **da esquerda para a direita e de cima para baixo**. A letra A começa na prateleira de cima, à esquerda, e a sequência continua na prateleira de baixo, de novo a partir da esquerda. Dentro do mesmo produto, a regra mais usada é concentração crescente da esquerda para a direita (dipirona 500 mg antes de 1 g) e, na mesma concentração, embalagem menor

antes da maior. O mesmo sentido vale para o gaveteiro: gaveta de cima à esquerda, depois para a direita, depois a fileira de baixo.

Genéricos

A exigência federal que a RDC 44/2009 faz sobre genéricos é de informação: manter à disposição dos usuários, em local de fácil visualização e de imediata identificação, lista atualizada dos medicamentos genéricos comercializados no país, com base na relação publicada pela Anvisa (art. 42, §1º). Nas normas federais consultadas não encontramos obrigação de expor genéricos em prateleira separada; algumas leis estaduais e municipais exigem cartaz ou lista própria, e cabe conferir a da cidade. O genérico se reconhece pela faixa amarela com o logotipo na face frontal da embalagem secundária (RDC 768/2022, art. 25). Separar ou não é decisão da loja, registrada no POP.

Nomes e embalagens parecidos

A ordem alfabética coloca lado a lado nomes que começam igual. Para medicamentos potencialmente perigosos e pares de nomes ou embalagens semelhantes, a boa prática é quebrar a ordem e separar fisicamente, sinalizar a prateleira e destacar em maiúsculas a parte que difere nas etiquetas (ex.: "hidrOXIZINA" e "hidrALAZINA"). O módulo de termolábeis e armazenamento traz as medidas para alta vigilância.

Etiqueta de endereço

Cada prateleira ou gaveta recebe uma etiqueta com o endereço (bloco, gôndola, prateleira, posição) e, se a loja usar sistema, esse endereço fica cadastrado no produto. Quem repõe sabe onde guardar; quem atende sabe onde procurar; o inventário confere por endereço.

CASO

Uma drogaria organizava a área restrita pelo nome comercial e os genéricos misturados entre as marcas, pela DCB. "Losartana" ficava entre "Lipitor" e "Lustral". O farmacêutico reescreveu o POP: marcas por nome comercial, genéricos em bloco próprio por DCB, e etiqueta de faixa alfabética em cada prateleira. O tempo de busca caiu e acabaram as trocas entre losartana 50 mg e 100 mg, que passaram a ficar em ordem crescente.

NO BALCÃO

Receita de "Glifage XR 500 mg". Com organização pela DCB, o atendente encontra no mesmo ponto a referência e os genéricos de cloridrato de metformina de liberação prolongada e pode oferecer o intercambiável. A troca segue a regra da intercambialidade: genérico no lugar da referência, liberação prolongada por liberação prolongada, nunca por metformina de liberação imediata.

Gôndola, alturas e condições do ambiente

Gôndola é o móvel de prateleiras usado na área de vendas; na área restrita, as prateleiras de parede e os gaveteiros cumprem o mesmo papel. A posição de cada produto na altura e na profundidade afeta três

coisas: segurança de quem pega, conservação do produto e venda.

Partes e vocabulário

- **Frente** (ou face): cada unidade visível de um mesmo produto na linha da frente. Três caixas lado a lado são três frentes.
- **Profundidade**: as unidades enfileiradas atrás da frente.
- **Ponta de gôndola**: a cabeceira do móvel, voltada para o corredor, muito vista pelo cliente.
- **Testeira**: faixa de sinalização no alto da gôndola, com o nome da categoria.
- **Trilho de preço**: régua na borda da prateleira onde ficam as etiquetas.

Altura das prateleiras

A divisão abaixo é prática corrente de varejo, sem norma sanitária que a imponha:

Nível	O que costuma ficar	Motivo
Superior (acima da cabeça)	Itens leves, de pouco giro, embalagens grandes e leves	Difícil de alcançar; risco de queda
Nível dos olhos	Itens de maior giro e os que a loja quer destacar	É o que o cliente vê primeiro
Nível das mãos	Itens de compra frequente e de escolha rápida	Pega fácil, sem abaixar
Inferior (perto do piso)	Pesados e volumosos (fraldas, embalagens grandes)	Evita queda de peso do alto

Na área restrita vale a mesma lógica pensando no atendente: o que sai muito fica entre o ombro e a cintura, frascos de vidro e pesados não vão para o alto, e itens de alta vigilância não ficam em prateleira que exija escada ou pegar "às cegas".

Afastamentos

Os produtos ficam "em gavetas, prateleiras ou suporte equivalente, afastados do piso, parede e teto, a fim de permitir sua fácil limpeza e inspeção" (RDC 44/2009, art. 36). A norma não fixa distância em centímetros; o POP da loja define. Caixa de estoque nunca fica no chão: vai para estrado (palete) ou prateleira baixa. Produto encostado na parede pega umidade e calor e esconde sujeira e pragas.

Luz, calor e umidade

O ambiente deve ser mantido limpo e protegido da ação direta da luz solar, da umidade e do calor (art. 35, §2º). Na prática:

- vitrine que recebe sol da tarde não expõe medicamento nem produto sensível ao calor; serve para sinalização ou produto resistente;
- prateleira sob lâmpada que esquenta, perto de motor de refrigerador, de forno de micro-ondas da copa ou de saída de ar quente não recebe medicamento;

- parede com infiltração, área próxima a banheiro ou pia e local onde se lava o piso com muita água não recebem estoque;
- temperatura e umidade do ambiente são medidas na faixa de horário de maior risco definida no POP (art. 35, §4º), com medidas previstas para quando estiverem inadequadas (§5º).

Corrosivos, inflamáveis e explosivos (álcool líquido, acetona, éter) ficam em local justificado em POP, longe de calor e de fontes de faísca (art. 39). Isso inclui não guardá-los perto do quadro de energia.

Como a embalagem fica na prateleira

- Face principal voltada para fora, com nome e concentração legíveis.
- Embalagem íntegra: caixa amassada, molhada, com lacre rompido ou etiqueta de outra loja sai da exposição e vai para avaliação (avariado).
- Etiqueta de preço colada na caixa, quando usada, nunca cobre lote, validade, registro, concentração ou advertências (boa prática).
- Prateleira sem excesso de peso e sem pilhas instáveis; as caixas de transporte respeitam o empilhamento máximo indicado nelas.

PONTO-CHAVE

Altura é decisão comercial e de segurança; afastamento, luz, calor e umidade são exigência sanitária (RDC 44/2009, arts. 35 e 36). Quando as duas se chocam, prevalece a exigência sanitária: vitrine ao sol não recebe medicamento, mesmo sendo o ponto mais visto da loja.

NO BALCÃO

Cliente reclama que o protetor solar "separou" e ficou com cheiro estranho. O atendente verifica que o lote veio da vitrine da frente, que recebe sol à tarde. Troca o produto, retira os demais da vitrine, registra a ocorrência e avisa o farmacêutico para avaliar o lote exposto e revisar o local de exposição.

Validade na prateleira e reposição

Validade é a data até a qual o fabricante garante a qualidade do produto, desde que conservado como indica a embalagem. Toda embalagem de medicamento traz lote e data de validade impressos de forma legível e indelével, no formato mês/ano ou dia/mês/ano (RDC 768/2022, art. 83). Quando a data vem só com mês e ano, a prática corrente é considerar o produto válido até o último dia daquele mês; a loja registra no POP como trata essa situação e quando retira o produto.

PVPS e PEPS

Dois critérios de saída aparecem em qualquer estoque:

Sigla	Significa	Olha para	Uso na farmácia
PVPS (FEFO)	Primeiro que vence, primeiro que sai (*first expired, first out*)	Data de validade	Critério para medicamentos e produtos com validade
PEPS (FIFO)	Primeiro que entra, primeiro que sai (*first in, first out*)	Data de chegada	Só funciona se os lotes chegarem sempre em ordem de validade

Um lote recebido hoje pode vencer antes de um lote recebido no mês passado (o distribuidor pode mandar sobra de lote antigo). Por isso o PEPS falha com medicamentos e o critério correto é o **PVPS**.

Onde fica o lote que vence primeiro

Como boa prática, a unidade que vence primeiro fica onde a mão vai primeiro:

- **na frente**, na profundidade da prateleira ou da gaveta;
- **à esquerda**, quando o mesmo produto ocupa várias frentes lado a lado, seguindo o sentido de leitura da gôndola;
- no gaveteiro, na posição mais próxima da abertura.

A reposição entra **por trás e pela direita**. Quem repõe puxa as unidades antigas para a frente e para a esquerda e só então coloca as novas no fundo. Colocar a caixa nova na frente, por pressa, é a origem da maior parte dos vencidos encontrados na prateleira.

Lotes misturados

Se duas validades diferentes ocupam a mesma fileira, a fileira fica em ordem: validade mais curta na frente, mais longa atrás. Quando há mais de duas validades para o mesmo item, a boa prática é concentrar na prateleira o lote mais curto e manter os demais no estoque, identificados, até a vez deles.

Puxar frente

"Puxar frente" é a rotina de trazer as unidades para a borda da prateleira, alinhar as faces e completar as frentes vazias. Feita na abertura e ao longo do dia, ela mantém o PVPS (quem puxa vê a validade) e mostra a ruptura antes que o cliente a perceba.

Recebimento e sistema

O PVPS começa no recebimento. A farmácia verifica o estado de conservação dos produtos ao receber (RDC 44/2009, art. 34) e confere lote e validade com a nota fiscal. Muitas lojas definem, por acordo comercial, uma validade mínima aceita na entrega (por exemplo, recusar produto com menos de alguns meses de validade restante); isso é política comercial, não exigência sanitária. Cadastrar lote e validade no sistema permite emitir o relatório mensal de vencimentos. Para controlados e antimicrobianos, o lote já é informado na escrituração do SNGPC.

CASO

Auxiliar novo repõe amoxicilina 500 mg colocando as caixas recém-chegadas (validade 2028) na frente das antigas (validade 03/2027). Na inspeção do mês, aparecem três caixas a quatro meses do vencimento, escondidas no fundo. O farmacêutico corrige a fileira, mostra o sentido de reposição (por trás, pela direita) e inclui no POP a conferência da validade da primeira e da última unidade de cada fileira ao repor.

NO BALCÃO

Cliente pede "a caixa do fundo, que deve ter validade maior". O atendente pode atender, porque o produto da frente está válido e o pedido é do cliente; mas, se for dispensar uma caixa com validade próxima, deve avisar (RDC 44/2009, art. 51, §1º) e conferir se o tratamento termina antes do vencimento (art. 51, §2º).

Controle mensal de validade

O PVPS organiza a saída; a inspeção mensal descobre o que escapou. A RDC 44/2009 exige que a política da empresa para produtos próximos ao vencimento seja clara para todos os funcionários e descrita no Manual de Boas Práticas (art. 38, §4º) e em POP (arts. 51 e 86, VI), e exige POP para o destino dos vencidos (art. 86, V).

O que a norma manda na dispensação

O QUE DIZ A NORMA

"O usuário deve ser alertado quando for dispensado produto com prazo de validade próximo ao seu vencimento" (RDC 44/2009, art. 51, §1º). "É vedado dispensar medicamentos cuja posologia para o tratamento não possa ser concluída no prazo de validade" (art. 51, §2º).

Exemplo: anticoncepcional oral em cartela para 21 dias, com validade no fim deste mês, faltando 10 dias. Se a cliente vai começar a cartela hoje, não completa o ciclo dentro da validade: a caixa não pode ser dispensada para esse uso.

Como fazer a inspeção

1. Dividir a loja em setores (gôndolas, gaveteiros, estoque, geladeira, armário de controlados) e montar um cronograma para que todos os setores sejam conferidos dentro do mês.
2. Emitir o relatório de validades do sistema para os próximos meses, por setor.
3. Conferir fisicamente: cada fileira, frente e fundo, e não só a primeira caixa.
4. Marcar os itens próximos do vencimento com a etiqueta definida no POP.
5. Registrar na planilha: produto, apresentação, lote, validade, quantidade, local, ação decidida, responsável, data.
6. Corrigir o sistema quando o físico não bater com o cadastro.

7. Levar ao farmacêutico a lista de ações (troca, devolução, transferência, promoção, retirada).

Etiqueta colorida

Como boa prática, muitas lojas usam uma cor de etiqueta por mês de vencimento, com legenda afixada no estoque. Quem passa pela prateleira vê de longe o que vence logo, sem ler data por data. A etiqueta fica na prateleira ou na caixa, sem cobrir lote, validade ou informações obrigatórias. Uma alternativa mais simples é a etiqueta escrita "VENCE 03/27" em cor única de alerta.

Antecedência para agir

A norma não fixa prazos; a política é da loja (art. 38, §4º). Um modelo usado como boa prática:

Faltam	Ação sugerida
6 meses	Identificar; verificar giro; suspender nova compra do item se o estoque for alto
3 a 4 meses	Negociar troca ou devolução com o fornecedor, conforme o contrato; transferir para filial com mais giro
1 a 2 meses	Priorizar a saída (PVPS); promoção permitida dentro das regras de preço e propaganda; avisar o cliente na dispensação
Mês do vencimento	Retirar da venda na data definida no POP; segregar; registrar; dar o destino

Medicamento de uso contínuo, vendido em caixa para 30 dias, precisa sair da prateleira antes do que um analgésico de uso pontual, por causa do art. 51, §2º. O POP pode fixar antecedências diferentes por tipo de produto.

Promoção de produto com validade próxima

Baixar o preço é permitido, desde que o produto esteja dentro da validade, o cliente seja avisado (art. 51, §1º) e o tratamento caiba no prazo (art. 51, §2º). As regras de preço e propaganda continuam valendo: anúncio de desconto informa também o preço integral (RDC 96/2008, art. 11, §4º); medicamento não entra como prêmio ou pontuação de programa de fidelidade (art. 10); e medicamento sob prescrição só tem preço divulgado em lista, sem argumento publicitário (art. 18 e art. 47).

Validade depois de aberto

Medicamento em embalagem multidose que perde validade após aberto traz no rótulo a frase "Após aberto, válido por ____" (RDC 768/2022, art. 54); a frase "Data do 1º uso: ____" é facultativa (art. 55). Na loja, isso importa em dois pontos: produtos abertos para uso interno (álcool 70%, antissépticos da sala de serviços) recebem a data de abertura escrita na embalagem; e o cliente é orientado a anotar a data de abertura de colírios, suspensões reconstituídas e frascos multidose. Os prazos por produto estão no módulo de termolábeis e armazenamento.

Fracionados

O fracionamento só ocorre depois da apresentação da receita, na quantidade prescrita e com dispensação imediata (RDC 80/2006, Anexo I, Parte II, item 4.1); não existe estoque de fracionados na prateleira. A embalagem original fracionável já aberta volta para a área restrita, identificada, e segue o controle de validade do fabricante. O rótulo do fracionado traz lote e validade (mês/ano) do medicamento de origem (RDC 80/2006), e a validade dele nunca vai além da validade da embalagem original.

NO BALCÃO

Cliente leva losartana 50 mg, caixa com 30 comprimidos, uso contínuo. A caixa disponível vence daqui a 20 dias. O atendente avisa a validade, procura outro lote no estoque e, se não houver, chama o farmacêutico, que só dispensa se o paciente for usar o conteúdo dentro do prazo; caso contrário, encomenda ou indica outra unidade.

Produto vencido, avariado, interditado ou recolhido

Quatro situações tiram um produto da venda na hora, e todas seguem a mesma lógica: separar, identificar, bloquear, registrar e dar destino.

Situação	Exemplo	Quem decide o destino
Vencido	Caixa com validade 08/2026 encontrada em outubro	Farmácia, pelo POP e pelo PGRSS
Avariado ou violado	Caixa molhada, frasco vazando, lacre rompido, blister furado	Farmácia; fornecedor, se a avaria veio na entrega
Interditado ou suspenso	Lote atingido por resolução da Anvisa publicada no Diário Oficial	Autoridade sanitária, nos termos do ato
Recolhido	Comunicado de recolhimento do detentor do registro	Detentor do registro, conforme as instruções do recolhimento

Base legal

- **RDC 44/2009, art. 38**: produtos violados, vencidos ou sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração são segregados em ambiente seguro, diverso da área de dispensação, e identificados quanto à condição e ao destino; não podem ser vendidos nem usados (§1º); o descarte segue as normas de resíduos de serviços de saúde (§2º); recolhimento segue regulamentação específica (§3º).
- **Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII**: é infração sanitária expor à venda ou entregar ao consumo produto de interesse à saúde com prazo de validade expirado, ou "apor-lhes novas datas, após expirado o prazo". Penas: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da licença e da autorização, e multa.
- **Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §6º**: são impróprios ao uso e consumo os produtos com prazo de validade vencido (inciso I) e os deteriorados, alterados, adulterados ou avariados (inciso II).

- **Lei 8.137/1990, art. 7º, IX**: vender, ter em depósito para vender ou expor à venda mercadoria em condições impróprias ao consumo é crime contra as relações de consumo, com detenção de 2 a 5 anos ou multa; a forma culposa também é punida, com pena reduzida (parágrafo único).

> **ATENÇÃO**
>
> Vencido na prateleira já configura exposição à venda, mesmo que ninguém tenha comprado. E trocar ou cobrir a data de validade é infração sanitária específica (Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII), além de crime contra o consumidor.

Segregação

A loja mantém uma área segregada fora da área de dispensação: armário, caixa fechada ou prateleira própria, com placa "PRODUTOS SEGREGADOS: NÃO COMERCIALIZAR" e separação por motivo (vencido, avariado, recolhido, suspeito). O produto é bloqueado no sistema no mesmo momento para não aparecer como disponível. Controlados vencidos ou avariados continuam no armário com chave, separados dos utilizáveis e identificados, até a baixa conforme a Portaria 344/1998 e a orientação da vigilância local.

Registro

Cada retirada gera registro: data, produto, apresentação, lote, validade, quantidade, motivo, local onde estava, quem retirou e destino. O registro serve à inspeção sanitária, à baixa contábil e à análise de perdas (quais itens vencem sempre e por quê).

Destino

- **Devolução ou troca com o fornecedor**: quando prevista no acordo comercial; avaria constatada no recebimento é recusada no ato.
- **Recolhimento ou interdição**: segue as instruções do ato ou do comunicado (quantidades, lotes, prazo e forma de devolução), com comprovante guardado.
- **Descarte**: como resíduo de serviço de saúde, pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), com empresa licenciada (RDC 222/2018). O vencido do estoque da farmácia não vai para o coletor de medicamentos domiciliares dos clientes, porque o Decreto 10.388/2020 não se aplica a medicamentos descartados por prestadores de serviços de saúde (art. 5º, III).

Suspeita de falsificação ou adulteração exige, além da segregação, notificação imediata à autoridade sanitária pelo farmacêutico (RDC 44/2009, art. 34, §§ 1º e 2º). O fluxo de reclamações, recolhimentos e notificações está no módulo de POPs.

> **CASO**
>
> Cliente volta com um xarope comprado ontem: vencido no mês anterior. O farmacêutico pede desculpas, troca o produto ou devolve o valor, confere se há outras unidades do mesmo lote na loja, segrega e bloqueia, registra a ocorrência e revê com a equipe por que a inspeção mensal não pegou o item. O cliente é orientado a procurar atendimento se tiver usado o xarope e apresentar qualquer reação.

NO BALCÃO

Ao separar uma receita, o atendente percebe que a caixa de omeprazol está com o lacre aberto. Não dispensa, entrega a caixa ao farmacêutico para segregação como violada e pega outra unidade íntegra.

Preço, etiqueta de gôndola e promoções

O preço do medicamento obedece a três conjuntos de normas ao mesmo tempo: as regras gerais de informação ao consumidor (Lei 10.962/2004 e Decreto 5.903/2006), o teto de preço fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e as regras sanitárias de propaganda (RDC 96/2008 e RDC 44/2009).

Formas de afixar o preço

A Lei 10.962/2004 admite, no varejo (art. 2º):

- no comércio em geral, etiqueta ou similar afixada diretamente no produto exposto, e preço à vista legível em vitrines (inciso I);
- onde o cliente tem acesso direto ao produto, como o autosserviço: preço impresso ou afixado na embalagem, código referencial ou código de barras (inciso II).

Com código de barras ou código referencial, o comerciante expõe junto aos itens o preço à vista, as características e o código (art. 2º, parágrafo único). Se a loja apreça por código de barras, deve oferecer leitores óticos para consulta na área de vendas (art. 4º): o Decreto 5.903/2006 manda sinalizar os leitores com cartazes suspensos, manter distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e o leitor mais próximo e ter croqui da área de vendas para a fiscalização (art. 7º, §§ 1º a 3º). O preço por unidade de medida (por mL, por grama), obrigatório para produtos fracionados em pequenas quantidades, não se aplica a medicamentos (art. 2º-A, parágrafo único).

Como deve ser a informação

O preço deve ter correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade (Decreto 5.903/2006, art. 2º). Fica sempre visível enquanto a loja estiver aberta, inclusive durante montagem, rearranjo ou limpeza (art. 4º). A etiqueta afixada no produto tem a face principal voltada para o consumidor (art. 5º). O art. 9º lista infrações, entre elas: letras de tamanho irregular, cor da letra igual ou parecida com a do fundo, caracteres apagados ou rasurados, preço só em parcelas, referência que deixa dúvida sobre o item, preços distintos para o mesmo item e informação na vertical. Havendo preços diferentes para o mesmo produto entre os sistemas da loja (etiqueta, leitor, caixa), o consumidor paga o menor (Lei 10.962/2004, art. 5º).

Etiqueta de gôndola de medicamento

Com base no Decreto 5.903/2006 (art. 6º, §3º), a etiqueta mostra preço à vista, características que particularizam o item (nome, quantidade e demais elementos) e código, em caracteres ostensivos e cor de destaque. Para medicamento, isso se traduz em:

- nome comercial e substância pela DCB (o genérico, só pela DCB);

- concentração, forma farmacêutica e quantidade da embalagem;
- preço à vista em reais;
- código de barras ou código interno;
- como boa prática, data de impressão da etiqueta, para saber se está atualizada.

ATENÇÃO

A etiqueta de medicamento não leva slogan, figura, selo, frase de efeito ou indicação de uso ("o melhor para dor", "mais vendido", "acaba com a gripe"). Preço de medicamento informado ao público vai em lista com nome comercial, DCB, apresentação, registro, detentor e preço (RDC 96/2008, art. 18), sem designações, símbolos, figuras ou argumentos publicitários (art. 47). Para MIP são permitidas outras formas de comunicação, desde que tragam as demais informações exigidas (art. 18, parágrafo único). Medicamento sob prescrição só tem propaganda em meios dirigidos a profissionais (art. 27).

CMED e preço máximo ao consumidor

A CMED define o **Preço Fábrica (PF)**, teto de venda do fabricante ou distribuidor, e o **Preço Máximo ao Consumidor (PMC)**, preço máximo a ser praticado pelo comércio varejista (Resolução CM-CMED 2/2018). O ajuste dos tetos é anual: em 2026, a Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026, autorizou a partir de 31 de março ajustes máximos de 3,81% (nível 1), 2,47% (nível 2) e 1,13% (nível 3).

O QUE DIZ A NORMA

"As unidades de comércio varejista deverão manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas, não podendo ser superiores aos preços publicados pela CMED no Portal da Anvisa" (Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º). O PMC varia conforme o ICMS de cada estado (art. 6º, parágrafo único).

A Resolução CM-CMED 2/2018 classifica como infração deixar de manter essas listas atualizadas e também ofertar ou vender medicamento acima do limite máximo (art. 5º). Por isso, etiqueta acima do PMC já é infração, mesmo sem venda. Preço abaixo do PMC é livre. A lista oficial é atualizada pela CMED e publicada no portal da Anvisa; a loja mantém à mão a lista atualizada ou a revista de preços, e o sistema precisa usar o PMC do estado da loja.

Promoções

- Desconto em percentual ou preço promocional vem acompanhado do preço integral praticado pela farmácia (RDC 96/2008, art. 11, §4º).
- Desconto anunciado em qualquer meio exige lista dos medicamentos anunciados, com o preço reduzido, em local visível ao público (art. 11, §5º).
- Frase de desconto por grupo ("genéricos com 30% de desconto") não pode vir com outros argumentos publicitários (art. 19).
- Comparação de preços dirigida ao consumidor, só entre medicamentos intercambiáveis (art. 11).

- Programa de fidelidade não usa medicamento como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio (art. 10).
- Desconto por forma ou prazo de pagamento é informado em local e formato visíveis (Lei 10.962/2004, art. 5º-A).

Em agosto de 2026 a Anvisa abriu processo para revisar as normas de propaganda de medicamentos; até a data deste material, a RDC 96/2008 continuava sendo aplicada.

NO BALCÃO

A etiqueta da gôndola mostra R$ 18,90 e o caixa registra R$ 21,40. O atendente cobra R$ 18,90 (Lei 10.962/2004, art. 5º), avisa o responsável para corrigir o cadastro ou a etiqueta e confere se o preço do sistema não ultrapassa o PMC.

Rotina de reposição, ruptura e conferência

Organização de prateleira se mantém com rotina. As normas sanitárias pedem o resultado (produtos ordenados, limpos, dentro da validade, com preço correto); as ferramentas abaixo são boas práticas de varejo que ajudam a chegar lá.

Rotina do dia

Momento	Tarefas
Abertura	Puxar frente; completar frentes vazias pelo PVPS; conferir etiquetas caídas ou trocadas; ler temperatura e umidade conforme o POP
Durante o dia	Repor itens de maior giro; recolher produtos deixados fora do lugar pelos clientes; manter corredores livres de caixas
Fechamento	Repor o que zerou; anotar faltas para compra; devolver ao estoque o que ficou no balcão; organizar o caixa de produtos para segregação

A reposição feita com a loja aberta não pode deixar o produto sem preço visível (Decreto 5.903/2006, art. 4º, parágrafo único).

Ruptura

Ruptura é o produto faltar na prateleira quando o cliente procura. Tem três origens: falta no estoque (compra atrasada ou falta no fornecedor), falta só na gôndola (o produto está no estoque e ninguém repôs) e divergência de sistema (o sistema mostra saldo que não existe fisicamente). Em medicamento de uso contínuo, a ruptura interrompe tratamento e leva o cliente para outra farmácia. O indicador simples é o percentual de itens da lista de referência que estavam em falta na conferência.

Curva ABC

A curva ABC ordena os itens pela participação no faturamento (ou na quantidade vendida) em um período:

- **A**: poucos itens que somam a maior parte do faturamento; nunca podem faltar, têm conferência mais frequente e estoque de segurança;
- **B**: participação intermediária;
- **C**: muitos itens, pouca venda cada um; são os que mais vencem na prateleira e pedem compra em quantidade pequena.

Os cortes entre A, B e C são definidos pela empresa. O uso prático para quem arruma: itens A ficam nos melhores pontos e são conferidos toda semana; itens C entram primeiro na lista de validade.

Planograma

Planograma é o mapa de cada gôndola: em que prateleira, em que posição e com quantas frentes cada produto fica. Ele padroniza a loja (e as filiais), mostra ao repositor onde cada item volta e evita que um produto ocupe o espaço de outro. Pode ser desenho, foto anotada ou tela do sistema. Muda quando entra ou sai um produto, e a etiqueta de endereço acompanha a mudança.

Limpeza das prateleiras

O ambiente de armazenamento é mantido limpo (RDC 44/2009, art. 35, §2º) e a limpeza segue o POP de limpeza (art. 86, I). Na prateleira, a boa prática é: retirar os produtos por trecho, limpar com pano apenas umedecido conforme o POP, secar, e devolver os produtos na ordem do planograma e do PVPS. Não se borrifa produto de limpeza sobre embalagens. A limpeza é o melhor momento para ver validade, avaria e sinais de pragas.

Conferência de preço e sistema

- Conferir por amostragem, toda semana, etiqueta de gôndola contra preço do sistema; corrigir na hora.
- Repetir a conferência completa depois do ajuste anual da CMED e de cada campanha de promoção.
- Retirar etiquetas antigas antes de colocar a nova (duas etiquetas para o mesmo item são preços distintos: Decreto 5.903/2006, art. 9º, VII).
- Testar os leitores de preço do autosserviço.
- Comparar o preço do sistema com o PMC do estado para os itens de maior venda.

Indicadores que valem acompanhar

Percentual de ruptura, valor perdido por vencimento por mês, número de divergências de preço encontradas e número de produtos encontrados fora do lugar. Cada indicador aponta um ajuste: de compra, de reposição ou de treinamento da equipe.

CASO

Uma loja perdia todo mês caixas de colírios e pomadas de pouco giro. A curva ABC mostrou que eram itens C comprados em caixa fechada de 12 unidades. O farmacêutico passou a comprar esses itens por unidade, incluiu-os na conferência quinzenal de validade e moveu os de maior risco para o nível das mãos, onde o PVPS é mais fácil de manter.

NO BALCÃO

Cliente procura um antiácido que "sempre tinha ali". O atendente consulta o sistema, vê saldo de 6 unidades, não encontra no endereço e acha as caixas no estoque, ainda no volume da entrega. Repõe pelo PVPS, atende o cliente e anota a falha de reposição para a reunião da equipe.

Fontes consultadas

1. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (art. 4º, XI). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
2. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Infrações à legislação sanitária federal (art. 10, XVIII, redação da MP 2.190-34/2001). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm
3. Brasil. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor (art. 18, §6º). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
4. Brasil. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Crimes contra as relações de consumo (art. 7º, IX). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm
5. Brasil. Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004. Oferta e formas de afixação de preços (com alterações das Leis 13.175/2015, 13.455/2017 e 13.543/2017). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.962.htm
6. Brasil. Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006. Regulamenta a Lei 10.962/2004 e a Lei 8.078/1990. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5903.htm
7. Brasil. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso (art. 5º, III).
8. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias (arts. 29, 34 a 42, 51, 54, 86 e 99). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
9. Anvisa. Resolução RDC nº 41, de 26 de julho de 2012. Altera os arts. 40 e 41 da RDC 44/2009 e revoga a IN 10/2009. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0041_26_07_2012.html
10. Anvisa. Instrução Normativa nº 9, de 17 de agosto de 2009. Relação de produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias e drogarias. Texto publicado pelo CFF: https://www.cff.org.br/userfiles/file/noticias/in9_170809.pdf
11. Anvisa. Resolução RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Propaganda, publicidade, informação e outras práticas de promoção comercial de medicamentos (arts. 8º, 10, 11, 18, 19, 22, 27 e 47). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0096_17_12_2008.html
12. Anvisa. Resolução RDC nº 768, de 12 de dezembro de 2022. Regras para a rotulagem de medicamentos (arts. 25, 54, 55 e 83).
13. Anvisa. Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/rdc0080_11_05_2006.html
14. Anvisa. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
15. Anvisa. Resolução RDC nº 882/2024 (enquadramento de MIP, art. 19) e Instrução Normativa nº 285/2024 (Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição), com atualizações.
16. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (art. 67).
17. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução CM-CMED nº 4, de 30 de março de 2026. Ajuste máximo de preços a partir de 31 de março de 2026 e publicidade dos preços (arts. 3º e 6º). Diário Oficial da União, 31 mar. 2026, Seção 1, p. 33.
18. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução CM-CMED nº 2, de 16 de abril de 2018, alterada pela Resolução CMED nº 2, de 3 de junho de 2025. Processo administrativo e infrações à regulação do mercado de

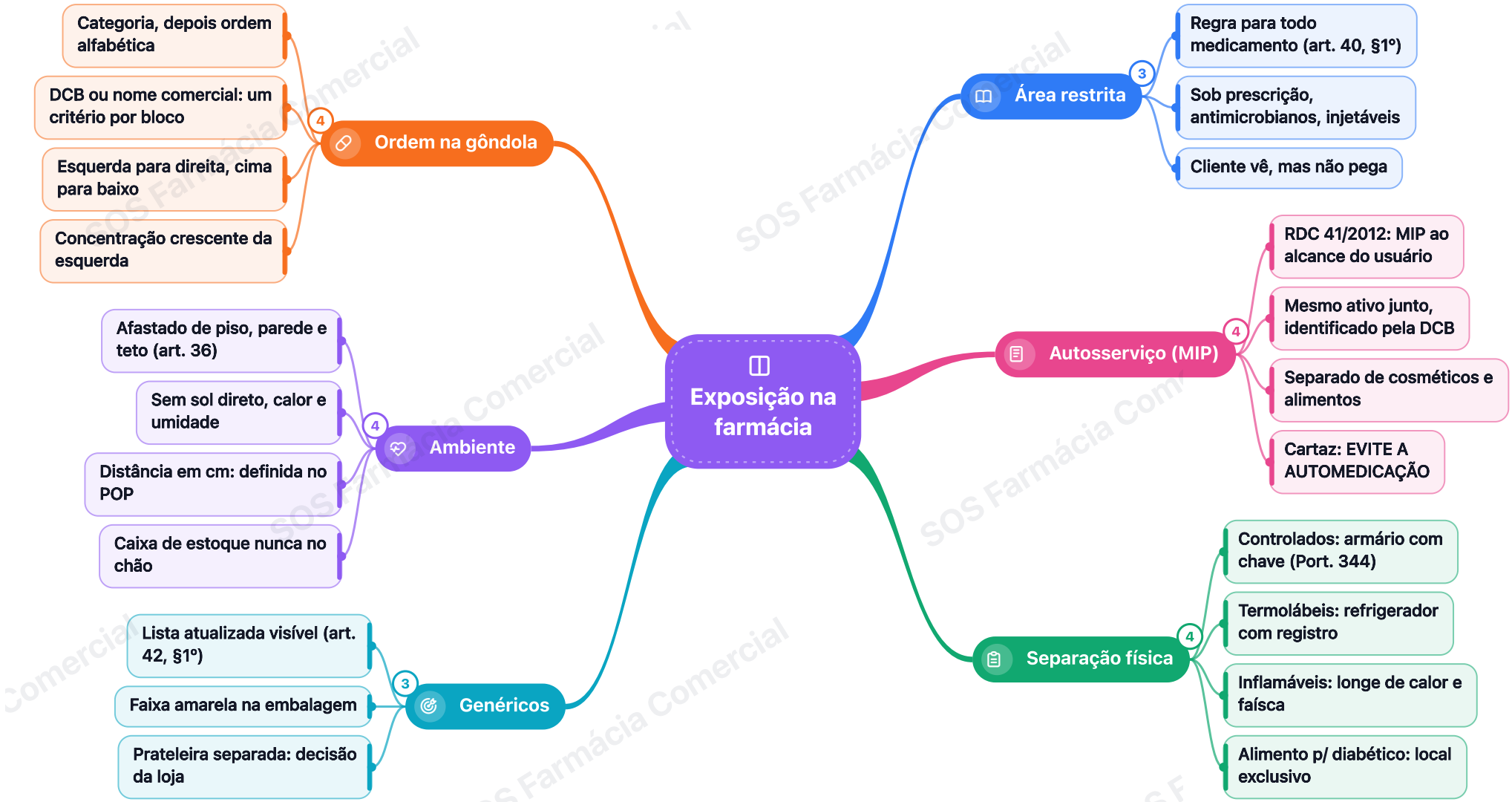
medicamentos (conceitos de PF e PMC; infrações no art. 5º).

19. Anvisa. Lista de preços de medicamentos (PMC), portal gov.br/anvisa, seção CMED, consultada em out. 2026. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos
20. Ouvidoria/Anvisa e Senacon. Consumo e Saúde: Preços de medicamentos, existe um limite? Ano 7, nº 35, jun. 2014.
21. Agência Gov. Anvisa aprova abertura de processo para revisar normas da propaganda de alimentos e de medicamentos. Ago. 2026.

SOS Farmácia Comercial

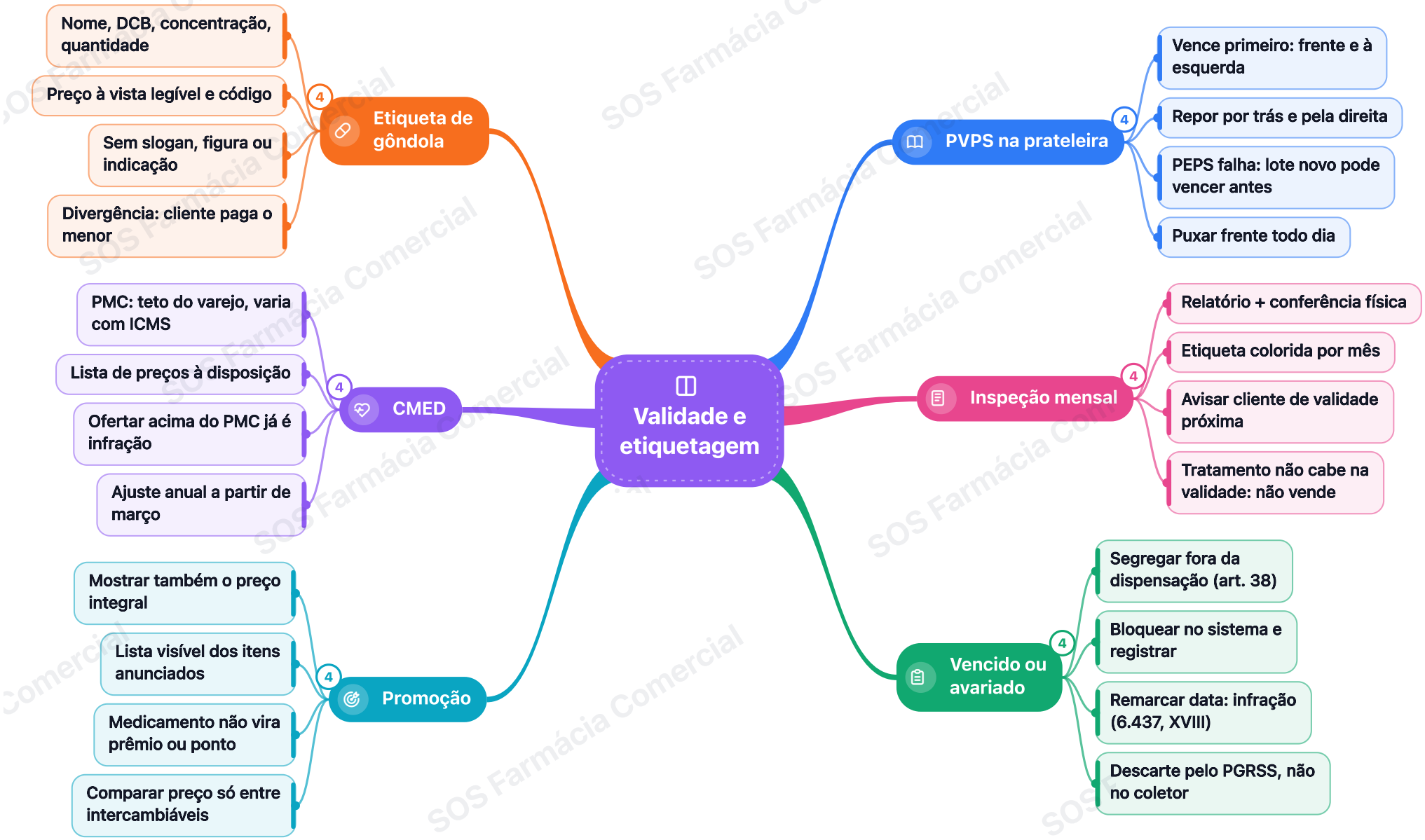
Onde e como expor

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 8



Validade, preço e etiqueta

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 8



Onde fica cada produto

Produto	Área	Condição	Base
MIP (analgésico, antiácido, antigripal isento)	Autosserviço ou área restrita	Agrupado por princípio ativo, identificado pela DCB, separado de outros produtos; cartaz obrigatório	RDC 44/2009, arts. 40, §2º, e 41 (RDC 41/2012)
Medicamento sob prescrição (tarja vermelha)	Área restrita	Fora do alcance do cliente	RDC 44/2009, art. 40, §1º
Antimicrobiano e agonista de GLP-1	Área restrita	Dispensação com retenção de receita	RDC 44/2009, art. 40, §1º; RDC 471/2021
Controlado (Portaria 344/1998)	Armário ou sala com chave, local exclusivo	Guarda do farmacêutico	Portaria 344/1998, art. 67; RDC 44/2009, art. 37
Termolábil (insulina, GLP-1, alguns colírios)	Refrigerador da área restrita	2 °C a 8 °C, temperatura registrada diariamente	RDC 44/2009, art. 35, §3º; módulo de termolábeis
Inflamável ou corrosivo (álcool líquido, acetona)	Local definido em POP	Longe de calor e de faíscas	RDC 44/2009, art. 39
Cosmético, perfume, higiene pessoal	Área comum	Separado dos MIP	IN 9/2009, art. 3º; RDC 44/2009, arts. 40, §3º, e 41, §2º
Produto médico de uso doméstico (termômetro, bolsa térmica)	Área comum	Só os de uso por leigos	IN 9/2009, art. 3º, §2º
Teste de diagnóstico in vitro	Área comum ou restrita, conforme o produto	Só autoteste	IN 9/2009, art. 3º, §3º
Alimento para diabéticos	Área comum	Local exclusivo, separado de outros produtos e alimentos	IN 9/2009, art. 6º, parágrafo único
Suplemento, chá, mel, própolis	Área comum	Regularizado; sem alegação terapêutica	IN 9/2009, arts. 7º a 12
Brinco estéril	Área comum ou restrita	Só se a loja faz perfuração de lóbulo	IN 9/2009, art. 4º, III
Vencido, avariado, recolhido	Área segregada, fora da dispensação	Identificado, bloqueado, sem venda	RDC 44/2009, art. 38

Itens não previstos na IN 9/2009 dependem da posição da vigilância sanitária local, porque há leis estaduais e decisões judiciais divergentes.

Desenho de uma gôndola: posição e validade

Vista de frente (sentido de leitura: esquerda para a direita, de cima para baixo). Exemplo de bloco de MIP para dor e febre, agrupado por princípio ativo e identificado pela DCB.

Prateleira	Posição 1 (esquerda)	Posição 2	Posição 3	Posição 4 (direita)
1 (alta)	Ácido acetilsalicílico 500 mg	Ácido acetilsalicílico 500 mg, embalagem maior	Dipirona 500 mg	Dipirona 1 g
2 (olhos)	Dipirona gotas 500 mg/mL	Ibuprofeno 200 mg	Ibuprofeno 400 mg	Ibuprofeno suspensão
3 (mãos)	Paracetamol 500 mg	Paracetamol 750 mg	Paracetamol gotas	Paracetamol suspensão
4 (baixa)	Embalagens grandes e pesadas do bloco	idem	idem	idem

Vista de cima de uma posição (paracetamol 500 mg com três frentes). A seta de saída é a frente; a reposição entra pelo fundo.

Profundidade	Frente 1 (esquerda)	Frente 2	Frente 3 (direita)
Frente (borda, sai primeiro)	Validade 02/2027	Validade 02/2027	Validade 05/2027
Meio	Validade 02/2027	Validade 05/2027	Validade 05/2027
Fundo (reposição entra aqui)	Validade 05/2027	Validade 11/2027	Validade 11/2027

- Validade mais curta: frente e esquerda. Validade mais longa: fundo e direita.
- Para repor: puxar as unidades que ficaram para a frente e para a esquerda, conferir a validade da primeira e da última unidade, colocar as novas no fundo.
- Etiqueta de preço no trilho, logo abaixo da posição, com a face voltada para o cliente (Decreto 5.903/2006, art. 5º, por analogia ao produto).
- Produtos afastados da parede do fundo e da prateleira de cima (RDC 44/2009, art. 36).

As posições e a ordem são exemplo de boa prática; o critério de cada loja fica no seu POP.

Inspeção mensal de validade

- [ ] Emitir o relatório de validades do sistema dos próximos 6 meses, por setor

- [ ] Seguir o cronograma: todos os setores conferidos dentro do mês, inclusive estoque, geladeira e armário de controlados
- [ ] Conferir cada fileira na frente e no fundo, não só a primeira caixa
- [ ] Verificar se a validade mais curta está na frente e à esquerda
- [ ] Marcar os itens próximos do vencimento com a etiqueta do mês definida no POP
- [ ] Retirar e segregar o que venceu ou vence no mês, conforme a política do Manual
- [ ] Bloquear no sistema todo item retirado
- [ ] Registrar produto, lote, validade, quantidade, local, ação e responsável
- [ ] Corrigir o cadastro quando o físico divergir do sistema
- [ ] Separar avariados encontrados (caixa molhada, lacre rompido, frasco vazando)
- [ ] Conferir se produtos abertos para uso interno têm a data de abertura anotada
- [ ] Entregar ao farmacêutico a lista de ações: troca, devolução, transferência, promoção ou descarte
- [ ] Assinar e datar a planilha e arquivar com os registros do mês

Etiquetagem

- [ ] Todo produto exposto tem preço visível, inclusive durante reposição e limpeza
- [ ] Etiqueta com nome comercial e DCB (genérico só pela DCB), concentração, forma e quantidade
- [ ] Preço à vista em reais, em caracteres legíveis e com contraste com o fundo
- [ ] Etiqueta no trilho logo abaixo do produto certo, com a face voltada para o cliente
- [ ] Uma só etiqueta por item: retirar a antiga antes de colocar a nova
- [ ] Preço da etiqueta igual ao do sistema
- [ ] Preço do sistema não ultrapassa o PMC do estado
- [ ] Lista de preços da CMED atualizada à disposição do consumidor

- ◯ Promoção mostra o preço integral junto do preço promocional
- ◯ Lista dos medicamentos anunciados em desconto em local visível
- ◯ Sem slogan, figura, selo ou indicação de uso na etiqueta de medicamento
- ◯ Etiqueta colada na caixa não cobre lote, validade, registro ou advertências
- ◯ Leitores de código de barras funcionando e sinalizados, a no máximo 15 m de qualquer produto
- ◯ Lista atualizada de genéricos em local de fácil visualização

SOS Farmácia Comercial

Achei um produto vencido na prateleira

Produto com validade expirada encontrado na área de venda ou no estoque

Retirar imediatamente da prateleira, junto com todas as unidades do mesmo lote

DECISÃO

É medicamento sujeito a controle especial?

SIM
Manter no armário com chave, separado e identificado como vencido, para baixa conforme a Portaria 344/1998 e a vigilância local

NÃO
Levar para a área segregada, fora da área de dispensação

Identificar: VENCIDO, NÃO COMERCIALIZAR, com data e destino previsto

Bloquear o lote no sistema para que não apareça como disponível

DECISÃO

Alguma unidade desse lote foi vendida depois do vencimento?

SIM
Avisar o farmacêutico, que avalia contato com o cliente, quando identificável, e registra a ocorrência

NÃO
Seguir para o registro

Registrar produto, lote, validade, quantidade, local, data e responsável

DECISÃO

Há acordo de troca ou devolução com o fornecedor para esse item?

SIM
Separar para devolução, com nota e comprovante

NÃO
Encaminhar ao descarte pelo PGRSS, com empresa licenciada

ATENÇÃO

Nunca remarcar a data nem colocar no coletor de medicamentos dos clientes

Verificar por que escapou da inspeção mensal e corrigir a reposição ou o cronograma

Comprovante de devolução ou de destinação arquivado

SOS Farmácia Comercial

Organização e reposição de prateleiras

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Organização e reposição de prateleiras**	Código: **POP-EXP-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Manter os produtos expostos e armazenados em local permitido, em ordem padronizada, dentro da validade, com preço visível, para que qualquer funcionário encontre o item certo e o cliente receba produto adequado.

Abrangência

Área de autosserviço, prateleiras e gaveteiros da área restrita e estoque da loja.

Responsáveis

- Auxiliar ou repositor: reposição, puxar frente, etiquetas
- Atendentes: devolver ao lugar os produtos deixados fora do endereço
- Farmacêutico: aprovar critério de organização, planograma e exceções (nomes parecidos, alta vigilância)

Materiais

- Planograma ou mapa de endereços atualizado
- Etiquetas de endereço e de preço
- Trilhos de preço
- Estrados para caixas de estoque
- Etiquetas de validade próxima
- Caixa identificada para segregação

Procedimento

1. Conferir no planograma o endereço de cada produto antes de repor.
2. Manter medicamentos sob prescrição na área restrita (RDC 44/2009, art. 40, §1º); só MIP vão para o autosserviço (art. 40, §2º).
3. No autosserviço, agrupar MIP do mesmo princípio ativo, identificados pela DCB, separados de cosméticos e alimentos, com o cartaz do art. 41 visível.
4. Organizar cada bloco por categoria e, dentro dela, em ordem alfabética pelo critério do Manual (DCB ou nome comercial).
5. Seguir o sentido de leitura: da esquerda para a direita e de cima para baixo; concentração crescente da esquerda para a direita.
6. Posicionar pesados e volumosos embaixo e itens de maior giro entre o nível dos olhos e o das mãos.

7. Manter os produtos afastados do piso, da parede e do teto, sem sol direto, calor ou umidade (arts. 35, §2º, e 36).
8. Repor por trás e pela direita: puxar as unidades antigas para a frente e para a esquerda e colocar as novas no fundo (PVPS).
9. Conferir a validade da primeira e da última unidade da fileira a cada reposição.
10. Retirar da exposição qualquer embalagem avariada ou violada e encaminhar à segregação.
11. Conferir se cada posição tem etiqueta de preço correta, voltada para o cliente, sem etiqueta duplicada.
12. Puxar frente na abertura e ao longo do dia; anotar faltas para compra.
13. Não deixar caixas de estoque no chão nem nos corredores da área de vendas.
14. Atualizar planograma e etiquetas de endereço sempre que um item entrar ou sair do mix.

Cuidados

- Controlados ficam sempre no armário com chave (Portaria 344/1998, art. 67).
- Separar fisicamente nomes e embalagens parecidos e sinalizar medicamentos de alta vigilância.
- Reposição com a loja aberta não pode deixar produto sem preço visível (Decreto 5.903/2006, art. 4º, parágrafo único).
- Produto fora da lista permitida não é exposto sem posição da vigilância local (IN 9/2009, art. 13).

Registros

- Planograma datado e aprovado
- Lista de faltas e rupturas do dia
- Registro de produtos retirados por avaria

Referências

- RDC 44/2009, arts. 35, 36, 37, 40, 41 e 86, III
- RDC 41/2012
- Instrução Normativa 9/2009
- Portaria SVS/MS 344/1998, art. 67
- Decreto 5.903/2006, arts. 4º e 5º
- Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Controle de validade

Logotipo e nome do estabelecimento	Procedimento operacional padrão **Controle de validade**	Código: **POP-VAL-01** Versão: ____ Emissão: ___/___/____ Revisão: ___/___/____

Objetivo

Garantir que nenhum produto vencido seja exposto ou dispensado, agir com antecedência sobre os próximos do vencimento e dar destino rastreável aos retirados.

Abrangência

Todos os produtos com validade: área de autosserviço, área restrita, estoque, refrigerador e armário de controlados.

Responsáveis

- Auxiliar designado: inspeção mensal, etiquetas e registro
- Comprador ou gerente: troca, devolução e transferência entre lojas
- Farmacêutico: aprovar a política, decidir destino, baixa de controlados e descarte

Materiais

- Relatório de validades do sistema
- Planilha de inspeção mensal
- Etiquetas coloridas por mês com legenda
- Caixas identificadas para segregação
- Formulário de baixa por vencimento ou avaria

Procedimento

1. Conferir lote e validade de cada produto no recebimento e cadastrar no sistema.
2. Aplicar o PVPS na guarda e na reposição: validade mais curta na frente e à esquerda.
3. No início de cada mês, emitir o relatório de validades dos próximos 6 meses por setor.
4. Conferir fisicamente todos os setores no mês, seguindo o cronograma, frente e fundo de cada fileira.
5. Marcar com a etiqueta da cor do mês os itens que vencem nos próximos meses, conforme a política do Manual (RDC 44/2009, art. 38, §4º).
6. Com 6 meses: suspender nova compra do item se o estoque for alto; com 3 a 4 meses: negociar troca ou devolução conforme o contrato ou transferir para outra loja.
7. Com 1 a 2 meses: priorizar a saída; promoção só dentro das regras de preço e propaganda (RDC 96/2008, arts. 10, 11 e 18).
8. Na dispensação de produto com validade próxima, avisar o cliente (art. 51, §1º) e não dispensar se o tratamento não puder terminar antes do vencimento (art. 51, §2º).

9. Retirar da venda na data definida no POP os produtos que vencem no mês; segregar fora da área de dispensação, identificados (art. 38).
10. Bloquear no sistema e registrar produto, lote, validade, quantidade, motivo e destino.
11. Encaminhar para devolução ao fornecedor, para o recolhimento em curso ou para descarte pelo PGRSS (RDC 222/2018).
12. Analisar mensalmente as perdas por vencimento e ajustar compra e reposição.

Cuidados

- Nunca alterar, cobrir ou remarcar a data de validade (Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII).
- Vencido do estoque não vai para o coletor de medicamentos domiciliares (Decreto 10.388/2020, art. 5º, III).
- Controlados vencidos permanecem no armário com chave, separados, até a baixa conforme a Portaria 344/1998 e a vigilância local.
- Produto aberto para uso interno recebe a data de abertura; vale o prazo de "Após aberto, válido por" do rótulo (RDC 768/2022, art. 54).

Registros

- Planilha de inspeção mensal assinada
- Formulário de baixa por vencimento ou avaria
- Comprovantes de devolução, recolhimento ou destinação

Referências

- RDC 44/2009, arts. 34, 38, 51 e 86, V e VI
- Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII
- Lei 8.078/1990, art. 18, §6º
- RDC 222/2018
- Decreto 10.388/2020
- RDC 768/2022, arts. 54 e 83
- RDC 80/2006

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):

Preço e etiqueta: o que a norma exige

Tema	Regra	Fonte
Autosserviço	Preço na embalagem, código referencial ou código de barras com preço, características e código junto ao produto	Lei 10.962/2004, art. 2º, II, e parágrafo único

Tema	Regra	Fonte
Leitor ótico	Obrigatório se apreçar por código de barras; sinalizado; máximo de 15 m de qualquer produto	Lei 10.962/2004, art. 4º; Decreto 5.903/2006, art. 7º
Preço divergente	Consumidor paga o menor	Lei 10.962/2004, art. 5º
Visibilidade	Preço sempre visível com a loja aberta, inclusive em montagem e limpeza	Decreto 5.903/2006, art. 4º
Infrações de apresentação	Letra irregular, sem contraste, rasurada, só parcelas, preços distintos para o mesmo item	Decreto 5.903/2006, art. 9º
Teto de preço	Não ofertar nem vender acima do PMC publicado pela CMED	Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º; CM-CMED 2/2018, art. 5º
Lista de preços	Lista atualizada à disposição de consumidores e órgãos de defesa do consumidor	Resolução CM-CMED 4/2026, art. 6º
Promoção	Informar também o preço integral; lista visível dos anunciados	RDC 96/2008, art. 11, §§ 4º e 5º
Conteúdo da lista de preço	Nome comercial, DCB, apresentação, registro, detentor e preço, sem argumento publicitário	RDC 96/2008, arts. 18 e 47
Fidelidade	Medicamento não é objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio	RDC 96/2008, art. 10

Cartões de revisão: prateleiras, validade e etiquetas

Pergunta	Resposta
Onde devem ficar os medicamentos, como regra?	Em área de circulação restrita aos funcionários, fora do alcance do cliente (RDC 44/2009, art. 40, §1º).
Qual norma permitiu MIP ao alcance do usuário?	A RDC 41/2012, que deu nova redação ao art. 40, §2º, e ao art. 41 da RDC 44/2009.
Três condições para MIP no autosserviço	Mesmo princípio ativo junto e identificado pela DCB; separado dos demais produtos; cartaz "EVITE A AUTOMEDICAÇÃO" visível.
Onde ficam os controlados?	Sob chave, em local exclusivo, sob guarda do farmacêutico (Portaria 344/1998, art. 67; RDC 44/2009, art. 37).
Que norma lista os produtos permitidos em farmácias e drogarias?	A Instrução Normativa 9/2009, ligada ao art. 29 da RDC 44/2009.
Diagnóstico in vitro na drogaria	Só produtos para autoteste, de uso por leigos (IN 9/2009, art. 3º, §3º).

Pergunta	Resposta
Alimentos para diabéticos	Em local exclusivo, separados de outros produtos e alimentos (IN 9/2009, art. 6º, parágrafo único).
Sentido de leitura da gôndola	Da esquerda para a direita e de cima para baixo, como página de livro (boa prática).
O que a RDC 44/2009 exige sobre genéricos?	Lista atualizada dos genéricos em local de fácil visualização (art. 42, §1º). Prateleira separada não é exigência federal.
Distância do piso, parede e teto	Afastados para limpeza e inspeção (RDC 44/2009, art. 36); a distância em centímetros é definida no POP.
PVPS x PEPS	PVPS sai pela validade; PEPS, pela data de chegada. Para medicamento vale PVPS, porque lote novo pode vencer antes.
Onde fica a unidade que vence primeiro?	Na frente e à esquerda. A reposição entra por trás e pela direita.
Validade próxima na dispensação	Avisar o cliente (art. 51, §1º) e não dispensar se o tratamento não puder ser concluído na validade (art. 51, §2º).
Remarcar a data de um vencido	Infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XVIII) e venda de produto impróprio é crime (Lei 8.137/1990, art. 7º, IX).
Vencido do estoque vai para o coletor do cliente?	Não. Segue o PGRSS; o Decreto 10.388/2020 não vale para serviços de saúde (art. 5º, III).
Preço da etiqueta diferente do caixa	O consumidor paga o menor (Lei 10.962/2004, art. 5º).
Distância máxima até o leitor de preço	15 metros entre qualquer produto e o leitor mais próximo (Decreto 5.903/2006, art. 7º, §2º).
O que é PMC?	Preço Máximo ao Consumidor: teto de preço do varejo, publicado pela CMED, que varia com o ICMS do estado.
Promoção de medicamento: o que mostrar?	O preço promocional e também o preço integral (RDC 96/2008, art. 11, §4º).
Curva ABC	Classifica itens pela participação na venda: A poucos itens e muita venda; C muitos itens e pouca venda, maior risco de vencer.

Questões: prateleiras, validade e etiquetagem

1. Auxiliar recém-contratado quer expor, na gôndola de livre acesso, caixas de omeprazol 20 mg de venda sob prescrição ao lado do omeprazol isento de prescrição, "porque é o mesmo remédio". Qual conduta está de acordo com a RDC 44/2009?

A Pode expor, desde que os dois fiquem agrupados pelo princípio ativo e identificados pela DCB

B Só o MIP vai ao autosserviço; o sob prescrição fica na área restrita

C Pode expor se houver o cartaz de alerta sobre automedicação na gôndola

D Só pode expor se o farmacêutico estiver presente na área de vendas

E Nenhuma das duas pode ficar no autosserviço, por serem do mesmo ativo

2. Na conferência mensal, a funcionária encontra cinco caixas de um anti-hipertensivo vencidas no mês anterior, no fundo da prateleira. Qual a primeira providência?

A Vender com desconto ainda nesta semana, avisando o cliente da validade

B Colar etiqueta com nova validade até a devolução ao fornecedor

C Colocar as caixas no coletor de medicamentos domiciliares da loja

D Retirar, segregar fora da dispensação, identificar e bloquear

E Deixar na prateleira até o farmacêutico decidir o destino

3. Uma farmácia recebe paracetamol 750 mg com validade 01/2027 e ainda tem em estoque unidades com validade 06/2027, recebidas no mês anterior. Pelo critério adequado a medicamentos, qual sai primeiro?

A As unidades com validade 01/2027, que vencem antes

B As unidades com validade 06/2027, que chegaram antes

C Tanto faz, porque as duas estão dentro da validade

D As que estiverem na frente da prateleira no momento

E As de maior preço de custo

4. Cliente compra uma caixa de anticoncepcional oral (21 comprimidos) para começar hoje. A única caixa disponível vence em 12 dias. Segundo a RDC 44/2009, o farmacêutico deve:

A dispensar normalmente, porque o produto está dentro da validade

B dispensar com desconto e registrar a venda como promoção

C dispensar e orientar a guardar na geladeira para durar mais

D dispensar metade da cartela e encomendar o restante

E não dispensar para esse uso, pois o ciclo não termina na validade

5. Sobre a organização de genéricos, assinale a afirmativa correta segundo as normas federais consultadas.

A. A RDC 44/2009 exige gôndola exclusiva para genéricos, identificada com placa própria

B. Genéricos devem ficar sempre em ordem alfabética pelo nome do fabricante do produto

C. A RDC 44/2009 exige lista atualizada de genéricos visível; separar é opção da loja

D. Genéricos não podem ficar ao lado do medicamento de referência da mesma substância

E. Genéricos só podem ser expostos na área de autosserviço da loja

6. A etiqueta da gôndola informa R$ 32,50 para um MIP e o leitor de preço do caixa mostra R$ 35,90. O cliente reclama. Pela Lei 10.962/2004, o cliente paga:

A. R$ 35,90, porque vale o preço do sistema

B. R$ 32,50, o menor dos preços informados

C. o PMC do produto

D. a média entre os dois preços

E. R$ 35,90, se a etiqueta estiver com data antiga

7. Uma drogaria cola na gôndola de MIP a etiqueta: "O MAIS VENDIDO PARA DOR! De R$ 12,00 por R$ 9,90". Qual o problema principal?

A. Falta o preço integral

B. O preço promocional não pode ser menor que o PMC

C. Etiqueta de MIP não pode mostrar preço

D. Desconto em MIP só é permitido com receita

E. Usa argumento publicitário em informação de preço

8. Sobre a lista de preços da CMED, é correto afirmar:

A. A loja mantém a lista atualizada à disposição e não cobra acima dela

B. A lista só precisa ser apresentada à vigilância sanitária durante a inspeção

C. O PMC é o mesmo em todos os estados, porque é fixado pela CMED

D. Vender abaixo do PMC é infração, porque desequilibra a concorrência

E. A loja pode ofertar acima do PMC desde que não efetive a venda

9. A loja usa código de barras para o preço no autosserviço. Qual exigência do Decreto 5.903/2006 se aplica aos leitores óticos?

A Um leitor por caixa registradora, sem nenhuma outra exigência

B Leitores apenas na entrada da loja, perto da porta

C Na área de vendas, sinalizados, a até 15 m de qualquer produto

D Leitores dispensados se houver lista de preços no balcão

E Um leitor para cada 50 metros quadrados de área de vendas

10. Ao repor dipirona 500 mg, o repositor encontra três validades diferentes no estoque. Pela boa prática de reposição, ele deve:

A colocar as caixas novas na frente para renovar a exposição

B puxar as antigas para frente e esquerda e pôr as novas no fundo

C misturar as validades, já que todas estão dentro do prazo

D expor só o lote de validade mais longa e guardar o resto

E deixar a validade mais curta no estoque para vender por último

11. Uma drogaria quer vender chinelos e refrigerantes no caixa. Considerando a IN 9/2009, qual a orientação mais adequada do farmacêutico ao proprietário?

A Pode vender livremente, porque a RDC 44/2009 não trata do assunto

B Pode vender, desde que os itens fiquem longe dos medicamentos

C Só pode vender se tiver também alvará de supermercado

D Consultar a vigilância local, pois a IN 9/2009 não inclui esses itens

E Pode vender se pedir autorização ao Conselho Regional de Farmácia

12. Um lote de xarope é objeto de recolhimento comunicado pelo detentor do registro. Na farmácia, a conduta correta é:

A bloquear a venda, segregar como recolhido e seguir o comunicado

B vender o estoque restante antes da data-limite do comunicado

C transferir o lote para outra filial com mais giro

D descartar imediatamente no coletor de medicamentos dos clientes

E manter na prateleira com uma etiqueta de alerta ao cliente

Gabarito comentado

1. **B**. O art. 40, §1º, da RDC 44/2009 manda manter medicamentos em área restrita aos funcionários; a exceção do §2º (redação da RDC 41/2012) vale só para MIP. O agrupamento pela DCB e o cartaz (art. 41) são condições para o MIP, não autorizam medicamento sob prescrição. A presença do farmacêutico não muda a regra. O MIP de omeprazol pode ficar no autosserviço.
2. **D**. Vencidos são segregados em ambiente diverso da área de dispensação e identificados (RDC 44/2009, art. 38). Vender é expor produto impróprio (CDC, art. 18, §6º, I; Lei 8.137/1990, art. 7º, IX). Apor nova data é infração do art. 10, XVIII, da Lei 6.437/1977. O coletor domiciliar não recebe resíduo de serviço de saúde (Decreto 10.388/2020, art. 5º, III). Mantê-lo na prateleira continua sendo exposição à venda.
3. **A**. Pelo PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai), sai antes o lote de validade mais curta, mesmo que tenha chegado depois. O PEPS (data de chegada) falharia aqui. "O que está na frente" só funciona se a reposição respeitou o PVPS, e custo não é critério de saída.
4. **E**. O art. 51, §2º, veda dispensar medicamento cuja posologia não possa ser concluída no prazo de validade. Estar válido no dia não basta. Desconto não muda a regra; refrigerar não estende validade; fracionar a cartela sem embalagem fracionável e sem os requisitos da RDC 80/2006 não é permitido.
5. **C**. O art. 42, §1º, da RDC 44/2009 exige a lista atualizada. Não há, nas normas federais consultadas, obrigação de prateleira exclusiva; leis estaduais ou municipais podem exigir cartaz ou lista. Organizar pela DCB, com referência e genéricos lado a lado, é uma opção válida. Genérico sob prescrição fica na área restrita.
6. **B**. Havendo divergência entre os sistemas de informação de preço do estabelecimento, o consumidor paga o menor (Lei 10.962/2004, art. 5º). O PMC é teto, não preço a cobrar. A loja corrige depois a etiqueta ou o cadastro; preços distintos para o mesmo item também são infração do Decreto 5.903/2006 (art. 9º, VII).
7. **E**. A etiqueta já mostra preço integral e promocional (RDC 96/2008, art. 11, §4º). O problema é a frase de efeito: em informação de preço não cabem argumentos publicitários (arts. 19 e 47), e expressões como "o mais vendido para dor" estimulam o uso. Preço abaixo do PMC é livre; MIP pode ter preço exposto e desconto não depende de receita.
8. **A**. A Resolução CM-CMED 4/2026 (art. 6º) exige a lista atualizada à disposição de consumidores e órgãos de defesa do consumidor, sem preços superiores aos publicados. O PMC varia com o ICMS do estado (parágrafo único). Preço abaixo do teto é permitido. A Resolução CM-CMED 2/2018 (art. 5º) classifica como infração tanto ofertar quanto vender acima do limite.
9. **C**. O art. 7º do Decreto 5.903/2006 exige leitores em perfeito funcionamento na área de vendas (caput), indicados por cartazes suspensos (§1º), com distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e o leitor mais próximo (§2º), e croqui para a fiscalização (§3º). A lista de preços só é admitida quando for impossível usar as outras modalidades (art. 8º).
10. **B**. O PVPS manda a validade mais curta sair primeiro: ela fica na frente e à esquerda, e a reposição entra por trás e pela direita. Colocar o novo na frente é a causa mais comum de vencidos escondidos no fundo. Misturar validades sem ordem e guardar o lote curto para depois aumentam a perda.
11. **D**. A IN 9/2009 lista os produtos permitidos e veda comercializar ou expor os não permitidos (art. 13, parágrafo único); chinelos e refrigerantes não estão na lista. A RDC 44/2009 remete a essa relação (art. 29). Há leis estaduais e decisões judiciais em casos concretos admitindo conveniências, por isso a vigilância local deve ser consultada antes. O CRF fiscaliza o exercício profissional e não autoriza o mix de produtos; separar dos medicamentos não resolve a questão de o produto ser ou não permitido.
12. **A**. Produtos recolhidos seguem a regulamentação específica e as instruções do recolhimento (RDC 44/2009, art. 38, §3º); são segregados fora da área de dispensação e identificados (caput). Vender, transferir ou manter exposto mantém o risco. Descarte no coletor domiciliar é vedado para o serviço de saúde (Decreto 10.388/2020, art. 5º, III) e impediria a devolução.

Módulo 9

Registro no Ministério da Saúde (código MS) e DCB

Como um produto se torna regular na Anvisa (registro, notificação ou isenção), a leitura do número de registro de 13 dígitos, a consulta no portal da Anvisa, os outros códigos da embalagem e a Denominação Comum Brasileira, com base na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013, nas RDC 912/2024, 768/2022, 576/2021 e 955/2024 e na Lei 9.787/1999.

- Registro, notificação e isenção
- Validade, renovação e situação do registro
- O número de registro do medicamento
- Cosméticos, saneantes, alimentos e dispositivos médicos
- Consulta de registro no portal da Anvisa
- Outros códigos da embalagem e do cadastro
- Denominação Comum Brasileira (DCB)

Registro, notificação e isenção

Todo medicamento vendido no Brasil precisa estar **regularizado na Anvisa**. Regularizar é obter da agência a autorização para fabricar, importar e vender aquele produto. A regra vem da Lei 6.360/1976, que trata da vigilância sanitária de medicamentos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e do Decreto 8.077/2013, que a regulamenta. A lei fala em registro "no Ministério da Saúde" porque é anterior à Anvisa (criada pela Lei 9.782/1999); por isso o número ainda é chamado de "código MS" ou "registro MS".

O QUE DIZ A NORMA

"Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde." (Lei 6.360/1976, art. 12, caput)

O Decreto 8.077/2013 repete a ideia (art. 7º: os produtos "somente poderão ser objeto das atividades a eles relacionadas se registrados junto a Anvisa") e acrescenta dois pontos que interessam ao balcão: o produto só pode ser oferecido ao consumo na **embalagem original**, salvo norma específica (art. 11), e a responsabilidade pela qualidade do produto até o consumidor é solidária entre todos os agentes da cadeia, o que inclui a farmácia (art. 15, § 2º).

Três caminhos de regularização

Caminho	Como funciona	O que aparece na caixa
Registro	A empresa protocola um dossiê; a Anvisa analisa qualidade, segurança e eficácia e publica a decisão no Diário Oficial da União (DOU)	"Registro:" seguido do número de 13 dígitos (RDC 768/2022, art. 5º, VII)
Notificação	Comunicação eletrônica à Anvisa de produto de baixo risco já descrito em lista oficial; não há análise prévia do dossiê	"MEDICAMENTO NOTIFICADO" (ou variante) no lugar do número de registro (RDC 768/2022, art. 5º, § 4º)
Isenção	Casos previstos em lei, como produtos de fórmula inscrita na Farmacopeia ou em formulário oficial e medicamento novo de uso exclusivamente experimental	Sem número de registro; segue sob fiscalização sanitária

Registro

O registro é o ato pelo qual a Anvisa reconhece que aquele medicamento, naquela fórmula, fabricado por aquela empresa, pode ser vendido. Ele vale para a **fórmula aprovada**: qualquer mudança de composição depende de autorização prévia e é averbada no registro (Lei 6.360/1976, art. 13). Os atos de registro só produzem efeito depois de publicados no DOU (RDC 250/2004, art. 2º).

O registro tem um **detentor**: a empresa titular, que responde pelo produto perante a Anvisa. O detentor pode fabricar ou terceirizar a fabricação; na caixa isso aparece como "Registrado por:", "Registrado e produzido por:" ou "Produzido por:" (RDC 768/2022, art. 5º, III).

Notificação simplificada

Para medicamentos de baixo risco, a Anvisa criou a **notificação**. A RDC 576/2021 define notificação como a "comunicação à Anvisa, realizada exclusivamente por meio eletrônico, referente à fabricação, importação e comercialização dos medicamentos isentos de registro presentes na lista de medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação" (art. 3º, V). A lista é a **LMN**, publicada pela IN 106/2021 e atualizada pela IN 430/2026 (DOU de 26/03/2026). Depois de pagar a taxa e ativar a notificação, a empresa gera a Declaração de Notificação e o produto fica autorizado a ser vendido (RDC 576/2021, art. 6º).

Os medicamentos notificados de baixo risco são de **venda isenta de prescrição** (art. 3º, IV). Exemplos de itens que aparecem como notificados nos dados abertos da Anvisa: solução nasal de cloreto de sódio 0,9%, óleo mineral, água oxigenada 3%, iodopovidona 10% em solução aquosa, simeticona 75 mg/mL em emulsão oral, álcool etílico 70%. A embalagem não traz número de registro: traz a frase "MEDICAMENTO NOTIFICADO" (RDC 576/2021, art. 18, § 5º, com redação da RDC 981/2025).

A notificação não se limita à LMN. Medicamentos dinamizados e medicamentos tradicionais fitoterápicos também podem ser notificados, com as frases "MEDICAMENTO DINAMIZADO NOTIFICADO" e "MEDICAMENTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO NOTIFICADO" (RDC 768/2022, art. 5º, § 4º, com redação da RDC 1.004/2025). Nos dados abertos da Anvisa, além de baixo risco, dinamizados e fitoterápicos, há gases medicinais e radiofármacos sob notificação.

PONTO-CHAVE

Notificado também é regular. A falta de número de registro em um soro nasal ou em um óleo mineral não indica irregularidade quando a caixa traz "MEDICAMENTO NOTIFICADO" e o produto consta na consulta de notificados da Anvisa.

Isenção de registro

A Lei 6.360/1976 lista os isentos: produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou em formulários aceitos; preparados homeopáticos de simples associação de tinturas ou incorporação a sólidos; solutos concentrados oficinais; e produtos equiparados aos oficinais aprovados pelo Ministério da Saúde (art. 23). Também são isentos os medicamentos novos destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, por até 3 anos (art. 24). Isenção de registro não significa ausência de controle: a fiscalização alcança "inclusive os isentos de registro" (Decreto 8.077/2013, art. 15).

O medicamento manipulado na farmácia, a partir de prescrição, também não tem número de registro: a regularidade dele está na licença da farmácia e no cumprimento das boas práticas de manipulação, assunto de outro módulo.

NO BALCÃO

Diante de um produto sem número de registro, pergunte primeiro qual é a categoria: medicamento notificado (frase na caixa), cosmético ou alimento (regras próprias, ver tópico seguinte) ou manipulado (rótulo da farmácia). Só depois de descartar essas hipóteses trate o item como suspeito e confira no portal da Anvisa.

CASO

Repositor estranha um frasco de solução nasal de cloreto de sódio 0,9% sem "Registro:" na caixa e separa o lote. A farmacêutica lê a lateral: "MEDICAMENTO NOTIFICADO", nome e CNPJ da empresa notificante, lote e validade. Ela confere o produto na consulta de medicamentos notificados e libera o lote para venda.

Validade, renovação e situação do registro

O registro tem prazo. A redação original da Lei 6.360/1976 fixava 5 anos; a Lei 13.097/2015 deu à Anvisa o poder de definir esse prazo por ato próprio, até o limite de 10 anos, conforme a natureza e o risco do produto (art. 12, § 1º). O Decreto 8.077/2013 ainda fala em 5 anos (art. 8º, § 1º), mas a norma que vale para medicamentos hoje é a **RDC 912/2024**, que fixou o prazo de **10 anos** para o registro de medicamentos (art. 2º) e prorrogou para 10 anos os registros concedidos antes dela (art. 9º).

Situação	Prazo de validade	Base
Medicamento registrado (regra geral)	10 anos	RDC 912/2024, art. 2º
Registro concedido com Termo de Compromisso	3 anos no início; 5 anos após a 1ª renovação; 10 anos após a 2ª	RDC 912/2024, art. 3º
Medicamento notificado	Sem renovação; declaração de interesse na continuidade a cada 10 anos	RDC 912/2024, arts. 4º e 5º
Dispositivo médico registrado (classes III e IV)	10 anos	RDC 751/2022, art. 11

Renovação (revalidação)

A empresa deve pedir a renovação com antecedência **máxima de 12 meses e mínima de 6 meses** do vencimento. Se o pedido foi feito no prazo e a Anvisa não decidiu até o vencimento, o registro é considerado **automaticamente revalidado** (RDC 250/2004, art. 1º, com redação da RDC 212/2018; Decreto 8.077/2013, art. 8º, §§ 2º e 3º). A revalidação automática não encerra a análise: se depois o pedido for indeferido, o registro é cancelado (Decreto 8.077/2013, art. 8º, § 6º).

Para renovar, a empresa precisa comprovar que vendeu o medicamento durante pelo menos os **dois terços finais** do período de validade que expirou (Lei 6.360/1976, art. 12, § 8º, II, com redação da Lei

13.411/2016; RDC 912/2024, art. 6º, III). Medicamento registrado e não comercializado tende a perder o registro.

As situações que o farmacêutico encontra

Situação	O que significa	Efeito para a farmácia
Válido (ativo)	Dentro do prazo, ou em revalidação automática	Pode comprar e vender
Vencido	Prazo terminou sem renovação deferida ou automática	Não comprar lote novo; conferir com o detentor e com a VISA o destino do estoque
Caduco	A empresa não pediu a renovação no prazo; a Anvisa declara a caducidade	Mesmo tratamento do vencido
Cancelado	Por pedido da empresa, por indeferimento da renovação, por mudança não autorizada na fórmula ou por infração	Ler o motivo e a data na consulta; seguir a orientação da Anvisa e da VISA

A caducidade está prevista na RDC 250/2004 (art. 1º, § 1º) e na Lei 6.360/1976 (art. 12, § 7º). O cancelamento por modificação não autorizada de fórmula, dosagem, fabricação ou indicações está no art. 19 da Lei 6.360/1976. Para os notificados, a falta da declaração de interesse na continuidade resulta em cancelamento (RDC 912/2024, art. 5º, § 2º).

No portal de consulta, a situação aparece no registro do produto e em cada apresentação. Uma apresentação pode estar inativa (por exemplo, a caixa com 60 comprimidos foi descontinuada) enquanto o produto segue válido com outras apresentações.

ATENÇÃO

Lote fabricado com registro válido e vendido depois do vencimento do registro é situação que exige consulta à vigilância sanitária local e ao detentor, porque o tratamento depende do motivo (vencimento simples, cancelamento a pedido, cancelamento por risco). Quando a Anvisa publica suspensão ou recolhimento de lote, a ordem é segregar o lote e seguir a resolução publicada, assunto do módulo de recolhimento.

Produto sem registro: infração e crime

Vender produto sem registro, licença ou autorização, quando exigidos, é **infração sanitária**. A Lei 6.437/1977 (art. 10, IV) inclui "comprar, vender, ceder ou usar" medicamentos, cosméticos, saneantes e correlatos "sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente", com penas de advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro e/ou multa.

A mesma conduta pode ser **crime**. O Código Penal, art. 273, § 1º-B, I, sujeita às penas do artigo quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou entrega a consumo produto terapêutico "sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente". O § 1º-B também alcança

produto em desacordo com a fórmula registrada (II), de procedência ignorada (V) e adquirido de estabelecimento sem licença sanitária (VI). A pena prevista no caput é de reclusão de 10 a 15 anos e multa (redação da Lei 9.677/1998). Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (RE 979.962, Tema 1003) considerou essa pena desproporcional para a importação de medicamento sem registro e mandou aplicar, nessa hipótese, a pena da redação original do artigo (reclusão de 1 a 3 anos e multa).

NO BALCÃO

Cliente pede "aquele remédio para emagrecer que vem do Paraguai". Responda que a farmácia não pode vender nem guardar produto sem registro, explique que não há garantia do conteúdo e oriente procurar o médico. Se alguém oferecer esse tipo de produto à loja, recuse e registre o contato; a denúncia vai para a vigilância sanitária.

CASO

Distribuidor oferece um suplemento de ferro "registrado no MS". O comprador da loja encontra o número na consulta, mas com situação "cancelado" há dois anos. A farmacêutica não autoriza a compra e pede ao fornecedor o documento de regularização vigente. Sem esse documento, o item não entra no cadastro.

O número de registro do medicamento

O número de registro de um medicamento tem **13 dígitos** e identifica uma **apresentação**: aquela concentração, naquela forma farmacêutica, naquela embalagem, daquele detentor. Os **9 primeiros dígitos** identificam o **produto** (o registro do medicamento como um todo). Por isso o mesmo medicamento tem um número de 9 dígitos e vários números de 13, um por apresentação.

Dígito a dígito

Exemplo **fictício**, escrito como costuma aparecer nos sistemas: **1.9990.0045.002-7**.

Posição	Dígitos no exemplo	O que indica
1º	1	Tipo de produto: medicamento. Todo registro de medicamento começa com 1
2º ao 5º	9990	Código da empresa detentora do registro
6º ao 9º	0045	Número do produto dentro daquela empresa
10º ao 12º	002	Apresentação (cada concentração e tamanho de embalagem tem a sua)
13º	7	Dígito verificador, que acusa erro de digitação

Essa divisão se confirma nos dados abertos da Anvisa. Na base de medicamentos, os registros de produto têm 9 dígitos e começam com 1. Na lista de preços da CMED, todas as apresentações trazem um registro de 13 dígitos cujos 9 primeiros coincidem com o registro do produto; os dígitos 10 a 12 mudam de uma

apresentação para outra do mesmo produto, e os dígitos 2 a 5 se repetem para a mesma empresa. O cálculo do dígito verificador é feito pelo sistema da Anvisa e não precisa ser feito à mão.

PONTO-CHAVE

9 dígitos = o produto. 13 dígitos = a apresentação. Clonazepam 0,5 mg com 30 comprimidos e clonazepam 2 mg com 30 comprimidos do mesmo detentor e do mesmo registro têm os mesmos 9 primeiros dígitos e números completos diferentes.

Como o número aparece na embalagem

Onde	Exigência	Base
Embalagem secundária (caixa)	"Registro:" + número conforme publicado no DOU, com os 13 dígitos	RDC 768/2022, art. 5º, VII
Embalagem primária vendida sem caixa	"Registro:" + no mínimo os 9 dígitos	RDC 768/2022, art. 31, I
Embalagem primária fracionável	"Registro" + no mínimo os 9 primeiros dígitos	RDC 768/2022, art. 50 (redação da RDC 808/2023)
Amostra grátis	Os 13 dígitos da apresentação comercial de origem	RDC 768/2022, art. 47
Medicamento notificado	"MEDICAMENTO NOTIFICADO" (ou variante) ou código gerado na notificação, no lugar do registro	RDC 768/2022, art. 5º, § 4º

Caixas antigas e muitos sistemas ainda usam as formas "Reg. MS", "MS nº" ou só "MS" antes do número, herança das normas de rotulagem anteriores. A RDC 768/2022 padronizou a expressão "Registro:". O número pode vir com pontos e hífen (1.9990.0045.002-7) ou corrido (1999000450027); os dígitos são os mesmos.

Onde o farmacêutico usa o número

- **SNGPC**: cada entrada, saída e perda de medicamento controlado ou antimicrobiano industrializado é escriturada pelo número de registro da apresentação. Número errado gera recusa do arquivo ou saldo lançado no produto errado (módulos do SNGPC e do software de gestão).
- **Cadastro do produto no software**: o campo "Registro MS" precisa ter os 13 dígitos da apresentação que está na prateleira, e não os 9 do produto.
- **Nota fiscal eletrônica**: nas notas de medicamentos há campo para o código do produto na Anvisa, com 13 dígitos (ou a indicação de isento, para produto sem registro). A conferência da nota no recebimento inclui esse número.
- **Lista de preços da CMED**: o registro de 13 dígitos permite achar o preço máximo daquela apresentação.
- **Recolhimentos e alertas**: resoluções da Anvisa identificam o produto pelo nome, pelo registro e pelo lote.

ATENÇÃO

Erro comum de cadastro: copiar para todas as apresentações o número de 9 dígitos ou o número da primeira apresentação. O estoque do SNGPC passa a misturar 0,5 mg e 2 mg, e o inventário não fecha.

NO BALCÃO

Ao receber um produto novo, leia o "Registro:" da caixa e compare com o número que o fornecedor mandou na nota e com o que está no cadastro. Os três precisam bater nos 13 dígitos. Se a caixa é antiga e mostra só 9 dígitos, complete o número pela consulta da Anvisa, escolhendo a apresentação exata.

CASO

O SNGPC recusa a entrada de alprazolam 1 mg. No cadastro, o produto está com o registro 1.9876.0110.001-3 (fictício), mas a caixa recebida mostra 1.9876.0110.003-X (fictício): é outra apresentação do mesmo produto, com 60 comprimidos. A farmacêutica cria o cadastro da apresentação correta, transfere o lançamento e reenvia.

Cosméticos, saneantes, alimentos e dispositivos médicos

A farmácia vende muito mais do que medicamentos: protetor solar, repelente, álcool em gel, fraldas, termômetros, suplementos, desinfetantes. Cada grupo tem seu próprio regime na Anvisa, e o formato do número muda. Saber isso evita dois erros opostos: recusar produto regular só porque não tem número de registro e aceitar produto irregular porque "tem um número".

Cosméticos, produtos de higiene e perfumes

A RDC 907/2024 divide esses produtos em Grau 1 e Grau 2, conforme o risco. A maior parte é **isenta de registro** e regularizada por comunicação prévia (notificação) no portal da Anvisa (art. 35). Ficam **sujeitos a registro** apenas os grupos listados no art. 34: bronzeador, gel antisséptico para as mãos, produto para alisar os cabelos, produto para alisar e tingir os cabelos, produto para ondular os cabelos, protetor solar, protetor solar infantil, repelente de insetos e repelente de insetos infantil. Nos dados abertos da Anvisa, o número de registro de cosmético tem 9 dígitos e começa, em quase todos os casos, com **2**.

Saneantes

A RDC 989/2025, que substituiu a RDC 59/2010, classifica os saneantes em **risco 1 (notificação)** e **risco 2 (registro)** (art. 8º). Produtos com ação antimicrobiana e desinfestantes estão entre os grupos tratados pela norma. Nos dados abertos, o registro de saneante tem 9 dígitos e começa com **3**; os notificados aparecem sem número de registro, identificados pelo número do processo.

Alimentos

A RDC 843/2024 organiza a regularização de alimentos em quatro situações: **registro** na Anvisa, **notificação** na Anvisa, comunicação de início de fabricação ou importação à vigilância local, e dispensa de regularização, conforme as categorias listadas nos anexos da IN 281/2024 (art. 3º). Nos dados abertos,

alimentos registrados têm número de 9 dígitos, que começa com 4, 5 ou 6; os notificados aparecem com número longo de processo. Suplementos alimentares, fórmulas infantis e alimentos para nutrição enteral são os alimentos mais vistos na farmácia.

Dispositivos médicos

A RDC 751/2022 classifica os dispositivos médicos em quatro classes de risco: I (baixo), II (médio), III (alto) e IV (máximo) (art. 5º). Classes I e II são sujeitas a **notificação** (art. 6º); classes III e IV, a **registro** (art. 7º), com validade de 10 anos (art. 11). Os produtos notificados também recebem número publicado no DOU, e só podem ser vendidos depois dessa publicação (art. 60, § 1º). Nos dados abertos, o número de notificação ou registro de dispositivo médico tem **11 dígitos**: os mais antigos começam com 1 (em geral 10) e os mais recentes com 8 (80 a 83).

Grupo	Regularização	Número que aparece	Norma
Medicamento	Registro ou notificação	13 dígitos, começa com 1; notificado: "MEDICAMENTO NOTIFICADO"	Lei 6.360/1976; RDC 768/2022
Cosmético	Notificação (maioria) ou registro (9 grupos)	Registrado: 9 dígitos, começa com 2	RDC 907/2024, arts. 34 e 35
Saneante	Notificação (risco 1) ou registro (risco 2)	Registrado: 9 dígitos, começa com 3	RDC 989/2025, art. 8º
Alimento	Registro, notificação, comunicação ou dispensa	Registrado: 9 dígitos, começa com 4, 5 ou 6	RDC 843/2024; IN 281/2024
Dispositivo médico	Notificação (classes I e II) ou registro (III e IV)	11 dígitos, começa com 1 ou 8	RDC 751/2022, arts. 5º a 7º

Os prefixos da tabela foram observados nos dados abertos da Anvisa e servem como pista de leitura. A prova de regularidade é sempre a consulta no portal, pelo nome, pela empresa ou pelo número.

PONTO-CHAVE

Um protetor solar, um repelente ou um gel antisséptico para as mãos precisam ter registro. Um xampu, um hidratante comum ou um desodorante não precisam: são notificados e não trazem número de registro.

NO BALCÃO

Cliente quer devolver um repelente porque "não tem número da Anvisa na embalagem". Antes de responder, procure o número na lateral ou no verso: repelente é registrado e deve trazer número de 9 dígitos começando com 2. Se a embalagem realmente não traz número, separe o lote e confira na consulta de cosméticos.

CASO

Fornecedor novo oferece termômetro digital e mostra o número "80999990001" (fictício) no folheto. O comprador faz a consulta de produtos para saúde pelo número e pelo nome da empresa. O número existe, mas pertence a outro modelo de outro fabricante. A loja não compra e comunica a vigilância sanitária.

Consulta de registro no portal da Anvisa

A consulta pública da Anvisa fica em **consultas.anvisa.gov.br** e é gratuita, sem login. Ela reúne medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos, produtos para saúde e outras áreas. A página de serviços da Anvisa separa duas consultas de medicamentos: **medicamentos registrados** (no portal de consultas) e **medicamentos de notificação simplificada** (relatório próprio).

Passo a passo para medicamentos

1. Entrar em consultas.anvisa.gov.br e escolher a área **Medicamentos**.
2. Preencher um critério. Os mais úteis no balcão são o **nome do produto**, o **número de registro** (os 9 primeiros dígitos já localizam o produto), o **princípio ativo** e o nome ou CNPJ da **empresa**.
3. Na lista de resultados, conferir nome, detentor e número antes de abrir. Medicamentos com o mesmo nome comercial podem existir em empresas diferentes, ativos e inativos.
4. Abrir a ficha do produto e ler os campos descritos abaixo.
5. Abrir as **apresentações** e localizar a que está na mão: concentração, forma farmacêutica, quantidade e o número completo de 13 dígitos.
6. Abrir a **bula** do paciente ou do profissional, quando precisar de informação técnica.

O que a ficha mostra

Campo	Para que serve no balcão
Nome do produto e princípio ativo	Confirmar que é o medicamento procurado e qual a DCB
Empresa detentora (razão social e CNPJ)	Conferir com o "Registrado por" da caixa e com a nota fiscal
Número do registro e do processo	Ligar a caixa ao cadastro e ao SNGPC
Situação e vencimento do registro	Saber se pode comprar e vender
Categoria regulatória	Saber se é novo, genérico, similar, específico, fitoterápico, biológico, dinamizado ou outra
Medicamento de referência	Para genéricos e similares, indica o produto de comparação
Classe terapêutica e código ATC	Classificar o produto no cadastro
Apresentações	Número de 13 dígitos, forma, embalagem, tarja e restrições de cada uma

Campo	Para que serve no balcão
Bula e rotulagem	Texto aprovado pela Anvisa

Os dados abertos da Anvisa usam as mesmas categorias da consulta: similar, genérico, novo, específico, fitoterápico, biológico, dinamizado, radiofármaco, gases medicinais, produto de terapia avançada e, para notificados, baixo risco.

As categorias regulatórias em uma linha

- **Novo**: medicamento com insumo ativo novo no país, em geral o produto inovador. Muitos são também o **medicamento de referência**, definido pela Lei 6.360/1976 (art. 3º, XXII, incluído pela Lei 9.787/1999) como produto inovador registrado e comercializado, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas no registro.
- **Genérico**: similar a um produto de referência, intercambiável com ele, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas, designado pela DCB ou, na falta, pela DCI (art. 3º, XXI).
- **Similar**: mesmo princípio ativo, concentração, forma, via, posologia e indicação do referência, identificado por nome comercial ou marca (art. 3º, XX). Desde a Lei 13.235/2015, o similar precisa comprovar eficácia, segurança e qualidade de forma equivalente à do genérico (Lei 6.360/1976, art. 21, § 6º).
- **Específico**: categoria da Anvisa para produtos que não se encaixam em novo, genérico ou similar, como muitas soluções de grande volume, vitaminas e minerais isolados.
- **Fitoterápico**: obtido de matéria-prima vegetal; tem as categorias medicamento fitoterápico e medicamento tradicional fitoterápico (RDC 1.004/2025).
- **Biológico**: obtido de fonte biológica (vacinas, soros, hemoderivados, anticorpos monoclonais, insulinas, entre outros).
- **Dinamizado**: homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos.

NO BALCÃO

Três usos rápidos da consulta. (1) Cliente pergunta se um medicamento novo "já foi aprovado": procure pelo princípio ativo e veja se há registro válido. (2) Receita com nome comercial que você não reconhece: a consulta mostra o princípio ativo e a empresa. (3) Dúvida se determinado produto é genérico ou similar: a categoria regulatória responde.

CASO

Cliente traz caixa de um anti-hipertensivo comprado em outra cidade e quer o "mesmo" na loja. A farmacêutica digita os 9 primeiros dígitos do "Registro:" da caixa, abre a ficha e vê: losartana potássica 50 mg, categoria similar, situação válida. Ela oferece o produto de referência, o genérico ou um similar intercambiável, conforme a receita, e explica a diferença de categoria.

ATENÇÃO

A consulta mostra o que está na base da Anvisa naquele momento. Resoluções de suspensão, apreensão ou recolhimento de lote saem no DOU e na página de alertas da Anvisa; registro válido não garante que um lote específico esteja liberado.

Outros códigos da embalagem e do cadastro

Além do registro, a caixa de medicamento e o cadastro da loja trazem outros códigos. Cada um tem dono e função diferentes, e o software de gestão costuma pedir vários deles na mesma tela.

Código de barras: EAN-13 ou GTIN-13

É o código de barras comercial, com **13 dígitos**, atribuído pela própria empresa dentro do sistema GS1. O dicionário de dados da lista de preços da CMED descreve o EAN como código de 13 dígitos que identifica a origem, a empresa, o produto e um dígito verificador. Os três primeiros dígitos indicam a organização GS1 que licenciou o número (789 e 790 para a GS1 Brasil, os mais vistos na farmácia); eles não provam o país onde o produto foi fabricado.

O EAN serve para a venda no caixa e o controle de estoque. Ele **não substitui** o registro: dois códigos de barras diferentes podem pertencer à mesma apresentação registrada (a lista da CMED tem colunas EAN 1, EAN 2 e EAN 3), e um código de barras não diz nada sobre a regularidade sanitária.

Código GGREM

Código de **15 dígitos** gerado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Segundo o dicionário de dados da lista de preços, é "um campo específico de identificação de determinada apresentação, cujo fornecimento e geração são exclusivos da CMED e são únicos para cada apresentação". Na lista da CMED, cada linha traz substância, CNPJ, laboratório, código GGREM, registro (13 dígitos), EAN, produto, apresentação, classe terapêutica, tipo de produto, preço fábrica (PF) e preço máximo ao consumidor (PMC). O farmacêutico usa essa lista para conferir o preço máximo de venda.

Rastreabilidade de medicamentos

A Lei 11.903/2009 criou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM). A Lei 13.410/2016 reorganizou o sistema em torno de um identificador individual por embalagem, com número de série único e banco de dados centralizado, e a Anvisa chegou a regulamentar esse modelo (RDC 157/2017 e RDC 319/2019). A **Lei 14.338/2022** mudou o rumo: revogou o número de série único e o banco centralizado (arts. 4º, 4º-A e 5º). Em 2024, a RDC 886/2024 revogou expressamente a RDC 157/2017 e a RDC 319/2019.

O QUE DIZ A NORMA

Pela Lei 11.903/2009, art. 3º, § 1º, com as redações das Leis 13.410/2016 e 14.338/2022, as embalagens de todos os medicamentos registrados devem conter no mínimo: número de registro, número do lote, data de validade e código de barras bidimensional que leve à bula digital. O detentor do registro deve manter mapa de distribuição com os quantitativos de cada lote e os destinatários (art. 3º-A).

Na prática, em outubro de 2026 a farmácia não transmite dados de unidade serializada para um banco nacional. A rastreabilidade se apoia em **registro + lote + validade**, no mapa de distribuição do detentor e na nota fiscal. Para controlados e antimicrobianos, o SNGPC continua exigindo o lote em cada movimentação.

Lote, fabricação e validade

A caixa deve trazer data de validade, data de fabricação e número de lote (RDC 768/2022, art. 5º, VIII). O lote liga a embalagem à ordem de produção do fabricante; é por ele que a Anvisa determina recolhimentos e que o SNGPC controla o saldo. O lote é digitado exatamente como está impresso, com letras, zeros e hifens.

Código de compras públicas

Em licitações e compras de órgãos públicos, o item costuma ser descrito pelo código do Catálogo de Materiais do governo federal (CATMAT). Esse código identifica a especificação do item na compra e não substitui o registro: o edital exige, além dele, o registro válido na Anvisa e a especificação pela DCB (Lei 9.787/1999, art. 3º).

PONTO-CHAVE

Registro (13 dígitos) diz que o produto é autorizado. EAN (13 dígitos) serve para vender e contar. GGREM (15 dígitos) liga a apresentação ao preço da CMED. Lote e validade identificam a fabricação. Os dois códigos de 13 dígitos são diferentes e não podem trocar de campo no cadastro.

NO BALCÃO

Se o leitor do caixa não reconhece o código de barras de uma caixa nova, não cadastre o EAN no campo do registro nem o registro no campo do EAN. Leia os dois na caixa: o registro está junto da expressão "Registro:"; o EAN está sob as barras.

CASO

Auxiliar cadastra um genérico novo e, no campo "Registro MS", digita 7899990001234 (fictício), lido pelo leitor de código de barras. O SNGPC recusa a primeira venda. A farmacêutica percebe que o número começa com 789, típico de EAN, corrige o campo com o registro da caixa e reenvia.

Denominação Comum Brasileira (DCB)

A **Denominação Comum Brasileira (DCB)** é o nome genérico oficial de um fármaco no Brasil. A Lei 6.360/1976, art. 3º, XVIII (incluído pela Lei 9.787/1999), define a DCB como a "denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária". A RDC 955/2024 a define como "nomenclatura genérica oficial atribuída aos insumos farmacêuticos pela Farmacopeia Brasileira, sendo de domínio público" (art. 4º, I).

Quem publica e como se atualiza

- **Regras**: RDC 955/2024, que trata do estabelecimento das DCB e da atualização da lista.
- **Lista**: aprovada por Instrução Normativa (RDC 955/2024, art. 1º, § 1º). A lista vigente é a da IN 342/2024, alterada periodicamente: a IN 416/2025 (dezembro de 2025) incluiu 22 DCB e alterou 3, e a IN 439/2026 (abril de 2026) trouxe novas inclusões. Em 22/07/2026 a Diretoria Colegiada aprovou mais uma atualização, com 21 inclusões e 2 alterações (Voto 221/2026).
- **Quem decide**: o Comitê Técnico Temático de DCB da Farmacopeia Brasileira (CTT DCB), a partir de pedidos de interessados (RDC 955/2024, arts. 5º e 6º).
- **Adequação**: após alteração ou exclusão de DCB, o setor tem 180 dias para se adequar (art. 7º, § 4º).

A lista consolidada fica no portal da Anvisa e traz, para cada DCB, o **número**, o **nome** e o **número CAS** ou, na falta dele, a referência usada (art. 8º).

O número DCB, a DCI e o CAS

Identificador	Quem atribui	Formato
Número DCB	Farmacopeia Brasileira (Anvisa)	Número sequencial de 5 dígitos (RDC 955/2024, art. 9º)
DCI (INN)	Organização Mundial da Saúde	Nome genérico internacional, em geral em inglês, latim, francês e espanhol
Número CAS	Chemical Abstracts Service (American Chemical Society)	Três grupos de números separados por hífen; os dois últimos com 2 e 1 algarismos (RDC 955/2024, art. 4º, X)

A DCB deve, sempre que possível, convergir com a DCI e ser uma tradução adequada do nome adotado em inglês pela OMS, respeitando a grafia do português (RDC 955/2024, arts. 10 e 15). Exemplo real tirado do Voto 221/2026 da Anvisa: a substância de DCB nº **00342**, CAS **14882-18-9**, teve o nome alterado de "salicilato de bismuto monobásico" para "subsalicilato de bismuto". O número DCB e o CAS ficaram; mudou o nome.

Sal e base

A DCB considera a forma de sal, de éster e a hidratação da substância (RDC 955/2024, art. 16). Por isso a lista traz nomes distintos para a base e para seus sais, cada um com número próprio. Exemplos de nomes: losartana e losartana potássica; sertralina e cloridrato de sertralina; enalapril e maleato de enalapril.

Na caixa, a face frontal traz a DCB em letras minúsculas e **sem o grau de hidratação** (RDC 768/2022, art. 3º, II, a). Uma das demais faces traz a composição quantitativa e, quando existir, a **equivalência sal-base** (art. 5º, I). Assim, "cloridrato de sertralina 55,95 mg equivalente a 50 mg de sertralina" significa que a dose clínica é 50 mg de sertralina. Já na losartana o padrão de mercado é expressar a dose pelo sal: "losartana potássica 50 mg".

ATENÇÃO

Trocar sal por base no cadastro ou no cálculo muda a quantidade de fármaco. Em manipulação e em conversões de dose, confira se a concentração da receita e a da matéria-prima se referem ao sal ou à base antes de calcular.

DCB na prescrição e na embalagem

- **SUS**: as prescrições médicas e odontológicas e as compras de medicamentos "adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI)" (Lei 9.787/1999, art. 3º).
- **Uso geral**: a RDC 955/2024 manda usar a DCB para nomear os insumos na regularização, na rotulagem, na bula, na propaganda, nos documentos oficiais, na prescrição e na dispensação (art. 3º).
- **Embalagem**: medicamento com nome comercial deve trazer também a DCB com o mesmo destaque (Lei 6.360/1976, art. 57, parágrafo único). A RDC 768/2022 fixa o tamanho: no mínimo 50% da altura do maior caractere do nome comercial para até dois insumos ativos e 30% para três ou mais (art. 72).
- **Genérico**: é designado pela DCB ou, na falta, pela DCI (Lei 6.360/1976, art. 3º, XXI).

DCB no SNGPC e no cadastro de insumos

No SNGPC, o medicamento industrializado é identificado pelo registro de 13 dígitos; o **insumo farmacêutico**, na farmácia de manipulação, é identificado pelo **código DCB**, com o CNPJ do fornecedor e o lote do fabricante (módulo do SNGPC). No software de gestão, a tabela de DCB é um cadastro próprio, ligado aos produtos e insumos. Por isso, DCB errada no cadastro de insumo gera recusa ou saldo no insumo errado, do mesmo modo que registro errado no medicamento.

Como achar a DCB certa

1. Ler a DCB impressa na face frontal da caixa ou no laudo do insumo.
2. Conferir na consulta da Anvisa o princípio ativo do produto.
3. Buscar o nome na lista consolidada de DCB, observando se é a base ou o sal (e qual sal).
4. Anotar o número de 5 dígitos e o CAS; o CAS do laudo do fornecedor deve coincidir.
5. Se não houver DCB, usar a DCI e registrar a ausência; a falta de DCB pode ser pedida à Anvisa por qualquer interessado (RDC 955/2024, art. 5º).

NO BALCÃO

Receita de UBS traz "Cozaar 50 mg". Pela Lei 9.787/1999, no SUS a prescrição deve usar a DCB, e o farmacêutico da rede pública pode precisar contatar o prescritor conforme o protocolo local. Na drogaria privada, a mesma receita pode ser aviada, e o farmacêutico explica ao cliente que o princípio ativo é losartana potássica, o que permite oferecer o genérico.

CASO

Farmácia de manipulação recebe cloridrato de sertralina, mas o cadastro de insumos aponta a DCB de "sertralina" (base). O SNGPC aceita o arquivo, mas o saldo fica no insumo errado e o livro não fecha. A farmacêutica corrige o cadastro para a DCB do sal, refaz o lançamento e confere o CAS do laudo com o da lista.

Fontes consultadas

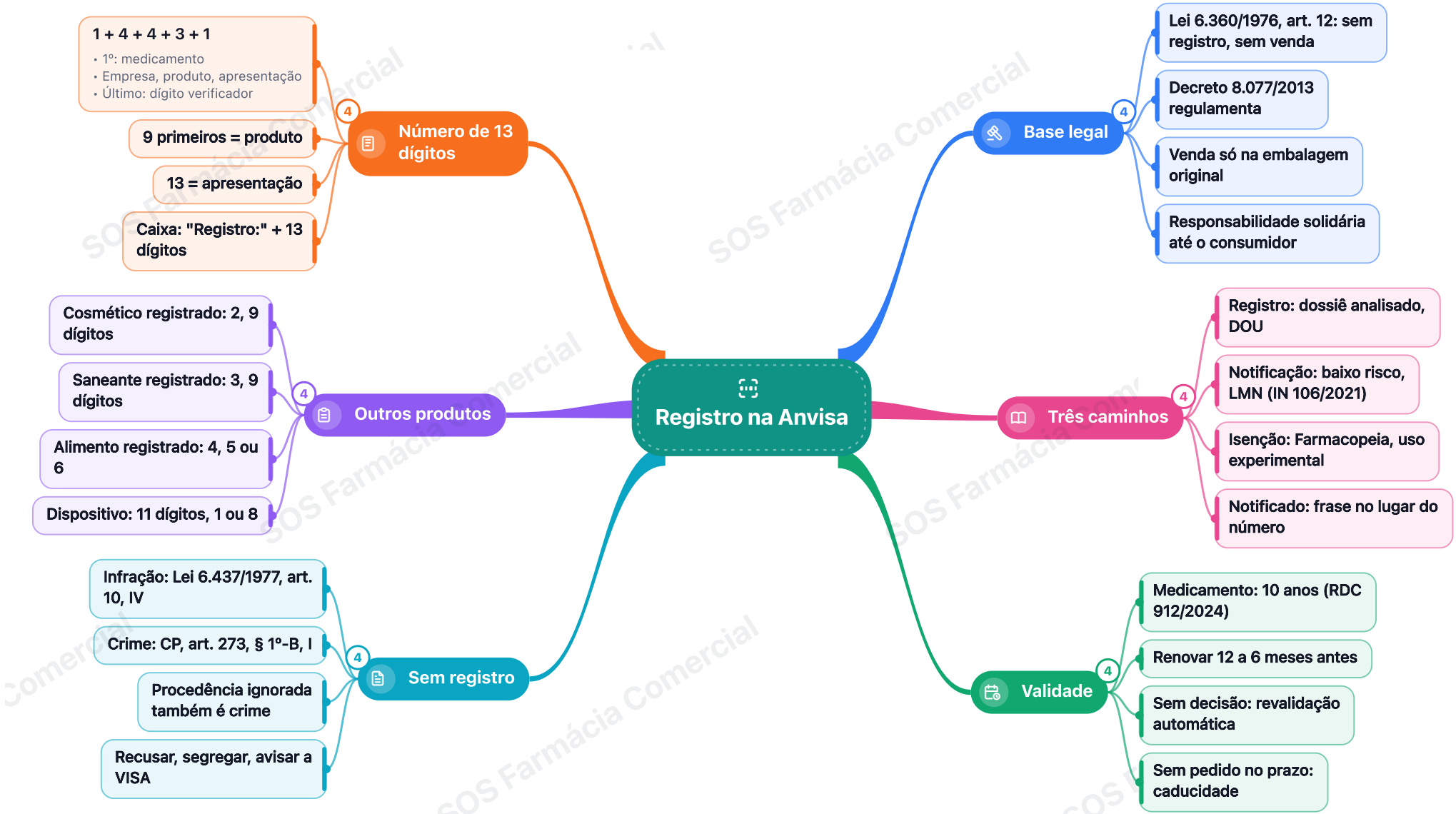
1. Brasil. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 (vigilância sanitária de medicamentos e outros produtos), texto compilado, arts. 3º, 12, 13, 19, 21, 23, 24 e 57. planalto.gov.br (consulta em 15 out. 2026).
2. Brasil. Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 (regulamenta a Lei 6.360/1976), arts. 7º, 8º, 11 e 15. planalto.gov.br.
3. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico e DCB), arts. 1º e 3º. planalto.gov.br.
4. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações sanitárias), art. 10, IV, texto compilado. planalto.gov.br.
5. Brasil. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), art. 273, com redação da Lei nº 9.677/1998, texto compilado. planalto.gov.br.
6. Supremo Tribunal Federal. RE 979.962/RS, Tema 1003 da repercussão geral, julgado em 24 mar. 2021 (consultado por resumos de jurisprudência).
7. Brasil. Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009, com as alterações das Leis nº 13.410/2016 e nº 14.338/2022 (rastreamento de medicamentos), texto compilado. planalto.gov.br.
8. Anvisa. RDC nº 912, de 19 de setembro de 2024 (prazos de validade e manutenção da regularização de medicamentos). Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
9. Anvisa. RDC nº 250, de 20 de outubro de 2004 (revalidação de registro), com redação da RDC nº 212/2018. Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
10. Anvisa. RDC nº 576, de 11 de novembro de 2021 (notificação de medicamentos de baixo risco), com redação da RDC nº 981/2025. Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
11. Anvisa. Instrução Normativa nº 106, de 11 de novembro de 2021 (LMN), e IN nº 430/2026 (atualização da LMN, DOU de 26 mar. 2026), conforme notícia de 2 abr. 2026 e Voto nº 221/2026.
12. Anvisa. RDC nº 768, de 12 de dezembro de 2022 (rotulagem de medicamentos), com redações das RDC nº 808/2023, nº 981/2025 e nº 1.004/2025, arts. 3º, 5º, 25 a 28, 31, 47, 50 e 72. Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
13. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada nº 1.004, de 17 de dezembro de 2025 (registro de medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de tradicionais fitoterápicos). anvisalegis.datalegis.net.
14. Anvisa. RDC nº 955, de 20 de dezembro de 2024 (regras para o estabelecimento das DCB e atualização da lista). Texto consolidado, anvisalegis.datalegis.net.
15. Anvisa. Voto nº 221/2026/SEI/DIRE4/Anvisa: atualização da lista de DCB, alterando a IN nº 342, de 20 de dezembro de 2024. Reunião Ordinária Pública 13/2026. gov.br/anvisa.
16. Anvisa. Atualizações da lista de DCB: IN nº 416, de 17 de dezembro de 2025, e IN nº 439, de 16 de abril de 2026 (conforme notícias setoriais que reproduzem a publicação).
17. Anvisa. RDC nº 886, de 10 de julho de 2024 (revogação de normas; revoga as RDC nº 157/2017 e nº 319/2019). anvisalegis.datalegis.net.
18. Anvisa. RDC nº 907, de 19 de setembro de 2024 (produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes), arts. 32 a 35. anvisalegis.datalegis.net.
19. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada nº 989, de 15 de agosto de 2025 (regularização e classificação de saneantes), art. 8º. anvisalegis.datalegis.net.

20. Anvisa. RDC nº 843, de 22 de fevereiro de 2024 (regularização de alimentos e embalagens), art. 3º, e IN nº 281/2024. anvisalegis.datalegis.net.
21. Anvisa. RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022 (classificação de risco, notificação e registro de dispositivos médicos), arts. 5º a 7º, 11 e 60. anvisalegis.datalegis.net.
22. Anvisa. Dados abertos: medicamentos registrados, consultas de produtos (medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos e produtos para saúde). dados.anvisa.gov.br (arquivos baixados em 15 out. 2026).
23. Anvisa/CMED. Lista de preços de medicamentos (TA_PRECO_MEDICAMENTO) e respectivo dicionário de dados (código GGREM, registro, EAN). dados.anvisa.gov.br.
24. Anvisa. Consulta a registro de medicamentos (página de serviço). gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/consulta-a-registro-de-medicamentos.

SOS Farmácia Comercial

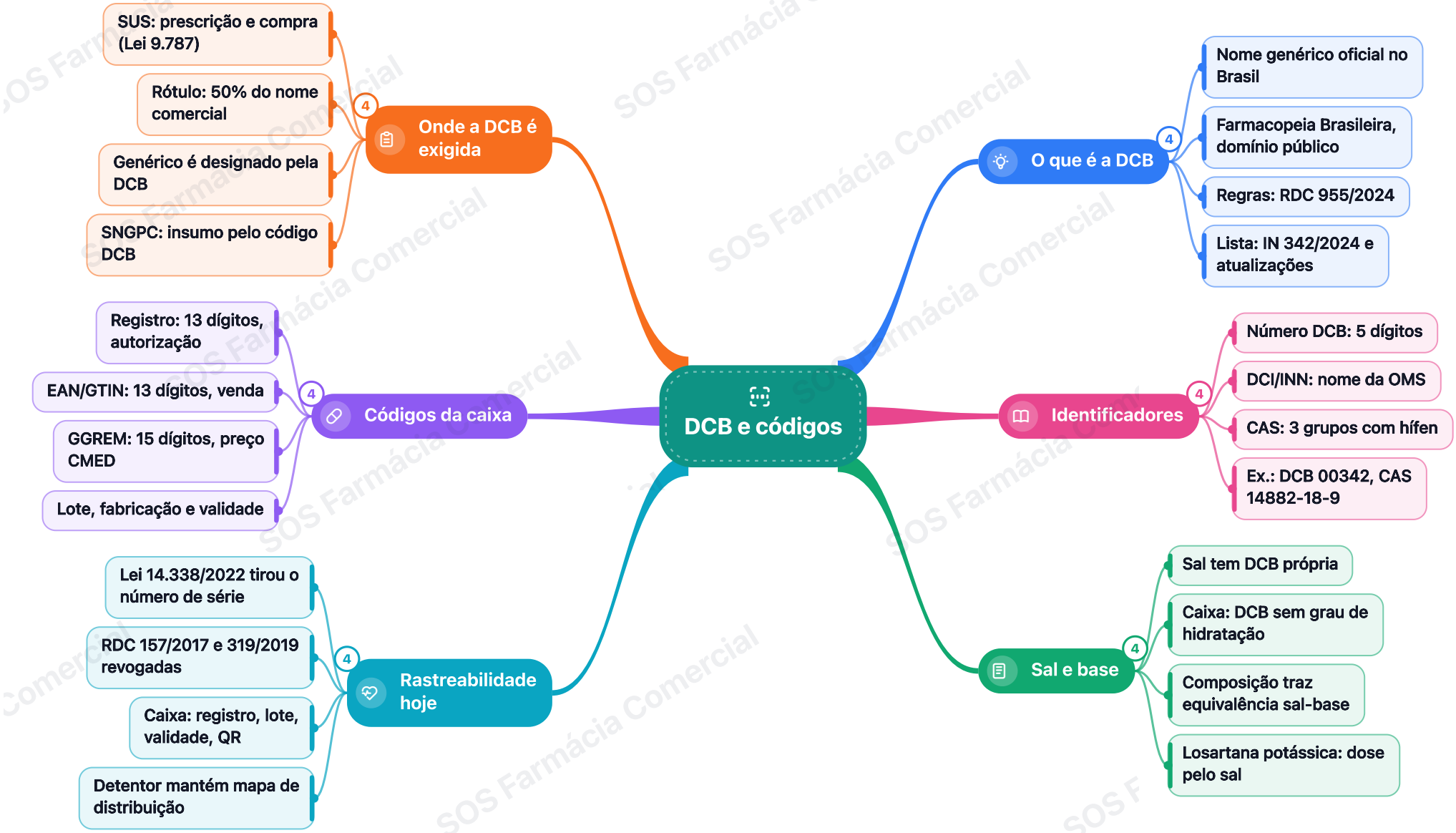
Registro sanitário e código MS

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 9



DCB e outros códigos

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 9



Anatomia do número de registro

Número **fictício** de uma apresentação de medicamento: **1.9990.0045.002-7** (corrido: 1999000450027).

Dígito	Valor	Bloco	Significado
1º	1	Categoria	Medicamento (todo registro de medicamento começa com 1)
2º	9	Empresa	Início do código da empresa detentora
3º	9	Empresa	Código da empresa
4º	9	Empresa	Código da empresa
5º	0	Empresa	Fim do código da empresa (9990)
6º	0	Produto	Início do número do produto na empresa
7º	0	Produto	Número do produto
8º	4	Produto	Número do produto
9º	5	Produto	Fim do número do produto (0045); aqui termina o registro do produto (9 dígitos)
10º	0	Apresentação	Início do código da apresentação
11º	0	Apresentação	Código da apresentação
12º	2	Apresentação	Fim do código da apresentação (002)
13º	7	Verificador	Dígito verificador, calculado pelo sistema da Anvisa

O mesmo produto, três apresentações (fictícias)

Apresentação	Registro do produto	Número completo
Comprimido 0,5 mg, caixa com 30	1.9990.0045	1.9990.0045.001-X
Comprimido 2 mg, caixa com 30	1.9990.0045	1.9990.0045.002-7
Comprimido 2 mg, caixa com 60	1.9990.0045	1.9990.0045.003-X

X = dígito verificador (não calculado nos exemplos). Exigências de rotulagem: caixa com os 13 dígitos (RDC 768/2022, art. 5º, VII); embalagem primária vendida sem caixa e embalagem fracionável com no mínimo 9 dígitos (arts. 31 e 50).

Categoria regulatória e como reconhecer na embalagem

Categoria	O que é	Sinal na embalagem	Como confirmar
Novo / referência	Insumo ativo novo no país; o referência é o inovador usado como padrão de comparação	Nome comercial; não há marca gráfica obrigatória de categoria	Consulta Anvisa: categoria "Novo"; lista de medicamentos de referência
Genérico	Intercambiável com o referência; designado pela DCB (Lei 6.360/1976, art. 3º, XXI)	Faixa amarela na face frontal com "G" e "Medicamento Genérico" (RDC 768/2022, arts. 25 a 28); sem nome comercial	Consulta Anvisa: categoria "Genérico"
Similar	Mesmo ativo, concentração, forma, via e indicação do referência, com nome comercial (art. 3º, XX)	Nome comercial; a cor amarela da faixa é proibida fora do genérico (RDC 768/2022, art. 27, § 1º)	Consulta Anvisa: categoria "Similar" e o referência indicado
Específico	Produtos fora de novo, genérico e similar, como muitas soluções e vitaminas isoladas	Sem frase obrigatória de categoria	Consulta Anvisa: categoria "Específico"
Fitoterápico	Ativo de origem vegetal (RDC 1.004/2025)	"MEDICAMENTO FITOTERÁPICO" ou "MEDICAMENTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO" (RDC 768/2022, art. 3º, IX)	Consulta Anvisa: categoria "Fitoterápico"
Biológico	Obtido de fonte biológica: vacinas, soros, insulinas, anticorpos	DCB do insumo biológico na face frontal (RDC 768/2022, art. 3º, II, d)	Consulta Anvisa: categoria "Biológico"
Dinamizado	Homeopático, antroposófico ou anti-homotóxico	"MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO", "ANTROPOSÓFICO" ou "ANTIHOMOTÓXICO" (art. 3º, X)	Consulta Anvisa: categoria "Dinamizado"
Notificado	Baixo risco da LMN, dinamizado ou tradicional fitoterápico notificado	"MEDICAMENTO NOTIFICADO" (ou variante) no lugar do número de registro (art. 5º, § 4º)	Consulta de medicamentos de notificação simplificada

A categoria regulatória não se confunde com a tarja (venda sob prescrição ou isenta). Um genérico pode ser tarjado ou isento de prescrição.

Códigos que aparecem na farmácia

Código	Formato	Quem atribui	Para que serve	Onde aparece
Registro do medicamento (apresentação)	13 dígitos, começa com 1	Anvisa	Prova a autorização de venda daquela apresentação	Caixa ("Registro:"), nota fiscal, SNGPC, cadastro

Código	Formato	Quem atribui	Para que serve	Onde aparece
Registro do produto	9 primeiros dígitos do anterior	Anvisa	Identifica o medicamento como um todo	Embalagem primária, blíster fracionável, consulta
Número de processo	Número longo de protocolo (ex.: 25351...)	Anvisa	Acompanha o pedido; identifica notificados de cosmético, saneante e alimento	Consulta Anvisa
EAN-13 / GTIN-13	13 dígitos; 789 ou 790 para GS1 Brasil	Empresa, no sistema GS1	Venda no caixa e estoque	Código de barras da caixa
GGREM	15 dígitos	CMED	Identifica a apresentação na lista de preços	Lista de preços da CMED
Lote	Letras e números definidos pelo fabricante	Fabricante	Rastreia a fabricação; base de recolhimentos e do SNGPC	Caixa e embalagem primária
Validade e fabricação	Data	Fabricante	Prazo de uso e idade do lote	Caixa e embalagem primária
Número DCB	5 dígitos	Farmacopeia Brasileira (Anvisa)	Identifica o insumo pelo nome genérico oficial	Lista de DCB, SNGPC de insumos, cadastro
Número CAS	3 grupos com hífen (ex.: 14882-18-9)	Chemical Abstracts Service	Identifica a substância química	Lista de DCB, laudo do insumo
Código ATC	Letras e números por nível	OMS	Classifica o fármaco por sistema e grupo terapêutico	Consulta Anvisa, cadastro
CATMAT	Código numérico do catálogo	Governo federal	Especifica o item em compras públicas	Editais e pedidos de compra pública

Registro e EAN têm os dois 13 dígitos. O registro de medicamento começa com 1; o EAN de empresa filiada à GS1 Brasil começa com 789 ou 790.

Registro, notificação e isenção por tipo de produto

Produto	Precisa de registro	Basta notificar	Norma
Medicamento	Regra geral	Baixo risco da LMN; dinamizados e tradicionais fitoterápicos notificáveis	Lei 6.360/1976; RDC 576/2021; IN 106/2021 e IN 430/2026
Cosmético	Bronzeador, gel antisséptico para mãos, alisantes, ondulantes, protetor solar, repelente (e versões infantis)	Todos os demais grupos	RDC 907/2024, arts. 34 e 35
Saneante	Risco 2	Risco 1	RDC 989/2025, art. 8º
Alimento	Categorias do Anexo I da IN 281/2024	Categorias do Anexo II; outras exigem só comunicação local ou são dispensadas	RDC 843/2024, art. 3º
Dispositivo médico	Classes III e IV	Classes I e II	RDC 751/2022, arts. 6º e 7º

SOS Farmácia Comercial

Este produto é regular?

Produto na mão: no recebimento, na prateleira ou trazido pelo cliente

Identificar o tipo: medicamento, cosmético, saneante, alimento ou dispositivo médico

DECISÃO

A embalagem traz número de registro ou de notificação?

SIM
Anotar o número e seguir para a consulta

NÃO
Verificar se é notificado ("MEDICAMENTO NOTIFICADO"), cosmético isento, alimento dispensado ou manipulado

DECISÃO

O formato do número combina com o tipo de produto?

SIM
Seguir para a consulta

NÃO
Desconfiar: número de outro tipo de produto, EAN no lugar de registro ou número inventado

Consultar em consultas.anvisa.gov.br pelo número, nome e empresa

DECISÃO

Nome, empresa detentora e apresentação conferem com a caixa?

SIM
Verificar a situação

NÃO
Segregar o item e pedir ao fornecedor a documentação de regularização

DECISÃO

A situação está válida e a apresentação ativa?

SIM
Conferir alertas de suspensão ou recolhimento do lote

NÃO
Não comprar nem vender; consultar o detentor e a VISA sobre o estoque

Lote, validade e procedência (nota fiscal de distribuidor licenciado) conferidos

ATENÇÃO

Produto sem registro exigível, de procedência ignorada ou de fornecedor sem licença: infração sanitária e possível crime (CP, art. 273, § 1º-B)

Produto regular: liberar para cadastro e venda

Conferência de um produto novo no cadastro

- ◯ Nome comercial e DCB conferidos com a face frontal da caixa
- ◯ DCB cadastrada é a do sal ou da base, conforme a caixa
- ◯ Concentração, forma farmacêutica e quantidade da apresentação conferidas
- ◯ Registro de 13 dígitos digitado a partir da caixa, não do EAN
- ◯ Nove primeiros dígitos do registro conferem com o produto na consulta da Anvisa
- ◯ Apresentação localizada na consulta, com situação ativa
- ◯ Situação do registro válida e data de vencimento anotada
- ◯ Empresa detentora e CNPJ conferem com o "Registrado por" e com a nota
- ◯ Categoria regulatória anotada (novo, genérico, similar, específico, outra)
- ◯ Notificado: frase "MEDICAMENTO NOTIFICADO" presente e produto na consulta de notificados
- ◯ Tarja e restrição de venda conferidas com a consulta e com a caixa
- ◯ Controlado ou antimicrobiano: classe terapêutica e lista corretas para o SNGPC
- ◯ EAN cadastrado no campo de código de barras
- ◯ Código GGREM e preço máximo conferidos na lista da CMED
- ◯ Unidade de controle definida (caixa ou frasco) para o SNGPC

- [ ] Primeiro lote recebido conferido entre caixa, nota e cadastro

Cartões: registro e DCB

Pergunta	Resposta
Artigo da Lei 6.360/1976 que proíbe vender produto não registrado	Art. 12, caput.
Prazo de validade do registro de medicamento hoje	10 anos (RDC 912/2024, art. 2º).
Quando a empresa deve pedir a renovação?	De 12 a 6 meses antes do vencimento (RDC 250/2004, art. 1º).
Pedido de renovação no prazo e sem decisão até o vencimento	Revalidação automática; a análise continua.
O que é caducidade do registro?	Perda do registro porque a renovação não foi pedida no prazo.
Quantos dígitos tem o registro completo de medicamento?	13, e começa com 1.
O que identificam os 9 primeiros dígitos?	O produto: categoria, empresa e número do produto.
O que identificam os dígitos 10 a 12?	A apresentação.
Expressão exigida na caixa antes do número	"Registro:" com os 13 dígitos (RDC 768/2022, art. 5º, VII).
O que substitui o número de registro no medicamento notificado?	A frase "MEDICAMENTO NOTIFICADO" (ou variante).
Lista de medicamentos de baixo risco notificáveis	LMN: IN 106/2021, atualizada pela IN 430/2026.
Cosméticos que exigem registro	Bronzeador, gel antisséptico, alisantes, ondulantes, protetor solar, repelente (RDC 907/2024, art. 34).
Dispositivos médicos sujeitos a registro	Classes III e IV (RDC 751/2022, art. 7º).
Formato do número DCB	Sequencial de 5 dígitos (RDC 955/2024, art. 9º).
Norma que aprova a lista de DCB vigente	IN 342/2024, com atualizações periódicas.
Onde a DCB é obrigatória na prescrição por lei?	No SUS (Lei 9.787/1999, art. 3º).
Código de 15 dígitos da CMED	GGREM, único por apresentação.
O que a Lei 14.338/2022 retirou da rastreabilidade?	O número de série único e o banco de dados centralizado.

Questões: registro e DCB

1. Farmacêutico recebe um lote de clonazepam 2 mg com 30 comprimidos. No cadastro já existe clonazepam 0,5 mg com 30 comprimidos do mesmo detentor, registrado como 1.9990.0045.001-X (número fictício). Sobre o cadastro do novo item, é correto afirmar:

A Pode usar o mesmo número, pois o produto é o mesmo

B Deve usar só os 9 primeiros dígitos, comuns às duas apresentações

C Deve cadastrar o número de 13 dígitos impresso na caixa do 2 mg

D Deve usar o código de barras como registro, porque é exclusivo

E Deve usar o número do processo, que identifica a apresentação

2. Pela norma vigente em 2026, o prazo de validade do registro de um medicamento novo concedido sem Termo de Compromisso é de:

A 5 anos, conforme o Decreto 8.077/2013

B 10 anos, conforme a RDC 912/2024

C 2 anos, como os produtos dietéticos

D 3 anos, renovável por mais 5

E Indeterminado após a primeira renovação

3. Uma drogaria recebe solução nasal de cloreto de sódio 0,9% cuja caixa não tem número de registro e traz a frase "MEDICAMENTO NOTIFICADO". A conduta adequada é:

A Recusar o lote, pois todo medicamento precisa de registro

B Aceitar sem conferir, porque produto isento não tem controle

C Conferir na consulta de notificados e aceitar se estiver regular

D Pedir ao fornecedor que imprima o número na embalagem

E Vender apenas com receita, porque não há registro

4. Segundo a RDC 907/2024, qual dos produtos abaixo, vendido em farmácia, está sujeito a registro na Anvisa?

A Xampu anticaspa sem ativo medicamentoso

B Desodorante antitranspirante

C Creme hidratante corporal

D Repelente de insetos infantil

E Sabonete líquido íntimo

5. Ao cadastrar um genérico, a auxiliar digitou no campo "Registro MS" o número 7899990001234 (fictício), lido pelo leitor de código de barras. Esse número é provavelmente:

A O EAN-13, código comercial da GS1 Brasil

B O registro do produto com 13 dígitos

C O código GGREM da lista da CMED

D O número DCB do princípio ativo

E O número CAS do insumo farmacêutico

6. Sobre a rastreabilidade de medicamentos (Lei 11.903/2009) em outubro de 2026, assinale a correta.

A A farmácia transmite cada unidade serializada a um banco nacional

B O número de série único continua obrigatório em toda embalagem

C A RDC 157/2017 segue regulando o identificador único

D A embalagem deve trazer registro, lote, validade e código para bula digital

E A rastreabilidade foi extinta e o lote deixou de ser exigido

7. Representante oferece à drogaria, por preço muito baixo, caixas de um anti-inflamatório sem nota fiscal e sem saber dizer de onde vieram. Em relação ao Código Penal, a compra para revenda:

A Só é crime se o produto estiver falsificado

B Não é crime, apenas infração sanitária leve

C É crime só para quem importou o produto

D Pode configurar crime, por procedência ignorada

E Depende da tarja do medicamento

8. Sobre a Denominação Comum Brasileira, é correto afirmar:

A É marca registrada da Farmacopeia Brasileira

B Tem número sequencial de 5 dígitos e é de domínio público

C É sempre idêntica à DCI em inglês

D É atualizada por lei federal a cada cinco anos

E Só vale para medicamentos genéricos

9. Receita emitida em Unidade Básica de Saúde prescreve um anti-hipertensivo apenas pelo nome comercial. A norma que obriga o uso da DCB (ou, na falta, da DCI) nas prescrições do SUS é:

A Lei 5.991/1973

B Lei 6.437/1977

C RDC 768/2022

D Lei 13.021/2014

E Lei 9.787/1999

10. A caixa de um medicamento informa: "cloridrato de sertralina 55,95 mg equivalente a 50 mg de sertralina". Para o cadastro de DCB e a orientação ao paciente, é correto:

A A dose clínica é de 55,95 mg de sertralina base

B O sal e a base têm a mesma DCB e o mesmo número

C A DCB do sal é cloridrato de sertralina; a dose clínica é 50 mg de sertralina

D A equivalência sal-base é proibida na rotulagem

E O grau de hidratação deve constar na face frontal

11. Na consulta da Anvisa, o farmacêutico encontra um medicamento com registro de produto válido, mas a apresentação de 60 comprimidos aparece inativa. A interpretação correta é:

A O registro inteiro está cancelado

B Aquela apresentação não está ativa, mas outras podem estar

C Basta usar o número do 30 comprimidos para o 60

D A apresentação inativa pode ser vendida sem SNGPC

E Inativa significa notificada

Gabarito comentado

1. **C**. Os 9 primeiros dígitos identificam o produto; os dígitos 10 a 12 identificam a apresentação. Cada concentração e embalagem tem número de 13 dígitos próprio, exigido na caixa (RDC 768/2022, art. 5º, VII) e usado no SNGPC. Repetir o número ou usar 9 dígitos mistura os estoques. EAN e número de processo não substituem o registro.
2. **B**. A Lei 13.097/2015 permitiu à Anvisa fixar prazo de até 10 anos (Lei 6.360/1976, art. 12, § 1º), e a RDC 912/2024 fixou 10 anos (art. 2º). O texto do Decreto 8.077/2013 ainda menciona 5 anos, mas a lei posterior delegou o prazo à Anvisa. Três anos é o prazo inicial de registro com Termo de Compromisso (art. 3º). Não existe registro de prazo indeterminado.
3. **C**. Medicamentos de baixo risco da LMN são regularizados por notificação (RDC 576/2021), e a frase "MEDICAMENTO NOTIFICADO" substitui o número de registro (RDC 768/2022, art. 5º, § 4º). Notificado é regular, mas continua sob fiscalização (Decreto 8.077/2013, art. 15), por isso a conferência na consulta. São de venda isenta de prescrição (RDC 576/2021, art. 3º, IV).
4. **D**. O art. 34 da RDC 907/2024 lista os grupos sujeitos a registro: bronzeador, gel antisséptico para as mãos, alisantes, produto para alisar e tingir, ondulante, protetor solar, protetor solar infantil, repelente e repelente infantil. Os demais grupos são isentos de registro e regularizados por comunicação prévia (art. 35).
5. **A**. Registro de medicamento começa com 1. O prefixo 789 é típico do EAN de empresa filiada à GS1 Brasil, lido pelo código de barras. GGREM tem 15 dígitos; número DCB tem 5; CAS tem três grupos separados por hífen (RDC 955/2024, arts. 4º, X, e 9º).
6. **D**. A Lei 14.338/2022 revogou o número de série único e o banco centralizado; a embalagem deve trazer registro, lote, validade e código bidimensional para a bula digital (art. 3º, § 1º), e o detentor mantém mapa de distribuição (art. 3º-A). A RDC 157/2017 foi revogada pela RDC 886/2024. O lote segue exigido.
7. **D**. O art. 273, § 1º-B, do Código Penal sujeita às penas do artigo quem vende, expõe à venda ou tem em depósito produto de procedência ignorada (inciso V), sem registro quando exigível (I) ou adquirido de estabelecimento sem licença (VI). Também é infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, IV). A tarja não muda essa regra.
8. **B**. A RDC 955/2024 define a DCB como nomenclatura genérica oficial de domínio público, não registrável como propriedade intelectual (art. 4º, I), com número sequencial de 5 dígitos (art. 9º). Deve convergir com a DCI quando possível, traduzida para o português (arts. 10 e 15). A lista é atualizada por Instrução Normativa, sem periodicidade fixa em lei, e vale para rotulagem, prescrição e dispensação em geral (art. 3º).
9. **E**. A Lei 9.787/1999, art. 3º, determina que as aquisições e as prescrições médicas e odontológicas no SUS adotem obrigatoriamente a DCB ou, na falta, a DCI. A Lei 6.437/1977 trata de infrações sanitárias; a RDC 768/2022, de rotulagem; as demais tratam do comércio farmacêutico e da atividade da farmácia.
10. **C**. A DCB considera a forma de sal (RDC 955/2024, art. 16), e o sal tem nome e número próprios. A rotulagem traz a composição com a equivalência sal-base (RDC 768/2022, art. 5º, I); a face frontal traz a DCB sem o grau de hidratação (art. 3º, II, a). A dose de 50 mg refere-se à base.
11. **B**. A situação é informada para o produto e para cada apresentação. Uma apresentação descontinuada pode ficar inativa enquanto o produto segue válido com outras. Usar o número de outra apresentação mistura estoques no SNGPC. Notificação é outro regime, sem número de registro.

Módulo 10

Trier Sistemas: o software de gestão por dentro

O software de gestão da farmácia na rotina do SNGPC, com o Trier SNGPC Web como exemplo: cadastros, lançamentos, importação de vendas, inventário, geração do arquivo XML e relatórios (livro de registro, balanço, relação mensal), tela a tela, com dados fictícios.

O software de gestão por dentro

O software de gestão por dentro

O site da Anvisa só recebe arquivos. Quem escritura é o **software de gestão** da farmácia. Cada fornecedor tem telas próprias, mas todos fazem as mesmas tarefas: cadastrar produtos, prescritores e clientes; lançar entradas, receitas e outras saídas; montar o inventário; gerar e enviar o XML; emitir livros e balanços. O exemplo deste tópico é o *Trier SNGPC Web*, comum em drogarias; em outro software, procure a tela equivalente pela função.

Mapa do software

Grupo	Telas	Para quê
Cadastros	Produtos, Cliente (comprador/paciente), Laboratórios, Fornecedores, Médicos, DCBs, Lojas, Manutenção de lotes, Livro de medicamento, Conferência de medicamentos	Deixar certos os dados que todo lançamento usa
Lançamentos	Entrada de mercadorias, Receitas, Outras saídas, Manutenção de movimentos	A escrituração propriamente dita
SNGPC	Geração de arquivo, Arquivos gerados, Histórico de importações, Lançamento de inventário inicial, Manutenção de página do livro	Montar e enviar o que vai para a Anvisa
Relatórios	Livro de registro específico (Portaria 344), Relação mensal de notificação de receita, Balanço, Conferência, Saldo de estoque, Ficha de estoque, Médicos, Entradas x saídas, Inventário inicial, Log de eventos	Prestar contas à VISA e investigar divergência
Diversos	Alteração de senha, Cadastro de usuários, Controle de acesso	Quem pode fazer o quê

Do balcão à Anvisa, na ordem

1. **Cadastro certo**: produto com registro MS, classe terapêutica, lista e unidade SNGPC; prescritor com conselho e UF; cliente com documento.
2. **Entrada**: nota fiscal lançada item a item, com lote, antes de qualquer venda daquele lote.
3. **Venda**: o caixa vende; a venda de controlado chega ao SNGPC Web (importação) ou é lançada em Receitas, com tipo de receita, número, prescritor, comprador, paciente, quantidade vendida e prescrita e lote.
4. **Pendências**: em Histórico de importações, nenhuma venda pendente; em Conferência, receitas e entradas conferidas com o papel.
5. **Outras saídas**: perdas, transferências e devoluções lançadas com o motivo e o documento.
6. **Arquivo**: Geração de arquivo SNGPC do período seguinte ao último aceito, com Envio para ANVISA (ou download e envio no site).
7. **Conferência do retorno**: no painel do software (status S) e, pelo hash, no Status de Transmissão do site da Anvisa.

PONTO-CHAVE

Unidade SNGPC é por embalagem (caixa ou frasco). Lançar comprimidos soltos como se fossem caixas, ou o contrário, multiplica o erro de estoque a cada venda.

ATENÇÃO

Três ações do software fecham portas: confirmar o inventário, emitir o livro de registro (o período fica bloqueado para lançamentos) e gerar o arquivo de um período. Confira antes. E restrinja, em Usuários, quem pode excluir receita ou alterar movimento.

NO BALCÃO

Combine com o caixa: venda de controlado só se conclui com a receita em mãos e os dados completos. A pendência que nasce no caixa vira atraso no arquivo e, depois, irregularidade no certificado.

CASO

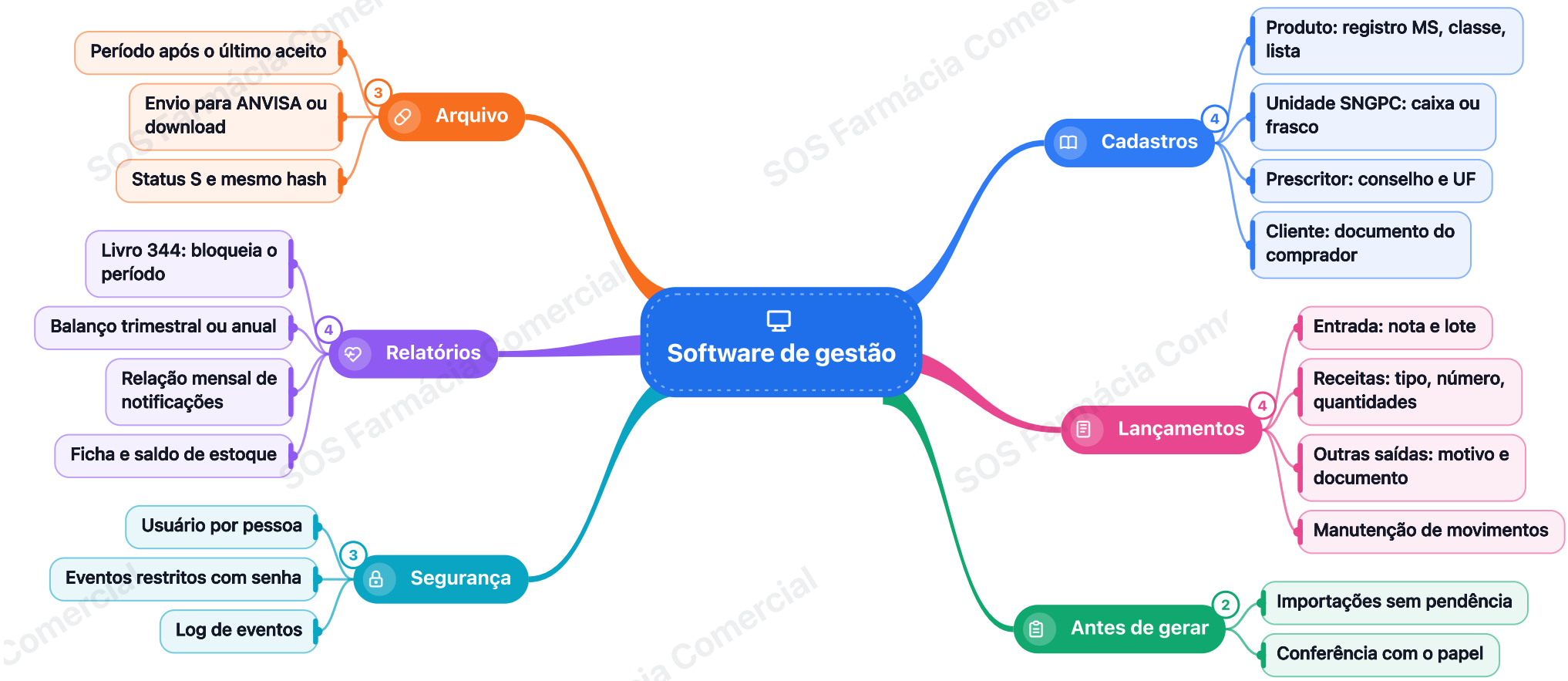
O painel mostra o último arquivo aceito até 11/10 e o software acusa alerta de não envio. Em Histórico de importações há três vendas de alprazolam pendentes, sem número de notificação. A farmacêutica localiza as notificações retidas, completa os dados em Receitas, confere, gera o arquivo de 12/10 a 18/10 com Envio para ANVISA e confirma no painel o status S e o mesmo hash no Status de Transmissão do site.

Fontes consultadas

1. Trier Sistemas. SNGPC Web: telas de cadastro, lançamentos, geração de arquivo e relatórios (sngpc.triersistemas.com.br), consultadas em 10/10/2026.

O software de gestão

6 ramos · 20 itens · mapa mental do módulo 10



Simulador: o Trier SNGPC Web tela a tela

SNGPC WEB Software de gestão da farmácia (réplica didática do Trier SNGPC Web, dados fictícios)

- **Painel**
- Produtos
- Médicos (prescritores)
- Cliente (comprador/paciente)
- Lojas
- Entrada de Mercadorias
- Receitas
- Outras Saídas
- Manutenção Movimentos
- Histórico de Importações
- Conferência de Medicamentos
- Lançamento de Inventário Inicial
- Geração de Arquivo SNGPC
- Livro de Registro Específico P. 344/98
- Balanço de Medicamentos
- Relação Mensal de Notificação Receita
- Ficha de Estoque
- Log de Eventos e Usuários

1

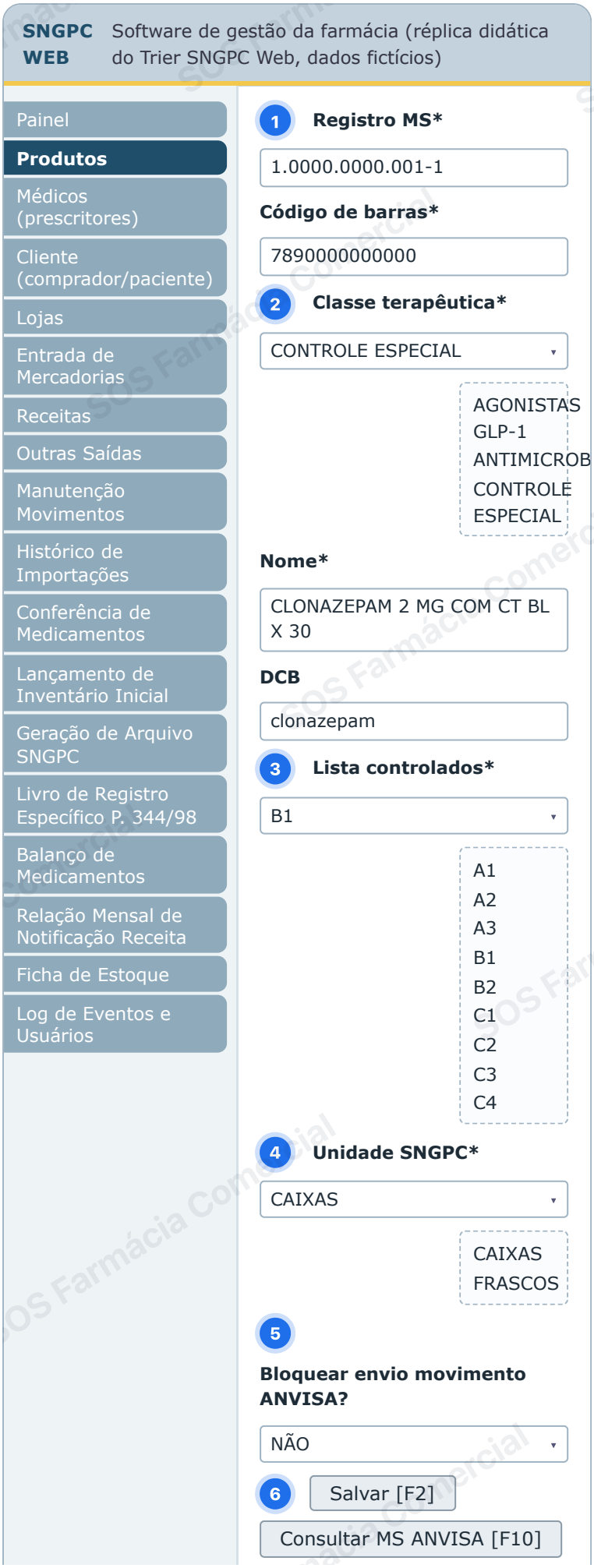
Tipo envio	Período	Data
MOVIMENTO	28/09/2026 a 04/10/2026	05/1
MOVIMENTO	05/10/2026 a 11/10/2026	12/1

2 Campo de busca no topo: Informe o recurso para pesquisa [CTRL+0]

Painel inicial: arquivos transmitidos

A primeira tela depois do login lista os últimos arquivos enviados. É a conferência mais rápida do dia.

1. Cada linha é um arquivo: tipo (MOVIMENTO ou inventário), período coberto, quando foi gerado, quando a Anvisa validou, se foi aprovado (S/N) e o hash. O hash é o mesmo que aparece no SNGPC da Anvisa em Status de Transmissão: é assim que se casa um arquivo do software com o registro da Anvisa. Os períodos têm de ser contínuos, sem buraco e sem sobreposição.
2. O campo de busca abre qualquer tela pelo nome (atalho Ctrl+0). Quase todas as telas têm atalhos de teclado nos botões (F2 salvar, F5 limpar, F3 ou F10 consultar).



Cadastros > Produtos

Todo controlado precisa estar cadastrado com registro, classe e lista corretos. Erro aqui contamina todas as movimentações daquele produto.

1. O registro MS é a chave que a Anvisa usa para reconhecer o medicamento. Registro errado gera recusa ou estoque em produto errado. O botão Consultar MS ANVISA confere o número.
2. Classe terapêutica define em que escrituração o produto entra: controle especial (Portaria 344), antimicrobianos ou agonistas de GLP-1.
3. Lista da Portaria 344 do produto (o adendo, quando houver, vai no campo ao lado). Ela define o receituário exigido e a ordem nos livros e balanços.
4. Unidade em que o produto é escriturado: caixas (comprimidos, cápsulas) ou frascos (líquidos). A quantidade transmitida é contada nessa unidade, não em comprimidos soltos.
5. Bloqueia o envio das movimentações do produto. Só se usa com orientação (por exemplo, produto cadastrado por engano como controlado), nunca para esconder divergência: o estoque oficial deixa de bater.
6. Quando a Anvisa muda uma substância de lista, a cópia de produto para a nova lista mantém o histórico; o histórico de alteração do registro mostra quem mudou o quê.

Cópia produtos troca lista controlados [Alt+C]

Histórico alteração Reg.MS [Alt+D]

SNGPC WEB Software de gestão da farmácia (réplica didática do Trier SNGPC Web, dados fictícios)

- Painel
- Produtos
- **Médicos (prescritores)**
- Cliente (comprador/paciente)
- Lojas
- Entrada de Mercadorias
- Receitas
- Outras Saídas
- Manutenção Movimentos
- Histórico de Importações
- Conferência de Medicamentos
- Lançamento de Inventário Inicial
- Geração de Arquivo SNGPC
- Livro de Registro Específico P. 344/98
- Balanço de Medicamentos
- Relação Mensal de Notificação Receita
- Ficha de Estoque
- Log de Eventos e Usuários

Nome*

PRESCRITOR FICTÍCIO

1 **Estado CR***

CEARÁ

Número CR*

00000

2 **Tipo CR***

CRM - Medicina

COREN - Enfermagem
CRM - Medicina
CRMV - Veterinária
CRO - Odontologia
RMS - Registro MS

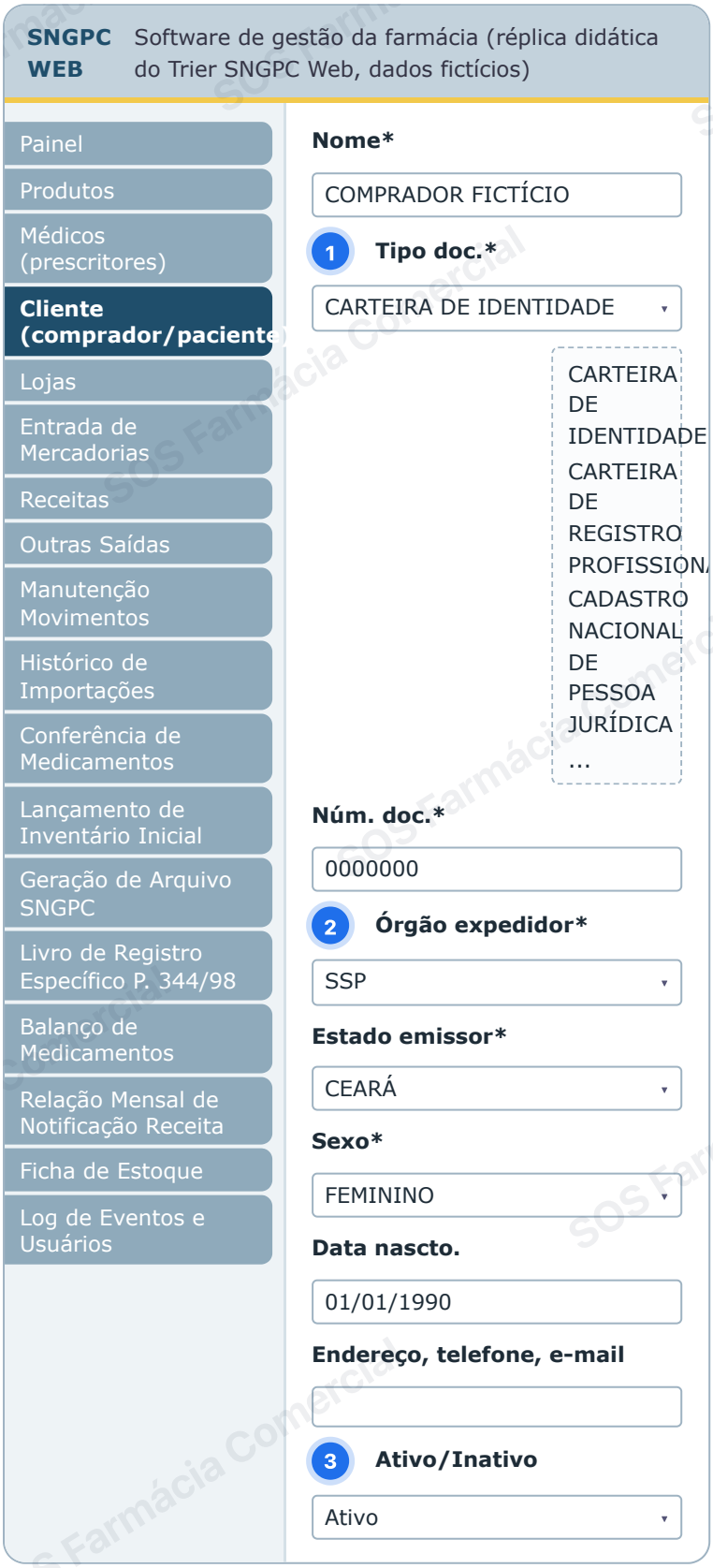
Salvar [F2] Limpar [F5]

Excluir [F6]

Cadastros > Médicos

Cadastro de quem prescreve. O nome da tela diz médicos, mas o campo Tipo CR aceita outros conselhos.

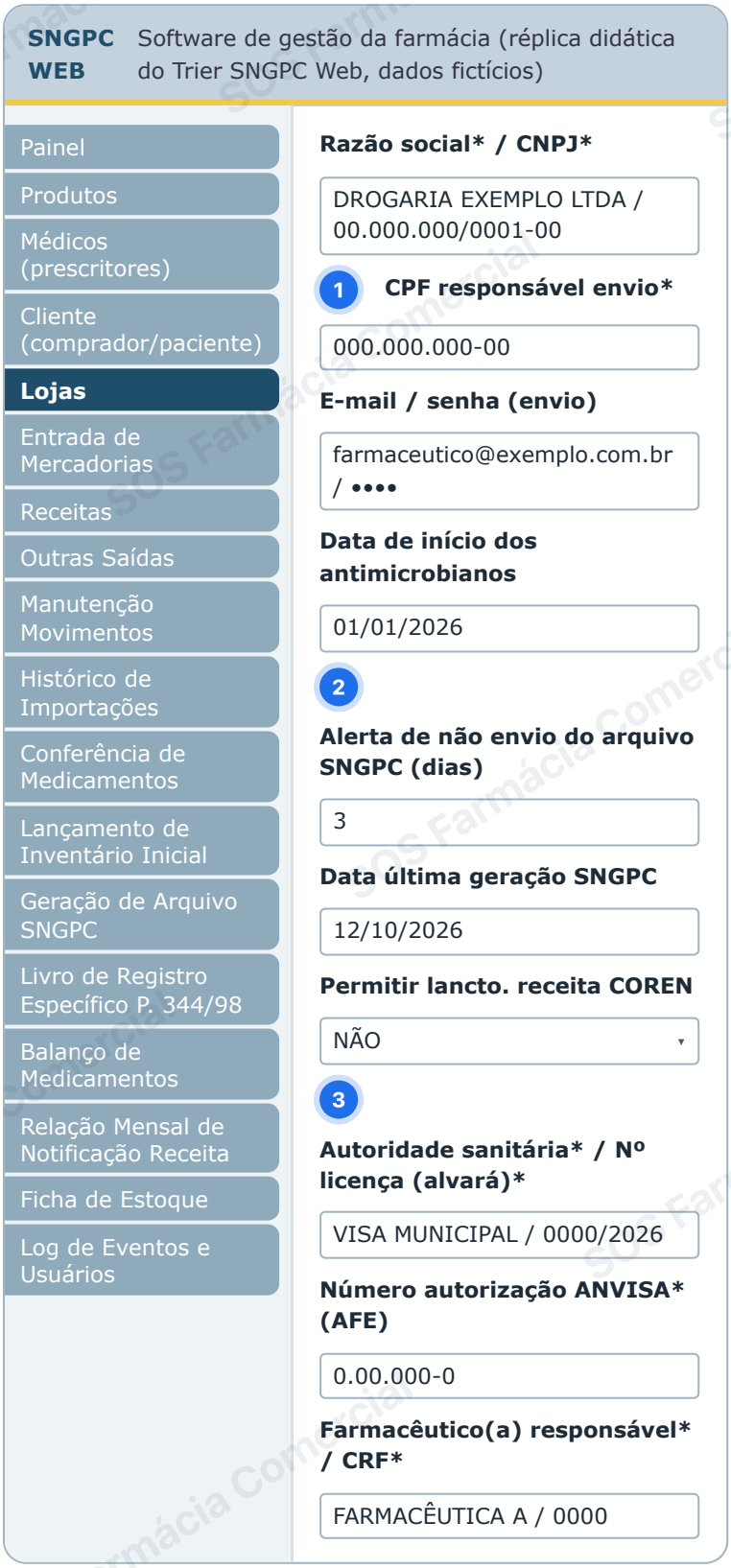
1. UF e número do conselho, como estão na receita. Prescritor cadastrado com UF ou número errado é causa comum de recusa ou de achado na fiscalização.
2. Tipo de conselho: CRM, CRO, CRMV, COREN ou RMS. Neste software, em outubro de 2026, a tela de geração avisava que receitas com prescritor COREN ainda não estavam sendo enviadas à Anvisa, à espera de confirmação da agência.



Cadastros > Cliente (comprador/paciente)

Comprador e paciente são cadastrados aqui e escolhidos na receita. O documento do comprador é obrigatório nas dispensações que exigem identificação.

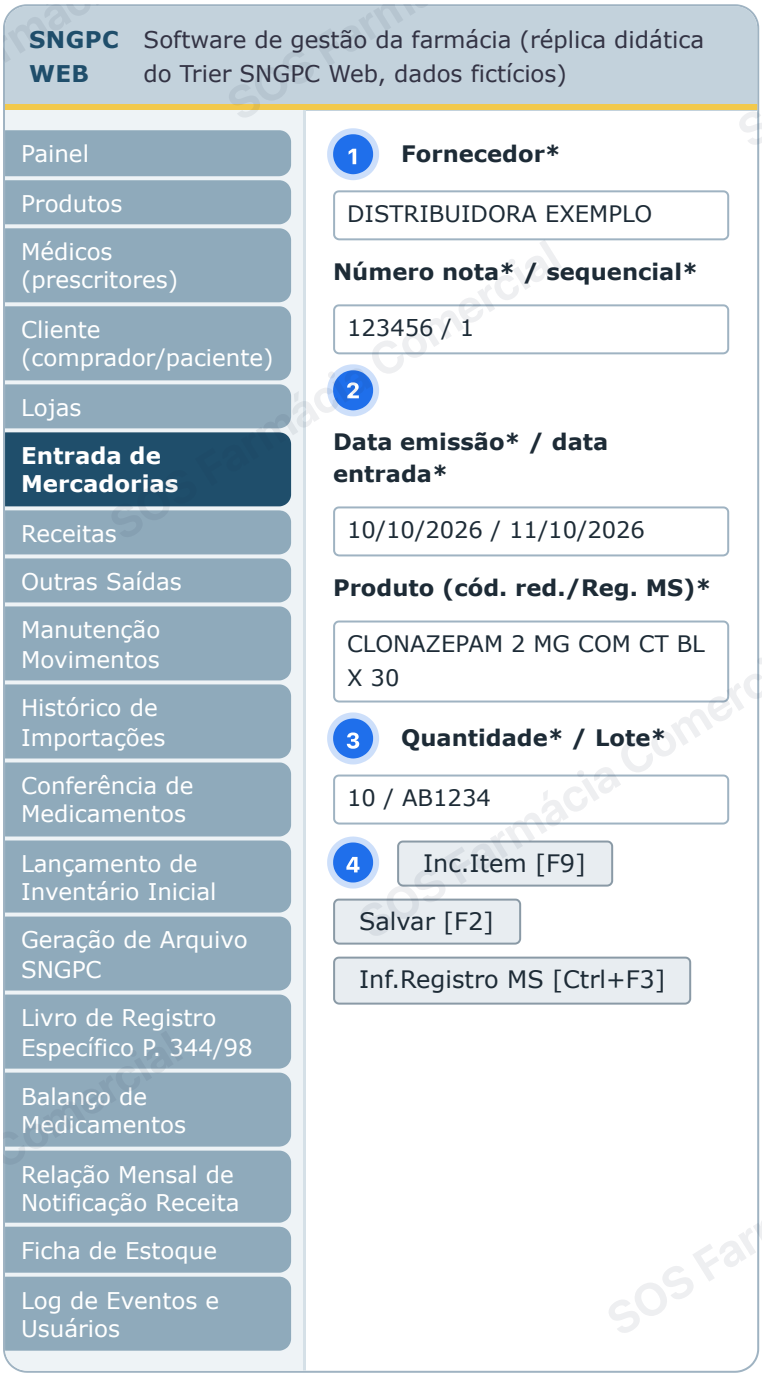
1. Tipo e número do documento de quem compra, como no documento apresentado no balcão.
2. Órgão e UF que emitiram o documento.
3. Cliente inativo não aparece para novas receitas, mas o histórico permanece. Dados pessoais exigem o cuidado da LGPD: só quem precisa acessa.



Cadastros > Lojas

Dados do estabelecimento e do envio. Aqui ficam o responsável pelo envio, a autorização da Anvisa, o farmacêutico responsável e o alerta de atraso.

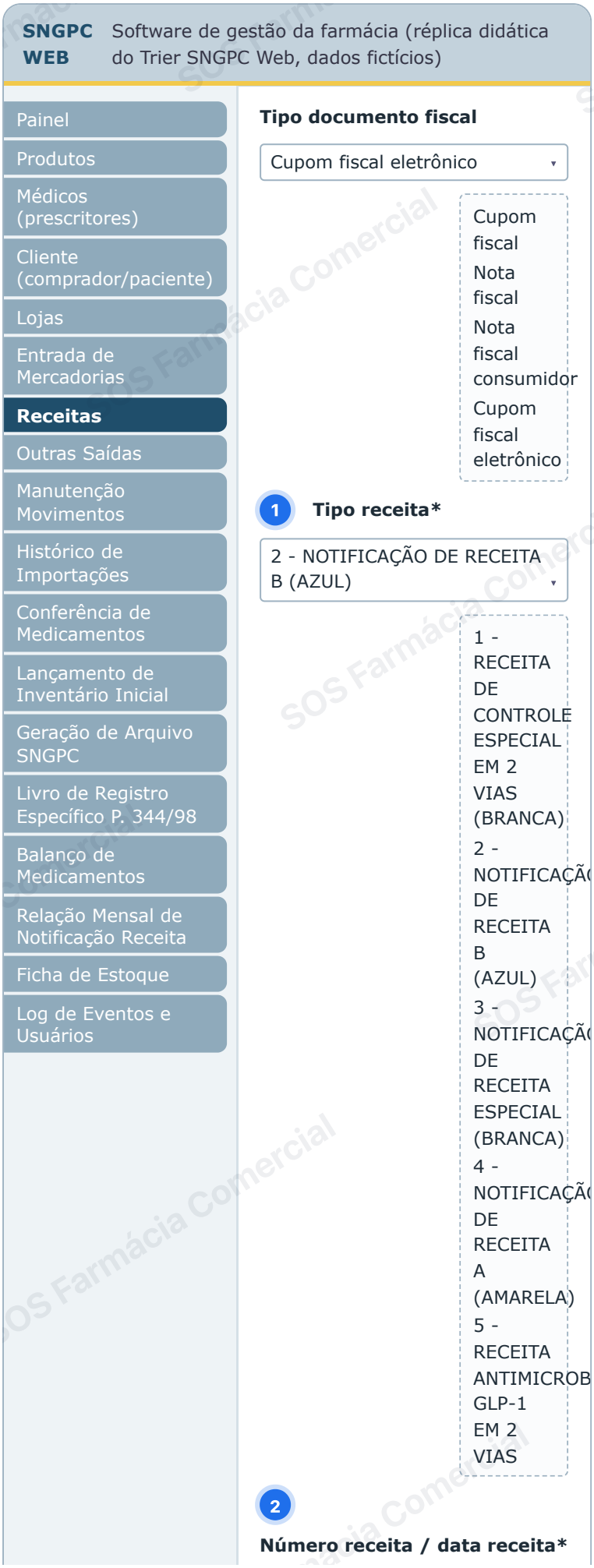
1. CPF, e-mail e senha de quem transmite: o envio sai em nome desse farmacêutico. Na troca de RT, atualize aqui junto com o SNGPC da Anvisa.
2. Número de dias sem gerar arquivo que dispara aviso no sistema. Coloque um valor menor que o prazo legal para ter folga.
3. Licença sanitária, AFE e farmacêutico responsável saem nos termos dos livros, no balanço e no inventário. Dados vencidos aparecem impressos.



Lançamentos > Entrada de Mercadorias

Toda compra de controlado entra aqui, pela nota fiscal, item a item, com lote.

1. Fornecedor com CNPJ, como na nota.
2. Data da nota e data em que a mercadoria entrou. A entrada vale a partir da data de entrada: saída de um lote antes da entrada dele gera estoque negativo e recusa.
3. Quantidade na unidade SNGPC do produto (caixas ou frascos) e lote exatamente como na caixa e na nota.
4. Inclua cada item e salve a nota. O registro MS enviado para a Anvisa aparece abaixo do item para conferência.



Lançamentos > Receitas

A dispensação de controlado. Em muitas lojas a venda vem do caixa por importação e o farmacêutico completa os dados aqui.

1. O tipo de receita tem de bater com a lista do produto: B1 com notificação azul, C1 com receita de controle especial, antimicrobiano ou GLP-1 com receita em 2 vias. Tipo errado é erro de escrituração.
2. Número da notificação (no SNCR, conforme a regra vigente de lançamento) e data de emissão da receita. A data de emissão também mostra se a receita estava no prazo de validade.
3. Conselho e prescritor, escolhidos no cadastro.
4. Quem comprou, com documento. Pode ser diferente do paciente.
5. Paciente, sexo e idade; o sistema pede também CID.
6. Uso prolongado marca tratamento contínuo, que tem regras próprias de quantidade e validade.
7. Quantidade vendida e quantidade prescrita separadas: quando a farmácia dispensa menos do que foi prescrito, as duas ficam registradas.
8. Lotes com saldo mostra só os lotes que existem em estoque: use para não vender lote inexistente. Salve o item e depois a receita.

0000000000 / 09/10/2026

Uso medicamento*

HUMANO

HUMANO
VETERINÁRIO

3

Prescritor (CR)* / médico*

CRM / PRESCRITOR FICTÍCIO

4

Comprador* + documento*

COMPRADOR FICTÍCIO / RG 0000000 SSP CE

5

Paciente* / sexo* / idade*

PACIENTE FICTÍCIO / F / 34 ANOS

CID*

F41.1

6

Produto* / uso prolongado*

CLONAZEPAM 2 MG / NÃO

7

Qtd. vendida* / qtd. prescrita*

2 / 2

Lote*

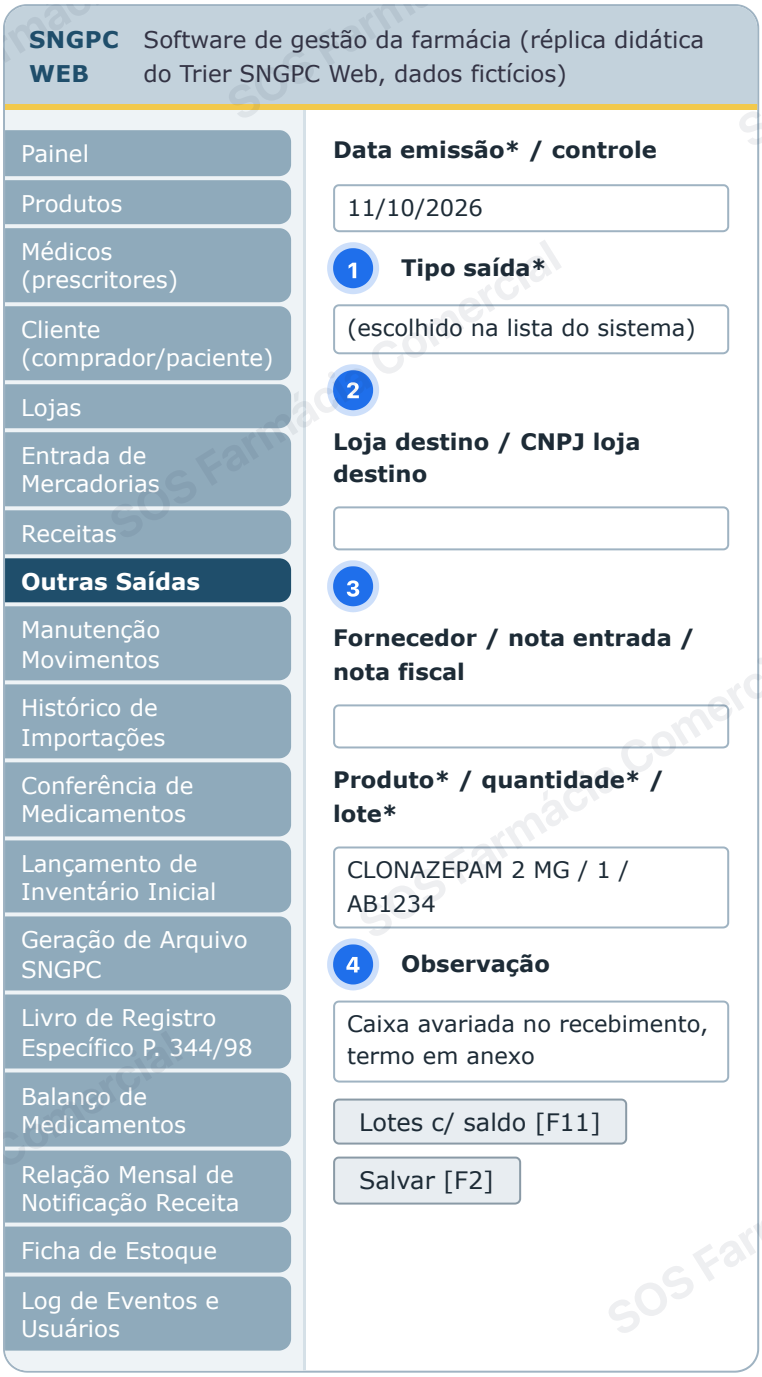
AB1234

8 Lotes c/ saldo [F11]

Salvar item [Ctrl+F2]

Salvar receita [F2]

SOS Farmácia Comercial



Lançamentos > Outras Saídas

Toda saída que não é dispensação: perdas, transferências entre lojas da mesma rede e devoluções.

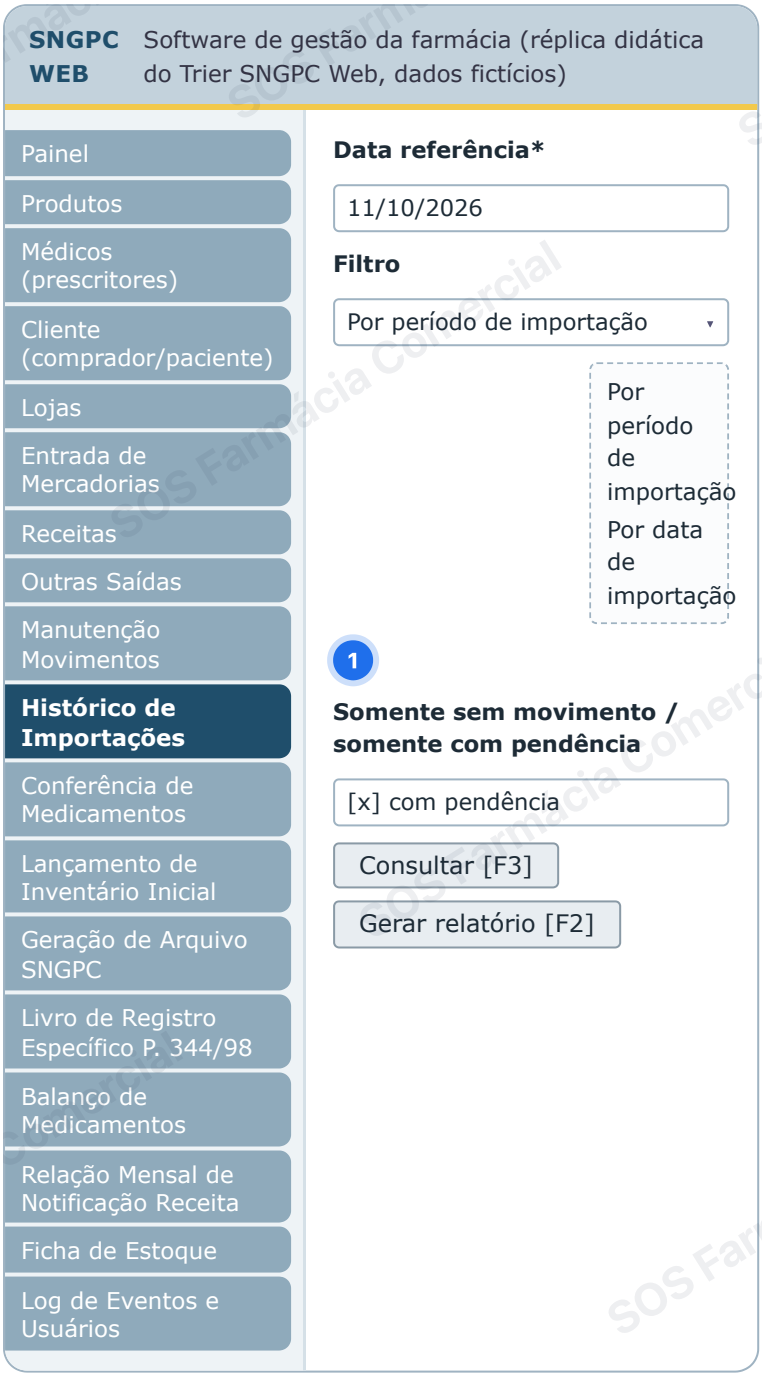
1. O tipo de saída vem de uma lista do sistema que segue os motivos aceitos pela Anvisa (perdas por vencimento, avaria, furto ou roubo, recolhimento, apreensão pela VISA e outros; transferência; devolução).
2. Na transferência, informe a loja de destino (mesma raiz de CNPJ).
3. Na devolução ao fornecedor, informe fornecedor e nota.
4. Descreva o fato e guarde o documento (boletim de ocorrência no furto, termo de inutilização no vencimento).

SOS Farmácia Comercial

Lançamentos > Manutenção Movimentos

Corrige movimentos já lançados de um produto, filtrando por período e lote.

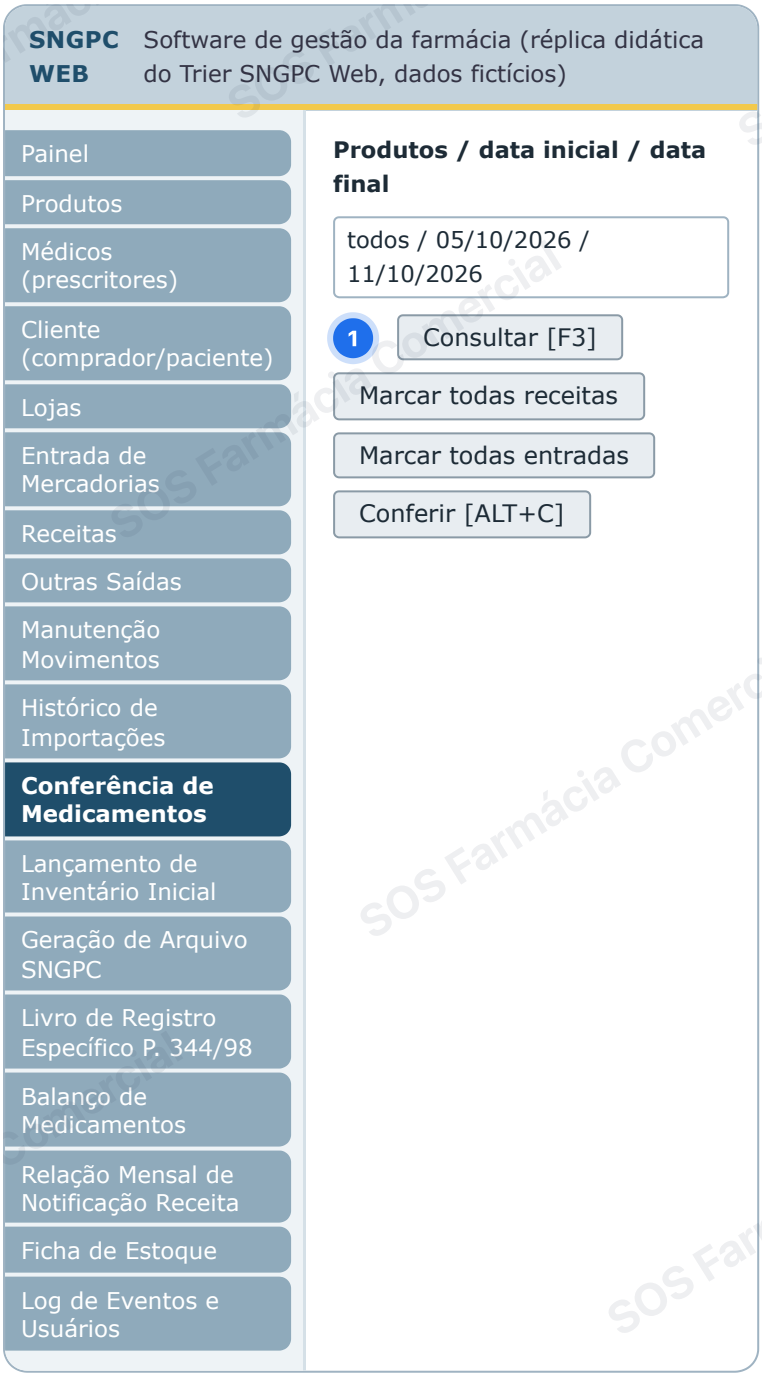
1. Use para corrigir data, número da receita, quantidade, lote ou registro de um movimento lançado errado.
2. Corrigir aqui só muda a Anvisa quando o período for transmitido. Se o período já foi aceito, a correção precisa seguir a orientação do fornecedor do software e, se for o caso, da VISA (ajuste de inventário).



SNGPC > Histórico de Importações

Mostra as vendas que vieram do sistema de caixa da loja e se ficaram pendentes.

1. Venda de controlado que entrou pelo caixa sem todos os dados de receita fica pendente e não vai no arquivo. Confira as pendências todo dia antes de gerar o arquivo.

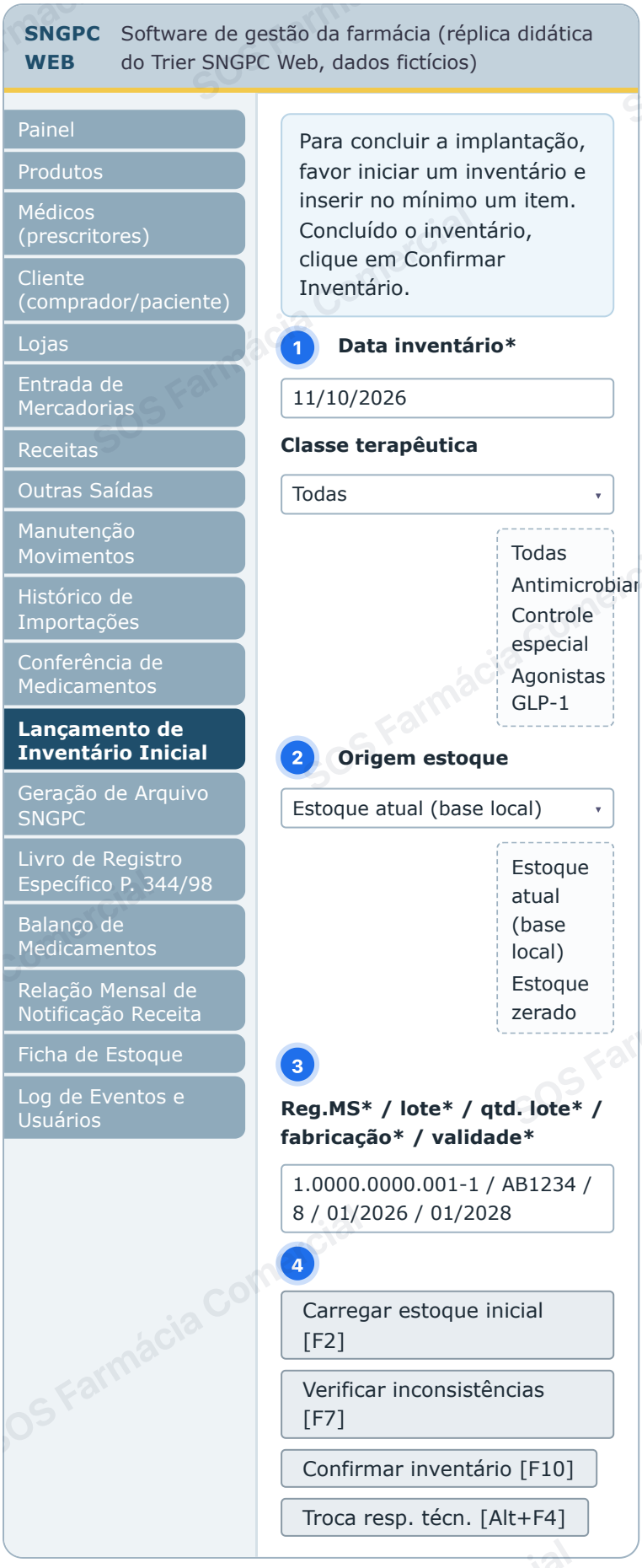


Cadastros > Conferência de Medicamentos

O farmacêutico marca as receitas e entradas que conferiu contra o papel.

1. Confira cada receita do período com a via retida (tipo, número, prescritor, quantidade, lote) e cada entrada com a nota. Marcar sem olhar o papel anula o propósito da conferência.

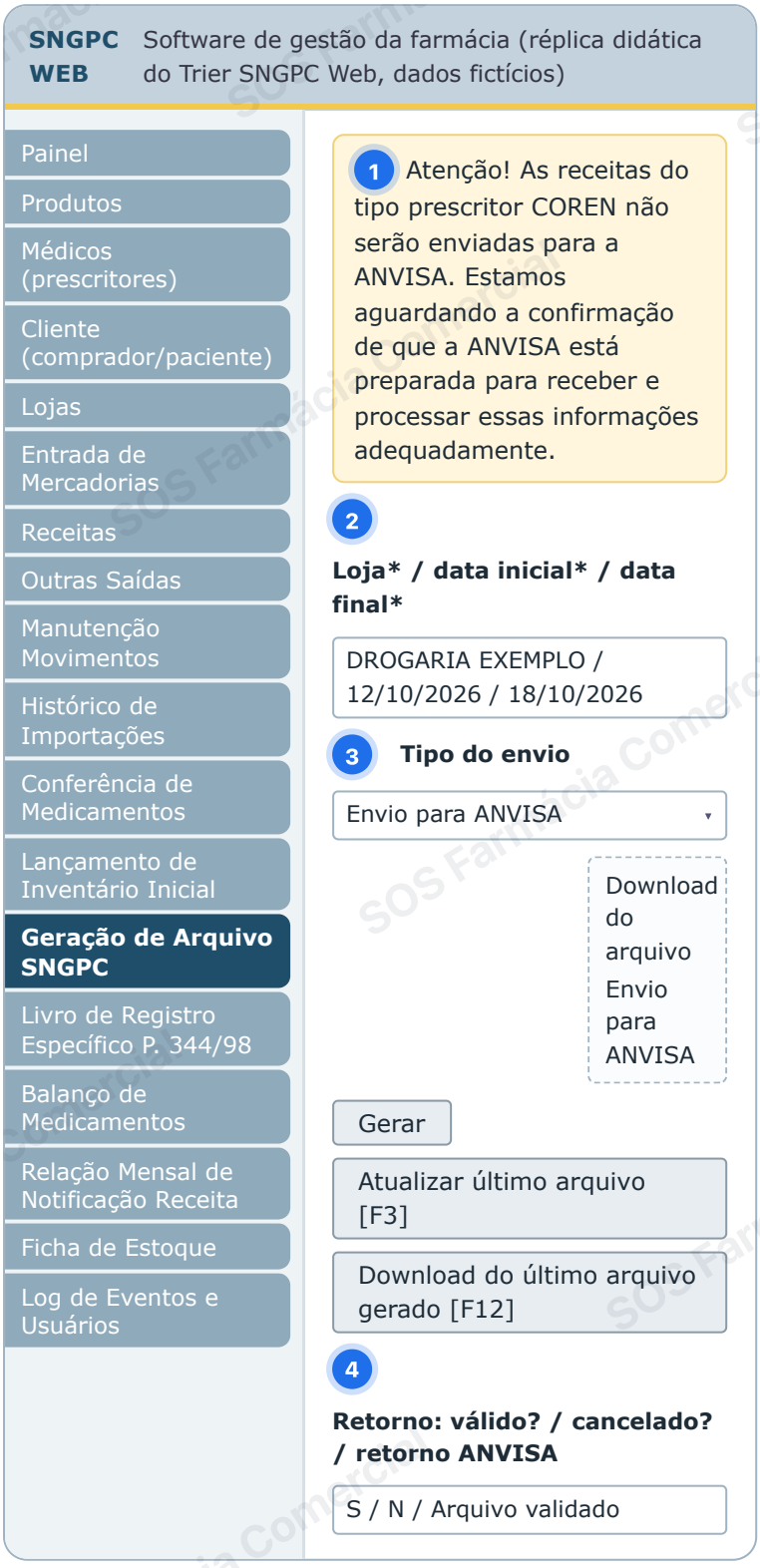
SOS Farmácia Comercial



SNGPC > Lançamento de Inventário Inicial

Monta o inventário que vai para a Anvisa: ao assumir a loja, ao trocar de RT ou num ajuste.

1. Data da contagem física.
2. Partir do estoque do sistema poupa digitação, mas cada lote tem de ser conferido contra a contagem real; partir do zero obriga a lançar tudo.
3. Cada lote com quantidade, fabricação e validade. O que não estiver na gaveta não entra.
4. Verifique inconsistências antes de confirmar. A troca de responsável técnico também começa aqui. Depois de confirmado, o inventário segue para a Anvisa, onde é confirmado de novo no site.

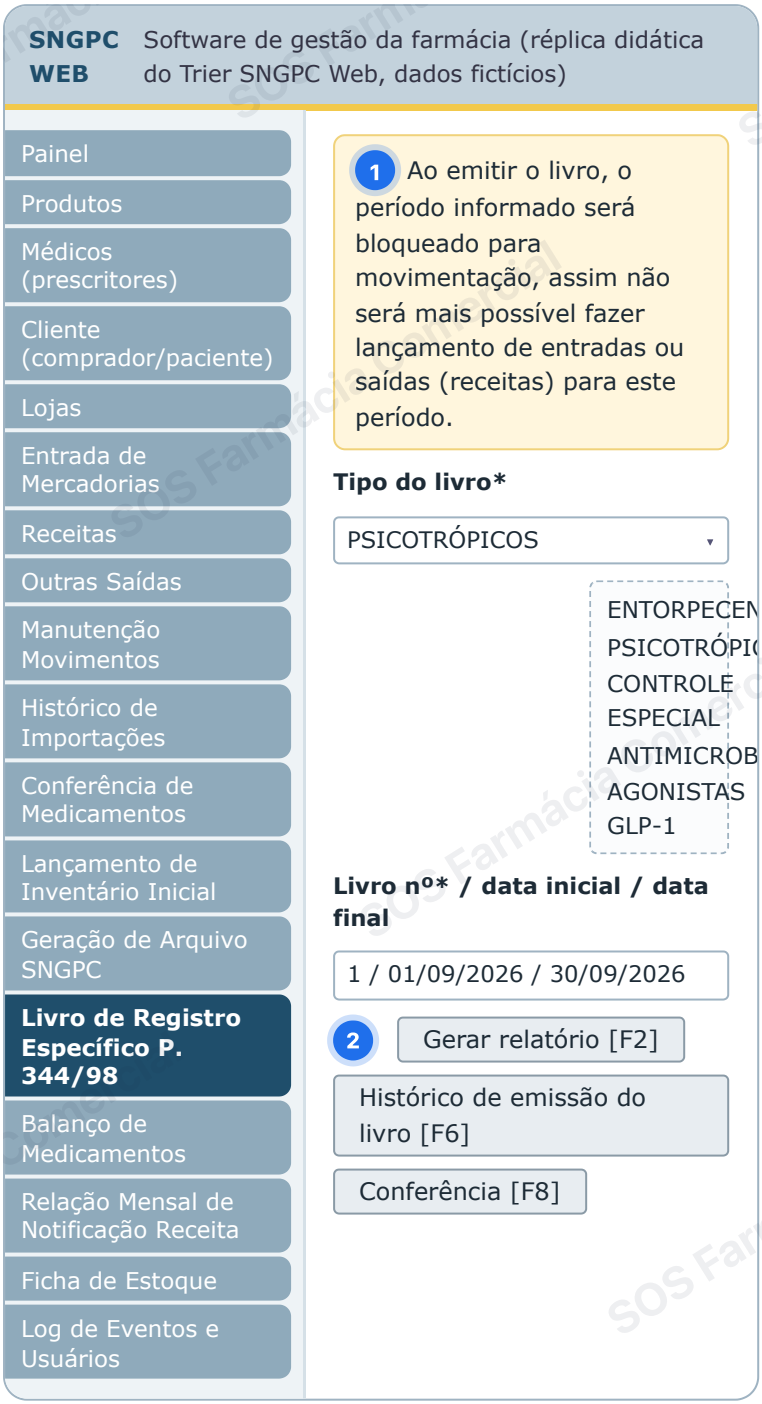


SNGPC > Geração de Arquivo SNGPC

Gera o XML do período e envia à Anvisa ou baixa o arquivo para envio manual.

1. Aviso do próprio software em outubro de 2026. Leia os avisos da tela: eles mudam com as regras.
2. O período começa no dia seguinte ao fim do último arquivo aceito. Sem buraco, sem sobreposição.
3. Envio para ANVISA transmite direto. Download gera o ZIP para enviar no site do SNGPC (Transmissão de arquivos).
4. O retorno mostra se a Anvisa validou. Confira também no painel e, se quiser, no Status de Transmissão do site da Anvisa pelo hash.

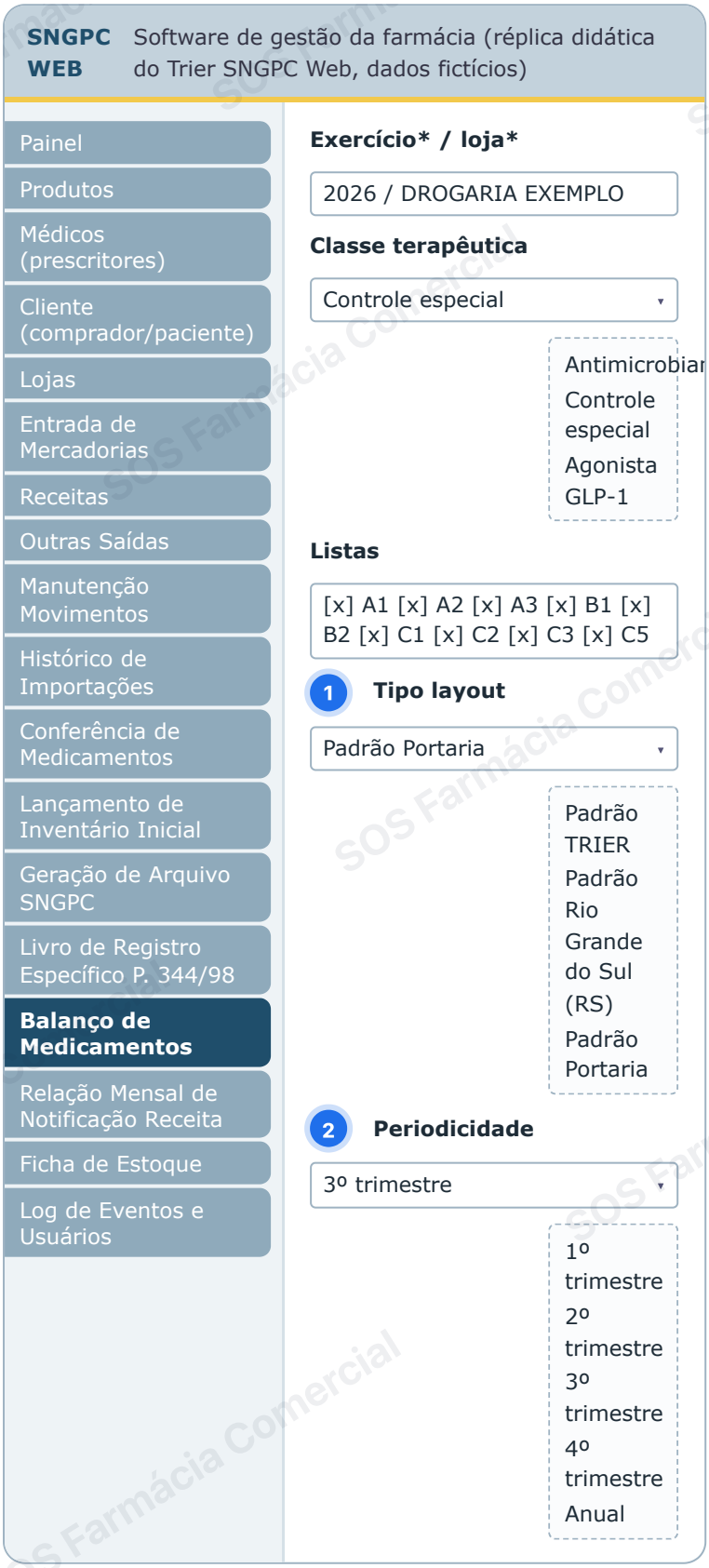
SOS Farmácia Comercial



Relatórios > Livro de Registro Específico P. 344/98

Emite o livro de registro por tipo (entorpecentes, psicotrópicos, controle especial, antimicrobiano, GLP-1).

1. Emitir o livro fecha o período no software. Só emita depois de conferir tudo.
2. Use a conferência antes; o histórico mostra o que já foi emitido.

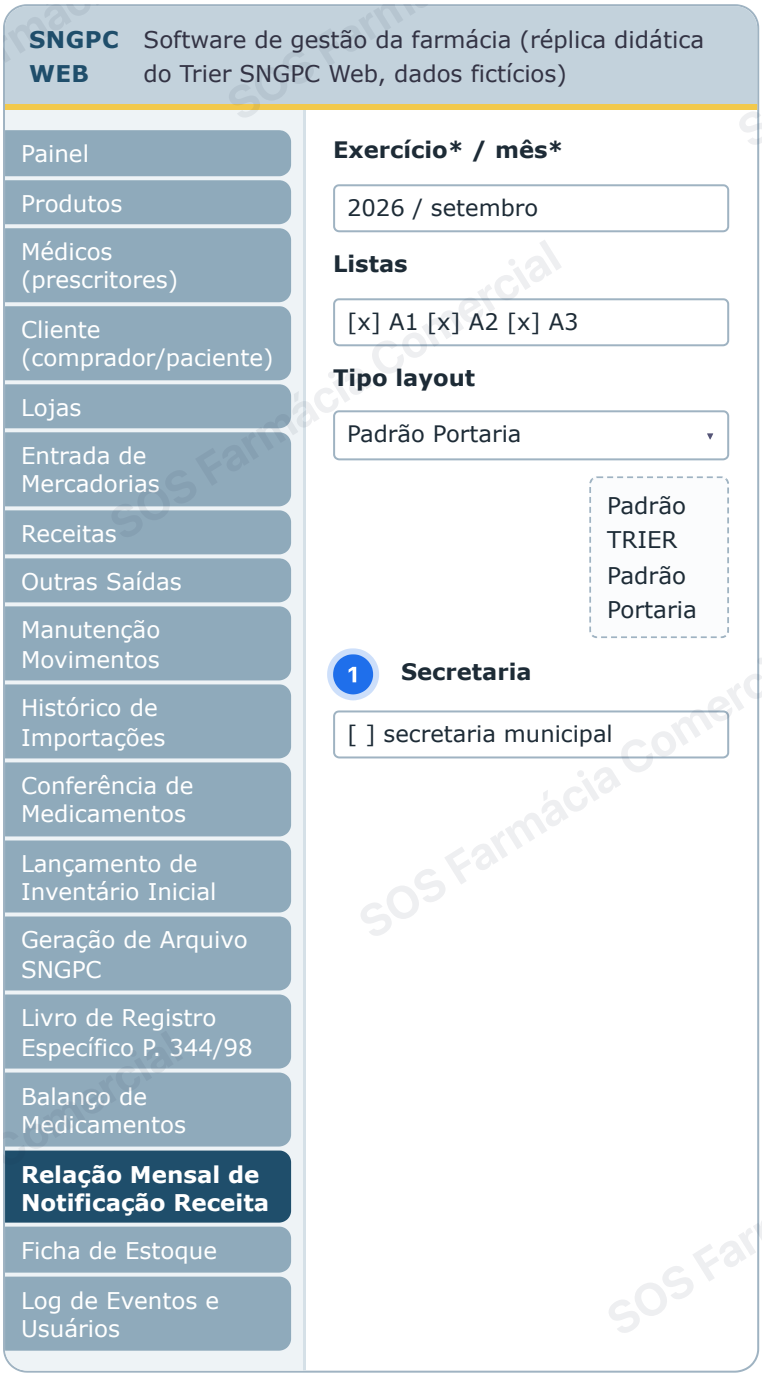


Relatórios > Balanço de Medicamentos

Gera o balanço por classe e lista, trimestral ou anual, no layout escolhido.

1. Escolha o layout que a sua vigilância aceita.
2. Periodicidade trimestral ou anual, conforme a exigência para cada lista.

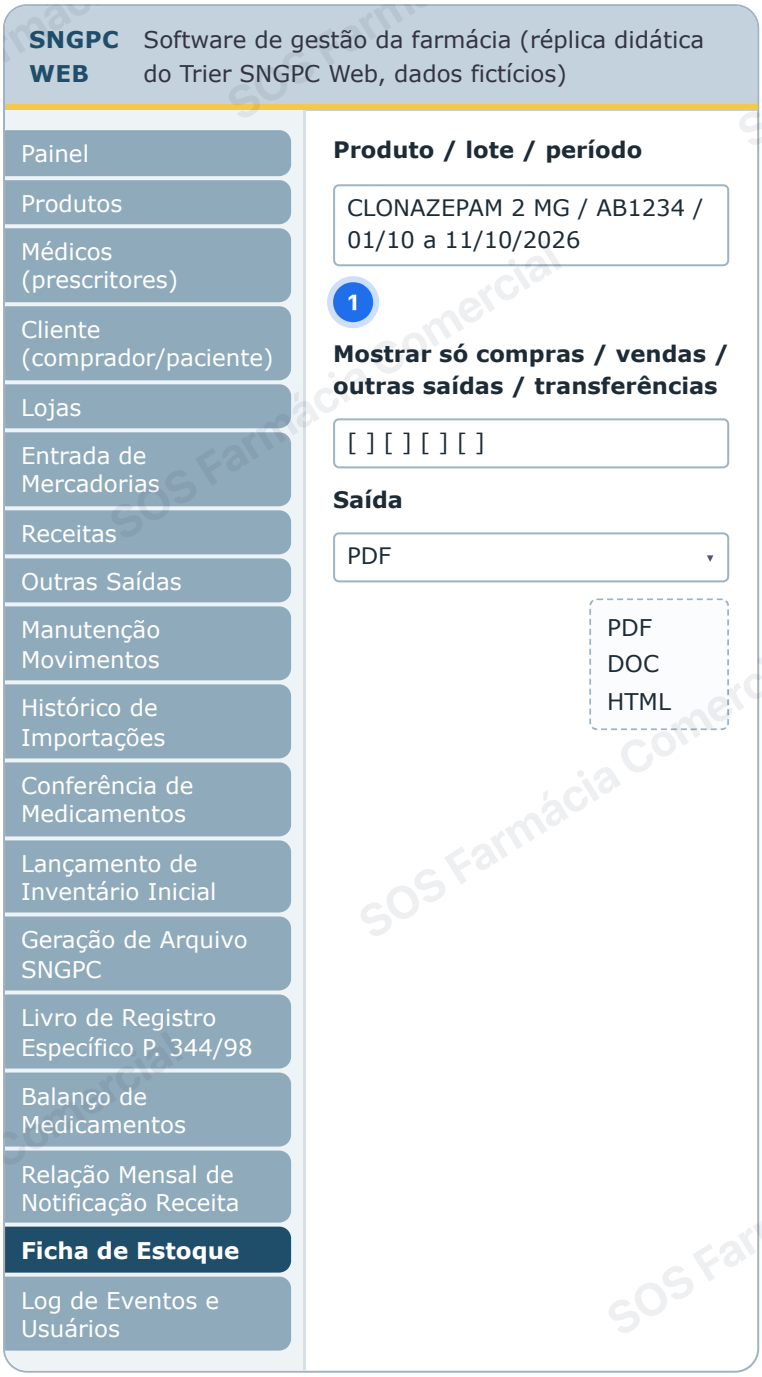
SOS Farmácia Comercial



Relatórios > Relação Mensal de Notificação Receita

Relação mensal das notificações de receita para a vigilância.

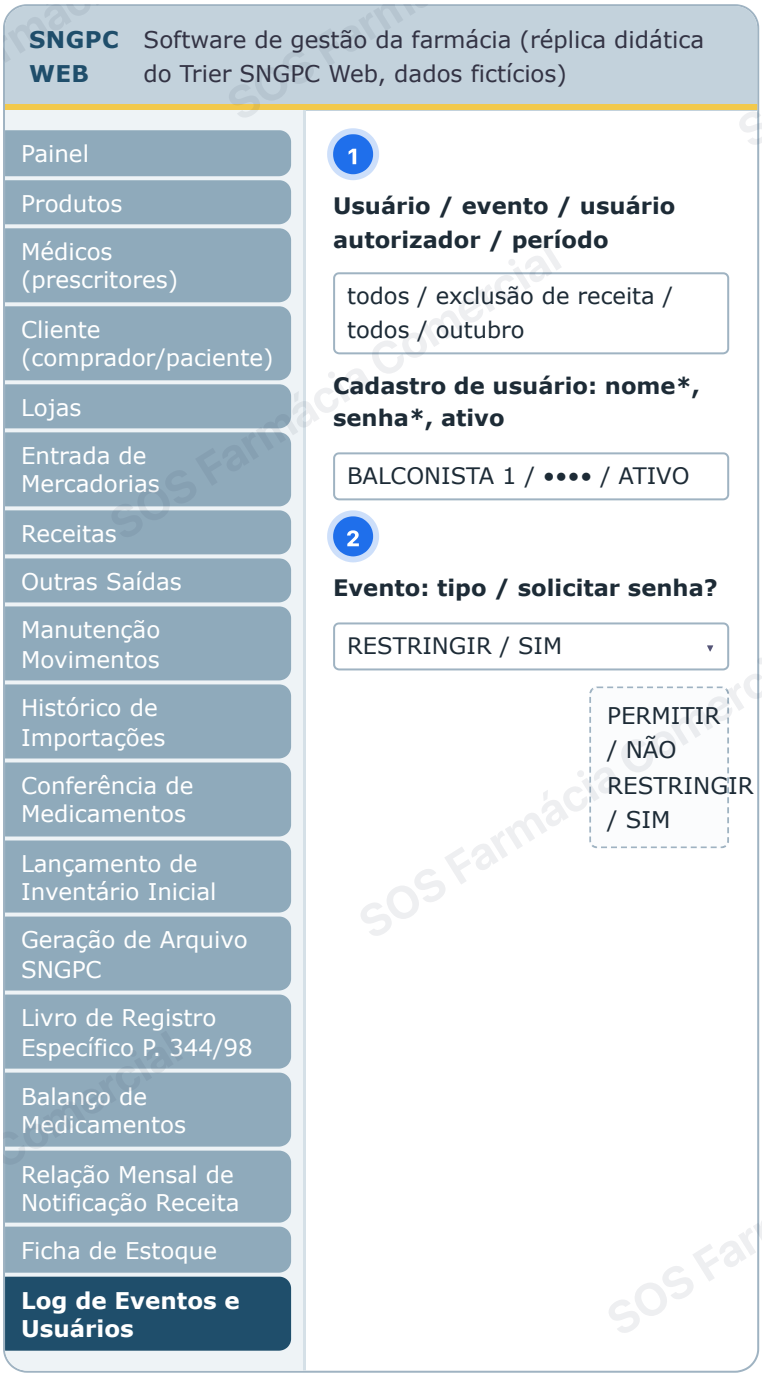
1. Marque a secretaria que recebe a relação na sua cidade e entregue no prazo que a VISA fixar.



Relatórios > Ficha de Estoque

Extrato de um produto por data e lote: o mesmo papel do Histórico de Movimentações da Anvisa, do lado do software.

1. Compare a ficha do software com o Histórico de Movimentações do SNGPC: a primeira diferença mostra onde está o lançamento que não foi ou foi errado. Saldo Estoque e Conferência completam a investigação.



Relatórios > Log de Eventos / Diversos > Usuários

Quem fez o quê. Cada pessoa com acesso tem usuário próprio e permissões por evento.

1. O log registra cada evento com o usuário e quem autorizou. Útil quando aparece uma exclusão ou alteração que ninguém lembra.
2. Restrinja eventos sensíveis (excluir receita, alterar movimento, gerar arquivo) ou exija senha do farmacêutico. Balconista não precisa poder apagar receita.

SOS Farmácia Comercial

Uma venda de clonazepam, do balcão à Anvisa

Cliente entrega a notificação B (azul) e o documento

Farmacêutico confere a receita (prazo, dados, quantidade) e o documento do comprador

DECISÃO

A receita está correta?

SIM
Seguir para a venda

NÃO
Não dispensar; orientar o paciente a voltar ao prescritor

Caixa registra a venda escolhendo um lote com saldo

No software: Receitas com tipo 2 (notificação B), número, data, prescritor, comprador, paciente, quantidade vendida e prescrita, lote

DECISÃO

Ficou pendência em Histórico de importações?

SIM
Completar os dados antes de gerar o arquivo

NÃO
Seguir

Conferência de medicamentos: receita marcada como conferida contra a via retida

Geração de arquivo SNGPC do período seguinte ao último aceito, Envio para ANVISA

DECISÃO

Status S no painel e Foi aceito? SIM no site da Anvisa?

SIM
Guardar a notificação retida e seguir a rotina

NÃO
Ler o retorno, corrigir em Manutenção de movimentos e reenviar o mesmo período

Venda escriturada e transmitida

Mesma tarefa, duas telas: software de gestão e site da Anvisa

Tarefa	No software (exemplo Trier)	No site do SNGPC
Lançar compra	Lançamentos > Entrada de Mercadorias	Não existe: chega pelo arquivo
Lançar dispensação	Lançamentos > Receitas	Não existe: chega pelo arquivo
Lançar perda, transferência, devolução	Lançamentos > Outras Saídas	Não existe: chega pelo arquivo
Corrigir um movimento	Lançamentos > Manutenção Movimentos	Não existe: reenviar o período ou ajuste de inventário
Montar o inventário	SNGPC > Lançamento de Inventário Inicial	Inventário Inicial (conferir e confirmar)
Enviar	SNGPC > Geração de Arquivo (Envio para ANVISA)	Transmissão de arquivos (ZIP), se for manual
Ver se foi aceito	Painel (status S) e Geração de Arquivo (retorno)	Relatórios > Status de Transmissão
Extrato do produto	Relatórios > Ficha de Estoque	Relatórios > Histórico de Movimentações
Estoque atual	Relatórios > Saldo Estoque	Visualizar Inventário
Trocar de RT	Inventário Inicial > Troca resp. técn.; Lojas	Finalizar Inventário; vínculo do novo RT

Cartões: o software de gestão

Pergunta	Resposta
Onde se lança a compra de controlado no software?	Lançamentos > Entrada de Mercadorias, com lote
Onde se lança a dispensação?	Lançamentos > Receitas
Onde se lança perda, transferência ou devolução?	Lançamentos > Outras Saídas
Unidade SNGPC de um comprimido	Caixa (líquidos: frasco)
Por que separar quantidade vendida e prescrita?	Registra a dispensação menor que a prescrição

Pergunta	Resposta
Onde ver vendas do caixa com dados faltando?	SNGPC > Histórico de Importações (com pendência)
Envio para ANVISA × Download do arquivo	Transmite direto × gera o ZIP para enviar no site
O que acontece ao emitir o livro de registro?	O período fica bloqueado para lançamentos
Como casar o arquivo do software com o da Anvisa?	Pelo hash
Quem deve poder excluir receita?	Só o farmacêutico, com senha (Usuários > eventos)

Questões: o software de gestão

1. No cadastro de um comprimido controlado, a farmacêutica escolhe a unidade SNGPC. Qual escolha é coerente?

A Frascos, porque é a unidade padrão do sistema

B Caixas, e a quantidade é lançada em número de caixas

C Comprimidos, porque a receita prescreve comprimidos

D Miligramas, porque a Anvisa controla a substância

E Qualquer uma, desde que seja sempre a mesma

2. Ao lançar uma notificação azul de alprazolam em Receitas, qual tipo de receita deve ser escolhido?

A 1 - Receita de controle especial em 2 vias

B 3 - Notificação de receita especial (branca)

C 4 - Notificação de receita A (amarela)

D 2 - Notificação de receita B (azul)

E 5 - Receita de antimicrobianos/agonistas GLP-1 em 2 vias

3. O software avisa que, ao emitir o livro de registro específico, o período será bloqueado. O que isso significa na prática?

A O período fica oculto do arquivo da Anvisa

B As receitas do período são apagadas do sistema

C Não será mais possível lançar entradas ou saídas naquele período

D O livro passa a ser enviado à Anvisa no lugar do XML

E O inventário é finalizado automaticamente

4. Uma venda de clonazepam entrou pelo caixa sem o número da notificação. Onde a farmacêutica percebe isso antes de gerar o arquivo?

A. No Histórico de Importações, filtrando as vendas com pendência
B. No Balanço de Medicamentos anual
C. No cadastro de Laboratórios
D. Na Relação Mensal de Notificação de Receita do ano anterior
E. Apenas no site da Anvisa, depois da recusa

5. Qual configuração de usuários reduz o risco de alteração indevida da escrituração?

A. Um único usuário com a senha do farmacêutico para toda a equipe
B. Restringir aos farmacêuticos eventos como excluir receita e alterar movimento, com senha
C. Permitir todos os eventos a todos e consultar o log uma vez por ano
D. Desativar o log de eventos para não pesar o sistema
E. Deixar o balconista gerar o arquivo e o farmacêutico só assinar o livro

Gabarito comentado

1. **B**. No software o produto é escriturado por embalagem: caixas para formas sólidas e frascos para líquidos. A quantidade de cada lançamento segue essa unidade. Comprimidos ou miligramas não são opções da tela.
2. **D**. Alprazolam é da lista B1, dispensado com notificação B (azul). O tipo de receita lançado tem de corresponder à lista do produto; a receita branca em duas vias é da lista C1, a amarela da A e a especial branca de retinoides e talidomida.
3. **C**. A emissão do livro trava o período para novos lançamentos, justamente para que o livro impresso não fique diferente da escrituração. Por isso o livro só deve ser emitido depois da conferência.
4. **A**. As vendas importadas do caixa com dados incompletos aparecem como pendentes no Histórico de Importações. Resolver ali, antes de gerar o arquivo, evita atraso e recusa.
5. **B**. Cada pessoa com usuário próprio e eventos sensíveis restritos ou com senha do farmacêutico. O log de eventos mostra quem fez cada ação e quem autorizou; senha compartilhada apaga essa rastreabilidade.

Módulo 11

Serviços clínicos na farmácia comercial

O que o farmacêutico da drogaria pode fazer na sala de serviços e como fazer: base legal, consulta e documentação (Declaração de Serviço Farmacêutico, encaminhamento, LGPD), aferição de pressão arterial e temperatura, glicemia capilar e outros exames do Serviço Tipo I, testes rápidos, injetáveis, vacinação, perfuração de lóbulo, revisão da farmacoterapia, adesão, dispositivos e biossegurança. Normas centrais: Lei 13.021/2014, RDC 44/2009, RDC 978/2025 (alterada pela RDC 986/2025), RDC 197/2017, Resoluções CFF 585/2013 e 499/2008; valores pela DBHA 2025, SBD (edição 2026) e guia de febre do CFF (2018).

- Base legal e catálogo de serviços
- Consulta farmacêutica, registro e documentos
- Aferição da pressão arterial
- Glicemia capilar
- Exames de análises clínicas e testes rápidos
- Temperatura, rastreamento e campanhas
- Administração de medicamentos, vacinação e perfuração de lóbulo
- Revisão da farmacoterapia, adesão e uso de dispositivos
- Biossegurança, resíduos e sala de serviços

Base legal e catálogo de serviços

Na drogaria, serviço clínico é o atendimento em que o farmacêutico avalia a pessoa e decide algo sobre a saúde dela, além de entregar um produto: medir a pressão, fazer uma glicemia capilar, aplicar um injetável, revisar a lista de remédios de um idoso, ensinar o uso da caneta de insulina. A Lei 13.021/2014 deu a base para isso ao definir a farmácia como "unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva" (art. 3º). Antes de oferecer qualquer serviço, duas condições precisam estar cumpridas: a norma sanitária permite aquele serviço e a licença da farmácia onde você trabalha o inclui.

Três camadas de norma

- **Lei federal**: a Lei 13.021/2014 permite que a farmácia disponha de vacinas e soros conforme o perfil epidemiológico da região (art. 7º) e obriga o farmacêutico a notificar reações adversas e intoxicações, fazer acompanhamento farmacoterapêutico, manter o perfil farmacoterapêutico do paciente em fichas e prestar orientação sobre uso, conservação e interações (art. 13).
- **Norma sanitária**: define o que o estabelecimento pode fazer e com que estrutura. As centrais são a RDC 44/2009 (serviços, ambiente e Declaração de Serviço Farmacêutico), a RDC 978/2025, alterada pela RDC 986/2025 (exames de análises clínicas), a RDC 197/2017 (vacinação) e a RDC 222/2018 (resíduos).
- **Norma profissional**: define o que o farmacêutico pode fazer como profissional. Resolução CFF 585/2013 (atribuições clínicas), 586/2013 (prescrição, com situação judicial própria), 499/2008 (serviços em farmácias e drogarias) e 654/2018 (vacinação).

Na inspeção, quem decide se o serviço é regular é a vigilância sanitária, com base na RDC e nas normas estaduais e municipais. Uma resolução do CFF organiza a prática do farmacêutico, mas não dá à farmácia permissão para um serviço que a RDC 44/2009 não prevê.

O que a RDC 44/2009 permite

O QUE DIZ A NORMA

"São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em farmácias ou drogarias a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para colocação de brincos." "A prestação de serviço de atenção farmacêutica compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, a execução de Exames de Análises Clínicas nos termos da legislação vigente e a administração de medicamentos." (RDC 44/2009, art. 61, §§ 1º e 2º, este com redação da RDC 786/2023)

A RDC 786/2023 foi revogada pela RDC 978/2025 (art. 193), mas as mudanças que ela fez no texto da RDC 44/2009 continuam no texto consolidado publicado no AnvisaLegis, que segue citando a redação de 2023. Os parâmetros fisiológicos permitidos são apenas dois: **pressão arterial e temperatura corporal** (art. 69, §1º). Exames, como a glicemia capilar, seguem a RDC 978/2025.

Regras gerais que valem para todos os serviços:

- só é regular o serviço indicado no licenciamento do estabelecimento, e é vedado usar qualquer dependência da farmácia como consultório ou para fim diverso do licenciado (art. 61, §3º; art. 90);
- o serviço é permitido pela autoridade sanitária após inspeção prévia, sem prejuízo de normas estaduais e municipais (art. 61, §4º), e é vedado prestar serviço não abrangido pela Resolução (art. 61, §5º);
- a farmácia mantém lista atualizada dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos, com endereço e telefone, para informar o usuário (art. 62);
- há protocolos com referências bibliográficas e indicadores (art. 64), registro que permita avaliar os resultados e POP com a metodologia dessa avaliação (art. 65);
- o farmacêutico orienta o usuário a procurar outro profissional quando julgar necessário (art. 66) e notifica eventos adversos e queixas técnicas (art. 67);
- atenção farmacêutica no domicílio só é permitida a estabelecimento licenciado para isso (art. 68, parágrafo único).

A Resolução CFF 499/2008 acrescenta a regra profissional: somente o farmacêutico inscrito no CRF presta serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias (art. 1º). Para injetáveis, admite outro profissional habilitado com autorização expressa do farmacêutico responsável técnico, e a presença ou supervisão do farmacêutico é condição essencial (art. 21).

Atribuições clínicas do farmacêutico

A Resolução CFF 585/2013 lista 28 atribuições clínicas no art. 7º. As que aparecem todo dia na drogaria são: prover a consulta farmacêutica em ambiente que garanta privacidade (VII); fazer a anamnese e verificar sinais e sintomas (VIII); determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos para acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em saúde (XIV); administrar medicamentos no âmbito da competência profissional (XXI); orientar quanto à administração de formas farmacêuticas (XXII); manejar problemas de saúde autolimitados (XXV); avaliar e promover a adesão (XXVII); e realizar rastreamento em saúde em consonância com as políticas vigentes (XXVIII).

Os serviços do arcabouço do CFF (2016)

O documento "Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual" (CFF, 2016) padronizou nomes e conceitos. O mesmo documento esclarece que a **consulta farmacêutica** não é um serviço: é o encontro entre farmacêutico e paciente, dentro do qual um ou mais serviços são prestados.

Serviço	Conceito resumido (CFF, 2016)	Exemplo na drogaria
Rastreamento em saúde	Identificação provável de doença em pessoa assintomática ou sob risco, com encaminhamento para diagnóstico	Campanha de PA; glicemia capilar em pessoa com fatores de risco
Educação em saúde	Estratégias educativas para autonomia e autocuidado	Roda sobre uso de inaladores; cartaz e conversa sobre sal e PA

Serviço	Conceito resumido (CFF, 2016)	Exemplo na drogaria
Dispensação	Análise técnica e legal da receita, entrega e orientação	Toda receita atendida no balcão
Manejo de problema de saúde autolimitado	Acolher a queixa, indicar medida não farmacológica ou MIP, ou encaminhar	Resfriado, azia, diarreia aguda leve (módulo de MIP)
Monitorização terapêutica de medicamentos	Medir e interpretar nível sérico de fármaco para individualizar a dose	Rara na drogaria (serviço de hospital)
Conciliação de medicamentos	Lista precisa de tudo o que o paciente usa, comparando fontes, nas transições de cuidado	Paciente com alta hospitalar e receitas antigas em casa
Revisão da farmacoterapia	Análise estruturada dos medicamentos em uso para resolver problemas e melhorar a adesão	Idoso que traz a sacola de remédios
Gestão da condição de saúde	Gerenciamento de uma condição estabelecida (hipertensão, diabetes) com metas e seguimento	Programa de acompanhamento de hipertensos da farmácia
Acompanhamento farmacoterapêutico	Gerenciamento de toda a farmacoterapia em vários encontros	Paciente polimedicado com retornos mensais

Prescrição farmacêutica

A Resolução CFF 586/2013 foi declarada ilegal em primeira instância (sentença de 18/11/2024, ACP 0060624-78.2013.4.01.3400), com recurso do CFF; a Resolução CFF 5/2025 está suspensa por liminar. O módulo de MIP traz o texto completo e a situação judicial. Para os serviços deste módulo, o caminho com base sanitária vigente é: indicar MIP e medidas não farmacológicas, orientar, encaminhar e registrar tudo na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC 44/2009, art. 81). Diante de parâmetro alterado, a RDC proíbe indicar ou alterar medicamento de venda sob prescrição (art. 69, §4º).

NO BALCÃO

O gerente pede que um balconista meça a pressão dos clientes na entrada da loja, num banquinho ao lado do caixa, durante a campanha do mês. A resposta técnica: a aferição é serviço farmacêutico, feita pelo farmacêutico (Resolução CFF 499/2008, art. 1º), na sala de serviços licenciada (RDC 44/2009, art. 15), com registro e Declaração de Serviço Farmacêutico. Campanha na calçada ou fora da sala depende de autorização da vigilância local. Proponha a campanha dentro da sala, com agenda e fluxo de fila.

Consulta farmacêutica, registro e documentos

A Resolução CFF 585/2013 define consulta farmacêutica como o atendimento do farmacêutico ao paciente, com respeito aos princípios éticos e profissionais, para obter os melhores resultados com a farmacoterapia e promover o uso racional de medicamentos (glossário). Na drogaria, a consulta acontece na sala de serviços farmacêuticos licenciada, que precisa garantir privacidade e conforto (RDC 44/2009, art. 15, §1º). A anamnese, os roteiros de perguntas e os sinais de alerta por queixa estão no módulo de MIP; aqui o foco é a sequência do atendimento e os documentos que ele gera.

Sequência do atendimento

1. **Acolhimento**: entender o motivo da procura e levar a pessoa à sala quando o assunto pedir reserva.
2. **Coleta de dados**: queixa, história, medicamentos em uso (inclusive MIP, fitoterápicos e suplementos), alergias, hábitos; e, quando útil, PA, temperatura ou exame permitido.
3. **Avaliação**: o farmacêutico decide se há problema relacionado a medicamento, se o caso cabe na farmácia ou se é preciso encaminhar, e com que urgência.
4. **Plano**: orientação, medida não farmacológica, MIP quando cabível, encaminhamento por escrito, data de retorno.
5. **Registro e documentos**: ficha do atendimento e Declaração de Serviço Farmacêutico.
6. **Seguimento**: retorno ou contato combinado, com o resultado anotado.

Registro no formato SOAP

O arcabouço do CFF (2016) cita as notas de evolução no formato SOAP (dados subjetivos, objetivos, avaliação e plano) como as mais usadas na área da saúde, sem torná-las obrigatórias. O formato se adapta bem à drogaria.

Letra	Conteúdo	Exemplo curto
S (subjetivo)	O que a pessoa relata	Hipertensa há 6 anos, "esquece o remédio da noite", cefaleia leve hoje
O (objetivo)	O que foi medido ou conferido	PA média 152/94 mmHg (duas últimas de três); losartana 50 mg 2 vezes ao dia na receita
A (avaliação)	Interpretação do farmacêutico	PA acima da meta, provável baixa adesão à dose noturna; sem sinais de urgência
P (plano)	O que foi feito e combinado	Tabela de horários, alarme no celular, encaminhamento por escrito à UBS, retorno em 15 dias para nova aferição

O registro precisa do **consentimento expresso** do usuário e deve conter, no mínimo, nome, endereço e telefone do usuário, orientações e intervenções realizadas, resultados e identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (RDC 44/2009, art. 64, §§ 1º e 2º).

Declaração de Serviço Farmacêutico

Após qualquer serviço, o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico, em papel com nome, endereço, telefone e CNPJ do estabelecimento e identificação do usuário (RDC 44/2009, art. 81, §1º). O conteúdo varia com o serviço (§2º): na atenção farmacêutica, medicamento prescrito e prescritor, MIP indicado e posologia, valores medidos ou resultados de exames seguidos dos valores de referência, a frase obrigatória "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" quando houver aferição ou exame, dados do medicamento administrado, orientação, plano de intervenção, data, assinatura e carimbo com CRF. Na perfuração de lóbulo, nome e CNPJ do fabricante e lote do brinco e da pistola. São duas vias, uma para o usuário e outra arquivada (§4º), e é

proibido usá-la como propaganda ou para indicar medicamento que exige prescrição (§3º). O modelo com os campos está no material de apoio.

Quando a farmácia executa exame de análises clínicas, entrega a Declaração e o laudo do exame, que podem compor um único documento (Anvisa, Perguntas e Respostas da RDC 978/2025, 2025, pergunta 42). O registro do resultado deve constar na Declaração (RDC 978/2025, art. 60, §2º).

Encaminhamento por escrito

Encaminhar é parte do serviço (RDC 44/2009, art. 66). Um encaminhamento oral se perde; o escrito chega ao médico com dados úteis. Conteúdo sugerido: identificação da farmácia e do farmacêutico com CRF; nome e idade do paciente; motivo do encaminhamento em linguagem objetiva; valores medidos com data, hora e técnica; medicamentos em uso; o que foi orientado; urgência sugerida. O texto descreve achados ("PA média de 168/102 mmHg em três medidas") e não faz diagnóstico ("paciente hipertenso descompensado"). Situação de risco imediato não espera papel: aciona-se o SAMU (192) e o registro é feito depois.

Sigilo e LGPD

- Os dados obtidos nos serviços recebem tratamento sigiloso e não podem ser usados para finalidade diversa (RDC 44/2009, art. 82).
- Dado referente à saúde é dado pessoal sensível (Lei 13.709/2018, art. 5º, II). O tratamento para tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, é hipótese legal própria (art. 11, II, "f").
- É vedado comunicar ou compartilhar dado sensível de saúde entre controladores para obter vantagem econômica, salvo as exceções da lei (art. 11, §4º). Glicemia anotada na sala de serviços não alimenta cadastro de promoção nem programa de fidelidade.
- Serviço que executa exames precisa de política de acesso e proteção dos dados conforme a LGPD (RDC 978/2025, art. 77).

Por quanto tempo guardar

A RDC 44/2009 exige o registro e a segunda via da Declaração, mas não fixa prazo de guarda. Para exames de análises clínicas, toda a documentação e os registros são mantidos por no mínimo 5 anos (RDC 978/2025, art. 115). O arcabouço do CFF (2016), com base na Resolução CFF 555/2011, indica guarda mínima de 5 anos a contar da última anotação, em papel ou meio eletrônico, salvo prazo maior fixado pela autoridade sanitária. Na prática, o POP da farmácia adota 5 anos para todos os registros de serviços, e o farmacêutico confere se a vigilância estadual ou municipal exige prazo maior.

Cobrança do serviço

Nenhuma norma federal citada aqui proíbe cobrar por serviço farmacêutico. Se houver cobrança, o preço é informado de forma clara antes do atendimento (Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III). Condicionar o serviço à compra de um produto é prática abusiva (CDC, art. 39, I). Serviço gratuito exige a mesma técnica, o mesmo registro e a mesma Declaração.

NO BALCÃO

Cliente pergunta se pode levar "o papel da pressão" para mostrar ao médico. Entregue a primeira via da Declaração com os valores, a referência e a frase obrigatória, e anexe o encaminhamento escrito quando houver motivo. Explique que o número medido na farmácia é triagem e que o diagnóstico é do médico. A segunda via fica arquivada, com o consentimento registrado na ficha.

CASO

A rede pede ao farmacêutico a planilha com nomes e glicemias dos clientes da campanha para enviar ofertas de tiras reagentes. O farmacêutico recusa: os dados do serviço são sigilosos e de uso exclusivo do serviço (RDC 44/2009, art. 82), e o uso de dado de saúde para vantagem econômica é vedado (Lei 13.709/2018, art. 11, §4º). Ele oferece um relatório com números agregados, sem identificação, para o indicador de resultados do serviço (art. 65).

Aferição da pressão arterial

Medir a pressão é o serviço mais procurado na drogaria e o mais feito de forma errada. Uma medida mal feita gera dois danos: assusta quem está bem e tranquiliza quem precisa de médico. A aferição na farmácia serve à assistência e à orientação, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (RDC 44/2009, art. 69). A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025) registra que a PA deve ser medida por todos os profissionais de saúde capacitados, mas que o diagnóstico de hipertensão e a conduta clínica são de responsabilidade dos médicos.

Aparelho

- Preferir **aparelho automático oscilométrico de braço, validado**: a DBHA 2025 recomenda o equipamento automático de braço para reduzir erros, e prefere os certificados pelo Inmetro.
- A calibração é avaliada pelo menos uma vez por ano (DBHA 2025). A farmácia guarda o registro de manutenção e calibração (RDC 44/2009, art. 71, parágrafo único) e usa só aparelho regularizado na Anvisa (art. 71).
- Aparelho de punho fica para exceções, como braço muito largo sem manguito adequado: os resultados têm mais erros sistemáticos e dependem da posição do punho em relação ao coração (Diretriz Brasileira de Medidas da PA Dentro e Fora do Consultório, SBC 2023).
- Esfigmomanômetro e termômetro de coluna de mercúrio são proibidos em serviços de saúde desde janeiro de 2019 (RDC 145/2017, conforme o guia de febre do CFF, 2018).
- Ter manguitos de tamanhos diferentes. A largura da bolsa inflável corresponde a 37% a 50% da circunferência do braço e o comprimento envolve pelo menos 75% a 100% do braço (Diretriz de Medidas da PA, SBC 2023).

Circunferência do braço	Manguito	Bolsa inflável (largura x comprimento)
22 a 26 cm	Adulto pequeno	10 x 24 cm
27 a 34 cm	Adulto	13 x 30 cm

Circunferência do braço	Manguito	Bolsa inflável (largura x comprimento)
35 a 44 cm	Adulto grande	16 x 38 cm
45 a 52 cm	Coxa	20 x 42 cm

Fonte da tabela: Diretriz Brasileira de Medidas da PA Dentro e Fora do Consultório (SBC, 2023), Quadro 7. Manguito pequeno para o braço superestima a pressão. A circunferência é medida no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, com o braço estendido ao longo do corpo.

Preparo da pessoa

Pela Diretriz de Medidas da PA (SBC, 2023, Quadro 4), antes da medida a pessoa:

- não está com a bexiga cheia;
- não praticou exercício físico há pelo menos 90 minutos;
- não ingeriu bebida alcoólica, café ou alimentos e não fumou nos 30 minutos anteriores;
- fica em repouso por 5 minutos em ambiente calmo, sem falar e sem se mexer durante a medida;
- está sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado; braço apoiado na altura do coração, palma para cima, sem roupa garroteando.

Técnica

1. Na primeira vez, medir nos dois braços e usar o de maior valor nas medidas seguintes; anotar qual braço. Diferença de PA sistólica acima de 15 mmHg entre os braços indica risco cardiovascular aumentado (DBHA 2025) e entra no encaminhamento.
2. Colocar o manguito sem folga, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, com o meio da bolsa sobre a artéria braquial.
3. **Fazer três medidas, com intervalo de 1 minuto, e usar a média das duas últimas.** Se houver diferença maior que 10 mmHg, fazer medidas adicionais (DBHA 2025, Quadro 3.1).
4. Em idosos, diabéticos, pessoas com disautonomia ou em uso de anti-hipertensivo com queixa de tontura ao levantar, investigar hipotensão ortostática: medir deitado após 5 minutos e em pé com 1 e 3 minutos; queda de 20 mmHg ou mais na sistólica ou de 10 mmHg ou mais na diastólica define o quadro (DBHA 2025; Diretriz de Medidas, 2023).
5. Informar o valor por escrito e de forma exata ("134/76 mmHg", e não "13 por 7"), como pede a DBHA 2025.

Classificação

Classificação (DBHA 2025, adultos a partir de 18 anos)	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)
PA normal	abaixo de 120	e	abaixo de 80
Pré-hipertensão	120 a 139	e/ou	80 a 89

Classificação (DBHA 2025, adultos a partir de 18 anos)	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)
Hipertensão estágio 1	140 a 159	e/ou	90 a 99
Hipertensão estágio 2	160 a 179	e/ou	100 a 109
Hipertensão estágio 3	180 ou mais	e/ou	110 ou mais

Quando sistólica e diastólica caem em categorias diferentes, vale a mais alta. A pré-hipertensão da DBHA 2025 reúne o que a diretriz de 2020 chamava de normal e pré-hipertensão. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hipertensão do Ministério da Saúde (2025) mantém outra nomenclatura (PA ótima, normal, normal alta e graus 1 a 3), e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina registrou, em setembro de 2025, que a rede pública segue o PCDT. Na Declaração, cite a referência usada ("DBHA 2025") ao lado dos valores.

Conduta

- **Abaixo de 120/80 mmHg**: orientar hábitos e medir pelo menos uma vez por ano (DBHA 2025).
- **Pré-hipertensão**: orientar medidas não medicamentosas (peso, sal, atividade física, álcool, tabaco) e sugerir avaliação de risco cardiovascular na unidade de saúde, sem urgência.
- **Média das duas últimas medidas de 140/90 mmHg ou mais**: a DBHA 2025 orienta vincular a pessoa à unidade de saúde de referência para consulta agendada. Entregar Declaração e encaminhamento escrito.
- **180/110 mmHg ou mais sem sintomas**: a DBHA 2025 trata como elevação importante sem lesão aguda de órgão-alvo (termo que substitui "urgência hipertensiva"), com reavaliação médica precoce, em 1 a 7 dias. Orientar avaliação médica no mesmo dia ou no dia seguinte; em hipertenso tratado, perguntar se tomou os remédios.
- **180/110 mmHg ou mais com sintomas** (dor no peito, falta de ar, fraqueza ou dormência em um lado do corpo, alteração da fala ou da visão, confusão): suspeita de emergência hipertensiva, que se define pela lesão aguda de órgão-alvo e não só pelo número. Acionar o SAMU (192).
- **Gestante**: hipertensão na gestação é PA de 140/90 mmHg ou mais (DBHA 2025). Gestante com valor nessa faixa é orientada a procurar o pré-natal ou a maternidade no mesmo dia.

ATENÇÃO

Diante de PA alta, a farmácia não indica nem altera medicamento de venda sob prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º). Também não se recomenda "tomar mais um comprimido" do anti-hipertensivo nem colocar comprimido debaixo da língua. A conduta é orientar, encaminhar e registrar.

A Diretriz de Medidas (SBC, 2023) reconhece o potencial da medida em farmácia para rastreamento e seguimento, mas registra que faltam protocolos validados e que não há critérios próprios de valores anormais para esse ambiente. Por isso a farmácia usa a técnica e os valores de consultório. A DBHA 2025 também recomenda que mulheres em uso de anticoncepcional hormonal combinado meçam a PA regularmente, a cada 6 meses: oportunidade de oferecer o serviço na dispensação.

NO BALCÃO

Homem de 52 anos pede para "ver a pressão rapidinho" porque está com dor de cabeça. Na sala, você pergunta sobre dor no peito, falta de ar, fraqueza em um lado do corpo, alteração visual: nega. Ele subiu a escada correndo e tomou café há 10 minutos. Você explica que a medida agora sairia falsamente alta, oferece água, espera os 30 minutos na sala de espera e faz três medidas. Média das duas últimas: 146/92 mmHg. Declaração com valores, referência e frase obrigatória; encaminhamento escrito para consulta agendada na UBS; orientação sobre sal; nenhum anti-hipertensivo indicado.

Glicemia capilar

A glicemia capilar feita pelo farmacêutico é um exame de análises clínicas (EAC). Desde a RDC 786/2023, substituída pela RDC 978/2025, ela deixou de ser um "parâmetro bioquímico" da RDC 44/2009 e passou a seguir a norma de exames. Segundo as Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a RDC 978/2025 (2025, pergunta 14), a glicemia capilar pelo farmacêutico é permitida em farmácia classificada como **Serviço Tipo I**, desde que cumpridos os requisitos. Quando o farmacêutico usa um glicosímetro de autoteste dentro da farmácia, a atividade é EAC e segue a RDC 978/2025 (art. 4º, parágrafo único; pergunta 27). A venda do glicosímetro e das tiras para uso em casa continua livre.

Requisitos para fazer glicemia na farmácia

- licença sanitária que indique as atividades de EAC (RDC 978/2025, art. 63) e inscrição no CNES (art. 74);
- execução exclusivamente por profissional legalmente habilitado (art. 11); na farmácia, só o farmacêutico (Perguntas e Respostas, pergunta 39); balconista e atendente não podem (pergunta 34);
- responsável técnico e substituto (art. 75) e supervisor do pessoal técnico presente durante o funcionamento, que pode ser o próprio RT (art. 122);
- sala de coleta e execução com lavatório, bancada, mesa, cadeira para coleta, área para equipamentos e recipiente para perfurocortantes e resíduos (art. 14);
- controle interno da qualidade (CIQ) com amostra controle, no mínimo a cada troca de lote e a cada remessa de tiras, conforme o fabricante, e a cada manutenção preventiva ou corretiva do glicosímetro (arts. 180 e 183); controle externo da qualidade (CEQ) para todos os equipamentos e analitos (arts. 185 a 188);
- procedimento escrito para resultados potencialmente críticos, disponível no local (art. 119) e fluxo de comunicação quando houver necessidade de decisão imediata (art. 165, parágrafo único);
- registros guardados por pelo menos 5 anos (art. 115).

O QUE DIZ A NORMA

"O EAC realizado pela farmácia autorizada como Serviço Tipo I tem a finalidade de triagem, sem fins confirmatórios, com vistas a compor as ações de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária." (RDC 978/2025, art. 60)

Técnica

1. Conferir o registro do CIQ do glicosímetro e do lote de tiras em uso; tira vencida ou fora da faixa de conservação não é usada.
2. Higienizar as mãos e calçar luvas (RDC 44/2009, art. 84).
3. Identificar a pessoa, registrar o horário da última refeição e os medicamentos (insulina, sulfonilureias, corticoides).
4. Mãos do cliente lavadas com água e sabão e secas, ou antissepsia com álcool 70% esperando secar: álcool úmido dilui a gota e resíduo de açúcar na pele falseia o valor.
5. Puncionar a face lateral da polpa digital, local usual citado pela SBD (2026), com lanceta de uso único; descartar a lanceta imediatamente no coletor rígido.
6. Aplicar a gota conforme a instrução do fabricante do glicosímetro, sem espremer com força.
7. Registrar valor, hora, condição (jejum de 8 horas ou mais, ou casual com horário da refeição) e entregar a Declaração com o valor de referência e a frase obrigatória.

Interpretação

Os critérios de diagnóstico da Sociedade Brasileira de Diabetes usam glicemia plasmática de laboratório e HbA1c; a glicemia capilar não está entre eles. Os valores abaixo orientam a triagem e o encaminhamento.

Situação	Valor	Fonte
Jejum normal	abaixo de 100 mg/dL	SBD, critérios diagnósticos (edição 2026 do site, texto de 2024)
Jejum na faixa de pré-diabetes	100 a 125 mg/dL	Idem
Jejum na faixa de diabetes	126 mg/dL ou mais	Idem
Casual com sintomas (sede, urina em excesso, perda de peso)	200 mg/dL ou mais	Idem
Hipoglicemia nível 1	54 a 69 mg/dL	SBD 2026, metas de controle glicêmico
Hipoglicemia nível 2	abaixo de 54 mg/dL	Idem
Hipoglicemia nível 3	evento grave com alteração mental ou física que exige ajuda de outra pessoa, qualquer valor	Idem
Meta capilar em adulto com diabetes	jejum e pré-prandial 80 a 130 mg/dL; 2 horas após refeição abaixo de 180 mg/dL	Idem

A SBD (capítulo de diagnóstico revisado em 2024 e mantido na edição 2026) recomenda rastrear diabetes em todos os adultos a partir de 35 anos e, antes disso, em quem tem sobrepeso ou obesidade com ao menos um fator de risco (parente de primeiro grau com diabetes tipo 2, doença cardiovascular,

hipertensão, síndrome dos ovários policísticos, sedentarismo, diabetes gestacional prévio, entre outros). O exame de triagem na farmácia ajuda a levar essas pessoas à unidade de saúde.

Conduta

- **Valor normal**: orientar, registrar e lembrar que o rastreamento formal é feito com exame de laboratório.
- **Jejum de 100 mg/dL ou mais, ou casual de 200 mg/dL ou mais**: encaminhar por escrito para glicemia plasmática e HbA1c, com consulta agendada.
- **Pessoa com diabetes fora da meta**: revisar adesão, técnica de insulina, alimentação e dias de doença; encaminhar ao médico que acompanha. Sem indicar nem ajustar dose de medicamento sob prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º).
- **Hipoglicemia** (abaixo de 70 mg/dL, com ou sem sintomas): se a pessoa está consciente e consegue engolir, oferecer carboidrato de absorção rápida (suco, refrigerante comum, açúcar), repetir a glicemia e não deixá-la sair sozinha dirigindo. Confusão, sonolência, convulsão ou incapacidade de engolir: SAMU (192), sem dar nada pela boca.
- **Glicemia muito alta** (leitura "HI" no aparelho ou valores acima de 250 mg/dL) com vômitos, dor abdominal, respiração rápida, sonolência ou desidratação: encaminhar com urgência. A SBD (2026) usa 250 mg/dL em duas medidas seguidas como gatilho para pesquisar cetonas em pessoas com diabetes tipo 1 em dia de doença.

ATENÇÃO

Resultado crítico pede ação imediata, prevista no procedimento escrito da farmácia (RDC 978/2025, arts. 119 e 165). Um valor de 45 mg/dL anotado com calma na Declaração, enquanto o cliente vai embora, é falha grave de serviço.

NO BALCÃO

Senhora de 61 anos, sem diagnóstico de diabetes, mãe diabética, IMC alto, pede a glicemia "de jejum" às 10h, após café com pão. Você registra como glicemia casual (refeição às 8h), mede 182 mg/dL, explica que o valor não fecha nem descarta diabetes, entrega a Declaração e o encaminhamento escrito para glicemia de jejum e HbA1c na UBS, e orienta que pela idade ela já está no grupo que a SBD manda rastrear.

Exames de análises clínicas e testes rápidos

Além da glicemia, a drogaria pode oferecer outros exames de análises clínicas, desde que cumpra a RDC 978/2025. A norma revogou a RDC 786/2023 (art. 193), entrou em vigor em 10/06/2025, data da publicação (art. 194), deu 90 dias para adequação (art. 191) e foi alterada pela RDC 986/2025, de 15/08/2025, que mudou a redação dos tipos de amostra permitidos ao Serviço Tipo I. Fazer exames é opcional: cada farmácia escolhe se oferece e quais oferece (Perguntas e Respostas da Anvisa, 2025, pergunta 38).

Os cinco requisitos do Serviço Tipo I

O QUE DIZ A NORMA

A farmácia pode ser classificada como Serviço Tipo I (RDC 978/2025, art. 8º) se: "executar EAC exclusivamente em material biológico obtido por coleta por punção capilar, coleta em cavidade oral, em nasofaringe ou em orofaringe" (art. 10, I, redação da RDC 986/2025); realizar todas as etapas no próprio serviço, inclusive CIQ e CEQ (II); não guardar, armazenar nem transportar material biológico, exceto o de controle de qualidade (III); não usar metodologia própria (IV); e usar só equipamento que não exija água reagente produzida no serviço (V).

Consequências práticas:

- **Só quatro tipos de amostra**: sangue de punção capilar, material da cavidade oral, swab de nasofaringe e de orofaringe. Urina, fezes, sangue venoso e secreções genitais ficam de fora.
- **Tudo no local e na hora**: a farmácia não coleta para mandar ao laboratório (pergunta 43) e não guarda amostra.
- **Nada remoto**: é proibida qualquer atividade de execução do exame de forma remota, inclusive leitura remota do resultado (pergunta 33). O termo antigo "teste laboratorial remoto" não descreve o que a farmácia faz hoje.
- **Finalidade de triagem**: o exame não confirma diagnóstico (art. 60). As Perguntas e Respostas enquadram o exame em farmácia no conceito de rastreamento em saúde da Resolução CFF 585/2013 (pergunta 1).

Estrutura e gestão

O Serviço Tipo I tem recepção separada da sala de coleta, depósito de material de limpeza, sanitário de uso público e sala de coleta e execução (art. 13); os três primeiros podem ser compartilhados com outras áreas da farmácia (§2º), e o depósito pode ficar no espaço do sanitário (§1º). Reagente que exija temperatura controlada vai para refrigerador exclusivo com registro de máxima, mínima e momento; o mesmo equipamento pode receber medicamentos que não exijam refrigerador exclusivo (art. 14, V e §1º). A sala de coleta pode ser compartilhada com outros serviços farmacêuticos, somando os requisitos de cada atividade (art. 14, §2º; pergunta 44). Exigências de infraestrutura física valem em reforma, ampliação, construção nova ou adaptação de imóvel (art. 191, parágrafo único).

A gestão exige instruções escritas de biossegurança (art. 110), PGRSS (art. 111), limpeza registrada no início e no fim do expediente (art. 113), programa de educação permanente com capacitação no mínimo anual e registrada (arts. 124 a 127), e documentos disponíveis: relação e registros de todos os procedimentos, inventário de produtos, relação nominal da equipe e registros de CIQ e CEQ (art. 117).

Laudo, registro e notificação

- A farmácia entrega a Declaração de Serviço Farmacêutico e o laudo, que podem ser um documento só (pergunta 42). O laudo é legível, datado e assinado pelo profissional habilitado (art. 166) e traz, entre outros itens, nome e CNES do serviço, RT e profissional que assina com registro no conselho,

identificação e idade do paciente, nome do exame, material e método, resultado com unidade, valores de referência e limitações do método (art. 167).

- Resultado que indique suspeita de doença de notificação compulsória é notificado, inclusive pela farmácia (art. 66; pergunta 41), e o serviço segue as diretrizes de diagnóstico do Ministério da Saúde para essas doenças (art. 67).

Testes rápidos: o que cabe na farmácia

Teste	Amostra	Na farmácia Tipo I	Observação
Glicemia capilar	Punção capilar	Pode, com requisitos	Perguntas e Respostas, pergunta 14
Antígeno de COVID-19 ou influenza	Swab nasofaríngeo ou orofaríngeo	Pode, com requisitos	Instrução de biossegurança para aerossóis; EPI com máscara e proteção ocular
Colesterol, triglicerídeos, HbA1c em equipamento portátil	Punção capilar	Pode, se o produto for regularizado e houver CIQ e CEQ	Resultado alterado: encaminhar para exame de laboratório
HIV, sífilis, hepatites B e C	Punção capilar ou fluido oral	A amostra é compatível com o Tipo I	Doenças de notificação compulsória (art. 66); seguir o fluxo de diagnóstico do Ministério da Saúde (art. 67); confirmar com a vigilância local antes de ofertar
Gravidez (hCG em urina)	Urina	Não pode executar	Urina não é amostra do Tipo I; a venda do autoteste é livre
Qualquer exame em sangue venoso	Punção venosa	Não pode	Coleta venosa é de posto de coleta (Serviço Tipo II)

Vender autoteste (glicemia, COVID-19, HIV, gravidez) é comércio de produto, fora do alcance da RDC 978/2025 (art. 4º). O cliente faz o teste em casa, seguindo a instrução do fabricante; o farmacêutico orienta a leitura, a conduta diante de resultado reagente e o descarte da lanceta.

ATENÇÃO

Teste reagente para HIV, sífilis ou hepatite feito na farmácia é triagem. A pessoa recebe a notícia em local reservado, com orientação clara, e sai com encaminhamento ao serviço de referência para confirmação e tratamento. A farmácia notifica a suspeita, mantém o sigilo e não divulga o resultado a acompanhantes sem autorização.

NO BALCÃO

Jovem pede para fazer "o teste de gravidez aí dentro, para não fazer em casa". Explique que a farmácia não executa exame em urina, ofereça o teste para uso próprio com orientação de leitura (horário, tempo de espera, linha fraca, repetição) e acrescente o que fazer com cada resultado: positivo, procurar a unidade de saúde para iniciar o pré-natal; negativo com atraso persistente, repetir conforme a bula do teste e procurar avaliação.

Temperatura, rastreamento e campanhas

Temperatura corporal é o outro parâmetro fisiológico permitido (RDC 44/2009, art. 69, §1º). Ela entra no atendimento de febre, de suspeita de infecção e de reação após vacina. Rastreamento e educação em saúde, por sua vez, são os serviços que dão forma às campanhas da farmácia.

Termômetro e técnica

- Usar termômetro regularizado na Anvisa (RDC 44/2009, art. 71). O de coluna de mercúrio é proibido em serviços de saúde desde 2019 (RDC 145/2017, citada pelo guia de febre do CFF, 2018).
- O guia do CFF (2018) não recomenda medida retal na farmácia, pelo risco, pelo desconforto e pela inconveniência. A via mais usada é a axilar, com axila seca; a oral sofre influência de bebida quente ou fria, comida e cigarro recentes.
- Higienizar o termômetro entre usos conforme o fabricante (em geral, álcool 70% na ponteira) e registrar a via usada.

Via	Normotermia	Febre
Axilar	34,7 a 37,4 °C	acima de 37,4 °C
Oral	35,5 a 37,5 °C	acima de 37,5 °C
Timpânica	35,7 a 37,8 °C	acima de 37,8 °C
Temporal (testa)	36,6 a 37,8 °C	acima de 37,8 °C a partir de 4 anos; acima de 37,9 °C de 3 meses a 4 anos; acima de 38,1 °C até 2 meses
Retal	36,6 a 38 °C	acima de 38 °C

Fonte: CFF, Guia de prática clínica: febre (2018), Tabela 1, adaptada de Krinsky et al. (2014). O próprio guia registra falta de consenso na literatura sobre esses limites.

Pelo mesmo guia: hipotermia é temperatura interna abaixo de 35 °C e deve ser encaminhada ao atendimento médico; hiperpirexia, acima de 41,1 °C, vai para urgência; criança com menos de 6 meses com 38 °C retal ou equivalente, ou com mais de 6 meses e 40 °C ou mais, é encaminhada ao médico. O módulo de MIP traz os demais sinais de alerta de febre (menor de 2 meses, suspeita de dengue, manchas na pele, convulsão, falta de ar) e a escolha do antitérmico.

NO BALCÃO

Mãe chega com bebê de 5 meses "quentinho". Temperatura axilar de 38,2 °C, criança sonolenta e mamando pouco. Pelo guia do CFF, menor de 6 meses com febre vai ao médico. Você não indica antitérmico por conta própria para adiar a consulta, registra a medida, entrega a Declaração e orienta procurar o pronto-atendimento pediátrico agora, informando o endereço do serviço mais próximo da lista da farmácia (RDC 44/2009, art. 62).

Rastreamento em saúde

Rastreamento é a identificação provável de doença em pessoa assintomática ou sob risco, com encaminhamento para diagnóstico e tratamento (CFF, 2016). Funciona quando tem público certo, técnica certa e encaminhamento garantido. Na drogaria, os rastreamentos com base em diretriz vigente são:

- **Pressão arterial** em todo adulto, pelo menos uma vez por ano (DBHA 2025).
- **Glicemia** em adultos a partir de 35 anos e em pessoas com sobrepeso ou obesidade e fator de risco (SBD); na farmácia, a glicemia capilar como triagem, com encaminhamento para exame de laboratório.
- **Questionário FINDRISC**, usado pela SBD para estratificar risco de diabetes (pontuação de 0 a 26; 15 ou mais indica risco alto ou muito alto).

Medidas antropométricas

Peso, altura, IMC e circunferência abdominal não estão entre os parâmetros fisiológicos listados na RDC 44/2009 (art. 69, §1º, só PA e temperatura). Muitas farmácias têm balança de autoatendimento, e a medida da cintura com fita é usada em ações educativas. Antes de incluir essas medidas como serviço registrado na Declaração, confirme o entendimento da vigilância local. Como informação educativa, a DBHA 2025 classifica obesidade por IMC (classe 1 de 30 a menos de 35 kg/m², classe 2 de 35 a menos de 40, classe 3 de 40 ou mais) e recomenda manter a circunferência abdominal abaixo de 102 cm em homens e de 88 cm em mulheres.

Educação em saúde e campanhas

A RDC 44/2009 permite que farmácias participem de campanhas e programas de promoção da saúde e educação sanitária do Poder Público (art. 92). Uma campanha bem feita tem:

- público definido e mensagem curta (por exemplo, "adultos acima de 35 anos: PA e risco de diabetes");
- atendimento na sala licenciada, por farmacêutico, com a mesma técnica do dia a dia;
- Declaração para cada atendido e encaminhamento escrito para quem tiver valor alterado, com o endereço da unidade de saúde;
- registro dos números (atendidos, alterados, encaminhados) para o indicador do serviço (art. 65);
- material educativo sem marca de medicamento: a Declaração não pode ter finalidade de propaganda (art. 81, §3º).

CASO

Campanha de novembro sobre diabetes: 140 atendidos em uma semana. O farmacêutico registra 31 glicemias alteradas e 31 encaminhamentos escritos, liga para 20 deles no mês seguinte e descobre que 12 fizeram exame de laboratório. Esse número entra no relatório do serviço e orienta a próxima campanha (por exemplo, agendar com a UBS vizinha um horário para os encaminhados).

Administração de medicamentos, vacinação e perfuração de lóbulo

Aplicar um injetável parece rotina, mas é o serviço da drogaria com maior risco imediato: reação alérgica grave, erro de medicamento, lesão no local, acidente com agulha. A norma trata a administração como parte da atenção farmacêutica, com regras próprias, e a vacinação como serviço com norma específica.

Administração de medicamentos

O QUE DIZ A NORMA

"Fica permitida a administração de medicamentos nas farmácias e drogarias no contexto do acompanhamento farmacoterapêutico." "É vedada a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar." (RDC 44/2009, art. 74 e parágrafo único)

- **Receita**: medicamento que exige prescrição só é administrado com receita apresentada e avaliada pelo farmacêutico (art. 75). Em caso de dúvida (dose, via, diluição, duração), o farmacêutico contata o prescritor (§1º) e confere a validade antes de aplicar (§2º).
- **Quem aplica**: o farmacêutico, ou outro profissional habilitado com autorização expressa do farmacêutico responsável técnico; a presença ou supervisão do farmacêutico é condição essencial (Resolução CFF 499/2008, art. 21).
- **Sobra**: medicamento comprado na farmácia em embalagem de múltiplas doses tem a sobra entregue ao usuário, com orientação de conservação; a farmácia não pode guardar medicamento com embalagem primária violada (RDC 44/2009, art. 76).
- **Material**: seringas, agulhas e acessórios regularizados na Anvisa, com registro de manutenção e calibração dos aparelhos (art. 77).
- **Registro**: a Declaração traz nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração e forma farmacêutica, via, lote e número de registro na Anvisa (art. 81, §2º, I, "e").

A técnica por via (locais, volumes, ângulo, agulha) e a conduta em intercorrência estão no POP de aplicação de injetáveis do módulo de POPs. Três decisões de balcão merecem atenção:

1. **Medicamento trazido de casa**: a RDC 44/2009 trata da sobra do medicamento comprado na farmácia; a aplicação de medicamento trazido pelo cliente fica a critério do POP. Se aceitar, confira receita, procedência, lote, validade, aspecto e conservação. Termolábil que viajou sem refrigeração ou sem informação confiável sobre o transporte não é aplicado.
2. **Anticoagulante, plaquetopenia, alergia prévia**: perguntar antes de toda aplicação; aplicação intramuscular em quem usa anticoagulante é discutida com o prescritor.

3. **Observação após a aplicação**: o cliente fica sentado na farmácia pelo tempo definido no POP. Falta de ar, inchaço de face ou lábios, urticária extensa, tontura com queda de pressão: SAMU (192) e kit de primeiros socorros, que deve estar identificado e acessível na sala (RDC 44/2009, art. 15, §4º).

A RDC 44/2009 não cita nebulização. Como a administração de medicamentos não está limitada por via na norma, há vigilâncias que aceitam a inalação como administração de medicamento, com receita, equipamento regularizado e máscara de uso individual ou reprocessada conforme o fabricante; outras não aceitam. Antes de oferecer, confirme por escrito com a vigilância local e inclua no licenciamento.

ATENÇÃO

Aplicar injetável sem receita quando o medicamento exige prescrição, aplicar medicamento de uso exclusivo hospitalar ou deixar o balconista aplicar sem farmacêutico na loja são infrações sanitárias e éticas. A pressa do cliente não muda a regra.

Vacinação

A farmácia pode dispor de vacinas e soros (Lei 13.021/2014, art. 7º). O serviço segue a RDC 197/2017 e a Lei 14.675/2023; a atuação do farmacêutico é regulada pela Resolução CFF 654/2018.

Exigência	Base (RDC 197/2017)
Licença sanitária para a atividade e inscrição no CNES	Arts. 4º e 5º
Calendário Nacional de Vacinação do SUS afixado em local visível	Art. 6º
Responsável técnico e substituto; profissional habilitado durante todo o período do serviço; capacitação periódica	Arts. 7º a 9º
Recepção separada, sanitário e sala com pia, bancada, mesa, cadeira, caixa térmica, refrigerador exclusivo regularizado na Anvisa com termômetro de máxima e mínima, coletores, maca e termômetro com cabo extensor para as caixas	Art. 10
Registro diário de temperatura máxima e mínima; conservação garantida mesmo em falta de energia; só vacinas registradas	Art. 11
Atendimento imediato de intercorrências e encaminhamento	Art. 13
Vacina fora do Calendário Nacional, em estabelecimento privado, só com prescrição médica; dispensação vinculada à administração	Art. 14
Registro no cartão e no sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde; prontuário individual; notificação de eventos adversos e de erros de vacinação	Arts. 15 e 16

O parágrafo único do art. 14 tem efeito direto no balcão: a farmácia que vacina não vende a vacina para o cliente levar e aplicar em outro lugar. A Lei 14.675/2023 garante ao usuário acompanhar a retirada da vacina do refrigerador e conferir nome e validade (art. 8º, conforme o módulo de POPs). A rede de frio, o plano de contingência e o registro de temperatura estão nos módulos de termolábeis e de POPs.

Perfuração de lóbulo auricular

- Aparelho específico que usa o próprio brinco como material perfurante; vedado usar agulha de injeção, agulha de sutura ou outro objeto (RDC 44/2009, art. 78).
- Brincos e pistola regularizados na Anvisa; brinco mantido estéril e aberto só no ambiente do serviço, à vista do usuário, depois da antissepsia (art. 79).
- POP com antissepsia do lóbulo e das mãos, uso e assepsia do aparelho, EPI e referência bibliográfica (art. 80).
- Declaração com nome e CNPJ do fabricante e lote do brinco e da pistola, data, assinatura e CRF (art. 81, §2º, II).
- A norma fala em lóbulo; cartilagem da orelha e outras regiões não estão incluídas. Alguns estados têm lei própria sobre o tema.

NO BALCÃO

Cliente chega com uma ampola de anti-inflamatório injetável e uma receita de 8 meses atrás, pedindo para aplicar "porque a dor voltou". Você explica que a aplicação depende de receita válida para o tratamento atual e da avaliação do farmacêutico (RDC 44/2009, art. 75), pergunta sobre a dor (tempo, sinais de alerta), oferece manejo com medidas não farmacológicas e MIP quando cabível e, se a dor tiver característica de alerta, encaminha por escrito. A recusa e a orientação entram no registro.

Revisão da farmacoterapia, adesão e uso de dispositivos

O cliente que mais se beneficia de um serviço clínico costuma ser o que compra mais: o idoso com cinco, oito, doze medicamentos. A DBHA 2025 define polifarmácia como o uso regular de cinco ou mais medicamentos e lembra que ela se associa a mais eventos adversos, interações e pior adesão. Revisar a farmacoterapia, apoiar a adesão e ensinar o uso de dispositivos são serviços que cabem na drogaria e não dependem de exame.

Revisão da farmacoterapia no balcão

Revisão da farmacoterapia é a análise estruturada e crítica dos medicamentos em uso, para reduzir problemas relacionados à farmacoterapia, melhorar a adesão e os resultados e evitar desperdício (CFF, 2016). Na drogaria, o formato mais viável é a revisão com o paciente presente e os medicamentos na mesa ("revisão da sacola").

1. **Agendar**: pedir que traga todos os medicamentos, inclusive os que parou, colírios, pomadas, MIP, fitoterápicos e suplementos, e as receitas e exames recentes.
2. **Montar a lista**: nome pela DCB, concentração, como o paciente realmente toma, para que acha que serve, quem prescreveu. Discrepâncias entre receita e uso real aparecem aqui.
3. **Procurar problemas**: duplicidade (mesmo fármaco em marca e genérico; dois anti-inflamatórios), interações relevantes, dose fora da faixa da bula, medicamento sem indicação clara, indicação sem tratamento, efeito adverso que o paciente atribui à idade, medicamento potencialmente inapropriado para idoso (Critérios de Beers, citados no módulo de MIP), dificuldade de uso de forma farmacêutica, custo que leva a falhas.

4. **Agir dentro do papel**: o farmacêutico orienta, organiza horários e encaminha ao prescritor por escrito o que exige mudança na prescrição. Ele não suspende nem troca medicamento de venda sob prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º; Código de Ética, módulo de MIP).
5. **Entregar**: lista atualizada para o paciente levar às consultas, tabela de horários, Declaração com orientação e plano.
6. **Retorno**: data combinada para saber se as mudanças funcionaram.

Conciliação de medicamentos é o mesmo cuidado com foco nas transições: alta hospitalar, troca de médico, mudança do SUS para o privado. A lista conciliada evita que o paciente volte a tomar em casa o que foi suspenso no hospital (CFF, 2016; Resolução CFF 585/2013, art. 7º, XXIV).

Adesão

A Resolução CFF 585/2013 inclui avaliar e promover a adesão entre as atribuições clínicas (art. 7º, XXVII), e a DBHA 2025 recomenda estratégias com equipe multiprofissional, comunicação, educação e aplicativos para melhorar a adesão ao anti-hipertensivo. Perguntas que funcionam sem constranger:

- "Muita gente esquece algum comprimido durante a semana. Isso acontece com você?"
- "Quantas vezes, nos últimos 7 dias, você deixou de tomar?"
- "Algum remédio você toma diferente do que está na receita, ou parou por conta própria? Por quê?"
- "Sobra ou falta remédio no fim do mês?"

Ferramentas simples: tabela de horários com desenhos, alarme no celular, caixa organizadora semanal, alinhar as tomadas a hábitos (café da manhã, escovar os dentes), revisar o custo com alternativas genéricas intercambiáveis, combinar com o prescritor um esquema mais simples quando possível (a DBHA 2025 prefere associações em dose única diária para quem toma muitos comprimidos).

Caneta de insulina

Pela diretriz da SBD (Práticas seguras para preparo e aplicação de insulina, Sparapani et al., edição 2026):

- usar a agulha mais curta disponível; na caneta, 4 ou 5 mm são primeira escolha em adultos e crianças; agulha de 12 mm ou mais não deve ser usada;
- com agulha de 4 ou 5 mm, a prega cutânea é dispensável, exceto em crianças menores de 6 anos e pessoas com pouco tecido subcutâneo; ângulo de 90°;
- insulina NPH e pré-misturas são homogeneizadas com 20 movimentos suaves antes do uso;
- teste de fluxo antes de cada aplicação: selecionar 1 UI, caneta com a agulha para cima, pressionar e ver a gota;
- após injetar, manter o botão pressionado por no mínimo 10 segundos e retirar a agulha com o botão ainda pressionado;
- não reutilizar agulha; fazer rodízio dos locais e não aplicar em área com lipo-hipertrofia (endurecimento);
- insulina lacrada em 2 a 8 °C até a validade; em uso, refrigerada ou em temperatura ambiente até 30 °C pelo tempo que cada fabricante indica na bula;
- agulha usada em recipiente rígido, sem reencapar, dobrar ou quebrar, e nunca no lixo doméstico.

Peça ao paciente que demonstre a aplicação com a caneta dele. A falha mais comum aparece na demonstração: retirar a agulha logo após apertar o botão, sem esperar os 10 segundos, ou aplicar sempre no mesmo ponto da barriga.

Inaladores

Cada dispositivo tem instrução própria na bula, e a técnica correta depende do modelo. Pontos que valem para a orientação no balcão:

- **Aerossol dosimetrado ("bombinha")**: agitar quando a bula pedir, expirar fora do bocal, disparar no início de uma inspiração lenta e profunda, segurar a respiração por alguns segundos conforme a bula; com espaçador, seguir a instrução do espaçador. Criança pequena e idoso com dificuldade de coordenação se beneficiam do espaçador.
- **Inalador de pó seco**: carregar a dose conforme o modelo, expirar longe do bocal (umidade estraga o pó), inspirar de forma rápida e forte, segurar a respiração. Não agitar e não usar espaçador.
- Com corticoide inalatório, enxaguar a boca e cuspir depois do uso.
- Contar as doses (contador do aparelho ou anotação) para não usar dispositivo vazio.

O módulo de MIP e os PCDT de asma (2026) e DPOC (2025) trazem o tratamento; aqui o serviço é verificar a técnica, porque erro de técnica é causa frequente de falha de tratamento.

NO BALCÃO

Senhor de 74 anos compra o terceiro frasco de broncodilatador no mês e diz que "a bombinha não faz efeito". Na demonstração, ele dispara o aerossol e só depois inspira, pela boca entreaberta. Você ensina a técnica com espaçador, pede que ele repita, anota a orientação na Declaração e encaminha por escrito ao médico, porque o uso frequente de broncodilatador de alívio indica asma ou DPOC mal controlada.

Biossegurança, resíduos e sala de serviços

A sala de serviços farmacêuticos é a parte da drogaria que mais se parece com um serviço de saúde, e a inspeção a avalia assim. Os POPs exigidos, a tabela de EPI, a classificação de resíduos e a autoinspeção completa estão no módulo de POPs; aqui ficam os pontos que o recém-formado verifica no primeiro dia como farmacêutico da sala.

Ambiente

- Ambiente diverso da área de dispensação e de circulação, com privacidade e conforto (RDC 44/2009, art. 15, §1º).
- Lavatório com água corrente, toalha descartável, sabonete líquido, gel antisséptico e lixeira com pedal e tampa (§2º); acesso ao sanitário que não passe pela sala (§3º); kit de primeiros socorros identificado e acessível (§4º).
- Limpeza diária no início e no fim do expediente, registrada; ambiente limpo antes de cada atendimento e nova limpeza quando necessário (art. 16; para exames, RDC 978/2025, art. 113).
- Para exames: itens da sala de coleta do Serviço Tipo I (RDC 978/2025, art. 14). Para vacinas: itens da sala de vacinação (RDC 197/2017, art. 10).

Mãos, EPI e perfurocortantes

- "A execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida da anti-sepsia das mãos do profissional, independente do uso de Equipamentos de Proteção Individual" (RDC 44/2009, art. 84).
- EPI fornecido pela farmácia (art. 18), com treinamento sobre uso e descarte (art. 26) e indicado no POP de cada serviço (art. 72, parágrafo único; art. 80, §2º).
- Lanceta, agulha e ampola: resíduo do grupo E em coletor rígido, trocado ao atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante, sem reencapar agulha com as mãos (RDC 222/2018; detalhes no módulo de POPs).
- Algodão e gaze com sangue seguem o PGRSS (RDC 44/2009, art. 73).

ATENÇÃO

Picada com lanceta ou agulha usada é acidente de trabalho com material biológico: lavar o local com água e sabão sem espremer, comunicar o farmacêutico responsável, identificar a pessoa atendida quando possível e encaminhar o trabalhador logo ao serviço de referência para avaliação de profilaxia (POP de biossegurança, RDC 44/2009, art. 27).

Documentos que a fiscalização pede na sala

- licença sanitária com os serviços listados (RDC 44/2009, art. 61, §3º), incluindo EAC (RDC 978/2025, art. 63) e vacinação (RDC 197/2017, art. 4º) quando houver;
- POPs dos serviços, com referências e EPI (RDC 44/2009, arts. 64, 72, 80 e 83);
- registros de atendimento com consentimento e segundas vias das Declarações (arts. 64 e 81, §4º);
- registros de limpeza, de calibração dos aparelhos (art. 71, parágrafo único) e de temperatura dos refrigeradores;
- para exames: CIQ, CEQ, relação dos procedimentos, relação nominal da equipe, educação permanente e instruções de biossegurança (RDC 978/2025, arts. 110, 117 e 127);
- registros de treinamento da equipe (RDC 44/2009, art. 28) e PGRSS com comprovantes de coleta.

NO BALCÃO

No primeiro dia, abra a sala antes do expediente e confira: planilha de limpeza do dia anterior assinada, coletor de perfurocortantes abaixo de 3/4, glicosímetro com CIQ do lote em uso, tiras na validade, refrigerador com máxima e mínima anotadas, Declarações em branco com cabeçalho completo, kit de primeiros socorros no lugar. O checklist do material de apoio cobre o resto.

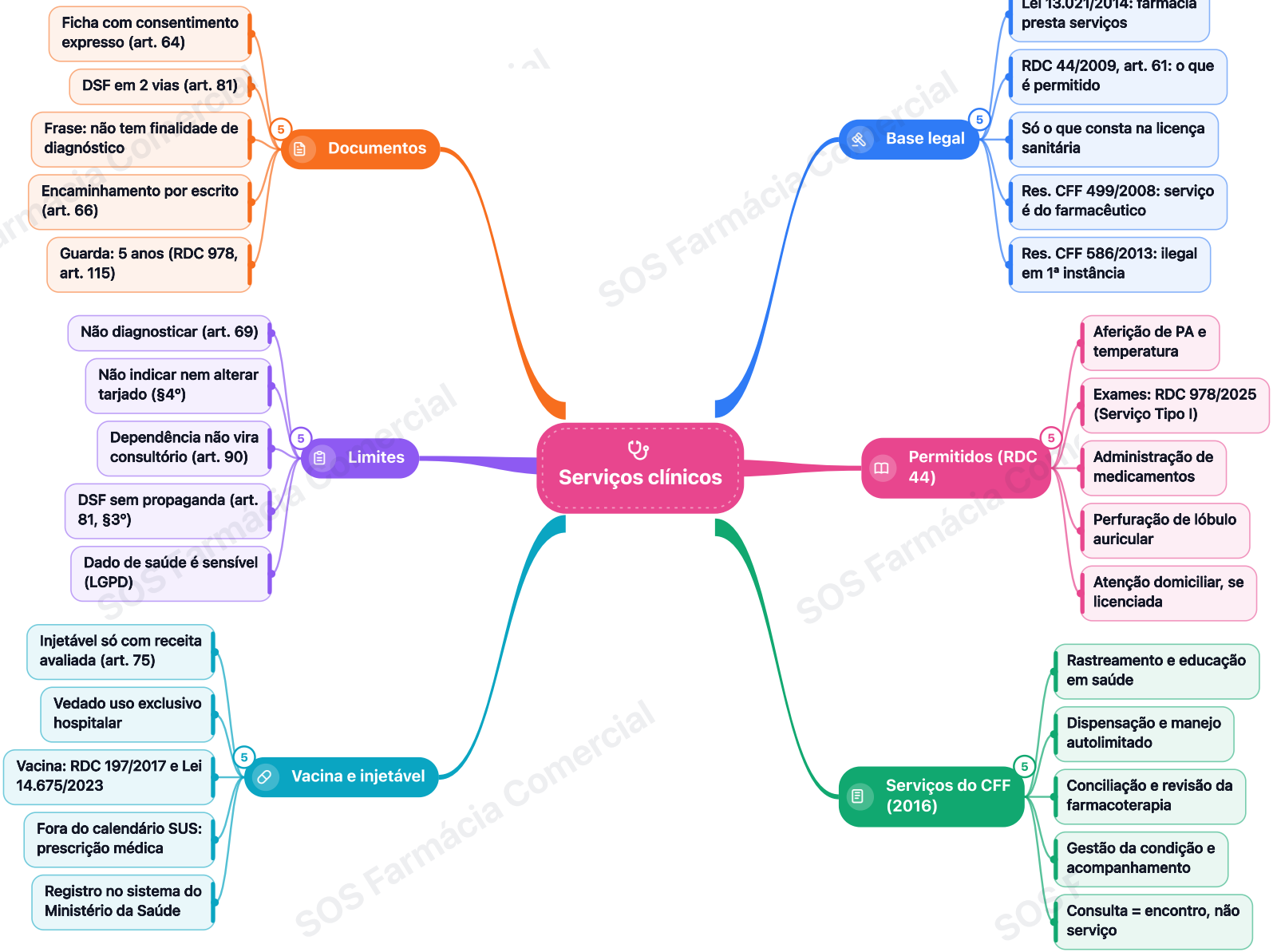
Fontes consultadas

1. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas (arts. 3º, 7º e 13). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
2. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (arts. 5º, II, e 11, II, f, e §4º), com redação da Lei nº 13.853/2019. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

3. Brasil. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 39, I).
4. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Texto consolidado com as alterações das RDC nº 41/2012, 786/2023 e 812/2023. AnvisaLegis, consultado em 15/10/2026.
5. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Funcionamento de serviços que executam exames de análises clínicas. Diário Oficial da União, 10 jun. 2025. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anvisa-n-978-de-6-de-junho-de-2025-635044217
6. Anvisa. Resolução RDC nº 986, de 15 de agosto de 2025. Altera a RDC nº 978/2025 (art. 10, I, entre outros). Texto consolidado da RDC 978/2025 no AnvisaLegis, consultado em 15/10/2026.
7. Anvisa. Perguntas e Respostas: Resolução da Diretoria Colegiada nº 978, de 06 de junho de 2025. 1ª edição. GGTES/GRECS, Brasília, 27 ago. 2025.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017. Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. Texto no AnvisaLegis, consultado em 15/10/2026.
9. Anvisa. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (conforme o módulo de POPs).
10. Brasil. Lei nº 14.675, de 14 de setembro de 2023. Funcionamento dos serviços privados de vacinação humana (conforme o módulo de POPs).
11. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf
12. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013, e situação judicial (ACP 0060624-78.2013.4.01.3400, sentença de 18/11/2024), conforme o módulo de MIP.
13. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 499, de 17 de dezembro de 2008 (arts. 1º e 21), citada em CRF-SP, Orientação Farmacêutica: Serviços Farmacêuticos (documento que já cita a RDC 978/2025). https://crfsp.org.br/images/2023/OrientacaoFarmaceutica/Servios_farmacuticos.pdf
14. Conselho Federal de Farmácia. Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual. Brasília: CFF, 2016. https://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_FINAL.pdf
15. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas não específicos: febre. Brasília: CFF, 2018 (Tabela 1 e Quadro 4; cita a RDC nº 145/2017). https://cff.org.br/userfiles/GuiaFebre.pdf
16. Brandão AA, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025. Arq Bras Cardiol. 2025;122(9):e20250624. doi:10.36660/abc.20250624 (texto completo no SciELO).
17. Feitosa ADM, et al. Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório 2023. Arq Bras Cardiol. 2024. doi:10.36660/abc.20240113 (PMC11186661).
18. Santa Catarina. Secretaria de Estado da Saúde. Informação nº 602/2025 DAPS/SES: posicionamento sobre a atualização dos parâmetros de hipertensão arterial em 2025 (comparação DBHA 2025 e PCDT de Hipertensão Arterial Sistêmica, Portaria SECTICS/MS nº 49/2025). 26 set. 2025.
19. Rodacki M, et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (última revisão 09/07/2024; exibido na edição 2026). https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/
20. Almeida-Pititto B, et al. Metas de controle glicêmico. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2026). doi:10.29327/5881296.2026-1
21. Marino EC, et al. Monitorização da glicemia capilar, da glicose intersticial (CGM) e cetonemia capilar em pessoas com diabetes mellitus. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2026). doi:10.29327/5937216.2026-1
22. Sparapani VC, et al. Práticas seguras para preparo e aplicação de insulina. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (edição 2026; doi:10.29327/5660187.2025-15).

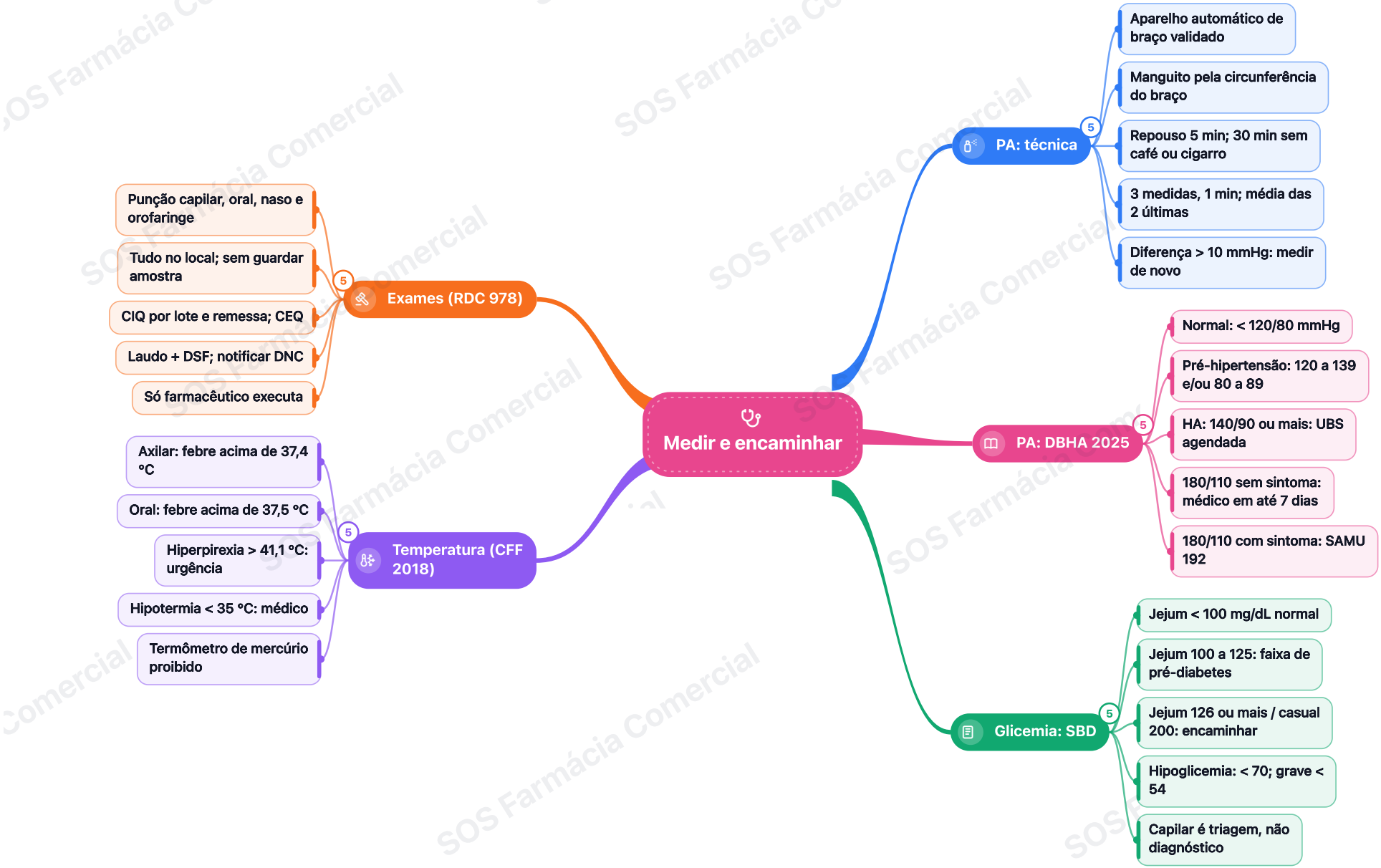
Serviços clínicos na drogaria

6 ramos · 30 itens · mapa mental do módulo 11



Aferições e exames: valores e condutas

5 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 11



Serviço, pode fazer?, requisitos, norma

Serviço	Pode fazer na drogaria?	Requisitos principais	Norma
Aferição de pressão arterial	Sim	Sala de serviços; aparelho regularizado e calibrado; POP; DSF com referência e frase	RDC 44/2009, arts. 15, 69, 71, 72 e 81
Temperatura corporal	Sim	Termômetro regularizado (sem mercúrio); POP com via e referência; DSF	RDC 44/2009, art. 69, §1º; RDC 145/2017
Glicemia capilar	Sim, como Serviço Tipo I	Licença com EAC; CNES; só farmacêutico; CIQ e CEQ; procedimento para resultado crítico; laudo e DSF	RDC 978/2025, arts. 8º a 14, 60, 63, 74, 119
Outros exames em punção capilar, cavidade oral, naso ou orofaringe	Sim, como Serviço Tipo I	Produto regularizado; tudo no local; sem metodologia própria; notificar doença de notificação compulsória	RDC 978/2025, art. 10 (redação RDC 986/2025), arts. 66 e 67
Exame em urina, fezes ou sangue venoso	Não	Fora do Tipo I; coleta venosa é de posto de coleta	RDC 978/2025, art. 10
Coletar e enviar amostra ao laboratório	Não	Farmácia não guarda nem transporta material biológico	RDC 978/2025, art. 10, III
Venda de autoteste	Sim (comércio)	Orientar leitura, conduta e descarte	RDC 978/2025, art. 4º
Administração de injetáveis	Sim	Receita avaliada; vedado uso exclusivo hospitalar; farmacêutico presente; registro de lote e registro Anvisa	RDC 44/2009, arts. 74 a 77 e 81; Res. CFF 499/2008, art. 21
Nebulização	Depende da vigilância local	Não citada na RDC 44/2009; confirmar enquadramento e licença	RDC 44/2009, art. 61, §§ 3º a 5º
Vacinação	Sim, com licença específica	CNES; RT e substituto; sala e refrigerador exclusivos; registro no sistema do MS; fora do calendário SUS só com prescrição médica	RDC 197/2017; Lei 14.675/2023; Res. CFF 654/2018
Perfuração de lóbulo auricular	Sim	Pistola e brinco regularizados; brinco estéril aberto na frente do usuário; POP; DSF com lotes	RDC 44/2009, arts. 78 a 81

Serviço	Pode fazer na drogaria?	Requisitos principais	Norma
Perfuração de cartilagem ou outra região	Não	Fora do art. 61	RDC 44/2009, art. 61, §5º
Atenção farmacêutica domiciliar	Só se licenciada	Licença e autorização específicas	RDC 44/2009, art. 68
Prescrição de medicamento tarjado	Não	Proibido indicar ou alterar tarjado; Res. CFF 586/2013 e 5/2025 contestadas judicialmente	RDC 44/2009, arts. 69, §4º, e 81, §3º
Medidas antropométricas (peso, IMC, cintura)	Confirmar com a vigilância	Não listadas como parâmetro fisiológico; usar como ação educativa	RDC 44/2009, art. 69, §1º

Todo serviço precisa constar da licença sanitária do estabelecimento e pode ter exigência adicional estadual ou municipal (RDC 44/2009, art. 61, §§ 3º e 4º).

Valores de referência e quando encaminhar

Medida	Valor	Conduta na farmácia	Fonte e ano
PA (média das 2 últimas de 3)	Abaixo de 120/80 mmHg	Orientar hábitos; medir ao menos 1 vez por ano	DBHA 2025
PA	120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg (pré-hipertensão)	Medidas não medicamentosas; avaliação de risco na UBS, sem urgência	DBHA 2025
PA	140/90 mmHg ou mais	Encaminhamento escrito para consulta agendada na unidade de saúde	DBHA 2025, cap. 14
PA	180/110 mmHg ou mais, sem sintomas	Avaliação médica precoce (diretriz: reavaliação em 1 a 7 dias); conferir adesão	DBHA 2025, cap. 11
PA	180/110 mmHg ou mais, com dor no peito, falta de ar, déficit neurológico ou confusão	SAMU 192	DBHA 2025, cap. 11
PA em gestante	140/90 mmHg ou mais	Pré-natal ou maternidade no mesmo dia	DBHA 2025, cap. 10 (definição)
Glicemia capilar de jejum (8 h ou mais)	Abaixo de 100 mg/dL	Orientar; rastreamento formal é exame de laboratório	SBD, critérios diagnósticos (texto 2024, edição 2026)
Glicemia capilar de jejum	100 a 125 mg/dL	Encaminhar para glicemia plasmática e HbA1c	SBD (texto 2024, edição 2026)

Medida	Valor	Conduta na farmácia	Fonte e ano
Glicemia capilar de jejum	126 mg/dL ou mais	Encaminhar com consulta agendada	SBD (texto 2024, edição 2026)
Glicemia capilar casual	200 mg/dL ou mais com sintomas	Encaminhar com prioridade	SBD (texto 2024, edição 2026)
Glicemia capilar	54 a 69 mg/dL (hipoglicemia nível 1)	Consciente: carboidrato de absorção rápida e nova medida	SBD 2026, metas de controle glicêmico
Glicemia capilar	Abaixo de 54 mg/dL ou confusão (níveis 2 e 3)	Inconsciente ou sem engolir: nada pela boca, SAMU 192	SBD 2026
Glicemia capilar	Leitura HI ou acima de 250 mg/dL com vômitos, sonolência, respiração rápida	Urgência	SBD 2026 (cetonemia em dia de doença no DM1)
Temperatura axilar	34,7 a 37,4 °C normal; acima de 37,4 °C febre	Avaliar sinais de alerta (módulo de MIP)	CFF, Guia de febre, 2018
Temperatura oral	35,5 a 37,5 °C normal; acima de 37,5 °C febre	Idem	CFF, 2018
Temperatura	Acima de 41,1 °C (hiperpirexia)	Urgência	CFF, 2018
Temperatura	Abaixo de 35 °C (hipotermia)	Atendimento médico	CFF, 2018
Temperatura em criança	Menor de 6 meses com 38 °C retal ou equivalente; maior de 6 meses com 40 °C ou mais	Encaminhar ao médico	CFF, 2018

Valores de triagem: não fecham diagnóstico (RDC 44/2009, art. 69; RDC 978/2025, art. 60). A Declaração de Serviço Farmacêutico traz o valor medido, a referência usada e a frase obrigatória.

SOS Farmácia Comercial

Aferição de PA no balcão

Cliente pede para medir a pressão; levar à sala de serviços

DECISÃO

Tem dor no peito, falta de ar, fraqueza ou dormência de um lado, alteração da fala ou da visão?

- **SIM** — Acionar SAMU 192 sem esperar a medida; registrar depois
- **NÃO** — Seguir para o preparo

DECISÃO

Fumou, tomou café, comeu ou bebeu álcool há menos de 30 min, ou fez exercício há menos de 90 min?

- **SIM** — Aguardar o intervalo na sala de espera
- **NÃO** — Seguir

Repouso de 5 min sentado; medir o braço e escolher o manguito

Três medidas com 1 min de intervalo; média das duas últimas (mais medidas se diferença > 10 mmHg)

DECISÃO

Média de 180/110 mmHg ou mais?

- **SIM** — Sem sintomas: avaliação médica no mesmo dia ou seguinte; com sintomas: SAMU 192
- **NÃO** — Classificar pela DBHA 2025

DECISÃO

Média de 140/90 mmHg ou mais?

- **SIM** — Encaminhamento escrito para consulta agendada na UBS
- **NÃO** — Normal ou pré-hipertensão: orientar hábitos e reavaliação

ATENÇÃO

Não indicar nem alterar anti-hipertensivo (RDC 44/2009, art. 69, §4º)

↓

Registrar com consentimento; entregar DSF com valores, referência e frase obrigatória

↓

Combinar retorno ou contato; higienizar braçadeira e mãos

SOS Farmácia Comercial

Glicemia capilar alterada

Resultado lido; CIQ do lote conferido antes do exame

DECISÃO

Valor abaixo de 70 mg/dL?

SIM
Ir para a conduta de hipoglicemia

NÃO
Seguir para valores altos

DECISÃO

Consciente e consegue engolir?

SIM
Carboidrato de absorção rápida, nova medida, não liberar dirigindo; encaminhar ao médico que acompanha

NÃO
Nada pela boca; SAMU 192

DECISÃO

Valor HI ou acima de 250 mg/dL com vômitos, dor abdominal, sonolência ou respiração rápida?

SIM
Encaminhar com urgência

NÃO
Interpretar pela condição (jejum ou casual)

DECISÃO

Sem diagnóstico de diabetes e jejum de 100 mg/dL ou mais, ou casual de 200 mg/dL ou mais?

SIM
Encaminhamento escrito para glicemia plasmática e HbA1c

NÃO
Com diabetes: comparar com a meta e revisar adesão e técnica

ATENÇÃO

Resultado não diagnostica; não indicar nem ajustar medicamento sob prescrição

Seguir o procedimento escrito para resultado crítico (RDC 978/2025, art. 119)

Entregar laudo e DSF com referência e frase obrigatória; registrar e combinar retorno

Modelo de Declaração de Serviço Farmacêutico (campos)

Campos montados a partir do art. 81 da RDC 44/2009. Os itens entre colchetes são preenchidos no atendimento; "quando houver" indica campo que só aparece se o serviço o exigir.

Bloco	Campos
Cabeçalho (papel do estabelecimento)	[Nome do estabelecimento] · [Endereço] · [Telefone] · [CNPJ] (§1º)
Título	DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO · [Serviço prestado] · [Data e hora]
Usuário	[Nome do usuário ou do responsável legal] (§1º)
Prescrição apresentada	Quando houver: [Medicamento prescrito] · [Nome e inscrição do prescritor no conselho] (§2º, I, a)
Medicamento isento indicado	Quando houver: [MIP pela DCB] · [Posologia] (§2º, I, b)
Parâmetros e exames	Quando houver: [Valor medido ou resultado, com unidade] · [Valor de referência e fonte] (§2º, I, c)
Frase obrigatória	Quando houver aferição ou exame: "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (§2º, I, d)
Medicamento administrado	Quando houver: [Nome comercial, exceto genérico] · [DCB] · [Concentração e forma farmacêutica] · [Via] · [Lote] · [Registro na Anvisa] (§2º, I, e)
Perfuração de lóbulo	Quando houver: brinco [fabricante, CNPJ, lote] · pistola [fabricante, CNPJ, lote] (§2º, II)
Orientação farmacêutica	[Texto da orientação] (§2º, I, f)
Plano de intervenção	Quando houver: [Encaminhamento, retorno, metas] (§2º, I, g)
Responsável	[Data] · [Assinatura] · [Carimbo com nome e CRF do farmacêutico] (§2º, I, h)
Vias	1ª via: usuário · 2ª via: arquivo do estabelecimento (§4º)

ATENÇÃO

Sem logotipo de laboratório, cupom ou propaganda, e sem indicação de medicamento que exige prescrição (art. 81, §3º). Em exame de análises clínicas, a farmácia entrega também o laudo com os itens do art. 167 da RDC 978/2025, e os dois podem formar um documento único.

Modelo de encaminhamento por escrito

Texto curto, com achados e sem diagnóstico. Entregue junto com a Declaração.

Campo	Exemplo de preenchimento (dados fictícios)
De	[Farmácia, endereço, telefone] · Farmacêutico [nome], CRF [UF e número]
Para	Médico da unidade de saúde de referência
Paciente	[Nome], [idade] anos
Motivo	PA elevada em aferição de triagem na farmácia
Achados	[Data e hora]: três medidas no braço direito, aparelho automático de braço, manguito adulto; média das duas últimas 152/96 mmHg. Nega dor torácica, dispneia e déficit neurológico.
Medicamentos em uso	[Lista com dose e horário, como o paciente usa]
Orientações dadas	Redução de sal; retorno à farmácia para nova aferição em [data]
Solicitação	Avaliação clínica em consulta agendada
Assinatura	[Data] · [Assinatura e carimbo com CRF]

Sala de serviços farmacêuticos pronta para a inspeção

- ◯ Licença sanitária lista cada serviço oferecido (PA, temperatura, EAC, injetáveis, lóbulo, vacinação)
- ◯ Farmácia que faz exames está inscrita no CNES
- ◯ Sala separada da dispensação, com privacidade e acesso ao sanitário que não passa por ela
- ◯ Lavatório com água, sabonete líquido, toalha descartável, gel antisséptico e lixeira com pedal e tampa
- ◯ Kit de primeiros socorros identificado e de fácil acesso
- ◯ Planilha de limpeza com registro no início e no fim de cada dia
- ◯ POP de cada serviço assinado, com técnica, referências, EPI e conduta em intercorrência
- ◯ Aparelho de PA automático de braço, regularizado, com registro de calibração no último ano
- ◯ Manguitos de pelo menos três tamanhos e fita métrica

- [ ] Termômetro regularizado, sem mercúrio
- [ ] Glicosímetro e tiras regularizados, tiras na validade, CIQ registrado por lote e remessa
- [ ] Comprovante de participação em controle externo da qualidade
- [ ] Procedimento escrito para resultado crítico afixado ou acessível na sala
- [ ] Refrigerador de reagentes ou vacinas com registro diário de máxima, mínima e momento
- [ ] Coletor de perfurocortantes rígido, identificado, abaixo de 3/4
- [ ] PGRSS e comprovantes de coleta de resíduos
- [ ] Declarações com cabeçalho completo (nome, endereço, telefone, CNPJ) e frase obrigatória
- [ ] Segundas vias das Declarações e fichas com consentimento arquivadas e acessíveis
- [ ] Lista atualizada dos serviços públicos de saúde próximos, com endereço e telefone
- [ ] Registros de treinamento da equipe e de educação permanente anual (para EAC)

Cartões de revisão: serviços clínicos

Pergunta	Resposta
Quais parâmetros fisiológicos a RDC 44/2009 permite aferir?	Somente pressão arterial e temperatura corporal (art. 69, §1º).
Que norma rege a glicemia capilar feita na farmácia?	A RDC 978/2025, alterada pela RDC 986/2025: a farmácia precisa estar classificada como Serviço Tipo I.
Quais amostras o Serviço Tipo I pode usar?	Punção capilar, cavidade oral, nasofaringe ou orofaringe (art. 10, I, redação da RDC 986/2025).
Balconista pode fazer glicemia capilar?	Não. Na farmácia, só o farmacêutico executa exame de análises clínicas (Anvisa, Perguntas e Respostas, 2025).
Qual a finalidade do exame feito na farmácia?	Triagem, sem fins confirmatórios (RDC 978/2025, art. 60).
Por quanto tempo guardar os registros de exames?	No mínimo 5 anos (RDC 978/2025, art. 115).
Técnica de PA da DBHA 2025: quantas medidas?	Três, com intervalo de 1 minuto, usando a média das duas últimas; mais medidas se diferença > 10 mmHg.
Pré-hipertensão pela DBHA 2025	Sistólica 120 a 139 e/ou diastólica 80 a 89 mmHg.

Pergunta	Resposta
PA de 180/110 mmHg com dor no peito: conduta?	Suspeita de emergência hipertensiva: acionar o SAMU (192).
Preparo antes da medida da PA (SBC, 2023)	Bexiga vazia; 90 min sem exercício; 30 min sem café, álcool, comida ou cigarro; 5 min de repouso.
Glicemia de jejum na faixa de pré-diabetes (SBD)	100 a 125 mg/dL.
Hipoglicemia nível 2 (SBD 2026)	Glicemia abaixo de 54 mg/dL.
Frase obrigatória na DSF com aferição ou exame	"ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (art. 81, §2º, I, d).
Quantas vias tem a Declaração de Serviço Farmacêutico?	Duas: a primeira para o usuário e a segunda arquivada (RDC 44/2009, art. 81, §4º).
Injetável que exige receita: condição para aplicar	Receita apresentada e avaliada pelo farmacêutico, validade conferida (RDC 44/2009, art. 75).
Vacina fora do Calendário Nacional em farmácia privada	Só com prescrição médica, e a dispensação fica vinculada à administração (RDC 197/2017, art. 14).
Febre axilar pelo guia do CFF (2018)	Acima de 37,4 °C.
Caneta de insulina: tempo com o botão pressionado	No mínimo 10 segundos, retirando a agulha com o botão ainda pressionado (SBD).
Teste de gravidez em urina pode ser executado na farmácia?	Não: urina não é amostra do Tipo I. A venda do autoteste é livre.

Questões: serviços clínicos na farmácia comercial

1. Uma drogaria licenciada para aferir parâmetros fisiológicos quer ampliar os serviços. Considerando a RDC 44/2009 e a RDC 978/2025, assinale a alternativa correta.

A Peso e altura estão entre os parâmetros fisiológicos listados na RDC 44/2009.

B A glicemia capilar segue como parâmetro bioquímico da RDC 44/2009, sem controle de qualidade.

C Exame em amostra de urina é permitido se o resultado sair na hora, no próprio local.

D A glicemia capilar exige classificação como Serviço Tipo I, com CIQ e CEQ.

E O balconista treinado pode executar a glicemia sob supervisão do farmacêutico.

2. O farmacêutico afere a pressão de um cliente de 50 anos com aparelho automático de braço. Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, o valor a registrar é:

A a média das duas últimas de três medidas feitas com 1 minuto de intervalo

B a primeira medida, feita logo após o cliente sentar, sem repouso prévio

C o maior valor entre três medidas feitas no mesmo braço em 5 minutos

D a média de duas medidas, uma em cada braço, feitas ao mesmo tempo na primeira consulta

E o menor valor obtido, para reduzir o efeito do avental branco

3. Adulto sem diagnóstico de hipertensão tem média de 134/86 mmHg, com técnica correta, na farmácia. Pela DBHA 2025, a classificação e a conduta adequadas são:

A PA normal; orientar a medir de novo daqui a cinco anos

B hipertensão estágio 1; acionar o SAMU pelo risco imediato

C hipertensão estágio 2; orientar iniciar anti-hipertensivo hoje

D PA ótima; nenhuma orientação é necessária no momento

E pré-hipertensão; medidas não medicamentosas e reavaliação

4. Hipertenso de 63 anos, em tratamento, tem média de 186/114 mmHg na farmácia. Nega dor no peito, falta de ar, alteração neurológica ou visual. Qual a conduta adequada?

A Indicar uma dose extra do anti-hipertensivo e repetir a medida em 1 hora.

B Orientar avaliação médica precoce, conferir a adesão e encaminhar por escrito.

C Acionar o SAMU, pois o valor isolado acima de 180/110 mmHg já define emergência hipertensiva.

D Considerar o valor aceitável por se tratar de hipertenso em tratamento.

E Oferecer captopril sublingual e liberar o cliente após nova medida.

5. Mulher de 47 anos, sem diagnóstico de diabetes, faz glicemia capilar em jejum de 10 horas na farmácia Tipo I: 112 mg/dL. Qual a conduta correta?

A Registrar o diagnóstico de pré-diabetes na Declaração de Serviço Farmacêutico.

B Indicar metformina e marcar retorno na farmácia em 30 dias.

C Encaminhar por escrito para glicemia plasmática e HbA1c, como resultado de triagem.

D Considerar normal, pois o limite superior da glicemia capilar de jejum é de 140 mg/dL.

E Repetir a glicemia capilar até obter valor abaixo de 100 mg/dL.

6. Senhora de 70 anos, em uso de insulina, chega suada e trêmula. Glicemia capilar: 48 mg/dL. Está consciente e consegue engolir. A conduta imediata é:

A registrar o valor na Declaração e orientar a procurar o médico que a acompanha na próxima semana

B aplicar insulina rápida para corrigir o desequilíbrio da glicose

C não oferecer nada e aguardar a melhora espontânea na sala

D oferecer carboidrato de absorção rápida, medir de novo e não liberá-la sozinha

E encaminhá-la a pé ao pronto-socorro, sem nova medida

7. Sobre a Declaração de Serviço Farmacêutico da RDC 44/2009, assinale a correta.

A É emitida em duas vias: uma para o usuário e outra arquivada na farmácia.

B Pode trazer o logotipo do laboratório que patrocinou a campanha de saúde da farmácia.

C Pode indicar medicamento tarjado quando a pressão aferida estiver alta.

D Dispensa a frase de alerta quando o valor medido está dentro do normal.

E Só é obrigatória quando o serviço farmacêutico for cobrado do cliente.

8. Farmácia licenciada para vacinação recebe pedido de cliente que quer comprar uma vacina que não consta do Calendário Nacional de Vacinação, para aplicar na clínica de um amigo. Pela RDC 197/2017, a farmácia deve:

A vender, pois a vacina fora do calendário dispensa prescrição na rede privada

B vender, desde que o cliente transporte a vacina em caixa térmica com gelo

C aplicar sem receita, porque a farmácia já tem licença sanitária para vacinar

D vender e anotar lote e validade no cartão de vacinação do próprio cliente

E só aplicar na farmácia, com prescrição médica, sem vender para uso externo

9. Farmácia classificada como Serviço Tipo I faz teste rápido de sífilis em sangue capilar, com resultado reagente. Assinale a alternativa correta.

A O resultado confirma o diagnóstico e dispensa outros exames.

B A suspeita é notificada e a pessoa é encaminhada para confirmação.

C A farmácia guarda a amostra e a envia ao laboratório de apoio para confirmação.

D O resultado pode ser informado ao acompanhante sem autorização.

E Teste em sangue capilar é proibido em qualquer farmácia.

10. Sobre a administração de medicamentos em drogaria, segundo a RDC 44/2009, é correto afirmar:

A Medicamentos de uso exclusivo hospitalar podem ser aplicados se houver receita.

B A sobra de frasco multidose fica guardada na farmácia para a próxima aplicação.

C Medicamento sob prescrição pode ser aplicado sem receita se o cliente já o usou antes.

D A Declaração registra o lote e o número de registro na Anvisa do medicamento aplicado.

E A aplicação dispensa o farmacêutico na loja quando é feita por técnico experiente e treinado.

11. A gerência da rede pede ao farmacêutico a lista de nomes e glicemias dos clientes atendidos na campanha, para enviar ofertas de tiras reagentes. O farmacêutico deve considerar que:

A é permitido, pois o cliente assinou o consentimento para o registro do serviço

B é permitido, desde que as ofertas sejam enviadas apenas por e-mail

C é vedado, pois os dados do serviço são sigilosos e de uso exclusivo dele

D é permitido para quem teve glicemia alterada, por interesse sanitário

E é vedado apenas no caso de clientes menores de 18 anos

12. Adulto tem temperatura axilar de 37,6 °C medida na farmácia com termômetro digital. Pela tabela do guia de febre do CFF (2018), ele:

A está em normotermia, pois o limite axilar de febre é 38,5 °C

B tem febre, pois a normotermia axilar vai até 37,4 °C

C tem hiperpirexia e deve ser levado à urgência agora

D tem hipotermia e precisa ser aquecido antes de nova medida

E precisa repetir a medida por via retal, a única aceita

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **D**. Correta a D: a glicemia capilar é exame de análises clínicas e a farmácia precisa ser Serviço Tipo I (RDC 978/2025, arts. 8º e 10), com CIQ e CEQ (arts. 183 e 185). A: a RDC 44/2009 só lista PA e temperatura (art. 69, §1º). B: o §2º do art. 69 e o art. 70, que tratavam da glicemia, foram revogados. C: urina não é amostra do Tipo I (art. 10, I). E: na farmácia, só o farmacêutico executa EAC (Perguntas e Respostas da Anvisa, 2025).
2. **A**. Correta a A: a DBHA 2025 (Quadro 3.1) recomenda três medidas com intervalo de 1 minuto e a média das duas últimas, com medidas adicionais se a diferença passar de 10 mmHg. B ignora o repouso de 5 minutos. C e E escolhem um valor isolado, o que a técnica não prevê. D confunde a medida inicial nos dois braços, que serve para escolher o braço de referência, com o valor final.
3. **E**. Correta a E: a DBHA 2025 define pré-hipertensão como 120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg e recomenda medidas não medicamentosas. A e D: normal é abaixo de 120/80 mmHg, e a categoria PA ótima deixou de existir na DBHA 2025. B e C: hipertensão começa em 140/90 mmHg; além disso, a farmácia não indica medicamento sob prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º).
4. **B**. Correta a B: sem sintomas, a DBHA 2025 trata como elevação importante sem lesão aguda de órgão-alvo, com reavaliação médica precoce (1 a 7 dias). A e E: a farmácia não indica nem altera medicamento sob prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º). C: emergência hipertensiva se define pela lesão aguda de órgão-alvo, não só pelo número. D: 180/110 mmHg ou mais é estágio 3 e pede avaliação.
5. **C**. Correta a C: o exame na farmácia é de triagem, sem fins confirmatórios (RDC 978/2025, art. 60), e a SBD usa glicemia plasmática e HbA1c para diagnóstico; 100 a 125 mg/dL em jejum é a faixa de pré-diabetes. A: farmácia não registra diagnóstico. B: metformina exige prescrição (RDC 44/2009, art. 69, §4º). D: o limite normal de jejum é abaixo de 100 mg/dL. E: repetir até o valor agradar não tem base técnica.
6. **D**. Correta a D: 48 mg/dL é hipoglicemia nível 2 (abaixo de 54 mg/dL, SBD 2026); com a pessoa consciente e capaz de engolir, oferece-se carboidrato de absorção rápida, repete-se a medida e não se libera a pessoa sozinha; se houver confusão ou incapacidade de engolir, SAMU. A adia uma situação crítica (RDC 978/2025, art. 119). B piora a hipoglicemia. C e E deixam a pessoa sem tratamento.
7. **A**. Correta a A (art. 81, §4º). B e C: é proibido usar a Declaração para propaganda ou para indicar medicamento que exige prescrição (art. 81, §3º). D: a frase é exigida quando houver aferição ou exame, independentemente do resultado (§2º, I, d). E: a Declaração é entregue após a prestação de qualquer serviço farmacêutico (art. 81, caput).
8. **E**. Correta a E: vacina fora do Calendário Nacional, em estabelecimento privado, só é administrada com prescrição médica, e a dispensação deve estar vinculada à administração (RDC 197/2017, art. 14 e parágrafo único). A e C contrariam a exigência de prescrição. B e D permitem venda para aplicação externa, vedada pelo parágrafo único do art. 14.
9. **B**. Correta a B: resultado que indique suspeita de doença de notificação compulsória é notificado também pela farmácia (RDC 978/2025, art. 66), e o exame na farmácia é de triagem (art. 60), seguindo as diretrizes de diagnóstico do Ministério da Saúde (art. 67). A contraria o art. 60. C: o Tipo I não guarda nem transporta material biológico (art. 10, III). D fere o sigilo (RDC 44/2009, art. 82). E: punção capilar é amostra permitida ao Tipo I (art. 10, I).
10. **D**. Correta a D (art. 81, §2º, I, e). A: é vedada a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar (art. 74, parágrafo único). B: a sobra é entregue ao usuário, e é vedado guardar embalagem primária violada (art. 76). C: é preciso receita avaliada pelo farmacêutico (art. 75). E: a presença ou supervisão do farmacêutico é condição essencial (Resolução CFF 499/2008, art. 21).
11. **C**. Correta a C: os dados dos serviços farmacêuticos são sigilosos e não podem ser usados para finalidade diversa (RDC 44/2009, art. 82); dado de saúde é sensível, e seu compartilhamento para vantagem econômica é vedado (Lei 13.709/2018, arts. 5º, II, e 11, §4º). A: o consentimento do art. 64 cobre o registro do serviço, não a oferta comercial. B, D e E criam exceções que a norma não prevê.

12. **B**. Correta a B: o guia do CFF (2018, Tabela 1) adota normotermia axilar de 34,7 a 37,4 °C e febre acima de 37,4 °C. A usa limite inexistente na tabela. C: hiperpirexia é acima de 41,1 °C. D: hipotermia é temperatura interna abaixo de 35 °C. E: o guia não recomenda a via retal na farmácia.

SOS Farmácia Comercial

Módulo 12

Medicamentos isentos de prescrição

Conceito, enquadramento e lista vigente de MIP, atendimento e indicação farmacêutica no balcão, classes e posologia dos MIP mais dispensados e a prescrição farmacêutica regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013.

- Conceito e base legal dos MIP
- Consulta à lista de MIP e armadilhas
- Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica
- Sinais de alerta e encaminhamento
- Populações especiais no balcão
- Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013
- Documentação e ética no atendimento
- Analgésicos e antitérmicos
- Anti-inflamatórios isentos de prescrição
- Aparelho digestivo
- Tosse, gripe e resfriado
- Antialérgicos isentos de prescrição
- Pele e mucosas
- Antiparasitários intestinais
- Vitaminas, minerais e suplementos
- Olhos, ouvidos e boca
- Outros produtos de balcão

Conceito e base legal dos MIP

Medicamento isento de prescrição (MIP) é aquele que **pode ser dispensado sem exigência de prescrição**. A definição está na norma que hoje rege o tema, a RDC nº 882/2024 da Anvisa (art. 2º, I). No mercado, o MIP também é chamado de medicamento de venda livre ou OTC (do inglês *over the counter*). O termo "venda livre" engana: o MIP continua sendo medicamento, só pode ser comercializado em farmácia ou drogaria e exige orientação de quem o dispensa.

A categoria de venda pertence ao *produto registrado* e a cada uma das suas apresentações. A mesma substância pode ser MIP em uma forma farmacêutica e concentração e exigir receita em outra. Por isso, no balcão, a verificação se faz sobre a apresentação que está na mão do cliente e a indicação pretendida.

Arcabouço legal

O enquadramento do MIP se apoia em leis federais, que dão a moldura, e em normas da Anvisa, que detalham critérios, lista, exposição e propaganda. O estudante precisa saber o papel de cada uma, porque provas e fiscalizações cobram exatamente essa correspondência.

Norma	O que interessa para o MIP
Lei nº 5.991/1973	Define dispensação (art. 4º, XV) e drogaria (art. 4º, XI). O comércio de medicamentos é privativo das empresas e estabelecimentos definidos na lei (art. 5º) e a dispensação é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento, unidade volante e dispensário (art. 6º). Vale para o MIP.
Lei nº 13.021/2014	Farmácia é unidade de prestação de serviços de assistência farmacêutica e assistência à saúde (art. 3º). Exige farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (art. 6º, I) e impõe ao farmacêutico o dever de orientar sobre benefício e risco, conservação, uso e interações (art. 13, VI).
RDC nº 882/2024	Critérios e procedimentos para enquadrar um medicamento como MIP e para reenquadrá-lo como sob prescrição. Em vigor desde 1º/7/2024. Revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27).
IN nº 285/2024	Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), em vigor desde 1º/4/2024, com anexos atualizados pela IN nº 388/2025 (art. 1º e Anexo II) e pela IN nº 404/2025 (Anexo I).
RDC nº 44/2009	Boas práticas em farmácias e drogarias: MIP pode ficar ao alcance do usuário (art. 40, §2º), cartaz obrigatório (art. 41), venda remota (art. 52) e Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).
RDC nº 96/2008	Propaganda e publicidade de medicamentos. Só o MIP pode ser anunciado ao público leigo, com advertências obrigatórias (arts. 22 a 26).
Lei nº 6.437/1977	Tipifica as infrações sanitárias. A RDC nº 882/2024 remete a ela em caso de descumprimento (art. 21).

Até 2016 o enquadramento seguia a RDC nº 138/2003, que trabalhava com uma relação de grupos e indicações terapêuticas especificadas (a chamada lista GITE): era isento o medicamento cujo grupo e indicação apareciam na relação. A RDC nº 98/2016 trocou esse modelo por critérios técnicos explícitos e por uma lista de fármacos (a LMIP), publicada por Instrução Normativa: IN nº 11/2016, IN nº 86/2021, IN nº

120/2022 e, hoje, IN nº 285/2024. Em 2024 a RDC nº 98/2016 foi substituída pela RDC nº 882/2024, que manteve a lógica de critérios mais lista. Material didático antigo que ainda cita a RDC nº 98/2016 como vigente está desatualizado.

Critérios de enquadramento

A RDC nº 882/2024 exige que o medicamento comprove, ao mesmo tempo, todos os critérios do art. 4º. Eles explicam por que alguns fármacos são MIP e outros, muito usados, não são.

Critério (art. 4º)	O que significa na prática
I. Tempo de comercialização	10 anos de mercado, sendo pelo menos 5 no Brasil como medicamento sob prescrição; ou 5 anos no exterior como isento, em país com critérios compatíveis. Vale para as mesmas concentrações, posologia, indicações, população, via e restrições.
II. Segurança	Reações adversas conhecidas e reversíveis com a suspensão; baixo potencial de toxicidade (efeito grave só com grande quantidade, janela terapêutica segura); baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar clinicamente relevante.
III. Indicação	Doença não grave, de evolução inexistente ou muito lenta, com sinais e sintomas facilmente percebidos pelo paciente, pelo cuidador ou pelo farmacêutico, sem necessidade de exame laboratorial ou consulta com prescritor.
IV. Tempo de uso	Uso por curto período ou pelo tempo previsto em bula, exceto os de uso preventivo.
V. Manejo	Manejável pelo próprio paciente, pelo cuidador ou mediante orientação do farmacêutico.
VI. Baixo risco de mau uso, abuso e intoxicação	Pouco risco de uso para outra finalidade, de uso acima da dose ou do tempo recomendados e de intoxicação.
VII. Dependência	Não pode ter potencial de causar dependência.

O QUE DIZ A NORMA

"As formas farmacêuticas injetáveis e os produtos de terapia avançada não são passíveis de enquadramento como MIP." (RDC nº 882/2024, art. 5º). E ainda: o enquadramento de fármacos isolados como MIP "não garante que a associação em doses fixas ou razão fixa de doses seja enquadrada como MIP" (art. 10).

O art. 10 é uma das regras mais cobradas. Se o paracetamol e a cafeína são MIP isoladamente, a associação dos dois precisa cumprir de novo os critérios do art. 4º. A única facilidade é que o prazo de comercialização do inciso I é dispensado quando todos os componentes já fazem parte de um MIP.

Quem pede, quem decide e quanto tempo leva

O farmacêutico de balcão não pede enquadramento. Quem solicita é a empresa detentora do registro. Há dois caminhos:

- **Na petição de registro** de um medicamento novo, com os dados que sustentam o enquadramento (art. 6º). Esse caminho não se aplica a genéricos e similares (art. 6º, §2º).
- **Por petição de enquadramento** de um medicamento já registrado como sob prescrição, para todas as condições aprovadas ou só para parte delas, como uma concentração menor, uma indicação ou uma população (art. 7º).

A empresa apresenta relatório técnico e o Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (art. 9º). A decisão é da Diretoria Colegiada da Anvisa e se materializa na atualização da LMIP (art. 11). Depois da publicação, as empresas têm 180 dias para adequar o registro (art. 13) e, se o produto for excluído da lista por deixar de cumprir algum critério, outros 180 dias para voltar à categoria sob prescrição (art. 17). O enquadramento pode ser revisto a qualquer momento (art. 20).

Duas regras finais da RDC nº 882/2024 mudam a rotina de quem confere categoria de venda:

- Medicamentos registrados como MIP antes da lista e que não aparecem nela **continuam MIP** até que a Anvisa avalie a pertinência do enquadramento (art. 18). A ausência na LMIP não transforma, sozinha, um MIP antigo em medicamento tarjado.
- Um mesmo registro pode ter apresentações isentas e apresentações sob prescrição, desde que distinguíveis por rótulo, bula e complemento de nome (art. 14). O complemento de nome é dispensado nos genéricos (art. 14, §2º).

Exposição, autosserviço e venda a distância

A RDC nº 44/2009 manda manter os medicamentos em área de circulação restrita aos funcionários (art. 40, §1º). O MIP é a exceção: pode permanecer ao alcance dos usuários, em autosserviço (art. 40, §2º, com redação da RDC nº 41/2012). Para isso há três condições:

- MIP do mesmo princípio ativo, ou da mesma associação, ficam juntos e identificados de forma visível pela DCB (art. 41, §1º).
- MIP ficam separados dos demais produtos da área de autosserviço, como cosméticos e alimentos (art. 41, §2º).
- Na área de medicamentos deve haver cartaz legível com a frase "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41).

Um medicamento recém-enquadrado só pode ir para o autosserviço depois que a empresa adequar bula e rotulagem (RDC nº 882/2024, art. 19). Na venda por telefone ou internet, o MIP pode ser dispensado por farmácia ou drogaria aberta ao público, com farmacêutico presente durante todo o horário (RDC nº 44/2009, art. 52). Para medicamento sujeito a prescrição solicitado a distância, a receita precisa ser apresentada e avaliada pelo farmacêutico (art. 52, §1º); para controlados, a venda remota é vedada, salvo exceção prevista em norma específica (art. 52, §2º, redação da RDC nº 812/2023).

Propaganda, embalagem e bula

Pela RDC nº 96/2008, só o MIP pode ser anunciado ao público em geral. Medicamento sob prescrição tem propaganda restrita a meios dirigidos a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar (art. 27). A peça de MIP deve trazer nome comercial, DCB com pelo menos 50% do tamanho do nome comercial e número de registro (art. 22), além da advertência específica da substância ou, na falta dela, a frase padrão

"É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA" (art. 23).

São vedados, entre outros: estimular o uso indiscriminado, sugerir diagnóstico ao público, mostrar pessoas usando o medicamento (art. 8º), usar expressões como "comprovado cientificamente" e sugerir que o MIP dispensa hábitos saudáveis ou a consulta médica (art. 26). Programas de fidelidade da farmácia não podem usar medicamentos como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio (art. 10). Comparação de preços dirigida ao consumidor só pode ser feita entre medicamentos intercambiáveis (art. 11).

Na embalagem, o MIP não traz tarja; o medicamento sob prescrição traz a tarja vermelha com a frase de restrição. Quando coexistem apresentações isentas e tarjadas no mesmo registro, rótulo, bula e complemento de nome precisam permitir distinguir uma da outra (RDC nº 882/2024, art. 14, §1º). Na mudança de categoria, a única alteração permitida no texto de bula é a decorrente da própria mudança (art. 13, §2º).

O que o enquadramento como MIP não autoriza

ATENÇÃO

Isento de prescrição não significa isento de risco. Os critérios falam em risco *baixo* nas condições de uso da bula. Fora delas o perfil muda: paracetamol acima da dose máxima lesa o fígado, dipirona pode causar agranulocitose, AINE causa sangramento digestivo e lesão renal, anti-histamínico de primeira geração seda e provoca quedas no idoso, descongestionante sistêmico eleva a pressão arterial.

- Não autoriza venda fora de farmácia ou drogaria (Lei nº 5.991/1973, arts. 5º e 6º).
- Não dispensa a orientação: o dever de orientar é do farmacêutico, em qualquer dispensação (Lei nº 13.021/2014, art. 13, VI; RDC nº 44/2009, art. 42).
- Não torna o MIP adequado para qualquer pessoa: gestantes, crianças pequenas, idosos frágeis e pacientes com doença crônica exigem avaliação própria.
- Não autoriza uso prolongado: o critério IV pressupõe uso curto ou pelo tempo da bula. Sintoma que persiste além do prazo da bula é motivo de encaminhamento.
- Não libera a indicação por quem não é farmacêutico. Indicar um MIP para um problema de saúde relatado pelo cliente é ato do farmacêutico, que o documenta (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV; RDC nº 44/2009, art. 81, §2º, I, b).
- Não permite propaganda livre nem bonificação de balconista para "empurrar" marca.

NO BALCÃO

Quando o cliente pega um MIP na gôndola e vai direto ao caixa, a dispensação não acabou. Um contato curto resolve a maior parte dos riscos: "Para quem é? Já usou antes? Usa algum outro remédio? Tem pressão alta, problema de estômago, de rim ou está grávida?". Em seguida, reforce dose máxima, intervalo e por quantos dias usar antes de procurar atendimento.

CASO

Senhora de 68 anos leva da gôndola três caixas de um antigripal com paracetamol, fenilefrina e clorfeniramina e um frasco de dipirona. Na conversa, conta que é hipertensa e que "a gripe já dura cinco dias". O farmacêutico explica que a fenilefrina pode elevar a pressão, que a clorfeniramina é anti-histamínico de primeira geração (sedação e risco de queda), que a associação com outro analgésico duplica o efeito antitérmico sem necessidade e que a quantidade é excessiva. Orienta repouso, hidratação e soro fisiológico nasal, indica um analgésico isolado em dose correta e combina reavaliação: se a febre passar de três dias, deve procurar atendimento.

Consulta à lista de MIP e armadilhas

A Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) é publicada pela Instrução Normativa nº 285/2024 e atualizada por outras INs que alteram seus anexos. Saber ler a lista evita dois erros opostos: vender sem receita um produto tarjado e recusar sem motivo um MIP legítimo.

Estrutura da lista

A IN nº 285/2024 tem dois anexos. O Anexo I reúne medicamentos sintéticos, específicos e biológicos, em colunas: fármaco, subgrupo terapêutico ou farmacológico (código ATC), forma farmacêutica, concentração máxima e indicação terapêutica simplificada. O Anexo II reúne os fitoterápicos, em colunas: espécie, classe terapêutica, parte empregada, indicações e via de administração. A RDC nº 882/2024 (art. 12, §1º e §2º) fixa esse conteúdo mínimo e acrescenta as restrições de uso.

O QUE DIZ A NORMA

A caracterização como isento "ocorre para um produto com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêutica, indicação(ões) terapêutica(s) e com concentração igual ou inferior àqueles indicados em cada linha da LMIP". A coluna "concentração máxima" "refere-se à dose do insumo farmacêutico ativo presente na forma farmacêutica, não se referindo à dose posológica" (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, I e II).

Para fitoterápicos, a isenção vale para produto com a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha (art. 1º, §3º). As indicações da lista são simplificações das indicações da bula do profissional (art. 1º, §1º).

Como consultar no dia a dia

1. Abra o texto consolidado da IN nº 285/2024 no AnvisaLegis (sistema de legislação da Anvisa). O próprio texto mostra "redação dada por" em cada anexo, o que garante que a versão é a atual. Em outubro de 2026, o Anexo I estava com a redação da IN nº 404/2025 e o Anexo II com a da IN nº 388/2025.
2. Busque pela DCB do fármaco, inclusive o sal ("cloridrato de", "maleato de"), e leia todas as linhas: um fármaco costuma ter uma linha por forma farmacêutica.
3. Compare quatro elementos com o produto na mão: fármaco ou associação, forma farmacêutica, concentração por unidade e indicação pretendida.

4. Confirme na embalagem (ausência de tarja) e, se houver dúvida, na consulta de produtos registrados da Anvisa. Lembre que MIP antigos fora da lista mantêm a categoria até reavaliação (RDC nº 882/2024, art. 18).

PONTO-CHAVE

A categoria de venda depende do conjunto fármaco, forma farmacêutica, concentração, indicação e via. Mudou qualquer um desses elementos, mudou a análise.

Armadilhas mais comuns

Os exemplos abaixo foram conferidos no texto consolidado da LMIP (IN nº 285/2024, Anexo I, redação da IN nº 404/2025). Eles mostram como a mesma substância muda de categoria conforme apresentação, associação e via.

Situação	Na LMIP	Fora da LMIP (exige análise do registro, em geral tarjado)
Via de administração	Diclofenaco gel e solução dermatológica (dor musculoesquelética); nimesulida gel 20 mg/g; cetoconazol creme e xampu; metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea)	Diclofenaco, nimesulida e cetoconazol por via oral; metronidazol oral
Concentração e forma	Ibuprofeno 400 mg (comprimido, cápsula); liberação prolongada 600 mg (200 mg imediata + 400 mg prolongada); suspensão oral até 200 mg/mL	Ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata
População	Ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL tem indicação restrita a adultos	Uso dessa concentração em criança
Indicação específica	Omeprazol 20 mg cápsula, para alívio de azia e queimação frequentes (dois ou mais dias na semana), incluído pela IN nº 404/2025	Omeprazol 40 mg; outros inibidores da bomba de prótons; uso para outras indicações
Associação	Maleato de dexclorfeniramina isolado (comprimido, creme, solução oral); nafazolina em colírio associado à feniramina ou ao sulfato de zinco	Dexclorfeniramina associada a corticoide sistêmico (o corticoide não é MIP; RDC nº 882/2024, art. 10)
Antiparasitários	Mebendazol comprimido 500 mg e suspensão 20 mg/mL; permetrina emulsão ou suspensão dermatológica 10 mg/mL (pediculose) e 50 mg/mL (escabiose)	Albendazol e ivermectina não constam da lista
Antifúngicos	Clotrimazol creme dermatológico e vaginal, comprimido vaginal 500 mg; miconazol creme e creme vaginal; terbinafina creme e solução tópica; ciclopirox esmalte	Fluconazol, itraconazol e terbinafina por via oral não constam
Corticoide tópico	Acetato de hidrocortisona creme ou pomada 10 mg/g	Outros corticoides tópicos não constam: confira o registro

Outras linhas que costumam surpreender o estudante: fenazopiridina 200 mg (alívio de dor e ardor ao urinar, sem tratar a infecção); nicotina em adesivo de até 21 mg e em goma ou pastilha de até 4 mg; naproxeno 500 mg e naproxeno sódico 550 mg; butilbrometo de escopolamina 10 mg e suas associações com dipirona ou paracetamol; sulfato de neomicina pomada; penciclovir creme 10 mg/g para herpes labial; anti-histamínicos de segunda geração (loratadina, desloratadina, levocetirizina, fexofenadina 180 mg, ebastina).

ATENÇÃO

Estar na LMIP não torna o produto adequado para a queixa do cliente. A fenazopiridina alivia o ardor, mas pode mascarar uma infecção urinária que precisa de antibiótico; o omeprazol MIP é para azia frequente sem sinais de alarme e por curso curto, conforme a bula; o neomicina tópico não trata infecção de pele extensa. A lista informa a categoria de venda; a adequação ao paciente depende da avaliação do farmacêutico.

Fitoterápicos isentos

No Anexo II a análise é por espécie, parte da planta e indicação, e a via aparece na própria coluna de indicação. Exemplos: *Aesculus hippocastanum* (castanha-da-índia), sementes, uso oral, para sintomas de insuficiência venosa nas pernas; *Arnica montana*, capítulo floral, uso tópico, para equimoses e contusões; *Althaea officinalis*, raízes, uso oral, para irritação da garganta e tosse seca associada. Um produto de arnica para uso oral, por exemplo, não se apoia nessa linha.

Mudanças da lista

A LMIP muda com frequência. Em 2025, a IN nº 388/2025 alterou o Anexo II e o art. 1º, e a IN nº 404/2025 reescreveu o Anexo I, incluindo o omeprazol 20 mg. Novas inclusões costumam levar até 180 dias para chegar ao mercado, porque as empresas precisam adequar bula e rotulagem antes do autosserviço (RDC nº 882/2024, arts. 13 e 19). Nesse intervalo podem coexistir no estoque caixas antigas com tarja e caixas novas sem tarja do mesmo produto.

NO BALCÃO

Monte na farmácia um atalho para o texto consolidado da LMIP e consulte sempre que um cliente pedir "sem receita" um produto que você não tem certeza. Antes de responder, olhe a caixa: forma farmacêutica, concentração e tarja. Se a apresentação pedida é tarjada, ofereça a alternativa isenta quando ela existir e fizer sentido clinicamente, ou encaminhe.

CASO

Homem de 45 anos pede "diclofenaco em comprimido" para dor nas costas após carregar peso, sem outros sintomas. O comprimido oral é tarjado e não pode ser vendido sem receita. O farmacêutico confirma que não há sinais de alerta (sem febre, sem perda de força, sem alteração urinária, sem trauma grave), indica diclofenaco gel, que está na LMIP, orienta aplicação local, calor e retorno às atividades leves, e combina procurar atendimento se a dor não melhorar ou se surgir qualquer sinal de alerta.

Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica

No balcão, três atos diferentes costumam ser chamados pelo mesmo nome de "atendimento". Separá-los é o primeiro passo para agir dentro da lei e documentar corretamente.

- **Dispensação**: fornecimento do medicamento ao usuário, a título remunerado ou não (Lei nº 5.991/1973, art. 4º, XV), acompanhado de orientação. Pode partir de uma receita ou de um pedido de MIP pelo nome.
- **Indicação farmacêutica**: o cliente relata um sintoma e pede ajuda; o farmacêutico avalia, decide se o problema é autolimitado e pode ser manejado na farmácia e, se for, seleciona um MIP ou uma medida não farmacológica. Corresponde ao "manejo de problemas de saúde autolimitados" das atribuições clínicas (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV).
- **Prescrição farmacêutica**: ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º), com documento próprio e registro do processo. Sua situação jurídica está discutida no tópico sobre a Resolução nº 586/2013.

Aspecto	Dispensação	Indicação	Prescrição farmacêutica
Começa com	Receita ou pedido de produto	Queixa ou sintoma	Necessidade de saúde avaliada em consulta
Decisão clínica do farmacêutico	Avaliar a receita e orientar	Escolher se trata e com quê	Selecionar, documentar e acompanhar a terapia
Documento	Receita (quando houver) e registros sanitários	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição (Res. nº 586/2013, art. 9º)

Na prática, um mesmo atendimento pode passar por mais de um ato. O cliente pede um xarope pelo nome (pedido de MIP), conta que a tosse dura três semanas (dado de anamnese) e sai encaminhado ao médico (desfecho da avaliação). A qualidade do atendimento se mede pelo raciocínio aplicado e registrado.

Etapas do atendimento de uma queixa

Os guias de prática clínica do Conselho Federal de Farmácia (série do ProFar: espirro e congestão nasal, 2016; febre, 2018; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) organizam o atendimento em etapas fixas, as mesmas para qualquer sintoma:

1. **Acolhimento da demanda**: receber o cliente, ouvir o motivo da procura e levá-lo, se necessário, a um local reservado.
2. **Anamnese farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos**: coletar dados por entrevista e, quando útil, medir pressão arterial ou temperatura.
3. **Identificação da necessidade e dos alertas**: decidir se o problema parece autolimitado ou se há situação que exige encaminhamento.
4. **Plano de cuidado**: encaminhamento, terapia não farmacológica, terapia farmacológica com MIP e educação do paciente, combinados com ele.
5. **Avaliação dos resultados**: retorno ou contato combinado para saber se o problema se resolveu.

A Resolução CFF nº 585/2013 define anamnese farmacêutica como o "procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde" (glossário).

Roteiros de anamnese

Para não esquecer perguntas no ritmo do balcão, farmacêuticos de vários países usam roteiros mnemônicos. Eles vêm da prática britânica (difundidos em obras como *Symptoms in the Pharmacy*, de Blenkinsopp e Paxton, citada nas referências da Resolução CFF nº 586/2013) e funcionam bem como lembrete. Não substituem o raciocínio: o roteiro serve para coletar dados, e a decisão vem da comparação com os sinais de alerta.

Roteiro	Letras (em inglês)	Pergunta correspondente
WWHAM	Who; What; How long; Action; Medication	Para quem é? Quais os sintomas? Há quanto tempo? O que já fez ou usou? Que medicamentos usa?
ASMETHOD	Age/appearance; Self or someone else; Medication; Extra medicines; Time persisting; History; Other symptoms; Danger symptoms	Idade e aparência; é para a própria pessoa?; medicamentos de uso contínuo; outros produtos já tentados; duração; história clínica; outros sintomas; sintomas de perigo
SIT DOWN SIR	Site; Intensity; Type; Duration; Onset; With; aNnoyed by; Spread; Incidence; Relieved by	Local, intensidade, tipo, duração, início, sintomas associados, o que piora, irradiação, frequência e o que alivia. Útil para dor.
ENCORE	Explore; No medication; Care; Observe; Refer; Explain	Explorar o problema; considerar não usar medicamento; cuidado em populações especiais; observar o paciente; encaminhar quando preciso; explicar a conduta

Os guias do CFF não adotam um acrônimo, mas cobrem os mesmos domínios. Uma forma prática de lembrar em português:

- **Quem**: idade, peso (em criança), gestação, amamentação, se o paciente está presente.
- **O quê**: sintoma principal, local, intensidade, características.
- **Desde quando**: início, duração, evolução (melhorando, igual, piorando), episódios anteriores.
- **Com o quê**: sintomas associados, febre, sinais de gravidade.
- **O que já fez**: medicamentos e medidas já tentados, dose, resultado.
- **O que mais tem e usa**: doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo, alergias, álcool, tabaco.

NO BALCÃO

Comece com pergunta aberta ("Me conte o que está sentindo") e só depois feche com perguntas diretas. Quando o pedido é para outra pessoa, pergunte idade, peso e se ela pode vir ou falar ao telefone: sem esses dados, a avaliação fica incompleta e o mais seguro pode ser não indicar. Ao final, peça que o cliente repita como vai usar o medicamento; isso confirma que a orientação foi entendida.

Parâmetros clínicos e seus limites

A RDC nº 44/2009 permite aferir pressão arterial e temperatura corporal (art. 69, §1º) e executar exames de análises clínicas nos termos da legislação vigente (art. 61, §2º). Hoje essa legislação é a RDC nº 978/2025, que revogou a RDC nº 786/2023: a farmácia que faz exames é serviço tipo I, só com amostra por punção capilar (como a glicemia), coleta em cavidade oral ou swab de nasofaringe ou orofaringe (redação da RDC 986/2025), todas as etapas no próprio estabelecimento e controle de qualidade. Esses dados servem para assistência e orientação, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (art. 69). Se o valor estiver fora da referência, o usuário deve ser orientado a procurar assistência médica (art. 69, §3º) e não podem ser indicados ou alterados medicamentos de venda sob prescrição (art. 69, §4º). A Declaração de Serviço Farmacêutico, nesses casos, leva a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (art. 81, §2º, I, d).

Plano de cuidado e orientação

Quando não há alerta, o plano costuma combinar medida não farmacológica e um MIP. A escolha leva em conta eficácia, segurança para aquele paciente, custo e conveniência, que são os mesmos critérios da Resolução nº 586/2013 (art. 7º, III). A orientação mínima inclui:

- nome do medicamento pela DCB, dose, intervalo e dose máxima diária;
- como usar (com ou sem alimento, como medir, como aplicar);
- por quanto tempo usar e quando parar;
- efeitos esperados e reações que exigem suspensão;
- o que evitar (álcool, outro produto com o mesmo fármaco, atividades de risco se houver sedação);
- quando procurar atendimento: piora, sinais de alerta ou ausência de melhora no prazo combinado.

A Lei nº 13.021/2014 (art. 13, VI) e a RDC nº 44/2009 (art. 42, §2º) listam como elementos da orientação a posologia, a influência dos alimentos, as interações, as reações adversas e a conservação.

Registro, consultório e retorno

Atendimento clínico sem registro não pode ser avaliado nem defendido. A RDC nº 44/2009 exige que as atividades de atenção farmacêutica sejam documentadas "de forma sistemática e contínua, com o consentimento expresso do usuário" (art. 64, §1º). O registro deve conter, no mínimo, nome, endereço e telefone do usuário, as orientações e intervenções realizadas, os resultados e a identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (art. 64, §2º). O serviço deve ter protocolos com referências e indicadores (art. 64) e o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).

O consultório farmacêutico é o "lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica", e pode funcionar como dependência de farmácia comunitária (Resolução CFF nº 585/2013, glossário). Do ponto de vista sanitário, o serviço precisa constar do licenciamento do estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 61, §3º e §4º). Do ponto de vista profissional, o registro de clínicas e consultórios farmacêuticos no CRF tem regulamentação própria do CFF; consulte o seu Conselho Regional.

O retorno completa o atendimento. Combine com o paciente quando ele deve estar melhor e o que fazer se não estiver. Em farmácia comunitária, isso pode ser um telefonema no terceiro dia ou o pedido para voltar se a febre persistir. O resultado vai para o registro.

CASO

Mulher de 29 anos chega pedindo "algo para dor de cabeça". Na anamnese: dor em pressão nos dois lados, iniciada no fim da tarde, sem febre, sem vômitos, sem alteração visual, padrão igual ao de outras vezes; não está grávida; usa apenas anticoncepcional oral. Não há sinais de alerta. O farmacêutico indica paracetamol em dose de adulto conforme a bula, orienta hidratação, pausa de telas e sono regular, explica que dor de cabeça frequente com uso de analgésico em muitos dias do mês precisa de avaliação médica, entrega a Declaração de Serviço Farmacêutico e registra o atendimento.

Sinais de alerta e encaminhamento

Sinal de alerta (em inglês, *red flag*) é qualquer dado da anamnese que sugere doença grave, não autolimitada ou fora do alcance do MIP. A presença de um único alerta basta para encaminhar. O objetivo da triagem é reconhecer que o caso foge do manejo na farmácia; o diagnóstico fica com o serviço que recebe o encaminhamento.

Os guias de prática clínica do CFF repetem uma regra geral que vale para qualquer queixa: encaminhar quando os sinais e sintomas forem persistentes, intensos ou recorrentes, quando não houver alívio com o tratamento prévio e sempre que houver dúvida sobre a necessidade de saúde do paciente. A RDC nº 44/2009 determina que o farmacêutico oriente o usuário a buscar outros profissionais quando julgar necessário (art. 66) e que a farmácia mantenha lista atualizada dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos, com endereço e telefone (art. 62).

Três níveis de resposta

Situação	Conduta	Exemplos
Problema autolimitado, sem alerta	Medidas não farmacológicas, MIP se necessário, orientação, prazo de reavaliação, registro	Resfriado comum, azia ocasional após refeição pesada, dor muscular por esforço
Alerta sem sinal de gravidade imediata	Encaminhar a consulta (unidade básica ou médico assistente), por escrito quando possível; evitar tratamento que mascare o quadro	Tosse há mais de três semanas, azia com perda de peso, disúria com febre baixa

Situação	Conduta	Exemplos
Sinal de gravidade	Encaminhar imediatamente a pronto atendimento ou acionar o SAMU (192); não oferecer MIP como substituto	Dor no peito com suor frio e falta de ar, rigidez de nuca com febre, desmaio, sangramento digestivo, bebê com menos de 2 meses com febre

ATENÇÃO

Tratar um sintoma de alerta com MIP pode atrasar o diagnóstico. O guia de febre do CFF lembra que, na suspeita de doença grave, o antitérmico pode "descaracterizar os sinais e sintomas e prejudicar o processo diagnóstico". Em suspeita de dengue e outras arboviroses, o mesmo guia orienta evitar ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroides.

Sinais de alerta por queixa

O quadro a seguir reúne as queixas mais comuns do balcão. Os prazos vêm dos guias de prática clínica do CFF (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) e do Caderno de Atenção Básica nº 28, volume II, do Ministério da Saúde (acolhimento à demanda espontânea). Quando a bula do MIP fixar prazo menor, vale o da bula.

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Dor de cabeça	Início súbito e muito forte; mudança do padrão habitual ou piora progressiva em semanas; febre com rigidez de nuca; convulsão; alteração neurológica (fraqueza, fala, visão); primeira crise após os 50 anos; após trauma na cabeça	Dor persistente por cerca de 15 dias ou uso de analgésico em muitos dias do mês
Febre	Criança com menos de 2 meses (avaliação hospitalar); menor de 6 meses com 38 °C retal ou mais; acima de 6 meses com 40 °C ou mais; suspeita de dengue, chikungunya ou zika; exantema, falta de ar, convulsão, confusão, dor intensa, criança muito sonolenta ou que não aceita líquidos; gestante com febre persistente; puérpera; imunossuprimido	Febre por mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico
Dor de garganta	Dificuldade de engolir a própria saliva ou de respirar; placas com febre alta e gânglios dolorosos no pescoço, sem tosse ou coriza (sugere faringite estreptocócica, que pede avaliação para antibiótico); placas com disfagia	Sem melhora em poucos dias ou piora após melhora inicial
Tosse	Menor de 2 anos; maior de 75 anos; falta de ar, chiado ou dor no peito; escarro purulento ou com sangue; perda de peso; febre acima de 38,5 °C por 2 dias ou mais; tosse noturna recorrente em criança; doença cardíaca; gestante ou lactante	Tosse por 3 semanas ou mais; sem melhora após 7 dias de tratamento
Espirro e congestão nasal	Obstrução de um lado só (corpo estranho); febre acima de 38 °C por mais de 24 horas mesmo com tratamento; dor facial e secreção purulenta; uso contínuo de descongestionante tópico com sangramento ou lesão nasal	Sintomas por mais de 10 a 14 dias sem tratamento ou sem melhora após 7 dias de tratamento

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Diarreia	Sangue ou muco nas fezes; febre; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina); vômitos que impedem a hidratação oral; lactente, idoso frágil ou imunossuprimido	Diarreia aguda dura menos de 14 dias; acima disso é persistente e precisa de avaliação
Azia e dispepsia	Dificuldade ou dor para engolir; perda de peso; vômitos persistentes; sangue no vômito ou fezes escuras; anemia; idade acima de 50 anos com sintoma novo; dor no peito irradiada com suor e falta de ar (urgência); criança até 12 anos; doença renal	Sintomas por mais de 7 dias apesar do antiácido; azia noturna por mais de 3 meses
Constipação	Sangue nas fezes; perda de peso; mudança recente do hábito intestinal após os 50 anos; dor abdominal intensa, vômitos ou distensão (suspeita de obstrução); início após medicamento novo	Sem resposta às medidas de dieta, líquidos e laxante no prazo da bula
Dor lombar	Idade abaixo de 20 ou acima de 50 anos; dor que piora à noite; história de câncer; emagrecimento; febre; trauma importante; osteoporose em tratamento; imunossupressão; fraqueza nas pernas; alteração urinária ou intestinal; anestesia na região da sela	Dor refratária ao tratamento
Lesões de pele	Pinta que cresce, muda de cor ou sangra; vermelhidão quente que se espalha; bolhas extensas; lesões com febre; dor em faixa de um lado do corpo com bolhas (suspeita de herpes-zóster); inchaço de lábios ou falta de ar com urticária (urgência)	Sem melhora no prazo da bula do produto tópico
Sintomas urinários	Febre, calafrio, dor lombar ou no flanco (suspeita de pielonefrite); homem; gestante; criança; idoso; diabético ou imunossuprimido; sangue na urina; corrimento ou lesão genital; episódios repetidos	Qualquer suspeita de infecção urinária precisa de avaliação: a fenazopiridina só alivia o ardor
Olho vermelho	Dor ocular forte; baixa da visão; sensibilidade intensa à luz; pupila diferente ou fixa; dor ocular com vômitos; trauma, corpo estranho ou produto químico; secreção purulenta abundante; usuário de lente de contato com dor	Irritação simples que não melhora com lubrificante e afastamento do irritante

Fontes do quadro: CFF, guias de prática clínica (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021); Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II (cefaleia, diarreia, disúria, dor de garganta, dor lombar, dispepsia e olho vermelho). Os itens de constipação, lesões de pele, lente de contato e dificuldade para engolir saliva ou respirar seguem a prática clínica geral e devem ser confirmados no protocolo do serviço.

Azia frequente depois da IN nº 404/2025

O guia do CFF de 2020 lista "azia frequente (2 ou mais vezes por semana)" como motivo de encaminhamento. Em 2025, a IN nº 404/2025 incluiu o omeprazol 20 mg na LMIP justamente para o alívio de azia e queimação frequentes, que ocorrem em dois ou mais dias na semana. As duas regras convivem assim: azia frequente, sem nenhum dos sinais de alarme da tabela, pode receber um curso curto de omeprazol MIP no prazo da bula; azia que persiste ou volta logo após o curso, ou que vem com qualquer

sinal de alarme, continua sendo caso de encaminhamento. O uso prolongado de inibidor da bomba de prótons sem acompanhamento também é motivo de encaminhamento no guia do CFF.

Como encaminhar

- Explique ao paciente, sem alarmismo, por que o caso precisa de avaliação e para onde ir (unidade básica, pronto atendimento, especialista).
- Entregue por escrito um resumo: queixa, duração, sinais observados, medidas já usadas, medicamentos em uso, parâmetros aferidos e identificação do farmacêutico. Os guias do CFF chamam esse documento de redação do encaminhamento.
- Não ofereça MIP para "segurar" até a consulta quando isso puder mascarar o quadro.
- Em urgência, oriente a ligar para o SAMU (192) ou ligue junto com o paciente.
- Registre o atendimento e o encaminhamento.

NO BALCÃO

Uma pergunta final evita a maioria dos erros de triagem: "Tem mais alguma coisa diferente que o senhor notou?". Sintomas que o paciente acha sem importância, como fezes escuras junto com azia ou falta de ar junto com tosse, costumam aparecer só nesse momento.

CASO

Mãe pede "um remédio para febre" para o filho de 7 semanas, que está com 38,2 °C desde a manhã. Pelo guia de febre do CFF, criança com menos de 2 meses e febre deve sempre ser avaliada em hospital. O farmacêutico não indica antitérmico, explica a urgência, informa o endereço do pronto atendimento pediátrico mais próximo, orienta a não agasalhar demais o bebê no trajeto e registra o encaminhamento.

Populações especiais no balcão

Os critérios de enquadramento do MIP foram pensados para o adulto sem doenças relevantes. Em gestantes, lactantes, crianças, idosos e pessoas com doença crônica ou em uso de anticoagulante, o mesmo produto pode ter risco muito maior. A primeira tarefa é identificar essas pessoas na anamnese, porque elas raramente se apresentam assim.

Gestante

Pergunte sempre a mulheres em idade fértil se há possibilidade de gravidez. Na gestação, priorize medidas não farmacológicas e use medicamento só quando o benefício for claro, na menor dose e pelo menor tempo.

- **Analgésico e antitérmico**: o paracetamol segue como opção de escolha na gestação. Em setembro de 2025, após a declaração do governo dos Estados Unidos sobre uma suposta relação entre paracetamol na gravidez e autismo, a Anvisa informou não haver registros de notificação que relacionem o uso ao autismo, e a Febrasgo afirmou não haver evidência conclusiva de causa e efeito, reforçando o uso responsável e orientado.

- **Anti-inflamatórios não esteroides**: a FDA recomendou, em outubro de 2020, evitar AINE a partir de cerca de 20 semanas de gestação, pelo risco de lesão renal fetal com redução do líquido amniótico; após cerca de 30 semanas, o risco de fechamento precoce do canal arterial já constava das bulas. A recomendação não se aplica ao ácido acetilsalicílico em baixa dose prescrito pelo médico.
- **Encaminhar**: gestante com febre persistente (guia de febre do CFF), com tosse (guia de tosse do CFF), com azia que não melhora com medidas não farmacológicas (guia de azia do CFF) e com sintomas nasais persistentes após lavagem nasal (guia de congestão do CFF).

Lactante

Na amamentação, avalie dois riscos: o efeito no lactente (passagem para o leite) e o efeito na produção de leite. Prefira fármacos com longa experiência de uso e meia-vida curta, use a menor dose eficaz e evite associações em dose fixa, que somam fármacos sem necessidade. Anti-histamínicos sedativos podem deixar o bebê sonolento. O guia de tosse do CFF orienta encaminhar lactantes com tosse, porque os dados de segurança de antitussígenos e expectorantes na amamentação são escassos. Para casos específicos, consulte bases de dados sobre medicamentos e lactação.

Criança

Na criança, a dose é calculada pelo peso, e o erro mais frequente no balcão está na conversão de miligramas para mililitros ou gotas.

- Pergunte sempre o peso atual. Idade é aproximação ruim.
- Para o paracetamol, a dose usual é de 10 a 15 mg/kg por dose (Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II), respeitando o intervalo e o número máximo de doses por dia da bula do produto.
- Verifique a apresentação. O mesmo fármaco existe em concentrações muito diferentes: dipirona em gotas 500 mg/mL e em solução oral 50 mg/mL (dez vezes menos concentrada); ibuprofeno em suspensão de 100 mg/mL e de 200 mg/mL, sendo esta última indicada na LMIP apenas para adultos.
- Gota não é unidade padronizada: o número de gotas por mililitro depende do produto e do conta-gotas. Use sempre o dosador da embalagem e confira na bula a equivalência.
- Escreva na caixa a dose em mL ou em gotas, o intervalo e a dose máxima diária.

CASO

Criança de 12 kg, com febre de 38,5 °C desde ontem, ativa, aceitando líquidos, sem outros sinais de alerta. Paracetamol 10 a 15 mg/kg por dose resulta em 120 a 180 mg. Com a solução de 200 mg/mL, isso corresponde a 0,6 a 0,9 mL por dose. O farmacêutico converte para gotas usando a equivalência da bula do produto escolhido, mostra o conta-gotas da embalagem, escreve a dose e o intervalo na caixa e orienta voltar ou procurar atendimento se a febre passar de 3 dias ou surgir qualquer sinal de alerta.

- Pelos guias do CFF, encaminhe menores de 2 anos com tosse, crianças até 12 anos com azia e menores de 2 meses com febre.
- A bula do ácido acetilsalicílico adverte contra seu uso em crianças e adolescentes com doença viral, como gripe e catapora, pelo risco de síndrome de Reye.

- Associações antigripais com descongestionante e anti-histamínico têm restrição de idade na bula; confira antes de indicar.

> **ATENÇÃO**
>
> Confundir "gotas" com "mL" multiplica a dose. "Dar 20" em um frasco de gotas e "dar 20" em um frasco de solução em mL são coisas muito diferentes. Toda orientação pediátrica deve informar a unidade por extenso e o dosador correto.

Idoso

No idoso, a função renal costuma estar reduzida, o efeito sedativo é maior e o risco de queda, sangramento e confusão aumenta. Os Critérios de Beers, da Sociedade Americana de Geriatria (atualização de 2023), listam medicamentos potencialmente inapropriados para pessoas de 65 anos ou mais. Vários estão entre os MIP ou nas associações vendidas sem receita.

Item dos Critérios de Beers 2023	Recomendação	Onde aparece no balcão
Anti-histamínicos de primeira geração	Evitar (altamente anticolinérgicos)	Dexclorfeniramina, clorfeniramina e prometazina, inclusive em antigripais
AINE oral não seletivo	Evitar uso crônico; evitar até o uso curto regular junto com corticoide, anticoagulante ou antiagregante	Ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico em dose analgésica
AINE na insuficiência cardíaca	Evitar na insuficiência cardíaca sintomática	Qualquer AINE oral
AINE na doença renal	Evitar com função renal abaixo de 30 mL/min	Qualquer AINE oral
Inibidor da bomba de prótons	Evitar uso regular por mais de 8 semanas sem indicação que justifique	Omeprazol 20 mg MIP usado por conta própria por meses
Óleo mineral por via oral	Evitar (risco de aspiração)	Laxantes com óleo mineral
Antiespasmódicos anticolinérgicos	Evitar (a lista cita escopolamina e atropina)	Produtos com escopolamina ou beladona
Ácido acetilsalicílico para prevenção primária	Não iniciar; considerar retirada	Idoso que decide "tomar AAS para o coração" por conta própria

Os Critérios de Beers expressam o limite renal em depuração de creatinina. No Brasil, o resultado de exame do paciente costuma vir como taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI 2021; use esse valor como referência e encaminhe quando houver dúvida. O guia de tosse do CFF recomenda encaminhar pessoas com mais de 75 anos com tosse.

Doenças crônicas e anticoagulação

Condição	Cuidado com MIP	Alternativa ou conduta
Hipertensão	Descongestionantes sistêmicos (fenilefrina e similares em antigripais) elevam a pressão; AINE retém sódio, eleva a pressão e reduz o efeito de anti-hipertensivos; comprimidos efervescentes trazem sódio	Soro fisiológico nasal, analgésico sem AINE, aferir a pressão; o guia de febre do CFF manda encaminhar alteração de pressão em uso de anti-hipertensivo
Diabetes	Xaropes e pastilhas com açúcar; sintomas atípicos de infecção; feridas nos pés	Preferir versões sem açúcar; lesão em pé de diabético é sempre encaminhamento
Doença renal crônica	AINE pode precipitar lesão renal aguda; antiácidos com magnésio e alumínio acumulam	Evitar AINE; o guia de azia do CFF manda encaminhar paciente com doença renal que precise de antiácido
Doença hepática	Paracetamol em dose alta ou com álcool aumenta o risco de lesão hepática	Dose e duração definidas com o médico que acompanha o paciente
Anticoagulante ou antiagregante	AINE e ácido acetilsalicílico aumentam o risco de sangramento; uso regular de paracetamol em dose alta por vários dias pode elevar o RNI de quem usa varfarina; omeprazol reduz a ativação do clopidogrel	Analgésico sem AINE em dose habitual e por pouco tempo; avisar o médico se o uso se prolongar; encaminhar se houver fezes escuras, urina com sangue, vômito com sangue ou sangramento nasal

NO BALCÃO

Peça para ver a caixa ou a receita dos medicamentos de uso contínuo. Muitos pacientes não se lembram do nome, mas sabem que tomam "um remédio para afinar o sangue" ou "um para pressão". Esse detalhe muda a escolha entre um AINE e um analgésico simples.

CASO

Homem de 72 anos em uso de varfarina pede ibuprofeno para dor no joelho. O farmacêutico explica o risco de sangramento da associação, indica paracetamol em dose habitual de adulto por poucos dias, orienta calor local e repouso relativo, avisa que o uso regular por vários dias deve ser comunicado ao médico que controla o RNI e lista os sinais de sangramento que exigem atendimento imediato.

Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013

A Resolução CFF nº 586, de 29 de agosto de 2013, "regula a prescrição farmacêutica". Tem a mesma data da Resolução CFF nº 585/2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. As duas formam um par: a 585 diz o que o farmacêutico faz no cuidado ao paciente, e a 586 detalha um desses atos, a prescrição. É conteúdo obrigatório de concursos, residências e provas de conselho, e precisa ser estudada junto com a sua situação jurídica atual.

Preâmbulo e considerandos

O preâmbulo apresenta a prescrição como prática multiprofissional, adotada em vários sistemas de saúde para ampliar acesso e resolutividade, com modos específicos para cada profissão e limites definidos pelas responsabilidades de cada uma. Os considerandos citam, entre outros:

- a Lei nº 3.820/1960 (criação dos conselhos de farmácia, art. 6º, alíneas "g" e "m") e o Decreto nº 85.878/1981 (atribuições profissionais do farmacêutico);
- o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Declaração de Alma-Ata (1978);
- a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução CNS nº 338/2004) e o Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria MS/GM nº 529/2013);
- resoluções do CFF sobre boas práticas, indicação de plantas medicinais e fitoterápicos isentos (nº 546/2011), registro de informações clínicas (nº 555/2011) e atribuições clínicas (nº 585/2013);
- normas da Anvisa então vigentes sobre categoria de venda (RDC nº 138/2003), medicamentos dinamizados, manipulação e boas práticas em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009).

Desde então, a norma da Anvisa sobre categoria de venda mudou duas vezes (RDC nº 98/2016 e, hoje, RDC nº 882/2024). A remissão do art. 5º a "categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal" acompanha essas mudanças.

Definição e natureza do ato

O QUE DIZ A NORMA

"Para os propósitos desta resolução, define-se a prescrição farmacêutica como ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde." (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º)

- É prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no CRF de sua jurisdição (art. 2º).
- É atribuição clínica, realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores evidências, em princípios éticos e conforme as políticas de saúde vigentes (art. 3º, parágrafo único).
- Pode ocorrer em estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e níveis de atenção diversos, desde que respeitadas a confidencialidade e a privacidade (art. 4º).

Repare que "prescrever" na resolução é mais amplo que escolher um medicamento. Inclui terapia não farmacológica (dieta, lavagem nasal, compressa, repouso) e outras intervenções, como o encaminhamento.

O que pode ser prescrito

A resolução separa dois grupos, com exigências muito diferentes.

Grupo	Base	Condições
Medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica	Art. 5º	Inclui industrializados e preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias aprovadas pelo órgão sanitário federal. Exige conhecimento de boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação, farmacologia clínica e terapêutica (§1º). Para dinamizados e práticas integrativas, conhecimento específico (§2º).
Medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica	Art. 6º	Somente com diagnóstico prévio e apenas quando previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para uso em instituições de saúde, ou quando houver acordo de colaboração formalizado com outros prescritores ou instituições. Exige título de especialista ou especialista profissional na área clínica reconhecido pelo CRF (§1º). Para dinamizados, título em homeopatia ou antroposofia (§2º).

O QUE DIZ A NORMA

"O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde." (art. 6º)

O glossário define acordo de colaboração como a "parceria formal entre o farmacêutico e o prescritor ou a instituição, com explícito acordo entre quem está delegando (prescritor ou instituição) e quem está recebendo a autorização (farmacêutico) para prescrever". No balcão de uma drogaria, sem protocolo institucional nem acordo formal, a resolução não autoriza prescrever tarjado em hipótese alguma.

ATENÇÃO

"É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração", caso em que a modificação, com justificativa, deve ser comunicada ao outro prescritor (art. 6º, §3º). Trocar dose, fármaco ou duração de uma receita médica por conta própria é infração.

Etapas do processo de prescrição

O art. 7º descreve o processo em sete etapas. Elas coincidem com o atendimento de queixas descrito nos guias do CFF.

1. Identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde.
2. Definição do objetivo terapêutico.
3. Seleção da terapia ou das intervenções, com base em segurança, eficácia, custo e conveniência, dentro do plano de cuidado.
4. Redação da prescrição.
5. Orientação ao paciente.

6. Avaliação dos resultados.
7. Documentação do processo de prescrição.

O art. 8º acrescenta medidas de segurança do paciente: basear-se nas melhores evidências; decidir de forma compartilhada e centrada no paciente; considerar outras condições clínicas, outros medicamentos, hábitos e contexto; atentar para os aspectos legais e éticos dos documentos entregues; comunicar as decisões de modo que paciente, responsável ou cuidador compreendam por completo; e garantir que os resultados sejam acompanhados e avaliados.

Documento de prescrição

O art. 9º exige prescrição "redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras", com os componentes mínimos:

1. identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado;
2. nome completo e contato do paciente;
3. descrição da terapia farmacológica, quando houver: nome do medicamento ou formulação, concentração ou dinamização, forma farmacêutica e via; dose, frequência e duração do tratamento; instruções adicionais, quando necessário;
4. descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção, quando houver;
5. nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no CRF;
6. local e data.

No SUS, a prescrição deve usar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na falta dela, a Denominação Comum Internacional (art. 10). No setor privado, preferencialmente a DCB (art. 11). É vedado prescrever sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e assinar receituário em branco (art. 12).

Sigilo, autonomia, propaganda e registro

- Sigilo dos dados obtidos na prescrição, vedado o uso para fim que não seja de interesse sanitário ou de fiscalização profissional (art. 13).
- Autonomia profissional e científica em relação a empresas e pessoas com interesse comercial na prescrição (art. 14).
- Proibição de usar a prescrição como meio de propaganda ou publicidade de qualquer natureza (art. 15). Prescrição com logotipo de laboratório ou cupom de desconto de marca fere esse artigo.
- Registro de todo o processo de prescrição na forma da lei (art. 16).

Relação com outras normas

Norma	Ponto de contato com a Resolução nº 586/2013
Resolução CFF nº 585/2013	Lista entre as atribuições clínicas "prescrever, conforme legislação específica" (art. 7º, XXVI), o manejo de problemas de saúde autolimitados (XXV), a consulta farmacêutica em consultório (VII), a anamnese (VIII) e o plano de cuidado (XVII).
Lei nº 13.021/2014	Define a farmácia como unidade de prestação de serviços de saúde (art. 3º) e impõe ao farmacêutico orientação, acompanhamento farmacoterapêutico e farmacovigilância (art. 13). A lei não trata expressamente de prescrição farmacêutica.
RDC nº 44/2009	A Declaração de Serviço Farmacêutico registra a "indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia" (art. 81, §2º, I, b) e não pode ser usada para indicar medicamento que exige prescrição nem para propaganda (art. 81, §3º).
Resolução CFF nº 724/2022 (Código de Ética)	Entre os direitos do farmacêutico, prescrever medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica, "desde que devidamente documentada" (art. 12, VII), e prescrever conforme protocolos institucionais ou acordos de colaboração (art. 12, VIII).

Situação jurídica em outubro de 2026

A prescrição farmacêutica é objeto de disputa judicial entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o CFF desde 2013. O estudante precisa conhecer os fatos, porque eles mudam o que se pode fazer com segurança jurídica.

Norma	O que dispõe	Situação conferida
Resolução CFF nº 586/2013	Prescrição farmacêutica (MIP e, com condições, tarjados)	Sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF, na ação civil pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 movida pelo CFM, julgou o pedido procedente, declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução, proibiu sua aplicação em todo o território nacional e determinou sua suspensão imediata. A sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório e o CFF recorreu ao TRF da 1ª Região.
Resolução CFF nº 5/2025	Nova regulamentação da prescrição, incluindo tarjados por farmacêutico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em farmácia clínica (RQE criado pela Resolução CFF nº 4/2025)	Datada de 20/02/2025 e publicada em 17/03/2025; suspensa por decisão liminar da 17ª Vara Federal Cível do DF em 31/03/2025, em ação do CFM.
Resolução CFF nº 12/2024	Prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêutico, conforme protocolo do CFF	Suspensa pela 13ª Turma do TRF da 1ª Região em agravo do CFM; em 2026 a sentença de primeira instância declarou sua nulidade e o CFF anunciou recurso (notícia do CFF de 20/05/2026).

O fundamento das decisões contrárias é que conselho profissional não pode ampliar, por resolução, atribuições que dependem de lei federal, e que diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica são atos privativos do médico pela Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico). O CFF sustenta o contrário e recorre.

Não foi localizada, até outubro de 2026, decisão de segundo grau restabelecendo a Resolução nº 586/2013.

PONTO-CHAVE

O conteúdo da Resolução nº 586/2013 continua sendo cobrado em provas e organiza a boa prática de documentação. Na rotina, enquanto a disputa não se resolve, o caminho com base sanitária vigente para o MIP é a indicação farmacêutica com orientação e registro na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Prescrição de medicamento tarjado por farmacêutico de drogaria, fora de protocolo institucional, não tem respaldo. Acompanhe as orientações do seu CRF.

NO BALCÃO

Se o cliente pedir "uma receita do farmacêutico" para apresentar em outro lugar ou para comprar um tarjado, explique que o farmacêutico não emite receita de medicamento tarjado e que o documento que você entrega registra a orientação e o MIP indicado. Nunca assine documento em branco nem inclua marca comercial como forma de propaganda.

Documentação e ética no atendimento

Documentar o atendimento protege o paciente, porque permite continuidade e comunicação com outros profissionais, e protege o farmacêutico, porque registra o que foi avaliado, decidido e orientado. No balcão, boa parte dos conflitos éticos nasce da pressão comercial por volume de vendas.

Declaração de Serviço Farmacêutico

Após a prestação de serviço farmacêutico, o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Ela é emitida em duas vias: a primeira vai para o usuário e a segunda fica arquivada no estabelecimento (art. 81, §4º).

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Cabeçalho	Papel com identificação do estabelecimento: nome, endereço, telefone e CNPJ (§1º)
Usuário	Identificação do usuário ou do responsável legal (§1º)
Prescrição apresentada	Medicamento prescrito e dados do prescritor (nome e inscrição no conselho), quando houver (§2º, I, a)
Indicação de MIP	Medicamento isento indicado e posologia, quando houver (§2º, I, b)
Parâmetros e exames	Valores aferidos ou resultados com os valores de referência, quando houver, e a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (§2º, I, c e d)
Medicamento administrado	Nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração e forma, via, lote e registro na Anvisa, quando houver (§2º, I, e)

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Orientação e plano	Orientação farmacêutica e plano de intervenção, quando houver (§2º, I, f e g)
Responsável	Data, assinatura e carimbo com inscrição no CRF do farmacêutico (§2º, I, h)

O QUE DIZ A NORMA

"É proibido utilizar a Declaração de Serviço Farmacêutico com finalidade de propaganda ou publicidade ou para indicar o uso de medicamentos para os quais é exigida prescrição médica ou de outro profissional legalmente habilitado." (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º)

A Declaração e o documento de prescrição da Resolução nº 586/2013 têm finalidades parecidas, mas bases diferentes. A Declaração é exigência sanitária da Anvisa, vigente, e registra o serviço prestado. O documento de prescrição é norma profissional do CFF, hoje discutida judicialmente, e tem o formato de uma receita. Quando se indica um MIP, a Declaração já contém os elementos essenciais: produto, posologia, orientação e identificação do farmacêutico.

Registro interno e privacidade

Além da via entregue, a farmácia mantém o registro do atendimento: dados de contato do usuário, orientações e intervenções, resultados e identificação do profissional, com consentimento expresso do usuário (RDC nº 44/2009, art. 64). Os dados obtidos nos serviços farmacêuticos recebem tratamento sigiloso e não podem ser usados para outra finalidade (art. 82).

Dado referente à saúde é dado pessoal sensível na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II). Na prática, isso significa:

- atender queixas íntimas (sintomas urinários, corrimento, contracepção de emergência, hemorroidas) em local reservado, e não no meio da fila;
- não comentar o caso com outros clientes ou colegas sem necessidade assistencial;
- não usar o registro clínico para oferta comercial;
- guardar fichas e arquivos com acesso restrito.

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 724/2022) inclui entre os deveres de todos os inscritos guardar sigilo de fatos e informações conhecidos no exercício da profissão, salvo quando a lei exige comunicação (art. 15, VI), e proíbe fornecer a terceiros dados que identifiquem o paciente, inclusive os de receitas e registros, em desacordo com a LGPD (art. 18, XLIII).

Recusa de venda e de dispensação

O farmacêutico tem o direito de "decidir, justificadamente, sobre a dispensação ou não de qualquer prescrição", em favor da segurança e da eficácia da terapêutica (Resolução CFF nº 724/2022, art. 12, XIV), e de "negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica" (art. 12, IV). O raciocínio vale para o MIP.

- Recusa justificada: grande quantidade de paracetamol com relato de tristeza intensa ou ideação suicida; pedido de MIP para criança de idade incompatível com a bula; pedido de antigripal com descongestionante por hipertenso com pressão muito elevada aferida na hora.
- Como recusar: explicar o motivo técnico em linguagem simples, oferecer alternativa segura ou encaminhamento, registrar o atendimento. Recusa sem explicação gera conflito e não protege ninguém.
- Em situação de risco à vida, a recusa vem acompanhada de encaminhamento ativo: acionar o SAMU (192) ou serviço de saúde mental, sem deixar a pessoa sair sozinha se houver risco imediato.

Condutas proibidas ou antiéticas

Conduta	Por que é proibida
Indicar ou vender sem receita medicamento tarjado	Venda sem a prescrição exigida é infração sanitária. A RDC nº 44/2009 veda indicar ou alterar tarjado mesmo diante de parâmetro alterado (art. 69, §4º) e veda usar a Declaração para isso (art. 81, §3º). A Resolução nº 586/2013 só admitia tarjado em protocolo institucional ou acordo de colaboração (art. 6º).
"Empurroterapia": indicar o produto que dá comissão ou bonificação	O Código de Ética proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia diante de interesses comerciais (art. 14).
Venda casada ou "leve três" de medicamento	Estimula uso indiscriminado (RDC nº 96/2008, art. 8º, I) e programas de fidelidade não podem usar medicamento como objeto de pontuação ou prêmio (art. 10).
Substituir medicamento sem regra de intercambialidade	A troca só é permitida nos limites legais: medicamento de referência pelo genérico correspondente (Lei nº 9.787/1999) ou pelo similar declarado intercambiável pela Anvisa. O Código de Ética garante o direito de realizar a intercambialidade "respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato" (art. 12, IX).
Dispensar para uso diferente da indicação registrada	Proibido, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento com o prescritor formalizado por escrito (Código de Ética, art. 17, IX).
Modificar a receita de outro prescritor	Vedado, salvo em acordo de colaboração (Resolução nº 586/2013, art. 6º, §3º).
Deixar o balconista indicar medicamento	Indicação é avaliação clínica do farmacêutico; delegar ato privativo é proibido (Código de Ética, art. 17, VIII).
Usar documento de atendimento como propaganda	Vedado na Declaração (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º) e na prescrição (Resolução nº 586/2013, art. 15).

Farmacovigilância

Reação adversa, intoxicação ou suspeita de falha relatada no balcão é informação de interesse sanitário. O farmacêutico deve notificar efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência às autoridades sanitárias, aos profissionais e ao fabricante (Lei nº 13.021/2014, art. 13, I) e contribuir para a

farmacovigilância notificando eventos adversos e queixas técnicas (RDC nº 44/2009, art. 67). A notificação à Anvisa é feita pelo sistema VigiMed.

NO BALCÃO

Quando o representante comercial oferecer premiação por venda de uma marca de MIP, lembre que a escolha do produto no atendimento é técnica. A marca pode estar no estoque, mas a indicação segue os critérios clínicos do atendimento.

CASO

Jovem de 19 anos pede quatro caixas de paracetamol 750 mg e, na conversa, diz que "não aguenta mais nada". O farmacêutico recusa a venda daquela quantidade, conversa em local reservado, pergunta diretamente sobre intenção de se machucar e, diante da resposta afirmativa, aciona o serviço de urgência e permanece com a jovem até a chegada da equipe. Registra o atendimento sem expor o caso a outros clientes.

Analgésicos e antitérmicos

Dor leve a moderada e febre respondem pela maior parte dos pedidos de balcão. Três fármacos resolvem quase todos esses casos: **paracetamol**, dipirona e ácido acetilsalicílico (AAS). Os três constam da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), Anexo I da IN 285/2024, republicado na íntegra pela IN 404/2025. A lista fixa a concentração máxima do insumo em cada forma farmacêutica e não estabelece dose diária: um produto é MIP quando tem o mesmo insumo, a mesma forma farmacêutica e a mesma indicação da linha da lista, com concentração igual ou menor (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).

O paracetamol aparece também na Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN), estabelecida pela IN 106/2021 e atualizada pela IN 430/2026. Produtos notificados são, por definição, de venda isenta de prescrição (RDC 576/2021, definições), e a LMN já traz o texto de posologia e de advertência que o fabricante deve usar.

Enquadramento

Fármaco	Apresentações isentas (concentração máxima)	Observação de balcão
Paracetamol	LMIP: comprimido revestido 750 mg; efervescente 500 mg; mastigável 160 mg; liberação prolongada 650 mg; pó 100 mg/g. LMN: comprimido 500 e 750 mg; solução oral 200 mg/mL; suspensão 32, 100 e 140 mg/mL	Associações com cafeína, fenilefrina, anti-histamínicos, orfenadrina e carisoprodol também constam da LMIP
Dipirona	Comprimido e efervescente até 1000 mg; solução oral até 500 mg/mL; supositório 300 mg	Forma injetável nunca é MIP (RDC 882/2024, art. 5º)
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg; comprimido de liberação prolongada 500 mg; associações com vitamina C, cafeína e paracetamol	A linha da LMIP cobre febre e dor; o uso antiagregante em dose baixa é decisão do médico

Paracetamol

Analgésico e antipirético de ação predominantemente central, com efeito anti-inflamatório periférico desprezível. Não irrita a mucosa gástrica nem interfere na agregação plaquetária, o que o torna a primeira opção em dengue suspeita, em pessoas com úlcera ou em uso de anticoagulante (com a ressalva da varfarina, abaixo).

Item	Conduta
Indicação de balcão	Febre; dor leve a moderada (cefaleia, dor de dente, dor muscular, cólica menstrual, dor de garganta)
Adulto e maior de 12 anos	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 horas; no máximo 1000 mg por dose e 4000 mg em 24 horas (LMN, IN 106/2021)
Criança	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas, no máximo 5 administrações em 24 horas (cerca de 50 a 75 mg/kg/dia). Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: avaliação médica antes do uso (LMN)
Gotas 200 mg/mL	Na bula do Tylenol® gotas: 1 gota/kg, até 35 gotas por dose em menores de 12 anos; adulto 40 a 70 gotas por dose, até 280 gotas por dia
Contraindicações	Alergia ao paracetamol; doença hepática grave; cautela em etilista e em desnutrido
Interações	Varfarina (uso regular pode elevar o INR: a bula pede consulta médica); outros produtos com paracetamol (antigripais); álcool
Encaminhar	Ingestão acima da dose máxima, mesmo sem sintomas; icterícia, urina escura ou dor no lado direito do abdome

ATENÇÃO

O texto obrigatório da LMN avisa que adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda com mais de 4 g em 24 horas, com uso simultâneo de outros produtos contendo paracetamol ou com 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. O erro mais comum é a duplicidade: o cliente toma paracetamol de 750 mg e um antigripal que também contém paracetamol. Leia o rótulo de tudo o que ele já usa.

Intoxicação por paracetamol tem antídoto (acetilcisteína) e janela de tempo. Quem ingeriu dose excessiva deve ir ao pronto-socorro imediatamente, ainda que esteja assintomático.

O número de gotas por mililitro depende do gotejador. O manual de dengue do Ministério da Saúde considera 20 gotas por mL para o paracetamol 200 mg/mL, enquanto na bula do Tylenol® 70 gotas correspondem a 1000 mg (cerca de 14 gotas por mL). Por isso a orientação em gotas vale para o produto entregue: confira a bula daquele frasco e nunca transfira a regra de uma marca para outra. A IN 430/2026 ajustou a posologia pediátrica e incluiu advertência sobre tempo de uso no texto da LMN, de modo que a bula do lote em mãos é a referência final.

Dipirona

Pró-fármaco cujos metabólitos inibem a síntese de prostaglandinas, com efeito analgésico, antipirético e leve ação espasmolítica. É o antitérmico mais vendido do país e, ao lado do paracetamol, o recomendado pelo Ministério da Saúde para dor e febre na dengue.

Item	Conduta (bula da Novalgina®)
Adulto e maior de 15 anos	500 a 1000 mg até 4 vezes ao dia. Gotas 500 mg/mL (1 mL = 20 gotas): 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia. Máximo 4 g/dia
5 a 8 kg (3 a 11 meses)	2 a 5 gotas por dose; máximo 20 gotas/dia
9 a 15 kg (1 a 3 anos)	3 a 10 gotas por dose; máximo 40 gotas/dia
16 a 23 kg (4 a 6 anos)	5 a 15 gotas por dose; máximo 60 gotas/dia
24 a 30 kg (7 a 9 anos)	8 a 20 gotas por dose; máximo 80 gotas/dia
31 a 45 kg (10 a 12 anos)	10 a 30 gotas por dose; máximo 120 gotas/dia
46 a 53 kg (13 a 14 anos)	15 a 35 gotas por dose; máximo 140 gotas/dia

Contraindicações listadas em bula: alergia a pirazolonas, agranulocitose prévia com essas substâncias, função de medula óssea prejudicada, broncoespasmo ou reação anafilactoide após analgésicos, porfiria hepática aguda intermitente, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, menores de 3 meses ou com menos de 5 kg. A bula da Novalgina® inclui gravidez e amamentação entre as contraindicações.

Interações relevantes: metotrexato (a associação deve ser evitada, aumenta a toxicidade hematológica), ciclosporina (níveis reduzidos), AAS em dose baixa para cardioproteção (a dipirona reduz o efeito antiplaquetário) e bupropiona (concentração reduzida). Em insuficiência renal ou hepática e em idosos, evitar doses altas.

ATENÇÃO

A **agranulocitose** por dipirona é rara e imprevisível, não depende da dose e pode ocorrer em qualquer momento do uso. Oriente o cliente: febre que volta ou persiste, calafrios, dor de garganta e feridas na boca durante o tratamento exigem suspender o medicamento e procurar atendimento no mesmo dia. Hipotensão e reação alérgica grave também são descritas, sobretudo em doses altas.

Ácido acetilsalicílico

Inibe de forma irreversível as ciclo-oxigenases 1 e 2, com efeito analgésico, antitérmico, anti-inflamatório e antiplaquetário que dura a vida da plaqueta. No balcão de hoje, perdeu espaço como antitérmico

justamente por esse efeito sobre a coagulação.

Item	Conduta (bula da Aspirina® 500 mg)
Adulto	500 a 1000 mg; repetir a cada 4 a 8 horas se necessário; no máximo 8 comprimidos (4 g) por dia; após as refeições
A partir de 12 anos	500 mg a cada 4 a 8 horas; no máximo 3 comprimidos por dia
Duração	Não usar por mais de 3 a 5 dias sem consulta
Contraindicações	Alergia a salicilatos; asma induzida por AINE; úlcera ativa; tendência a sangramento; dengue suspeita
Interações	Anticoagulantes e antiplaquetários; outros AINE; metotrexato; corticoides (sangramento digestivo)

ATENÇÃO

Síndrome de Reye: doença rara e grave, com lesão hepática e encefalopatia, associada ao AAS em crianças com infecção viral. A bula determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta médica. No balcão, a regra prática é simples: antitérmico para criança ou adolescente é paracetamol ou dipirona.

Associações analgésicas

A LMIP inclui várias associações. A cafeína (30 a 65 mg por comprimido) potencializa o analgésico e pode causar insônia, palpitação e piora da gastrite. A orfenadrina (relaxante muscular com ação anticolinérgica) pede cautela em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática e idosos. O carisoprodol causa sonolência. O isometepteno é vasoconstritor e não deve ser usado por hipertenso. Antes de dispensar uma associação, confirme se o cliente precisa de cada componente.

Dengue suspeita

Na época de transmissão, toda febre aguda com dor no corpo, dor atrás dos olhos, cefaleia ou manchas na pele deve ser tratada como dengue até prova em contrário. O guia *Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança* (Ministério da Saúde, 6ª edição, 2024) orienta prescrever paracetamol e/ou dipirona e não utilizar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides nem corticoides. AAS e AINE aumentam o risco de sangramento, inclusive digestivo, em pessoa que pode estar com plaquetas baixas.

Fármaco	Adulto	Criança
Dipirona	20 gotas ou 1 comprimido (500 mg) até de 6/6 horas	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas, respeitando a dose máxima por peso e idade

Fármaco	Adulto	Criança
Paracetamol	40 gotas ou 1 comprimido (500 mg) de 4/4 horas, ou 60 gotas ou 2 comprimidos até de 6/6 horas; não exceder 4 g/24 h	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas; doses maiores são hepatotóxicas

Fonte das doses: Apêndice H do guia do Ministério da Saúde (2024). O mesmo guia lista os **sinais de alarme**: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotimia, aumento do fígado, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Qualquer um deles indica atendimento médico imediato. Mesmo sem sinal de alarme, a pessoa com suspeita de dengue deve ser encaminhada para avaliação e notificação, com orientação de hidratação oral até lá.

PONTO-CHAVE

Em dengue suspeita: paracetamol ou dipirona, hidratação e encaminhamento. Nada de AAS, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida ou corticoide. Cliente cardiopata em uso contínuo de AAS não deve suspender por conta própria: encaminhe para avaliação médica no mesmo dia.

Alternância de antitérmicos

Alternar paracetamol, dipirona e ibuprofeno em horários intercalados é hábito comum de pais. O documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre febre aguda (2025) trata o uso intercalado como mito a ser combatido, por favorecer polimedicação e intoxicação. Estudo publicado no Jornal de Pediatria (2013) encontrou evidência escassa de benefício e mostrou que cerca de 70% das doses usadas pelas famílias estavam abaixo da dose mínima recomendada. A conduta correta é escolher um antitérmico, calcular a dose pelo peso e respeitar o intervalo. O antitérmico serve para o conforto da criança, e a temperatura não precisa voltar ao normal a cada dose.

NO BALCÃO

Pergunte idade e peso (para criança, sempre o peso), temperatura medida e há quanto tempo, outros sintomas (manchas, vômitos, dor abdominal, sangramento), doenças de fígado, rim, estômago ou asma, gestação ou amamentação, uso de anticoagulante e de outros remédios para gripe ou dor, e consumo de álcool.

Encaminhe: febre em menor de 3 meses; febre por mais de 72 horas; febre com manchas, rigidez de nuca, sonolência excessiva ou dificuldade para respirar; cefaleia súbita e intensa ou diferente das habituais; dor que exige dose máxima por vários dias; qualquer sinal de alarme de dengue.

CASO

Mãe pede algo para a febre do filho de 2 anos e 12 kg, com 38,6 °C desde ontem, em bairro com casos de dengue. Sem manchas, vômitos ou sonolência. Conduta: paracetamol 200 mg/mL, 1 gota/kg (12 gotas no frasco do Tylenol®, conferindo o gotejador do produto entregue), a cada 6 horas se febre ou dor, sem alternar com outro antitérmico; oferecer líquidos; nada de AAS ou ibuprofeno; levar à unidade de saúde para avaliação ainda hoje e voltar com urgência se surgir dor abdominal, vômitos repetidos, sangramento ou sonolência.

Anti-inflamatórios isentos de prescrição

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINE) inibem as ciclo-oxigenases e reduzem a síntese de prostaglandinas. Têm efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, mas pagam o preço em três órgãos: estômago, rim e sistema cardiovascular. Por isso a LMIP libera poucos AINE orais, em concentrações limitadas, e um número maior de formas tópicas.

Anti-inflamatórios na LMIP

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Ibuprofeno	Cápsula mole ou comprimido 400 mg; comprimido revestido 400 mg; liberação prolongada 600 mg; suspensão oral 100 e 200 mg/mL	Febre; dor leve a moderada
Ibuprofeno arginina	Comprimido revestido ou granulado 770 mg	Febre; dor leve a moderada; traumatismos
Ibuprofeno + paracetamol	Comprimido revestido 200 + 500 mg	Febre; dor leve a moderada, cefaleia, cólica abdominal
Naproxeno	Comprimido 500 mg	Dor aguda inflamatória, dor e febre, dor muscular e articular, dor pós-trauma
Naproxeno sódico	Comprimido revestido 550 mg	Mesma indicação do naproxeno
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	Inflamação da garganta
Diclofenaco dietilamônio	Gel 23,2 mg/g; solução dermatológica 11,6 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Diclofenaco sódico	Gel 10 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Aceclofenaco	Creme 15 mg/g	Dor musculoesquelética
Nimesulida	Gel 20 mg/g	Dor musculoesquelética
Loxoprofeno sódico	Adesivo transdérmico 100 mg	Dor musculoesquelética

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Salicilato de metila (associações)	Pomadas, géis, soluções e adesivos com cânfora e mentol	Dor muscular e articular

ATENÇÃO

Não constam da LMIP vigente: **nimesulida oral**, diclofenaco oral (sódico, potássico ou resinato), cetoprofeno, meloxicam, piroxicam, tenoxicam, etoricoxibe e celecoxibe. São medicamentos de venda sob prescrição. A nimesulida é MIP apenas em gel. Vender nimesulida comprimido sem receita, mesmo a pedido insistente, é dispensação irregular.

Ibuprofeno

Derivado do ácido propiônico, é o AINE oral de melhor perfil de segurança gastrintestinal em dose baixa. A dose de automedicação é menor que a dose anti-inflamatória que o médico prescreve.

Item	Conduta
Adulto (produto MIP, bula do Advil® 400 mg)	400 mg; repetir com intervalo mínimo de 4 a 6 horas; máximo 1200 mg em 24 horas; durante ou após as refeições
Doses acima de 1200 mg/dia	Somente com prescrição (bulas de ibuprofeno de venda sob prescrição admitem até 3200 mg/dia)
Criança a partir de 6 meses	5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas, no máximo 4 vezes ao dia; acima de 30 kg, até 200 mg por dose e 800 mg por dia (bula do Alivium® gotas)
Gotas 100 mg/mL	1 gota/kg por dose (bula do Alivium®)
Gotas 200 mg/mL	1 gota a cada 2 kg por dose (bula do Alivium®)
Contraindicações	Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo atual ou prévio; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; dengue suspeita

Naproxeno

AINE de meia-vida longa, útil em cólica menstrual e dor musculoesquelética. Na bula do Flanax® (naproxeno sódico): comprimido de 275 mg, 1 comprimido 1 a 2 vezes ao dia; comprimido de 550 mg, 1 comprimido 1 vez ao dia. A dose de 550 mg em 24 horas não deve ser excedida sem prescrição, o uso não deve passar de 10 dias consecutivos e o produto não é indicado para menores de 12 anos. Idosos e pessoas com doença renal, hepática ou cardíaca precisam de dose menor e avaliação médica.

Riscos sistêmicos dos AINE

Sistema	Risco	Quem tem mais risco
Gastrintestinal	Dispepsia, úlcera, sangramento e perfuração	Idoso, úlcera prévia, uso de anticoagulante, antiplaquetário, corticoide ou inibidor seletivo da recaptação de serotonina, álcool
Renal	Queda da filtração, retenção de sódio, hipercalemia, lesão renal aguda	Desidratação (diarreia, vômitos, calor), doença renal, uso de diurético com IECA ou BRA, idoso
Cardiovascular	Aumento da pressão, piora de insuficiência cardíaca, eventos trombóticos com uso prolongado	Hipertenso, cardiopata, pós-infarto ou AVC
Respiratório	Broncoespasmo em asma induzida por AINE	Asmático com pólipos nasais ou crise prévia com analgésico
Hematológico	Sangramento	Dengue suspeita, anticoagulados, plaquetopenia

PONTO-CHAVE

A combinação de AINE com diurético e com IECA ou BRA é a tríade clássica de lesão renal aguda em idosos. Se o cliente usa losartana e hidroclorotiazida e pede ibuprofeno para dor no joelho, prefira paracetamol ou um AINE tópico.

Gestação e amamentação

AINE orais devem ser evitados na gestação sem prescrição. No terceiro trimestre há risco de fechamento precoce do canal arterial do feto e de redução do líquido amniótico, e agências reguladoras estenderam o alerta de oligoidrâmnio ao uso a partir de cerca de 20 semanas. No balcão, gestante com dor recebe paracetamol e orientação para falar com o pré-natal. Na amamentação, o ibuprofeno é considerado compatível em doses usuais, mas a decisão de uso regular deve passar pelo médico ou pelo farmacêutico com fonte de lactação atualizada.

Formas tópicas

AINE tópicos atingem concentração local suficiente para dor de partes moles superficiais (entorse, contusão, tendinite, dor lombar mecânica) com exposição sistêmica muito menor. São boa escolha para idoso, hipertenso e quem tem risco gástrico. Orientações: aplicar em pele íntegra, 3 a 4 vezes ao dia ou conforme a bula do produto, massageando até absorver; lavar as mãos depois (exceto se as mãos forem a área tratada); não cobrir com curativo oclusivo; não aplicar em mucosas, olhos ou feridas; evitar sol direto na área tratada. A bula do Cataflampro® aerossol indica o uso para adultos e adolescentes acima de 14 anos. Produtos com salicilato de metila são contraindicados para quem tem alergia a AAS e não devem ser usados em grandes áreas ou em crianças pequenas.

Os fitoterápicos tópicos da LMIP com indicação semelhante incluem *Arnica montana* (equimoses e contusões), *Cordia verbenacea* (processos inflamatórios localizados), *Symphytum officinale* (entorses e

contusões) e *Solidago chilensis* (contusões e dores musculares).

NO BALCÃO

Antes de qualquer AINE oral, pergunte: tem ou teve úlcera, gastrite com sangramento ou fezes escuras? Usa anticoagulante, AAS, corticoide ou antidepressivo? Tem pressão alta, doença do coração ou do rim? É asmático? Está grávida? Pode ser dengue? Uma resposta positiva desloca a escolha para paracetamol, dipirona ou forma tópica.

Encaminhe: dor articular com calor, vermelhidão e febre; trauma com deformidade, incapacidade de apoiar o membro ou dor óssea localizada; dor lombar com perda de força, alteração urinária ou febre; dor que persiste após 7 a 10 dias de uso.

CASO

Homem de 68 anos, hipertenso em uso de losartana e hidroclorotiazida, pede ibuprofeno para dor no ombro após pintar a casa. Conduta: explicar o risco renal e de descompensar a pressão, indicar diclofenaco gel no ombro 3 a 4 vezes ao dia por até 7 dias, paracetamol 750 mg se necessário (máximo 4 g/dia) e encaminhar se a dor limitar o movimento ou persistir além de uma semana.

Aparelho digestivo

Azia, gases, diarreia, prisão de ventre e cólica formam o segundo grande bloco do balcão. A maior parte dos produtos é MIP, mas vários fármacos que o cliente chama pelo nome comercial (Dramin®, Plasil®, Imosec®, Tiorfan®) não são. O raciocínio começa pelo sintoma, passa pelos sinais de alarme e só então chega ao produto.

Antiácidos e alginatos

Neutralizam o ácido já secretado e aliviam a azia em minutos, com efeito curto. Os alginatos formam uma camada que flutua sobre o conteúdo gástrico e reduz o refluxo. Constam da LMIP: hidróxido de alumínio (até 230 mg por comprimido), associações de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio (comprimido mastigável, pó e suspensão), as mesmas com simeticona ou oxetacaína, magaldrato 80 mg/mL (isolado ou com simeticona), alginato de sódio com bicarbonato e carbonato de cálcio (concentração ampliada pela IN 388/2025) e os sais efervescentes com bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico.

Componente	Efeito adverso típico	Cuidado
Hidróxido de alumínio	Constipação	Acúmulo de alumínio em doença renal crônica; uso prolongado reduz fósforo
Hidróxido de magnésio	Diarreia	Acúmulo de magnésio em doença renal
Carbonato de cálcio	Constipação, eructação	Hipercalcemia com uso crônico em dose alta

Componente	Efeito adverso típico	Cuidado
Bicarbonato de sódio	Distensão, eructação	Carga de sódio: evitar em hipertenso, cardiopata, gestante e dieta hipossódica

Posologia de referência (bula do Mylanta Plus®, alumínio + magnésio + simeticona): adultos e maiores de 12 anos, 10 a 20 mL entre as refeições e ao deitar, no máximo 12 colheres-medida em 24 horas e sem usar a dose máxima por mais de 2 semanas sem supervisão médica.

ATENÇÃO

Antiácidos com alumínio, magnésio ou cálcio formam complexos com quinolonas, tetraciclinas, sais de ferro, levotiroxina e bisfosfonatos, reduzindo a absorção. Oriente intervalo de pelo menos 2 horas, ou o intervalo que constar na bula do outro medicamento. Na bula do Dulcolax®, os antiácidos aparecem também como causa de dissolução precoce do revestimento entérico do bisacodil.

Omeprazol isento de prescrição

A IN 404/2025 incluiu na LMIP o **omeprazol 20 mg** em cápsula dura e cápsula dura de liberação retardada, com a indicação simplificada de alívio de sintomas frequentes (que ocorrem em dois ou mais dias na semana) de azia e queimação. O voto da Diretoria Colegiada que aprovou a inclusão (processo 25351.918052/2023-80) define as condições: apresentações com 7 a 14 unidades, rotulagem própria sem tarja vermelha, uso por até 14 dias e intervalo mínimo de 4 meses entre ciclos, como recomendou o parecer de farmacovigilância citado no voto. As apresentações de omeprazol 20 mg com 28 ou 56 cápsulas continuam sob prescrição: o mesmo registro pode ter apresentações tarjadas e isentas (RDC 882/2024, art. 14).

Item	Omeprazol 20 mg MIP
Mecanismo	Inibe a bomba de prótons da célula parietal; efeito pleno em 1 a 4 dias
Indicação	Azia ou queimação em 2 ou mais dias por semana, sem sinal de alarme
Posologia	1 cápsula ao dia, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, por até 14 dias
Repetição	Novo ciclo só após 4 meses; sintomas que voltam antes disso pedem avaliação médica
Interações	Clopidogrel (reduz a ativação), metotrexato, varfarina, fármacos que dependem de acidez para absorver (cetoconazol oral, sais de ferro)
Não indicado	Azia ocasional que precisa de alívio imediato (antiácido age antes); dor epigástrica com sinal de alarme

PONTO-CHAVE

Nenhum antagonista H2 consta da LMIP vigente. A famotidina tem venda sob prescrição (bula do Famox®). No balcão, a escalada é antiácido ou alginato para sintoma ocasional e omeprazol 20 mg por até 14 dias para azia frequente, com encaminhamento se não resolver.

Antiflatulentos

A **simeticona** reduz a tensão superficial das bolhas de gás e facilita sua eliminação. É medicamento de notificação simplificada (LMN, IN 106/2021; a IN 430/2026 incluiu a cápsula de 250 mg). Doses do texto da LMN: emulsão 75 mg/mL ou 150 mg/mL, adultos 40 a 125 mg por dose, repetir a cada 6 horas se necessário, máximo 500 mg/dia; crianças de 2 a 12 anos, 15 a 30 mg por dose; até 2 anos, até 15 mg por dose; nas duas faixas pediátricas, máximo 180 mg/dia. Comprimido de 40 mg: adultos 1 a 3 comprimidos a cada 6 horas (máximo 12 por dia). Contraindicada em distensão abdominal grave, cólica grave, dor persistente por mais de 36 horas, massa palpável no abdome e obstrução ou perfuração suspeita. O fitoterápico *Cinnamomum verum* + *Syzygium aromaticum* (canela e cravo) consta do Anexo II da LMIP como antiflatulento.

Náusea, vômito e enjoo de movimento

Aqui está uma das maiores armadilhas do balcão. **Dimenidrinato** não consta da LMIP: as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem "Venda sob prescrição médica". Metoclopramida (Plasil®), bromoprida, domperidona e ondansetrona (Vonau®) também são tarjados. Para cinetose, a LMIP inclui a **meclozina** 50 mg (profilaxia e tratamento da cinetose) e o fitoterápico *Zingiber officinale* (gengibre, profilaxia de náuseas por movimento e pós-cirúrgicas). Mesmo assim, verifique a embalagem: um produto só é MIP se o registro dele foi adequado à lista (a bula do Meclin® consultada ainda traz venda sob prescrição).

ATENÇÃO

Vômitos em criança pequena, idoso ou gestante, vômitos com sangue ou aspecto de borra de café, vômitos que impedem a ingestão de líquidos, dor abdominal intensa, rigidez de nuca ou sonolência exigem avaliação médica. Antiemético não é produto de autocuidado no Brasil, e o papel do farmacêutico é hidratar com sais de reidratação oral e encaminhar.

Diarreia aguda

A prioridade é prevenir e tratar a desidratação. Os **sais de reidratação oral** são medicamentos de notificação simplificada (LMN): o envelope é dissolvido em 1 litro de água filtrada ou fervida, e a solução preparada é descartada após 24 horas. Para reposição de perdas, o texto da LMN indica 75 mL/kg em 4 a 6 horas, até o limite de 4 litros; crianças amamentadas continuam no peito. O farmacêutico deve diferenciar a solução de reidratação de bebidas isotônicas e refrigerantes, que têm açúcar demais e sódio de menos.

Produto	Status	Uso
Sais de reidratação oral (pó, solução)	LMN e LMIP (formulações com zinco)	Prevenção e tratamento da desidratação, todas as idades
Saccharomyces boulardii	LMIP, até 250 mg	Coadjuvante; bula do Floratil® 200 mg: 1 cápsula 2 vezes ao dia na diarreia aguda; 2 a 3 dias costumam bastar; procurar médico se persistir após 5 dias
Bacillus cereus (suspensão)	LMIP	Coadjuvante no tratamento da diarreia e de enterocolites
Policarbofila cálcica 625 mg	LMIP	Regularização do hábito intestinal em síndrome do intestino irritável e diverticulose
Subsalicilato de bismuto 35 mg/mL	LMN (incluído pela IN 430/2026)	Conferir bula; contém salicilato: mesmas restrições do AAS (criança com virose, dengue, anticoagulado)
Loperamida	Fora da LMIP (bula do Imosec®: venda sob prescrição)	Não indicar
Racecadotrila	Fora da LMIP (bula do Tiorfan®: venda sob prescrição)	Não indicar

NO BALCÃO

Pergunte: idade, há quanto tempo, quantas evacuações por dia, se há sangue, muco ou febre, se urina pouco, se há vômitos, viagem recente, uso recente de antibiótico e se outras pessoas da casa estão com o mesmo quadro.

Encaminhe: sangue nas fezes; febre alta; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina, sonolência); lactente; idoso frágil; gestante; diarreia por mais de 3 dias em adulto; diarreia após uso de antibiótico; imunossupressão.

Constipação

Antes do laxante vêm fibras, água e atividade física. A escolha segue a lógica do mecanismo: formadores de massa para uso contínuo, osmóticos para casos mais persistentes e estimulantes para uso ocasional.

Classe	Exemplos MIP	Posologia de referência	Cuidados
Formadores de massa	*Plantago ovata* (psílio), policarbofila cálcica	Conforme bula, com bastante água	Sem água suficiente podem obstruir; efeito em 1 a 3 dias
Osmóticos	Lactulose 667 mg/mL; macrogol 3350 (LMN); macrogol com eletrólitos	Lactulose (bula da Lactulona®): adulto 15 a 30 mL/dia; 6 a 12 anos 10 a 15 mL; 1 a 5 anos 5 a 10 mL; lactentes 5 mL	Flatulência e cólica no início; macrogol: não exceder 100 g/dia (LMN)

Classe	Exemplos MIP	Posologia de referência	Cuidados
Estimulantes	Bisacodil 5 mg; picossulfato de sódio 7,5 mg/mL; sene, cáscara-sagrada (*Frangula purshiana*)	Bisacodil (bula do Dulcolax®): adulto e maior de 10 anos 5 a 10 mg à noite; 4 a 10 anos 5 mg	Cólica; uso crônico só com orientação; não tomar bisacodil com leite, antiácido ou omeprazol
Lubrificante	Óleo mineral (LMN)	Adulto 15 mL à noite; maiores de 6 anos 1 a 2 mL/kg (LMN)	Risco de pneumonia lipoídica em acamado, disfágico, idoso e bebê; reduz absorção de vitaminas lipossolúveis; não usar por mais de 1 semana
Retais	Supositório de glicerina (LMN); sorbitol + laurilsulfato de sódio	Glicerina: ação em 15 a 30 minutos	Úteis em fecaloma leve e em crianças, por curto período

ATENÇÃO

Constipação recente em adulto sem causa evidente, sangue nas fezes, afinamento das fezes, perda de peso, anemia ou dor abdominal intensa pedem avaliação médica. O texto da LMN do óleo mineral orienta consultar o médico antes de usar laxante quando o hábito intestinal muda de repente por duas semanas.

Cólicas e antiespasmódicos

O **butilbrometo de escopolamina** é um antimuscarínico de amônio quaternário que relaxa a musculatura lisa digestiva, biliar e urinária com pouca passagem ao sistema nervoso central. Constam da LMIP o comprimido de 10 mg, a solução oral de 10 mg/mL e as associações com dipirona (10 + 250 mg) e com paracetamol (10 + 500 mg).

Produto	Posologia (bulas Buscopan® e Buscopan Composto®)	Cuidados
Escopolamina 10 mg	Adultos e maiores de 6 anos: 10 a 20 mg, 3 a 5 vezes ao dia	Boca seca, taquicardia, retenção urinária; evitar em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática com retenção, miastenia e megacólon
Escopolamina gotas 10 mg/mL	Adultos e maiores de 6 anos: 20 a 40 gotas, 3 a 5 vezes ao dia; 1 a 6 anos: 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia	Lactente com cólica: encaminhar ao pediatra antes de qualquer antiespasmódico
Escopolamina + dipirona 10 + 250 mg	1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia	Todas as restrições da dipirona; uso prolongado exige hemograma

Não use antiespasmódico para mascarar dor abdominal sem diagnóstico. Dor que começa no centro do abdome e migra para o lado direito inferior, dor com febre, dor com vômitos persistentes, abdome rígido ou dor em gestante são situações de pronto atendimento.

Outros produtos digestivos da LMIP

Associações de racemetionina, citrato de colina e betaína, o *Silybum marianum*, o boldo (*Peumus boldus*), a alcachofra (*Cynara scolymus*), a espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*) e o alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra*) são MIP com indicação de dispepsia e auxílio em distúrbios hepáticos ou biliares. Servem para desconforto pós-prandial leve. Não tratam doença hepática e não substituem investigação de dor persistente. O alcaçuz em uso prolongado retém sódio e eleva a pressão.

CASO

Mulher de 42 anos relata queimação retroesternal 3 a 4 vezes por semana há um mês, piora ao deitar, sem dificuldade para engolir, perda de peso, vômitos ou fezes escuras. Usa apenas anticoncepcional oral. Conduta: omeprazol 20 mg MIP, 1 cápsula em jejum por 14 dias, orientação sobre refeições menores, evitar deitar até 2 a 3 horas após comer e elevar a cabeceira; registrar a intervenção e orientar consulta médica se os sintomas não cederem ou voltarem antes de 4 meses.

Tosse, gripe e resfriado

Resfriado e gripe são infecções virais autolimitadas. Nenhum MIP encurta a doença: todos tratam sintomas. O trabalho do farmacêutico é escolher o produto que cobre o sintoma principal do cliente, evitar componentes desnecessários e reconhecer quando a "gripe" é pneumonia, sinusite bacteriana, crise de asma ou dengue.

Antigripais em associação

A LMIP inclui dezenas de associações que combinam um analgésico (paracetamol, dipirona ou AAS), um descongestionante oral (cloridrato de fenilefrina), um anti-histamínico de primeira geração (clorfeniramina, dexclorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina) e, às vezes, cafeína ou vitamina C. Exemplos de linhas da lista: paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina 400 + 4 + 4 mg; paracetamol + fenilefrina 800 + 20 mg; dipirona + clorfeniramina + cafeína 500 + 2 + 30 mg.

Componente	Para que serve	Quem deve evitar
Paracetamol, dipirona ou AAS	Febre, dor no corpo, cefaleia	Ver tópico de analgésicos; AAS nunca em criança com gripe nem em dengue suspeita
Fenilefrina oral	Congestão nasal	Hipertenso não controlado, cardiopata, hipertireoidismo, glaucoma, uso de IMAO
Anti-H1 de primeira geração	Coriza e espirros (efeito anticolinérgico seca secreção)	Idoso, motorista, quem opera máquinas, glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática
Cafeína	Contrabalança a sonolência	Insônia, arritmia, ansiedade, gestante

Exemplo de bula: Resfenol® (paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina) indica, para adultos de 18 a 60 anos, 1 cápsula a cada 4 horas, no máximo 5 cápsulas por dia e por no máximo 3 dias, e é contraindicado para menores de 18 anos. Cada associação tem limites próprios: leia a bula do produto entregue e some o paracetamol de todas as fontes.

ATENÇÃO

Antigripal mais paracetamol isolado mais "remédio para dor de cabeça" é a receita da intoxicação hepática não intencional. Antigripal com fenilefrina para hipertenso descompensado e antigripal com anti-H1 sedativo para quem vai dirigir são erros de dispensação, mesmo quando o cliente insiste no produto.

Descongestionantes nasais e solução salina

Os vasoconstritores nasais tópicos (nafazolina, oximetazolina, fenoxazolina) **não constam da LMIP**. As bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem "Venda sob prescrição médica". São de tarja vermelha sem retenção de receita, o que não autoriza vendê-los sem prescrição. Além do aspecto legal, o uso por mais de poucos dias causa rinite medicamentosa (congestão rebote que leva ao uso crônico), e a ingestão acidental por crianças pequenas pode provocar sonolência, bradicardia e hipotermia.

Produto nasal	Status	Uso
Cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico nasal)	LMN	Lavagem e umidificação; qualquer idade, quantas vezes precisar
Cloreto de sódio até 30 mg/mL (hipertônico 3%) e gel nasal	LMIP; a IN 430/2026 incluiu na LMN a solução de 20 mg/mL	Congestão e mucosa ressecada; pode arder
Acetilcisteína solução nasal 11,5 mg/mL	LMIP	Congestão com secreção espessa
Azelastina solução nasal 1 mg/mL	LMIP	Rinite alérgica (anti-H1 tópico)
Levomentol + cânfora (óleo, pomada)	LMIP	Sensação de desobstrução; não aplicar dentro do nariz de bebês
Nafazolina, oximetazolina	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Descongestionante oral isento: bronfeniramina + fenilefrina (comprimido de liberação prolongada 12 + 15 mg e soluções orais), além das associações antigripais com fenilefrina.

Antitussígenos para tosse seca

Antitussígeno só tem lugar na tosse seca, irritativa, que atrapalha o sono. Na tosse produtiva, suprimir o reflexo retém secreção. Também não faz sentido associar antitussígeno com expectorante.

Fármaco	Forma MIP	Posologia (bula)	Cuidados
Dextrometorfano	Solução oral até 3 mg/mL	Adultos e maiores de 12 anos: 10 a 20 mg a cada 4 horas ou 30 mg a cada 6 a 8 horas; máximo 120 mg/dia	Contraindicado com IMAO (até 2 semanas antes), asma, DPOC, pneumonia, insuficiência respiratória; cautela com antidepressivos serotoninérgicos; potencial de abuso

Fármaco	Forma MIP	Posologia (bula)	Cuidados
Dropropizina	Solução oral até 30 mg/mL	Gotas (bula do Vibral®): adultos 30 gotas 4 vezes ao dia; maiores de 3 anos 15 gotas; 2 a 3 anos 4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia	Sonolência; evitar em asmático e na tosse produtiva
Cloperastina	Suspensão 35,4 mg/mL; solução 3,54 mg/mL	Xarope (bula do Seki®): adultos 10 mL 3 vezes ao dia; crianças 0,5 a 1 mL/kg/dia em 3 tomadas	Sonolência leve
Clobutinol	Solução oral até 4 mg/mL	Conforme bula do produto	Tosse seca apenas
Difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio	Solução oral e pastilha	Conforme bula	Sedação (anti-H1 de primeira geração)

Expectorantes e mucolíticos

Mucolíticos reduzem a viscosidade do muco; expectorantes aumentam o volume da secreção e facilitam a eliminação. A evidência de benefício em resfriado comum é modesta, e a hidratação faz parte do tratamento.

Fármaco	Forma MIP	Adulto	Criança
Acetilcisteína	Granulado/efervescente até 600 mg; solução oral até 40 mg/mL	600 mg 1 vez ao dia, de preferência à noite, por 5 a 10 dias (bula do Fluimucil®)	Xarope 20 mg/mL: 2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes ao dia
Ambroxol	Cápsula LP 75 mg; solução 7,5 mg/mL; xarope até 6 mg/mL	Xarope adulto 5 mL 3 vezes ao dia ou cápsula de 75 mg 1 vez ao dia (bula do Mucosolvan®)	Xarope pediátrico: 2 a 5 anos 2,5 mL 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 5 mL 3 vezes ao dia (0,5 mg/kg por dose)
Bromexina	Solução 2 mg/mL; xarope até 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes ao dia (bula do Bisolvon®)	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes ao dia (0,1 mg/kg por dose)
Carbocisteína	Solução oral até 50 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula
Guaifenesina	Solução oral até 16 mg/mL; com dextrometorfano 13,3 + 1,3 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula
Fitoterápicos	*Hedera helix* (hera), *Mikania glomerata* (guaco), *Thymus*, *Pelargonium sidoides*	Conforme bula	Guaco contém cumarina: cautela em anticoagulado

ATENÇÃO

Abaixo de 2 anos, mucolíticos não são produto de automedicação: a bula do Mucosolvan® restringe o uso nessa faixa à prescrição médica e o Fluimucil® pediátrico é indicado a partir de 2 anos. Lactente com tosse e secreção precisa de avaliação, lavagem nasal com soro e hidratação.

Dor de garganta

Pastilhas e soluções da LMIP: cloreto de cetilpiridínio (antisséptico), benzocaína (anestésico local), benzidamina (anti-inflamatório local, pastilha 3,15 mg e colutório 1,5 mg/mL), cloreto de dequalínio, tirotricina com hidroxiquinolina e o **flurbiprofeno** 8,75 mg. Na bula do Strepsils® com flurbiprofeno: adultos e maiores de 12 anos, 1 pastilha a cada 3 a 6 horas, no máximo 5 em 24 horas e por até 3 dias, movimentando a pastilha na boca; não indicado abaixo de 12 anos. Como é AINE, valem as restrições de úlcera, asma por AINE, anticoagulante e dengue.

NO BALCÃO

Pergunte idade, sintoma principal (nariz, tosse seca, tosse com catarro, garganta, febre), há quantos dias, se há falta de ar, chiado ou dor no peito, doenças crônicas (hipertensão, asma, DPOC, cardiopatia, diabetes, glaucoma, próstata), gestação e medicamentos em uso, em especial antidepressivos e IMAO.

Encaminhe: falta de ar, chiado, dor torácica, febre alta por mais de 3 dias ou que volta depois de melhorar, dor facial intensa com secreção purulenta por mais de 10 dias, placas na garganta com febre alta e sem tosse, dificuldade para engolir a saliva, tosse há 3 semanas ou mais (investigar tuberculose), sintomas gripais em pessoa de grupo de risco para complicação (idoso, gestante, criança pequena, imunossuprimido, doença crônica), que pode precisar de antiviral precoce.

CASO

Homem de 55 anos, hipertenso em uso de anlodipino, pede "o antigripal mais forte" para coriza, espirros e dor no corpo há 2 dias, sem febre alta nem falta de ar. Vai dirigir para o trabalho. Conduta: evitar associação com fenilefrina e com anti-H1 sedativo; paracetamol 750 mg até 4 vezes ao dia para dor, soro fisiológico nasal várias vezes ao dia, hidratação; se a coriza incomodar à noite, considerar anti-H1 não sedativo isento. Orientar retorno se surgir febre alta ou falta de ar.

Antialérgicos isentos de prescrição

Os anti-histamínicos H1 bloqueiam o receptor H1 da histamina (agem como agonistas inversos) e aliviam coriza, espirros, prurido nasal e ocular e urticária. Os de **primeira geração** atravessam a barreira hematoencefálica e têm ação anticolinérgica: sedam, prejudicam reflexos e secam mucosas. Os de **segunda geração** quase não entram no sistema nervoso central e são tomados uma vez ao dia. A congestão nasal responde pouco a qualquer anti-H1 oral.

Enquadramento dos anti-H1

Conferência feita, fármaco a fármaco, no Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025):

Fármaco	Na LMIP?	Formas e concentração máxima
Loratadina	Sim	Comprimido e cápsula mole 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Desloratadina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 1,25 mg/mL
Fexofenadina	Sim	Comprimido revestido 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL
Levocetirizina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 5 mg/mL
Ebastina	Sim	Comprimido revestido 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Epinastina	Sim	Comprimido revestido 20 mg; solução oral 2 mg/mL
Dexclorfeniramina	Sim	Comprimido 2 mg; liberação prolongada 6 mg; solução oral 2,8 mg/mL; creme 10 mg/g
Meclozina	Sim	Comprimido 50 mg, só para cinetose
Azelastina	Sim	Solução nasal 1 mg/mL
Cetirizina	**Não**	A bula do Zyrtec® traz venda sob prescrição médica (a levocetirizina, seu enantiômero, é MIP)
Prometazina	Só tópica	Creme 20 mg/g; a forma oral é tarjada
Hidroxizina, bilastina, rupatadina	Não	Venda sob prescrição
Clorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina, feniramina	Só em associações	Antigripais, descongestionantes orais e colírio com nafazolina

PONTO-CHAVE

Status de MIP é por linha da lista, e não por classe. A levocetirizina é MIP e a cetirizina não é. A dexclorfeniramina comprimido é MIP e a prometazina comprimido não é. Na dúvida, abra a LMIP e confira fármaco, forma e concentração.

Posologia dos anti-H1 de segunda geração

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Loratadina	10 mg 1 vez ao dia; não exceder 10 mg em 24 horas	Maiores de 12 anos ou acima de 30 kg: 10 mg; 2 a 12 anos com menos de 30 kg: 5 mg (5 mL do xarope 1 mg/mL) 1 vez ao dia	Bula do Claritin®

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Desloratadina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 11 meses: 1 mg (2 mL); 1 a 5 anos: 1,25 mg (2,5 mL); 6 a 11 anos: 2,5 mg (5 mL), 1 vez ao dia	Bula do Desalex®; aumentar a dose não aumenta o efeito e pode dar sono
Fexofenadina	Rinite: 120 ou 180 mg 1 vez ao dia, ou 60 mg 12/12 h; urticária: 180 mg 1 vez ao dia ou 60 mg 12/12 h	2 a 11 anos (acima de 10,5 kg): 30 mg (5 mL) 12/12 h	Bula do Allegra®; tomar com água; antiácidos com alumínio e magnésio e sucos de fruta reduzem a absorção
Levocetirizina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez ao dia (máximo diário)	Bula do Zyxem®; ajustar em doença renal
Ebastina	10 mg 1 vez ao dia; 20 mg em rinite intensa	Comprimido para maiores de 12 anos; xarope contraindicado abaixo de 2 anos	Bula do Ebastel®; doença hepática leve a moderada: máximo 10 mg
Epinastina	Rinite: 10 a 20 mg 1 vez ao dia; dermatoses: 20 mg; máximo 40 mg/dia	6 a 12 anos: 5 a 10 mg (xarope); contraindicado abaixo de 6 anos	Bula do Talerc®

Dexclorfeniramina e a sedação

A dexclorfeniramina é o anti-H1 de primeira geração MIP mais usado, inclusive para prurido de picadas e urticária aguda. Bula do Polaramine®: adultos e maiores de 12 anos, 2 mg 3 a 4 vezes ao dia (máximo 12 mg/dia); solução 2 mg/5 mL: 6 a 12 anos, 2,5 mL 3 vezes ao dia (máximo 6 mg/dia); 2 a 6 anos, 1,25 mL 3 vezes ao dia (máximo 3 mg/dia); gotas: 2 a 6 anos, 1 gota a cada 2 kg ou 5 gotas, 3 vezes ao dia. Contraindicada em menores de 2 anos.

Efeitos esperados: sonolência, redução da atenção, boca seca, visão borrada, constipação e retenção urinária. Somam-se a álcool, benzodiazepínicos, opioides e outros depressores. Em criança pode ocorrer excitação paradoxal.

ATENÇÃO

No **idoso**, anti-H1 de primeira geração causa confusão, quedas, retenção urinária e constipação; os Critérios de Beers da Sociedade Americana de Geriatria recomendam evitá-los. Prefira loratadina, desloratadina ou fexofenadina. Para quem dirige, opera máquinas ou trabalha em altura, a regra é a mesma.

Gestação, amamentação e crianças

Na gestação, nenhum anti-H1 deve ser iniciado por automedicação: o cliente deve falar com o pré-natal, que costuma optar por fármacos com mais dados de uso, como a loratadina. Na amamentação, anti-H1 sedativos podem causar sonolência e irritabilidade no lactente e reduzir a produção de leite; os de segunda geração são preferidos, com orientação. Em crianças, respeite a idade mínima de cada bula, sempre com dose por idade ou peso e seringa dosadora.

Limites do anti-H1

Rinite persistente com obstrução nasal importante responde melhor a corticoide nasal, que exige prescrição. Rinite com tosse noturna, chiado ou falta de ar sugere asma associada. Urticária que dura mais de 6 semanas é crônica e precisa de investigação. Prurido generalizado sem lesão de pele pode ser sinal de doença hepática, renal ou hematológica.

ATENÇÃO

Inchaço de lábios, língua ou pálpebras, rouquidão, dificuldade para respirar ou engolir, tontura ou desmaio após alimento, picada de inseto ou medicamento indicam **anafilaxia** ou angioedema. Anti-H1 oral não trata anafilaxia: ligue para o SAMU (192) e não ofereça comprimido como solução.

NO BALCÃO

Pergunte: os sintomas são sazonais ou o ano todo? Há obstrução nasal, chiado ou falta de ar? Já usou anti-H1 antes? Precisa dirigir ou trabalhar em atenção? Idade, gestação, amamentação, glaucoma, próstata, doença renal ou hepática? Usa sedativos ou bebe álcool?

Para rinite intermitente leve em adulto ativo: anti-H1 de segunda geração 1 vez ao dia, lavagem nasal com soro e controle de alérgenos (poeira, ácaros, mofo). Reavalie em 7 a 14 dias e encaminhe se não houver melhora.

CASO

Motorista de aplicativo, 38 anos, com espirros e coriza clara toda manhã há 2 semanas, sem febre ou chiado, pede "Polaramine". Conduta: explicar a sedação da dexclorfeniramina e indicar loratadina 10 mg ou fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia, soro fisiológico nasal e medidas contra ácaros; encaminhar se houver obstrução persistente, chiado ou piora.

Pele e mucosas

A pele concentra o maior número de linhas da LMIP: antifúngicos, antissépticos, antibióticos tópicos, cicatrizantes, corticoide de baixa potência, antiviral labial, escabicidas e produtos para acne. A regra de ouro é identificar a lesão antes de escolher o produto. Corticoide em micose, antifúngico em eczema e antibiótico em lesão viral são erros comuns que pioram o quadro.

Antifúngicos tópicos

Indicados em micoses superficiais: frieira (tinha dos pés), micose de virilha, tinha do corpo (lesão arredondada com borda ativa e centro mais claro), pitiríase versicolor ("pano branco") e candidíase de dobras. O tratamento é longo: deve continuar por cerca de 2 semanas após o desaparecimento dos sintomas, para evitar recidiva (bula do Canesten®).

Fármaco (LMIP)	Formas e concentração máxima	Posologia de referência
Clotrimazol	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	2 a 3 vezes ao dia; pés e dobras: 3 a 4 semanas (bula do Canesten®)
Miconazol	Creme e pó 20 mg/g; emulsão 20 mg/mL	Conforme bula; a emulsão tem indicação também para dermatite de fraldas
Cetoconazol	Creme 20 mg/g; xampu 20 mg/mL	Creme 1 vez ao dia por cerca de 4 semanas (bula do Nizoral®); xampu para dermatite seborreica
Terbinafina	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	Conforme bula; alilamina de ação fungicida, costuma exigir ciclos mais curtos
Tioconazol, oxiconazol, flutrimazol, butenafina	Creme (e solução) 10 mg/g	Conforme bula
Amorolfina	Creme 2,5 mg/g; esmalte 50 mg/mL	Esmalte para onicomicose leve, uso semanal prolongado conforme bula
Ciclopirox	Esmalte 80 mg/mL; creme e spray 10 mg/mL (incluídos pela IN 388/2025)	Conforme bula
Nistatina + óxido de zinco	Pomada	Assaduras com componente de candidíase
Sulfeto de selênio	Xampu 25 mg/mL	Caspa, dermatite seborreica do couro cabeludo

Onicomicose em uma ou poucas unhas, sem atingir a base (matriz), pode ser tratada com esmalte por muitos meses. Comprometimento de várias unhas, da matriz, diabético com lesão no pé ou imunossuprimido precisam de avaliação médica, porque o antifúngico oral (terbinafina comprimido, itraconazol, fluconazol) exige prescrição.

Candidíase vaginal

Produto MIP	Esquema (bula do Gino-Canesten®)
Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal	1 aplicação à noite, dose única
Clotrimazol creme vaginal 20 mg/g	1 aplicador (cerca de 5 g) à noite por 3 noites seguidas
Clotrimazol creme vaginal 10 mg/g	1 aplicador à noite por 6 noites seguidas
Miconazol creme vaginal 20 mg/g	Conforme o número de noites indicado na bula do produto

ATENÇÃO

Só trate candidíase vaginal no balcão quando a mulher já teve diagnóstico médico prévio e reconhece o mesmo quadro: prurido intenso e corrimento branco grumoso, sem odor. Encaminhe: primeiro episódio; gestante; menor de idade; corrimento com odor forte, amarelado ou esverdeado; dor pélvica, febre ou dor ao urinar; episódios repetidos ao longo do ano; diabetes descompensado; risco de infecção sexualmente transmissível. O fluconazol oral não consta da LMIP.

Antissépticos e antibióticos tópicos

Ferida superficial é limpa primeiro com água corrente e sabão neutro. Depois, se necessário, antisséptico. São MIP: iodopovidona (pomada 10% e sabonete; também na LMN), clorexidina em solução de 0,5% a 4% (LMN), álcool 70% (LMN, só em pele íntegra) e peróxido de hidrogênio 3% (LMN), este último pouco indicado em feridas porque lesa tecido de granulação. A neomicina pomada 5 mg/g e a associação neomicina + bacitracina constam da LMIP para impetigo, furúnculo e prevenção de infecção em ferimento cortante. A neomicina é causa frequente de dermatite de contato alérgica. A sulfadiazina de prata não consta da lista.

Cicatrizantes e protetores

Dexpantenol pomada 50 mg/g, óxido de zinco (pasta e pomada, LMN), associação de vitaminas A e D com óxido de zinco ou alantoína (assaduras), colagenase pomada (desbridamento enzimático de ferimentos leves, escoriações e escaras) e ureia creme 200 mg/g (pele seca, calosidades) são MIP. Entre os fitoterápicos do Anexo II, *Aloe vera*, *Calendula officinalis* e *Matricaria recutita* têm indicação de cicatrizante em queimaduras térmicas leves.

Queimadura leve

Primeiro grau (vermelhidão e dor, sem bolha) e pequenas queimaduras de segundo grau superficial podem ser conduzidas no balcão. Orientação: resfriar com água corrente fria por vários minutos (sem gelo), retirar anéis e relógios, não furar bolhas, não aplicar pasta de dente, manteiga, café ou clara de ovo, cobrir com curativo limpo não aderente e usar analgésico oral. Para eritema solar e queimadura de primeiro grau, o acetato de hidrocortisona 1% é MIP.

ATENÇÃO

Encaminhe para atendimento: queimadura em face, mãos, pés, genitais ou sobre articulações; bolhas extensas (área maior que a palma da mão do paciente, que equivale a cerca de 1% da superfície corporal); queimadura química ou elétrica; queimadura em criança pequena ou idoso; lesão branca, acinzentada ou indolor (profunda); sinais de infecção.

Hidrocortisona tópica

O acetato de hidrocortisona creme ou pomada até 10 mg/g (1%) é o único corticoide tópico da LMIP. Indicação simplificada: dermatites, eczemas, eritema solar, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. Bula do Berlison®: camada fina 2 a 3 vezes ao dia e, após melhora, 1 vez ao dia; em bebês e

crianças de até 4 anos, não ultrapassar 3 semanas, especialmente sob fralda. Não usar em micose, herpes, acne, rosácea ou ferida infectada. Betametasona, dexametasona, mometasona, clobetasol e associações com antifúngico ou antibiótico são de venda sob prescrição.

Herpes labial

O **penciclovir** creme 10 mg/g é o antiviral tópico da LMIP. Bula do Penvir Lábia®: aplicar a cada 2 horas enquanto acordado, por 4 dias, começando aos primeiros sinais (formigamento, ardor); não recomendado abaixo de 12 anos. O **aciclovir creme não consta da LMIP**: a bula do Zovirax® traz venda sob prescrição médica. Encaminhe herpes em criança pequena, imunossuprimido, lesão perto do olho, crises muito frequentes ou lesão que não cicatriza em 10 a 14 dias.

Piolho e sarna

Produto	Status	Como usar (bula)
Permetrina 1% (10 mg/mL)	LMIP, pediculose	Xampu ou loção no cabelo molhado, deixar 10 minutos, enxaguar e passar pente fino; repetir após 7 a 14 dias se ainda houver piolhos (bula do Nedax®)
Permetrina 5% (50 mg/mL)	LMIP, escabiose	Pele limpa, seca e fria, do pescoço aos pés (incluir couro cabeludo em criança e idoso), remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação; 6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g; segunda aplicação em 7 a 10 dias se surgirem lesões novas
Deltametrina 0,2 mg/mL	LMIP, pediculose, ftiríase, escabiose	Aplicar no banho, deixar 5 minutos, enxaguar, por 4 dias seguidos; repetir o esquema 7 dias após a última aplicação (bula do Deltacid®)
Benzoato de benzila (emulsão, sabonete)	LMN	Diluir conforme bula (o Sanasar® orienta 1:1 em adultos e 1:3 em crianças); irrita a pele
Tiabendazol tópico 5%	LMN, larva migrans e escabiose	Larva migrans: 3 vezes ao dia por 5 dias; não usar em gestante e lactante
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Coceira pode persistir por até algumas semanas após o tratamento correto da escabiose e, segundo a bula da permetrina 5%, raramente indica falha. Todos os contatos da casa são tratados ao mesmo tempo, e roupas de cama, toalhas e roupas usadas nos últimos dias são lavadas com água quente ou guardadas fechadas em saco plástico por alguns dias.

Acne e rosácea

O **peróxido de benzoíla** é medicamento de notificação simplificada (LMN) em sabonete 2,5% e 5%, loção 5% e gel 10%. Texto da LMN para o gel 10%: aplicar à noite; na primeira semana, manter por 1 hora e enxaguar; sem irritação, passar a manter a noite inteira; usar fotoprotetor durante o dia; uso a partir de 12 anos. Descolore cabelo, tecidos e toalhas. Constam ainda da LMIP o ácido azelaico (creme 200 mg/g e gel

150 mg/g, acne e rosácea papulopustulosa), o metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea) e o ácido salicílico gel 270 mg/g, indicado para verrugas comuns. Adapaleno, tretinoína, clindamicina e eritromicina tópicas e isotretinoína oral exigem prescrição. Encaminhe acne com nódulos, cistos, cicatrizes, piora emocional importante ou sem resposta após algumas semanas de uso correto.

Fotoprotetores

Protetores solares são regularizados na Anvisa como cosméticos, mesmo quando vendidos em farmácia. A orientação farmacêutica continua necessária: fator de proteção alto e proteção UVA indicada no rótulo, quantidade suficiente, reaplicação a cada 2 horas e após suor ou banho de mar, barreiras físicas (chapéu, roupa, sombra) e cuidado com bebês, que devem ficar longe do sol direto. Quem usa peróxido de benzoíla, ácido azelaico ou retinoide precisa de fotoproteção rigorosa.

NO BALCÃO

Peça para ver a lesão quando o ambiente permitir privacidade. Pergunte há quanto tempo existe, se coça ou dói, se tem secreção, se já usou algum creme (corticoide mascara micose), se há pessoas na casa com o mesmo quadro, se é diabético ou imunossuprimido.

Encaminhe: lesão extensa, febre, celulite (vermelhidão quente que se espalha), lesão em face próxima ao olho, ferida que não cicatriza em 2 semanas, pinta que muda de forma, cor ou tamanho, lesão em mucosa genital sem diagnóstico.

CASO

Rapaz de 20 anos, jogador de futebol, com descamação e coceira entre o quarto e o quinto dedo dos pés há 3 semanas, sem dor, secreção ou vermelhidão subindo pelo pé. Já usou pomada de corticoide com antibiótico que "melhorou e voltou". Conduta: suspender o corticoide, terbinafina creme ou clotrimazol creme conforme bula, mantendo por 2 semanas após a cura aparente; secar bem entre os dedos, trocar meias diariamente, chinelo em vestiário. Encaminhar se não melhorar em 2 a 4 semanas.

Antiparasitários intestinais

Verminoses intestinais continuam frequentes no Brasil, sobretudo em crianças e em áreas com saneamento precário. A automedicação com "vermífugo" é antiga e, em parte, culturalmente aceita. O farmacêutico precisa saber que apenas dois antiparasitários orais constam da LMIP.

Enquadramento

Fármaco	Status	Forma e concentração
Mebendazol	LMIP	Comprimido 500 mg; suspensão oral 20 mg/mL
Levamisol	LMIP, apenas ascaridíase	Comprimido até 150 mg

Fármaco	Status	Forma e concentração
Albendazol	Fora da LMIP	A bula do Zentel® traz venda sob prescrição médica
Ivermectina, nitazoxanida, secnidazol, metronidazol oral, tinidazol, praziquantel	Fora da LMIP	Venda sob prescrição

PONTO-CHAVE

Albendazol é provavelmente o vermífugo mais pedido pelo nome, e não é MIP. Pedido de albendazol sem receita deve ser redirecionado: avalie se cabe mebendazol e, se o quadro sugerir outra parasitose (giardíase, amebíase, estrongiloidíase, teníase), encaminhe.

Mebendazol

Benzimidazol que inibe a polimerização da tubulina do parasita e bloqueia a captação de glicose. Pouco absorvido, age na luz intestinal. Indicações da bula do Pantelmin®: *Enterobius vermicularis* (oxiúro), *Trichuris trichiura*, *Ascaris lumbricoides*, ancilostomídeos e, na suspensão, também tênias.

Apresentação	Esquema (bula do Pantelmin®)
Comprimido 500 mg	Adultos e crianças acima de 1 ano: 1 comprimido em dose única, com um pouco de líquido, sem jejum ou dieta
Suspensão 20 mg/mL, nematódeos	5 mL (100 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias seguidos, independentemente de peso e idade
Suspensão 20 mg/mL, cestódeos	Adultos: 10 mL (200 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias; crianças: 5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias

Contraindicado abaixo de 1 ano pelo risco de convulsão; entre 1 e 2 anos, só se o benefício justificar, o que no balcão significa encaminhar ao pediatra. Na gestação, não usar sem orientação médica. Efeitos adversos: dor abdominal, diarreia, náusea; raramente reação de hipersensibilidade. A bula orienta evitar o uso junto com metronidazol (relato de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) e avisar o médico se o paciente usa cimetidina.

Levamisol

Agonista nicotínico que paralisa o áscaris, eliminado em até 24 horas. Dose única ao deitar, sem laxante ou dieta (bula do Ascaridil®): lactentes até 1 ano, 40 mg; 1 a 7 anos, 80 mg; acima de 7 anos e adultos, 150 mg. Serve apenas para ascaridíase. É tratamento de dose única.

Repetição de dose e medidas gerais

Na **oxiuríase** há autoinfecção (ovos na região perianal levados à boca pelas mãos) e reinfecção entre moradores. Por isso, protocolos internacionais (como o do CDC norte-americano) recomendam repetir a

dose após 2 semanas e tratar todos da casa ao mesmo tempo. A bula do mebendazol no Brasil não traz esquema de repetição, de modo que a segunda dose deve ser combinada com o prescritor ou registrada como orientação farmacêutica fundamentada. Medidas que valem para qualquer verminose: lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, manter unhas curtas, trocar e lavar roupas íntimas e de cama, lavar bem frutas e verduras, beber água tratada ou fervida, andar calçado.

"Vermífugo de seis em seis meses" para toda a família sem sintomas não é indicação de balcão. A bula do Pantelmin® cita o tratamento repetido 3 a 4 vezes ao ano em áreas altamente endêmicas, estratégia de saúde pública organizada pelo SUS que não se transfere para a rotina individual.

ATENÇÃO

Encaminhe: criança menor de 2 anos; gestante; diarreia com sangue ou muco; diarreia prolongada, perda de peso ou anemia; eliminação de "pedaços brancos e achatados" (proglotes de tênia), porque a teníase pelo *Taenia solium* se relaciona à cisticercose; prurido anal que persiste após o tratamento correto; sintomas após viagem ou contato com água de rio e lagoa (esquistossomose).

NO BALCÃO

Pergunte: quem tem os sintomas e qual a idade e o peso; qual o sintoma (coceira anal noturna sugere oxiúro; eliminação de verme longo e cilíndrico sugere áscaris); há outras pessoas na casa com o mesmo quadro; houve diarreia com sangue, febre ou perda de peso; gestação.

CASO

Mãe relata que a filha de 6 anos acorda à noite com coceira anal e que viu "vermezinhos brancos e finos" nas fezes. O irmão de 9 anos tem o mesmo sintoma. Conduta: mebendazol 500 mg em dose única para as duas crianças e para os adultos da casa, higiene de mãos e unhas, troca diária de roupa íntima e de cama, orientação de repetir em 2 semanas conforme combinado com o pediatra; encaminhar se persistir.

Vitaminas, minerais e suplementos

Vitaminas e minerais chegam à prateleira por três caminhos regulatórios diferentes, e o cliente raramente percebe a diferença. O farmacêutico precisa reconhecer em qual categoria está o produto, porque isso define se é MIP, se exige receita e o que o rótulo pode prometer.

Categorias regulatórias

Categoria	Base normativa	Como reconhecer	Exemplos
Medicamento registrado	Registro na Anvisa; categoria de venda definida no registro (RDC 882/2024 para MIP)	Número de registro do Ministério da Saúde, bula, indicação terapêutica; pode ter tarja	Vitamina D em gotas de alta concentração, ferro polimaltosado, complexo B injetável ou em alta dose

Categoria	Base normativa	Como reconhecer	Exemplos
Medicamento de notificação simplificada	RDC 576/2021; lista na IN 106/2021 com atualizações (IN 430/2026)	Venda isenta de prescrição por definição; texto de rótulo padronizado pela LMN	Sulfato ferroso, ácido fólico 0,2 mg/mL, carbonato de cálcio + colecalciferol
Suplemento alimentar	RDC 243/2018 e IN 28/2018 (listas de constituintes, limites mínimos e máximos, alegações)	É alimento; não pode alegar tratar, curar ou prevenir doença; limites por faixa etária	Polivitamínicos, vitamina D e magnésio em cápsulas

Na conferência feita para este material, bulas de vários medicamentos vitamínicos e minerais muito procurados trazem "Venda sob prescrição médica": Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum® gotas, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva® e Endofolin® (ácido fólico 5 mg). Portanto, ser vitamina não torna o produto MIP. O suplemento alimentar, por sua vez, dispensa receita, mas também não pode ser indicado para tratar deficiência diagnosticada como se fosse medicamento.

PONTO-CHAVE

Para saber se um produto vitamínico é MIP, olhe a embalagem: medicamento registrado traz a categoria de venda (com ou sem tarja); produto notificado segue a LMN; suplemento alimentar traz a designação de suplemento e não tem bula. A IN 28/2018 limita as doses diárias dos suplementos por grupo populacional, e esses limites são revistos periodicamente por novas INs.

Ferro

O sulfato ferroso consta da LMN em comprimido de 40 mg e de 60 mg de ferro elementar e em solução oral de 25 mg/mL de ferro elementar, com indicação de auxiliar nas anemias carenciais.

Apresentação (LMN)	Posologia do texto padronizado
Comprimido 40 ou 60 mg de ferro elementar	Adulto: 1 comprimido ao dia, por via oral, em jejum
Solução 25 mg/mL de ferro elementar	Maiores de 12 anos e adultos: 4 mL 1 vez ao dia; 6 a 18 meses: 1 mL 1 vez por semana; 18 meses a 6 anos: 1 mL 1 vez ao dia; 6 a 12 anos: 2 mL 1 vez ao dia

Advertências da LMN: cautela em doença hepática, úlcera péptica, alcoolismo e insuficiência renal; evitar uso por mais de 6 meses; não usar em anemia hemolítica. Efeitos adversos: constipação ou diarreia, náusea, dor abdominal, fezes escuras (esperado, deve ser avisado), escurecimento dos dentes com a solução (usar canudo ou escovar após).

Interações de absorção: antiácidos, omeprazol, cálcio, leite e derivados, chá e café reduzem a absorção; vitamina C aumenta. O ferro reduz a absorção de levotiroxina, quinolonas, tetraciclinas e bisfosfonatos: separar por pelo menos 2 horas, ou conforme a bula do outro fármaco.

ATENÇÃO

Ferro é causa importante de intoxicação grave em crianças pequenas. Oriente guardar fora do alcance e da vista, nunca chamar de "balinha" e procurar pronto-socorro imediatamente em ingestão acidental. Anemia em homem adulto ou em mulher após a menopausa pode significar sangramento digestivo oculto: encaminhe para investigação em vez de apenas vender ferro.

Ácido fólico

A LMN inclui a solução de ácido fólico 0,2 mg/mL, com duas indicações: redução da ocorrência de malformações fetais (adulto, 2 mL ao dia, ou seja, 0,4 mg) e tratamento da carência de folatos (até 5 mL ao dia, 1 mg). O texto padronizado alerta que doses acima de 0,1 mg/dia podem mascarar anemia perniciosa (o sangue normaliza enquanto o dano neurológico progride) e que doses muito altas podem precipitar convulsões em quem usa fenitoína. O ácido fólico 5 mg (Endofolin®) é de venda sob prescrição.

Mulher que planeja engravidar deve iniciar ácido fólico antes da concepção e manter no início da gestação, de preferência com acompanhamento do pré-natal. É um ótimo momento para o farmacêutico perguntar sobre planejamento reprodutivo e encaminhar à unidade de saúde.

Vitamina D e cálcio

A LMN inclui carbonato de cálcio 1250 mg (500 mg de cálcio elementar) com colecalciferol 200 UI ou 400 UI, para prevenção do raquitismo e auxílio na desmineralização óssea. Posologia padronizada: adultos, 1 a 3 comprimidos ao dia (200 UI) ou 1 a 2 comprimidos ao dia (400 UI), após as refeições; uso pediátrico, 1 comprimido ao dia. Contraindicações: hipercalcemia, hipervitaminose D, hipersensibilidade.

Medicamentos de vitamina D em alta concentração (gotas, comprimidos ou cápsulas de doses semanais ou mensais) são, nos produtos conferidos, de venda sob prescrição. Doses altas sem dosagem prévia e sem acompanhamento podem causar hipercalcemia: sede, aumento da urina, náusea, vômitos, constipação, confusão, cálculo renal e arritmia. Cálcio isolado causa constipação, interage com ferro, levotiroxina, quinolonas e tetraciclinas e deve ser usado com cautela por quem tem cálculo renal.

Complexo B e polivitamínicos

Produtos com vitaminas B1, B6 e B12 em doses altas (Citoneurin®, Benerva®) são de venda sob prescrição. Vitamina B6 em dose alta e uso prolongado causa neuropatia periférica. Polivitamínicos de uso diário costumam ser suplementos alimentares. Para o cliente que pede "algo para cansaço", a vitamina raramente é a resposta: cansaço persistente pode ser anemia, hipotireoidismo, depressão, apneia do sono ou diabetes, e merece avaliação médica. O Anexo II da LMIP inclui fitoterápicos com indicação de cansaço físico e mental (*Panax ginseng*, *Paullinia cupana*), que estimulam e podem elevar a pressão e causar insônia.

NO BALCÃO

Pergunte: para que o cliente quer a vitamina, se tem exame com deficiência diagnosticada, se está grávida ou planejando, que medicamentos usa (levotiroxina, anticonvulsivantes, anticoagulantes), se já toma outros suplementos (a soma das doses importa) e se tem doença renal ou cálculo.

Ao entregar ferro: em jejum ou longe de leite, café e antiácido, fezes escuras são esperadas, guardar longe de crianças, retornar ao médico para controle. Ao entregar vitamina D: não somar com outro produto que já contenha vitamina D sem orientação.

CASO

Mulher de 28 anos diz que vai "tentar engravidar" e pede um polivitamínico "para gestante". Conduta: explicar a importância do ácido fólico antes da concepção, indicar ácido fólico 0,4 mg ao dia (2 mL da solução 0,2 mg/mL, conforme a LMN), orientar consulta pré-concepcional na unidade de saúde, revisar medicamentos em uso (anticonvulsivantes, isotretinoína, varfarina) e registrar a orientação.

Olhos, ouvidos e boca

Olhos, ouvidos e boca têm MIP úteis e também os sintomas de alarme mais traiçoeiros do balcão. Dor ocular, baixa de visão e dor de ouvido com febre não são casos de automedicação.

Lubrificantes oculares (lágrimas artificiais)

Constam da LMIP, com indicação de lubrificante oftálmico: carmelose sódica 10 mg/mL (isolada ou com glicerol), hialuronato de sódio 2 mg/mL, hipromelose 5 mg/mL, dextrana com hipromelose (com ou sem glicerol), álcool polivinílico 14 mg/mL, carbômer gel (com ou sem sorbitol) e macrogol com propilenoglicol (com ou sem hidroxipropil guar). Indicação de balcão: olho seco por tela, ar-condicionado, vento, leitura prolongada. Uso: 1 a 2 gotas várias vezes ao dia, conforme bula; o gel é melhor à noite porque embaça a visão.

- Usuário de lente de contato: escolher produto compatível com lente ou sem conservante (o cloreto de benzalcônio adere às lentes gelatinosas); na dúvida, retirar a lente e aguardar o tempo da bula.
- Frascos multidose têm validade curta após abertos, definida na bula. Flaconetes de dose única sem conservante são descartados após o uso.
- Não encostar a ponta do frasco no olho ou nos cílios.
- Mais de um colírio: intervalo de cerca de 5 minutos entre eles.

Vasoconstritores oculares

Constam da LMIP: nafazolina + feniramina (0,25 + 3 mg/mL), nafazolina + sulfato de zinco (0,15 + 0,3 mg/mL) e cloreto de benzalcônio + ácido bórico (irritação e higiene ocular). Bula do Colírio Moura Brasil®: 1 a 2 gotas no olho afetado até 4 vezes ao dia; procurar o médico se a irritação persistir, se houver dor ou alteração da visão. Contraindicações de vasoconstritores: glaucoma de ângulo fechado e uso de IMAO.

ATENÇÃO

O vasoconstritor clareia o olho por algumas horas, mas o uso contínuo causa **hiperemia de rebote** e dependência do colírio. Indique por poucos dias, para irritação leve, e nunca para olho vermelho com dor, secreção purulenta, fotofobia ou baixa da visão. Colírios com antibiótico, corticoide, anti-inflamatório ou anti-glaucomatoso exigem prescrição.

Sinal de alarme ocular	Possível causa	Conduta
Dor ocular intensa, visão embaçada, halos, náusea	Glaucoma agudo	Emergência oftalmológica
Olho vermelho em usuário de lente de contato	Ceratite	Retirar a lente e procurar oftalmologista no mesmo dia
Respingo de produto químico	Queimadura química	Lavar com água corrente abundante por vários minutos e ir ao pronto-socorro
Corpo estranho que não sai, trauma	Lesão de córnea	Não esfregar; encaminhar
Secreção purulenta, pálpebras coladas	Conjuntivite bacteriana	Avaliação médica

Ouvidos

A LMIP inclui duas soluções otológicas com indicação simplificada de dor de ouvido e remoção de cerume: hidroxiquinolina + trolamina (0,4 + 140 mg/mL) e fenol + mentol (18,6 + 1,3 mg/mL). Bula do Cerumin®: 5 gotas no ouvido afetado, 3 vezes ao dia, com intervalo de cerca de 8 horas, aplicadas com a pessoa deitada e o ouvido para cima, mantendo a posição por 5 minutos; o refluxo da solução é normal.

ATENÇÃO

Não pingue nada no ouvido se houver suspeita de perfuração do tímpano (saída de secreção ou sangue, dor que melhorou de repente após muita dor), tubo de ventilação, cirurgia prévia no ouvido, febre ou dor intensa. Dor de ouvido em criança com febre é otite média até prova em contrário e precisa de avaliação. Antibióticos e corticoides otológicos não são MIP. Cotonete empurra o cerume e pode ferir o canal.

Boca e garganta

MIP de uso bucal: cloridrato de benzidamina colutório 1,5 mg/mL (inflamação da boca e garganta), cetilpiridínio em solução, associações para aftas com camomila (*Matricaria chamomilla*), lidocaína e polidocanol em gel ou solução, tirotricina com hidroxiquinolina e fluoreto (gel), neomicina com bismuto e procaína (suspensão para aftas) e procaína com timol, mentol e cânfora. Enxaguantes de uso diário sem indicação terapêutica costumam ser produtos de higiene bucal regularizados como cosméticos.

- Afta comum: pequena, dolorosa, com halo vermelho, cicatriza em 7 a 14 dias. Anestésico tópico alivia a dor para comer.

- Encaminhe ao dentista ou médico: lesão que não cicatriza em 2 a 3 semanas, mancha branca ou vermelha que não sai ao raspar, lesão endurecida, especialmente em fumante e etilista (risco de câncer de boca); múltiplas lesões com febre em criança; aftas muito frequentes.
- Dor de dente: analgésico como ponte até o dentista; abscesso com inchaço no rosto, febre ou dificuldade para abrir a boca é urgência.
- Gengivas que sangram ao escovar indicam doença periodontal; o antisséptico não substitui o tratamento odontológico.

NO BALCÃO

Olho: pergunte se há dor, alteração da visão, secreção, trauma, uso de lente de contato, glaucoma. Ouvido: dor, febre, secreção, sensação de ouvido tapado após banho ou piscina, cirurgia prévia. Boca: há quanto tempo a lesão existe, se dói, se é recorrente, se fuma.

Ao entregar colírio, ensine a técnica: lavar as mãos, inclinar a cabeça, puxar a pálpebra inferior, pingar sem encostar, fechar o olho por 1 a 2 minutos comprimindo o canto interno.

CASO

Analista de sistemas de 30 anos, usuária de lente de contato gelatinosa, pede colírio "para tirar a vermelhidão" de olhos ardidos no fim do expediente, sem dor, secreção ou baixa da visão. Conduta: não indicar vasoconstritor de uso contínuo; lágrima artificial sem conservante ou compatível com lentes, pausas de tela, reduzir horas de uso da lente; encaminhar ao oftalmologista se surgir dor, secreção ou fotofobia.

Outros produtos de balcão

Alguns MIP não cabem nas classes anteriores, mas aparecem todos os dias no balcão: a terapia de reposição de nicotina, os fitoterápicos, o analgésico urinário, os produtos para hemorroidas e a solução capilar para calvície. Ao lado deles, dois itens que o cliente costuma achar que são de venda livre: o contraceptivo de emergência e certos testes.

Terapia de reposição de nicotina

A nicotina do adesivo, da goma ou da pastilha alivia a síndrome de abstinência (irritabilidade, ansiedade, fissura, insônia, aumento do apetite) sem o monóxido de carbono e as substâncias cancerígenas da fumaça. A LMIP inclui o adesivo transdérmico até 21 mg e a goma de mascar e a pastilha até 4 mg, com indicação de dependência do tabaco. Funciona melhor quando associada a aconselhamento comportamental, oferecido gratuitamente no SUS.

Forma	Esquema (bulas)	Como usar
Adesivo 24 horas (NiQuitin®, Nicotinell®)	Mais de 10 cigarros/dia: 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas. Até 10 cigarros/dia: 14 mg por 6 semanas, 7 mg por 2 semanas	1 adesivo por dia, pela manhã, em pele limpa, seca e sem pelos; trocar o local a cada dia e não repetir o mesmo local por 7 dias; não cortar

Forma	Esquema (bulas)	Como usar
Goma (Nicorette®)	Iniciar com 2 mg; quem fuma mais de 20 cigarros/dia inicia com 4 mg; máximo 30 gomas de 2 mg ou 24 de 4 mg por dia	Mascar devagar até sentir sabor forte ou formigamento, "estacionar" entre bochecha e gengiva, voltar a mascar; cerca de 30 minutos por goma
Pastilha (NiQuitin®)	2 mg se o primeiro cigarro é após 30 minutos do despertar; 4 mg se é nos primeiros 30 minutos. Semanas 1 a 6: 1 a cada 1 a 2 horas (mínimo 9 por dia); 7 a 9: a cada 2 a 4 horas; 10 a 12: a cada 4 a 8 horas; máximo 20 por dia; até 24 semanas	Deixar dissolver movendo na boca (20 a 30 minutos); não mastigar nem engolir; não comer ou beber durante o uso

Idade mínima conforme o produto: a bula do NiQuitin® contraindica abaixo de 12 anos e a do Nicorette® abaixo de 18 anos. Efeitos adversos: irritação no local do adesivo, sonhos vívidos e insônia (adesivo de 24 horas pode ser retirado ao deitar), soluço, irritação da boca e dor na mandíbula com a goma, náusea. Sinais de excesso de nicotina (náusea, salivação, palpitação, tontura) indicam que a pessoa continua fumando junto ou que a dose está alta.

ATENÇÃO

Precisam de avaliação médica antes da reposição: infarto ou AVC recentes, arritmia grave, angina instável, gestação e amamentação. Ainda assim, para quase todos os cardiopatas a nicotina medicinal é muito menos perigosa do que continuar fumando; a decisão cabe ao médico, e o papel do farmacêutico é encaminhar. Bupropiona e vareniclina exigem prescrição.

Fitoterápicos MIP

O Anexo II da LMIP (IN 285/2024) lista 57 espécies ou associações de fitoterápicos isentos de prescrição. Para ser MIP, o produto precisa ter a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha da lista (IN 285/2024, art. 1º, § 3º), e ser registrado ou notificado como medicamento na Anvisa. Chá vendido como alimento não tem indicação terapêutica.

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Varizes, peso e inchaço nas pernas	*Aesculus hippocastanum* (castanha-da-índia), *Centella asiatica*, *Vitis vinifera*	Edema de uma perna só, quente e dolorosa: suspeitar de trombose e encaminhar
Dispepsia, azia, digestão lenta	*Peumus boldus* (boldo), *Cynara scolymus* (alcachofra), *Monteverdia ilicifolia* (espinheira-santa), *Glycyrrhiza glabra* (alcaçuz), *Silybum marianum*	Alcaçuz eleva pressão e baixa potássio; boldo não é para gestante; obstrução biliar contraindica coleréticos
Tosse e gripe	*Hedera helix* (hera), *Mikania glomerata* (guaco), *Thymus vulgaris*, *Pelargonium sidoides*, *Eucalyptus globulus*	Guaco tem cumarina: cautela com varfarina

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Ansiedade leve e insônia	*Passiflora incarnata*, associações com *Valeriana officinalis*, *Crataegus*, *Salix alba*; *Melissa officinalis*	Somam sedação com álcool e benzodiazepínicos; ansiedade intensa precisa de avaliação
Cansaço físico e mental	*Panax ginseng*, *Paullinia cupana* (guaraná), *Rhodiola rosea*	Insônia, palpitação, aumento da pressão
Constipação ocasional	*Senna alexandrina*, *Cassia fistula*, *Frangula purshiana*, *Plantago ovata*	Estimulantes só por curto período
Cinetose e náusea	*Zingiber officinale* (gengibre)	Cautela com anticoagulantes em doses altas
Trato urinário	*Vaccinium macrocarpon* (cranberry): prevenção de infecção urinária; *Serenoa repens*: sintomas de hiperplasia prostática depois que um médico excluiu doenças mais sérias	Cranberry não trata infecção instalada
Climatério	*Glycine max* (soja, isoflavonas)	Ondas de calor intensas ou sangramento pós-menopausa: médico
Dor articular e lombar leve	*Harpagophytum* (garra-do-diabo), *Salix alba*, *Uncaria tomentosa*	*Salix* contém salicilatos: mesmas restrições do AAS

Ginkgo biloba e *Hypericum perforatum* (erva-de-são-joão) não constam do Anexo II. A erva-de-são-joão é potente indutora enzimática e reduz o efeito de anticoncepcionais, varfarina, ciclosporina e antirretrovirais, razão a mais para perguntar sobre "chás e remédios naturais" em toda anamnese.

Contraceptivo de emergência

O levonorgestrel 1,5 mg em dose única (Postinor Uno® e similares) **não consta da LMIP**, e a bula traz "Venda sob prescrição médica". É de tarja vermelha sem retenção de receita. Por não ser MIP, não pode ser objeto da prescrição farmacêutica de medicamentos isentos regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013, e sua dispensação depende de prescrição. Também é oferecido gratuitamente nas unidades de saúde do SUS.

- Uso (bula do Postinor Uno®): 1 comprimido o mais cedo possível após a relação desprotegida, sem ultrapassar 72 horas; a eficácia cai com a demora.
- Vômito em até 4 horas após a dose: repetir a dose.
- Age principalmente impedindo ou retardando a ovulação; não interrompe gravidez já implantada.
- Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis; orientar testagem e preservativo.
- A menstruação pode adiantar ou atrasar; atraso importante pede teste de gravidez.
- Indutores enzimáticos (carbamazepina, fenitoína, rifampicina, efavirenz, erva-de-são-joão) reduzem a eficácia; a mulher deve procurar o serviço de saúde.
- Não é método de uso regular: oriente planejamento reprodutivo na unidade de saúde.

NO BALCÃO

Atenda em local reservado, sem julgamento. Diante de pedido sem receita, explique que o medicamento exige prescrição, informe que a unidade básica de saúde, a UPA e os serviços de referência fornecem o contraceptivo de emergência e que o tempo importa. Se houver relato de violência sexual, oriente atendimento imediato no serviço de referência, que oferece contracepção de emergência, profilaxias e acolhimento.

Fenazopiridina

Analgésico local das vias urinárias, consta da LMIP em comprimido de 200 mg para dor, ardor e desconforto ao urinar. Bula do Pyridium®: 200 mg a cada 8 horas, após as refeições. Colore a urina de laranja ou vermelho e pode manchar roupas e lentes de contato. Se os sintomas persistirem por mais de 2 dias, o médico deve ser consultado; pele ou olhos amarelados indicam acúmulo do fármaco (função renal reduzida) e exigem suspensão.

ATENÇÃO

A fenazopiridina alivia o sintoma e não trata a infecção urinária. Ela pode mascarar a evolução para pielonefrite. Encaminhe sempre: homem, gestante, criança, idoso frágil, febre, dor lombar, sangue na urina, sintomas recorrentes, diabetes descompensado. Mulher adulta sem esses sinais precisa de avaliação para antibiótico, e a fenazopiridina é apenas ponte de até 2 dias.

Hemorroidas

MIP para hemorroidas e fissuras: policresuleno + cinchocaína (pomada retal 50 + 10 mg/g e supositório), tribenosídeo + lidocaína (creme retal e supositório) e o fitoterápico *Hamamelis virginiana*. Para hematomas e flebite superficial, o polissulfato de mucopolissacarídeo e a heparina sódica em gel. Orientação: fibras, água, não forçar a evacuação, banho de assento morno. Sangramento retal sem diagnóstico, sobretudo após os 45 a 50 anos ou com mudança do hábito intestinal, deve ser investigado.

MIP pouco lembrados

- Alfaestradiol solução capilar 0,25 mg/mL: alopecia androgenética. O minoxidil tópico não consta da LMIP.
- Menaeptenona (vitamina K2) 180 mcg: auxiliar na mineralização óssea.
- Acetato de hidrocortisona 1%, penciclovir e colagenase: tópicos já vistos, que muitos alunos imaginam ser tarjados.
- Nistatina oral, aciclovir creme, cetoconazol comprimido, fluconazol, albendazol e dimenidrinato: o inverso, tarjados que o cliente imagina serem de venda livre.

Testes rápidos e autotestes

Os exames de análises clínicas feitos na farmácia seguem a RDC 978/2025, que revogou a RDC 786/2023. A farmácia que executa exames é **serviço tipo I** (art. 8º): só usa amostra obtida por punção capilar

(glicemia, testes rápidos em sangue), coleta em cavidade oral ou swab de nasofaringe ou orofaringe (redação da RDC 986/2025) e faz todas as etapas no próprio estabelecimento, com controle interno e externo da qualidade (art. 10). A atividade precisa constar da licença sanitária (art. 63), o exame é feito por profissional legalmente habilitado (art. 11) e tem finalidade de triagem, nunca confirmatória (art. 60). O resultado vai na Declaração de Serviço Farmacêutico, com o valor de referência e a frase de que o procedimento não tem finalidade de diagnóstico, e os registros são guardados por no mínimo 5 anos. O Ministério da Saúde publicou nota técnica sobre testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais em farmácias habilitadas, com exigência de confirmação laboratorial dos resultados reagentes.

Autotestes vendidos para uso em casa (gravidez, HIV, covid-19, entre outros) são produtos para diagnóstico in vitro registrados na Anvisa, fora da categoria de medicamentos. A RDC 978/2025 não se aplica à venda de autotestes regularizados. Ao vender, oriente sobre janela imunológica, leitura correta, necessidade de confirmação e onde buscar atendimento em caso de resultado reagente.

CASO

Homem de 45 anos, fumante de 25 cigarros por dia que acende o primeiro logo ao acordar, quer parar de fumar. Sem infarto, AVC ou arritmia. Conduta: adesivo de 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas e 7 mg por 2 semanas; marcar data para parar; encaminhar ao programa de cessação do SUS para apoio comportamental; orientar sobre irritação da pele e insônia; agendar retorno na farmácia em 2 semanas para acompanhar sintomas de abstinência.

Fontes consultadas

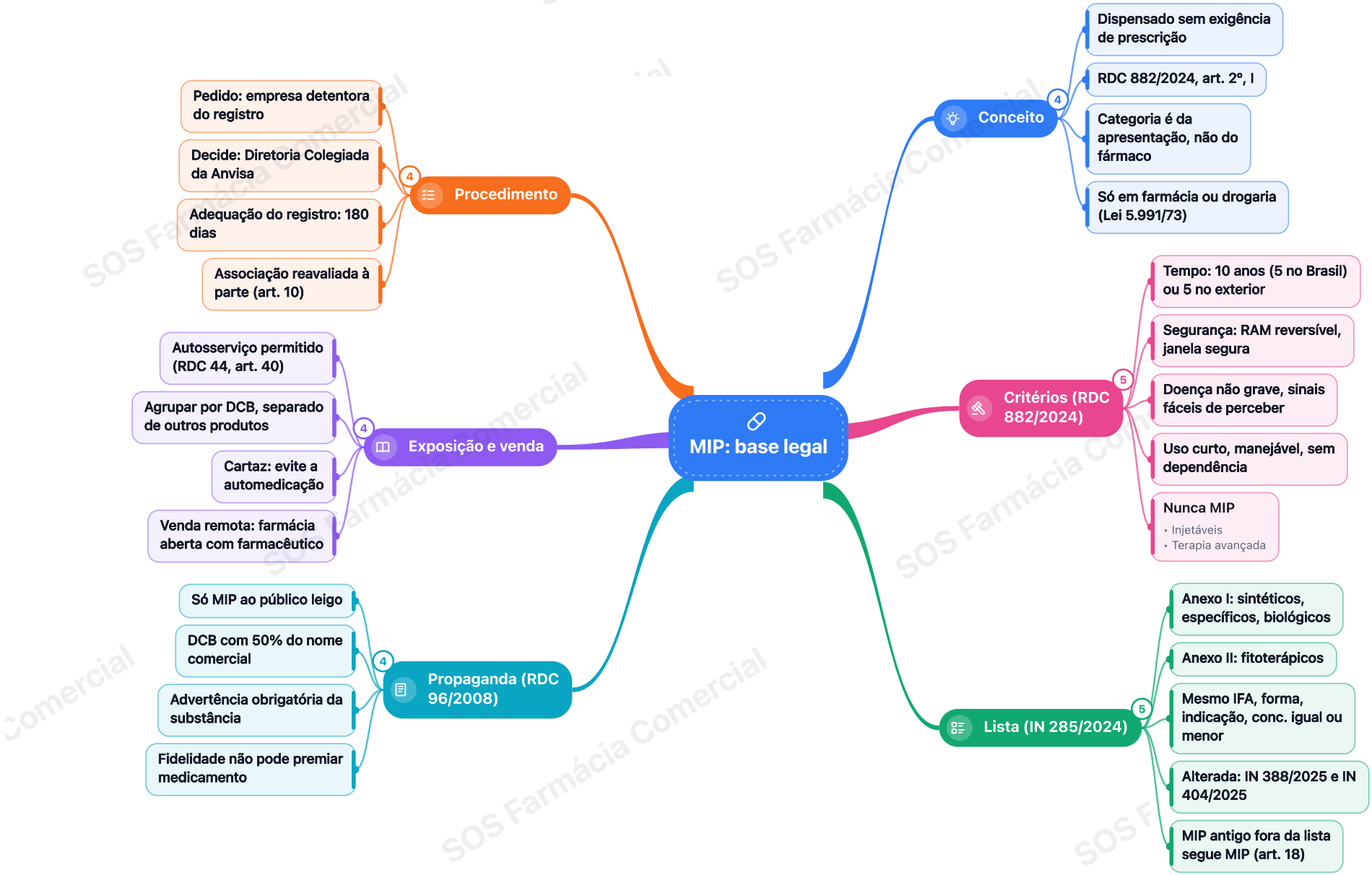
1. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
2. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como sob prescrição (vigência em 1º/7/2024; revoga a RDC nº 98/2016). Texto consolidado no AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
4. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 285, de 7 de março de 2024. Define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. Texto consolidado com as alterações da IN nº 388, de 29/07/2025, e da IN nº 404, de 10/11/2025. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
5. Anvisa. Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) e Legislação vigente de MIP. Portal gov.br/anvisa, consultado em 08/10/2026.
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Texto consolidado com alterações das RDC nº 41/2012, nº 786/2023 e nº 812/2023. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
7. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Diário Oficial da União, 10/06/2025.
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Propaganda, publicidade e informação de medicamentos. Texto consolidado com alterações da RDC nº 23/2009 e da RDC nº 576/2021. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
9. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/586.pdf

10. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf
11. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 724, de 29 de abril de 2022. Código de Ética, Código de Processo Ético e infrações e sanções ético-disciplinares. Diário Oficial da União, 24/05/2022, Seção 1, p. 180.
12. Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 17ª Vara Federal Cível. Ação Civil Pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 (CFM x CFF). Sentença de 18/11/2024. Cópia publicada pelo CFM em portal.cfm.org.br.
13. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a Resolução nº 586/2013. Notícia de 22/11/2024. site.cff.org.br
14. Conselho Federal de Farmácia. Conselho Federal de Farmácia (CFF) se manifesta sobre a Resolução nº 5/2025. Notícia de 20/03/2025; e CFF recorre e Justiça analisa direito à prescrição de medicamentos por farmacêuticos, notícia de 02/05/2025. site.cff.org.br
15. Demarest Advogados. CFF autoriza a prescrição de medicamentos tarjados por farmacêuticos e institui o Registro de Qualificação de Especialista (Resoluções CFF nº 4/2025 e nº 5/2025; suspensão liminar em 31/03/2025). demarest.com.br, 2025.
16. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer de decisão que suspende prescrição de contraceptivos por farmacêuticos (Resolução CFF nº 12/2024). Notícia de 20/05/2026. site.cff.org.br
17. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: espirro e congestão nasal. Brasília: CFF, 2016 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 1).
18. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas não específicos: febre. Brasília: CFF, 2018 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 3).
19. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas do trato gastrintestinal: azia (acidez/pirose) e dispepsia. Brasília: CFF, 2020 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 4).
20. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: tosse. Brasília: CFF, 2021 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 5).
21. Brasil. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, nº 28, volume II. Brasília: Ministério da Saúde, 2012 (1ª reimpressão, 2013).
22. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2023.
23. U.S. Food and Drug Administration. FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. Drug Safety Communication, outubro de 2020.
24. Anvisa. Nota sobre paracetamol na gestação, 24/09/2025; Febrasgo, nota de 22/09/2025 (conforme noticiado pela imprensa; textos originais não consultados).
25. Pharmacy mnemonics (WWHAM, ASMETHOD, SIT DOWN SIR, ENCORE). ResourcePharm e material de formação Numark (Counter Excellence), consultados em 08/10/2026.
26. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024. Institui as Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (Anexo I e Anexo II). Diário Oficial da União, 12 mar. 2024.
27. Anvisa. Instrução Normativa nº 388, de 29 de julho de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão de ciclopirox e ampliação de concentração de alginato com bicarbonato e carbonato de cálcio). Diário Oficial da União, 2025.
28. Anvisa. Instrução Normativa nº 404, de 10 de novembro de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão do omeprazol 20 mg) e republica o Anexo I. Diário Oficial da União, 13 nov. 2025.
29. Anvisa. Diretoria Colegiada. Voto nº 261/2025, processo 25351.918052/2023-80: inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP. ROP 18/2025.
30. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Requisitos e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição. Diário Oficial da União, 21 jun. 2024.
31. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 576, de 11 de novembro de 2021. Notificação de medicamentos de baixo risco. Diário Oficial da União, 2021.

32. Anvisa. Instrução Normativa nº 106, de 11 de novembro de 2021. Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN). Diário Oficial da União, 2021.
33. Anvisa. Instrução Normativa nº 430, de 24 de março de 2026. Atualiza a Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação. Diário Oficial da União, 26 mar. 2026.
34. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 243, de 26 de julho de 2018, e Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, com atualizações. Suplementos alimentares.
35. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Serviços que executam exames de análises clínicas. Revogada pela RDC nº 978/2025.
36. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica.
37. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (Apêndice H, uso de medicamentos para dengue).
38. Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento científico: Abordagem da febre aguda em pediatria e reflexões sobre a febre nas arboviroses. 2025.
39. Jornal de Pediatria. Estudo sobre uso alternado de antitérmicos em crianças no Sul do Brasil. 2013.
40. Bulas consultadas (texto reproduzido no portal Consulta Remédios, outubro de 2026): Novalgina®, Dipirona Iquego, Tylenol®, Aspirina®, Advil® 400 mg, Alivium®, Flanax®, Cataflampro®, Mylanta Plus®, Buscopan®, Buscopan Composto®, Floratil®, Dulcolax®, Lactulona®, Fluimucil®, Mucosolvan®, Bisolvon®, Vibral®, Seki®, Bromidrato de Dextrometorfano, Strepsils®, Resfenol®, Benegrip®, Claritin®, Desalex®, Allegra®, Zyxem®, Polaramine®, Ebastel®, Talerc®, Canesten®, Gino-Canesten®, Nizoral®, Berlison®, Penvir Lábia®, Nedax®, Permetrina 5%, Deltacid®, Sanasar®, Pantelmin®, Ascaridil®, Pyridium®, Colírio Moura Brasil®, Lacrima Plus®, Cerumin®, NiQuitin® adesivo e pastilha, Nicotinell®, Nicorette®, Postinor Uno®.
41. Bulas consultadas para categoria de venda (venda sob prescrição médica): Dramin®, Dramin B6®, Plasil®, Vonau®, Imosec®, Tiorfan®, Famox®, Neosoro®, Sorine®, Afrin®, Zyrtec®, Zovirax®, Zentel®, Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum®, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva®, Endofolin®, Meclin®.

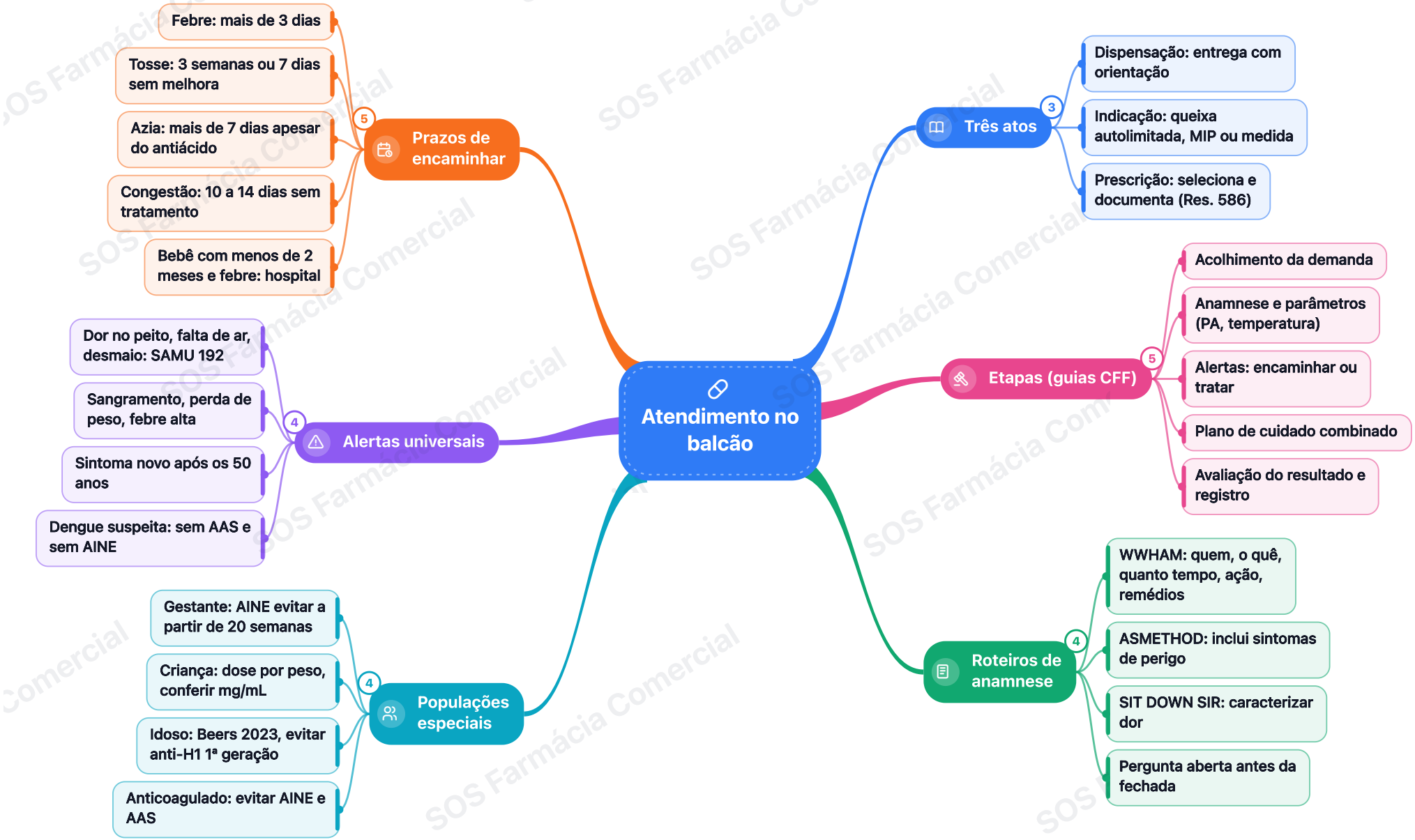
MIP: base legal

6 ramos · 26 itens · mapa mental do módulo 12



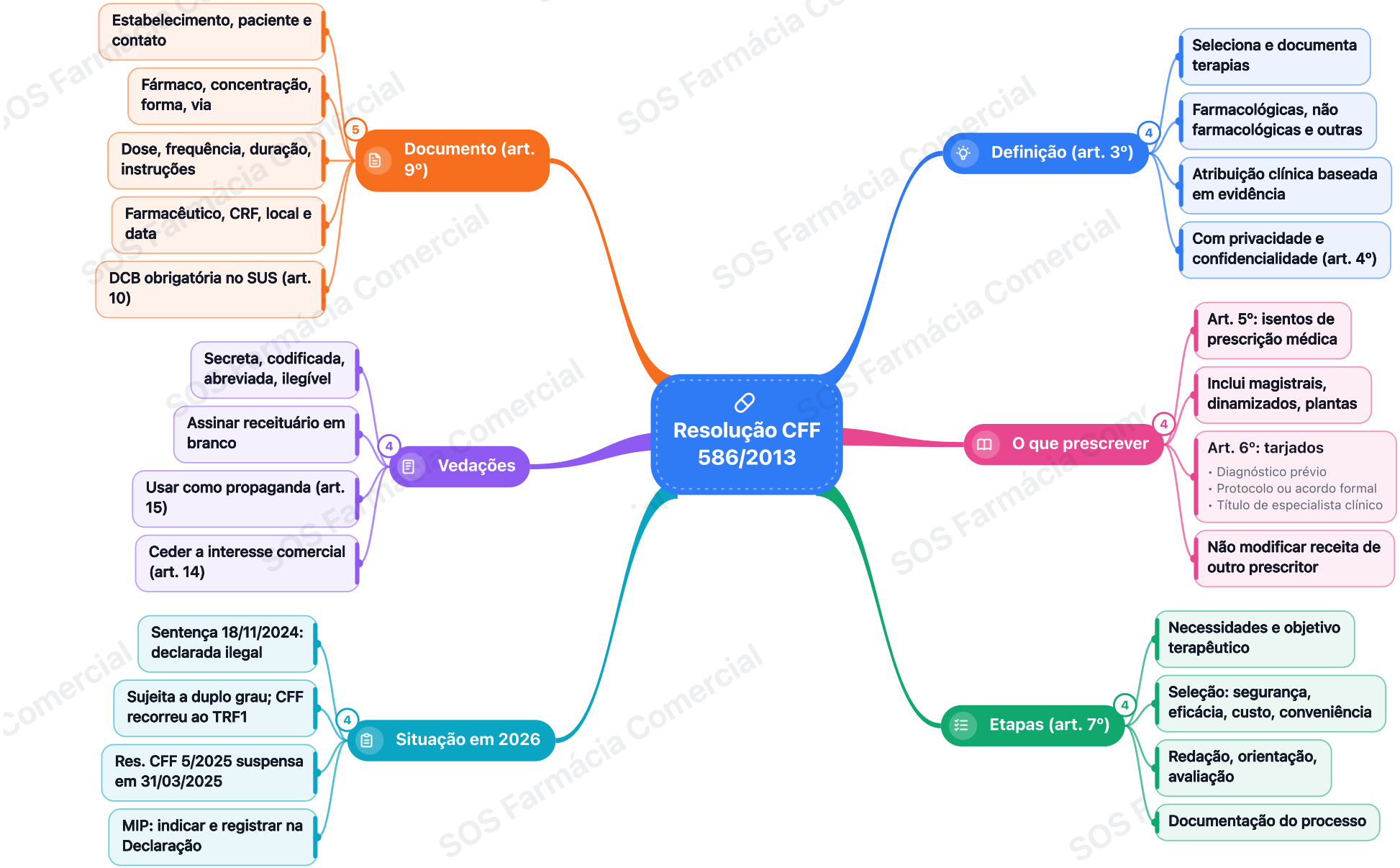
Atendimento e sinais de alerta

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 12



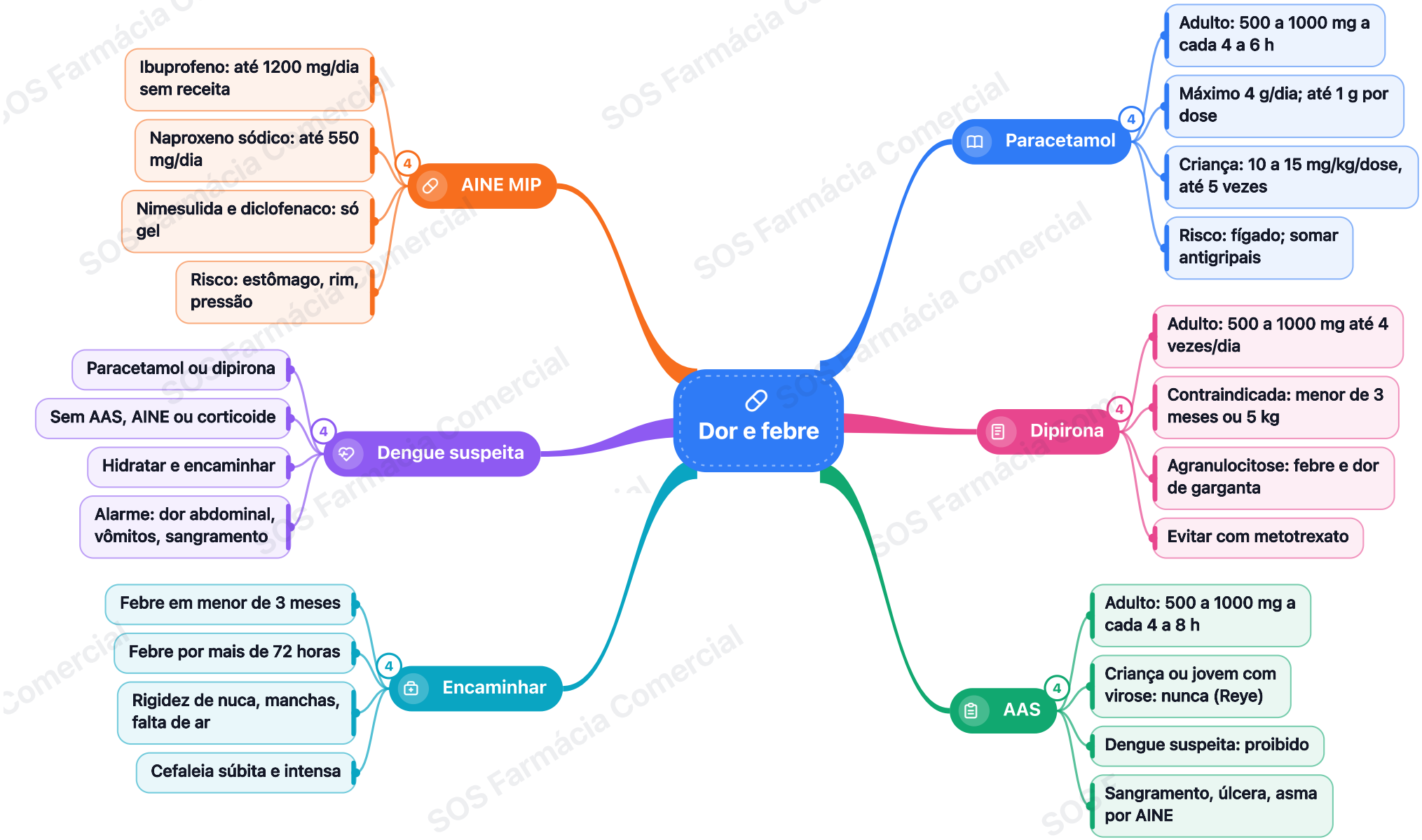
Prescrição farmacêutica (Resolução CFF nº 586/2013)

6 ramos · 25 itens · mapa mental do módulo 12



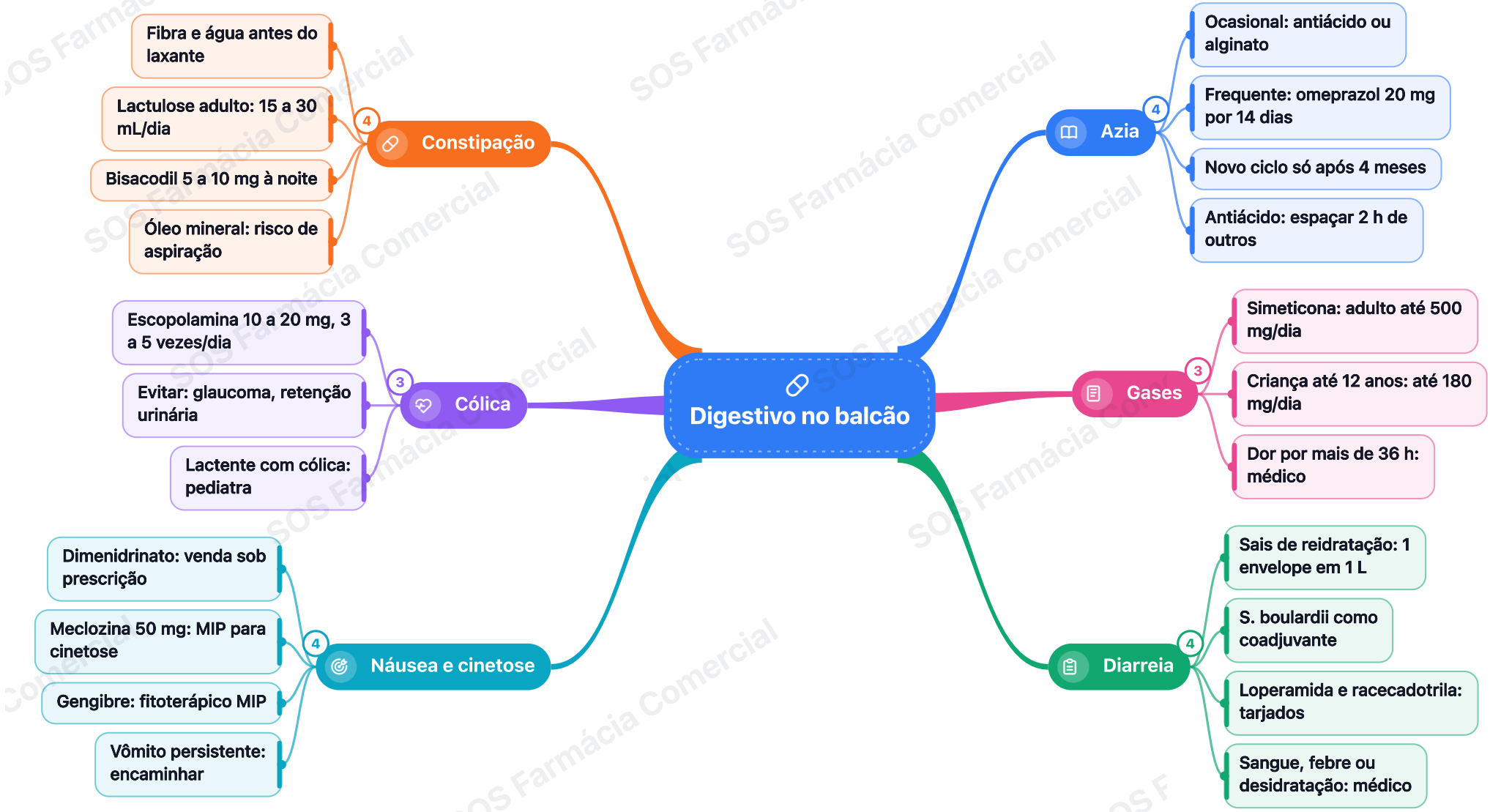
Dor e febre no balcão

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 12



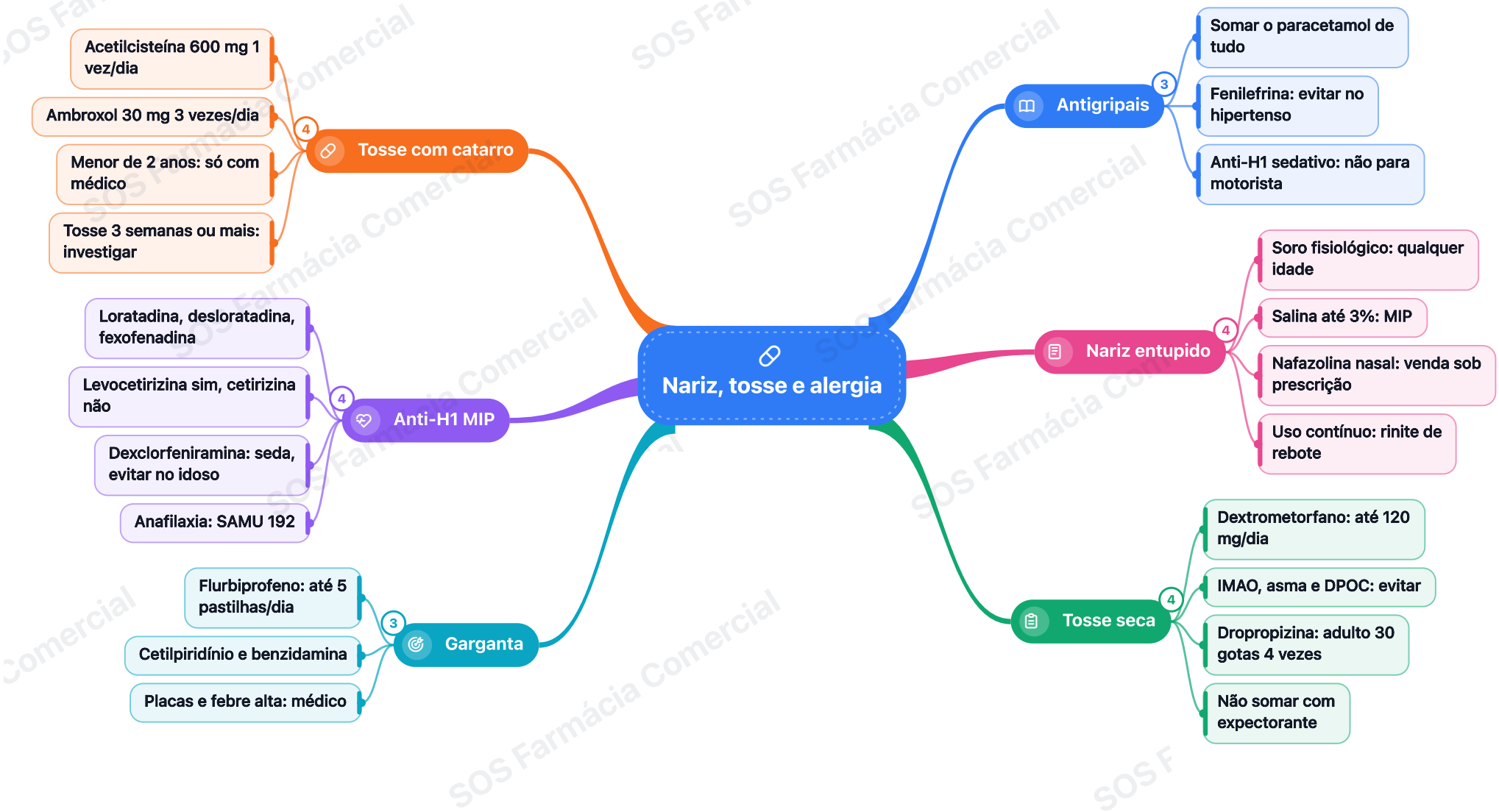
Sintomas digestivos

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 12



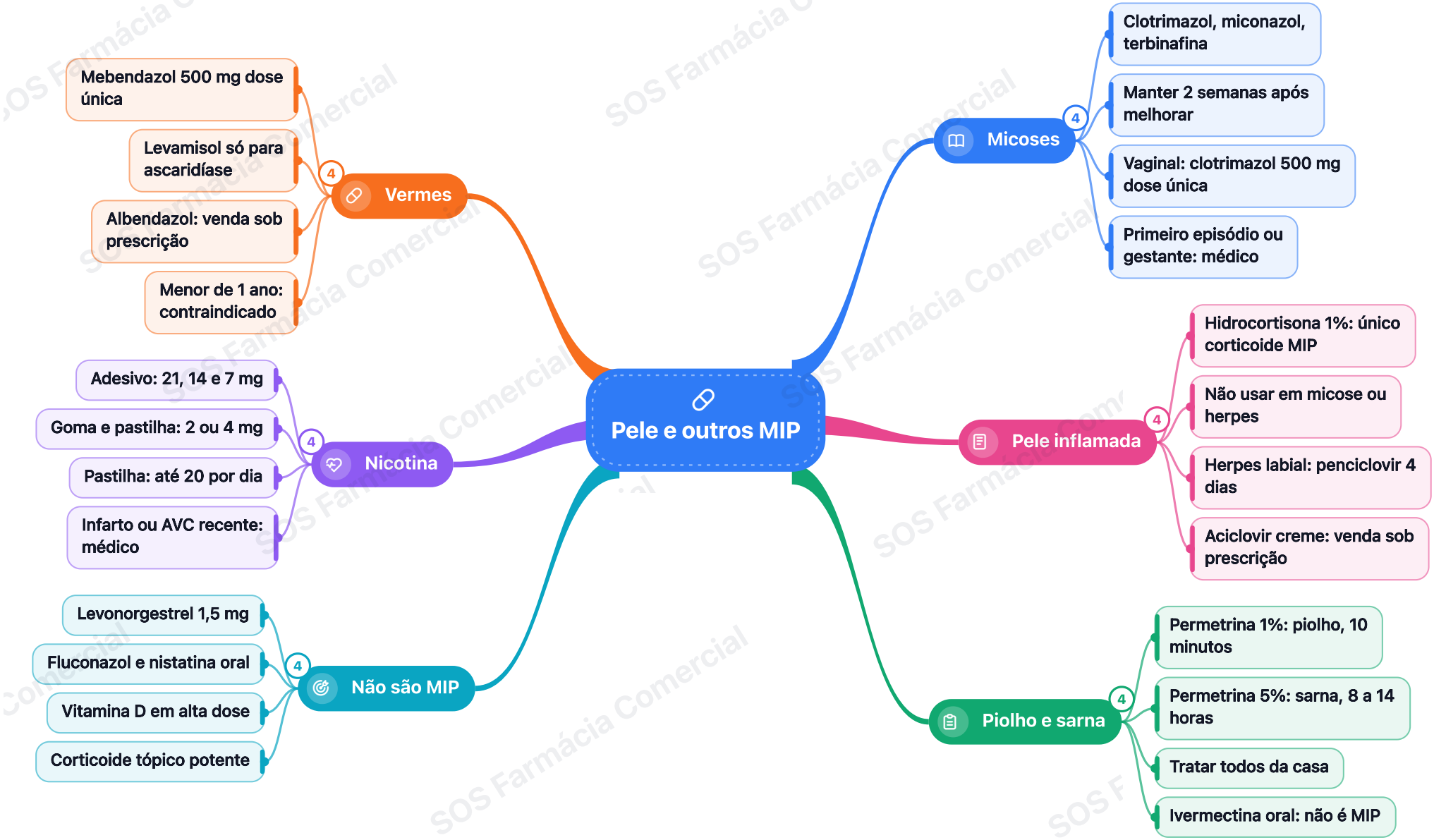
Respiratório alto e alergia

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 12



Pele, parasitas e outros MIP

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 12



Dispensação, indicação e prescrição farmacêutica

Aspecto	Dispensação	Indicação farmacêutica	Prescrição farmacêutica
Ponto de partida	Receita ou pedido de produto pelo nome	Queixa ou sintoma relatado	Necessidade de saúde identificada em consulta
Decisão do farmacêutico	Avaliar a receita, conferir o produto e orientar	Encaminhar ou tratar; escolher MIP ou medida não farmacológica	Selecionar, redigir, orientar e acompanhar a terapia
O que pode envolver	Qualquer medicamento, conforme receita e categoria de venda	Somente MIP e medidas não farmacológicas	MIP (art. 5º); tarjado só com diagnóstico prévio e protocolo ou acordo formal (art. 6º)
Base normativa	Lei 5.991/1973, art. 4º, XV; Lei 13.021/2014, arts. 13 e 14; RDC 44/2009, arts. 42 a 47	Res. CFF 585/2013, art. 7º, XXV; RDC 44/2009, art. 81, §2º, I, b	Res. CFF 586/2013 (sentença de 18/11/2024 declarou ilegal; recurso pendente)
Documento entregue	Receita devolvida ou retida conforme a regra do medicamento	Declaração de Serviço Farmacêutico, em duas vias	Documento de prescrição com os campos do art. 9º
Registro	Registros sanitários exigidos para o medicamento	Registro do serviço com consentimento (RDC 44/2009, art. 64)	Registro de todo o processo (Res. 586/2013, art. 16)
Erro típico	Entregar sem orientar ou sem avaliar a receita	Tratar sintoma com sinal de alerta	Prescrever tarjado sem protocolo ou modificar receita médica

A prescrição farmacêutica pela Resolução CFF nº 586/2013 está judicialmente contestada (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400). A indicação de MIP documentada na Declaração de Serviço Farmacêutico tem base na RDC nº 44/2009, vigente.

Modelo de documento de prescrição farmacêutica (campos do art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013)

Campo	Preenchimento	Base
Estabelecimento, consultório ou serviço	Nome, endereço, telefone (e CNPJ, se farmácia) _____	Art. 9º, I
Paciente	Nome completo _____ Contato (telefone) _____	Art. 9º, II

Campo	Preenchimento	Base
Terapia farmacológica	Medicamento pela DCB ou formulação _____ Concentração ou dinamização _____ Forma farmacêutica _____ Via _____	Art. 9º, III, a; arts. 10 e 11
Posologia	Dose _____ Frequência _____ Duração do tratamento _____	Art. 9º, III, b
Instruções adicionais	Como usar, o que evitar, quando parar _____	Art. 9º, III, c
Terapia não farmacológica ou outra intervenção	Medidas e, se houver, encaminhamento _____	Art. 9º, IV
Farmacêutico	Nome completo _____ CRF nº _____ Assinatura _____	Art. 9º, V
Local e data	_____, ____/____/_____	Art. 9º, VI

Regras de redação: em vernáculo, por extenso, legível, com nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras (art. 9º, caput). Vedado: documento sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e folhas assinadas em branco (art. 12). Vedado usar como propaganda (art. 15). O processo inteiro deve ser registrado (art. 16).

ATENÇÃO

O modelo reproduz os campos exigidos pela norma para fins de estudo. A Resolução nº 586/2013 foi declarada ilegal por sentença de 18/11/2024, ainda sujeita a recurso. Na drogaria, a indicação de MIP se documenta na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81), que pede, entre outros, o MIP indicado e a posologia, a orientação, data, assinatura e carimbo com CRF.

Sinais de alerta por queixa e prazo para reavaliar

Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Dor de cabeça	Início súbito e forte; mudança de padrão; febre com rigidez de nuca; déficit neurológico; início após 50 anos	Dor persistente por cerca de 15 dias	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de congestão nasal
Febre	Menor de 2 meses; menor de 6 meses com 38 °C retal; 40 °C acima de 6 meses; suspeita de arbovirose; exantema, dispneia, convulsão	Mais de 3 dias ou sem resposta ao antitérmico	CFF, guia de febre (2018)
Dor de garganta	Placas, febre e gânglios dolorosos sem tosse ou coriza; placas com disfagia	Sem melhora ou piora após melhora inicial	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de tosse
Tosse	Menor de 2 anos ou maior de 75; dispneia, chiado, dor torácica; escarro purulento ou com sangue; perda de peso	3 semanas, ou 7 dias de tratamento sem melhora	CFF, guia de tosse (2021)

Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Congestão e espirros	Obstrução unilateral; febre acima de 38 °C por mais de 24 h; secreção purulenta com dor facial	10 a 14 dias sem tratamento ou 7 dias com tratamento	CFF, guia de congestão nasal (2016)
Diarreia	Sangue ou muco; febre; desidratação; vômitos que impedem hidratação	Diarreia por 14 dias ou mais é persistente	MS, CAB 28 v. II
Azia e dispepsia	Disfagia, perda de peso, vômitos, sangramento, anemia; dor torácica com suor; até 12 anos	Mais de 7 dias apesar do antiácido	CFF, guia de azia (2020); MS, CAB 28 v. II
Dor lombar	Menor de 20 ou maior de 50 anos; dor noturna; câncer prévio; febre; fraqueza; alteração urinária ou intestinal; anestesia em sela	Dor refratária	MS, CAB 28 v. II
Sintomas urinários	Febre, dor no flanco; homem, gestante, criança; sangue na urina; corrimento	Toda suspeita de infecção deve ser avaliada	MS, CAB 28 v. II
Olho vermelho	Dor forte, baixa visual, fotofobia, pupila alterada, trauma ou produto químico	Irritação simples sem melhora	MS, CAB 28 v. II

Prazos de bula do MIP, quando menores, prevalecem. Constipação e lesões de pele seguem a prática clínica geral (ver tópico de sinais de alerta).

SOS Farmácia Comercial

Atendimento de uma queixa no balcão

Cliente relata sintoma ou pede um MIP pelo nome

Acolher e, se a queixa for íntima, levar a local reservado

Anamnese: para quem, idade e peso, sintoma, duração, o que já usou, doenças, medicamentos, gestação ou amamentação

Aferir pressão ou temperatura quando ajudar a decisão

DECISÃO

Há sinal de gravidade imediata?

SIM
Acionar SAMU (192) ou encaminhar ao pronto atendimento, sem oferecer MIP

NÃO
Seguir para a checagem de alertas

DECISÃO

Há sinal de alerta, prazo vencido ou dúvida?

SIM
Encaminhar por escrito à unidade de saúde ou ao médico assistente

NÃO
Problema autolimitado: montar plano de cuidado

Escolher medida não farmacológica e, se necessário, MIP adequado ao paciente (conferir LMIP, bula e interações)

Orientar dose, intervalo, dose máxima, duração, efeitos esperados e quando procurar atendimento; pedir que o paciente repita

ATENÇÃO

Não usar tarjado, não trocar receita, não indicar por comissão

Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico e registrar o atendimento com consentimento

Combinar retorno; registrar o resultado e encaminhar se não houver melhora no prazo

Checklist do atendimento de queixa com MIP

- ◯ Identificar para quem é o medicamento e se a pessoa está presente
- ◯ Perguntar idade e, em criança, o peso atual
- ◯ Perguntar sobre gestação ou amamentação
- ◯ Caracterizar o sintoma: local, intensidade, início e duração
- ◯ Perguntar sintomas associados e sinais de alerta da queixa
- ◯ Perguntar o que já usou, em que dose e com que resultado
- ◯ Listar doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo e alergias
- ◯ Decidir: urgência, encaminhamento ou manejo na farmácia
- ◯ Conferir na LMIP e na embalagem a forma, concentração e indicação
- ◯ Checar interações e contraindicações para aquele paciente
- ◯ Orientar dose, intervalo, dose máxima diária e duração
- ◯ Informar quando parar e quando procurar atendimento
- ◯ Confirmar o entendimento pedindo que o paciente repita
- ◯ Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico em duas vias
- ◯ Registrar o atendimento com consentimento do usuário
- ◯ Combinar retorno e registrar o desfecho

Declaração de Serviço Farmacêutico e documento de prescrição farmacêutica

Aspecto	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição farmacêutica
Norma	RDC nº 44/2009, art. 81 (Anvisa, vigente)	Resolução CFF nº 586/2013, art. 9º (contestada judicialmente)
Natureza	Registro sanitário do serviço prestado	Documento profissional no formato de receita
Quando emitir	Após qualquer serviço farmacêutico	Após o processo de prescrição
Conteúdo central	Estabelecimento com CNPJ, usuário, MIP indicado e posologia, parâmetros, orientação, plano, data, assinatura e CRF	Estabelecimento, paciente e contato, terapia com dose, frequência e duração, terapia não farmacológica, farmacêutico e CRF, local e data
Vias	Duas: usuário e arquivo	Não define número de vias; exige registro do processo
Proibições	Propaganda; indicar tarjado	Propaganda; forma secreta, codificada ou abreviada; folhas em branco

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma define hoje os critérios para enquadrar um medicamento como MIP?	RDC nº 882/2024 (vigente desde 1º/7/2024), que revogou a RDC nº 98/2016.
Qual instrução normativa traz a lista de MIP vigente?	IN nº 285/2024, com anexos alterados pela IN nº 388/2025 e pela IN nº 404/2025.
Quais formas nunca podem ser MIP?	Formas farmacêuticas injetáveis e produtos de terapia avançada (RDC nº 882/2024, art. 5º).
Associação de dois MIP é MIP automaticamente?	Não. A associação precisa cumprir os critérios do art. 4º; só o prazo de comercialização é dispensado (art. 10).
O que significa a coluna "concentração máxima" da LMIP?	Quantidade do fármaco na forma farmacêutica, e não a dose posológica (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, II).
MIP registrado antes da lista e ausente dela continua MIP?	Sim, até a Anvisa avaliar a pertinência do enquadramento (RDC nº 882/2024, art. 18).
Prazo para a empresa adequar o registro após inclusão na LMIP?	180 dias (RDC nº 882/2024, art. 13).
Qual MIP entrou na lista pela IN nº 404/2025?	Omeprazol 20 mg cápsula, para azia e queimação em dois ou mais dias na semana.
Diclofenaco é MIP?	Em gel e solução dermatológica, sim. Por via oral, não consta da LMIP.

Pergunta	Resposta
Frase do cartaz obrigatório na área de medicamentos?	Medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação: informe-se com o farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 41).
O que significa WWHAM?	Who, What, How long, Action, Medication: para quem, quais sintomas, há quanto tempo, o que já fez, que medicamentos usa.
Febre: depois de quantos dias encaminhar, pelo guia do CFF?	Mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico.
Tosse: quando encaminhar pelo tempo?	Tosse por 3 semanas ou mais, ou sem melhora após 7 dias de tratamento (guia de tosse do CFF).
Criança com menos de 2 meses e febre: conduta?	Avaliação hospitalar sempre (guia de febre do CFF). Não indicar antitérmico como substituto.
Etapas do processo de prescrição (art. 7º da Res. 586/2013)?	Necessidades, objetivo, seleção, redação, orientação, avaliação dos resultados e documentação.
Condições para o farmacêutico prescrever tarjado pela Res. 586/2013?	Diagnóstico prévio, previsão em programa, protocolo ou acordo de colaboração formal e título de especialista na área clínica.
O que decidiu a sentença de 18/11/2024 sobre a Res. 586/2013?	Declarou-a inconstitucional e ilegal e proibiu sua aplicação no país; está sujeita a duplo grau e o CFF recorreu.
Quantas vias tem a Declaração de Serviço Farmacêutico?	Duas: uma para o usuário e outra arquivada no estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 81, §4º).

Questões de fixação

1. Sobre o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição no Brasil, em outubro de 2026, assinale a correta.

A Os critérios estão na RDC nº 98/2016, e a lista na IN nº 86/2021.

B Os critérios estão na RDC nº 882/2024, e a lista na IN nº 285/2024.

C Os critérios estão na RDC nº 44/2009, e a lista na RDC nº 96/2008.

D Os critérios estão na Lei nº 13.021/2014, e a lista na IN nº 11/2016.

E Os critérios estão na RDC nº 138/2003, e a lista é a de grupos terapêuticos.

2. Um laboratório quer enquadrar como MIP uma associação em dose fixa de dois fármacos que já são MIP isoladamente. Pela RDC nº 882/2024:

A) a associação é MIP automaticamente, porque cada componente já está na LMIP.

B) a associação só pode ser MIP se for apresentada em forma injetável de dose única.

C) a associação deve cumprir o art. 4º, dispensado só o prazo de comercialização.

D) a associação nunca pode ser MIP, por proibição expressa de doses fixas na norma.

E) basta a empresa notificar à Anvisa a alteração de rotulagem e de bula do produto.

3. Cliente pede ibuprofeno sem receita. Na prateleira há ibuprofeno 400 mg comprimido, ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata e ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL. Pela LMIP vigente:

A) as três apresentações são MIP, porque o fármaco ibuprofeno consta da lista.

B) nenhuma é MIP, porque todo anti-inflamatório oral exige receita no Brasil.

C) 400 mg e suspensão (adulto) são MIP; o 600 mg imediato não consta.

D) só a suspensão é MIP, porque a lista restringe o ibuprofeno ao uso pediátrico.

E) o 600 mg é MIP, e o 400 mg exige receita por ser concentração menor que a da lista.

4. Em relação à exposição de MIP em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009), é correto afirmar:

A) MIP ficam ao alcance do usuário, agrupados pela DCB e separados de outros produtos.

B) MIP devem ficar sempre atrás do balcão, em área restrita, como os demais medicamentos.

C) MIP podem ser expostos junto a cosméticos e alimentos, sem necessidade de separação.

D) MIP podem ser expostos em supermercados, desde que haja farmacêutico no horário.

E) o cartaz sobre automedicação é obrigatório apenas na área dos medicamentos tarjados.

5. Mãe relata que o filho de 7 semanas está com 38,3 °C desde a manhã, mamando menos. A conduta do farmacêutico, segundo o guia de febre do CFF, é:

A) indicar paracetamol em gotas pelo peso e reavaliar a criança em 72 horas.

B) indicar dipirona em gotas pelo peso e orientar banho morno se a febre subir.

C) orientar compressas, roupas leves e observar a evolução por 24 horas.

D) indicar ibuprofeno em suspensão pelo peso, alternando com paracetamol.

E) não indicar antitérmico e encaminhar já para avaliação hospitalar.

6. Homem de 58 anos pede omeprazol 20 mg MIP para azia que começou há um mês e relata dificuldade para engolir e perda de 4 kg. A conduta adequada é:

A dispensar omeprazol 20 mg pelo prazo da bula e reavaliar o paciente no retorno.

B encaminhar ao médico, pois há sinais de alarme para azia.

C indicar antiácido com magnésio e alumínio por 7 dias e orientar dieta fracionada.

D dispensar omeprazol 40 mg, mais eficaz para sintomas que já duram um mês.

E indicar chá de espinheira-santa, elevar a cabeceira e reavaliar em 30 dias.

7. Pela Resolução CFF nº 586/2013, a prescrição de medicamento cuja dispensação exige prescrição médica pelo farmacêutico:

A é livre para o farmacêutico inscrito no CRF há mais de cinco anos, em qualquer local.

B é permitida em drogarias, desde que registrada na Declaração de Serviço Farmacêutico.

C exige diagnóstico prévio, protocolo ou acordo formal e título clínico.

D é permitida para renovar qualquer receita vencida de medicamento de uso contínuo.

E depende apenas de autorização verbal do médico que acompanha o paciente.

8. Entre os componentes mínimos do documento de prescrição farmacêutica previstos no art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013, NÃO consta:

A o diagnóstico nosológico do paciente com código da CID.

B o nome completo e o contato do paciente.

C a dose, a frequência e a duração do tratamento.

D o nome, a assinatura e o número de registro do farmacêutico no CRF.

E a identificação do estabelecimento, consultório ou serviço.

9. Sobre a situação da Resolução CFF nº 586/2013 em outubro de 2026, é correto afirmar:

A foi revogada expressamente pelo CFF e substituída pela Resolução nº 5/2025, em vigor.

B foi confirmada pelo STF, com efeito vinculante para todo o país.

C nunca foi questionada judicialmente.

D foi declarada ilegal por sentença de 2024, sujeita a duplo grau, com recurso do CFF.

E foi incorporada à RDC nº 44/2009 pela Anvisa.

10. Idosa de 80 anos, com insônia e rinite, pede um antialérgico "que dê sono". Considerando os Critérios de Beers 2023, a melhor conduta é:

A indicar dexclorfeniramina à noite, pois o mesmo comprimido trata os dois problemas.

B indicar prometazina, que é mais sedativa e tem efeito mais longo durante a noite.

C indicar antigripal com clorfeniramina, que também descongestiona o nariz.

D evitar anti-H1 de 1ª geração; para a rinite, um de 2ª geração.

E indicar dois anti-histamínicos diferentes ao mesmo tempo para somar os efeitos.

11. Sobre a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009), assinale a INCORRETA.

A É emitida em duas vias, uma entregue ao usuário e outra arquivada no estabelecimento.

B Pode registrar a indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia.

C Pode indicar tarjado se o farmacêutico for especialista.

D Deve conter data, assinatura e carimbo com a inscrição do farmacêutico no CRF.

E Leva frase de alerta quando há aferição de parâmetros fisiológicos ou exames.

12. Representante de laboratório oferece ao farmacêutico de uma drogaria um prêmio por caixa vendida de determinada marca de MIP. Do ponto de vista ético e normativo, é correto afirmar que:

A é permitido, desde que o prêmio recebido seja declarado no imposto de renda.

B é permitido para MIP, pois a restrição ética alcança apenas os tarjados.

C é permitido se o produto premiado for mais barato que o concorrente direto.

D é vedado apenas quando o farmacêutico for o responsável técnico da drogaria.

E é vedado: a vantagem comercial não pode guiar a indicação.

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **B**. A RDC nº 882/2024 revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27) e vige desde 1º/7/2024. A LMIP está na IN nº 285/2024, alterada pelas INs nº 388/2025 e nº 404/2025. A IN nº 86/2021 e a IN nº 11/2016 foram substituídas; a RDC nº 44/2009 trata de boas práticas em farmácias; a RDC nº 96/2008 trata de propaganda; a RDC nº 138/2003 é o modelo antigo.
2. **C**. O art. 10 diz que o enquadramento de fármacos isolados não garante o da associação, que deve cumprir o art. 4º; o parágrafo único dispensa os prazos do inciso I quando todos os componentes já fazem parte de MIP. Injetáveis não podem ser MIP (art. 5º). Não há proibição geral de associação MIP, e o enquadramento depende de decisão da Diretoria Colegiada pela atualização da LMIP (art. 11).
3. **C**. A isenção vale para o mesmo IFA, forma, indicação e concentração igual ou inferior à da linha (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º). A LMIP lista ibuprofeno 400 mg, suspensão 100 mg/mL e 200 mg/mL (esta com indicação em adultos) e 600 mg apenas em liberação prolongada (200 mg imediata e 400 mg prolongada). O 600 mg de liberação imediata não está na lista.
4. **A**. O art. 40, §2º permite o autosserviço de MIP; o art. 41, §1º exige agrupamento por princípio ativo com identificação pela DCB e o §2º, separação dos demais produtos. O cartaz do art. 41 é obrigatório na área de medicamentos. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto e dispensário (Lei nº 5.991/1973, art. 6º).
5. **E**. O guia de febre do CFF (2018) estabelece que crianças menores de 2 meses com febre devem sempre ser avaliadas em hospital, e que o antitérmico pode descaracterizar sinais de doença grave. As demais alternativas tratam ou adiam a avaliação de um lactente de alto risco.
6. **B**. O guia de azia do CFF e o CAB 28 v. II tratam disfagia, perda de peso e idade acima de 50 anos com sintoma novo como sinais de alarme, que exigem encaminhamento. A inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP (IN nº 404/2025) vale para azia frequente sem alarme. Omeprazol 40 mg não consta da LMIP, e tratar o sintoma atrasaria o diagnóstico.
7. **C**. O art. 6º condiciona a prescrição de tarjados a diagnóstico prévio e a programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados em instituições de saúde, ou a acordos de colaboração formais; o §1º exige título de especialista na área clínica. A Declaração não pode ser usada para indicar tarjado (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º). Acordo de colaboração é parceria formal, não verbal (glossário).
8. **A**. O art. 9º exige identificação do estabelecimento (I), nome e contato do paciente (II), descrição da terapia farmacológica com dose, frequência e duração (III), terapia não farmacológica (IV), identificação do farmacêutico com CRF (V) e local e data (VI). Diagnóstico com CID não é componente previsto.
9. **D**. A sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400) declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da norma, proibiu sua aplicação e ficou sujeita ao duplo grau obrigatório; o CFF recorreu. A Resolução nº 5/2025 foi suspensa por liminar em 31/03/2025. Não houve decisão do STF localizada nem incorporação pela Anvisa.
10. **D**. Os Critérios de Beers 2023 recomendam evitar anti-histamínicos de primeira geração em idosos (altamente anticolinérgicos, risco de confusão e queda). Dexclorfeniramina, prometazina e clorfeniramina são de primeira geração. Para rinite, há anti-histamínicos de segunda geração na LMIP; insônia pede abordagem não farmacológica e, se persistente, avaliação.
11. **C**. O art. 81, §3º proíbe usar a Declaração para propaganda ou para indicar medicamento que exige prescrição, sem exceção por titulação. As demais alternativas reproduzem o art. 81: duas vias (§4º), indicação de MIP e posologia (§2º, I, b), data, assinatura e carimbo com CRF (§2º, I, h) e frase de alerta (§2º, I, d).
12. **E**. O Código de Ética (Resolução CFF nº 724/2022) proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia em relação a interesses comerciais (art. 14). A regra vale para MIP e para qualquer farmacêutico, responsável técnico ou não.

Tabela-mestra de posologia de MIP

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Paracetamol	Comprimido 500 e 750 mg; gotas 200 mg/mL	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 h	4 g	10 a 15 mg/kg/dose, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg: médico	Hepatotoxicidade; somar antigripais
Dipirona	Comprimido até 1 g; gotas 500 mg/mL	500 a 1000 mg até 4 vezes/dia	4 g	Gotas por faixa de peso (bula); contraindicada abaixo de 3 meses ou 5 kg	Agranulocitose; hipotensão
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg	500 a 1000 mg a cada 4 a 8 h	4 g (8 comprimidos)	A partir de 12 anos: 500 mg, até 3/dia; nunca em virose	Reye; dengue; sangramento
Ibuprofeno	Comprimido 400 mg; suspensão 100 e 200 mg/mL	400 mg a cada 4 a 6 h, com alimento	1200 mg sem prescrição	A partir de 6 meses: 5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 h, até 4 doses	Estômago, rim, pressão; dengue
Naproxeno sódico	Comprimido 275 e 550 mg	275 mg 1 a 2 vezes/dia ou 550 mg 1 vez/dia	550 mg; até 10 dias	Não indicado abaixo de 12 anos	Estômago, rim, pressão
Diclofenaco gel	Gel 10 e 23,2 mg/g	Aplicar 3 a 4 vezes/dia ou conforme bula	Conforme bula	Aerossol: a partir de 14 anos	Pele íntegra; lavar as mãos
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	1 pastilha a cada 3 a 6 h	5 pastilhas; até 3 dias	Não usar abaixo de 12 anos	Restrições de AINE
Butilescopolamina	Comprimido 10 mg; gotas 10 mg/mL	10 a 20 mg, 3 a 5 vezes/dia	100 mg	1 a 6 anos: 5 a 10 mg 3 vezes/dia; lactente: pediatra	Glaucoma; retenção urinária

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Simeticona	Comprimido 40 mg; emulsão 75 mg/mL	40 a 125 mg a cada 6 h	500 mg	2 a 12 anos: 15 a 30 mg/dose; até 180 mg/dia	Dor por mais de 36 h: médico
Alumínio + magnésio + simeticona	Suspensão oral	10 a 20 mL entre refeições e ao deitar	12 colheres-medida; até 2 semanas	A partir de 12 anos	Espaçar 2 h de outros fármacos
Omeprazol MIP	Cápsula 20 mg, caixa de 7 ou 14	20 mg em jejum 1 vez/dia	20 mg; 14 dias; ciclo a cada 4 meses	Uso adulto	Sinais de alarme; clopidogrel
Sais de reidratação oral	Envelope para 1 L	75 mL/kg em 4 a 6 h na reidratação	Até 4 L nessa fase	Todas as idades; manter o aleitamento	Descartar após 24 h
Saccharomyces boulardii	Cápsula até 250 mg	200 mg 2 vezes/dia (Floratil®)	Conforme bula	Conforme bula	Mais de 5 dias: médico
Lactulose	Xarope 667 mg/mL	15 a 30 mL/dia	Ajustar para 2 a 3 evacuações/dia	1 a 5 anos 5 a 10 mL; 6 a 12 anos 10 a 15 mL	Gases no início
Bisacodil	Comprimido 5 mg	5 a 10 mg à noite	10 mg	Acima de 10 anos: 5 a 10 mg; 4 a 10 anos: 5 mg	Não tomar com leite, antiácido ou omeprazol
Óleo mineral	Líquido (LMN)	15 mL à noite	45 mL (30 à noite e 15 de manhã)	Acima de 6 anos: 1 a 2 mL/kg	Pneumonia lipoídica; até 1 semana
Loratadina	Comprimido 10 mg; xarope 1 mg/mL	10 mg 1 vez/dia	10 mg	2 a 12 anos abaixo de 30 kg: 5 mg	Pouca sedação
Desloratadina	Comprimido 5 mg; solução oral	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 11 meses 1 mg; 1 a 5 anos 1,25 mg; 6 a 11 anos 2,5 mg	Dose maior não melhora
Fexofenadina	Comprimido até 180 mg; suspensão 6 mg/mL	120 a 180 mg 1 vez/dia	180 mg	2 a 11 anos: 30 mg a cada 12 h	Antiácido e suco de fruta reduzem absorção

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Levocetirizina	Comprimido 5 mg	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez/dia	Ajustar em doença renal
Dexclorfeniramina	Comprimido 2 mg; solução	2 mg 3 a 4 vezes/dia	12 mg	6 a 12 anos até 6 mg/dia; 2 a 6 anos até 3 mg/dia; abaixo de 2 anos contraindicada	Sedação; evitar em idoso
Dextrometorfano	Solução até 3 mg/mL	10 a 20 mg a cada 4 h ou 30 mg a cada 6 a 8 h	120 mg	Conforme bula do produto	IMAO; asma; DPOC
Dropropizina	Gotas 30 mg/mL	30 gotas 4 vezes/dia	120 gotas	Acima de 3 anos: 15 gotas 4 vezes/dia	Só tosse seca
Acetilcisteína	Granulado 600 mg; xarope 20 e 40 mg/mL	600 mg 1 vez/dia por 5 a 10 dias	600 mg sem prescrição	2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes/dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Ambroxol	Xarope 6 mg/mL; pediátrico 3 mg/mL; cápsula LP 75 mg	30 mg 3 vezes/dia ou 75 mg 1 vez/dia	90 mg	2 a 5 anos 7,5 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 15 mg 3 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Bromexina	Xarope 0,8 e 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes/dia	24 mg	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes/dia	Hidratação junto
Mebendazol	Comprimido 500 mg; suspensão 20 mg/mL	500 mg dose única ou 100 mg 2 vezes/dia por 3 dias	Conforme esquema	Acima de 1 ano: mesma dose; 1 a 2 anos só se justificado	Evitar com metronidazol
Levamisol	Comprimido até 150 mg	150 mg dose única ao deitar	Dose única	Até 1 ano 40 mg; 1 a 7 anos 80 mg	Somente ascaridíase

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Permetrina 5%	Loção cremosa 50 mg/mL	Pescoço aos pés, remover após 8 a 14 h	30 g por aplicação (até 60 g)	6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g	Tratar todos os contatos
Permetrina 1%	Xampu ou loção 10 mg/mL	10 minutos no cabelo; repetir em 7 a 14 dias se preciso	1 aplicação por vez	Conforme bula	Pente fino
Deltametrina	Xampu ou loção 0,2 mg/mL	5 minutos no banho por 4 dias; repetir 7 dias depois	Conforme bula	Conforme bula	Irritação local
Clotrimazol vaginal	Comprimido 500 mg; creme 20 mg/g	500 mg dose única ou creme por 3 noites	Dose única	Não se aplica: menor de idade vai ao médico	Primeiro episódio e gestante: médico
Acetato de hidrocortisona	Creme ou pomada 1%	Camada fina 2 a 3 vezes/dia	Conforme bula	Até 4 anos: no máximo 3 semanas	Não usar em micose ou herpes
Penciclovir	Creme 10 mg/g	A cada 2 h acordado, por 4 dias	4 dias	Não recomendado abaixo de 12 anos	Iniciar no formigamento
Nicotina adesivo	7, 14 e 21 mg/24 h	21 mg/dia se mais de 10 cigarros/dia	1 adesivo/dia	NiQuitin®: contraindicado abaixo de 12 anos	Infarto ou AVC recentes: médico
Nicotina pastilha	2 e 4 mg	1 a cada 1 a 2 h nas semanas 1 a 6	20 pastilhas	Conforme bula	Não mastigar nem engolir
Sulfato ferroso	40 ou 60 mg de ferro; solução 25 mg/mL	1 comprimido ao dia em jejum	1 comprimido	6 a 18 meses 1 mL/semana; 18 meses a 6 anos 1 mL/dia; 6 a 12 anos 2 mL/dia	Intoxicação infantil; espaçar de levotiroxina
Ácido fólico	Solução 0,2 mg/mL	0,4 mg/dia (2 mL) na prevenção	1 mg (5 mL)	Conforme bula	Pode mascarar anemia perniciosa

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Fenazopiridina	Comprimido 200 mg	200 mg a cada 8 h após refeições	600 mg; até 2 dias	Não indicar	Não trata infecção urinária
Hidroxiquinolina + trolamina	Solução otológica	5 gotas 3 vezes/dia	Conforme bula	Conforme bula	Suspeita de perfuração: não usar
Nafazolina (colírio associado)	Solução oftálmica	1 a 2 gotas até 4 vezes/dia	4 aplicações	Conforme bula	Rebote; glaucoma

Doses conferidas na LMN (IN 106/2021), no guia de dengue do Ministério da Saúde (2024) e em bulas de referência citadas nos tópicos. Concentrações isentas conforme a LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025). A bula do produto entregue prevalece: limites e gotas por mL variam entre marcas.

Evitar ou ter cautela: grupos especiais

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Gestante	AAS e AINE orais (contraindicados no 3º trimestre); dipirona (bula da Novalgina®); antigripal com fenilefrina; óleo mineral; mebendazol; tiabendazol tópico; anti-H1 sem pré-natal	Qualquer MIP sem conhecimento do pré-natal; antiácido com bicarbonato de sódio	Paracetamol na menor dose e pelo menor tempo; soro nasal; medidas não farmacológicas; encaminhar ao pré-natal
Lactante	Anti-H1 de primeira geração (sedação do bebê, menos leite); dipirona (bula); uso prolongado de laxante estimulante	AAS; descongestionantes orais; fitoterápicos sem dados	Paracetamol; ibuprofeno em dose usual; anti-H1 de segunda geração com orientação
Idoso	Anti-H1 de primeira geração; antigripal com anti-H1 e fenilefrina; AINE oral contínuo; óleo mineral (aspiração)	Dipirona (hipotensão); escopolamina; antiácido com magnésio ou alumínio se rim comprometido; bisacodil crônico	Paracetamol; AINE tópico; loratadina ou fexofenadina; laxante formador de massa ou osmótico
Hipertenso	Fenilefrina oral; isometepteno; AINE oral regular; sal de fruta (bicarbonato de sódio); alcaçuz	Cafeína em associações; guaraná e ginseng; vasoconstritor ocular frequente	Paracetamol; soro nasal; anti-H1 de segunda geração isolado; AINE tópico

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Anticoagulado	AAS; AINE orais; salicilato de metila em área extensa; guaco; *Salix alba*	Paracetamol regular com varfarina (eleva o INR); omeprazol com varfarina; gengibre em dose alta	Paracetamol em uso pontual; AINE tópico em área pequena; orientar sinais de sangramento
Asmático	AAS e AINE se já houve crise com analgésico; dextrometorfano (bula); dropropizina	Dipirona (reação cruzada possível); anti-H1 sedativo	Paracetamol; encaminhar tosse com chiado
Doença renal	AINE oral; antiácidos com magnésio ou alumínio de uso contínuo; fenazopiridina	Levocetirizina (ajuste); dipirona em dose alta	Paracetamol; encaminhar qualquer uso prolongado

Quadro de triagem para o balcão. Gestantes, lactantes e pessoas com doença crônica devem ter o uso de qualquer MIP comunicado ao médico assistente.

Pedidos comuns que não são MIP

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Dimenidrinato (Dramin®, Dramin B6®)	Venda sob prescrição (bula)	Cinetose: meclozina 50 mg ou gengibre, se MIP na embalagem; vômito: sais de reidratação e encaminhar
Metoclopramida, bromoprida, ondansetrona	Venda sob prescrição	Encaminhar
Loperamida (Imosec®)	Venda sob prescrição (bula)	Sais de reidratação; *S. boulardii*; encaminhar se sinal de alarme
Racecadotrila (Tiorfan®)	Venda sob prescrição (bula)	Idem
Famotidina e demais anti-H2	Fora da LMIP	Antiácido, alginato ou omeprazol 20 mg MIP
Nafazolina e oximetazolina nasais	Venda sob prescrição (Neosoro®, Sorine®, Afrin®)	Soro fisiológico ou salina hipertônica
Cetirizina (Zyrtec®)	Venda sob prescrição (bula)	Levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina
Nimesulida oral, cetoprofeno, diclofenaco oral	Fora da LMIP	Ibuprofeno ou naproxeno em dose MIP; nimesulida ou diclofenaco gel
Aciclovir creme (Zovirax®)	Venda sob prescrição (bula)	Penciclovir creme 10 mg/g

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Albendazol (Zentel®)	Venda sob prescrição (bula)	Mebendazol, quando indicado
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Permetrina ou deltametrina tópicas; encaminhar
Fluconazol	Fora da LMIP	Clotrimazol ou miconazol vaginal, com critérios
Levonorgestrel 1,5 mg (Postinor Uno®)	Venda sob prescrição (bula)	Encaminhar com urgência à UBS ou UPA, que fornecem gratuitamente
Corticoides tópicos de média e alta potência	Fora da LMIP	Acetato de hidrocortisona 1%
Vitamina D em alta dose, ferro polimaltosado, complexo B em alta dose	Venda sob prescrição nos produtos conferidos	Carbonato de cálcio + vitamina D3 e sulfato ferroso da LMN, com critério
Minoxidil tópico	Fora da LMIP	Alfaestradiol solução capilar; dermatologista

Status conferido na LMIP vigente e nas bulas dos produtos citados (outubro de 2026). Tarja vermelha sem retenção de receita continua exigindo prescrição.

Orientação na entrega do MIP

- ◯ Identificar quem vai usar: idade, peso (criança), gestação e amamentação
- ◯ Conferir na embalagem se o produto é MIP (sem tarja) e a concentração
- ◯ Perguntar sobre doenças de fígado, rim, estômago, pressão, asma, glaucoma e próstata
- ◯ Revisar medicamentos em uso, inclusive outros MIP, chás e fitoterápicos
- ◯ Checar duplicidade de princípio ativo (paracetamol em antigripal)
- ◯ Informar a dose na unidade que o cliente vai medir (comprimido, mL, gotas)
- ◯ Mostrar o dosador do frasco e conferir quantas gotas tem cada mL
- ◯ Informar o intervalo entre doses e a dose máxima em 24 horas
- ◯ Informar por quantos dias usar sem reavaliação
- ◯ Explicar o efeito adverso mais comum e o que fazer se ocorrer

- ◯ Explicar os sinais de alarme que exigem procurar atendimento
- ◯ Orientar armazenamento e manter fora do alcance de crianças
- ◯ Entregar a orientação por escrito quando houver cálculo de dose
- ◯ Em suspeita de dengue: sem AAS e sem AINE, hidratar e encaminhar
- ◯ Registrar a indicação farmacêutica e combinar retorno ou acompanhamento

SOS Farmácia Comercial

Escolha do analgésico ou antitérmico

Cliente com febre ou dor leve a moderada pede analgésico ou antitérmico

DECISÃO

Há sinal de gravidade? (febre em menor de 3 meses, rigidez de nuca, manchas, falta de ar, sonolência, dor súbita e intensa)

SIM
Não dispensar como autocuidado: encaminhar para atendimento de urgência

NÃO
Seguir para a avaliação de dengue

DECISÃO

Pode ser dengue? (época de transmissão, febre com dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas)

SIM
Paracetamol ou dipirona, nada de AAS, AINE ou corticoide; hidratação oral; encaminhar para avaliação e notificação

NÃO
Seguir

DECISÃO

É criança ou adolescente com gripe, catapora ou outra virose?

SIM
Paracetamol ou dipirona com dose pelo peso; AAS proibido (síndrome de Reye)

NÃO
Seguir

DECISÃO

Há contraindicação a AINE? (úlcera ou sangramento, anticoagulante, doença renal, hipertensão ou cardiopatia, asma por AINE, gestação)

SIM
Paracetamol ou dipirona; AINE tópico se a dor for localizada

NÃO
Seguir

DECISÃO

A dor tem componente inflamatório? (cólica menstrual, dor muscular, dor de dente, entorse)

SIM
Ibuprofeno ou naproxeno em dose MIP, com alimento, pelo menor tempo

NÃO
Paracetamol ou dipirona

↓

Checar doença hepática, etilismo, G6PD, alergia a pirazolonas e produtos em uso com o mesmo ativo

↓

Calcular a dose pelo peso na criança e conferir as gotas por mL do frasco entregue

↓

Orientar intervalo, dose máxima, um antitérmico só (sem alternar) e hidratação

↓

ATENÇÃO

Procurar atendimento se a febre passar de 72 horas, se houver piora ou sinal de alarme

↓

Registrar a indicação e a orientação dada

Cartões: classes de MIP

Pergunta	Resposta
Qual norma traz hoje a lista de MIP?	IN 285/2024 (Anexo I sintéticos, Anexo II fitoterápicos), com Anexo I republicado pela IN 404/2025.
A concentração máxima da LMIP é dose diária?	Não. É a quantidade do insumo na forma farmacêutica (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).
Dose máxima diária de paracetamol no adulto?	4 g em 24 horas, até 1 g por dose (LMN).
Dose pediátrica de paracetamol?	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg, médico.
Idade e peso mínimos para dipirona?	3 meses e 5 kg (bula da Novalgina®).
Antitérmicos indicados na dengue suspeita?	Paracetamol e dipirona (MS, 2024). Sem AAS, AINE ou corticoide.
Por que não dar AAS a criança com gripe?	Risco de síndrome de Reye (bula da Aspirina®).

Pergunta	Resposta
Dose máxima de ibuprofeno sem prescrição no adulto?	1200 mg/dia (bula do Advil® 400 mg).
Nimesulida comprimido é MIP?	Não. Só a nimesulida gel 20 mg/g consta da LMIP.
Condições do omeprazol MIP?	20 mg, caixas de 7 ou 14, azia 2 ou mais dias/semana, até 14 dias, intervalo de 4 meses.
Dimenidrinato é MIP?	Não. Dramin® e Dramin B6® têm venda sob prescrição; meclozina 50 mg consta da LMIP para cinetose.
Loperamida e racecadotrila são MIP?	Não. Imosec® e Tiorfan® têm venda sob prescrição.
Nafazolina nasal é MIP?	Não. Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP; soro fisiológico é a opção isenta.
Cetirizina ou levocetirizina: qual é MIP?	Levocetirizina 5 mg. Cetirizina não consta da LMIP.
Antiviral tópico MIP para herpes labial?	Penciclovir creme 10 mg/g, a cada 2 h acordado por 4 dias. Aciclovir creme não é MIP.
Permetrina 5%: quanto tempo na pele?	Remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação.
Antiparasitários orais da LMIP?	Mebendazol (500 mg e 20 mg/mL) e levamisol (até 150 mg). Albendazol não.
Esquema do adesivo de nicotina para quem fuma mais de 10 cigarros/dia?	21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas.
Levonorgestrel 1,5 mg é MIP?	Não. Venda sob prescrição; usar até 72 h; repetir se vomitar em 4 h.
Sulfato ferroso e ácido fólico 0,2 mg/mL são isentos por quê?	São medicamentos de notificação simplificada da LMN (IN 106/2021), de venda isenta por definição.

Questões: casos de balcão com MIP

1. Durante surto de dengue, mulher de 30 anos chega com febre de 39 °C há 2 dias, dor no corpo e dor atrás dos olhos, sem sinais de alarme. Pede ibuprofeno porque "funciona melhor". Qual a conduta adequada?

A Dispensar ibuprofeno 400 mg a cada 6 horas por ser MIP

B Indicar paracetamol ou dipirona, hidratação oral e encaminhar para avaliação

C Indicar AAS 500 mg, que tem efeito antitérmico mais duradouro

D Indicar naproxeno 550 mg 1 vez ao dia para reduzir o número de doses

E Alternar ibuprofeno e paracetamol a cada 3 horas

2. Cliente pede "Dramin" para enjoo em viagem de ônibus amanhã. Sobre o enquadramento regulatório, assinale a correta.

A Dimenidrinato consta da LMIP e pode ser indicado livremente

B Todos os antieméticos orais são MIP desde a IN 285/2024

C Dimenidrinato é MIP apenas quando associado à piridoxina

D Dimenidrinato não consta da LMIP; a meclozina 50 mg consta, para cinetose

E A metoclopramida é a alternativa MIP ao dimenidrinato

3. Criança de 4 anos e 16 kg com febre de 38,8 °C. A mãe tem dipirona gotas 500 mg/mL (20 gotas = 1 mL). Pela bula da Novalgina®, qual faixa de dose por tomada é adequada?

A 5 a 15 gotas por dose, até 4 vezes ao dia

B 20 a 40 gotas por dose, até 4 vezes ao dia

C 1 gota por kg, até 6 vezes ao dia

D 2 a 5 gotas por dose, no máximo 20 gotas ao dia

E 40 gotas em dose única diária

4. Homem de 70 anos, em uso de losartana, hidroclorotiazida e varfarina, pede ibuprofeno para dor no joelho após caminhada. Qual a melhor conduta farmacêutica?

A Ibuprofeno 400 mg 3 vezes ao dia por 10 dias

B Naproxeno 550 mg 1 vez ao dia por ser de dose única

C AAS 500 mg, por ter menor risco renal que o ibuprofeno

D Nimesulida comprimido, que é mais seletiva

E AINE tópico no joelho e, se preciso, paracetamol em uso pontual

5. Sobre o omeprazol incluído na LMIP pela IN 404/2025, é correto afirmar:

A Qualquer apresentação de 20 mg passou a ser isenta, inclusive caixas de 28

B A isenção abrange 40 mg em uso contínuo para refluxo

C Vale para 20 mg em caixas de até 14 unidades, por até 14 dias, para azia frequente

D A isenção depende de retenção de receita do farmacêutico

E O ciclo pode ser repetido livremente após 7 dias de pausa

6. Adolescente de 13 anos com catapora e febre. O pai quer "aspirina infantil". Qual o principal motivo para recusar e orientar outro antitérmico?

A Hepatotoxicidade dose-dependente do AAS

B Risco de síndrome de Reye com AAS em virose na infância e adolescência

C AAS não tem efeito antitérmico em crianças

D AAS infantil foi retirado da LMIP em 2025

E Risco de agranulocitose idiossincrásica

7. Cliente pede "Neosoro" para nariz entupido por resfriado. Assinale a afirmação correta.

A Nafazolina nasal é MIP por ser de uso tópico

B O uso por mais de 15 dias é seguro em adultos

C Pode ser indicada para bebês por ter baixa concentração

D É indicada como primeira escolha em hipertensos

E Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP e causam rebote

8. Motorista de ônibus de 45 anos com rinite alérgica intermitente pede um antialérgico. Qual opção é MIP e mais adequada?

A Fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia

B Dexclorfeniramina 2 mg 4 vezes ao dia

C Cetirizina 10 mg 1 vez ao dia

D Hidroxizina 25 mg à noite

E Prometazina 25 mg comprimido

9. Mulher de 25 anos relata prurido vulvar intenso e corrimento branco grumoso sem odor, igual a episódio diagnosticado pelo ginecologista no ano anterior. Não está grávida e não tem outros sintomas. Qual conduta é compatível com a LMIP?

A Fluconazol 150 mg oral em dose única, que é MIP

B Metronidazol gel vaginal à noite por 7 noites seguidas

C Clotrimazol 500 mg vaginal em dose única, com orientação de retorno

D Creme vaginal com corticoide e antibiótico

E Nistatina suspensão oral por 7 dias, com bochecho

10. Mãe pede albendazol para os dois filhos (5 e 8 anos) com coceira anal noturna. Qual a conduta mais adequada?

A Dispensar albendazol 400 mg, que é MIP desde 2024

B Indicar levamisol, que trata oxiuríase em dose única

C Recusar qualquer antiparasitário e encaminhar ao pronto-socorro

D Indicar ivermectina em dose única para toda a família

E Mebendazol 500 mg em dose única para a família, higiene e repetição combinada

11. Fumante de 30 cigarros por dia, que acende o primeiro logo ao acordar, quer iniciar reposição de nicotina com pastilhas. Pela bula do NiQuitin® pastilha, qual a concentração e o limite diário?

A 2 mg, sem limite diário

B 4 mg, no máximo 20 pastilhas por dia

C 4 mg, no máximo 5 pastilhas por dia

D 2 mg, no máximo 9 pastilhas por dia

E 1 mg, a cada 30 minutos

12. Jovem de 19 anos pede "pílula do dia seguinte" sem receita, 20 horas após relação desprotegida. Qual a orientação correta sobre o levonorgestrel 1,5 mg?

A É MIP e pode ser prescrito pelo farmacêutico pela CFF 586/2013

B Só tem efeito se usado até 12 horas após a relação

C Atua interrompendo gravidez já implantada

D É tarjado, depende de prescrição e o SUS fornece gratuitamente

E Protege contra infecções sexualmente transmissíveis

Gabarito comentado

1. **B**. O guia do Ministério da Saúde (Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024) orienta paracetamol e/ou dipirona e proíbe salicilatos, AINE e corticoides pelo risco de sangramento. Ibuprofeno, naproxeno e AAS estão errados pelo mesmo motivo, e a alternância é desaconselhada e ainda inclui um AINE.
2. **D**. A conferência do Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025) não encontra dimenidrinato, e as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem venda sob prescrição médica. A lista inclui dicloridrato de meclozina 50 mg com indicação de cinetose e o fitoterápico *Zingiber officinale*. Metoclopramida também é tarjada.
3. **A**. Na tabela da bula, 16 a 23 kg (4 a 6 anos) recebe 5 a 15 gotas por dose, máximo 60 gotas/dia (4 tomadas de 15). A dose de 20 a 40 gotas é para maiores de 15 anos; 2 a 5 gotas é para 5 a 8 kg; as demais não constam da bula.
4. **E**. AINE oral com diurético e BRA aumenta o risco de lesão renal aguda, e com varfarina aumenta o risco de sangramento. AAS soma risco hemorrágico. Nimesulida oral não é MIP. O AINE tópico tem baixa exposição sistêmica; o paracetamol pontual é aceitável, lembrando que o uso regular pode elevar o INR.
5. **C**. A IN 404/2025 incluiu omeprazol 20 mg em cápsula dura e de liberação retardada, para sintomas de azia em 2 ou mais dias por semana. O voto da Diretoria Colegiada prevê apresentações de 7 a 14 unidades, uso por até 14 dias e intervalo de 4 meses entre ciclos; caixas maiores seguem sob prescrição (coexistência permitida pela RDC 882/2024, art. 14).
6. **B**. A bula da Aspirina® determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta, pelo risco de síndrome de Reye. Hepatotoxicidade dose-dependente é característica do paracetamol; agranulocitose, da dipirona. O AAS 500 mg segue na LMIP.
7. **E**. Nafazolina e oximetazolina nasais não constam da LMIP e as bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem venda sob prescrição. O uso prolongado causa rinite medicamentosa; a ingestão por crianças pequenas pode causar intoxicação grave; hipertensos devem evitar. A alternativa isenta é o soro fisiológico ou a salina hipertônica.
8. **A**. Fexofenadina até 180 mg consta da LMIP e quase não causa sedação (bula do Allegra®). Dexclorfeniramina é MIP, mas seda e prejudica a direção. Cetirizina, hidroxizina e prometazina oral não constam da LMIP.
9. **C**. Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal consta da LMIP para candidíase vaginal (bula do Gino-Canesten®: dose única). Fluconazol, metronidazol vaginal, associações com corticoide e nistatina oral não constam da lista. O caso preenche os critérios de tratamento no balcão: episódio recorrente com diagnóstico prévio, sem sinais de alarme.
10. **E**. Albendazol (bula do Zentel®) e ivermectina não são MIP. Levamisol é indicado só para ascaridíase. O mebendazol 500 mg (LMIP) trata *Enterobius* em dose única acima de 1 ano; por reinfecção, todos os moradores são tratados, com higiene e repetição após 2 semanas conforme orientação clínica. Pronto-socorro não é necessário sem sinal de alarme.
11. **B**. A bula orienta 4 mg para quem fuma nos primeiros 30 minutos após acordar e 2 mg para quem fuma depois; o máximo é 20 pastilhas por dia, com pelo menos 9 por dia nas semanas 1 a 6. Não existe pastilha de 1 mg na LMIP, cujo limite é 4 mg.
12. **D**. O levonorgestrel 1,5 mg não consta da LMIP e a bula do Postinor Uno® traz venda sob prescrição; por isso não entra na prescrição farmacêutica de MIP. Deve ser usado o quanto antes, até 72 horas, age principalmente sobre a ovulação, não interrompe gravidez implantada e não protege contra IST. O farmacêutico deve orientar o acesso rápido na UBS ou UPA.

Módulo 13

Calculadora de dose

Cálculo de dose no balcão: unidades e concentrações, dose por peso, por faixa de peso e por idade, tetos, gotas, reconstituição, quantidade a dispensar (RDC 471/2021), insulinas e canetas, função renal, injetáveis e conduta diante de erros. Inclui calculadora com 99 linhas de fármacos (líquidos, comprimidos e injetáveis) alimentada por dados de bula.

- Unidades, concentrações e regra de três
- Peso, idade e superfície corporal
- Dose por peso e tetos
- Febre e dor na criança
- Gotas, seringas e colheres
- Antimicrobianos pediátricos
- Suspensões para reconstituir
- Sal, base e elemento
- Quantidade a dispensar
- Função renal e idoso
- Insulinas e canetas
- Injetáveis na sala de serviços
- Erros clássicos e dose que não bate

Unidades, concentrações e regra de três

Todo cálculo de dose no balcão se resume a três perguntas: quanto de fármaco o paciente deve receber (em mg, mcg ou UI), quanto de fármaco existe em cada mililitro do produto (a concentração) e, portanto, que volume entregar. Errar a unidade em qualquer etapa multiplica ou divide a dose por 10, 100 ou 1000. Por isso o primeiro passo é sempre escrever a unidade ao lado de cada número.

Unidades de massa e de volume

Unidade	Equivale a	Exemplo de balcão
1 g (grama)	1000 mg	Amoxicilina 0,5 g = 500 mg
1 mg (miligrama)	1000 mcg	Levotiroxina 0,1 mg = 100 mcg
1 mcg (micrograma)	0,001 mg	Ivermectina: dose-alvo de 200 mcg/kg na bula da Revectina®
1 L (litro)	1000 mL	Soro de 0,5 L = 500 mL
UI (unidade internacional)	Medida de atividade biológica, sem conversão fixa para mg	Insulina, algumas vitaminas, heparina

A UI não se converte em miligramas por regra geral: cada substância tem a sua equivalência, definida por padrão biológico. Para a insulina, o que importa no balcão é a concentração em UI/mL impressa no rótulo. O símbolo "U" isolado deve ser evitado na escrita, porque pode ser lido como zero; o boletim do ISMP Brasil sobre abreviaturas (2015) relata uma prescrição de "5U" de insulina interpretada como 50 unidades.

Formas de expressar a concentração

O mesmo produto pode ter a concentração escrita de jeitos diferentes no rótulo, na bula e na receita. Converter tudo para **mg/mL** antes de calcular evita a maioria dos erros.

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
500 mg/mL	500 mg/mL	Dipirona gotas
250 mg/5 mL	50 mg/mL	Amoxicilina suspensão
200 mg/5 mL	40 mg/mL	Azitromicina suspensão
400 mg + 57 mg/5 mL	80 mg/mL de amoxicilina e 11,4 mg/mL de clavulanato	Amoxicilina + clavulanato BD
2% (p/v)	20 mg/mL	Soluções e géis em porcentagem

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
0,9% (p/v)	9 mg/mL	Cloreto de sódio 0,9%

Porcentagem peso/volume (p/v) indica gramas em 100 mL. Uma solução a 1% tem 1 g em 100 mL, ou seja, 1000 mg em 100 mL, que dá 10 mg/mL. Regra rápida: multiplique a porcentagem por 10 e terá mg/mL. O cloreto de sódio 0,9% tem 9 mg/mL; um frasco de 500 mL contém 4500 mg, isto é, 4,5 g.

Concentrações em mEq (miliequivalente) aparecem em sais como cloreto de potássio e bicarbonato de sódio, e expressam carga elétrica, não massa. O rótulo e a bula trazem a correspondência; o farmacêutico de drogaria raramente precisa convertê-la, mas deve conferir se a receita e o produto usam a mesma unidade.

Regra de três

A regra de três resolve quase todo cálculo de volume. Monte sempre na mesma ordem: concentração do produto na primeira linha, dose desejada na segunda.

PONTO-CHAVE

Volume (mL) = dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL). Dose (mg) = volume (mL) × concentração (mg/mL). Se a concentração estiver em mg/5 mL, converta antes para mg/mL.

CASO

Receita para criança de 25 kg: amoxicilina 250 mg/5 mL, 7,5 mL de 8 em 8 horas.

Passo 1: concentração em mg/mL: 250 ÷ 5 = 50 mg/mL.
Passo 2: dose por tomada: 7,5 mL × 50 mg/mL = 375 mg.
Passo 3: dose diária: 375 mg × 3 tomadas = 1125 mg/dia.
Passo 4: dose por peso: 1125 ÷ 25 kg = 45 mg/kg/dia.
Conclusão: a bula do Amoxil® indica 20 a 50 mg/kg/dia para crianças abaixo de 40 kg, em doses divididas de 8 em 8 horas. A prescrição está dentro da faixa.

Arredondamento

Doses calculadas raramente dão números redondos. Arredonde o volume para o que o dosador do produto consegue medir com segurança: seringas de 5 mL costumam ter marcação de 0,2 em 0,2 mL ou de 0,25 em 0,25 mL, e copos-medida marcam de 2,5 em 2,5 mL. Gotas não se fracionam. Ao arredondar, confira se a dose final continua dentro da faixa da bula e abaixo do teto.

NO BALCÃO

Faça a conta no papel ou na calculadora, nunca de cabeça, e refaça uma segunda vez pelo caminho inverso (do volume para os mg/kg). Mostre ao cuidador a marca da seringa correspondente à dose e peça que ele repita o volume em voz alta.

Dose por peso e tetos

Em pediatria a dose depende do peso, porque a capacidade de metabolizar e eliminar fármacos acompanha o tamanho do corpo. As bulas expressam essa dose de duas formas, e confundi-las é uma das causas mais comuns de erro.

mg/kg por dose e mg/kg por dia

Forma	O que significa	Exemplo (bula)
mg/kg/dose	Quantidade de cada tomada	Paracetamol 10 a 15 mg/kg/dose, a cada 4 a 6 horas, até 5 vezes ao dia (Tylenol®)
mg/kg/dia	Total das 24 horas, que deve ser dividido pelo número de tomadas	Amoxicilina 20 a 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas (Amoxil®)
mg/kg a cada X horas	Dose por tomada já com o intervalo	Claritromicina 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (Klaricid®)

Antitérmicos e analgésicos costumam vir em mg/kg/dose. Antibióticos costumam vir em mg/kg/dia. Ao ler uma receita, identifique primeiro se o número a conferir se refere à tomada ou ao dia inteiro.

CASO

Criança de 18 kg com receita de amoxicilina 250 mg/5 mL na dose de 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas.

Passo 1: dose diária: 18 kg × 50 mg/kg/dia = 900 mg/dia.
Passo 2: dose por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg.
Passo 3: volume: 300 mg ÷ 50 mg/mL = 6 mL de 8 em 8 horas.
Erro típico: aplicar 50 mg/kg em cada tomada daria 900 mg três vezes ao dia, o triplo da dose.

Qual peso usar

Use o peso atual, medido há pouco tempo, informado pelo cuidador ou constante na receita. Tabelas de bula por idade trazem a "média de idade" apenas como referência: na bula da Novalgina®, a faixa de 9 a 15 kg corresponde a "1 a 3 anos", mas uma criança de 2 anos com 9 kg e outra com 15 kg recebem doses diferentes. Na dúvida sobre o peso, peça que a criança seja pesada na farmácia, se houver balança, ou na unidade de saúde.

Tetos: dose máxima por tomada e por dia

A dose por peso cresce com a criança até alcançar a dose de adulto. A partir daí, aumentar o peso não aumenta a dose. As bulas fixam esses limites de jeitos diferentes:

Fármaco	Teto na bula	Fonte
Paracetamol	No máximo 5 administrações em 24 h; total diário até 75 mg/kg e até 4000 mg; até 1000 mg por administração	Tylenol®
Ibuprofeno (criança)	200 mg por dose e 800 mg por dia	Alivium® gotas
Amoxicilina	Até 150 mg/kg/dia; a partir de 40 kg, posologia de adulto	Amoxil®
Azitromicina	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento todo	Zitromax® e Astro®
Claritromicina	500 mg duas vezes ao dia	Klaricid®
Cefalexina	Acima de 4 g/dia, considerar cefalosporina injetável	Keflex®
Prednisolona	80 mg por dia	Prelone®

CASO

Criança de 35 kg com febre alta. A mãe pergunta quanto dar de ibuprofeno.

Passo 1: dose por peso para febre alta: 35 kg × 10 mg/kg = 350 mg.
Passo 2: teto da bula do Alivium® para crianças: 200 mg por dose e 800 mg por dia.
Passo 3: a dose calculada passa do teto. A dose correta é 200 mg por tomada, no máximo 4 vezes ao dia.
Conclusão: quando o peso leva a uma dose acima do teto, vale o teto. Em gotas de 100 mg/mL do Alivium® (10 gotas por mL), 200 mg são 20 gotas.

CASO

Adolescente de 55 kg com receita de azitromicina suspensão 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: 55 kg × 10 mg/kg = 550 mg/dia.
Passo 2: a bula fixa 500 mg/dia e, acima de 45 kg, dose igual à de adulto.
Passo 3: a dose correta é 500 mg/dia (12,5 mL), total de 1500 mg (37,5 mL): um frasco de 1500 mg.
Conduta: a diferença é pequena, mas a receita está acima do teto. Contate o prescritor para confirmar a dose antes de orientar.

Associações: qual componente calcular

Em associações, a bula escolhe um componente como referência, e a conta deve seguir essa escolha. Na amoxicilina com clavulanato, a dose em mg/kg é a da amoxicilina; o clavulanato acompanha na proporção fixa da apresentação. No sulfametoxazol com trimetoprima, a bula do Bactrim® fixa doses por idade e

informa que elas correspondem a cerca de 6 mg/kg/dia de trimetoprima e 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol, de 12 em 12 horas, com aumento de até 50% em infecção grave. Como a relação entre os dois é fixa (5 para 1), calcular por qualquer um dos componentes leva ao mesmo volume, desde que a concentração usada seja a do mesmo componente.

CASO

Criança de 14 kg com receita de sulfametoxazol + trimetoprima suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL, 5 mL de 12 em 12 horas.

Passo 1: concentração de sulfametoxazol: 200 ÷ 5 = 40 mg/mL; 5 mL = 200 mg por tomada, 400 mg/dia.
Passo 2: por peso: 400 ÷ 14 = 28,6 mg/kg/dia de sulfametoxazol.
Passo 3: pela trimetoprima: 8 mg/mL × 5 mL × 2 = 80 mg/dia, ou 5,7 mg/kg/dia.
Conclusão: as duas contas confirmam a dose usual da bula (cerca de 30 e 6 mg/kg/dia), que corresponde ao esquema fixo de 5 mL para crianças de 6 meses a 5 anos. Se a receita trouxesse a suspensão F (400 mg + 80 mg/5 mL) no mesmo volume, a dose dobraria.

ATENÇÃO

A faixa de mg/kg é o primeiro filtro, o teto é o segundo. Uma dose pode estar dentro da faixa por quilo e mesmo assim passar do máximo por tomada ou por dia, o que acontece com crianças maiores e com sobrepeso. Confira sempre os dois.

NO BALCÃO

Para toda prescrição pediátrica, pergunte o peso e a idade, anote na receita ou no sistema e confira: dose por tomada, número de tomadas, total diário, mg/kg/dia e tetos. Se faltar o peso e a dose parecer alta para a idade, não presuma: peça o dado ao cuidador ou ao prescritor.

Gotas, seringas e colheres

Gota não é unidade de volume padronizada. O tamanho da gota depende do bico do frasco, da viscosidade e da tensão superficial do líquido e até do ângulo em que o frasco é segurado. Por isso cada bula informa quantas gotas o seu gotejador libera em 1 mL, e esse número muda entre produtos e entre fabricantes do mesmo fármaco.

Gotas por mL declaradas em bula

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Novalgina® gotas (dipirona)	500 mg/mL	20	25 mg
Tylenol® gotas (paracetamol)	200 mg/mL	14 a 16	12,5 a 14,2 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	50 mg/mL	10	5 mg

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Alivium® gotas (ibuprofeno)	100 mg/mL	10	10 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	200 mg/mL	10	20 mg
Keflex® gotas (cefalexina)	100 mg/mL	cerca de 22	cerca de 4,5 mg

A equivalência "1 mL = 20 gotas" vem dos equipos de soro de macrogotas, em que o gotejador é padronizado. Equipos de microgotas liberam 60 microgotas por mL. Esses números valem para infusão venosa e não se transferem para frascos conta-gotas de medicamentos orais: entre os produtos da tabela, só a dipirona da Novalgina® segue os 20 gotas por mL.

CASO

Criança de 12 kg. O pai quer dar 150 mg de paracetamol (12,5 mg/kg) usando o frasco de Tylenol® gotas 200 mg/mL.

Passo 1: volume: 150 mg ÷ 200 mg/mL = 0,75 mL.
Passo 2: com o gotejador do Tylenol® (cerca de 15 gotas/mL): 0,75 × 15 ≈ 11 gotas. A bula simplifica para 1 gota/kg, isto é, 12 gotas.
Passo 3: se alguém assumir 20 gotas/mL, calcula 15 gotas. Com o gotejador do Tylenol®, 15 gotas entregam cerca de 200 mg, ou 16,7 mg/kg, acima da faixa de 10 a 15 mg/kg.
Conclusão: a orientação em gotas só vale para o frasco entregue. Ao trocar de marca, refaça a conta com o número de gotas por mL da nova bula.

"Gota por quilo"

Várias bulas resumem a dose como gotas por quilo de peso, o que facilita a vida do cuidador mas esconde a concentração. Na bula do Alivium®, a dose é 1 a 2 gotas/kg na apresentação de 50 mg/mL, 1 gota/kg na de 100 mg/mL e 1 gota a cada 2 kg na de 200 mg/mL. As três orientações entregam a mesma faixa em mg (5 a 10 mg/kg). Quem decorou "1 gota por quilo de ibuprofeno" e recebe o frasco de 200 mg/mL dá o dobro da dose.

Seringa dosadora, copo-medida e colher

Para volumes acima de poucos mililitros, o dosador que acompanha o produto é o instrumento correto. Colheres de cozinha variam muito de volume e induzem erro. Algumas observações das bulas:

- A seringa da Novalgina® Infantil (dipirona 50 mg/mL) foi desenvolvida para esse produto e a bula proíbe usá-la para outros medicamentos. A bula do Annita® tem a mesma advertência para a seringa da nitazoxanida.
- Há bula de paracetamol 100 mg/mL que manda encher a seringa "até o nível correspondente ao peso (kg) do bebê": a escala da seringa está em quilos, não em mililitros. Usar essa seringa com outro produto gera erro na hora.
- Alguns produtos trazem copo-medida (Tylenol® Criança 32 mg/mL, mebendazol suspensão), outros seringa (Clavulin®, Klaricid®). O dosador deve ficar com o frasco a que pertence.

ATENÇÃO

Nunca oriente "uma colher de chá" ou "uma colher de sopa". Converta a dose em mL, entregue um dosador graduado e marque a dose na própria seringa, se possível com caneta ou fita, na frente do cuidador.

NO BALCÃO

Ao entregar gotas, pergunte se a família já tem outro frasco do mesmo fármaco em casa, de outra marca ou concentração. Explique que o número de gotas vale para este frasco e mostre como segurar o conta-gotas (a bula do Tylenol® pede o frasco a 90°, na vertical). Para doses pequenas em lactentes, prefira a seringa graduada ao conta-gotas quando o produto permitir.

Suspensões para reconstituir

Muitos antibióticos pediátricos são vendidos como pó, porque o fármaco se degrada rapidamente em água. A suspensão é preparada em casa, imediatamente antes do primeiro uso, e a partir daí tem validade curta. Erros de reconstituição mudam a concentração e, com ela, a dose de cada mililitro.

Água que entra e volume que sai

O pó ocupa volume. Por isso a água adicionada é menor que o volume final, e o fabricante marca no frasco a linha até onde o líquido deve chegar. Se a família coloca o volume final em água (por exemplo, 100 mL num frasco que pede 90 mL), a suspensão fica mais diluída que o rótulo e a criança recebe menos fármaco em cada dose.

Produto	Água para reconstituir	Volume final
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL	100 mL
Clavulin® BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL	64 mL	70 mL
Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL	62 mL ou 124 mL	70 mL ou 140 mL
Astro® (azitromicina 200 mg/5 mL), frasco de 600 mg	9 mL	15 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 900 mg	12 mL	22,5 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 1500 mg	22 mL	37,5 mL utilizáveis

A bula da azitromicina fala em **volume utilizável**: parte da suspensão fica retida nas paredes do frasco e no dosador, e o fabricante já considera essa perda. O volume que importa para calcular quantas doses um frasco rende é o utilizável, não a soma de pó e água.

Técnica de reconstituição

1. Conferir o lacre e o prazo de validade do pó.

2. Agitar o frasco fechado para soltar o pó do fundo.
3. Adicionar água filtrada (ou fervida e já fria, conforme a bula) até perto da marca, tampar e agitar.
4. Esperar a espuma baixar e completar lentamente até a marca exata. A bula do Amoxil® e a do Clavulin® descrevem essa segunda etapa.
5. Agitar antes de cada dose, sempre.

Nem todo líquido pediátrico precisa de preparo. O Keflex® gotas (100 mg/mL) é pó para reconstituir, mas as suspensões Keflex® de 250 mg/5 mL e de 500 mg/5 mL já vêm prontas para uso. O cuidador que "reconstitui" uma suspensão pronta dilui o medicamento sem perceber. Na azitromicina Astro® e Azi®, o diluente vem na embalagem, e a bula manda adicionar todo o seu conteúdo.

Validade depois de preparada

Produto	Depois de preparado
Amoxil® (amoxicilina)	14 dias em geladeira (2 °C a 8 °C)
Clavulin® e Clavulin® BD	7 dias em geladeira; descartar depois
Keflex® gotas (cefalexina)	14 dias em geladeira
Cefamox® (cefadroxila)	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira
Klaricid® (claritromicina)	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem refrigeração
Astro® (azitromicina)	5 dias entre 15 °C e 30 °C
Annita® (nitazoxanida)	7 dias na embalagem original bem fechada

A tabela mostra que não existe regra única: há suspensão que deve ir à geladeira e há a que não deve. A claritromicina do Klaricid® é conservada fora da geladeira. A amoxicilina com clavulanato escurece se não for refrigerada, e a bula descreve a mudança de cor como sinal de degradação.

CASO

Criança de 20 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: dose diária: 20 × 10 = 200 mg = 5 mL.
Passo 2: total do tratamento: 200 mg × 3 dias = 600 mg = 15 mL.
Passo 3: o frasco de 600 mg rende 15 mL utilizáveis: um frasco basta, sem sobra.
Orientação: adicionar todo o diluente, agitar, usar a seringa da embalagem, dar uma vez ao dia, guardar em temperatura ambiente e descartar o que sobrar após 5 dias.

NO BALCÃO

Ao entregar uma suspensão em pó, pergunte quem vai preparar, mostre a marca no frasco e explique as duas etapas de água. Escreva no rótulo a data do preparo e a data de descarte. Confirme se a casa tem geladeira, quando a bula exige refrigeração, e oriente a não guardar a sobra para "a próxima vez".

Quantidade a dispensar

Calcular a dose é metade do trabalho. A outra metade é entregar a quantidade que cubra o tratamento inteiro, nem menos (a criança fica sem remédio no meio do curso) nem muito mais (sobra que vira automedicação depois).

A conta básica

PONTO-CHAVE

Volume total = volume por tomada × tomadas por dia × dias de tratamento. Número de frascos = volume total ÷ volume utilizável de um frasco, arredondado para cima. Depois, confira se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco.

CASO

Receita: amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem frascos de 150 mL.

Passo 1: volume diário: 7 mL × 3 = 21 mL.
Passo 2: volume total: 21 mL × 10 dias = 210 mL.
Passo 3: frascos: 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos.
Passo 4: estabilidade: o primeiro frasco dura cerca de 7 dias de uso, dentro dos 14 dias em geladeira da bula do Amoxil®. O segundo deve ser preparado apenas quando o primeiro acabar.

Quando a validade pós-preparo manda mais que o volume

CASO

Criança de 16 kg com receita de Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias.

Passo 1: dose diária de amoxicilina: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg.
Passo 2: volume por tomada: 360 mg ÷ 80 mg/mL = 4,5 mL. Volume diário: 9 mL. Total: 90 mL.
Passo 3: um frasco de 140 mL teria volume suficiente, mas a suspensão vale 7 dias depois de preparada. No 7º dia terão sido usados 63 mL e os 77 mL restantes devem ser descartados.
Passo 4: a solução é entregar 2 frascos de 70 mL. O primeiro cobre os dias 1 a 7 (63 mL, sobram 7 mL para descarte). O segundo é preparado no 8º dia e cobre os dias 8 a 10 (27 mL).

Quantas doses tem um frasco de gotas

Para gotas, a conta da duração usa o número de gotas por mL da bula. Um frasco de 15 mL de Tylenol® gotas, com cerca de 15 gotas/mL, tem perto de 225 gotas. Uma criança de 12 kg que recebe 12 gotas até 5 vezes ao dia usa no máximo 60 gotas por dia: o frasco dura pelo menos 3 a 4 dias de uso pleno. Para antitérmico isso basta; o frasco que dura semanas em casa costuma indicar uso irregular ou subdose, e merece pergunta. Na Novalgina® gotas, um frasco de 20 mL tem 400 gotas.

Comprimidos e cápsulas

Para formas sólidas a conta é a mesma: unidades por tomada × tomadas por dia × dias. Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias pede 21 cápsulas. Se houver apresentação fracionável registrada e a farmácia for autorizada a fracionar (RDC 80/2006), é possível entregar exatamente 21; se não, entrega-se a menor quantidade de embalagens que cubra o tratamento.

Antimicrobianos: a quantidade e a receita

O QUE DIZ A NORMA

A dispensação de antimicrobianos deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante apresentação comercial fracionável" (RDC 471/2021, art. 11). A receita deve trazer posologia e quantidade, esta em algarismos arábicos (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único).

Na prática, a quantidade escrita pelo prescritor e a quantidade calculada pela posologia precisam bater. Três situações são comuns:

- **Receita com quantidade suficiente**: dispensar o número de frascos que cobre o tratamento e registrar nas duas vias.
- **Quantidade escrita menor que a posologia exige** (receita de "1 frasco" para um tratamento que precisa de 2): contatar o prescritor para corrigir. Entregar só um frasco interrompe o tratamento; entregar dois sem respaldo extrapola a receita.
- **Receita sem quantidade** ou com "1 caixa": falta dado obrigatório. Contatar o prescritor antes de dispensar.

Para agonistas do GLP-1, sujeitos à retenção de receita pela RDC 973/2025, a mesma lógica vale: a quantidade de canetas precisa cobrir o período prescrito, considerando quantas doses cada caneta entrega (tópico sobre canetas).

NO BALCÃO

Antes de buscar o produto, faça a conta do volume total e diga ao cliente quantos frascos o tratamento exige. Se forem dois, explique que o segundo fica fechado até o primeiro acabar e mostre a data de descarte do primeiro. Sobras de antibiótico vão para o ponto de coleta, nunca para o armário.

Insulinas e canetas

Insulina é dosada em unidades internacionais (UI), e a seringa e a caneta já trazem a escala em UI. O cálculo no balcão raramente é de dose, que o prescritor ajusta pela glicemia, mas sim de volume, duração da caneta ou do frasco e quantidade a dispensar.

Concentrações

Concentração	Apresentação	Total de UI
100 UI/mL	Frasco-ampola de 10 mL (Humulin® N, NovoRapid®, Lantus®)	1000 UI
100 UI/mL	Refil de 3 mL para caneta (Lantus®, Humulin® N)	300 UI
300 UI/mL	Caneta descartável de 1,5 mL (Toujeo®, insulina glargina)	450 UI

Quase todas as insulinas do mercado brasileiro têm 100 UI/mL, conhecidas no jargão como U-100. A glargina do Toujeo® tem 300 UI/mL (U-300). Em receita e em orientação, escreva sempre a unidade por extenso ou como UI.

A bula do Humulin® N lembra que o volume a injetar depende da concentração, e que a seringa usada deve ser graduada para a concentração da insulina. A seringa de insulina comum é graduada para 100 UI/mL: 1 mL corresponde a 100 UI, e 12 UI correspondem a 0,12 mL. Por isso a bula do Toujeo® proíbe retirar a insulina da caneta com seringa: a seringa marcaria 12 UI, mas o líquido de 300 UI/mL conteria 36 UI. A caneta do Toujeo® foi desenhada para essa concentração e mostra a dose diretamente em unidades, sem necessidade de recálculo.

ATENÇÃO

Troca entre glarginas de concentrações diferentes não é unidade por unidade. A bula do Lantus® recomenda que, ao passar da glargina 300 UI/mL para a de 100 UI/mL, a dose inicial seja 80% da anterior. Mudança de produto é decisão do prescritor, com monitoração da glicemia.

Quanto dura uma caneta

Antes de cada aplicação a caneta exige um teste de segurança, que gasta insulina. Na caneta do Toujeo®, o teste usa 3 unidades. A conta da duração precisa incluir esse gasto e, depois, ser confrontada com o prazo de uso da caneta aberta.

CASO

Paciente usa Toujeo® 27 UI uma vez ao dia.

Passo 1: gasto diário: 27 UI + 3 UI do teste = 30 UI.
Passo 2: duração: 450 UI ÷ 30 UI = 15 dias.
Passo 3: prazo após o primeiro uso, segundo a bula: 6 semanas (42 dias), até 30 °C. A caneta acaba antes do prazo.
Passo 4: para 30 dias: 30 × 30 UI = 900 UI = 2 canetas.
Erro típico: ignorar o teste dá 16,7 dias por caneta e leva a subestimar a compra em tratamentos longos.

CASO

Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (1000 UI), 24 UI por dia.

Passo 1: duração pelo volume: 1000 ÷ 24 = 41,6 dias.
Passo 2: prazo depois de aberto, pela bula do Humulin® N: 28 dias.
Conclusão: o frasco deve ser descartado no 28º dia, com cerca de 328 UI ainda dentro. Para 28 dias, 1 frasco; para 60 dias, 3 frascos, um por período de uso.

Produto	Antes de abrir	Em uso
Toujeo® (caneta)	Geladeira, 2 °C a 8 °C	Até 6 semanas (42 dias), até 30 °C, fora da geladeira
Lantus® (frasco e refil)	Geladeira	28 dias; refil na caneta não vai à geladeira
Humulin® N (frasco e refil)	Geladeira	28 dias, abaixo de 30 °C
NovoRapid® (frasco)	Geladeira	4 semanas, entre 15 °C e 30 °C

Agulhas e suspensões

A bula do Toujeo® manda usar agulha nova e estéril a cada injeção: agulha reutilizada entope e pode gerar subdose ou superdose. A caneta é de uso individual, mesmo trocando a agulha. Insulinas em suspensão, como a NPH, precisam ser homogeneizadas antes de cada dose: a bula do Humulin® N orienta rolar o refil entre as palmas e invertê-lo 10 vezes cada, até ficar uniformemente leitoso.

Canetas de agonistas do GLP-1

Nas canetas de semaglutida (Ozempic®), a dose é selecionada em mg e não em unidades. A caneta de 0,25 mg/0,5 mg contém 2 mg e entrega 4 doses de 0,25 mg e 2 de 0,5 mg, ou 4 doses de 0,5 mg; a caneta de 1 mg contém 4 mg e entrega 4 doses. Como a aplicação é semanal, uma caneta dura cerca de 4 semanas na dose de manutenção. A bula avisa: não conte os cliques do seletor, confira a dose no contador. Em uso, a caneta vale 6 semanas, abaixo de 30 °C ou em geladeira.

NO BALCÃO

Pergunte a dose diária, quantas aplicações por dia e qual caneta ou frasco o paciente usa. Calcule a duração incluindo o teste de segurança e compare com o prazo de uso aberto. Confira se o paciente tem agulhas para o período e se descarta caneta e agulha em recipiente rígido. Nunca troque uma insulina por outra de concentração diferente sem nova prescrição.

Erros clássicos e dose que não bate

A maioria dos erros de dose em pediatria segue poucos padrões repetidos. Conhecê-los faz o farmacêutico desconfiar no momento certo. O ponto comum a todos: o farmacêutico confere e questiona, mas não corrige a receita por conta própria.

Erro de 10 vezes

Acontece quando uma vírgula some ou aparece. "2,0 mL" escrito à mão vira "20 mL"; ",5 mL" vira "5 mL". Por isso a boa prática de prescrição dispensa zero à direita (2 mL, não 2,0 mL) e exige zero à esquerda (0,5 mL, não ,5 mL), recomendações difundidas pelo ISMP Brasil. A abreviatura "U" para unidades pode ser lida como zero: "4U" vira 40.

CASO

Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia por 5 dias".

Passo 1: dose: 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg/dia.
Passo 2: por peso: 60 ÷ 10 = 6 mg/kg/dia. A bula do Prelone® indica dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia e máximo de 80 mg/dia.
Passo 3: 2 mL dariam 6 mg/dia (0,6 mg/kg/dia), dentro da faixa. A hipótese é que o prescritor quis escrever 2,0 mL.
Conduta: não dispensar com a orientação de 20 mL nem trocar para 2 mL por conta própria. Ligar para o prescritor, relatar o cálculo e registrar a confirmação.

Concentrações trocadas

O mesmo fármaco existe em concentrações que diferem duas, quatro ou dez vezes. Quando a receita indica um volume ("5 mL") e o produto entregue tem outra concentração, a dose muda na mesma proporção.

- **Amoxicilina** 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL: 5 mL entregam 250 ou 500 mg.
- **Amoxicilina com clavulanato**: o Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL é para 3 tomadas diárias; o Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL é para 2. Trocar um pelo outro altera a dose de amoxicilina, a de clavulanato e o intervalo.
- **Ibuprofeno** gotas de 50, 100 e 200 mg/mL: no Alivium®, cada gota tem 5, 10 ou 20 mg. A orientação "1 gota por quilo" só vale para a de 100 mg/mL.
- **Paracetamol** 200 mg/mL (gotas), 100 mg/mL (bebê, seringa) e 32 mg/mL (criança, copo): 5 mL da suspensão de 100 mg/mL contêm 500 mg, mais de três vezes o que 5 mL da de 32 mg/mL contêm

(160 mg).

- **Cefalexina** 100 mg/mL em gotas e 500 mg/5 mL em suspensão têm a mesma concentração (100 mg/mL), mas uma é medida em gotas e a outra em mL.
- **Prednisolona** 3 mg/mL (solução) e 11 mg/mL (gotas).

Dipirona em lactente

A dipirona é contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg (bula da Novalgina®). Na faixa de 5 a 8 kg, a dose é de 2 a 5 gotas da solução de 500 mg/mL (50 a 125 mg), até 20 gotas por dia. O erro grave é dar "1 mL" das gotas: são 500 mg, quatro vezes a maior dose única da faixa e o total diário inteiro de uma vez. Outro erro é usar o número de gotas da solução de 500 mg/mL com a solução infantil de 50 mg/mL, que é medida em mL.

mg e mL na mesma receita

"Dar 250" sem unidade, "5 mg" quando o prescritor quis dizer 5 mL, ou a dose em mg sem a concentração do produto são falhas de prescrição. Se a receita traz a dose em mg, o farmacêutico calcula o volume para o produto entregue e escreve o volume na embalagem. Se traz a dose em mL, precisa saber de qual concentração.

CASO

Receita: "dipirona gotas, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg.

Passo 1: Novalgina® gotas: 25 mg por gota; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose.
Passo 2: a tabela da bula para 9 a 15 kg indica 3 a 10 gotas por dose (75 a 250 mg) e até 40 gotas por dia.
Passo 3: 12 gotas por dose passam da faixa e 48 gotas por dia passam do máximo diário.
Conduta: contatar o prescritor antes de orientar a dose.

O que fazer quando a dose não bate

1. Refazer a conta pelo caminho inverso e conferir peso, concentração e intervalo.
2. Comparar com a faixa e os tetos da bula do produto entregue.
3. Se houver divergência, contatar o prescritor pelo telefone da receita, relatar o cálculo e perguntar qual era a intenção.
4. Registrar a intervenção: o que foi constatado, com quem falou, horário e conduta confirmada.
5. Se não conseguir contato e a dose for de risco, não dispensar a dose duvidosa; orientar o retorno ao prescritor ou à unidade de saúde. Se a criança estiver com sinais de gravidade, encaminhar para atendimento.

ATENÇÃO

O farmacêutico não altera dose, concentração ou intervalo por conta própria, ainda que a correção pareça óbvia. A receita é ato do prescritor; a conferência é ato do farmacêutico. Uma "correção" silenciosa pode estar errada (a criança pode ter peso diferente do informado, a dose pode ser intencional) e retira do prescritor a chance de rever o raciocínio.

NO BALCÃO

Explique ao cuidador, sem alarmar, que a farmácia precisa confirmar um detalhe da dose com o médico. Evite frases que soem como acusação de erro. Depois da confirmação, escreva a dose em mL ou gotas na embalagem e repita a orientação.

Peso, idade e superfície corporal

Toda dose pediátrica parte de uma medida do corpo. A bula escolhe qual medida usar conforme o fármaco e o que foi estudado: peso, idade ou superfície corporal. O farmacêutico precisa reconhecer qual delas a receita seguiu, conferir se a medida informada é atual e saber arredondar o resultado para algo que o cuidador consiga medir em casa.

Três formas de individualizar a dose

Medida	Como aparece na bula	Exemplos de balcão
Peso	mg/kg por dose ou por dia; gotas/kg	Antitérmicos, amoxicilina, cefalexina, azitromicina, ferro
Idade (faixas fixas)	Volume ou comprimido por faixa etária	Sulfametoxazol + trimetoprima, anti-helmínticos, antialérgicos (tabela de dose fixa da parte anterior)
Faixa de peso	Dose fixa para cada intervalo de peso	Dipirona gotas (Novalgina®: 5 a 8 kg, 9 a 15 kg, 16 a 23 kg)
Superfície corporal (SC)	mg/m²	Antineoplásicos orais, alguns imunossupressores; raro na drogaria, comum na farmácia que atende oncologia

Dose por idade é uma aproximação feita para facilitar a vida do cuidador: a bula supõe que a criança tenha o peso médio daquela idade. Quando o peso real foge muito da média, a tabela por idade erra junto. Por isso, sempre que a bula oferecer também a dose por peso, a conferência deve ser feita pelo peso.

Superfície corporal

A superfície corporal reflete melhor do que o peso o metabolismo basal, e por isso é usada para fármacos de margem terapêutica estreita. A fórmula mais usada é a de Mosteller (1987):

PONTO-CHAVE

SC (m²) = raiz quadrada de [altura (cm) × peso (kg) ÷ 3600]. A conta exige altura e peso medidos; idade não entra.

CASO

Criança com 110 cm e 20 kg. A receita traz um fármaco na dose de 100 mg/m² por dia.

Passo 1: 110 × 20 = 2200.
Passo 2: 2200 ÷ 3600 = 0,611.
Passo 3: raiz quadrada de 0,611 = 0,78 m².
Passo 4: dose diária: 100 mg/m² × 0,78 m² = 78 mg.
Conferência: um adulto de 170 cm e 70 kg tem SC de 1,82 m². A criança tem cerca de 43% da superfície do adulto, embora pese 29% do que ele pesa. Por isso doses por m² e por kg não são intercambiáveis.

Peso real e peso ideal na criança com obesidade

Na criança com excesso de peso, a dose calculada pelo peso real pode ficar alta, porque gordura e músculo não distribuem os fármacos do mesmo jeito. Fármacos lipofílicos tendem a ter volume de distribuição maior no obeso; os hidrofílicos podem ter volume maior ou menor, e a depuração hepática pode cair por infiltração gordurosa do fígado. Há poucos estudos pediátricos que definam, fármaco a fármaco, qual peso usar.

O posicionamento do Pediatric Pharmacy Advocacy Group (Matson e colaboradores, 2017) é a referência mais citada e traz três regras práticas:

- abaixo de 18 anos e de 40 kg, usar a dose por peso;
- a partir de 40 kg, ainda pode-se usar a dose por peso, **desde que não ultrapasse a dose de adulto** para a mesma indicação;
- para fármacos de margem estreita, o ajuste deve se apoiar em farmacocinética e no acompanhamento do prescritor.

Algumas referências pediátricas sugerem peso ideal ou peso ajustado para certos fármacos. Essa escolha é do prescritor. No balcão, a conferência do farmacêutico tem dois pontos firmes: a dose por quilo deve estar dentro da faixa da bula para o peso usado, e o resultado não pode passar do teto por tomada e por dia.

CASO

Menino de 8 anos com 45 kg. A pediatra anotou que o peso esperado para a altura dele seria de 26 kg. A mãe pede paracetamol para febre e quer saber a dose máxima do dia.

Passo 1: pelo peso real: 45 kg × 15 mg/kg = 675 mg por tomada; teto diário de 75 mg/kg: 45 × 75 = 3375 mg.
Passo 2: pelo peso esperado: 26 kg × 15 mg/kg = 390 mg por tomada; 26 × 75 = 1950 mg por dia.
Passo 3: tetos da bula do Tylenol®: 1000 mg por tomada, 4000 mg por dia e 75 mg/kg/dia. As duas contas ficam abaixo dos tetos absolutos.
Conduta: sem orientação escrita do pediatra, oriente a dose pela faixa de 10 a 15 mg/kg do peso real no limite inferior (10 mg/kg = 450 mg), sem passar de 5 tomadas ao dia e de 3375 mg, e pergunte se o pediatra já definiu um peso de cálculo. Se ele definiu, siga-o.

Arredondamento seguro de volume

Arredondar é escolher um volume que o dosador consegue medir e que mantém a dose dentro da faixa. Três regras evitam erro:

1. Arredonde para a graduação do dosador entregue (seringa de 0,1 mL, de 0,2 mL ou copo de 2,5 mL).
2. Quando o valor calculado estiver perto do teto, arredonde para baixo.
3. Depois de arredondar, refaça a conta de mg/kg com o volume final.

CASO

Criança de 13 kg, febre alta, ibuprofeno suspensão 30 mg/mL, dose de 10 mg/kg.

Passo 1: 13 × 10 = 130 mg.
Passo 2: 130 ÷ 30 = 4,33 mL.
Passo 3: com seringa graduada de 0,1 mL: 4,3 mL = 129 mg (9,9 mg/kg). Com seringa graduada de 0,5 mL, 4,5 mL dariam 135 mg (10,4 mg/kg), acima do topo da faixa; 4 mL dão 120 mg (9,2 mg/kg), dentro da faixa.
Conclusão: 4,3 mL na seringa fina ou 4 mL na de 0,5 mL. Nunca 4,5 mL.

Comprimido: partir ou não partir

Quando a dose cai entre dois comprimidos, a tentação é partir. Partir só é seguro quando a bula do produto autoriza. O sulco nem sempre serve para dividir a dose: em alguns produtos ele só facilita engolir, e as metades saem desiguais. O cortador de comprimidos melhora a precisão, mas não corrige um comprimido que não foi desenhado para ser dividido.

Tipo	Pode partir?	Por quê
Comprimido simples com sulco de partição declarado na bula	Sim, pelo sulco	Metades com teor equivalente, conforme a bula

Tipo	Pode partir?	Por quê
Comprimido simples sem sulco	Só se a bula permitir	Metades desiguais; risco em margem estreita
Revestido gastrorresistente (entérico)	Não	O revestimento protege o fármaco do ácido ou o estômago do fármaco
Liberação prolongada ou modificada (siglas como XR, LP, CR, retard)	Não, salvo se a bula disser o contrário	Quebrar libera de uma vez a dose de horas: risco de toxicidade
Revestido só por sabor ou cor	Conforme a bula	Pode amargar ou manchar, sem perda de efeito; confirme no texto

CASO

Criança de 28 kg com receita de prednisolona 1 mg/kg/dia por 5 dias. A família prefere comprimido.

Passo 1: 28 × 1 = 28 mg/dia.
Passo 2: com um comprimido de 20 mg cuja bula declara sulco de partição: 1,5 comprimido = 30 mg (1,07 mg/kg). Com a solução de 3 mg/mL: 28 ÷ 3 = 9,3 mL.
Passo 3: os dois caminhos ficam abaixo do teto de 80 mg/dia da bula do Prelone®.
Conduta: a diferença entre 28 e 30 mg é pequena, mas a troca de forma farmacêutica e a dose arredondada precisam do aval do prescritor, que escreveu a dose em mg/kg.

ATENÇÃO

Triturar ou abrir comprimido de liberação prolongada para dar a uma criança ou a um idoso com dificuldade de engolir pode causar intoxicação. Se o paciente não consegue engolir, procure uma forma líquida ou outro produto e fale com o prescritor.

NO BALCÃO

Pergunte peso e altura, quando foram medidos e se a pediatra definiu um peso de cálculo. Anote o peso usado na receita ou no sistema. Ao arredondar, mostre ao cuidador a marca exata no dosador e explique por que não se deve "completar um pouco mais". Antes de orientar a partir um comprimido, leia a bula daquele produto.

Febre e dor na criança

Febre é uma das queixas mais frequentes no balcão, e quase sempre chega com uma pergunta de dose. O documento científico "Manejo da febre aguda" da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, Departamentos de Pediatria Ambulatorial e de Infectologia, 2021) é a referência nacional mais recente localizada e orienta o que o farmacêutico deve repetir ao cuidador: tratar o desconforto, usar um antitérmico por vez, na dose certa, e avaliar a criança como um todo.

Quando dar antitérmico

Para a SBP (2021), febre é temperatura axilar acima de 37,2 °C a 37,3 °C, medida de preferência com termômetro digital na axila. O antitérmico é indicado quando a febre vem com desconforto evidente: choro intenso, irritabilidade, menos atividade, perda de apetite, sono alterado. O documento recomenda não fixar um número de temperatura para medicar. Métodos físicos (banho, compressas) não são recomendados, salvo na hipertermia (temperatura central de 40 °C ou mais com alteração neurológica). O antitérmico também não previne convulsão febril e não deve ser dado de rotina antes de vacinas.

Doses por peso e por tomada

Fármaco	Dose por tomada	Intervalo e máximo	Idade mínima	Fonte
Paracetamol	10 a 15 mg/kg	4 a 6 horas; até 5 tomadas em 24 h; até 75 mg/kg/dia, 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia	Abaixo de 11 kg ou 2 anos: só com orientação médica (Tylenol®); único recomendado abaixo de 1 mês (SBP)	SBP 2021; bula do Tylenol®
Dipirona	10 a 12 mg/kg (SBP); bula por faixa de peso	Até 4 tomadas ao dia (6 em 6 horas); 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia são a dose de adulto	Contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg	SBP 2021; bula da Novalgina®
Ibuprofeno	5 mg/kg (febre baixa) a 10 mg/kg (febre alta)	6 em 6 ou 8 em 8 horas; criança: até 200 mg por tomada e 800 mg/dia	A partir de 6 meses	SBP 2021; bula do Alivium®

A calculadora da parte anterior usa para a dipirona a faixa de 10 a 15 mg/kg por tomada. A SBP (2021) preconiza 10 a 12 mg/kg, e o guia de dengue do Ministério da Saúde (2024) usa 10 mg/kg. Na prática, a conferência fica mais segura no limite inferior e sempre dentro da tabela da bula do produto. A SBP chama atenção para um costume: "1 gota por quilo" de dipirona gotas (25 mg por gota na Novalgina®) entrega 25 mg/kg, mais que o dobro da dose, com risco de hipotensão, hipotermia e sudorese.

CASO

Criança de 14 kg com febre e choro. A mãe quer dar dipirona gotas 500 mg/mL "1 gota por quilo", como fazia a avó.

Passo 1: dose pela SBP: 14 × 10 = 140 mg a 14 × 12 = 168 mg.
Passo 2: na Novalgina® (20 gotas/mL), cada gota tem 25 mg: 140 ÷ 25 = 5,6 e 168 ÷ 25 = 6,7. Dose: 6 gotas (150 mg, 10,7 mg/kg).
Passo 3: a tabela da bula para 9 a 15 kg aceita 3 a 10 gotas por tomada; 6 gotas estão dentro.
Passo 4: o hábito da família: 14 gotas = 350 mg = 25 mg/kg, acima da faixa da bula e mais que o dobro da faixa da SBP.
Orientação: 6 gotas, até de 6 em 6 horas, no máximo 4 vezes ao dia.

Alternância de antitérmicos

PONTO-CHAVE

A SBP (2021) é direta: "o uso alternado ou associado de antitérmicos não é recomendado". Os três fármacos agem pelo mesmo mecanismo (inibição da síntese de prostaglandina E2), a alternância não traz benefício clínico e confunde o cuidador, o que multiplica o risco de superdose.

Um estudo brasileiro citado pela SBP mostrou que 26,7% dos cuidadores alternavam antitérmicos, muitas vezes por orientação profissional, e que, em média, consideravam febre 37,4 °C. O mesmo documento relata que 43,3% das crianças avaliadas em outro estudo receberam subdose, principalmente de paracetamol, em parte porque os gotejadores das cópias entregam gotas menores que as do produto de referência. A conduta segura é escolher um antitérmico, dar a dose correta para o peso e respeitar o intervalo.

CASO

Pai de criança de 12 kg conta que, desde ontem, dá dipirona e ibuprofeno "um a cada 3 horas, para a febre não voltar".

Passo 1: em 24 horas, uma tomada a cada 3 horas soma 8 tomadas: 4 de dipirona e 4 de ibuprofeno.
Passo 2: o ibuprofeno a cada 6 horas está no limite do intervalo da bula; se a dose foi de 10 mg/kg (120 mg), o total de 480 mg/dia está abaixo de 800 mg.
Passo 3: o problema maior é a exposição dupla: dois fármacos, oito tomadas e nenhuma pausa para observar a criança.
Conduta: orientar um único antitérmico na dose do peso, explicar que a febre pode voltar entre as doses e investigar os sinais de alerta abaixo. Febre que persiste há mais de 3 dias pede avaliação médica, e a bula do ibuprofeno limita o uso para febre a 3 dias sem orientação médica.

Sinais de alerta para encaminhar

A SBP (2021) lembra que a intensidade da febre não diferencia infecção grave de leve, exceto em lactentes abaixo de 3 meses. O que diferencia é o estado geral. Encaminhe para avaliação médica no mesmo dia, e com urgência se houver mais de um sinal:

- lactente abaixo de 3 meses com febre (abaixo de 1 mês, paracetamol é o único antitérmico recomendado, e só com avaliação médica);
- criança prostrada, pouco responsiva ou difícil de acordar, mesmo depois que a febre baixa;
- respiração rápida (acima de 50 por minuto entre 6 e 12 meses, acima de 40 depois de 1 ano) ou saturação de oxigênio de 95% ou menos, quando medida;
- frequência cardíaca muito alta para a idade (160 ou mais abaixo de 12 meses, 150 ou mais entre 12 e 24 meses, 140 ou mais de 2 a 5 anos);
- enchimento capilar acima de 3 segundos, mucosas secas, pouca urina, recusa de líquidos;
- convulsão, febre há mais de 3 dias ou doença crônica de base.

Dengue: o que muda

Na suspeita de dengue, o guia "Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança" (Ministério da Saúde, 6ª edição, 2024) manda prescrever paracetamol e/ou dipirona e não usar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides nem corticosteroides, porque aumentam o risco de sangramento. O ácido acetilsalicílico já não é recomendado como antitérmico em criança pela SBP (2021), por causa da síndrome de Reye.

Fármaco	Criança	Adulto
Dipirona	10 mg/kg/dose até de 6 em 6 horas	500 mg (20 gotas ou 1 comprimido) até de 6 em 6 horas
Paracetamol	10 mg/kg/dose até de 6 em 6 horas	500 mg de 4 em 4 horas ou 1000 mg até de 6 em 6 horas; não passar de 4 g em 24 horas

O mesmo apêndice informa "1 mL = 20 gotas" para o paracetamol 200 mg/mL. Essa equivalência não vale para todos os frascos: o gotejador do Tylenol® entrega 14 a 16 gotas por mL. Calcule as gotas com o número da bula do produto entregue.

CASO

Criança de 16 kg com febre há 2 dias e dor no corpo, em bairro com casos de dengue. A mãe pede ibuprofeno.

Passo 1: ibuprofeno não é indicado na suspeita de dengue (MS, 2024).
Passo 2: paracetamol 10 mg/kg: 16 × 10 = 160 mg.
Passo 3: Tylenol® gotas 200 mg/mL: 160 ÷ 200 = 0,8 mL; com cerca de 15 gotas/mL, 0,8 × 15 = 12 gotas.
Passo 4: se alguém usar "20 gotas por mL", calcula 16 gotas, que no gotejador do Tylenol® entregam cerca de 213 mg (13,3 mg/kg).
Orientação: 12 gotas até de 6 em 6 horas, hidratação oral reforçada e procura imediata de atendimento diante de sinal de alarme.

ATENÇÃO

Sinais de alarme da dengue (MS, 2024): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, tontura ao levantar ou desmaio, fígado aumentado, sangramento de mucosa (gengiva, nariz), sonolência ou irritabilidade. Com qualquer um deles, a orientação é procurar atendimento de urgência, não trocar de antitérmico.

NO BALCÃO

Pergunte idade, peso, há quanto tempo há febre, como a criança está entre os picos, o que já tomou, em que dose e em que horário. Escreva no papel o nome do antitérmico escolhido, o número de gotas ou mL, o intervalo mínimo e o máximo de tomadas no dia. Desaconselhe a alternância e explique o motivo. Se houver sinal de alerta, encaminhe por escrito.

Antimicrobianos pediátricos

Antibiótico pediátrico é o cálculo de maior impacto na drogaria: a dose errada para baixo leva a falha de tratamento e favorece resistência; para cima, aumenta efeitos adversos. A conferência tem quatro partes: a dose por quilo está dentro da faixa para a indicação, a duração faz sentido, a quantidade de frascos cobre o tratamento e a receita cumpre a RDC 471/2021.

Dose padrão e dose alta de amoxicilina

A bula do Amoxil® indica, para crianças abaixo de 40 kg, 20 a 50 mg/kg/dia em doses divididas de 8 em 8 horas, com possibilidade de até 150 mg/kg/dia. A mesma bula cita 80 a 90 mg/kg/dia em duas tomadas como primeira escolha na otite média aguda. Essa dose alta vem da diretriz de otite média aguda da American Academy of Pediatrics (AAP, 2013) e existe para vencer o pneumococo com sensibilidade reduzida à penicilina.

Situação	Dose de amoxicilina	Fonte
Infecções em geral (abaixo de 40 kg)	20 a 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas	Bula do Amoxil®
Otite média aguda	80 a 90 mg/kg/dia, em 2 tomadas	AAP, 2013; citada na bula do Amoxil®
Otite com uso de amoxicilina nos últimos 30 dias, conjuntivite associada ou falha em 48 a 72 h	Amoxicilina + clavulanato: 90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato (proporção 14:1), em 2 tomadas	AAP, 2013
Sinusite bacteriana aguda	Amoxicilina, com ou sem clavulanato; dose padrão ou dose alta conforme o risco de resistência	AAP, 2013
A partir de 40 kg	Posologia de adulto	Bula do Amoxil®

Duração na otite média aguda pela AAP (2013): 10 dias abaixo de 2 anos e em quadro grave; 7 dias de 2 a 5 anos com quadro leve ou moderado; 5 a 7 dias a partir de 6 anos com quadro leve ou moderado. Para sinusite, a AAP (2013) relata recomendações de 10 a 28 dias e uma alternativa prática: manter até 7 dias depois da melhora, com no mínimo 10 dias. A duração é definida pelo prescritor; ao farmacêutico cabe conferir se a quantidade dispensada cobre os dias escritos.

ATENÇÃO

O Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL tem proporção 7:1, e a bula vai até 70 mg/kg/dia de amoxicilina (45 a 70 mg/kg/dia na dose alta). Uma receita de "90 mg/kg/dia" com esse produto dobra o clavulanato em relação ao esquema 14:1 estudado pela AAP e passa da faixa da bula. Confirme com o prescritor; uma saída comum é associar amoxicilina pura para completar a dose de amoxicilina, o que é decisão dele.

Da dose ao número de frascos

CASO

Criança de 16 kg com otite média aguda. Receita: amoxicilina suspensão 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias.

Passo 1: dose diária: 16 × 90 = 1440 mg.
Passo 2: por tomada: 1440 ÷ 2 = 720 mg.
Passo 3: concentração: 500 ÷ 5 = 100 mg/mL; volume: 720 ÷ 100 = 7,2 mL por tomada.
Passo 4: volume total: 7,2 × 2 × 10 = 144 mL.
Passo 5: frasco de 150 mL: 1 frasco, com sobra de 6 mL. A suspensão vale 14 dias em geladeira (Amoxil®), mais que os 10 dias de uso.

CASO

Criança de 20 kg, mesma receita (90 mg/kg/dia, 500 mg/5 mL, 12 em 12 horas, 10 dias).

Passo 1: 20 × 90 = 1800 mg/dia; 900 mg por tomada; 9 mL por tomada.
Passo 2: total: 9 × 2 × 10 = 180 mL.
Passo 3: 180 ÷ 150 = 1,2: são 2 frascos. O primeiro dura 8 dias (144 mL), dentro dos 14 dias de validade; o segundo é preparado no 9º dia.
Conferência legal: a quantidade escrita na receita precisa ser 2 frascos. Se estiver "1 frasco", contate o prescritor.

Receita: validade, retenção e quantidade

O QUE DIZ A NORMA

A receita de antimicrobiano vale 10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º, para o qual remete o art. 7º da RDC 471/2021), é prescrita em 2 vias com posologia e quantidade em algarismos arábicos (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único), e a dispensação deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito" (art. 11). A segunda via fica retida na farmácia.

O detalhamento das regras de receita, escrituração e tratamento prolongado está no módulo da RDC 471. No cálculo, o que importa é conferir que a quantidade escrita e a quantidade calculada pela posologia batem, e que a receita ainda está no prazo no dia da dispensação.

Dose abaixo ou acima da faixa

Antes de concluir que a dose está errada, identifique a indicação (a receita nem sempre traz) e qual faixa da bula vale para ela. Uma amoxicilina de 50 mg/kg/dia está correta para amigdalite e baixa para otite em que o prescritor quis dose alta; 90 mg/kg/dia é correta na otite e alta para uma infecção urinária simples.

1. Calcule mg/kg/dia e mg por tomada com o peso atual.
2. Compare com a faixa da bula e, quando a indicação for conhecida, com a diretriz citada.

3. Confira os tetos: dose de adulto a partir de 40 kg (amoxicilina) e máximos por tomada e por dia.
4. Se a dose estiver abaixo da faixa: subdose de antibiótico aumenta o risco de falha do tratamento. Contate o prescritor.
5. Se estiver acima: veja se cabe em alguma indicação de dose alta. Se não couber, contate o prescritor.
6. Registre a intervenção e a resposta.

CASO

Criança de 22 kg, receita de cefalexina 250 mg/5 mL, 5 mL de 12 em 12 horas por 7 dias, para infecção de pele.

Passo 1: 5 mL × 50 mg/mL = 250 mg por tomada; 500 mg/dia.
Passo 2: 500 ÷ 22 = 22,7 mg/kg/dia.
Passo 3: a bula do Keflex® indica 25 a 50 mg/kg/dia e admite divisão de 12 em 12 horas em infecção de pele. A dose está pouco abaixo do mínimo.
Conduta: a diferença é de 10%, mas é subdose. Ligue para o prescritor, informe o peso e pergunte se ele quer ajustar para 6 mL (300 mg, 27,3 mg/kg/dia).

NO BALCÃO

Pergunte o peso e para que foi receitado. Faça a conta de mg/kg/dia antes de buscar o produto. Diga ao cuidador quantos frascos o tratamento exige e quantos dias dura cada um. Explique que o antibiótico vai até o último dia escrito, mesmo que a criança melhore antes, e que a sobra vai para o ponto de coleta.

Sal, base e elemento

Muitos fármacos são vendidos como sal (cloridrato, sulfato, fumarato, besilato) ou como complexo, e a dose pode estar escrita em três jeitos: massa do sal, massa da base (a molécula ativa sem o contra-íon) ou massa do elemento (ferro, cálcio, potássio). Quando a receita usa um jeito e o rótulo outro, a dose real pode mudar duas, três ou cinco vezes.

Como ler a embalagem

- **"Equivalente a"**: "cloridrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina base" (bula do Zoloft®). A dose da receita é a da base.
- **"Contém X mg de ferro elementar"** ou **"de Fe III"**: o número de ferro já foi calculado pelo fabricante.
- **Só o nome do sal com a massa**: "carbonato de cálcio 1250 mg". A massa é do sal; o elemento vem descrito em outra linha, às vezes só na bula.

PONTO-CHAVE

Massa do elemento = massa do sal × fração do elemento. Massa do sal = massa do elemento ÷ fração. Antes de calcular, descubra se o número da receita é do sal, da base ou do elemento.

Ferro

As doses de ferro em diretriz e em receita são em **ferro elementar**. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (Ministério da Saúde, 2013) usa 1 mg de ferro elementar/kg/dia para crianças de 6 a 24 meses e 40 mg de ferro elementar por dia para gestantes, e cita para tratamento da anemia 3 mg/kg/dia na criança abaixo de 2 anos, sem passar de 60 mg/dia, e 120 mg/dia no adulto (OMS, 2001). O Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes (Ministério da Saúde, 2022) reorganizou a suplementação infantil em ciclos; confira o esquema vigente no documento oficial antes de orientar profilaxia.

Sal ou complexo	Ferro por massa do sal	Exemplo de rótulo
Sulfato ferroso heptaidratado	Cerca de 20%	200 mg de sal = 40 mg de ferro
Sulfato ferroso seco	Cerca de 30% a 33%, conforme a hidratação	Rótulo traz o ferro elementar
Fumarato ferroso	Cerca de 33%	Rótulo traz o ferro elementar
Gluconato ferroso	Cerca de 12%	Rótulo traz o ferro elementar
Glicinato férrico (ferro quelato)	Varia com o sal; no Neutrofer® gotas, 20% (250 mg/mL = 50 mg/mL de ferro)	Neutrofer®: 2,5 mg de ferro por gota
Ferripolimaltose (hidróxido férrico polimaltosado)	Rótulo em ferro III	Noripurum® gotas: 50 mg/mL de ferro, 2,5 mg por gota

As gotas de ferro são o ponto de maior confusão, porque o número de gotas por mL e a concentração mudam entre produtos:

Produto	Ferro por mL	Gotas por mL	Ferro por gota
Sulfato ferroso gotas (genérico cuja bula foi consultada)	25 mg	25	1 mg
Noripurum® gotas (ferripolimaltose)	50 mg	20	2,5 mg
Neutrofer® gotas (glicinato férrico)	50 mg	20	2,5 mg

CASO

Criança de 10 kg com anemia. Receita: "ferro elementar 3 mg/kg/dia". A família comprou da primeira vez sulfato ferroso gotas (25 mg/mL, 25 gotas/mL) e agora quer levar Neutrofer® gotas "porque mancha menos".

Passo 1: dose: 10 × 3 = 30 mg de ferro por dia.
Passo 2: sulfato ferroso: 1 mg por gota, então 30 gotas.
Passo 3: Neutrofer®: 2,5 mg por gota, então 30 ÷ 2,5 = 12 gotas.
Passo 4: se a mãe mantiver 30 gotas com o produto novo: 30 × 2,5 = 75 mg/dia, 7,5 mg/kg, acima do teto de 60 mg/dia citado pelo PNSF.
Conduta: a troca de produto pede novo cálculo de gotas, escrito na caixa, e de preferência ciência do prescritor.

Cálcio

Pela composição química, o carbonato de cálcio tem 40% de cálcio elementar e o citrato de cálcio tetraidratado, cerca de 21%. Um comprimido de 1250 mg de carbonato fornece 500 mg de cálcio. Para os mesmos 500 mg com citrato, são necessários cerca de 2380 mg do sal. A orientação de tomada também difere: o carbonato precisa de ácido gástrico e vai melhor junto da refeição, enquanto o citrato é absorvido com ou sem alimento, o que favorece quem usa inibidor de bomba de prótons. Doses de cálcio costumam ser divididas em tomadas de até 500 mg de elemento, porque a fração absorvida cai com doses maiores.

Vitamina D

PONTO-CHAVE

Por definição, 1 mcg de colecalciferol = 40 UI. De UI para mcg, divida por 40; de mcg para UI, multiplique por 40. 1000 UI = 25 mcg; 7000 UI = 175 mcg; 50.000 UI = 1250 mcg.

A vitamina D aparece em UI nas receitas e, cada vez mais, em mcg nos rótulos de suplementos. Os produtos vão de gotas com poucas centenas de UI a cápsulas de 50.000 UI. O erro grave é de frequência: 50.000 UI por semana é esquema comum de reposição, e a mesma cápsula tomada todos os dias dá 350.000 UI por semana.

CASO

Receita: "colecalciferol 7000 UI, 1 vez por semana". A farmácia tem cápsulas rotuladas como 175 mcg e gotas com 200 UI por gota.

Passo 1: 7000 ÷ 40 = 175 mcg. A cápsula de 175 mcg corresponde a 7000 UI: 1 cápsula por semana.
Passo 2: em gotas: 7000 ÷ 200 = 35 gotas por semana, ou 5 gotas por dia (1000 UI/dia), se o prescritor aceitar o fracionamento diário.
Orientação: escrever na caixa "1 cápsula por semana, no mesmo dia". A troca para gotas diárias é decisão do prescritor.

Potássio e outros sais

O cloreto de potássio tem massa molar de 74,55 g/mol: 1 g de KCl contém cerca de 13,4 mEq de potássio. O xarope a 6% tem 60 mg/mL; 15 mL contêm 900 mg de KCl, cerca de 12 mEq. Receita em mEq e produto em mg (ou o contrário) pedem essa conversão.

Fármaco	Dose expressa em	Observação
Sertralina (cloridrato)	Base	50 mg de base correspondem a cerca de 56 mg do cloridrato (cálculo pela massa molar)
Anlodipino (besilato)	Base	Rótulo: "besilato de anlodipino equivalente a 5 mg de anlodipino"
Prednisolona (fosfato sódico)	Base	1 mg de prednisolona = 1,34 mg de fosfato sódico (Prelone®)
Metformina (cloridrato)	Sal	"Cloridrato de metformina 850 mg"
Losartana (potássica)	Sal	"Losartana potássica 50 mg"
Levotiroxina (sódica)	Sal, em mcg	"Levotiroxina sódica 50 mcg"

Na troca entre marcas, confira se as duas embalagens expressam a dose do mesmo jeito. A conferência fica crítica quando se manipula, quando se troca de sal (por exemplo, fumarato por sulfato ferroso) e quando a receita vem de outro país.

ATENÇÃO

Ferro é causa clássica de intoxicação acidental em criança pequena. Oriente guardar fora do alcance e longe de vitaminas infantis com sabor, e nunca dobrar a dose esquecida.

NO BALCÃO

Ao dispensar ferro, cálcio, vitamina D ou potássio, leia em voz alta, com o cliente, a linha do rótulo que diz quanto de elemento ou de UI há por gota, comprimido ou mL. Se a receita não diz se a dose é do sal ou do elemento, pergunte ao prescritor. Ao trocar de marca, refaça a conta e escreva a nova orientação na embalagem.

Função renal e idoso

Fármacos eliminados pelos rins se acumulam quando a filtração glomerular cai. A dose que era segura passa a produzir concentrações maiores e mais efeitos adversos: hipoglicemia, sangramento, confusão mental, hipercalemia. Idosos concentram o problema, porque a filtração cai com a idade e porque costumam usar vários medicamentos ao mesmo tempo.

Por que a creatinina "normal" engana no idoso

A creatinina sérica vem do músculo. Uma idosa magra produz pouca creatinina, e o valor no exame pode ficar dentro da referência do laboratório mesmo com filtração reduzida. Por isso a dose se decide pela taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), que corrige a creatinina por idade e sexo, e nunca pela creatinina isolada.

CKD-EPI 2021

A equação CKD-EPI 2021 para creatinina (Inker e colaboradores, 2021) foi reajustada sem o coeficiente de raça, e a diretriz KDIGO 2024 recomenda não usar raça no cálculo. O resultado sai em mL/min/1,73 m². Muitos laboratórios já liberam a TFGe no laudo; confira qual equação foi usada.

PONTO-CHAVE

$TFGe = 142 \times \min(Cr/\kappa; 1)^{\alpha} \times \max(Cr/\kappa; 1)^{-1,200} \times 0,9938^{idade} \times 1,012$ (se mulher). Cr em mg/dL; κ = 0,7 (mulher) ou 0,9 (homem); α = −0,241 (mulher) ou −0,302 (homem). Use calculadora validada; o importante no balcão é saber ler o resultado.

Paciente	Creatinina	TFGe (CKD-EPI 2021)
Mulher, 80 anos	0,8 mg/dL	74 mL/min/1,73 m²
Mulher, 82 anos	1 mg/dL	56 mL/min/1,73 m²
Mulher, 78 anos	1,3 mg/dL	42 mL/min/1,73 m²
Mulher, 80 anos	1,4 mg/dL	38 mL/min/1,73 m²
Homem, 70 anos	1,5 mg/dL	50 mL/min/1,73 m²
Homem, 74 anos	2 mg/dL	34 mL/min/1,73 m²

A tabela mostra o efeito da idade: com creatinina de 1 mg/dL, valor que muitos consideram normal, a idosa de 82 anos já tem filtração abaixo de 60.

Clearance de creatinina nas bulas

Muitas bulas, sobretudo as antigas, dão o ajuste em "clearance de creatinina" (mL/min), porque os estudos de farmacocinética usaram a fórmula de Cockcroft-Gault. A KDIGO 2024 reconhece essa inconsistência, aponta os problemas daquela fórmula (criada antes da padronização da creatinina, sem mulheres e sem negros na amostra, dependente de um peso alterado por edema e obesidade) e orienta: para a maioria das pessoas e situações, equações validadas de TFGe com creatinina servem para ajustar dose (KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.2). Agências reguladoras passaram a aceitar qualquer equação contemporânea de TFG em estudos de farmacocinética.

Na prática da farmácia:

- use a TFGe do laudo (CKD-EPI 2021) como valor de referência para comparar com o limite da bula ou da diretriz;
- em pessoas muito pequenas ou muito grandes, e em fármacos de margem estreita, converta para TFGe não indexada (mL/min): TFGe × SC ÷ 1,73 (KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.4);
- quando o resultado ficar perto do limite, ou a função renal estiver mudando (desidratação, doença aguda), não decida sozinho: fale com o prescritor.

CASO

Mulher de 78 anos, 45 kg e 155 cm, creatinina 1,3 mg/dL, TFGe de 42 mL/min/1,73 m² no laudo.

Passo 1: SC (Mosteller): raiz de (155 × 45 ÷ 3600) = 1,39 m².
Passo 2: TFGe não indexada: 42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8 mL/min.
Conclusão: por ser pequena, a filtração real dela, em mL/min, é menor do que o número do laudo sugere. Para um fármaco com corte em 30 mL/min, a margem é estreita.

Ajustes comuns no balcão

Fármaco	Função renal	Conduta	Fonte
Metformina	TFGe 30 a 59	Dose inicial 500 ou 850 mg/dia; máximo 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar risco e benefício	Bula do Glifage®
Metformina	TFGe abaixo de 30	Contraindicada; interromper	Bula do Glifage®
Nitrofurantoína	Insuficiência renal moderada (bula); CrCl abaixo de 30 (Beers)	Bula: contraindicada; Beers: evitar	Bula da Macrodantina®; AGS Beers 2023
AINE (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, celecoxibe)	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Gabapentina e pregabalina	CrCl abaixo de 60	Reduzir a dose	AGS Beers 2023
Ciprofloxacino	CrCl abaixo de 30	Reduzir a dose usual	AGS Beers 2023
Sulfametoxazol + trimetoprima	CrCl 15 a 29; abaixo de 15	Reduzir; evitar	AGS Beers 2023
Espironolactona	CrCl abaixo de 30	Evitar (hipercalemia)	AGS Beers 2023
Tramadol	CrCl abaixo de 30	Liberação imediata: reduzir; prolongada: evitar	AGS Beers 2023

Os Critérios de Beers da American Geriatrics Society (2023) se aplicam a pessoas de 65 anos ou mais e expressam os cortes em clearance de creatinina; a tabela completa está no material de apoio. A bula

brasileira continua sendo o documento legal do produto. Quando bula e diretriz divergem, como na nitrofurantoína, prevalece a conduta mais segura e a decisão compartilhada com o prescritor.

CASO

Mulher de 80 anos, TFGe 38 mL/min/1,73 m² em exame do mês passado, com receita nova de metformina 850 mg duas vezes ao dia.

Passo 1: dose prescrita: 1700 mg/dia.
Passo 2: bula do Glifage®: entre 30 e 59, máximo de 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar a continuidade; função renal a cada 3 meses entre 30 e 44.
Passo 3: a dose está 70% acima do máximo da bula para essa faixa.
Conduta: contatar o prescritor com o valor da TFGe e a data do exame. Pergunte também à paciente sobre vômitos, diarreia ou pouca ingestão de água, situações que derrubam a função renal e aumentam o risco de acidose láctica.

CASO

Homem de 74 anos, TFGe 34 mL/min/1,73 m², com dor no joelho, pede ibuprofeno 600 mg. Usa enalapril e hidroclorotiazida.

Passo 1: a TFGe está acima de 30, mas a associação de AINE com inibidor da ECA e diurético reduz a filtração.
Passo 2: o Beers 2023 manda evitar AINE abaixo de 30 mL/min, e o paciente está perto do corte.
Conduta: não indicar AINE; oferecer paracetamol dentro da dose de adulto, medidas não farmacológicas e encaminhar para avaliação da dor.

NO BALCÃO

Para idosos e para quem tem doença renal, pergunte se há exame recente de creatinina e qual a TFGe, peso e altura, e liste os medicamentos em uso, incluindo os de venda livre. Contate o prescritor quando a dose passar do limite para a faixa de função renal, quando o exame tiver mais de alguns meses e o paciente estiver doente, ou quando houver combinação de AINE, inibidor da ECA ou BRA e diurético.

Injetáveis na sala de serviços

Na sala de serviços farmacêuticos, o cálculo vira aplicação: o volume aspirado entra no paciente e não volta. A administração de medicamentos na farmácia segue a RDC 44/2009 (arts. 74 a 81) e a técnica do POP de injetáveis; aqui o foco é a conta: reconstituição, conversão de UI e mg em mL, volume por região e conferência.

Reconstituição e volume final

Como nas suspensões orais, o pó ocupa volume, e o volume final é maior que o de diluente. A concentração final deve ser calculada pelo volume final informado na bula.

Produto	Diluente	Volume final	Concentração aproximada
Ceftriaxona 500 mg IM (Rocefin®)	2 mL de lidocaína 1%	Cerca de 2,36 mL	212 mg/mL
Ceftriaxona 1 g IM (Rocefin®)	3,5 mL de lidocaína 1%	Cerca de 4,22 mL	237 mg/mL
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI (Benzetacil®, suspensão pronta)	Não precisa	4 mL	300.000 UI/mL

ATENÇÃO

O diluente da ceftriaxona IM é solução de lidocaína e "nunca deve ser administrado na veia" (bula do Rocefin®). A mesma bula recomenda não aplicar mais de 1 g em cada local e usar a solução logo após o preparo. Ceftriaxona IV e IM são apresentações diferentes: confira o rótulo antes de reconstituir.

CASO

Receita para criança de 15 kg: ceftriaxona 50 mg/kg IM, dose única. A farmácia tem o frasco de 1 g IM.

Passo 1: dose: 15 × 50 = 750 mg.
Passo 2: após reconstituir com 3,5 mL de lidocaína 1%, o frasco tem 1000 mg em 4,22 mL: 237 mg/mL.
Passo 3: volume: 750 ÷ 237 = 3,2 mL. O restante (cerca de 1 mL) é descartado, porque a solução deve ser usada logo.
Passo 4: 3,2 mL passam do volume recomendado para um único músculo nessa idade (tabela abaixo).
Conduta: confirmar com o prescritor a dose e a divisão em dois locais, e avaliar se a aplicação pediátrica cabe no serviço da farmácia ou deve ser feita na unidade de saúde. O erro clássico é aspirar 3,5 mL, o volume do diluente.

Penicilina benzatina: UI e mL

A dose de benzilpenicilina benzatina é escrita em unidades internacionais. No Benzetacil® em suspensão pronta (300.000 UI/mL), a conversão é direta: UI ÷ 300.000 = mL. Há também apresentações em pó para reconstituir; nelas, a concentração final depende do diluente e do volume final da bula daquele produto.

Indicação (bula do Benzetacil®)	Dose	Volume a 300.000 UI/mL
Faringite estreptocócica, criança até 27 kg	300.000 a 600.000 UI	1 a 2 mL
Faringite estreptocócica, criança maior	900.000 UI	3 mL
Faringite estreptocócica, adulto	1.200.000 UI	4 mL
Profilaxia de febre reumática	1.200.000 UI a cada 4 semanas	4 mL

Indicação (bula do Benzetacil®)	Dose	Volume a 300.000 UI/mL
Sífilis primária, secundária e latente precoce	2.400.000 UI, dose única	8 mL, em dois locais (4 mL em cada glúteo)
Sífilis latente tardia e terciária	2.400.000 UI por semana, 3 semanas	8 mL por semana, em dois locais

A bula manda injeção intramuscular profunda, lenta e contínua (a suspensão pode entupir a agulha), aspiração antes de injetar e, em adulto, o quadrante superior lateral do glúteo; em lactentes e crianças pequenas, pode ser preferível a face lateral da coxa. O material do TelessaúdeRS-UFRGS (2023) aponta a região ventroglútea como preferencial.

CASO

Criança de 20 kg com receita de penicilina benzatina 600.000 UI IM, dose única. A farmácia tem frasco de 1.200.000 UI em 4 mL.

Passo 1: concentração: 1.200.000 ÷ 4 = 300.000 UI/mL.
Passo 2: volume: 600.000 ÷ 300.000 = 2 mL.
Passo 3: a dose está na faixa da bula para crianças até 27 kg.
Passo 4: o restante do frasco (2 mL) é desprezado, como manda a bula.
Erro a evitar: ler "600.000" e aspirar o frasco inteiro, ou confundir "1.200.000 UI" com "1,2 mL".

Volume máximo por região

O volume que um músculo tolera depende da massa muscular, do biotipo e da idade, e a literatura não é uniforme. As referências usadas na enfermagem brasileira trazem valores próximos destes:

Região	Adulto	Criança
Ventroglútea	Até 4 mL	Indicada a partir de cerca de 7 meses; volumes menores, conforme a idade
Dorsoglútea	Até 4 mL	Pouco desenvolvida abaixo de 1 ano; evitar em criança pequena
Vasto lateral da coxa	3 a 4 mL	Local preferido abaixo de 2 anos; até cerca de 1 mL nessa faixa
Deltoide	0,5 a 1 mL	Pouca massa muscular; evitar em criança pequena

Valores de adulto para ventroglútea, dorsoglútea e vasto lateral: TelessaúdeRS-UFRGS (2023). Deltoide e criança: BVS Atenção Primária (2021), com base no Parecer COREN-SP 010/2020. A tabela por faixa etária completa está no material de apoio.

Conferência e dupla checagem

Antes de aspirar, confira em voz alta cinco pares: paciente e receita; medicamento e apresentação (IM ou IV); dose prescrita e unidade (mg ou UI); concentração final e volume calculado; via e região. A dupla

checagem independente, em que uma segunda pessoa refaz a conta sem ver o resultado da primeira, é recomendada pelo ISMP Brasil para medicamentos de alto risco e é útil sempre que houver conversão de UI ou fracionamento de frasco.

NO BALCÃO

Leia a receita, a bula e o rótulo do frasco antes de preparar. Escreva a conta (dose, concentração, volume) na ficha do atendimento e peça a um colega que refaça sem olhar o seu resultado. Pergunte sobre alergia a penicilina e a lidocaína, uso de anticoagulante e reação em aplicação anterior. Registre lote, validade, volume, região e horário, e mantenha o paciente em observação pelo tempo do POP.

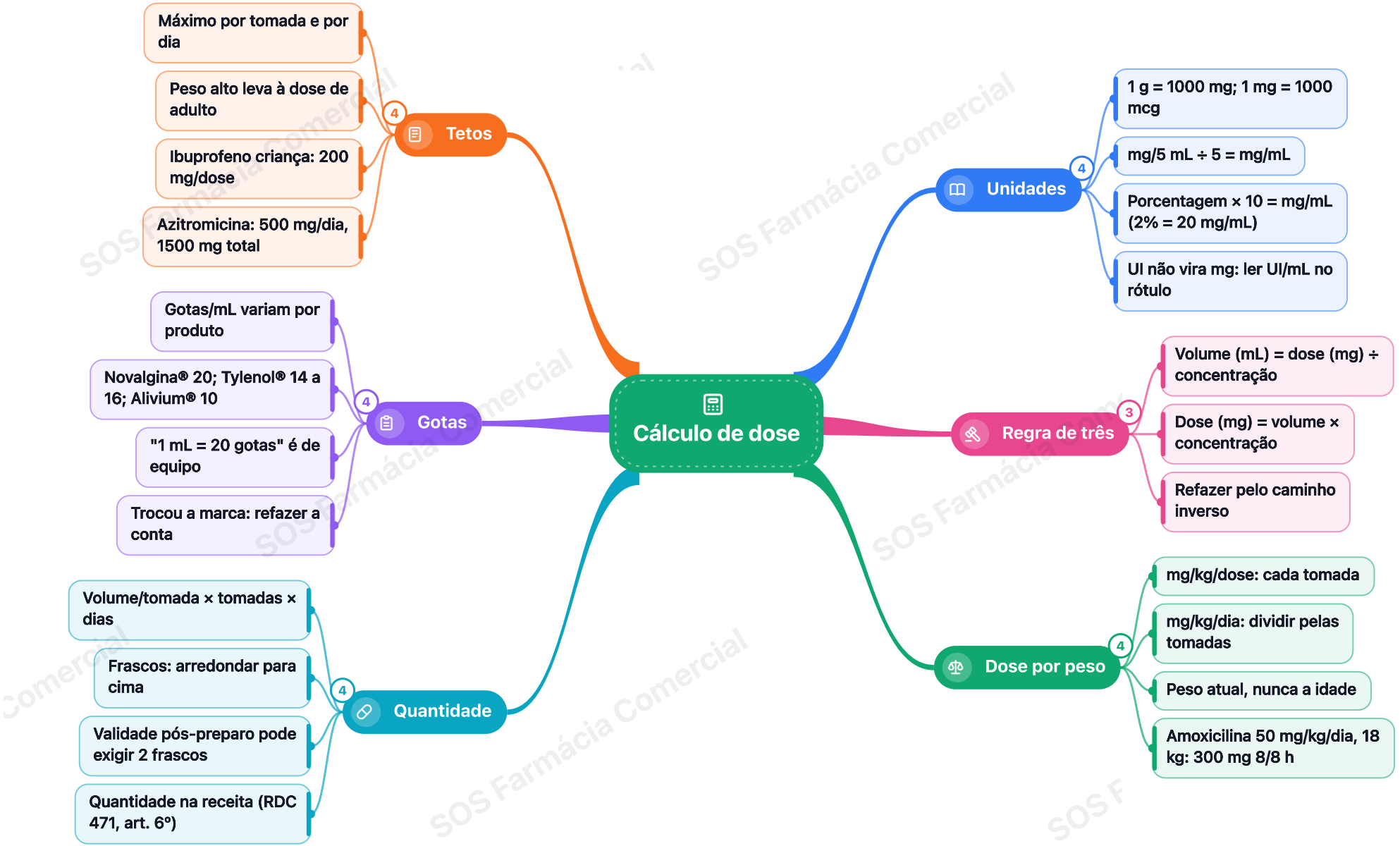
Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021 (arts. 6º e 11), com alterações da RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Texto consolidado consultado em out. 2026.
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias.
3. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (doses pediátricas de paracetamol e dipirona).
4. Magni AM, Scheffer DK, Bruniera P. Antipyretic effect of ibuprofen and dipyrone in febrile children. J Pediatr (Rio J). 2011;87(1):36-42.
5. ISMP Brasil. Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos. Boletim ISMP Brasil, v. 4, n. 2, jun. 2015 (conteúdo conferido por citação secundária; PDF não acessado).
6. Bulas consultadas em texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), outubro de 2026: Tylenol® gotas, Bebê e Criança (Janssen-Cilag); paracetamol genérico; Novalgina® solução oral e gotas (Sanofi Medley); dipirona monoidratada genérica; Alivium® (Cosmed/Brainfarma); ibuprofeno genérico; Amoxil® (GlaxoSmithKline); amoxicilina genérica; Clavulin® e Clavulin® BD (GlaxoSmithKline); Zitromax® (Pfizer); Astro® (Eurofarma); Azi®; azitromicina genérica; Keflex® (Antibióticos do Brasil); cefalexina genérica; Cefamox® (Bristol-Myers Squibb); cefadroxila genérica; Klaricid® (Abbott); Bactrim® (Farmoquímica); sulfametoxazol + trimetoprima genérico; Prelone® (Aché); Predsim®; Annita® (Farmoquímica); nitazoxanida genérica; Flagyl®.
7. Bulas consultadas no mesmo portal para dose fixa e insulinas: Claritin® (Bayer), Polaramine®, Pantelmin® (Janssen-Cilag), Zentel® (GlaxoSmithKline), Luftal® (Reckitt Benckiser), Revectina® (Abbott), Toujeo® (Sanofi), Lantus® (Sanofi), Humulin® N (Eli Lilly), NovoRapid® (Novo Nordisk), Ozempic® (Novo Nordisk).
8. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamentos Científicos de Pediatria Ambulatorial e de Infectologia. Documento científico: Manejo da febre aguda. 5 de outubro de 2021. https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23229e-DC_Manejo_da_febre_aguda_SITE.pdf
9. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (conduta do grupo A e Apêndice H, uso de medicamentos; Quadro 1, sinais de alarme).
10. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. Brasília, 2013 (Quadro 2 e Anexos B e C).
11. Ministério da Saúde. Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes. Brasília, 2022 (conferido por material de divulgação; documento original não lido).
12. Lieberthal AS et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013;131(3):e964-e999 (American Academy of Pediatrics; conferido pelo resumo da American Family Physician, 2013).
13. Wald ER et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics. 2013;132(1):e262-e280 (conferido pelo resumo da American Family Physician, 2014).

14. Matson KL, Horton ER, Capino AC; Pediatric Pharmacy Advocacy Group. Medication dosage in overweight and obese children. J Pediatr Pharmacol Ther. 2017;22(1):81-83. doi:10.5863/1551-6776-22.1.81
15. Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med. 1987;317(17):1098.
16. Inker LA et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med. 2021;385(19):1737-1749.
17. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314 (pontos de prática 1.2.4.2 e 4.2.1 a 4.2.5).
18. By the 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081 (Tabela 6). doi:10.1111/jgs.18372
19. Anvisa. RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, com alterações da RDC nº 973/2025; Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (conforme o módulo de RDC 471 deste material).
20. Anvisa. RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, arts. 74 a 81 (conforme o módulo de serviços clínicos deste material).
21. TelessaúdeRS-UFRGS. Como deve ser administrada a benzilpenicilina benzatina para o tratamento de sífilis? 2023. https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/como-deve-ser-administrada-benzilpenicilina-benzatina-para-o-tratamento-de-sifilis/
22. BVS Atenção Primária à Saúde. Quais são as orientações para administração de medicação intramuscular em crianças? 25/06/2021 (com base no Parecer COREN-SP 010/2020). https://aps-repo.bvs.br/aps/quais-sao-as-orientacoes-para-administracao-de-medicacao-intramuscular-em-criancas/
23. Silva e Santos (2005), tabela de volume intramuscular por faixa etária, citada no Parecer COREN-SP 039/2012 (conferida por fonte secundária: guia de habilidades da Unoeste).
24. Bulas consultadas em texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), outubro de 2026: Glifage® (cloridrato de metformina); Macrodantina® (nitrofurantoína; Cosmed/Brainfarma); Rocefin® (ceftriaxona; Produtos Roche, bula de 18/03/2025); Benzetacil® suspensão injetável 300.000 UI/mL (Eurofarma, bula de 18/03/2025); Noripurum® gotas (ferripolimaltose); Neutrofer® (glicinato férrico); sulfato ferroso gotas genérico; Zoloft® (cloridrato de sertralina; Mylan); Tylenol®, Novalgina®, Alivium®, Amoxil®, Clavulin® BD, Keflex® e Prelone® (já conferidas na parte a).

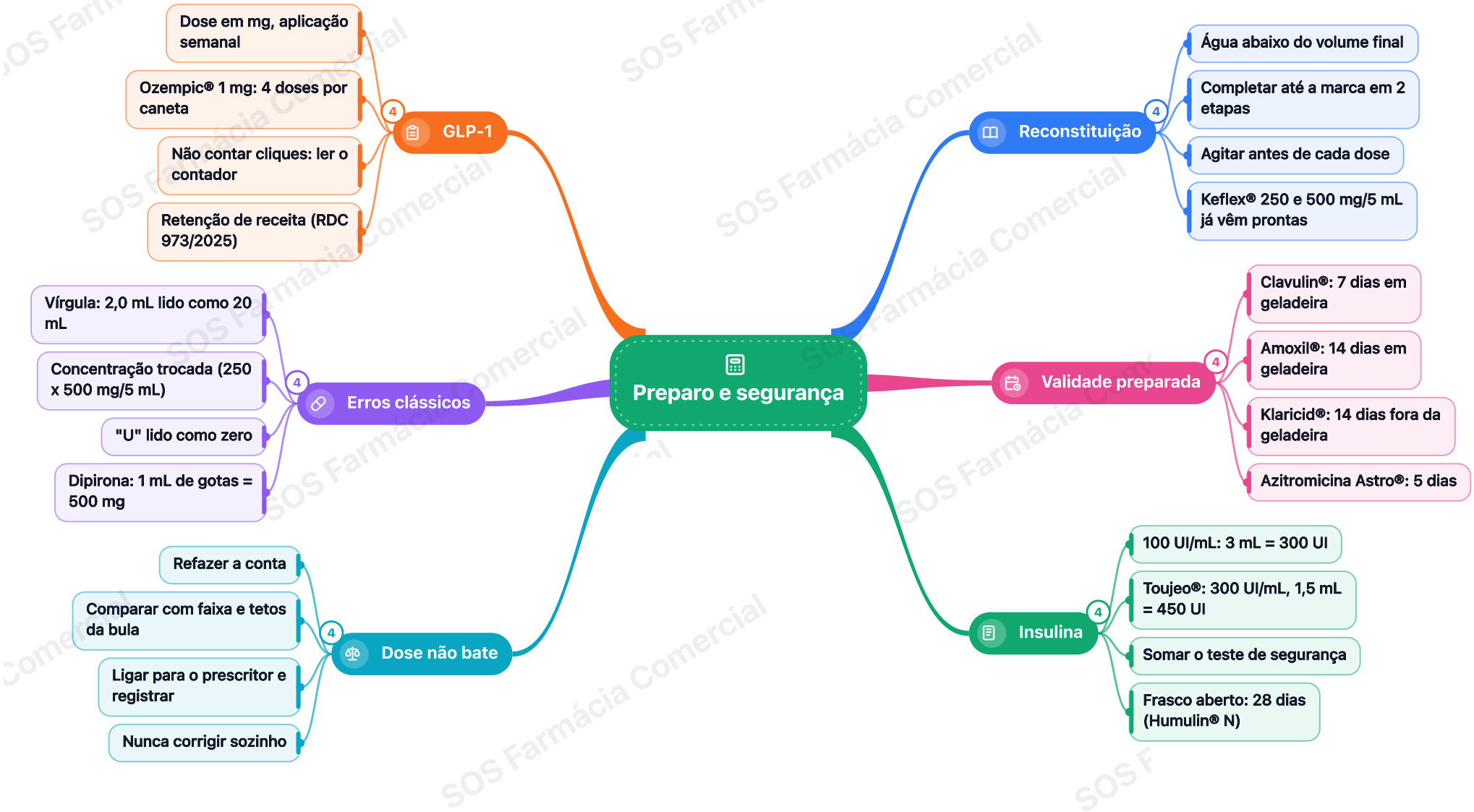
Cálculo de dose: visão geral

6 ramos · 23 itens · mapa mental do módulo 13



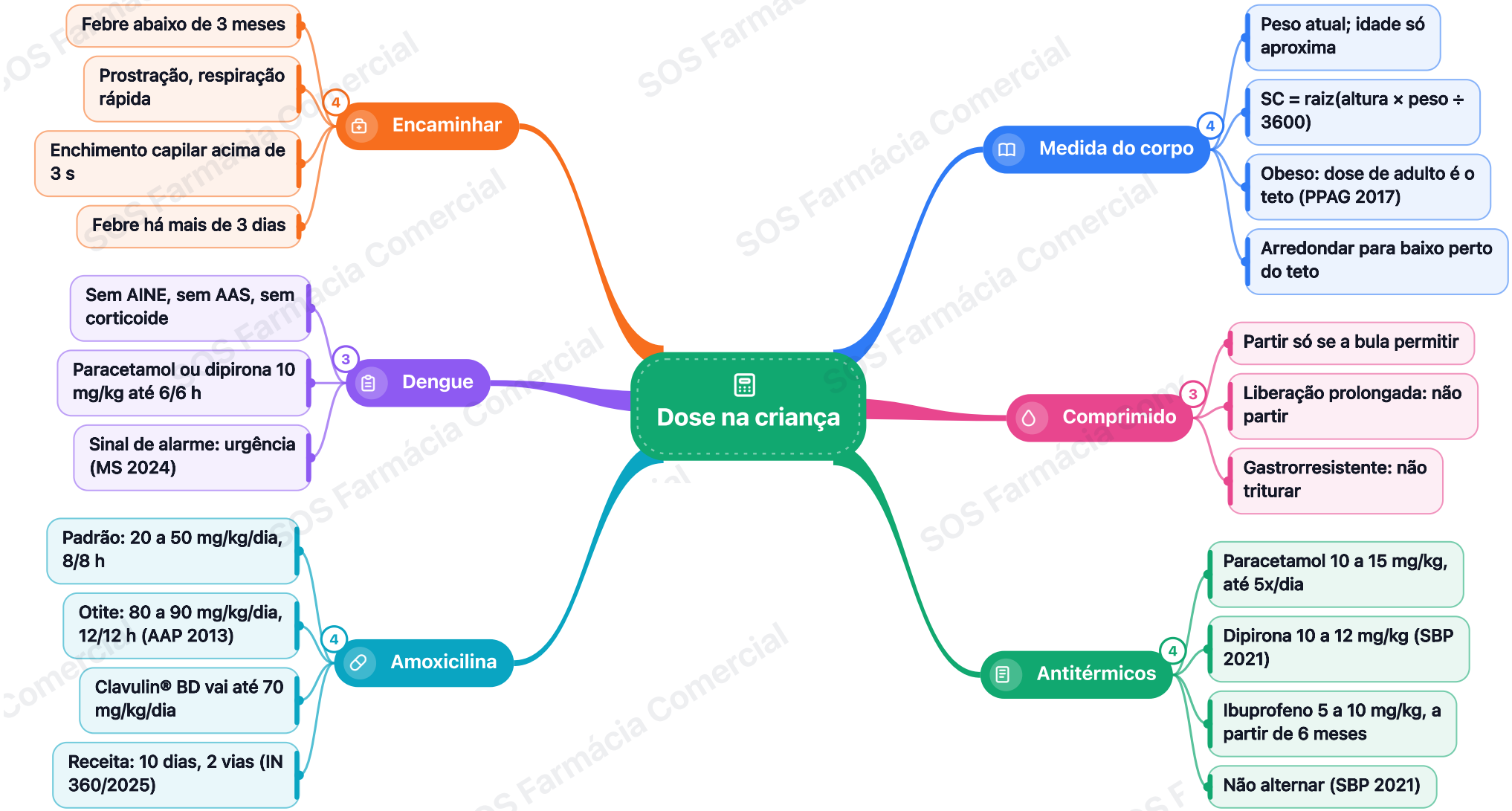
Suspensões, canetas e erros

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 13



Criança: peso, febre e antibiótico

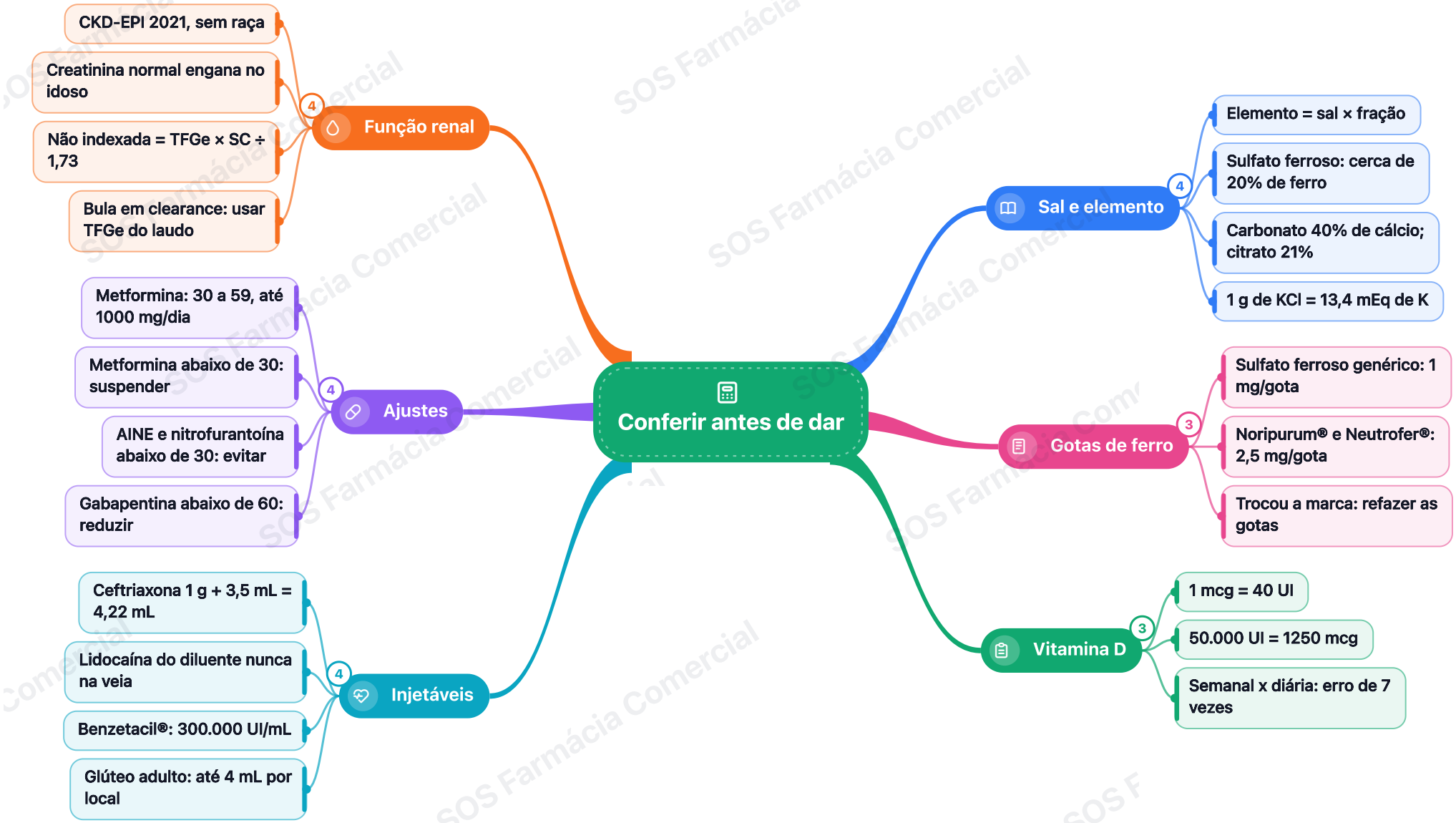
6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 13



SOS Farmácia Comercial

Sal, rim e injetáveis

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 13



Calculadora de dose

CONTAS

Dose por tomada (mg) = peso (kg) x dose (mg/kg), ou peso x dose diária (mg/kg/dia) ÷ tomadas por dia. Volume (mL) = dose (mg) ÷ concentração (mg/mL). Gotas = volume (mL) x gotas por mL da bula do produto. Respeite o teto por tomada e por dia. Frascos = mL por tomada x tomadas x dias ÷ volume do frasco, arredondado para cima.

Dipirona. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 500 mg/mL (Novalgina®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL); Solução oral 50 mg/mL (infantil, seringa)

Idade: Contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg

Duração usual: Uso sintomático; até 4 vezes ao dia

Observação: A bula da Novalgina® não traz mg/kg: usa faixas de peso (ex.: 9 a 15 kg, 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas por dia; 5 a 8 kg, 2 a 5 gotas e até 20 por dia). A faixa de 10 a 15 mg/kg por dose vem do guia de dengue do Ministério da Saúde (10 mg/kg) e da literatura pediátrica (15 mg/kg). Confira sempre a tabela da bula. Teto de 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia é a dose de adulto.

Fonte: Novalgina® solução oral, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026); Ministério da Saúde, Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024; Magni AM et al., J Pediatr (Rio J), 2011

Paracetamol. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 4 a 5 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 75 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 200 mg/mL (Tylenol®: 14 a 16 gotas/mL) (15 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL, outras marcas (conferir gotas/mL na bula); Suspensão oral 100 mg/mL (bebê, seringa); Suspensão oral 32 mg/mL (criança, copo-medida)

Idade: Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: a bula manda consultar o médico antes do uso

Duração usual: Uso sintomático; intervalo de 4 a 6 horas

Observação: No máximo 5 administrações em 24 horas. Abaixo de 12 anos, a bula do Tylenol® gotas limita a dose a 35 gotas por tomada (1 gota/kg). O número de gotas por mL varia entre fabricantes: confira a bula do frasco entregue.

Fonte: Tylenol® gotas, Tylenol® Bebê e Tylenol® Criança, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Cetoprofeno gotas. *Venda sob prescrição*

Dose: 1 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 300 mg/dia

Apresentações: Gotas 20 mg/mL (Profenid®: 20 gotas/mL, 1 gota = 1 mg) (20 gotas/mL)

Idade: A partir de 1 ano (abaixo de 1 ano a segurança não foi estabelecida)

Duração usual: Conforme a receita; intervalo de 6 ou 8 horas

Observação: Bula: 1 gota/kg (1 mg/kg) a cada 6 ou 8 horas, sempre diluída em um pouco de água. De 7 a 11 anos a bula também aceita dose fixa de 25 gotas por tomada. O teto de 300 mg/dia (300 gotas) aparece junto da dose de adulto. O cetoprofeno pediátrico 1 mg/mL (xarope de genérico) tem outro esquema: 0,5 mg/kg por dose, 3 a 4 vezes ao dia, até 2 mg/kg/dia, a partir de 6 meses e em geral por 2 a 5 dias. Não use este cálculo para o xarope.

Fonte: Profenid® gotas, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); cetoprofeno pediátrico 1 mg/mL, genérico (mesmo portal)

Diclofenaco gotas (resinato). *Venda sob prescrição*

Dose: 0,5 a 2 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/dia

Apresentações: Suspensão oral gotas 15 mg/mL (Cataflam®: cerca de 0,5 mg por gota, 30 gotas/mL) (30 gotas/mL)

Idade: A partir de 1 ano. A mesma bula diz que o diclofenaco não é indicado abaixo de 14 anos, exceto na artrite juvenil crônica, em que só gotas e suspensão servem a partir de 1 ano

Duração usual: Tratamento de curto prazo; a menor dose pelo menor tempo

Observação: Bula: 1 a 4 gotas/kg/dia divididas em 2 ou 3 tomadas (cerca de 0,5 mg por gota, o que dá 0,5 a 2 mg/kg/dia). Exemplo da bula: 20 kg, 20 a 80 gotas por dia. Teto de 300 gotas/dia (150 mg). Concentração expressa em diclofenaco potássico (15 mg/mL). Agitar o frasco por 1 minuto; as gotas não se dissolvem em água, suco ou leite: pingar numa colher.

Fonte: Cataflam® gotas, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em nov. 2022)

Ibuprofeno. *MIP (gotas 200 mg/mL do Alivium®: venda sob prescrição)*

Dose: 5 a 10 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 200 mg por tomada; 800 mg/dia

Apresentações: Gotas 50 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 100 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Suspensão oral 30 mg/mL (seringa)

Idade: A partir de 6 meses

Duração usual: Febre: não usar por mais de 3 dias sem orientação médica; dor: não mais de 10 dias

Observação: 5 mg/kg para febre baixa e 10 mg/kg para febre alta (abaixo ou acima de 39 °C), de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Tetos de criança: 200 mg por dose e 800 mg/dia. No Alivium®, todas as gotas têm 10 gotas/mL: 1 a 2 gotas/kg (50 mg/mL), 1 gota/kg (100 mg/mL), 1 gota a cada 2 kg (200 mg/mL).

Fonte: Alivium® suspensão oral e gotas, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Betametasona elixir. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 0,25 mg/kg/dia; 8 mg/dia

Apresentações: Elixir 0,1 mg/mL (0,5 mg/5 mL)

Idade: Uso adulto e pediátrico; a bula não fixa idade mínima

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Dose inicial da criança: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia (ou 0,5 a 7,5 mg/m²/dia). A bula dá como exemplo o máximo de 5 mg/dia para 20 kg, o que equivale a 0,25 mg/kg/dia. A dose de manutenção é tomada de uma vez, de manhã; a bula não diz em quantas tomadas dividir a dose inicial. O teto de 8 mg/dia é o de adulto. O elixir contém açúcar e álcool (0,39%).

Fonte: Celestone® comprimidos e elixir, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Deflazacorte comprimido. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,22 a 1,65 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 6 mg; Comprimido 30 mg

Idade: Uso adulto e pediátrico

Duração usual: Conforme a receita; suspensão sempre gradual

Observação: Bula: criança, 0,22 a 1,65 mg/kg/dia ou em dias alternados; adulto, dose inicial de 6 a 90 mg/dia conforme a gravidade. A bula não fixa o número de tomadas: a calculadora mostra a dose do dia em tomada única. A bula não descreve sulco nos comprimidos de 6 e 30 mg (têm uma cruz gravada): conferir antes de orientar fração.

Fonte: Calcort®, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Prednisolona. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 0,14 a 2 mg/kg/dia; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 80 mg/dia

Apresentações: Solução oral 3 mg/mL; Gotas 11 mg/mL (gotas/mL não informado na bula)

Idade: Dose individualizada pela resposta clínica

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia, de 1 a 4 vezes ao dia (a bula da solução de 3 mg/mL fala em 3 a 4 vezes). Dose máxima de 80 mg/dia. As concentrações referem-se à prednisolona base (1 mg de prednisolona = 1,34 mg de fosfato sódico). A bula das gotas não informa gotas por mL.

Fonte: Prelone® solução oral e gotas, Aché (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Prednisolona comprimido. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,14 a 2 mg/kg/dia; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 80 mg/dia

Apresentações: Comprimido 5 mg (sulcado); Comprimido 10 mg (sulcado); Comprimido 20 mg (sulcado); Comprimido 40 mg (sulcado)

Idade: Uso adulto e pediátrico; na criança, dose individualizada pela doença e pela resposta

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Bula: dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia), em 1 a 4 tomadas; dose máxima de 80 mg/dia. Todos os comprimidos do Predsim® descritos na bula são sulcados (5, 10, 20 e 40 mg). Para crianças pequenas, a solução oral já está na calculadora.

Fonte: Predsim® comprimido, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Prednisona comprimido. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,14 a 2 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 5 mg (sem sulco); Comprimido 20 mg (sulcado)

Idade: Uso adulto e pediátrico; na criança, dose individualizada pela doença e pela resposta

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Bula: dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia); adulto, 5 a 60 mg/dia. Tomar pela manhã, com líquido; pode ser prescrita em dias alternados na manutenção. A bula não fixa teto. O comprimido de 20 mg é sulcado; o de 5 mg não tem sulco, então a dose se monta com comprimidos inteiros.

Fonte: Meticorten®, Organon (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Amoxicilina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 50 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/kg/dia; 6.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Abaixo de 40 kg: dose por peso; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: 20 a 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, até 150 mg/kg/dia. A mesma bula cita 80 a 90 mg/kg/dia em duas tomadas como primeira escolha na otite média aguda (seção de resultados de eficácia). Suspensão preparada: 14 dias em geladeira.

Fonte: Amoxil® suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato (8 em 8 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 60 mg/kg/dia; 3 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg + 62,5 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 20 a 40 mg/kg/dia; dose alta: 40 a 60 mg/kg/dia, em três tomadas. Sem dados acima de 40 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Os tetos (500 mg por tomada, 1500 mg/dia) correspondem à dose de adulto da bula (500 mg + 125 mg de 8 em 8 horas). Preparo: 90 mL de água para 100 mL; validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato BD (12 em 12 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 70 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 875 mg por tomada; 1.750 mg/dia

Apresentações: Suspensão BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL; Suspensão BD 400 mg + 57 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 25 a 45 mg/kg/dia; dose alta: 45 a 70 mg/kg/dia, em duas tomadas. Sem dados acima de 45 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Tetos correspondem à dose de adulto (875 mg + 125 mg de 12 em 12 horas). Preparo: 64 mL de água (200 mg/5 mL) ou 62 mL (400 mg/5 mL) para 70 mL; 124 mL para 140 mL. Validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® BD pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato comprimido (500 mg + 125 mg). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 40 kg ou mais (dose de adulto, em mg de amoxicilina): 500 mg; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido revestido 500 mg + 125 mg (Clavulin®: caixas com 21 ou 30)

Idade: Comprimido não recomendado abaixo de 12 anos; criança com 40 kg ou mais recebe a dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem reavaliação médica

Observação: Calculado pela amoxicilina. Bula: adultos e crianças acima de 12 anos, 1 comprimido de 500 mg + 125 mg de 8 em 8 horas, no início da refeição. Abaixo de 40 kg, usar as suspensões (linhas de amoxicilina + clavulanato). Insuficiência renal moderada: 1 comprimido de 12 em 12 horas; grave: comprimido não recomendado. O comprimido BD de 875 mg + 125 mg tem esquema de 12 em 12 horas e a bula consultada só traz dose de adulto.

Fonte: Clavulin®, GlaxoSmithKline Brasil, e Amoxicilina + clavulanato de potássio genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026; páginas atualizadas em abr. 2025 e out. 2020); IN 360/2025, art. 1º

Amoxicilina cápsula. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: acima de 40 kg: 500 mg; 3 tomadas por dia

Tetos: 6.000 mg/dia

Apresentações: Cápsula 500 mg (Amoxil®: caixas com 15, 21 ou 30)

Idade: Cápsula: uso adulto e pediátrico acima de 40 kg; abaixo de 40 kg, suspensão por mg/kg (linha Amoxicilina)

Duração usual: Conforme a receita; amigdalite estreptocócica pede no mínimo 10 dias

Observação: Bula da cápsula: adultos e crianças acima de 40 kg, 500 mg de 8 em 8 horas. Dose alta (até 6 g/dia): 3 g de 12 em 12 horas na infecção respiratória purulenta grave ou recorrente. Gonorreia: 3 g em dose única. Doses abaixo de 500 mg exigem a suspensão. Engolir inteira, com água; pode ser tomada nas refeições. Insuficiência renal moderada: no máximo 500 mg de 12 em 12 horas.

Fonte: Amoxil® cápsula 500 mg, GlaxoSmithKline Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Azitromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 5 a 10 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg/5 mL

Idade: Comprimidos só acima de 45 kg; acima de 45 kg, dose de adulto

Duração usual: 3 dias (10 mg/kg/dia) ou 5 dias (10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg do 2º ao 5º)

Observação: Dose total usual em crianças: 30 mg/kg, no máximo 1500 mg por tratamento. Na otite média aguda, alternativa de 30 mg/kg em dose única (não use a calculadora diária nesse caso). Frascos de 600, 900 e 1500 mg rendem 15, 22,5 e 37,5 mL utilizáveis; suspensão preparada vale 5 dias em temperatura ambiente.

Fonte: Zitromax®, Pfizer; Astro®, Eurofarma; Azi® (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Azitromicina comprimido. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: acima de 45 kg: 500 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 500 mg/dia

Apresentações: Comprimido revestido 500 mg (Zitromax®: caixas com 2 ou 3)

Idade: Comprimido só para criança com mais de 45 kg; abaixo disso, usar a suspensão (linha Azitromicina)

Duração usual: 3 dias de 500 mg (dose total de 1500 mg, que é o máximo por tratamento em criança)

Observação: Bula: o comprimido revestido só deve ser dado a crianças com mais de 45 kg; dose total em criança de 30 mg/kg, no máximo 1500 mg, sem passar de 500 mg por dia. Uma tomada ao dia, com ou sem alimento. Adulto com DST por clamídia, H. ducreyi ou gonococo sensível: 1000 mg em dose única. Não partir nem mastigar.

Fonte: Zitromax®, Pfizer Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Benzilpenicilina benzatina IM (estreptococo do grupo A). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021; penicilina G na IN 360/2025)*

Dose: criança até 27 kg: 300.000 a 600.000 UI; acima de 27 kg: 900.000 UI na criança maior, 1.200.000 UI no adulto: 900.000 a 1.200.000 UI; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão injetável 300.000 UI/mL (Benzetacil®: frasco-ampola de 4 mL = 1.200.000 UI)

Idade: Faixas da bula para infecção estreptocócica do trato respiratório superior e da pele

Duração usual: Injeção única; profilaxia da febre reumática: 1.200.000 UI a cada 4 semanas (ou 3 semanas, a critério médico)

Observação: Só IM profunda (quadrante superior lateral da nádega; em lactente e criança pequena, face lateral da coxa). Agitar bem o frasco, aspirar antes de injetar e aplicar devagar e de forma contínua, porque a suspensão concentrada entope a agulha. Desprezar a sobra. Na faixa acima de 27 kg a bula não dá peso para separar criança de adulto: decide a idade (criança maior, 900.000 UI; adulto, 1.200.000 UI). Sífilis primária, secundária e latente recente: 2.400.000 UI em dose única (adulto). A bula atual do Benzetacil® é de suspensão pronta; se o produto for pó para reconstituir, a concentração vem da bula daquele produto.

Fonte: Benzetacil®, Eurofarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (penicilina G)

Benzilpenicilina benzatina IM (sífilis congênita, abaixo de 2 anos). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021; penicilina G na IN 360/2025)*

Dose: 50.000 UI/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão injetável 300.000 UI/mL (Benzetacil®: frasco-ampola de 4 mL)

Idade: Abaixo de 2 anos, sem sintomas; de 2 a 12 anos, a bula manda ajustar pela tabela de adulto

Duração usual: Dose única

Observação: Bula: sífilis congênita em paciente assintomático, 50.000 UI/kg em dose única abaixo de 2 anos. Em geral o esquema é feito no serviço de saúde que acompanha a criança; na farmácia, só com prescrição e conferência da dose. Mesmos cuidados de aplicação da linha anterior (IM profunda, face lateral da coxa no lactente, aspirar antes, injetar devagar).

Fonte: Benzetacil®, Eurofarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (penicilina G)

Cefaclor. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 40 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL (pronta); Suspensão 375 mg/5 mL (pronta)

Idade: Contraindicado abaixo de 1 mês

Duração usual: Estreptococo beta-hemolítico: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 20 a 40 mg/kg/dia divididos de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas; 40 mg/kg/dia na otite média e em infecções mais graves; dose máxima de 1 g/dia. As tabelas da bula usam a suspensão de 250 mg/5 mL de 8 em 8 horas e a de 375 mg/5 mL de 12 em 12 horas. A suspensão já vem pronta (oleosa), guardada em temperatura ambiente. A de 250 mg/5 mL contém tartrazina.

Fonte: Ceclor® suspensão oral, EMS Sigma Pharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Cefadroxila. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 2.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Prematuros e recém-nascidos abaixo de 6 semanas e meia: cautela

Duração usual: Faringite e amigdalite: no mínimo 10 dias (bula de cefadroxila genérica)

Observação: Bula do Cefamox®: 25 a 50 mg/kg/dia em duas tomadas de 12 em 12 horas. Bula de cefadroxila genérica admite 30 mg/kg/dia em dose única ou em duas doses na faringite. Teto de 2000 mg/dia corresponde à dose de adulto (1 a 2 g/dia). Preparada: 10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira.

Fonte: Cefamox®, Bristol-Myers Squibb (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); cefadroxila genérica (mesmo portal)

Cefalexina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: 100 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 100 mg/mL (Keflex®: cerca de 22 gotas/mL) (22 gotas/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (pronta); Suspensão 500 mg/5 mL (pronta)

Idade: A bula não fixa idade mínima para as formas líquidas

Duração usual: Conforme a receita; cistite: 7 a 14 dias

Observação: Doses divididas de 6 em 6 horas; em faringite estreptocócica (acima de 1 ano), infecção urinária leve e infecção de pele, pode ser dividida de 12 em 12 horas. Em infecção grave a dose pode ser dobrada; otite média: 75 a 100 mg/kg/dia em 4 tomadas. Gotas: pó para reconstituir, 14 dias em geladeira. Suspensões de 250 e 500 mg/5 mL já vêm prontas.

Fonte: Keflex®, Antibióticos do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jan. 2026)

Ceftriaxona IM (injetável intramuscular). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 80 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 4.000 mg/dia

Apresentações: Pó IM 500 mg + 1,7 mL de lidocaína 1% (Tabela 1 da bula: 2,1 mL, 250 mg/mL); Pó IM 1 g + 2,9 mL de lidocaína 1% (Tabela 1 da bula: 3,6 mL, 285 mg/mL); Pó IM 500 mg + ampola inteira de 2 mL (volume final 2,36 mL, cerca de 212 mg/mL); Pó IM 1 g + ampola inteira de 3,5 mL (volume final 4,22 mL, cerca de 237 mg/mL)

Idade: De 15 dias a 12 anos: 20 a 80 mg/kg/dia; abaixo de 14 dias, 20 a 50 mg/kg (sem passar de 50 mg/kg); com 50 kg ou mais, dose de adulto (1 a 2 g, até 4 g por dia)

Duração usual: Manter no mínimo 48 a 72 horas depois de sumir a febre ou de haver sinal de erradicação

Observação: Uma aplicação a cada 24 horas, IM profunda no glúteo ou em músculo grande, no máximo 1 g por local. O diluente da apresentação IM é lidocaína a 1%: nunca na veia; excluir contraindicação à lidocaína. Preparo de rotina: 500 mg em 2 mL (volume final 2,36 mL) e 1 g em 3,5 mL (volume final 4,22 mL); as concentrações dessas duas opções são cálculo a partir do volume final da bula. Para dose por peso, a bula traz a Tabela 1: 500 mg + 1,7 mL de lidocaína a 1% (2,1 mL, 250 mg/mL) e 1 g + 2,9 mL (3,6 mL, 285 mg/mL; a conta simples daria cerca de 278 mg/mL). Usar logo após o preparo e descartar a sobra. Contraindicada em prematuro até 41 semanas de idade pós-menstrual e em recém-nascido que recebe ou vai receber cálcio na veia. Meningite: 100 mg/kg/dia, no máximo 4 g (tratamento hospitalar).

Fonte: Rocefin® IM, F. Hoffmann-La Roche, registrado por Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Cefuroxima (axetilcefuroxima). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 30 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL

Idade: Sem dados de estudos abaixo de 3 meses; comprimido só a partir de 2 anos

Duração usual: Usual de 7 dias (5 a 10)

Observação: Bula: amigdalite e faringite, 10 mg/kg duas vezes ao dia (máximo de 500 mg/dia); otite, 15 mg/kg duas vezes ao dia (máximo de 1000 mg/dia), e a tabela agrupa sinusite, pneumonia, infecção urinária e de pele na mesma célula da otite. Tomar com alimento. Preparo: 25 mL de água no frasco de 70 mL e 19 mL no de 50 mL, água filtrada resfriada, nunca líquido quente; repousar 1 hora na geladeira antes da 1ª dose. Preparada: 10 dias em geladeira, sem congelar. O comprimido não pode ser partido nem triturado.

Fonte: Zinnat® pó para suspensão oral, Glaxo Operations UK, registrado e importado por Sandoz do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Cefuroxima (axetilcefuroxima) comprimido. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 15 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 250 mg por tomada; 500 mg/dia

Apresentações: Comprimido revestido 250 mg (Zinnat®: caixas com 10 ou 14)

Idade: Comprimido em criança a partir de 2 anos (otite média, pneumonia, piodermite); sem experiência abaixo de 3 meses

Duração usual: Geralmente 7 dias

Observação: Bula do comprimido, crianças: 15 mg/kg duas vezes ao dia ou 1 comprimido de 250 mg duas vezes ao dia, até 500 mg/dia. Na amigdalite, faringite e sinusite da criança a bula indica a suspensão (linha Cefuroxima). O comprimido não pode ser partido nem triturado: na prática a dose da criança fica em 1 comprimido de 250 mg, quando o peso permite. Tomar após as refeições.

Fonte: Zinnat®, Glaxo Operations UK, registrado e importado por Sandoz do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Ciprofloxacino comprimido (fibrose cística, 5 a 17 anos). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.500 mg/dia

Apresentações: Comprimido revestido 500 mg (Cipro®: caixas com 6 ou 14)

Idade: Em criança, a bula só indica de 5 a 17 anos na fibrose cística (e no antraz por inalação)

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: infecção aguda por Pseudomonas aeruginosa na fibrose cística, de 5 a 17 anos, 20 mg/kg duas vezes ao dia, no máximo 1500 mg/dia, quando não houver tratamento injetável mais eficaz; a bula não recomenda outras indicações em criança. Antraz por inalação em criança: 15 mg/kg duas vezes ao dia, no máximo 500 mg por dose (1000 mg/dia), conta que cabe no cálculo livre. Não tomar com leite, iogurte ou suco enriquecido com cálcio isoladamente; separar de antiácidos e suplementos de cálcio, magnésio ou alumínio. Contraindicado com tizanidina. Risco de tendinite e ruptura de tendão.

Fonte: Cipro®, Bayer (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Claritromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 15 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 125 mg/5 mL (25 mg/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

Idade: Acima de 6 meses

Duração usual: 5 a 10 dias, conforme indicação médica

Observação: 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (0,3 mL/kg da suspensão de 25 mg/mL ou 0,15 mL/kg da de 50 mg/mL), até 500 mg duas vezes ao dia. Em infecção por micobactérias: 7 a 15 mg/kg por dose. Preparada: 14 dias em temperatura ambiente, sem refrigeração.

Fonte: Klaricid® grânulos para suspensão pediátrica, Abbott (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Doxiciclina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 2,2 a 4,4 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 200 mg/dia

Apresentações: Comprimido solúvel 100 mg; Comprimido revestido 100 mg

Idade: Contraindicada abaixo de 8 anos; com 45 kg ou mais, dose de adulto

Duração usual: Conforme a receita; estreptococo beta-hemolítico do grupo A: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 4,4 mg/kg no 1º dia e 2,2 mg/kg/dia nos dias seguintes, em dose única ou dividida de 12 em 12 horas; em infecção grave, 4,4 mg/kg/dia durante todo o tratamento. Um trecho da bula escreve "acima de 45 kg" para a dose por peso e outro manda dose de adulto a partir de 45 kg: o cálculo por kg vale abaixo de 45 kg. Teto de 200 mg/dia deduzido da dose de adulto em infecção grave. Não tomar antes de deitar; beber bastante líquido. O comprimido solúvel pode ser dissolvido em 50 mL de água.

Fonte: Vibramicina®, Pfizer Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Eritromicina (estolato). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 30 a 50 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL (pronta)

Idade: A bula da suspensão não fixa idade mínima

Duração usual: Estreptococo do grupo A: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 30 a 50 mg/kg/dia em doses divididas; em infecção grave a dose pode ser dobrada. Faringite e amigdalite estreptocócicas: 20 a 50 mg/kg/dia. Duas tomadas por dia só se a dose total não passar de 1 g/dia. A bula não fixa teto pediátrico; a tabela por peso chega a 1000 mg/dia acima de 36 kg (dose de adulto). Uso acima de 10 dias: risco de hepatite colestática. Suspensão pronta, em temperatura ambiente.

Fonte: Ilosone® suspensão oral, Valeant Farmacêutica do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em fev. 2021); IN 360/2025, art. 1º

Fenoximetilpenicilina potássica (penicilina V). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25.000 a 90.000 UI/kg/dia; 3 a 6 tomadas por dia

Tetos: 500.000 UI por tomada

Apresentações: Pó para solução oral 80.000 UI/mL (400.000 UI/5 mL); Comprimido 500.000 UI (acima de 12 anos)

Idade: Solução oral contraindicada abaixo de 5 anos; comprimido abaixo de 12 anos

Duração usual: Amigdalite bacteriana: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: abaixo de 12 anos, 25.000 a 90.000 UI/kg/dia em 3 a 6 tomadas; em infecção respiratória leve a moderada (inclui ouvido), 40.000 UI/kg/dia em 2 tomadas por 10 dias. Acima de 12 anos, 200.000 a 500.000 UI por tomada, conforme a infecção. O teto de 500.000 UI por tomada é a maior dose de adulto da bula, não um limite pediátrico declarado. Melhor absorção em jejum. Preparada: 7 dias em temperatura ambiente. O esquema de 2 tomadas (40.000 UI/kg/dia) não sai da faixa da calculadora: use o cálculo livre.

Fonte: Pen-Ve-Oral®, Eurofarma, fabricado por Momenta Farmacêutica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (penicilina V)

Gentamicina IM (adulto). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021; gentamicina na IN 360/2025)*

Dose: 2 a 3 mg/kg/dia; 1 a 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Solução injetável 40 mg/mL (Garamicina®: 60 mg/1,5 mL ou 80 mg/2 mL); Solução injetável 80 mg/mL (Garamicina®: 120 mg/1,5 mL ou 160 mg/2 mL); Solução injetável 140 mg/mL (Garamicina®: 280 mg/2 mL)

Idade: Adulto com função renal normal; criança tem linha própria

Duração usual: Geralmente 7 a 10 dias

Observação: Bula, adulto com função renal normal: infecção grave, 3 mg/kg/dia em dose única diária ou dividida de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas; infecção menos grave, 2 mg/kg/dia em 1 ou 2 tomadas. Doses de até 5 mg/kg/dia ficam para doença com risco de morte (hospital). Infecção urinária sem insuficiência renal: 160 mg IM uma vez ao dia por 7 a 10 dias; adulto com menos de 50 kg, 3 mg/kg/dia. Obeso: calcular pela massa magra estimada. Insuficiência renal exige ajuste. Tóxica para rim, audição e equilíbrio.

Fonte: Garamicina® injetável, Hypermarcas (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); IN 360/2025, art. 1º

Gentamicina IM (criança). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021; gentamicina na IN 360/2025)*

Dose: 6 a 7,5 mg/kg/dia; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Solução injetável 20 mg/mL (Garamicina® pediátrica: ampola de 1 mL); Solução injetável 40 mg/mL (Garamicina®: ampola de 1 mL)

Idade: Criança; recém-nascido e lactente têm esquemas próprios na bula

Duração usual: Geralmente 7 a 10 dias

Observação: Bula, crianças com função renal normal: 6 a 7,5 mg/kg/dia (2 a 2,5 mg/kg de 8 em 8 horas). Recém-nascido com mais de uma semana e lactente: 7,5 mg/kg/dia (2,5 mg/kg de 8 em 8 horas); prematuro ou recém-nascido com até uma semana: 5 a 6 mg/kg/dia de 12 em 12 horas. Três aplicações por dia exigem acompanhamento próximo; insuficiência renal exige ajuste. Tóxica para rim, audição e equilíbrio.

Fonte: Garamicina® injetável, Hypermarcas (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); IN 360/2025, art. 1º

Lincomicina IM (injetável intramuscular). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 10 mg/kg por tomada; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 600 mg por tomada

Apresentações: Solução injetável 300 mg/mL (Frademicina®: ampola de 1 mL = 300 mg ou de 2 mL = 600 mg)

Idade: Contraindicada abaixo de 1 mês

Duração usual: Conforme a resposta clínica

Observação: Bula, crianças acima de 1 mês: 10 mg/kg IM a cada 24 horas; na infecção grave, 10 mg/kg a cada 12 horas ou com mais frequência. Adulto: 600 mg (2 mL) IM a cada 24 horas, até a cada 12 horas. O teto de 600 mg por aplicação foi deduzido da dose IM de adulto, não é limite pediátrico escrito na bula. Solução pronta, sem diluir para IM; a via IV exige diluição e infusão lenta (não é aplicação de farmácia). Contém álcool benzílico, associado à síndrome de gasping e a mortes em pacientes pediátricos.

Fonte: Frademicina®, Wyeth, fabricado por Laboratórios Pfizer (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); IN 360/2025, art. 1º

Metronidazol (benzoilmetronidazol suspensão). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 mg/kg por tomada; 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão 40 mg/mL de benzoilmetronidazol (25 mg/mL de metronidazol)

Idade: Acima de 1 ano

Duração usual: Amebíase intestinal: 5 a 7 dias; amebíase hepática: 7 a 10 dias; giardíase: 5 dias

Observação: Cálculo em mg de benzoilmetronidazol: 20 mg (0,5 mL)/kg, 4 vezes ao dia, na amebíase. Cada mL tem 40 mg de benzoilmetronidazol, que equivalem a 25 mg de metronidazol. Na giardíase a bula usa volume fixo por idade: 1 a 5 anos, 5 mL duas vezes ao dia; 5 a 10 anos, 5 mL três vezes ao dia. A bula não fixa teto pediátrico. Contém açúcar. Suspensão pronta, em temperatura ambiente e protegida da luz.

Fonte: Flagyl® Pediátrico, Sanofi-Aventis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jul. 2023); benzoilmetronidazol genérico (mesmo portal); IN 360/2025, art. 1º (metronidazol)

Sulfametoxazol + trimetoprima. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 30 a 45 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.200 mg por tomada; 2.400 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL; Suspensão F 400 mg + 80 mg/5 mL

Idade: Suspensão comum acima de 6 semanas; suspensão F acima de 6 meses

Duração usual: Infecção aguda: no mínimo 5 dias ou até 2 dias sem sintomas

Observação: Calculado pelo sulfametoxazol. A bula fixa doses por idade que correspondem a cerca de 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol (6 mg/kg/dia de trimetoprima), de 12 em 12 horas; em infecção grave, até 50% a mais (45 mg/kg/dia). Teto: dose máxima de adulto em casos graves, 1200 mg de sulfametoxazol de 12 em 12 horas (dose habitual de adulto: 800 mg).

Fonte: Bactrim® suspensão, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Albendazol. *Venda sob prescrição (fora da LMIP)*

Dose: por idade: acima de 2 anos (adulto e criança): 400 mg; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido mastigável 400 mg (caixa com 1); Suspensão oral 40 mg/mL (frasco de 10 mL, dose única)

Idade: Uso acima de 2 anos; abaixo disso, a bula não traz dose

Duração usual: Dose única (ascaridíase, ancilostomíase, tricuríase, enterobíase); 3 dias (estrongiloidíase, teníase, himenolepíase); 5 dias na giardíase de 2 a 12 anos

Observação: A dose não muda com o peso nem com a idade acima de 2 anos: 400 mg (1 comprimido mastigável ou 10 mL da suspensão). Larva migrans cutânea: 400 mg/dia por 1 a 3 dias. Opistorquíase: 400 mg 2 vezes ao dia por 3 dias (por isso o seletor vai até 2 tomadas).

Fonte: Zentel®, GlaxoSmithKline Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ivermectina. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 0,2 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 6 mg (sulcado)

Idade: Contraindicada abaixo de 15 kg ou de 5 anos

Duração usual: Dose única; em geral não é preciso repetir (conforme avaliação médica)

Observação: Bula: cerca de 200 mcg/kg em dose única (estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose, pediculose). Tabela da bula: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1; 36 a 50 kg, 1 e meio; 51 a 65 kg, 2; 66 a 79 kg, 2 e meio; 80 kg ou mais, 200 mcg/kg. Oncocercose: 150 mcg/kg. Tomar com água. Não usar com barbitúricos, benzodiazepínicos, ácido valproico ou oxibato de sódio.

Fonte: Revectina®, Abbott Laboratórios do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Levamisol. *MIP (LMIP: só ascaridíase, comprimido até 150 mg)*

Dose: por idade: lactentes até 1 ano: 40 mg; 1 a 7 anos: 80 mg; acima de 7 anos e adultos: 150 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 80 mg (infantil); Comprimido 150 mg (adulto)

Idade: Abaixo de 6 meses, só com prescrição médica (bula)

Duração usual: Dose única

Observação: Indicado para ascaridíase. Lactente até 1 ano: meio comprimido de 80 mg. Tomar em dose única; a bula do Ascaridil® não pede laxante nem dieta.

Fonte: Ascaridil®, Janssen-Cilag Farmacêutica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; última atualização da bula em mar. 2025); LMIP pela IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025

Mebendazol suspensão. *MIP (LMIP: suspensão oral 20 mg/mL)*

Dose: por idade: 1 ano ou mais (nematódeos): 100 mg; 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão oral 20 mg/mL (Pantelmin®)

Idade: Contraindicado abaixo de 1 ano; de 1 a 2 anos, só se o benefício justificar o risco

Duração usual: 3 dias consecutivos

Observação: Nematódeos: 5 mL (100 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias, independentemente de peso e idade. Cestódeos: adulto 10 mL (200 mg) e criança 5 mL, 2 vezes ao dia por 3 dias; a bula não fixa a idade em que se passa à dose de adulto.

Fonte: Pantelmin® suspensão oral (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio de 2024); enquadramento na LMIP pela IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025

Nitazoxanida. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 7,5 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 20 mg/mL

Idade: Suspensão a partir de 1 ano; comprimido a partir de 12 anos

Duração usual: 3 dias na maioria das indicações; 14 dias em criptosporidíase de imunodeprimido com CD4 acima de 50

Observação: 0,375 mL/kg (7,5 mg/kg) de 12 em 12 horas, com alimentos. O teto de 500 mg por dose corresponde à dose do comprimido para maiores de 12 anos. Preparada: 7 dias.

Fonte: Annita®, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Pamoato de pirvínio. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 10 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: 600 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 10 mg/mL; Drágea 100 mg (acima de 12 anos)

Idade: Suspensão não recomendada abaixo de 10 kg; drágea a partir de 12 anos

Duração usual: Dose única; repetir cerca de 2 semanas depois

Observação: Indicado na oxiuríase (enterobíase). Suspensão: 1 mL/kg em tomada única; drágea: 1 para cada 10 kg. Máximo de 600 mg (60 mL ou 6 drágeas), qualquer que seja o peso. A repetição após 2 semanas cobre a recontaminação. Pode manchar roupas. Frasco aberto vale 6 meses.

Fonte: Pyr-Pam®, Uci-Farma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jun. 2024)

Praziquantel. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 5 a 25 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 150 mg (Cestox®; conferir o número de comprimidos da caixa)

Idade: Tabela da bula a partir de 12 kg; abaixo de 4 anos, a bula do praziquantel (Cisticid®) cita falta de dados de segurança

Duração usual: Dose única; na himenolepíase, repetir após 10 dias

Observação: Faixa larga porque depende do verme. Teníase: 5 a 10 mg/kg em tomada única. Himenolepíase: 15 a 25 mg/kg em tomada única. Na teníase, a tabela da bula dá 1 comprimido de 150 mg de 12 a 19 kg e 2 comprimidos de 20 a 39 kg. Engolir inteiro, sem mastigar, durante uma refeição. Contraindicado na cisticercose ocular.

Fonte: Cestox® 150 mg (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página sem dizeres legais, atualizada em maio 2024); Praziquantel (bula do Cisticid®, mesmo portal)

Praziquantel 500 mg (cisticercose). *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 30 a 50 mg/kg/dia; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 500 mg com sulco em cruz (Cisticid®: caixa com 50)

Idade: Uso a partir de 4 anos; abaixo disso, só com controle médico rigoroso

Duração usual: Cisticercose subcutânea ou muscular: 30 mg/kg/dia por 7 dias; neurocisticercose: 50 mg/kg/dia por 15 dias, com o paciente internado

Observação: Esquema diferente do praziquantel de 150 mg da teníase (dose única). Bula: cisticercose subcutânea ou muscular, 30 mg/kg/dia em 3 tomadas com intervalo de 4 a 6 horas, por 7 dias; neurocisticercose, 50 mg/kg/dia em 3 tomadas por 15 dias, só com o paciente hospitalizado e acompanhado por neurologista ou neurocirurgião. Engolir inteiro, durante a refeição; o comprimido tem sulco em cruz. Contraindicado na cisticercose ocular e com rifampicina. Toranja aumenta o nível do praziquantel; carbamazepina, fenitoína, dexametasona e cloroquina diminuem.

Fonte: Cisticid®, Merck (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); Praziquantel 500 mg, mesmo portal (página atualizada em fev. 2024)

Secnidazol. *Prescrição (sem retenção; secnidazol não consta da IN 360/2025)*

Dose: 30 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: 2.000 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 30 mg/mL (frasco de 450 mg para 15 mL ou de 900 mg para 30 mL)

Idade: A bula da suspensão não fixa idade mínima

Duração usual: Amebíase intestinal e giardíase: dose única; amebíase hepática: 30 mg/kg/dia por 5 a 7 dias

Observação: Bula: 30 mg/kg (1 mL/kg) em tomada única, no máximo 2 g, de preferência numa refeição à noite. Preparo: completar com água até a marca do frasco e agitar 1 minuto; a sobra deve ser descartada. Contraindicado na gestação suspeita, no 1º trimestre e no aleitamento. Evitar bebida alcoólica durante o uso e até 4 dias depois.

Fonte: Secnidazol suspensão oral, EMS (genérico; texto da bula reproduzido em bula.com.br, atualizado em set. 2026); Secnidazol, texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; IN 360/2025, art. 1º

Cetoconazol comprimido. *Prescrição (sem retenção; cetoconazol não consta da IN 360/2025)*

Dose: 15 a 30 kg (meio comprimido): 100 mg; acima de 30 kg (1 comprimido, às vezes 2): 200 a 400 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 400 mg/dia

Apresentações: Comprimido 200 mg (a bula manda meio comprimido na faixa de 15 a 30 kg)

Idade: Não recomendado abaixo de 15 kg nem abaixo de 2 anos (uso não estudado)

Duração usual: Conforme a micose e a resposta clínica

Observação: Uso oral reservado pela bula a micoses sistêmicas e profundas (blastomicose, coccidioidomicose, histoplasmose, cromomicose, paracoccidioidomicose) quando outras terapias falharam ou não foram toleradas, por causa do risco de toxicidade hepática grave. Contraindicado na doença hepática aguda ou crônica; suspender e procurar o médico se surgir falta de apetite, náusea, vômito, cansaço, icterícia, dor abdominal ou urina escura. Tomar numa refeição; com acidez gástrica reduzida a absorção cai (a bula sugere bebida ácida). Inibe o CYP3A4: conferir toda a prescrição antes de dispensar. Fabricante e tamanho da caixa não aparecem na página consultada.

Fonte: Cetoconazol comprimido 200 mg, genérico (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em set. 2023, sem fabricante identificado); IN 360/2025, art. 1º (cetoconazol não listado)

Fluconazol cápsula. *Prescrição (sem retenção; fluconazol não consta da IN 360/2025)*

Dose: 3 a 12 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 400 mg/dia

Apresentações: Cápsula 100 mg (Zoltec®: caixa com 8)

Idade: Acima de 4 semanas: dose diária. Nas 2 primeiras semanas de vida, a mesma dose em mg/kg a cada 72 horas; na 3ª e 4ª semana, a cada 48 horas

Duração usual: Conforme a resposta clínica e micológica; candidíase orofaríngea costuma levar 7 a 14 dias

Observação: Bula, crianças: candidíase de mucosa, 3 mg/kg uma vez ao dia (pode haver ataque de 6 mg/kg no 1º dia); candidíase sistêmica e criptococose, 6 a 12 mg/kg uma vez ao dia; prevenção em neutropenia, 3 a 12 mg/kg/dia. A criança não pode passar da dose diária máxima de adulto; o teto de 400 mg/dia é a maior dose diária de adulto da bula. A

cápsula não pode ser partida nem aberta: a dose só fecha quando dá em cápsulas inteiras, senão o prescritor precisa ajustar. A cápsula de 150 mg em dose única não é recomendada abaixo de 18 anos sem supervisão médica. Não usar com terfenadina, cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida ou quinidina. Insuficiência renal muda a dose.

Fonte: Zoltec®, Pfizer Brasil, e Fluconazol genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026; páginas atualizadas em abr. 2025 e ago. 2024); IN 360/2025, art. 1º (fluconazol não listado)

Griseofulvina. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 10 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg/dia

Apresentações: Comprimido 500 mg (sulcado)

Idade: A bula não fixa idade mínima

Duração usual: Longo: resposta em cerca de 1 mês na pele, 6 a 8 semanas no couro cabeludo e até 6 meses nas unhas; até 12 meses em infecção resistente

Observação: Bula: crianças, 10 mg/kg/dia em dose única ou fracionada, após as refeições. Teto de 1000 mg/dia deduzido da dose de adulto em casos graves. Comprimido de 500 mg sulcado: doses pequenas podem não ser viáveis com o comprimido, confira com o prescritor. Contraindicada na gestação e na lactação; evitar gravidez durante o uso e até 1 mês depois. Confira a disponibilidade do produto no mercado.

Fonte: Fulcin®, AstraZeneca do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); IN 360/2025, art. 1º (griseofulvina não listada)

Nistatina suspensão oral. *Venda sob prescrição (nistatina oral fora da LMIP)*

Dose: por idade: lactentes (1 a 2 mL): 100.000 a 200.000 UI; crianças e adultos (1 a 6 mL): 100.000 a 600.000 UI; 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão oral 100.000 UI/mL

Idade: Prematuro e baixo peso: 1 mL (100.000 UI) 4 vezes ao dia

Duração usual: Até 48 horas depois de sumirem os sintomas; sem melhora após 14 dias, reavaliar

Observação: Bula: prematuro e baixo peso, 1 mL; lactente, 1 a 2 mL; criança e adulto, 1 a 6 mL; 4 vezes ao dia. No lactente, metade da dose em cada lado da boca. A bula não define a idade de lactente; aqui foi usado até 2 anos.

Fonte: Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL, bula de genérico que remete à bula do profissional do Canditrat® (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; última atualização em mar. 2025)

Oseltamivir. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: até 15 kg: 30 mg; acima de 15 até 23 kg: 45 mg; acima de 23 até 40 kg (2 cápsulas de 30 mg): 60 mg; acima de 40 kg: 75 mg; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Cápsula 30 mg; Cápsula 45 mg; Cápsula 75 mg

Idade: Tabela por peso de 1 a 12 anos; a partir de 13 anos, 75 mg; abaixo de 1 ano a bula diz que segurança e eficácia não foram estabelecidas

Duração usual: Tratamento: 2 vezes ao dia por 5 dias, iniciar nas primeiras 48 horas de sintomas; profilaxia: 1 vez ao dia por 10 dias, iniciar em até 2 dias após o contato

Observação: A dose por tomada sai da faixa de peso; tratamento de 12 em 12 horas, profilaxia uma vez ao dia. Acima de 40 kg: 1 cápsula de 75 mg ou uma de 30 mg mais uma de 45 mg. Quem não engole cápsula pode abrir e misturar o pó em no máximo 1 colher de chá de alimento doce. Função renal reduzida muda a dose. Convulsão e delírio foram relatados, sobretudo em crianças e adolescentes.

Fonte: Tamiflu®, Roche, sob licença de Gilead Sciences (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Bromoprida gotas. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,17 a 0,33 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 60 mg/dia

Apresentações: Gotas pediátricas 4 mg/mL (Digesan®: 24 gotas/mL) (24 gotas/mL)

Idade: Contraindicada abaixo de 1 ano

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: 1 a 2 gotas/kg, 3 vezes ao dia. Com 4 mg/mL e 24 gotas/mL, cada gota tem cerca de 0,17 mg, e a faixa equivale a 0,17 a 0,33 mg/kg por tomada. O teto de 60 mg/dia é a dose máxima de adulto da bula. Pode causar reações extrapiramidais; a bula contraindica o uso com outros medicamentos que também as provocam.

Fonte: Digesan® gotas pediátricas, Eurofarma; bromoprida gotas pediátrica, genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026; páginas atualizadas em abr. 2025 e ago. 2024)

Dimenidrinato + piridoxina gotas (2 a 6 anos). *Venda sob prescrição*

Dose: 1,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 75 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de dimenidrinato + 5 mg/mL de piridoxina (Dramin® B6: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Gotas contraindicadas abaixo de 2 anos; esta linha vale de 2 a 6 anos

Duração usual: Conforme a necessidade; intervalo de 6 a 8 horas

Observação: Calculado pelo dimenidrinato. Bula: 1 gota/kg (1,25 mg/kg) a cada 6 a 8 horas, sem passar de 60 gotas (75 mg) em 24 horas nessa idade. Pingar numa colher, não direto na boca. Causa sonolência; em crianças pequenas pode causar excitação.

Fonte: Dramin® B6 gotas, Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dimenidrinato + piridoxina gotas (6 a 12 anos). *Venda sob prescrição*

Dose: 1,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de dimenidrinato + 5 mg/mL de piridoxina (Dramin® B6: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 6 a 12 anos

Duração usual: Conforme a necessidade; intervalo de 6 a 8 horas

Observação: Calculado pelo dimenidrinato. Bula: 1 gota/kg (1,25 mg/kg) a cada 6 a 8 horas, sem passar de 120 gotas (150 mg) em 24 horas nessa idade. Acima de 12 anos: 1 gota/kg a cada 4 a 6 horas, até 320 gotas (400 mg) por dia. Causa sonolência.

Fonte: Dramin® B6 gotas, Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Domperidona suspensão. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 10 mg por tomada; 1 mg/kg/dia; 35 mg/dia

Apresentações: Suspensão oral 1 mg/mL (seringa)

Idade: A partir de 12 anos, ou abaixo de 12 anos só com 35 kg ou mais. Em lactentes e crianças abaixo de 12 anos e de 35 kg a eficácia não foi estabelecida

Duração usual: Náusea e vômito agudos: em geral até 1 semana; outras indicações: até 4 semanas e então reavaliar

Observação: Abaixo de 35 kg (12 anos ou mais): 0,25 mL/kg (0,25 mg/kg) 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições, e, se necessário, uma dose ao deitar; teto de 1 mg/kg/dia e 35 mg/dia. Com 35 kg ou mais: 10 mg (10 mL) 3 vezes ao dia, até 40 mg/dia; nessa faixa o teto de 35 mg/dia da calculadora não se aplica.

Fonte: Motilium® suspensão oral, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Escopolamina, butilbrometo (gotas). *MIP*

Dose: 0,3 a 0,5 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 10 mg/mL (Buscopan®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 1 a 6 anos; abaixo de 1 ano a bula usa outra dose por kg (ver observação)

Duração usual: Uso sintomático; não usar de forma contínua sem investigar a causa da dor abdominal

Observação: Bula, de 1 a 6 anos: 0,3 a 0,5 mg/kg por dose, 3 vezes ao dia (ou 10 a 20 gotas 3 vezes ao dia). Até 3 meses: 1,5 mg/kg por dose; de 3 a 11 meses: 0,7 mg/kg por dose; ambos 3 vezes ao dia. Acima de 6 anos: 20 a 40 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. A bula não fixa teto diário para criança.

Fonte: Buscopan® gotas e Buscopan® Pediátrico gotas, Cosmed (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Lactulose xarope. *MIP*

Dose: por idade: lactentes: 5 mL; 1 a 5 anos: 5 a 10 mL; 6 a 12 anos: 10 a 15 mL; acima de 12 anos e adultos: 15 a 30 mL; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Xarope 667 mg/mL (dose em mL; frasco de 120 mL ou sachês de 15 mL)

Idade: Uso em criança só com orientação médica (bula)

Duração usual: Constipação crônica: ajustar à resposta

Observação: Dose em mL do xarope 667 mg/mL, por dia, de preferência em tomada única pela manhã ou à noite. Flatulência e cólica são comuns no início. Constipação na criança merece avaliação: encaminhe antes de indicar.

Fonte: Lactulona®, Daiichi Sankyo Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; última atualização da bula em mar. 2025)

Omeprazol MUPS (esofagite grave, criança). *Venda sob prescrição*

Dose: 10 a 20 kg (10 mg; se preciso, 20 mg): 10 a 20 mg; acima de 20 kg (20 mg; se preciso, 40 mg): 20 a 40 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido MUPS 10 mg (dispersível em água); Comprimido MUPS 20 mg (dispersível em água)

Idade: A partir de 1 ano, com 10 kg ou mais

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula do Losec® MUPS, esofagite de refluxo grave em crianças a partir de 1 ano: 10 a 20 kg, 10 mg uma vez ao dia; acima de 20 kg, 20 mg; se necessário, 20 mg e 40 mg. Tomar pela manhã. Não partir, esmagar nem mastigar: quem não engole pode dispersar o comprimido em meio copo de água sem gás ou suco de fruta (nunca leite ou água com gás) e tomar em até 30 minutos, sem mastigar os grânulos. Abaixo de 10 kg a bula não traz dose.

Fonte: Losec® MUPS, AstraZeneca/Biopas (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ondansetrona comprimido orodispersível. *Venda sob prescrição*

Dose: por idade: 2 a 11 anos: 4 mg; acima de 11 anos: 4 a 8 mg; 1 a 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido orodispersível 4 mg; Comprimido orodispersível 8 mg (acima de 11 anos)

Idade: 4 mg acima de 2 anos; 8 mg acima de 11 anos

Duração usual: Pós-operatório: dose única 1 hora antes da anestesia; quimioterapia e radioterapia: por 1 a 2 dias após o término, conforme o esquema

Observação: Prevenção de náusea e vômito: 2 a 11 anos, 4 mg; acima de 11 anos, 4 a 8 mg; adulto até 16 mg (2 comprimidos de 8 mg), conforme a bula. Na quimioterapia e na radioterapia, a criança de 2 a 11 anos toma 4 mg a cada 8 horas (3 vezes ao dia). Insuficiência hepática grave: até 8 mg/dia.

Fonte: Vonau® Flash, Biolab (bulário do m20; texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Simeticona gotas. *MIP*

Dose: por idade: lactentes (3 a 5 gotas): 9 a 15 mg; crianças até 12 anos (5 a 10 gotas): 15 a 30 mg; acima de 12 anos e adultos (13 gotas): 39 mg; 3 tomadas por dia

Tetos: 500 mg/dia

Apresentações: Gotas 75 mg/mL (Luftal®: 25 gotas/mL, 3 mg por gota) (25 gotas/mL)

Idade: Sem contraindicação por faixa etária na bula

Duração usual: Uso sintomático; dor abdominal persistente: encaminhar

Observação: A bula dá a dose em gotas: lactentes, 3 a 5 gotas; crianças até 12 anos, 5 a 10 gotas, no máximo 60 gotas (180 mg) por dia; acima de 12 anos, 13 gotas; sempre 3 vezes ao dia. Teto de adulto: 500 mg/dia (166 gotas). A bula não define a idade de lactente; aqui foi usado até 2 anos. Pode reduzir a absorção da levotiroxina.

Fonte: Luftal® gotas, Reckitt Benckiser Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Cetirizina solução oral. *Venda sob prescrição (fora da LMIP)*

Dose: por idade: 2 a 6 anos: 2,5 mg; 6 a 12 anos: 5 mg; adultos e 12 anos ou mais: 10 mg; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 10 mg/dia

Apresentações: Solução oral 1 mg/mL (frasco de 120 mL); Comprimido revestido 10 mg (acima de 12 anos)

Idade: Solução oral a partir de 2 anos; comprimido só acima de 12 anos

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Abaixo de 12 anos são 2 tomadas (manhã e noite): 2 a 6 anos, 2,5 mL; 6 a 12 anos, 5 mL. A partir de 12 anos, 10 mL 1 vez ao dia (escolha 1 tomada); a bula admite começar com 5 mL. Pode dar sonolência.

Fonte: Zyrtec® solução oral e comprimido (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Desloratadina xarope. *MIP pela LMIP (solução oral até 1,25 mg/mL); confira a frase da embalagem*

Dose: por idade: 6 a 11 meses: 1 mg; 1 a 5 anos: 1,25 mg; 6 a 11 anos: 2,5 mg; 12 anos ou mais: 5 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 5 mg/dia

Apresentações: Xarope 0,5 mg/mL (frascos de 60 e 100 mL, com seringa)

Idade: Acima de 6 meses

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Bula: 6 a 11 meses, 2 mL; 1 a 5 anos, 2,5 mL; 6 a 11 anos, 5 mL; 12 anos ou mais, 10 mL; 1 vez ao dia. Dose maior não aumenta o efeito. O Desalex® consultado traz venda sob prescrição na embalagem, embora o fármaco conste da LMIP.

Fonte: Desalex® xarope, Organon (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025 (LMIP)

Dexclorfeniramina gotas (2 a 6 anos). *MIP*

Dose: 0,05 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 3 mg/dia

Apresentações: Gotas 2,8 mg/mL (Polaramine®: 28 gotas/mL, 0,1 mg por gota) (28 gotas/mL)

Idade: Contraindicada abaixo de 2 anos; esta linha vale de 2 a 6 anos

Duração usual: Uso sintomático

Observação: Bula: 1 gota para cada 2 kg, 3 vezes ao dia (cada gota tem 0,1 mg de maleato de dexclorfeniramina), ou dose fixa de 5 gotas 3 vezes ao dia. Teto de 3 mg/dia (30 gotas). A solução oral 0,4 mg/mL tem só dose por idade na bula (1,25 mL 3 vezes ao dia nessa faixa), sem cálculo por peso. Dá sonolência.

Fonte: Polaramine® solução gotas e solução oral, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dexclorfeniramina gotas (6 a 12 anos). *MIP*

Dose: 0,05 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 6 mg/dia

Apresentações: Gotas 2,8 mg/mL (Polaramine®: 28 gotas/mL, 0,1 mg por gota) (28 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 6 a 12 anos

Duração usual: Uso sintomático

Observação: Bula: 1 gota para cada 2 kg, 3 vezes ao dia, ou dose fixa de 10 gotas 3 vezes ao dia. Teto de 6 mg/dia (60 gotas). Acima de 12 anos: 20 gotas 3 a 4 vezes ao dia, até 12 mg/dia (120 gotas). A solução oral 0,4 mg/mL tem só dose por idade na bula (2,5 mL 3 vezes ao dia nessa faixa).

Fonte: Polaramine® solução gotas e solução oral, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dexclorfeniramina solução oral. *MIP*

Dose: por idade: 2 a 6 anos (1,25 mL): 0,5 mg; 6 a 12 anos (2,5 mL): 1 mg; adultos e maiores de 12 anos (5 mL): 2 mg; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 12 mg/dia

Apresentações: Solução oral 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL; frasco de 120 mL)

Idade: Contraindicada abaixo de 2 anos

Duração usual: Uso sintomático

Observação: Bula: 2 a 6 anos, 1,25 mL 3 vezes ao dia (máximo 3 mg ou 7,5 mL/dia); 6 a 12 anos, 2,5 mL 3 vezes ao dia (máximo 6 mg ou 15 mL/dia); adultos e maiores de 12 anos, 5 mL 3 a 4 vezes ao dia (máximo 12 mg ou 30 mL/dia). Abaixo de 12 anos, use 3 tomadas; a calculadora só confere o teto de adulto. Dá sonolência. As gotas estão em outras linhas da calculadora.

Fonte: Polaramine® solução oral, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ebastina xarope. *MIP (LMIP: solução oral 1 mg/mL)*

Dose: por idade: 2 a 5 anos: 2,5 mg; 6 a 11 anos: 5 mg; 12 anos ou mais: 10 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Xarope 1 mg/mL (frasco de 60 mL, com seringa); Comprimido revestido 10 mg (12 anos ou mais)

Idade: Xarope contraindicado abaixo de 2 anos; comprimido contraindicado abaixo de 12 anos

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Bula: 2 a 5 anos, 2,5 mL; 6 a 11 anos, 5 mL; 12 anos ou mais, 10 mL; 1 vez ao dia. O comprimido de 10 mg pode ir a 20 mg 1 vez ao dia na rinite intensa do adulto.

Fonte: Ebastel® xarope e comprimido (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Fexofenadina suspensão oral. *MIP (LMIP: suspensão oral 6 mg/mL)*

Dose: por idade: 6 meses a 2 anos (só urticária): 15 mg; 2 a 11 anos: 30 mg; 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão oral 6 mg/mL (frascos de 60 e 150 mL)

Idade: Rinite alérgica: a partir de 2 anos; urticária crônica: a partir de 6 meses. A partir de 12 anos, comprimido

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Bula: 6 meses a 2 anos (ou até 10,5 kg), 2,5 mL (15 mg) a cada 12 horas, só na urticária crônica idiopática; 2 a 11 anos (ou acima de 10,5 kg), 5 mL (30 mg) a cada 12 horas, na rinite ou na urticária. Agitar antes de usar.

Fonte: Allegra® Pediátrico suspensão oral, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Hidroxizina comprimido. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,7 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 2 mg/kg/dia; 100 mg/dia

Apresentações: Comprimido revestido 25 mg

Idade: Comprimido só a partir de 12 anos e 30 kg; abaixo disso, xarope

Duração usual: Tratamento restrito a 10 dias, salvo orientação médica

Observação: Bula: criança, 0,7 mg/kg a cada 8 horas; até 40 kg, no máximo 2 mg/kg/dia; acima de 40 kg, no máximo 100 mg/dia. Adulto: 25 mg 3 a 4 vezes ao dia; idoso, no máximo 50 mg/dia. Três tomadas de 0,7 mg/kg somam 2,1 mg/kg/dia: a calculadora acusa o teto, e a diferença está na própria bula. Dá sonolência; cuidado com outros depressores e ao dirigir. Contém lactose.

Fonte: Hixizine® (dicloridrato de hidroxizina) comprimido, Theraskin (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Hidroxizina xarope. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,7 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 2 mg/kg/dia; 100 mg/dia

Apresentações: Xarope 2 mg/mL (seringa dosadora de 10 mL)

Idade: Xarope a partir de 6 meses; comprimidos só a partir de 12 anos e 30 kg

Duração usual: Tratamento restrito a 10 dias, salvo orientação médica (bula, para adultos e crianças acima de 6 anos)

Observação: Bula: 0,7 mg/kg a cada 8 horas. A mesma bula limita a 2 mg/kg/dia até 40 kg e a 100 mg/dia acima de 40 kg. Três tomadas de 0,7 mg/kg somam 2,1 mg/kg/dia: a calculadora acusa o teto, e a diferença está na própria bula. A bula também traz a dose em mL por faixa de peso (ex.: 12 a 24 kg, 4 a 8,5 mL por tomada). Dá sonolência; cuidado com outros depressores do sistema nervoso central.

Fonte: Hixizine® xarope, Theraskin (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Levocetirizina gotas (2 a 6 anos). *MIP (LMIP: solução oral 5 mg/mL)*

Dose: por idade: 2 a 6 anos: 1,25 mg; 2 tomadas por dia

Tetos: 2,5 mg/dia

Apresentações: Gotas 5 mg/mL (Zyxem®: 20 gotas/mL, 0,25 mg por gota; frasco de 20 mL) (20 gotas/mL)

Idade: Abaixo de 2 anos não recomendado (dados limitados); esta linha vale de 2 a 6 anos

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Bula: 2,5 mg/dia divididos em 2 tomadas de 1,25 mg (5 gotas) a cada 12 horas. Teto de 2,5 mg/dia nessa faixa. Ajustar em doença renal.

Fonte: Zyxem® gotas, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Levocetirizina gotas (6 anos ou mais). *MIP (LMIP: solução oral 5 mg/mL e comprimido 5 mg)*

Dose: por idade: 6 anos ou mais: 5 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 5 mg/dia

Apresentações: Gotas 5 mg/mL (Zyxem®: 20 gotas/mL, 0,25 mg por gota; frasco de 20 mL) (20 gotas/mL); Comprimido revestido 5 mg

Idade: Esta linha vale a partir de 6 anos; o comprimido não é recomendado abaixo de 6 anos

Duração usual: Uso sintomático ou conforme prescrição

Observação: Bula: 6 a 12 anos e adultos, 5 mg (20 gotas ou 1 comprimido) 1 vez ao dia; de 6 a 12 anos, 5 mg é o máximo diário. Ajustar em doença renal.

Fonte: Zyxem® gotas e comprimidos, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Loratadina xarope. *MIP*

Dose: abaixo de 30 kg: 5 mg; acima de 30 kg: 10 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 10 mg/dia

Apresentações: Xarope 1 mg/mL (copo-medida)

Idade: Xarope a partir de 2 anos

Duração usual: Uso sintomático, uma vez ao dia

Observação: Bula, de 2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL (5 mg) uma vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL (10 mg). Acima de 12 anos: 10 mg. A bula não diz o que fazer com exatamente 30 kg; a calculadora usa 5 mg até 30 kg. Na doença do fígado ou insuficiência renal, a mesma dose em dias alternados.

Fonte: Claritin® xarope, Bayer (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Acetilcisteína xarope pediátrico. *MIP (LMIP: solução oral até 40 mg/mL)*

Dose: por idade: 2 a 4 anos (2 a 3 vezes ao dia): 100 mg; acima de 4 anos (3 a 4 vezes ao dia): 100 mg; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Xarope pediátrico 20 mg/mL

Idade: Contraindicado abaixo de 2 anos

Duração usual: Adulto: 5 a 10 dias; persistindo os sintomas, procurar o médico

Observação: Bula: 5 mL (100 mg) por tomada; 2 a 4 anos, 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos, 3 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico (a dose pode ser dobrada só com prescrição). O xarope adulto (40 mg/mL) é de 600 mg 1 vez ao dia, à noite. Depois de aberto, usar em até 14 dias.

Fonte: Fluimucil® xarope pediátrico e adulto, Zambon (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ambroxol (xarope pediátrico e gotas). *MIP*

Dose: 0,5 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 90 mg/dia

Apresentações: Xarope pediátrico 3 mg/mL (15 mg/5 mL); Gotas 7,5 mg/mL (Mucosolvan®: 1 mL = 25 gotas) (25 gotas/mL)

Idade: Abaixo de 2 anos, só com prescrição médica (bula)

Duração usual: Doença aguda: em geral até 14 dias

Observação: Bula: 0,5 mg/kg 3 vezes ao dia por via oral. O teto de 90 mg/dia corresponde à dose de adulto (4 mL das gotas 3 vezes ao dia, que a bula chama de dose diária máxima de 12 mL). As gotas também servem para inalação, com outra dose (0,6 mg/kg, 1 a 2 vezes ao dia): não use este cálculo para inalação. O xarope contém sorbitol (evitar na intolerância à frutose).

Fonte: Mucosolvan® gotas e xarope pediátrico, Sanofi Medley, fabricado por Boehringer Ingelheim (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Bromexina xarope. *MIP (LMIP: xarope até 1,6 mg/mL)*

Dose: por idade: 2 a 6 anos: 2 mg; 6 a 12 anos: 4 mg; acima de 12 anos: 8 mg; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Xarope infantil 4 mg/5 mL (0,8 mg/mL; frasco de 120 mL); Xarope adulto 8 mg/5 mL (1,6 mg/mL; frasco de 120 mL; acima de 12 anos)

Idade: Não usar abaixo de 2 anos

Duração usual: Uso sintomático; tosse que persiste: encaminhar

Observação: Bula, xarope infantil 4 mg/5 mL: 2 a 6 anos, 2,5 mL; 6 a 12 anos, 5 mL; acima de 12 anos, 10 mL; 3 vezes ao dia. Xarope adulto 8 mg/5 mL: 5 mL 3 vezes ao dia acima de 12 anos. Beber bastante líquido junto.

Fonte: Bisolvon® xarope infantil e adulto (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Guaifenesina xarope. *MIP (LMIP: solução oral até 16 mg/mL)*

Dose: por idade: 2 a 6 anos: 66,7 mg; 6 a 12 anos: 100 mg; adultos e maiores de 12 anos: 200 mg; 1 a 6 tomadas por dia

Tetos: 2.400 mg/dia

Apresentações: Xarope 13,3 mg/mL (200 mg/15 mL; frasco de 120 mL)

Idade: Contraindicado abaixo de 2 anos

Duração usual: Se a tosse passar de 7 dias ou vier com febre: médico

Observação: Bula, xarope 13,3 mg/mL: 2 a 6 anos, 5 mL; 6 a 12 anos, 7,5 mL; adultos e maiores de 12 anos, 15 mL; a cada 4 horas. Tetos diários: 600 mg (2 a 6 anos), 1.200 mg (6 a 12 anos) e 2.400 mg (adulto); a calculadora só confere o de adulto. A concentração e o mL por dose mudam entre fabricantes (há xarope sabor mel com outra dose): confira a bula do frasco.

Fonte: Guaifenesina xarope 13,3 mg/mL, Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Bula.com.br, consultado em out. 2026; bula atualizada em jul. 2025)

Montelucaste. *Venda sob prescrição*

Dose: por idade: 6 meses a 2 anos (sachê, asma): 4 mg; 2 a 5 anos: 4 mg; 6 a 14 anos: 5 mg; 15 anos ou mais: 10 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Granulado oral 4 mg (sachê); Comprimido mastigável 4 mg; Comprimido mastigável 5 mg; Comprimido revestido 10 mg

Idade: Segurança e eficácia não estabelecidas abaixo de 6 meses

Duração usual: Uso contínuo, conforme prescrição

Observação: Bula: sachê de 4 mg de 6 meses a 5 anos na asma (na rinite alérgica, de 2 a 5 anos); comprimido mastigável de 4 mg de 2 a 5 anos; mastigável de 5 mg de 6 a 14 anos; comprimido de 10 mg a partir de 15 anos; 1 vez ao dia. Na asma, tomar ao anoitecer.

Fonte: Singulair® e Singulair® Baby (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Salbutamol xarope. *Venda sob prescrição*

Dose: por idade: 2 a 6 anos: 1 a 2 mg; 6 a 12 anos: 2 mg; acima de 12 anos: 2 a 4 mg; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Xarope 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL)

Idade: Posologia pediátrica a partir de 2 anos

Duração usual: Conforme prescrição

Observação: Bula: 2 a 6 anos, 2,5 a 5 mL (1 a 2 mg); 6 a 12 anos, 5 mL (2 mg); acima de 12 anos, 5 a 10 mL (2 a 4 mg), sempre 3 ou 4 vezes ao dia. Adulto: 4 mg (10 mL), podendo chegar a 8 mg por tomada; idoso começa com 2 mg. Na crise de falta de ar, oriente procurar atendimento.

Fonte: Aerolin® xarope, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Carbamazepina comprimido (comum e CR). *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 20 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 200 mg (comum; não partir para meia dose); Comprimido CR 200 mg (liberação prolongada; pode partir); Comprimido CR 400 mg (liberação prolongada; pode partir)

Idade: Uso adulto e pediátrico (criança que engole comprimido; para as menores, a suspensão já está na calculadora)

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: na criança, início com 100 a 200 mg/dia (base de 10 a 20 mg/kg/dia) e manutenção de 400 a 600 mg/dia; adolescentes, 600 a 1.000 mg/dia; adulto com epilepsia, 800 a 1.200 mg/dia (às vezes 1.600 a 2.000 mg). Sempre em 2 a 4 tomadas (no primeiro dia pode ser uma), durante ou após as refeições. Comprimido comum: o sulco serve só para ajudar a engolir, não para tomar meia dose. Comprimido CR: pode ser partido na linha, sem mastigar, e a metade guardada na embalagem deve ser usada em até 7 dias. Muitas interações.

Fonte: Tegretol® e Tegretol® CR, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2025)

Carbamazepina suspensão. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 20 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL, seringa dosadora)

Idade: Suspensão contraindicada no recém-nascido: menos de 4 semanas de vida (a termo) ou menos de 44 semanas (prematuro)

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: na criança, início com 100 a 200 mg/dia (base de 10 a 20 mg/kg/dia) e manutenção de 400 a 600 mg/dia; adolescentes, 600 a 1.000 mg/dia. Sempre em doses divididas, 2 a 4 vezes ao dia (no primeiro dia pode ser uma). A bula não fixa teto pediátrico; no adulto cita 1.200 mg/dia (neuralgia) e até 1.600 a 2.000 mg/dia em alguns casos de epilepsia. Agitar a suspensão. Muitas interações: conferir os outros medicamentos.

Fonte: Tegretol® suspensão oral, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2025)

Clobazam comprimido (epilepsia, criança). *Controle especial: lista B1 (Notificação de Receita B, azul, retenção)*

Dose: 0,3 a 1 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 10 mg (sulcado); Comprimido 20 mg (sulcado)

Idade: 3 a 15 anos por kg; acima de 15 anos, dose de adulto

Duração usual: Reavaliar em até 4 semanas; não suspender de repente

Observação: Bula, epilepsia em associação, de 3 a 15 anos: início com 5 mg e manutenção de 0,3 a 1 mg/kg/dia. Acima de 15 anos: início com 5 a 15 mg/dia, até 80 mg/dia. Dose única ao deitar ou dividida, com a parte maior à noite. A bula não fixa teto pediátrico. Os comprimidos de 10 e 20 mg são sulcados. Sonolência; evitar álcool e outros depressores.

Fonte: Frisium® e Urbanil®, Pharlab (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; páginas atualizadas em abr. 2025); lista B1 conferida no Anexo I da Portaria 344/98 republicado pela RDC Anvisa nº 1.023/2026

Fenitoína comprimido. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 4 a 8 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 300 mg/dia

Apresentações: Comprimido 100 mg (liso, sem sulco)

Idade: Criança: esquema por kg; acima de 6 anos pode precisar da dose mínima de adulto (300 mg/dia)

Duração usual: Uso contínuo; o efeito estável leva cerca de 1 semana; retirada gradual

Observação: Bula, criança: início com 5 mg/kg/dia divididos em duas ou três tomadas, até 300 mg/dia; manutenção usual de 4 a 8 mg/kg/dia. Adulto: 100 mg três vezes ao dia, manutenção de 300 a 400 mg/dia, máximo de 600 mg/dia; idoso começa com 3 mg/kg/dia. O teto de 300 mg/dia da calculadora é o da criança. Tomar durante ou após as refeições.

O comprimido de 100 mg é liso (sem sulco), então a dose se monta com comprimidos inteiros. Pequenas mudanças de dose podem elevar muito o nível no sangue.

Fonte: Hidantal® comprimido, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Fenobarbital comprimido (adulto). *Controle especial: lista B1, adendo do fenobarbital (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 2 a 3 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 50 mg (liso); Comprimido 100 mg (monossectado)

Idade: Comprimido: uso adulto (para criança, as gotas já estão na calculadora)

Duração usual: Uso contínuo; avaliar ajuste só após 15 dias; retirada gradual

Observação: Bula: adulto, 2 a 3 mg/kg/dia em dose única ou fracionada (a bula não fixa o número de tomadas). Reduzir no idoso, no alcoolista e na doença renal ou hepática. O comprimido de 50 mg é liso; o de 100 mg é monossectado. O abuso pode causar dependência.

Fonte: Gardenal®, Pharlab (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Fenobarbital gotas. *Controle especial: lista B1, adendo do fenobarbital (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 3 a 4 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 40 mg/mL (Gardenal®: 40 gotas/mL, 1 gota = 1 mg) (40 gotas/mL)

Idade: A bula não fixa idade mínima; contraindica o uso na gravidez e em mulheres e meninas em idade fértil

Duração usual: Uso contínuo; avaliar ajuste só após 15 dias; retirada gradual

Observação: Bula, criança: 3 a 4 mg/kg/dia em dose única ou fracionada (a bula não fixa o número de tomadas). 1 mL = 40 gotas e 1 gota = 1 mg. Diluir em água. Em uso prolongado na criança, a bula recomenda profilaxia de raquitismo com vitamina D. Contém álcool. O abuso pode causar dependência.

Fonte: Gardenal® gotas, Pharlab (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); enquadramento na lista B1 conforme o módulo Portaria 344/98 deste material

---

Levetiracetam comprimido. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 30 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.500 mg por tomada; 3.000 mg/dia

Apresentações: Comprimido revestido 250 mg; Comprimido revestido 750 mg

Idade: Comprimido a partir de 6 anos; dose por kg vale abaixo de 50 kg; abaixo de 25 kg, a bula prefere a solução

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula, terapia adjuvante abaixo de 50 kg: 10 mg/kg duas vezes ao dia, com ajustes de no máximo 10 mg/kg por dose a cada 2 semanas, até 30 mg/kg duas vezes ao dia. A partir de 50 kg, dose de adulto (até 1.500 mg duas vezes ao dia). Os comprimidos não servem para doses abaixo de 250 mg. Na função renal reduzida a dose é individualizada (no SOS, TFG pela CKD-EPI 2021).

Fonte: Keppra®, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Levetiracetam solução oral. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 30 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.500 mg por tomada; 3.000 mg/dia

Apresentações: Solução oral 100 mg/mL (seringa de 3 mL)

Idade: Esta linha vale a partir de 6 meses e abaixo de 50 kg; de 1 a 6 meses a dose é 7 a 21 mg/kg duas vezes ao dia; a partir de 50 kg, dose de adulto

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: 10 mg/kg (0,1 mL/kg) duas vezes ao dia, com aumentos de no máximo 10 mg/kg por dose a cada duas semanas, até 30 mg/kg (0,3 mL/kg) duas vezes ao dia. Teto de adulto: 1.500 mg duas vezes ao dia. Na função renal reduzida a dose cai. Medir com a seringa que acompanha o frasco.

Fonte: Keppra® solução oral, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); levetiracetam, genérico (mesmo portal)

Levetiracetam XR (uma vez ao dia). *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 20 a 60 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: 3.000 mg por tomada; 3.000 mg/dia

Apresentações: Comprimido de liberação prolongada 500 mg; Comprimido de liberação prolongada 750 mg

Idade: Adolescentes de 12 a 17 anos com menos de 50 kg; a partir de 50 kg, dose de adulto

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula do Keppra® XR, terapia adjuvante de 12 a 17 anos abaixo de 50 kg: 20 mg/kg uma vez ao dia, ajustes de no máximo 20 mg/kg a cada 2 semanas, até 60 mg/kg uma vez ao dia. Adulto: 1.000 a 3.000 mg uma vez ao dia. O XR não serve para início em criança abaixo de 25 kg nem para doses abaixo de 500 mg. Não trocar comprimido comum por XR (ou o contrário) sem a receita dizer.

Fonte: Keppra® XR, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Oxcarbazepina (suspensão e comprimidos). *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 8 a 46 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 60 mg/kg/dia

Apresentações: Suspensão oral 60 mg/mL (2 seringas dosadoras); Comprimido 300 mg (sulco divide a dose); Comprimido 600 mg (não partir para meia dose)

Idade: A partir de 1 mês de idade

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula, criança: início com 8 a 10 mg/kg/dia em duas tomadas, aumento gradual até a manutenção usual de 30 a 46 mg/kg/dia; teto de 60 mg/kg/dia. Adulto: início com 600 mg/dia, manutenção de 600 a 2.400 mg/dia (excepcionalmente até 4.200 mg/dia). Na doença renal, a dose inicial é a metade. A bula pede a receita da suspensão em mL, porque a seringa é graduada em mL: receita só em mg deve ser conferida com o prescritor. Agitar o frasco antes de cada dose. O sulco do comprimido de 300 mg divide doses iguais; o de 600 mg só pode ser partido para ajudar a engolir, não para tomar meia dose.

Fonte: Trileptal®, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Topiramato comprimido (epilepsia, criança). *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 5 a 9 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido revestido 25 mg (não partir); Comprimido revestido 50 mg (não partir); Comprimido revestido 100 mg (não partir)

Idade: Acima de 2 anos (terapia adjuvante na epilepsia)

Duração usual: Uso contínuo; retirada gradual

Observação: Bula, terapia adjuvante acima de 2 anos: 5 a 9 mg/kg/dia em duas tomadas. Titulação: 25 mg (ou 1 a 3 mg/kg/dia) à noite na primeira semana e aumentos de 1 a 3 mg/kg/dia a cada 1 ou 2 semanas; doses de até 30 mg/kg/dia foram bem toleradas. Em monoterapia, alvo inicial de 3 a 6 mg/kg/dia. Função renal: a bula usa clearance de creatinina; abaixo de 70 mL/min, metade da dose (no SOS, TFG pela CKD-EPI 2021). O comprimido não pode ser partido nem mastigado: a dose se monta com comprimidos inteiros de 25, 50 e 100 mg.

Fonte: Topamax®, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ácido valproico xarope. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 60 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 60 mg/kg/dia

Apresentações: Xarope 50 mg/mL (250 mg/5 mL, copo dosador)

Idade: Depakene® e o ácido valproico genérico consultado são contraindicados abaixo de 10 anos

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: início com 10 a 15 mg/kg/dia (crises de ausência: 15 mg/kg/dia), com aumento de 5 a 10 mg/kg por semana até a resposta, em 2 a 3 tomadas; teto de 60 mg/kg/dia. Doses diárias maiores devem ser divididas. Risco de malformação fetal: em meninas e mulheres em idade fértil a bula exige programa de prevenção da gravidez.

Fonte: Depakene® xarope, Abbott; ácido valproico, genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026)

Risperidona (irritabilidade no autismo). *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: menos de 20 kg (início 0,25 mg; dia 4: 0,5 mg; faixa 0,5 a 1,5 mg): 0,25 a 1,5 mg; 20 a 45 kg (início 0,5 mg; dia 4: 1 mg; faixa 1 a 2,5 mg): 0,5 a 2,5 mg; acima de 45 kg (como 20 kg ou mais; máximo estudado 3,5 mg): 0,5 a 3,5 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Solução oral 1 mg/mL (pipeta de 3 mL); Comprimido 0,5 mg (sulcado); Comprimido 1 mg (sulcado)

Idade: Crianças e adolescentes a partir de 5 anos (sem experiência abaixo de 5 anos)

Duração usual: Avaliar a resposta perto do 14º dia; aumentos só a cada 2 semanas ou mais

Observação: Doses da tabela da bula em mg POR DIA. Abaixo de 20 kg: 0,25 mg/dia nos dias 1 a 3, 0,5 mg/dia a partir do dia 4, aumentos de 0,25 mg; a partir de 20 kg: 0,5 mg/dia, depois 1 mg/dia, aumentos de 0,5 mg. Doses abaixo de 0,25 mg/dia não foram eficazes. A dose do dia pode ser dada de uma vez ou dividida em duas (a calculadora mostra o total em uma tomada; para duas, dividir ao meio). Sonolência melhora dando à noite ou em duas tomadas. Comprimidos sulcados; solução 1 mg/mL com pipeta de 3 mL.

Fonte: Risperdal®, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Enoxaparina tratamento 1 mg/kg (12 em 12 horas). *Venda sob prescrição*

Dose: 1 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Seringa preenchida 100 mg/mL (20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL, 60 mg/0,6 mL, 80 mg/0,8 mL, 100 mg/1 mL; usar a menor que contém a dose)

Idade: Uso adulto; a bula diz que a segurança em crianças não foi estabelecida

Duração usual: TVP: em média 10 dias, até o anticoagulante oral fazer efeito; angina instável e IAM sem supra: 2 a 8 dias

Observação: Bula: TVP com ou sem embolia pulmonar, 1 mg/kg por via subcutânea de 12 em 12 horas (esquema preferido nos casos complicados); o mesmo 1 mg/kg de 12 em 12 horas vale na angina instável e no IAM sem supra de ST, com AAS. Profilaxia não é por peso: 40 mg uma vez ao dia (ou 20 mg no risco moderado). A partir de 75 anos, no IAM com supra, a dose é 0,75 mg/kg de 12 em 12 horas, sem bolus. Função renal: a bula usa clearance de creatinina. Abaixo de 30 mL/min, os dois esquemas de tratamento passam a 1 mg/kg uma vez ao dia (e a profilaxia de 40 mg cai para 20

mg/dia); de 30 a 80 mL/min não há ajuste, só monitoramento. No SOS a função renal é estimada pela TFG CKD-EPI 2021; com valor perto de 30, confirmar a dose com o prescritor. O ajuste não vale para o uso na hemodiálise. Seringas de 60, 80 e 100 mg são graduadas: o excesso é desprezado antes de aplicar; nas de 20 e 40 mg não se tira a bolha de ar.

Fonte: Clexane® (enoxaparina sódica), Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jul. 2026)

Enoxaparina tratamento 1,5 mg/kg (uma vez ao dia). *Venda sob prescrição*

Dose: 1,5 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Seringa preenchida 100 mg/mL (60 mg/0,6 mL, 80 mg/0,8 mL, 100 mg/1 mL graduadas; 20 e 40 mg também existem)

Idade: Uso adulto; a bula diz que a segurança em crianças não foi estabelecida

Duração usual: TVP: em média 10 dias; trombose associada ao câncer: até 6 meses, conforme a receita

Observação: Bula: TVP com ou sem embolia pulmonar, 1,5 mg/kg por via subcutânea uma vez ao dia (alternativa ao 1 mg/kg de 12 em 12 horas, que a bula prefere nos casos complicados). Doses acima de 100 mg pedem duas seringas ou a combinação de seringas graduadas. Função renal: a bula usa clearance de creatinina. Abaixo de 30 mL/min, os dois esquemas de tratamento passam a 1 mg/kg uma vez ao dia (e a profilaxia de 40 mg cai para 20 mg/dia); de 30 a 80 mL/min não há ajuste, só monitoramento. No SOS a função renal é estimada pela TFG CKD-EPI 2021; com valor perto de 30, confirmar a dose com o prescritor. O ajuste não vale para o uso na hemodiálise. Peso baixo (mulher abaixo de 45 kg, homem abaixo de 57 kg) aumenta a exposição nas doses fixas de profilaxia: a bula pede monitoramento.

Fonte: Clexane® (enoxaparina sódica), Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jul. 2026)

Fondaparinux tratamento de TVP e TEP. *Venda sob prescrição*

Dose: menos de 50 kg: 5 mg; 50 a 100 kg: 7,5 mg; mais de 100 kg: 10 mg; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Seringa 7,5 mg/0,6 mL (12,5 mg/mL)

Idade: Uso adulto (a partir de 17 anos, pela bula)

Duração usual: Pelo menos 5 dias e até o anticoagulante oral estabilizar (RNI 2 a 3); duração usual de 5 a 9 dias

Observação: Bula: dose subcutânea uma vez ao dia por faixa de peso: 5 mg abaixo de 50 kg, 7,5 mg de 50 a 100 kg, 10 mg acima de 100 kg. Profilaxia e trombose venosa superficial não são por peso (2,5 mg uma vez ao dia). Função renal: a bula usa depuração de creatinina; no tratamento, não usar abaixo de 30 mL/min; na profilaxia, de 20 a 30 mL/min a dose é 2,5 mg em dias alternados e abaixo de 20 mL/min não é recomendado. No SOS a função renal é estimada pela TFG CKD-EPI 2021; com valor perto do corte, confirmar com o prescritor. A bula reproduzida lista seringas de 2,5 mg/0,5 mL e 7,5 mg/0,6 mL: a dose de 5 mg corresponde a 0,4 mL da seringa de 7,5 mg e a de 10 mg não cabe em uma seringa; conferir as apresentações à venda. O protetor da agulha contém látex.

Fonte: Arixtra® (fondaparinux sódico), Aspen Pharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Furosemida comprimido (criança). *Venda sob prescrição*

Dose: 2 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 40 mg/dia

Apresentações: Comprimido 40 mg

Idade: Lactentes e crianças abaixo de 15 anos (a bula prefere a via oral nessa faixa)

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: na criança, 2 mg/kg até o máximo de 40 mg por dia. A bula não diz em quantas tomadas; para o adulto, recomenda a dose do dia de uma vez, com o estômago vazio. Adulto: início de 20 a 80 mg/dia, manutenção de 20 a 40 mg/dia. A bula reproduzida não descreve sulco no comprimido de 40 mg: dose pequena em criança costuma não fechar com o comprimido, e aí vale a orientação do prescritor.

Fonte: Lasix®, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Sais de reidratação oral (Plano A). *MIP (sais de reidratação: notificação simplificada, LMN)*

Dose: por idade: menores de 1 ano: 50 a 100 mL; 1 a 10 anos: 100 a 200 mL; 1 a 10 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Solução preparada: 1 envelope em 1 L de água (usar em até 24 horas); Hidrafix®: flaconete de 25 mL completado para 250 mL de água

Idade: Maiores de 10 anos: a quantidade que o paciente aceitar (sem volume fixo)

Duração usual: Enquanto durar a diarreia; sem melhora em 2 dias ou com sinal de perigo, levar ao serviço de saúde

Observação: Plano A (sem desidratação, tratamento em casa): o volume é por evacuação diarreica, então aqui as tomadas por dia são as evacuações. Manter o aleitamento e a alimentação. Sinais de perigo: piora da diarreia, vômitos repetidos, muita sede, recusa de alimento, sangue nas fezes, diurese diminuída. O cartaz de 2026 do Ministério da Saúde mantém o Plano A e o zinco para menores de 5 anos, sem volumes por idade; os volumes são do cartaz anterior.

Fonte: Ministério da Saúde, cartaz Manejo do paciente com diarreia (Plano A, quantidade após cada evacuação por idade; versão publicada pela SES-GO, arquivo de 2016); Ministério da Saúde, cartaz Manejo clínico das doenças diarreicas agudas (gov.br, publicado em 09/02/2026); Hidrafix®, Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Sais de reidratação oral (Plano B). *MIP (notificação simplificada)*

Dose: 50 a 100 mL/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: SRO preparado (volume em mL; frasco = litro preparado)

Idade: Todas as idades, com desidratação (Plano B); o Plano B é feito no estabelecimento de saúde, não no balcão

Duração usual: Volume para 4 a 6 horas, com reavaliação; sem melhora em 6 horas, encaminhar ao hospital

Observação: Ministério da Saúde: apenas como orientação inicial, 50 a 100 mL/kg (média de 75 mL/kg) em 4 a 6 horas; a quantidade real depende da sede, e o SRO segue até sumirem os sinais de desidratação. Na farmácia o papel é o Plano A (sem desidratação): após cada evacuação, 50 a 100 mL abaixo de 1 ano, 100 a 200 mL de 1 a 10 anos e o quanto aceitar acima de 10 anos; e encaminhar quem tem sinais de desidratação ou de alerta. Vômitos persistentes no Plano B: antiemético só com prescrição. Preparar conforme a instrução do envelope.

Fonte: Ministério da Saúde, cartaz Manejo do paciente com diarreia, versão atualizada divulgada em 2023 (cópia lida no portal Estratégia MED em out. 2026; o bvsms.saude.gov.br estava fora do ar)

Colecalciferol (vitamina D3) gotas, profilaxia. *Venda sob prescrição (conforme a embalagem do produto)*

Dose: por idade: primeira semana de vida até 12 meses (SBP): 400 UI; 12 a 24 meses (SBP): 600 UI; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 3.300 UI/mL (Addera D3®: 132 UI por gota, 25 gotas/mL) (25 gotas/mL)

Idade: Desde a primeira semana de vida, inclusive no aleitamento materno exclusivo; pré-termo: 400 UI/dia quando passar de 1.500 g e tolerar a dieta enteral (SBP 2014)

Duração usual: Uso diário contínuo até os 24 meses (SBP 2014)

Observação: Dose de profilaxia da SBP, não de tratamento de deficiência. A bula do Addera D3® 3.300 UI/mL limita o lactente (0 a 2 anos) a 40 UI/kg/dia e no máximo 400 UI/dia (3 gotas), e acima de 2 anos a até 800 UI (6 gotas) 1 vez ao dia: a dose de 600 UI dos 12 aos 24 meses depende da prescrição. A atualização da SBP de nov. 2024 (Departamento de Endocrinologia) estende 600 UI/dia até 18 anos, conforme resumos publicados (documento original não conferido). A concentração varia muito entre marcas (há gotas de 200, 400 e 5.000 UI): confira a UI por gota do rótulo.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento de Nutrologia, Documento Científico Deficiência de vitamina D em crianças e adolescentes, out. 2014 (texto do PDF no site da SBP); Addera D3® solução oral gotas (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em ago. 2024)

Ferro polimaltosado (gotas e xarope). *Venda sob prescrição*

Dose: 2,5 a 5 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 50 mg/mL de ferro (Noripurum®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL); Xarope 10 mg/mL de ferro (copo graduado)

Idade: Uso adulto e pediátrico; a bula não fixa idade mínima

Duração usual: Anemia: 3 a 5 meses até normalizar a hemoglobina e depois 2 a 3 meses na dose de profilaxia; deficiência sem anemia: 1 a 2 meses

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR (ferro III). Bula: 2,5 a 5 mg/kg/dia conforme a gravidade, em uma ou mais tomadas. Gotas: 1 mL (20 gotas) = 50 mg, ou 2,5 mg por gota; a faixa equivale a 1 a 2 gotas/kg/dia. Tomar durante ou logo após as refeições. A bula também traz doses fixas por idade (1 a 12 anos: 10 a 20 gotas/dia na profilaxia, 20 a 40 gotas/dia no tratamento). Gotas de ferro polimaltosado e de sulfato ferroso não são intercambiáveis gota a gota.

Fonte: Noripurum® gotas e xarope, Blanver, fabricado por Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Sulfato ferroso gotas (profilaxia). *MIP*

Dose: 1 a 2 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 15 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de ferro elementar (25 gotas/mL, 1 gota = 1 mg de ferro) (25 gotas/mL)

Idade: Lactente a termo: a partir de 180 dias (sem fator de risco) ou 90 dias (com fator de risco) até 24 meses; baixo peso e prematuro: a partir de 30 dias (SBP 2021)

Duração usual: Até o 24º mês de vida (SBP 2021)

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR, não de sulfato ferroso. Na apresentação de 25 mg de ferro elementar/mL (25 gotas/mL), 1 gota = 1 mg de ferro. SBP 2021: 1 mg/kg/dia no lactente a termo; 2 mg/kg/dia no baixo peso e no prematuro acima de 1.500 g; 3 e 4 mg/kg/dia nos prematuros de 1.000 a 1.500 g e abaixo de 1.000 g, por um ano, depois 1 mg/kg/dia por mais um ano. Bula: 2 gotas/kg/dia, até 15 gotas/dia no lactente (teto usado aqui) e 50 gotas/dia na criança, ou a critério médico. Tomar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Outras marcas podem ter concentração diferente: confira se o mg/mL do rótulo é de ferro elementar ou do sal.

Fonte: Sulfato ferroso solução oral gotas, bula de genérico reproduzida no portal Consulta Remédios (página de maio de 2020, sem fabricante identificado), consultada em out. 2026; Sociedade Brasileira de Pediatria, Consenso sobre anemia ferropriva: atualização, destaques 2021 (Diretrizes nº 2, jun. 2018, atualizado em 26/08/2021)

Sulfato ferroso gotas (tratamento). *MIP*

Dose: 3 a 6 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 50 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de ferro elementar (25 gotas/mL, 1 gota = 1 mg de ferro) (25 gotas/mL)

Idade: Criança com anemia ferropriva confirmada, com prescrição

Duração usual: Seis meses ou até repor os estoques; controle com hemograma e reticulócitos em 30 a 45 dias (SBP 2021)

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR. SBP 2021: 3 a 6 mg de ferro elementar/kg/dia, em dose única ou fracionada. O teto de 50 mg/dia é o da bula para a criança (50 gotas/dia, "ou a critério médico"); a dose de tratamento da SBP pode passar dele em crianças maiores, e aí vale a receita. Na apresentação de 25 mg/mL, 1 gota = 1 mg de ferro. Tomar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Superdose de ferro é grave em criança pequena: guardar fora do alcance.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, Consenso sobre anemia ferropriva: atualização, destaques 2021 (Diretrizes nº 2, jun. 2018, atualizado em 26/08/2021); sulfato ferroso solução oral gotas, bula de genérico reproduzida no portal Consulta Remédios (página de maio de 2020), consultada em out. 2026

A calculadora confere a prescrição, não a substitui: diante de divergência, fale com o prescritor.

Concentrações que confundem

Fármaco	Apresentações	5 mL ou 1 gota entregam	Armadilha
Paracetamol	Gotas 200 mg/mL; suspensão 100 mg/mL; suspensão 32 mg/mL	5 mL: 500 mg (100 mg/mL) ou 160 mg (32 mg/mL)	Seringa do bebê marcada em kg em algumas marcas; gotas/mL varia
Dipirona	Gotas 500 mg/mL; solução 50 mg/mL	1 gota: 25 mg (Novalgina®); 5 mL da solução: 250 mg	Dar em mL a gota, ou em gotas a solução
Ibuprofeno	Gotas 50, 100 e 200 mg/mL; suspensão 30 mg/mL	1 gota do Alivium®: 5, 10 ou 20 mg	"1 gota por quilo" só vale para 100 mg/mL
Amoxicilina	250 mg/5 mL; 500 mg/5 mL	5 mL: 250 ou 500 mg	Receita em mL sem a concentração
Amoxicilina + clavulanato	250 mg + 62,5 mg/5 mL (8/8 h); BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL e 400 mg + 57 mg/5 mL (12/12 h)	5 mL: 250, 200 ou 400 mg de amoxicilina	Trocar BD por comum muda dose, clavulanato e intervalo
Cefalexina	Gotas 100 mg/mL; suspensão 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL	1 gota: cerca de 4,5 mg; 5 mL: 250 ou 500 mg	Gotas e suspensão de 500 mg/5 mL têm a mesma concentração
Claritromicina	25 mg/mL; 50 mg/mL	5 mL: 125 ou 250 mg	Volume por kg muda (0,3 ou 0,15 mL/kg)
Sulfametoxazol + trimetoprima	200 mg + 40 mg/5 mL; F 400 mg + 80 mg/5 mL	5 mL: 200 ou 400 mg de sulfametoxazol	A suspensão F tem o dobro
Prednisolona	Solução 3 mg/mL; gotas 11 mg/mL	1 mL: 3 ou 11 mg	Gotas em mL dão quase 4 vezes a dose
Insulina glargina	100 UI/mL (Lantus®); 300 UI/mL (Toujeo®)	0,1 mL: 10 ou 30 UI	Nunca aspirar da caneta de 300 UI/mL com seringa

Concentrações das bulas do Tylenol®, Novalgina®, Alivium®, Amoxil®, Clavulin®, Keflex®, Klaricid®, Bactrim®, Prelone®, Lantus® e Toujeo®. Outras marcas podem ter apresentações diferentes.

Medicamentos pediátricos de dose fixa por idade

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Loratadina (Claritin®)	Xarope 1 mg/mL	2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL 1 vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL	2 anos

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Dexclorfeniramina (Polaramine®)	Gotas e solução oral	2 a 6 anos: 5 gotas ou 1,25 mL 3 vezes ao dia (máx. 3 mg/dia); 6 a 12 anos: 10 gotas ou 2,5 mL 3 vezes ao dia (máx. 6 mg/dia)	2 anos
Mebendazol (Pantelmin®)	Suspensão 20 mg/mL	5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias, independente de peso e idade	Abaixo de 2 anos só se o benefício justificar
Albendazol (Zentel®)	Comprimido 400 mg	400 mg em dose única (ou por 3 a 5 dias, conforme o parasita)	Acima de 2 anos
Simeticona (Luftal® gotas)	Gotas 75 mg/mL	Lactentes: 3 a 5 gotas 3 vezes ao dia; até 12 anos: 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia	Sem idade mínima na bula
Ivermectina (Revectina®)	Comprimido 6 mg	Por faixa de peso: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1 comprimido; 36 a 50 kg, 1 e meio	Contraindicada abaixo de 15 kg ou de 5 anos
Ondansetrona (Vonau® Flash)	Comprimido orodispersível 4 mg e 8 mg	2 a 11 anos: 4 mg; acima de 11 anos: 4 a 8 mg (a dose por peso da bula do Zofran® é intravenosa, na quimioterapia)	2 anos
Salbutamol (Aerolin® xarope)	Xarope 0,4 mg/mL	2 a 6 anos: 1 a 2 mg; 6 a 12 anos: 2 mg; 3 ou 4 vezes ao dia	2 anos
Levamisol (Ascaridil®)	Comprimido 80 mg e 150 mg	Dose única: até 7 anos, 80 mg; acima de 7 anos, 150 mg	Conforme a bula

Loratadina, dexclorfeniramina gotas e ivermectina também estão na calculadora (por faixa de peso ou por kg). Mesmo nos medicamentos de dose fixa, confira a idade, a concentração do produto entregue e o dosador.

Preparo e validade das suspensões da calculadora

Produto	Preparo	Depois de preparado	Frasco
Amoxil® 250 e 500 mg/5 mL	Água filtrada até a marca, em 2 etapas	14 dias em geladeira	150 mL
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL de água	7 dias em geladeira	100 mL
Clavulin® BD	64 ou 62 mL (frasco de 70 mL); 124 mL (frasco de 140 mL)	7 dias em geladeira	70 ou 140 mL
Astro® (azitromicina)	Todo o diluente da embalagem (9, 12 ou 22 mL)	5 dias entre 15 °C e 30 °C	15; 22,5; 37,5 mL utilizáveis

Produto	Preparo	Depois de preparado	Frasco
Keflex® gotas	Água até a marca vermelha	14 dias em geladeira	15 ou 30 mL
Keflex® 250 e 500 mg/5 mL	Prontas para uso	Conforme a validade do frasco	100 mL
Cefamox®	Água até a linha do frasco, em porções	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira	100 mL
Klaricid®	Água até a flecha do rótulo	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem geladeira	60 mL
Annita®	Água até a marca do rótulo	7 dias	45 ou 100 mL

Dados das bulas reproduzidas no portal Consulta Remédios (out. 2026). Para genéricos e similares, siga a bula do produto entregue.

SOS Farmácia Comercial

Conferir uma prescrição pediátrica

Receber a receita e identificar o medicamento, a concentração e a forma farmacêutica

DECISÃO

Peso atual e idade da criança estão disponíveis?

- **SIM** — Anotar e seguir
- **NÃO** — Perguntar ao cuidador; se ninguém souber, pesar ou contatar o prescritor

DECISÃO

Idade e peso estão acima do mínimo da bula?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não dispensar; contatar o prescritor

Converter a concentração para mg/mL e calcular mg por tomada e mg por dia

Dividir pelo peso: mg/kg/dose ou mg/kg/dia, conforme a bula

DECISÃO

A dose está na faixa da bula e abaixo dos tetos por tomada e por dia?

- **SIM** — Seguir para a quantidade
- **NÃO** — Refazer a conta; persistindo, ligar para o prescritor

ATENÇÃO

Nunca alterar dose, concentração ou intervalo sem a confirmação do prescritor

Calcular volume total, número de frascos e validade após o preparo

DECISÃO

A quantidade da receita cobre o tratamento?

SIM
Dispensar e registrar

NÃO
Contatar o prescritor para ajustar a quantidade

Orientar preparo, dosador, horários, conservação e descarte; escrever a dose na embalagem

Antes de entregar uma suspensão

- ◯ Conferir se o fármaco e a concentração entregues são os da receita
- ◯ Confirmar peso e idade da criança e anotar
- ◯ Refazer o cálculo da dose em mg e em mL
- ◯ Conferir faixa de mg/kg e tetos por tomada e por dia
- ◯ Calcular o volume total e o número de frascos
- ◯ Conferir se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco
- ◯ Verificar se o produto é pó para reconstituir ou suspensão pronta
- ◯ Mostrar a marca de água no frasco e explicar as duas etapas
- ◯ Escrever no rótulo a data do preparo e a data de descarte
- ◯ Entregar o dosador do próprio produto e marcar nele a dose
- ◯ Explicar se a suspensão vai ou não à geladeira
- ◯ Orientar a agitar antes de cada dose
- ◯ Pedir que o cuidador repita a dose e os horários
- ◯ Para antimicrobiano: registrar a dispensação nas duas vias e reter a segunda

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Quantos mg/mL tem uma suspensão de 250 mg/5 mL?	50 mg/mL (250 ÷ 5).
Uma solução a 2% p/v tem quantos mg/mL?	20 mg/mL (2 g em 100 mL).
Fórmula do volume a administrar	Dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL).
Diferença entre mg/kg/dose e mg/kg/dia	A primeira é cada tomada; a segunda é o total de 24 horas, a dividir pelas tomadas.
Dose máxima de ibuprofeno para criança (Alivium®)	200 mg por dose e 800 mg por dia.
Teto diário de paracetamol (Tylenol®)	75 mg/kg e 4000 mg em 24 horas; no máximo 5 administrações.
Teto da azitromicina em crianças	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento inteiro.
Gotas por mL da Novalgina® gotas	20 gotas/mL; cada gota tem 25 mg.
Gotas por mL do Tylenol® gotas	14 a 16 gotas/mL (12,5 a 14,2 mg por gota).
Gotas por mL do Alivium® gotas	10 gotas/mL nas três concentrações (5, 10 ou 20 mg por gota).
Por que a água de reconstituição é menor que o volume final?	O pó ocupa volume; completa-se até a marca do frasco.
Validade do Clavulin® depois de preparado	7 dias em geladeira.
Klaricid® preparado vai à geladeira?	Não. Fica entre 15 °C e 30 °C por até 14 dias.
Keflex® 500 mg/5 mL precisa ser reconstituído?	Não. As suspensões de 250 e 500 mg/5 mL vêm prontas; só as gotas são pó.
Quantas UI há numa caneta de Toujeo®?	450 UI (1,5 mL de 300 UI/mL).
Teste de segurança da caneta Toujeo®	3 unidades antes de cada injeção; entra na conta da duração.
Prazo de uso do frasco aberto de Humulin® N	28 dias, mesmo que sobre insulina.
Dipirona: idade e peso mínimos	3 meses e 5 kg (Novalgina®).
O que fazer quando a dose prescrita não bate	Refazer a conta, contatar o prescritor e registrar; nunca alterar sozinho.

Questões de fixação com cálculo

1. Mãe de criança de 16 kg pede orientação para dar paracetamol suspensão 32 mg/mL na dose de 15 mg/kg. Qual o volume por tomada?

A 3,75 mL
B 5 mL
C 7,5 mL
D 10 mL
E 12 mL

2. Receita de amoxicilina 250 mg/5 mL, 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, para criança de 18 kg. Qual o volume por tomada?

A 3 mL
B 6 mL
C 9 mL
D 12 mL
E 18 mL

3. Receita de amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem apenas frascos de 150 mL. Quantos frascos o tratamento exige?

A 1 frasco
B 3 frascos
C 4 frascos
D 2 frascos
E 5 frascos

4. Receita: "dipirona gotas 500 mg/mL, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg. Com o gotejador da Novalgina® (20 gotas/mL), a conduta correta é:

A dispensar, pois 12 gotas equivalem a 1 gota/kg
B contatar o prescritor: a dose passa da bula
C dispensar e orientar a dar 6 gotas
D trocar pela solução de 50 mg/mL na mesma dose
E dispensar, pois a dose é de 10 mg/kg

5. Criança de 15 kg com febre de 39,5 °C. O produto disponível é ibuprofeno gotas 200 mg/mL (Alivium®, 10 gotas/mL). Na dose de 10 mg/kg, quantas gotas por tomada?

A 7 a 8 gotas

B 15 gotas

C 30 gotas

D 3 gotas

E 75 gotas

6. Criança de 24 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias. Qual a melhor opção de dispensação?

A 1 frasco de 600 mg

B 2 frascos de 900 mg

C 2 frascos de 600 mg

D 1 frasco de 1500 mg

E 1 frasco de 900 mg

7. Paciente usa insulina glargina 300 UI/mL (Toujeo®, caneta de 1,5 mL), 27 UI uma vez ao dia, e faz o teste de segurança de 3 unidades antes de cada aplicação. Quantos dias dura uma caneta?

A 10 dias

B 15 dias

C 16 dias

D 17 dias

E 42 dias

8. Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (100 UI/mL), 24 UI por dia. Por quanto tempo o frasco aberto pode ser usado, segundo a bula do Humulin® N?

A 41 dias, até acabar a insulina

B 6 semanas

C 28 dias, descartando a sobra

D até a validade impressa no frasco

E 14 dias

9. Criança de 16 kg com receita de amoxicilina + clavulanato BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de amoxicilina de 12 em 12 horas. Qual o volume por tomada?

A 2,25 mL

B 3 mL

C 6 mL

D 9 mL

E 4,5 mL

10. Criança de 8 kg com receita de cefalexina 50 mg/kg/dia dividida de 6 em 6 horas. O produto é Keflex® gotas 100 mg/mL, cujo gotejador libera cerca de 22 gotas/mL. Quantas gotas por tomada?

A 11 gotas

B 20 gotas

C 22 gotas

D 44 gotas

E 5 gotas

11. Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia". A bula indica 0,14 a 2 mg/kg/dia, máximo de 80 mg/dia. A conduta correta é:

A dispensar, pois 60 mg está abaixo de 80 mg/dia

B orientar 2 mL, provável intenção do médico

C contatar o prescritor: dose de 6 mg/kg/dia

D trocar para gotas de 11 mg/mL

E dispensar e orientar a dividir em 3 tomadas

12. O cliente pergunta quantos gramas de cloreto de sódio há em um frasco de 500 mL de solução a 0,9%. A resposta correta é:

A 0,45 g

B 4,5 g

C 45 g

D 0,9 g

E 9 g

Gabarito comentado

1. **C**. Dose: 16 kg × 15 mg/kg = 240 mg. Volume: 240 ÷ 32 = 7,5 mL. 3,75 mL corresponde a 120 mg (7,5 mg/kg, abaixo da faixa de 10 a 15 mg/kg da bula do Tylenol®); 5 mL dá 160 mg (10 mg/kg, limite inferior); 10 e 12 mL passam de 15 mg/kg.
2. **B**. Dose diária: 18 × 50 = 900 mg; por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg; volume: 300 ÷ 50 mg/mL = 6 mL. 18 mL resulta de aplicar 50 mg/kg em cada tomada, o triplo da dose. 3 mL usaria a concentração errada (100 mg/mL); 9 e 12 mL não correspondem a nenhuma leitura correta.
3. **D**. Volume diário: 7 × 3 = 21 mL; total: 21 × 10 = 210 mL; 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos. Um frasco acabaria no 8º dia. A bula do Amoxil® dá 14 dias de validade em geladeira, então cada frasco é usado dentro do prazo. A RDC 471/2021 (art. 11) pede que a dispensação atenda ao tratamento prescrito.
4. **B**. Cada gota tem 25 mg; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose. Para 9 a 15 kg, a bula indica 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas/dia; a receita dá 48 gotas/dia. O farmacêutico contata o prescritor e não muda a dose por conta própria (por isso dar 6 gotas está errado). Trocar de apresentação sem receita também é alteração indevida, e 10 mg/kg seriam cerca de 5 gotas.
5. **A**. Dose: 15 × 10 = 150 mg; 150 ÷ 200 = 0,75 mL; 0,75 × 10 = 7,5 gotas, o que a bula resume como 1 gota a cada 2 kg. 15 gotas seria aplicar "1 gota/kg" (regra da apresentação de 100 mg/mL) e daria 300 mg, acima do teto de 200 mg por dose. 30 gotas seria a regra de 2 gotas/kg da de 50 mg/mL. Lembrar que, no Alivium®, a apresentação de 200 mg/mL é de venda sob prescrição.
6. **E**. Dose diária: 240 mg = 6 mL; total: 720 mg = 18 mL. O frasco de 900 mg rende 22,5 mL utilizáveis e cobre o tratamento. O de 600 mg (15 mL) é insuficiente. Dois de 600 mg ou um de 1500 mg cobrem, mas deixam sobra maior; dois de 900 mg dobram a quantidade sem necessidade.
7. **B**. Caneta: 1,5 mL × 300 UI/mL = 450 UI. Gasto diário: 27 + 3 = 30 UI. 450 ÷ 30 = 15 dias. Ignorar o teste dá 16,7 dias. 42 dias é o prazo máximo de uso da caneta aberta segundo a bula, não a duração neste caso.
8. **C**. Pelo volume, 1000 UI ÷ 24 UI = 41,6 dias, mas a bula limita o frasco aberto a 28 dias abaixo de 30 °C. No 28º dia sobram cerca de 328 UI, que devem ser descartadas. Seis semanas é o prazo da caneta Toujeo®, outro produto. A validade impressa vale para o frasco fechado.
9. **E**. Dose diária: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg; concentração: 400 ÷ 5 = 80 mg/mL; volume: 360 ÷ 80 = 4,5 mL. 9 mL é o volume do dia inteiro em uma tomada. 2,25 mL corresponde à metade da dose. A dose está na faixa de 25 a 45 mg/kg/dia da bula do Clavulin® BD.
10. **C**. Dose diária: 8 × 50 = 400 mg; por tomada: 100 mg = 1 mL = cerca de 22 gotas (a tabela da bula traz o mesmo valor). 20 gotas resulta de supor 20 gotas/mL. 11 gotas é a dose de 25 mg/kg/dia; 44 gotas seria a dose de 12 em 12 horas.
11. **C**. 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg = 6 mg/kg/dia, três vezes o limite superior por peso, ainda que abaixo do teto absoluto de 80 mg/dia. A hipótese de erro de vírgula (2,0 mL) é provável, mas o farmacêutico não corrige sozinho: confirma com o prescritor e registra. Dividir a dose não muda o total diário.
12. **B**. 0,9% p/v = 0,9 g em 100 mL = 9 mg/mL. Em 500 mL: 9 × 500 = 4500 mg = 4,5 g. 0,9 g é o conteúdo de 100 mL; 9 g seria o de 1 litro; 0,45 g e 45 g erram a casa decimal por 10 vezes.

Sal e elemento

Substância	Forma	Fração ativa	Exemplo de conta	Fonte
Ferro	Sulfato ferroso heptaidratado	Cerca de 20% de ferro	200 mg de sal = 40 mg de ferro	Massa molar

Substância	Forma	Fração ativa	Exemplo de conta	Fonte
Ferro	Sulfato ferroso seco	Cerca de 30% a 33%	Ler o ferro elementar no rótulo	Massa molar
Ferro	Fumarato ferroso	Cerca de 33%	200 mg de sal = 66 mg de ferro	Massa molar
Ferro	Gluconato ferroso	Cerca de 12%	300 mg de sal = 35 mg de ferro	Massa molar
Ferro	Glicinato férrico (Neutrofer® gotas)	20%	250 mg/mL = 50 mg/mL de ferro; 2,5 mg/gota	Bula do Neutrofer®
Ferro	Ferripolimaltose (Noripurum® gotas)	Rótulo em ferro III	50 mg/mL; 20 gotas/mL; 2,5 mg/gota	Bula do Noripurum®
Ferro	Sulfato ferroso gotas (genérico consultado)	Rótulo em ferro elementar	25 mg/mL; 25 gotas/mL; 1 mg/gota	Bula do genérico
Cálcio	Carbonato de cálcio	40% de cálcio	1250 mg = 500 mg de cálcio	Massa molar
Cálcio	Citrato de cálcio tetraidratado	Cerca de 21%	500 mg de cálcio = cerca de 2380 mg do sal	Massa molar
Vitamina D	Colecalciferol	1 mcg = 40 UI	7000 UI = 175 mcg; 50.000 UI = 1250 mcg	Definição da UI
Potássio	Cloreto de potássio	1 g = 13,4 mEq de K	Xarope 6%: 15 mL = 900 mg = 12 mEq	Massa molar
Sertralina	Cloridrato	Dose em base	50 mg de base = cerca de 56 mg do sal	Bula do Zoloft®; massa molar
Prednisolona	Fosfato sódico	Dose em base	1 mg de base = 1,34 mg do sal	Bula do Prelone®

Frações calculadas pela massa molar são aproximadas e dependem da hidratação do sal. O número que vale é o do rótulo do produto entregue.

Ajuste renal de medicamentos comuns

Fármaco	Limite	Conduta	Fonte
Metformina	TFGe 30 a 59 mL/min/1,73 m²	Máximo 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar; função renal a cada 3 a 6 meses (45 a 59) ou 3 meses (30 a 44)	Bula do Glifage®
Metformina	TFGe abaixo de 30	Contraindicada	Bula do Glifage®

Fármaco	Limite	Conduta	Fonte
Nitrofurantoína	Insuficiência renal moderada	Contraindicada	Bula da Macrodantina®
Nitrofurantoína	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
AINE (inclusive celecoxibe)	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Ciprofloxacino	CrCl abaixo de 30	Reduzir a dose usual	AGS Beers 2023
Sulfametoxazol + trimetoprima	CrCl 15 a 29; abaixo de 15	Reduzir; evitar	AGS Beers 2023
Gabapentina	CrCl abaixo de 60	Reduzir	AGS Beers 2023
Pregabalina	CrCl abaixo de 60	Reduzir	AGS Beers 2023
Baclofeno	TFGe abaixo de 60	Evitar; se inevitável, menor dose e vigiar confusão	AGS Beers 2023
Duloxetina	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Tramadol	CrCl abaixo de 30	Liberação imediata: reduzir; prolongada: evitar	AGS Beers 2023
Famotidina	CrCl abaixo de 50	Reduzir	AGS Beers 2023
Espironolactona	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Colchicina	CrCl abaixo de 30	Reduzir e vigiar toxicidade	AGS Beers 2023
Rivaroxabana	CrCl 15 a 50; abaixo de 15	Reduzir conforme a bula e a indicação; evitar	AGS Beers 2023
Dabigatrana	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023

Os Critérios de Beers valem para 65 anos ou mais e usam clearance de creatinina; a KDIGO 2024 aceita a TFGe por creatinina para ajuste de dose na maioria dos casos e, em extremos de peso, a TFGe não indexada (TFGe × SC ÷ 1,73). A bula do produto continua sendo a referência legal.

Fórmulas do farmacêutico

Para achar	Conta	Exemplo
Concentração em mg/mL	mg ÷ volume indicado (mg/5 mL ÷ 5)	250 mg/5 mL = 50 mg/mL
mg/mL a partir de porcentagem	% × 10	6% = 60 mg/mL
Volume da dose	dose (mg) ÷ concentração (mg/mL)	720 mg ÷ 100 mg/mL = 7,2 mL

Para achar	Conta	Exemplo
Dose por tomada (mg/kg/dose)	peso × mg/kg	14 kg × 10 mg/kg = 140 mg
Dose por tomada (mg/kg/dia)	peso × mg/kg/dia ÷ tomadas	16 × 90 ÷ 2 = 720 mg
Conferir mg/kg de uma receita	mL × mg/mL × tomadas ÷ peso	5 × 50 × 2 ÷ 22 = 22,7 mg/kg/dia
mg por gota	mg/mL ÷ gotas/mL	500 ÷ 20 = 25 mg
Número de gotas	mL × gotas/mL (ou mg ÷ mg por gota)	0,8 mL × 15 = 12 gotas
Volume total do tratamento	mL por tomada × tomadas/dia × dias	9 × 2 × 10 = 180 mL
Frascos	volume total ÷ volume utilizável, para cima; conferir validade pós-preparo	180 ÷ 150 = 1,2 = 2 frascos
Insulina em mL	UI ÷ UI/mL	12 UI ÷ 100 UI/mL = 0,12 mL
Duração de caneta	UI da caneta ÷ (dose + teste de segurança)	450 ÷ (27 + 3) = 15 dias
Superfície corporal (Mosteller)	raiz de (altura cm × peso kg ÷ 3600)	110 cm, 20 kg = 0,78 m²
Dose por superfície	mg/m² × SC	100 × 0,78 = 78 mg
Elemento a partir do sal	massa do sal × fração	1250 mg × 0,4 = 500 mg de cálcio
Sal a partir do elemento	massa do elemento ÷ fração	500 ÷ 0,21 = cerca de 2380 mg de citrato
Vitamina D	UI ÷ 40 = mcg; mcg × 40 = UI	50.000 UI = 1250 mcg
Potássio	mg de KCl ÷ 74,55 = mEq	900 mg = 12 mEq
TFGe não indexada	TFGe × SC ÷ 1,73	42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8 mL/min
Volume de injetável em UI	UI prescritas ÷ UI/mL	600.000 ÷ 300.000 = 2 mL
Concentração após reconstituir	dose do frasco ÷ volume final da bula	1000 mg ÷ 4,22 mL = 237 mg/mL

PONTO-CHAVE

A TFGe por CKD-EPI 2021 vem do laudo ou de calculadora validada. Toda conta deve ser refeita pelo caminho inverso antes de orientar.

SOS Farmácia Comercial

Criança com febre no balcão

Cuidador pede antitérmico para criança com febre

Perguntar idade, peso, tempo de febre, estado geral, o que já tomou e em que horário

DECISÃO

Menor de 3 meses ou algum sinal de alerta (prostração, respiração rápida, enchimento capilar lento, desidratação, convulsão)?

SIM
Encaminhar para avaliação médica imediata; não atrasar com orientação de dose

NÃO
Seguir a avaliação

DECISÃO

Suspeita de dengue (febre com dor no corpo, área com casos)?

SIM
Sem AINE e sem AAS; paracetamol ou dipirona 10 mg/kg até de 6 em 6 horas; orientar sinais de alarme

NÃO
Escolher um antitérmico conforme idade e histórico

Escolher um único antitérmico: paracetamol, dipirona (a partir de 3 meses e 5 kg) ou ibuprofeno (a partir de 6 meses)

Calcular mg pelo peso, converter em mL ou gotas com a bula do frasco entregue e conferir tetos por tomada e por dia

DECISÃO

Família alterna ou associa antitérmicos?

SIM
Explicar que a SBP (2021) não recomenda e reorientar para um só fármaco

NÃO
Seguir

ATENÇÃO

Gotas por quilo de memória levam a superdose (dipirona 1 gota/kg = 25 mg/kg)

Escrever fármaco, dose, intervalo mínimo e máximo de tomadas na embalagem

Orientar retorno ou avaliação se a febre passar de 3 dias ou surgir sinal de alerta

Antes de aplicar um injetável

- ◯ Receita válida, com dose, via e frequência, avaliada pelo farmacêutico (RDC 44/2009, art. 75)
- ◯ Medicamento não é de uso exclusivo hospitalar
- ◯ Apresentação confere com a via (ceftriaxona IM com lidocaína nunca na veia)
- ◯ Lote, validade, aspecto e conservação conferidos
- ◯ Alergias perguntadas (penicilina, lidocaína, metabissulfito)
- ◯ Uso de anticoagulante, plaquetopenia e reação em aplicação anterior perguntados
- ◯ Unidade da dose identificada: mg ou UI
- ◯ Concentração final calculada pelo volume final da bula
- ◯ Volume calculado, escrito e refeito por um segundo profissional
- ◯ Volume cabe na região escolhida; se não couber, dividir em dois locais com aval do prescritor
- ◯ Região escolhida pela idade e massa muscular, com agulha adequada ao biotipo
- ◯ Aspiração antes de injetar quando o produto exigir (penicilina benzatina)
- ◯ Sobra descartada quando a bula manda usar logo após o preparo
- ◯ Paciente em observação pelo tempo do POP, com kit de primeiros socorros acessível
- ◯ Registro com lote, volume, região, horário e profissional

Volume máximo por injeção intramuscular, por idade (mL)

Faixa etária	Deltoide	Ventroglútea	Dorsoglútea	Vasto lateral
Prematuro e neonato	Não indicado	Não indicado	Não indicado	0,5
Lactente	Não indicado	Não indicado	Não indicado	1
3 a 6 anos	Não indicado	1,5	1	1,5
6 a 14 anos	0,5	1,5 a 2	1,5 a 2	1,5
Adolescente	1	2 a 2,5	2 a 2,5	1,5 a 2
Adulto	1	4	4	4

Tabela de Silva e Santos (2005), citada no Parecer COREN-SP 039/2012 e reproduzida em guias de ensino; conferida por fonte secundária. O TelessaúdeRS-UFRGS (2023) indica, em adulto, até 4 mL na ventroglútea e na dorsoglútea e 3 a 4 mL no vasto lateral. Siga o POP da farmácia.

Cartões de revisão: parte b

Pergunta	Resposta
Fórmula de Mosteller da superfície corporal	SC (m²) = raiz de (altura em cm × peso em kg ÷ 3600).
Criança obesa de 45 kg: qual o limite da dose por peso?	A dose de adulto para a mesma indicação (PPAG, 2017). Peso de cálculo diferente do real é decisão do prescritor.
Pode partir comprimido de liberação prolongada?	Não, salvo se a bula autorizar: libera de uma vez a dose de horas.
Dose de dipirona por tomada segundo a SBP (2021)	10 a 12 mg/kg por tomada.
Quanto entrega 1 gota/kg de dipirona 500 mg/mL (20 gotas/mL)?	25 mg/kg, mais que o dobro da dose da SBP.
A SBP recomenda alternar antitérmicos?	Não. Uso alternado ou associado não é recomendado (SBP, 2021).
Antitérmicos na suspeita de dengue	Paracetamol e/ou dipirona; sem AINE, salicilatos e corticoide (MS, 2024).
Dose alta de amoxicilina na otite média aguda	80 a 90 mg/kg/dia em 2 tomadas (AAP, 2013).
Duração da otite média aguda abaixo de 2 anos	10 dias (AAP, 2013).
Validade da receita de antimicrobiano	10 dias da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º).
Cálcio elementar no carbonato e no citrato	Carbonato: 40%. Citrato tetraidratado: cerca de 21%.

Pergunta	Resposta
Converter 50.000 UI de vitamina D em mcg	50.000 ÷ 40 = 1250 mcg.
Ferro por gota: sulfato ferroso genérico e Noripurum®	1 mg por gota (25 mg/mL, 25 gotas/mL) e 2,5 mg por gota (50 mg/mL, 20 gotas/mL).
mEq de potássio em 1 g de KCl	Cerca de 13,4 mEq (1000 ÷ 74,55).
Qual equação estima a TFG?	CKD-EPI 2021, sem raça. Nunca Cockcroft-Gault como padrão.
TFGe não indexada	TFGe × SC ÷ 1,73; usar em extremos de peso (KDIGO 2024).
Metformina com TFGe entre 30 e 59	Máximo de 1000 mg/dia; abaixo de 30, contraindicada (bula do Glifage®).
Ceftriaxona 1 g IM: diluente e volume final	3,5 mL de lidocaína 1%; cerca de 4,22 mL (Rocefin®).
Volume de 600.000 UI de Benzetacil® 300.000 UI/mL	2 mL.
Volume máximo no glúteo do adulto	Até 4 mL por local (TelessaúdeRS-UFRGS, 2023).

Questões com cálculo: parte b

1. Criança de 18 kg com febre e irritabilidade. A família tem dipirona gotas 500 mg/mL (20 gotas/mL). Pela dose da SBP (10 a 12 mg/kg por tomada), quantas gotas orientar?

A 4 gotas
B 8 gotas
C 12 gotas
D 18 gotas
E 36 gotas

2. Criança de 16 kg com suspeita de dengue. Pelo guia do Ministério da Saúde (2024), paracetamol 10 mg/kg/dose. O frasco é Tylenol® gotas 200 mg/mL, com cerca de 15 gotas/mL. Quantas gotas por tomada?

A 8 gotas
B 10 gotas
C 16 gotas
D 12 gotas
E 20 gotas

3. Menino de 8 anos, 45 kg, usará paracetamol para febre. Pela bula do Tylenol® (até 75 mg/kg/dia, 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia), qual o total máximo em 24 horas pelo peso real?

A 3375 mg

B 2250 mg

C 4000 mg

D 4500 mg

E 6750 mg

4. Criança com 110 cm e 20 kg recebe um fármaco prescrito em 100 mg/m² por dia. Pela fórmula de Mosteller, qual a dose diária?

A 39 mg

B 49 mg

C 100 mg

D 156 mg

E 78 mg

5. Criança de 16 kg com otite média aguda. Receita: amoxicilina 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas. Qual o volume por tomada?

A 3,6 mL

B 5 mL

C 7,2 mL

D 9 mL

E 14,4 mL

6. Criança de 20 kg, amoxicilina 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias. Frascos de 150 mL, validade de 14 dias em geladeira após o preparo. Quantos frascos dispensar?

A 1 frasco

B 3 frascos

C 2 frascos

D 4 frascos

E 5 frascos

7. Criança de 10 kg com receita de ferro elementar 3 mg/kg/dia. A família troca o sulfato ferroso gotas (25 mg/mL, 25 gotas/mL) por Neutrofer® gotas (50 mg/mL, 20 gotas/mL). Quantas gotas do produto novo?

A 30 gotas

B 6 gotas

C 15 gotas

D 12 gotas

E 24 gotas

8. Receita de colecalciferol 50.000 UI por semana. A farmácia tem cápsulas rotuladas em mcg. Qual valor procurar no rótulo?

A 125 mcg

B 500 mcg

C 1250 mcg

D 2000 mcg

E 12.500 mcg

9. Paciente precisa de 600 mg de cálcio elementar por dia usando carbonato de cálcio (40% de cálcio). Quantos mg do sal correspondem a essa dose?

A 240 mg

B 1500 mg

C 600 mg

D 1000 mg

E 2400 mg

10. Mulher de 78 anos, 155 cm e 45 kg, TFGe (CKD-EPI 2021) de 42 mL/min/1,73 m². Qual a TFGe não indexada, em mL/min (SC = 1,39 m²)?

A 24 mL/min

B 52 mL/min

C 42 mL/min

D 58 mL/min

E 34 mL/min

11. Criança de 20 kg com receita de penicilina benzatina 600.000 UI IM, dose única. O frasco disponível é de 1.200.000 UI em 4 mL de suspensão pronta. Qual volume aspirar?

A 0,6 mL

B 2 mL

C 1,2 mL

D 4 mL

E 6 mL

12. Receita de ceftriaxona 750 mg IM. O frasco de 1 g é reconstituído com 3,5 mL de lidocaína 1%, com volume final de cerca de 4,22 mL (bula do Rocefin®). Qual volume aspirar?

A 2,4 mL

B 3,2 mL

C 2,6 mL

D 3,5 mL

E 4,2 mL

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **B**. Dose: 18 × 10 = 180 mg a 18 × 12 = 216 mg. Cada gota tem 25 mg (500 ÷ 20): 7,2 a 8,6 gotas, ou seja, 8 gotas (200 mg, 11,1 mg/kg). 4 gotas dão 100 mg (5,6 mg/kg, subdose). 12 gotas dão 300 mg (16,7 mg/kg). 18 gotas é o hábito de 1 gota/kg: 450 mg, 25 mg/kg. 36 gotas equivalem a 900 mg, dose de adulto. Fonte: SBP, Manejo da febre aguda, 2021; bula da Novalgina®.
2. **D**. Dose: 16 × 10 = 160 mg. Volume: 160 ÷ 200 = 0,8 mL. Gotas: 0,8 × 15 = 12. 16 gotas resultam de supor 20 gotas/mL, equivalência do apêndice do guia que não vale para o gotejador do Tylenol® e entregaria cerca de 213 mg. 8 e 10 gotas ficam abaixo de 10 mg/kg; 20 gotas dariam cerca de 267 mg. Ibuprofeno não é opção na suspeita de dengue.
3. **A**. 75 mg/kg × 45 kg = 3375 mg, abaixo do teto absoluto de 4000 mg; vale o menor dos limites. 2250 mg corresponderia a 50 mg/kg; 4000 mg ignora o limite por quilo; 4500 mg corresponde a 100 mg/kg e 6750 mg a 150 mg/kg, ambos acima da bula. Se o pediatra definir um peso de cálculo menor, por causa da obesidade, o teto cai junto.
4. **E**. SC = raiz de (110 × 20 ÷ 3600) = raiz de 0,611 = 0,78 m². Dose: 100 × 0,78 = 78 mg. 100 mg seria a dose de 1 m²; 39 mg é metade da correta; 49 mg resulta de estimar a SC pela proporção do peso (20 ÷ 70 × 1,73 = 0,49 m²), o que subestima a superfície da criança; 156 mg dobra a conta.
5. **C**. 16 × 90 = 1440 mg/dia; ÷ 2 = 720 mg por tomada; concentração 100 mg/mL; 720 ÷ 100 = 7,2 mL. 14,4 mL é a dose do dia inteiro numa tomada. 3,6 mL resulta de dividir por 4 tomadas. 9 mL seria a dose de uma criança de 20 kg. 5 mL é volume padrão sem cálculo. Dose alta de 80 a 90 mg/kg/dia em 2 tomadas: AAP, 2013, citada na bula do Amoxil®.
6. **C**. Por tomada: 20 × 90 ÷ 2 = 900 mg = 9 mL. Total: 9 × 2 × 10 = 180 mL. 180 ÷ 150 = 1,2, arredondado para 2 frascos. O primeiro dura 8 dias, dentro da validade. 1 frasco interrompe o tratamento no 9º dia; 3 ou mais geram sobra. A quantidade escrita na receita precisa coincidir (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único).
7. **D**. Dose: 10 × 3 = 30 mg de ferro. Neutrofer®: 50 ÷ 20 = 2,5 mg por gota; 30 ÷ 2,5 = 12 gotas. 30 gotas era a dose do sulfato ferroso (1 mg/gota) e, no produto novo, daria 75 mg, acima do teto de 60 mg/dia citado pelo PNSF (MS, 2013). 15 gotas resultam de 2 mg por gota; 6 gotas de 5 mg por gota; 24 gotas de 1,25 mg por gota.
8. **C**. 1 mcg = 40 UI: 50.000 ÷ 40 = 1250 mcg. 125 mcg corresponde a 5000 UI; 500 mcg a 20.000 UI; 2000 mcg a 80.000 UI; 12.500 mcg a 500.000 UI. Conferir também a frequência: semanal, não diária.
9. **B**. Sal = elemento ÷ fração: 600 ÷ 0,4 = 1500 mg de carbonato. 240 mg é o cálcio contido em 600 mg de carbonato (conta invertida). 600 mg confunde sal com elemento. 2400 mg seria o caminho com fração de 25%. 1000 mg não corresponde a nenhuma fração usada para cálcio. Com citrato (21%), seriam cerca de 2860 mg.
10. **E**. TFGe não indexada = 42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8, cerca de 34 mL/min. 42 é o valor indexado, que superestima a filtração de uma pessoa pequena. 52 resulta de multiplicar por 1,73 e dividir por 1,39 (conta invertida). 24 e 58 não saem da fórmula. KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.4.
11. **B**. Concentração: 1.200.000 ÷ 4 = 300.000 UI/mL. Volume: 600.000 ÷ 300.000 = 2 mL. 0,6 e 1,2 mL são leituras erradas dos números em UI como se fossem mL. 4 mL é o frasco inteiro (dose de adulto). 6 mL não existe no frasco. A bula do Benzetacil® indica 300.000 a 600.000 UI para crianças até 27 kg.
12. **B**. Concentração: 1000 mg ÷ 4,22 mL = 237 mg/mL. Volume: 750 ÷ 237 = 3,2 mL. 2,6 mL resulta de usar 3,5 mL como volume final (750 ÷ 286); 3,5 mL é o volume do diluente; 4,2 mL é o frasco inteiro (1 g); 2,4 mL não sai de nenhuma conta coerente. O restante deve ser descartado, pois a solução é usada logo após o preparo.

Módulo 14

Bulário

Leitura da bula do paciente e do profissional (RDC 47/2009 e alterações), Bulário Eletrônico da Anvisa, referência, genérico e similar intercambiável (RDC 16/2007, RDC 58/2014), rotulagem vigente (RDC 768/2022), orientação ao paciente e farmacovigilância (Lei 13.021/2014, VigiMed e Notivisa), com um bulário de bolso dos medicamentos mais dispensados.

- Estrutura da bula
- Bulário Eletrônico da Anvisa
- Referência, genérico e similar intercambiável
- Embalagem e rotulagem no balcão
- Da bula à orientação ao paciente
- Farmacovigilância a partir da bula

Estrutura da bula

A **bula** é o documento legal, aprovado pela Anvisa, que acompanha o medicamento e reúne as informações necessárias ao uso seguro. A norma que fixa forma e conteúdo da bula é a RDC 47/2009, ainda vigente em outubro de 2026, com alterações pontuais feitas pela RDC 406/2020, pela RDC 769/2022 e pela RDC 831/2023. Ela define dois textos diferentes para o mesmo produto: a bula para o paciente e a bula para o profissional de saúde.

O QUE DIZ A NORMA

Bula para o paciente: "bula destinada ao paciente, aprovada pela Anvisa, com conteúdo sumarizado, em linguagem apropriada e de fácil compreensão". A bula para o profissional de saúde tem conteúdo detalhado tecnicamente (RDC 47/2009, art. 4º, IV e V).

As três partes de toda bula

As duas versões seguem o mesmo esqueleto, em três partes (RDC 47/2009, Anexo I):

1. **Identificação do medicamento**: nome comercial, denominação genérica pela DCB, apresentações (forma farmacêutica, concentração, quantidade e acessório dosador), via de administração, faixa etária de uso (em caixa alta e negrito, como USO ADULTO ou USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES) e composição com os excipientes.
2. **Informações ao paciente** (na bula do paciente) ou **informações técnicas aos profissionais de saúde** (na bula do profissional).
3. **Dizeres legais**: número de registro no Ministério da Saúde, farmacêutico responsável com o número no CRF, razão social e CNPJ da empresa titular, fabricante e importador, telefone do SAC e as restrições de venda e de uso.

Bula do paciente: nove perguntas

A parte central da bula do paciente é escrita como perguntas fixas, sempre na mesma ordem. Saber a ordem economiza tempo no balcão.

Nº	Pergunta da bula do paciente	Uso típico no balcão
1	Para que este medicamento é indicado?	Conferir se a indicação bate com a queixa
2	Como este medicamento funciona?	Tempo de início de ação
3	Quando não devo usar este medicamento?	Contraindicações, idade mínima
4	O que devo saber antes de usar este medicamento?	Gestação, lactação, interações, álcool, direção

Nº	Pergunta da bula do paciente	Uso típico no balcão
5	Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?	Conservação e validade depois de aberto
6	Como devo usar este medicamento?	Dose, intervalo, relação com refeições
7	O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?	Dose esquecida
8	Quais os males que este medicamento pode me causar?	Reações adversas por frequência
9	O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?	Superdose, intoxicação acidental

Leitura rápida no balcão

Com o cliente esperando, a leitura segue uma ordem que responde primeiro ao que pode causar dano:

1. **Identificação**: concentração, forma farmacêutica e faixa etária. Muitos erros nascem aqui, antes de qualquer dose.
2. **Contraindicações** (pergunta 3 ou item 4): idade mínima, gestação, doenças que impedem o uso.
3. **Posologia** (pergunta 6 ou item 8): dose por tomada, intervalo, dose máxima e duração sem reavaliação médica.
4. **Interações e advertências** (pergunta 4 ou itens 5 e 6): álcool, outros medicamentos em uso, direção de veículos.
5. **Conservação** (pergunta 5 ou item 7): temperatura, luz, prazo depois de aberto.

Indicação, mecanismo e estudos de eficácia raramente mudam a conduta no balcão e podem ser lidos depois. Quando a bula do paciente usa termo vago, como "conforme orientação médica", a resposta técnica costuma estar no item 8 da bula do profissional.

Bula do profissional: dez itens

A bula do profissional de saúde é organizada em dez itens numerados: 1. Indicações; 2. Resultados de eficácia; 3. Características farmacológicas; 4. Contraindicações; 5. Advertências e precauções; 6. Interações medicamentosas; 7. Cuidados de armazenamento do medicamento; 8. Posologia e modo de usar; 9. Reações adversas; 10. Superdose. É nela que estão as doses por quilo, a farmacocinética, o ajuste na insuficiência renal ou hepática e a lista completa de interações. Para conferir dose pediátrica ou dose máxima, a fonte é o item 8 da bula do profissional, e não a bula impressa do paciente que está na caixa.

PONTO-CHAVE

As reações adversas do item 9 são agrupadas por frequência: muito comum (mais de 1 em 10 pacientes), comum (1 em 100 a 1 em 10), incomum (1 em 1.000 a 1 em 100), rara (1 em 10.000 a 1 em 1.000) e muito rara (menos de 1 em 10.000). Uma reação "rara" pode ser grave, como a agranulocitose da dipirona.

Alterações recentes da norma

- **RDC 406/2020**: atualizou as frases obrigatórias do item de reações adversas da bula do profissional, ligadas à notificação de eventos adversos.
- **RDC 769/2022**: passou a permitir, nas embalagens, um mecanismo digital (como QR Code) que dá acesso à bula publicada no Bulário Eletrônico.
- **RDC 831/2023**: em vigor desde fevereiro de 2024, alterou o art. 14 e permitiu que bulas de genéricos e similares difiram da bula padrão, desde que de acordo com o que foi aprovado no registro de cada produto.
- **RDC 885/2024**: aprovou um projeto-piloto de bula digital, com dispensa opcional da bula impressa em embalagens de determinados medicamentos, condicionada ao fornecimento da bula impressa sempre que o paciente, o prescritor ou o estabelecimento pedir. Em 2026 a Anvisa abriu consultas para avaliar o resultado do piloto.

ATENÇÃO

Se a caixa participa do piloto e veio sem bula impressa, o paciente continua com direito ao texto em papel. A farmácia não deve negar a informação: imprime a bula do Bulário Eletrônico ou orienta o acesso pelo código da embalagem (RDC 885/2024).

Bula em formato especial

A empresa titular do registro deve fornecer de graça a bula em formato especial (áudio, formato digital, Braille ou fonte ampliada) quando a pessoa com deficiência visual pedir, e o SAC deve ser capaz de ler a bula por telefone (RDC 47/2009, art. 40). O envio deve ocorrer em até 10 dias úteis (art. 41). O telefone do SAC está nos dizeres legais da bula e na embalagem.

NO BALCÃO

Cliente idoso com baixa visão pede ajuda para "ler a bula do remédio novo". Leia com ele os itens 6 e 7 (como usar e dose esquecida), escreva o horário na caixa em letra grande e informe que o fabricante é obrigado a enviar a bula em fonte ampliada ou áudio pelo SAC.

Bulário Eletrônico da Anvisa

O **Bulário Eletrônico** é a base pública da Anvisa onde ficam as últimas versões aprovadas das bulas do paciente e do profissional. A RDC 47/2009 determina que as bulas sejam publicadas ali e que apenas bulas de medicamentos comercializados constem da base (art. 38). Na prática, é a fonte oficial para conferir dose, contraindicação e categoria de venda de um produto.

Como consultar

1. Acesse o portal de consultas da Anvisa (consultas.anvisa.gov.br) e escolha **Bulário Eletrônico**. Pelo site gov.br/anvisa, o caminho passa por "Sistemas" e "Sistemas de consultas".
2. Preencha ao menos um campo: nome do medicamento, empresa, número de registro, número do expediente da bula, categoria regulatória ou período de publicação. Os filtros podem ser combinados.

3. Na lista de resultados, cada linha corresponde a um produto de uma empresa. Abra o PDF da **bula do paciente** ou da **bula do profissional** pelo ícone correspondente.
4. Confira a data de publicação e, se precisar, o histórico de versões anteriores.

> **PONTO-CHAVE**
>
> Pesquise pelo nome comercial quando quiser a bula de um produto específico. Pesquise pela substância (DCB) quando quiser ver todos os fabricantes: aparecem referência, genéricos e similares, cada um com sua bula.

Bula do referência, do genérico e do similar

A RDC 47/2009 chama de **bula padrão** o texto que serve de modelo para harmonizar as demais bulas do mesmo fármaco; para genéricos e similares, a bula padrão é a do medicamento de referência (art. 4º, VII). Por isso a bula de um genérico costuma repetir quase literalmente a do referência. Desde a RDC 831/2023, porém, a bula de genérico ou similar pode diferir da bula padrão quando o registro do produto aprovou características diferentes. Exemplos que mudam a orientação:

- apresentações e concentrações diferentes (um genérico pode não ter a forma pediátrica do referência);
- excipientes diferentes, que importam para quem tem alergia a corante, intolerância à lactose ou fenilcetonúria;
- número de gotas por mL, que depende do conta-gotas de cada fabricante;
- cuidados de conservação e prazo depois de aberto;
- categoria de venda, quando um registro foi atualizado para isento de prescrição e outro não.

Bula do profissional ou do paciente

Para estudar e para responder a dúvidas técnicas, use a bula do profissional: ela traz posologia por peso, ajuste em insuficiência renal e hepática, interações com mecanismo e superdose com conduta. Para orientar o paciente, use a linguagem da bula do paciente, que já foi escrita para o público leigo. As duas devem dizer a mesma coisa em níveis de detalhe diferentes.

Versão e data da bula

Toda bula muda ao longo do tempo: inclusão de nova reação adversa, mudança de faixa etária, nova apresentação, alteração de categoria de venda. A bula impressa que acompanha uma caixa fabricada há dois anos pode estar desatualizada em relação à versão publicada hoje. Para questões de segurança, a referência é a última versão do Bulário Eletrônico, cuja data aparece na consulta. A empresa tem prazos para colocar a nova bula nas embalagens e no Bulário depois de cada alteração aprovada (RDC 47/2009, art. 51).

Quando o Bulário não abre

O sistema da Anvisa às vezes fica lento ou bloqueia acessos automatizados. Alternativas, em ordem de confiança: o site do fabricante (que deve manter a bula aprovada), a bula impressa da embalagem em

estoque (conferindo a data de aprovação no fim do texto) e reproduções em portais privados. Portais privados podem estar desatualizados e misturar textos de apresentações diferentes; use como apoio, nunca como fonte final de dose máxima ou de categoria de venda.

CASO

Mãe pede "o mesmo antialérgico em xarope" para um filho de 8 meses. O produto de referência tem solução oral liberada a partir de 6 meses, mas o genérico disponível na loja tem outra faixa etária na bula. O farmacêutico pesquisa a substância no Bulário, abre a bula do profissional do genérico e confere a idade mínima antes de dispensar.

NO BALCÃO

Mantenha no computador do balcão um atalho para o Bulário Eletrônico. Em dúvida sobre dose pediátrica, idade mínima ou dose máxima, consulte a bula do profissional do produto que será entregue, e não a de outro fabricante.

Referência, genérico e similar intercambiável

O cliente pergunta se "o genérico é igual". A resposta correta depende de três categorias de registro, definidas pela regulamentação de genéricos (RDC 16/2007, com redação da RDC 51/2007) e pela norma de similares intercambiáveis (RDC 58/2014).

Categoria	Definição resumida	Como reconhecer	Intercambialidade
Referência	Inovador registrado, com eficácia, segurança e qualidade comprovadas no registro	Nome de marca; consta da lista de referência da Anvisa	Pode ser trocado pelo genérico ou pelo similar intercambiável correspondente
Genérico	Intercambiável com o referência, designado pela DCB	Nome pela DCB; logotipo "Medicamento Genérico" em faixa amarela; frase "Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999"	Substitui o referência, salvo restrição expressa do prescritor
Similar	Mesmo princípio ativo, concentração, forma, via, posologia e indicação; identificado por marca	Nome comercial próprio	Só é intercambiável se aprovado pela Anvisa e listado
Similar intercambiável	Similar com equivalência farmacêutica e bioequivalência (ou bioisenção) aprovadas	Frase "MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA" na bula	Substitui o referência

O QUE DIZ A NORMA

"Será considerado intercambiável o medicamento similar cujos estudos de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade relativa/bioequivalência ou bioisenção tenham sido apresentados, analisados e aprovados pela ANVISA." (RDC 58/2014, art. 2º). O parágrafo único manda a Anvisa publicar a relação dos similares com os referências correspondentes.

Regras da substituição no balcão

- O farmacêutico pode substituir o medicamento prescrito pelo genérico correspondente, salvo restrição expressa do prescritor (RDC 16/2007, Anexo, item 2.1).
- Ao substituir, indica a troca na receita, apõe carimbo com nome e número no CRF, data e assina (item 2.2).
- Deve explicar ao paciente a dispensação feita e orientar o uso (item 2.4). A Resolução CFF 349/2000 reconhece essa atribuição do farmacêutico.
- A troca de similar intercambiável é feita em relação ao referência. A lista publicada pela Anvisa liga cada similar ao seu referência; ela não autoriza trocar genérico por similar nem similar por outro similar.

O que a bula garante e o que não garante

A bula de um genérico ou de um similar intercambiável garante o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, forma farmacêutica, via e posologia do referência, com equivalência demonstrada. Ela não garante que o produto seja idêntico em tudo. Podem mudar: cor, formato, sulco do comprimido, excipientes, sabor, tamanho do frasco, acessório dosador, número de gotas por mL e prazo de validade. Para o paciente, isso tem consequência prática: o idoso estranha o comprimido de outra cor e acha que é outro remédio; o alérgico a corante reage ao excipiente; a mãe usa o conta-gotas de um frasco para medir a dose de outro fabricante.

ATENÇÃO

A categoria de registro não muda a regra de venda. Um genérico de antimicrobiano continua sujeito à retenção de receita pela RDC 471/2021, e um genérico de tramadol continua na lista A2 da Portaria 344/1998, com a receita definida pelo adendo da lista.

CASO

Receita de Allegra® 180 mg, sem restrição à troca. O cliente pede algo mais barato. O farmacêutico oferece o genérico de fexofenadina 180 mg, anota a substituição na receita com carimbo, CRF, data e assinatura e avisa que o comprimido pode ter outra cor. Um similar só poderia entrar no lugar do referência se constasse da relação de intercambiáveis da Anvisa.

Biológicos, fitoterápicos e específicos

Não existe genérico de medicamento biológico nem de fitoterápico no modelo da Lei 9.787/1999. Vitaminas, minerais e outros medicamentos específicos também ficam fora da lógica de intercambialidade. Nesses casos, a troca de marca precisa de nova prescrição.

NO BALCÃO

Ao entregar um genérico ou similar intercambiável no lugar do referência, mostre ao paciente o nome da substância na caixa, diga que a cor ou o formato podem ser diferentes e peça que não tome os dois juntos. Se o produto anterior era em gotas, explique a nova dose em gotas, conferida na bula do produto entregue.

Embalagem e rotulagem no balcão

A embalagem é a primeira bula que o atendente lê. Desde dezembro de 2022, as regras de rotulagem de medicamentos estão na **RDC 768/2022**, que revogou a RDC 71/2009 (art. 104, III). O prazo final para as empresas adequarem as embalagens foi 30 de dezembro de 2025 (art. 95 e regras de transição), e a Anvisa ainda analisa pedidos individuais de exceção para esgotar estoques antigos. Em 2026, portanto, o balcão convive com caixas do modelo novo e algumas do modelo antigo.

Face frontal

A face principal do cartucho deve trazer o nome comercial, a DCB, a concentração, a forma farmacêutica, a via de administração, a restrição de uso por idade (por exemplo USO ADULTO, em caixa alta e negrito) e a identificação da empresa (RDC 768/2022, art. 3º). É ali também que aparecem as marcas de categoria de venda:

- **Venda sob prescrição**: faixa vermelha ou preta com a frase VENDA SOB PRESCRIÇÃO dentro da faixa (arts. 20 e 23). A faixa preta identifica os controlados mais restritos, como os sujeitos a Notificação de Receita.
- **Retenção de receita**: frase própria para os controlados das listas que exigem retenção e para os antimicrobianos (arts. 35 e 43). Nas bulas conferidas aparece como "Só pode ser vendido com retenção da receita" (Tramal®, Tylex®, Dermazine®).
- **Isento de prescrição**: frase em negrito "Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde", além das indicações e das principais contraindicações na embalagem (art. 17).
- **Genérico**: logotipo "Medicamento Genérico" dentro da faixa amarela (arts. 25 a 29).

Demais faces

As outras faces trazem os dados de rastreio e de uso seguro: empresa, CNPJ e "Registrado por"; número de registro; lote, data de fabricação e prazo de validade; telefone do SAC; cuidados de conservação; a orientação para consultar a bula; frases de alerta definidas na RDC 770/2022; quantidade total; e o código de barras e os dados de rastreabilidade (RDC 768/2022, art. 5º).

Informação	Onde está	Para que serve no balcão
Concentração e forma	Face frontal	Evitar troca de 200 mg/mL por 50 mg/mL; comprimido de liberação prolongada por convencional
Restrição de idade	Face frontal	USO ADULTO no frasco de gotas impede a venda para criança
Faixa e frase de venda	Face frontal	Decidir se exige receita e se retém
Lote e validade	Lateral ou aba	Conferir na entrega; anotar na queixa técnica e na notificação de evento adverso
Conservação	Lateral	Orientar temperatura, luz, umidade e prazo após aberto
Registro e SAC	Lateral	Confirmar regularidade; contato com o fabricante

PONTO-CHAVE

A categoria de venda vale por registro, e não por substância. A desloratadina consta da lista de isentos, mas a bula do Desalex® consultada em 2026 ainda traz "venda sob prescrição médica". O ibuprofeno em gotas de 50 e 100 mg/mL é isento, e a apresentação de 200 mg/mL do mesmo fabricante traz venda sob prescrição. Leia a embalagem do produto que está na mão.

Erros de leitura que causam dano

- Confundir mg/mL com mg/gota: 500 mg/mL de dipirona em gotas são 25 mg por gota quando o frasco tem 20 gotas por mL.
- Ler só o nome de marca e não ver a extensão: "Retard", "Entérico", "Flash", "D", "Baby" mudam forma, dose ou idade.
- Ignorar "uso adulto" em gotas de metoclopramida ou em comprimidos de loperamida.
- Dispensar embalagem com validade próxima do fim de um tratamento longo.

NO BALCÃO

Antes de embalar, leia em voz alta para o cliente o nome, a concentração e a forma farmacêutica escritos na caixa e compare com a receita ou com o pedido. A conferência em três pontos (nome, concentração, forma) pega a maioria das trocas.

Da bula à orientação ao paciente

A bula diz o que pode ser feito; a orientação diz ao paciente o que ele vai fazer amanhã às 8 horas. Transformar uma em outra é trabalho do farmacêutico (Lei 13.021/2014, art. 13, VI). O roteiro abaixo cobre o que mais gera erro de uso.

Posologia em horários

"1 comprimido a cada 8 horas" e "3 vezes ao dia" não são a mesma coisa para medicamentos que dependem de nível constante. Combine com o paciente horários reais (por exemplo 6 h, 14 h e 22 h) e escreva na caixa. Para analgésicos usados "se dor", explique o intervalo mínimo entre doses e a dose máxima do dia, que estão no item 8 da bula do profissional e no item 6 da bula do paciente.

Medicamento (bula consultada)	Dose máxima diária na bula
Paracetamol 750 mg (genérico Medley)	4000 mg, sem passar de 1000 mg por dose
Dipirona (Novalgina®)	Adulto: 40 gotas ou 1 g por dose, até 4 vezes ao dia
Ibuprofeno 400 mg (Advil®)	1200 mg sem prescrição
Naproxeno sódico (Flanax®)	550 mg sem prescrição, até 10 dias
Loperamida (Imosec®)	16 mg (8 comprimidos)
Dimenidrinato 50 mg (Dramin® Capsgel)	400 mg no adulto; 150 mg de 6 a 12 anos

Relação com alimentos e com outros medicamentos

A bula indica se o medicamento deve ser tomado em jejum, com alimento ou longe de outro produto. Exemplos conferidos:

- Bisacodil (Dulcolax®): não tomar com leite, antiácido ou inibidor de bomba de prótons, que dissolvem o revestimento entérico antes da hora.
- Fexofenadina (Allegra®): evitar suco de frutas junto e esperar 2 horas de antiácido com alumínio e magnésio.
- Acetilcisteína (Fluimucil®): quando houver antibiótico oral, separar 2 horas.
- Metoclopramida (Plasil®): 10 minutos antes das refeições; domperidona (Motilium®): 15 a 30 minutos antes.
- AINE (Advil®, Profenid®): durante ou após as refeições.
- Omeprazol (Losec Mups®): pela manhã; se precisar dispersar, usar água sem gás ou suco, nunca leite.
- Montelucaste na asma (Singulair®): ao anoitecer.
- Simeticona e levotiroxina: a simeticona pode reduzir a absorção da levotiroxina (bula do Luftal®).

Medir a dose líquida

O número de gotas por mL é definido pelo conta-gotas de cada produto e está na bula. Nas bulas consultadas: dipirona Novalgina® 20 gotas/mL; bromoprida Digesan® 24 gotas/mL; metoclopramida Plasil® 21 gotas/mL; butilescopolamina Buscopan® 20 gotas/mL; tramadol Tramal® 20 a 40 gotas para 50 a 100 mg, a 100 mg/mL. Orientar sempre com o dosador que veio na caixa e nunca com colher de cozinha.

ATENÇÃO

Trocar o frasco de gotas por outro fabricante ou outra concentração sem recalcular a dose é causa clássica de superdose em criança. Ibuprofeno existe em 50, 100 e 200 mg/mL; a mesma "quantidade de gotas" muda a dose em até quatro vezes.

Conservação

Quase todas as bulas conferidas pedem temperatura ambiente entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade. O banheiro, com vapor do chuveiro, e o carro ao sol são os piores lugares. Alguns produtos têm prazo próprio depois de aberto: acetilcisteína xarope (Fluimucil®) 14 dias; tramadol gotas (Tramal®) 6 meses; fexofenadina suspensão (Allegra®) 12 meses; budesonida + formoterol spray (Symbicort®) 3 meses após abrir o invólucro de alumínio. O aerossol de salbutamol não pode ser furado nem exposto a mais de 50 °C, e o efeito cai se o frasco ficar frio (bula do Aerolin®). O aciclovir creme não deve ir à geladeira (bula do Zovirax®).

Dose esquecida

A resposta está no item 7 da bula do paciente. A regra mais comum é tomar assim que lembrar, a menos que esteja perto do horário da próxima dose; nesse caso, pular a esquecida e seguir o horário, sem dobrar a dose. Há exceções que dependem do produto, como contraceptivos orais e anticoagulantes: leia o item 7 do produto antes de responder.

CASO

Senhor de 70 anos sai com omeprazol 20 mg, bisacodil 5 mg e leite de magnésia comprados juntos. A orientação, tirada das bulas, é: omeprazol pela manhã, em jejum; bisacodil à noite, nunca com o leite de magnésia nem com leite, e longe do omeprazol; procurar o médico se a prisão de ventre durar mais que alguns dias.

NO BALCÃO

Termine a entrega com três perguntas de checagem: "Como o senhor vai tomar?", "Até quando?" e "O que faz se esquecer?". Se o paciente não souber responder, a orientação ainda não terminou.

Farmacovigilância a partir da bula

Farmacovigilância é a vigilância dos efeitos dos medicamentos depois que chegam ao mercado. A farmácia comercial é um ponto privilegiado: é ali que o cliente volta dizendo que "o remédio deu coceira" ou que "a cápsula veio grudada". A Lei 13.021/2014 obriga o farmacêutico a notificar os profissionais de saúde, os órgãos sanitários e o laboratório fabricante dos efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência observados (art. 13, I).

O QUE DIZ A NORMA

"Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a: I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância" (Lei 13.021/2014, art. 13, I).

Evento adverso ou queixa técnica

	Evento adverso	Queixa técnica
O que é	Dano ou efeito indesejado na pessoa que usou o medicamento	Suspeita de problema no produto: desvio de qualidade, falsificação, produto sem registro, empresa irregular
Exemplos	Urticária após dipirona; sonolência intensa com ciclobenzaprina; falta de efeito inesperada	Comprimido quebrado ou manchado, cor diferente no mesmo lote, frasco vazando, rótulo ilegível, lacre violado
Sistema da Anvisa	VigiMed	Notivisa
Quem notifica	Cidadão, profissional de saúde, serviço de saúde, empresa	Profissional, serviço, cidadão

Para notificar evento adverso não é preciso ter certeza da causa: a suspeita basta. A Anvisa não reconhece bases privadas de notificação como válidas para farmacovigilância. Na queixa técnica, o sigilo do notificante é preservado e os dados pessoais não ficam visíveis para a empresa, que recebe a notificação para investigar.

Como a bula ajuda

- O **item 8 da bula do paciente** (item 9 da bula do profissional) diz se a reação é esperada e com que frequência. Reação descrita na bula também deve ser notificada; reação grave ou ausente da bula merece atenção dobrada.
- O **item 3 ou 4** (contraindicações e advertências) mostra se houve uso fora do previsto, por exemplo AINE em quem tem asma induzida por ácido acetilsalicílico.
- Os **dizeres legais** trazem o fabricante, o registro e o SAC, dados exigidos na notificação.
- A **embalagem** traz lote e validade, sem os quais a queixa técnica não pode ser rastreada.

PONTO-CHAVE

Guarde o produto suspeito, a embalagem e a bula. Na queixa técnica, separe as unidades do mesmo lote que estão em estoque até a resposta da empresa ou da vigilância sanitária.

O que registrar

1. Paciente: iniciais, idade, sexo, peso se criança, gestação.
2. Medicamento: nome comercial e DCB, concentração, fabricante, lote, validade, dose, via, data de início e de suspensão.
3. Evento: descrição, data de início, gravidade, desfecho, se melhorou com a suspensão e se voltou ao reintroduzir.
4. Outros medicamentos em uso, inclusive isentos de prescrição e fitoterápicos.
5. Conduta da farmácia: encaminhamento, suspensão orientada, contato com o prescritor.

ATENÇÃO

Sinais de gravidade pedem encaminhamento imediato antes de qualquer formulário: falta de ar, inchaço de lábios ou língua, bolhas na pele ou nas mucosas, febre com dor de garganta durante uso de dipirona, fezes pretas durante uso de AINE, sonolência extrema ou respiração lenta com codeína ou tramadol.

CASO

Cliente de 41 anos volta à farmácia com placas vermelhas que coçam, dois dias após iniciar nimesulida prescrita. Não há falta de ar nem lesão em mucosa. O farmacêutico orienta suspender e procurar o prescritor, consulta o item de reações adversas da bula, registra lote e validade da caixa e notifica a suspeita no VigiMed.

NO BALCÃO

Tenha um formulário interno de farmacovigilância junto ao caixa, com campos de lote e validade. A notificação feita no mesmo dia, com a caixa na mão, é muito mais completa do que a feita de memória.

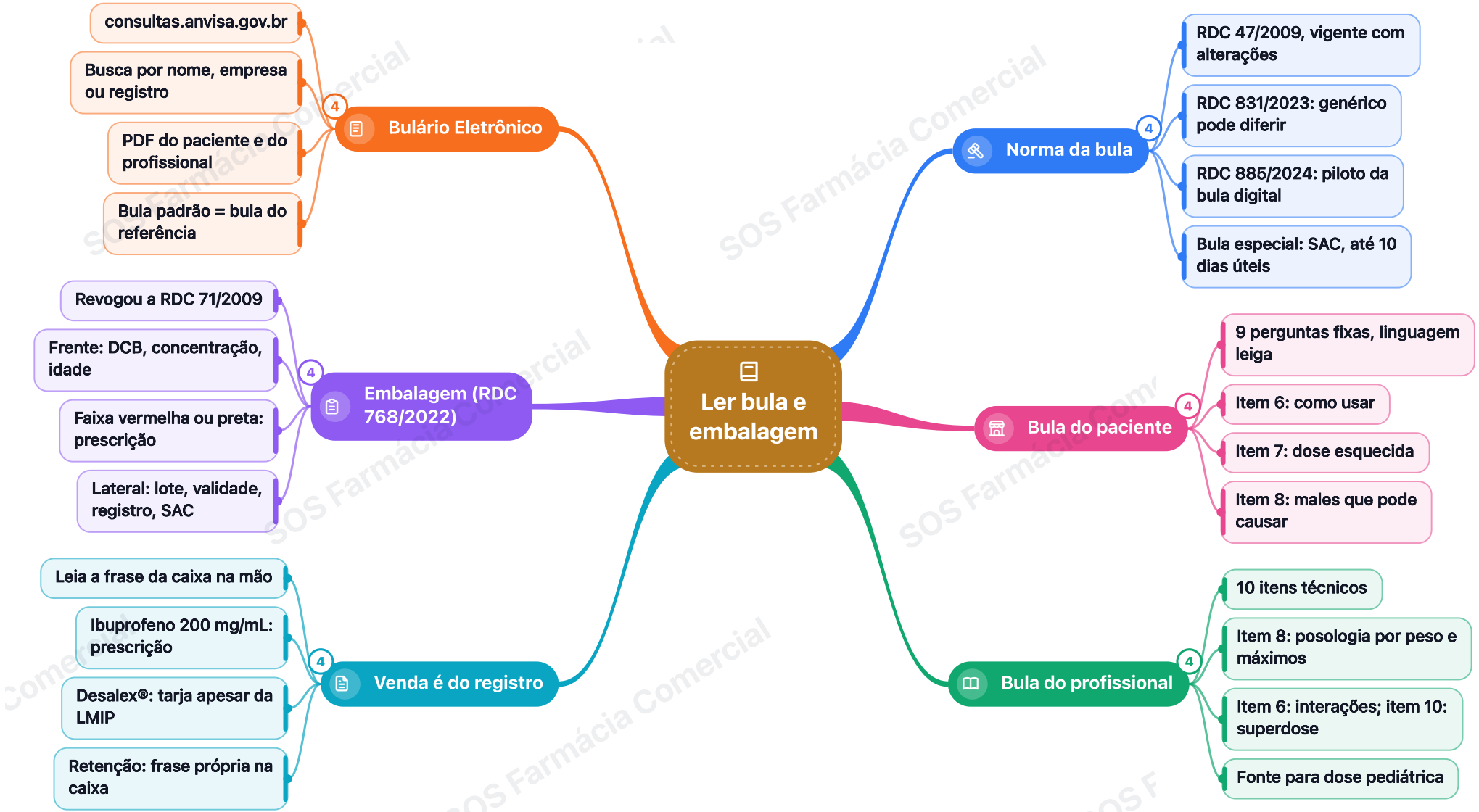
Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução RDC nº 47, de 8 de setembro de 2009. Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos. Texto em bvsms.saude.gov.br (consulta out. 2026).
2. Anvisa. Resolução RDC nº 406, de 2020 (farmacovigilância; altera frases obrigatórias de reações adversas da bula do profissional). Citada em fontes secundárias.
3. Anvisa. Resolução RDC nº 769, de 12 de dezembro de 2022 (altera a RDC 47/2009: mecanismo digital de acesso à bula, art. 26, § 2º).
4. Anvisa. Resolução RDC nº 831, de 6 de dezembro de 2023 (altera o art. 14 da RDC 47/2009). Vigência a partir de 6 fev. 2024.
5. Anvisa. Resolução RDC nº 885, de 2024. Projeto-piloto de bula digital (publicada em julho de 2024); Consultas Dirigidas 4/2026 e 5/2026 para avaliação de resultado regulatório.
6. Anvisa. Resolução RDC nº 768, de 12 de dezembro de 2022. Regras para a rotulagem de medicamentos (arts. 3º, 5º, 17, 20, 23, 25 a 29, 35, 43, 95 e 104). Texto em lex.com.br (consulta out. 2026); Perguntas e Respostas RDC 768/2022, v.2, 2025.

7. Anvisa. Resolução RDC nº 16, de 2 de março de 2007, com redação da RDC nº 51, de 15 de agosto de 2007. Regulamento técnico para medicamentos genéricos (definições e itens 2.1 a 2.5 de dispensação), conforme transcrição do CRF-SP, Orientação Farmacêutica Intercambialidade de medicamentos, 2023.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014. Intercambialidade de medicamentos similares com o medicamento de referência.
9. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 349, de 20 de janeiro de 2000. Competência do farmacêutico para intercambialidade e substituição genérica.
10. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico).
11. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, art. 13. planalto.gov.br (consulta out. 2026).
12. Anvisa. VigiMed e Notivisa: páginas de notificação de eventos adversos e queixas técnicas em gov.br (consulta out. 2026); nota da Anvisa de 27/08/2025 sobre notificação por suspeita.
13. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024, com redação da IN nº 404, de 10 de novembro de 2025 (LMIP).
14. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, e Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (antimicrobianos).
15. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, Anexo I, lista A2 e adendos (conforme módulo de controlados do SOS Farmácia Comercial).
16. Ministério da Saúde. Cartaz Manejo do paciente com diarreia. bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/manejo_paciente_diarreia_cartaz.pdf (consulta out. 2026).
17. Bulas consultadas (bula do paciente com trechos da bula do profissional, texto reproduzido no portal Consulta Remédios, outubro de 2026; o Bulário Eletrônico da Anvisa não foi acessado diretamente): Tylenol® Bebê e Criança (Janssen-Cilag); paracetamol 750 mg genérico (Sanofi Medley); Novalgina® comprimido e solução oral (Sanofi Medley); Advil® 400 mg (PF Consumer Healthcare); Alivium® (Cosmed); Nisulid® (Aché); Cataflam®, Cataflam® gotas e Voltaren® (Novartis); Profenid® (Sanofi Medley); Flanax®, Naprosyn® e Aspirina® (Bayer); Miosan® (Apsen); Tramal® (Grünenthal); Tylex® (Cellera); Meticorten® (Organon); Predsim® (Cosmed); Prelone® e Decadron® (Aché).
18. Bulas consultadas (mesma origem): Claritin® (Bayer); Desalex® e Singulair® (Organon); Zyrtec® e Aerolin® (GlaxoSmithKline); Allegra® e Mucosolvan® (Sanofi Medley); Polaramine® (Cosmed); Symbicort® Spray (AstraZeneca); Fluimucil® (Zambon); Losec Mups® (Biopas); Pantozol® (Takeda); Vonau Flash® (Biolab); Zofran® (Novartis); Plasil® (Sanofi-Aventis); Digesan® (Eurofarma); Motilium® e Imosec® (Janssen-Cilag); Buscopan® (Cosmed); Luftal® (Reckitt Benckiser); Hidrafix® (Takeda); Lactulona® (Daiichi Sankyo); Dulcolax® (Sanofi Medley); Dramin® Capsgel (Cosmed); Nizoral® creme e Daktarin® gel oral (Janssen-Cilag); Vodol® (União Química); Gino-Canesten® (Bayer); Micostatin® creme vaginal (Takeda); nistatina suspensão oral genérico (Prati-Donaduzzi); Zovirax® creme (GlaxoSmithKline); Dermazine® (Cristália).
19. Bulas dos medicamentos do Bulário de bolso: texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), consulta em outubro de 2026; fabricante indicado em cada item.
20. Anvisa. Instrução Normativa nº 360/2025 (lista de antimicrobianos da RDC 471/2021).
21. Anvisa. RDC nº 1.036/2026: Atualização nº 101 do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

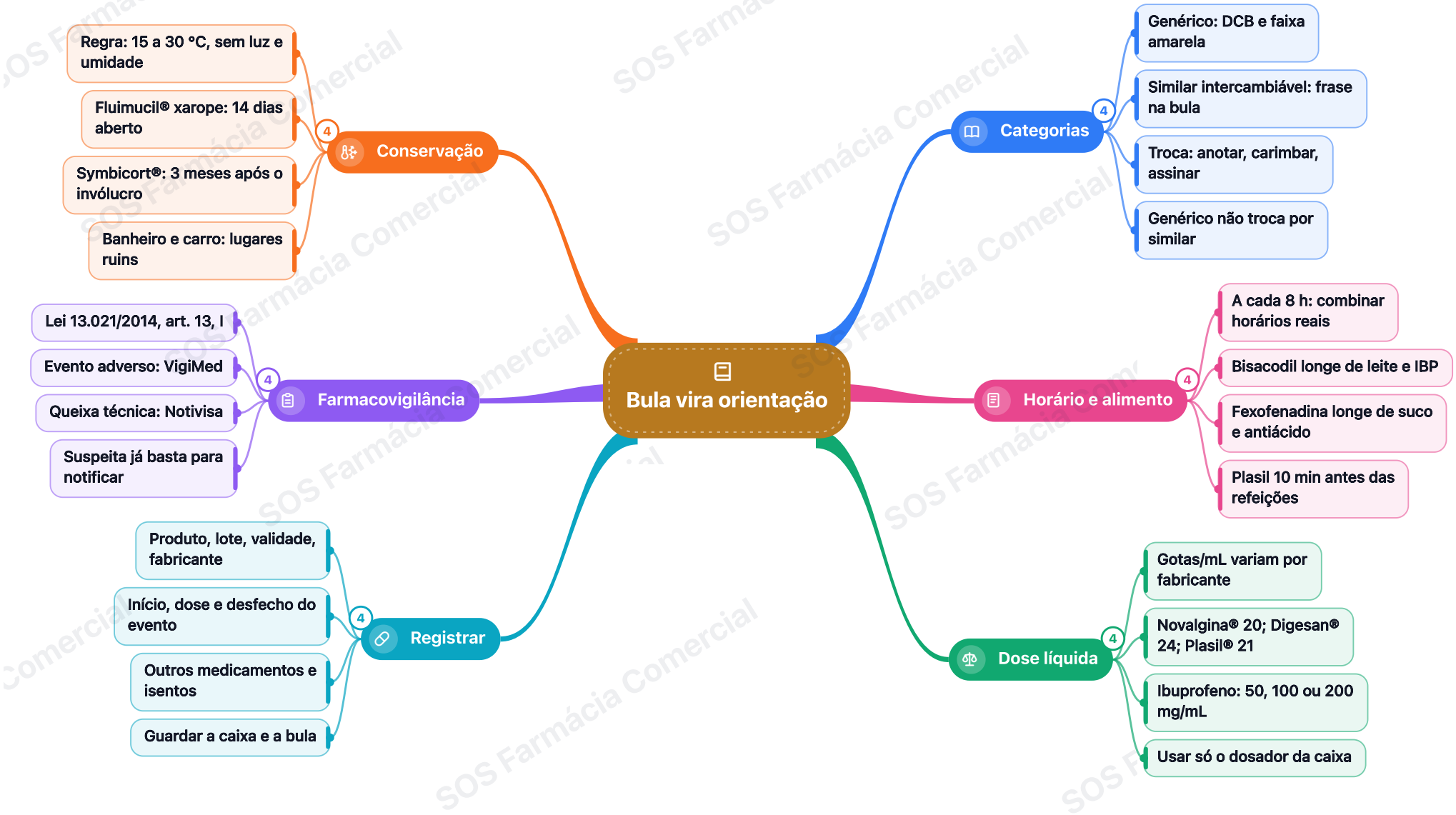
Bula e embalagem

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 14



Da bula ao uso seguro

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 14



Bulário de bolso

Resumo para consulta rápida, montado a partir das bulas conferidas em outubro de 2026. A bula vigente do produto dispensado prevalece sobre este quadro.

Acetilcisteína (Fluimucil® (referência)). Mucolítico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Granulado 600 mg; comprimido efervescente 200 e 600 mg; xarope 20 mg/mL (pediátrico) e 40 mg/mL (adulto)

Indicações: Secreção espessa em bronquite e outras doenças respiratórias; antídoto do paracetamol (uso hospitalar)

Adulto: 600 mg 1 vez ao dia, de preferência à noite, por 5 a 10 dias

Criança: 2 a 4 anos: 100 mg 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos: 100 mg 3 a 4 vezes ao dia (xarope 20 mg/mL)

Dose máxima: 600 mg/dia sem prescrição

Contraindicações: Menor de 2 anos; alergia aos componentes

Interações: Antitussígenos (acúmulo de secreção); antibiótico oral: separar 2 h; carvão ativado

Gestação e lactação: Preferível evitar na gestação

Conservação: 15 a 30 °C; xarope válido por 14 dias após aberto

No balcão: Dissolver o granulado em meio copo de água e tomar logo. Beber bastante líquido. Não associar a xarope para tosse seca.

Fonte: Bula do Fluimucil® (Zambon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 285/2024 (LMIP)

Aciclovir (creme) (Zovirax® creme (referência)). Antiviral tópico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Creme 50 mg/g, bisnaga 10 g

Indicações: Herpes labial e genital

Adulto: 5 vezes ao dia, a cada 4 h acordado; pelo menos 4 dias (labial) ou 5 dias (genital)

Criança: Mesmo esquema (uso adulto e pediátrico)

Dose máxima: Se não cicatrizar, mais 5 dias; lesão após 10 dias: médico

Contraindicações: Alergia a aciclovir, valaciclovir ou propilenoglicol

Interações: Sem interações significativas

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco

Conservação: Abaixo de 30 °C; não colocar na geladeira

No balcão: Começar no formigamento. Lavar as mãos antes e depois. Sem receita, a lista de isentos tem penciclovir creme.

Fonte: Bula do Zovirax® creme (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Aciclovir (oral) (Zovirax® comprimido (referência)). Antiviral (análogo de nucleosídeo). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 200 mg (25); genéricos com 400 mg conforme o fabricante

Indicações: Herpes simples (tratamento, supressão e prevenção) e herpes-zóster

Adulto: Herpes simples: 200 mg 5 vezes ao dia (de 4/4 h, pulando a noite) por 5 dias. Supressão: 400 mg de 12/12 h. Zóster: 800 mg 5 vezes ao dia por 7 dias

Criança: Comprimido a partir de 6 anos; dose pediátrica conforme a bula do produto

Dose máxima: 4 g/dia (800 mg 5 vezes ao dia, no zóster)

Contraindicações: Alergia a aciclovir ou valaciclovir

Interações: Probenecida, cimetidina e micofenolato (aumentam níveis); ajustar dose em insuficiência renal e idosos

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco. Lactação: passa ao leite; com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, na embalagem original

No balcão: Começar o quanto antes, de preferência ao primeiro formigamento. Beber água ao longo do dia, sobretudo idosos. Lesão perto do olho: encaminhar.

Fonte: Bula do Zovirax® comprimido (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Ácido acetilsalicílico (dose analgésica) (Aspirina® 500 mg (referência)). Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório (salicilato). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg

Indicações: Dor e febre em adultos

Adulto: 500 a 1000 mg a cada 4 a 8 h, após refeições, com bastante líquido

Criança: A partir de 12 anos: 500 mg a cada 4 a 8 h, até 3 comprimidos/dia

Dose máxima: 4 g/dia (8 comprimidos); até 3 a 5 dias sem médico

Contraindicações: Alergia a salicilatos; asma por AINE; úlcera; tendência a sangramento; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; metotrexato 15 mg/semana ou mais; último trimestre de gestação

Interações: Anticoagulantes, antiagregantes, álcool, outros AINE, corticoide, metotrexato, valproato

Gestação e lactação: Contraindicado no último trimestre; evitar no restante sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Não usar na suspeita de dengue, gripe ou varicela em criança e adolescente (síndrome de Reye). Dose analgésica é diferente da dose antiplaquetária.

Fonte: Bula da Aspirina® 500 mg (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Ácido acetilsalicílico 100 mg (antiagregante) (Aspirina® Prevent). Antiagregante plaquetário (inibidor da COX-1). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos gastrorresistentes 100 mg e 300 mg

Indicações: Prevenção secundária após infarto, AVC ou AIT; angina; prevenção de trombose após intervenção vascular; redução do risco de primeiro infarto conforme avaliação médica

Adulto: 100 a 300 mg 1 vez ao dia (redução de risco do primeiro infarto: 100 mg/dia). Tomar 30 minutos antes de uma refeição, com água, sem partir nem mastigar

Contraindicações: Alergia a salicilatos; asma induzida por AINE; úlcera gastrointestinal ativa; tendência a sangramento; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; metotrexato a partir de 15 mg/semana; último trimestre da gestação. Não recomendado abaixo de 18 anos

Interações: Anticoagulantes, clopidogrel e outros antiagregantes: sangramento. AINE e ISRS: úlcera e sangramento digestivo. Álcool: lesão gástrica. Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia. Metotrexato: toxicidade

Gestação e lactação: Evitar no 1º e 2º trimestres salvo necessidade; contraindicado no 3º trimestre

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade; tirar do blíster só na hora de tomar

No balcão: Não partir nem mastigar o comprimido gastrorresistente no uso diário. Fezes escuras, vômito com sangue ou manchas roxas fáceis exigem avaliação médica. Avisar o dentista antes de extração

Fonte: Bula de Aspirina® Prevent (Bayer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Ácido fólico (Endofolin® (Marjan)). Vitamina do complexo B (folato). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg (30) e 5 mg (30 ou 90); solução oral 0,2 mg/mL em produtos de notificação simplificada (isentos)

Indicações: Prevenção de defeitos do tubo neural; anemia megaloblástica por folato; prevenção da toxicidade do metotrexato; hiper-homocisteinemia

Adulto: Tubo neural: 5 mg/dia (ou 2 x 2 mg) desde antes da concepção até 12 semanas de gestação. Metotrexato: 5 mg 1 vez por semana ou 2 mg/dia

Dose máxima: 15 mg/dia (bula do Endofolin®)

Contraindicações: Anemia perniciosa sem diagnóstico excluído (mascara a falta de B12); hepatopatia grave com distúrbio de coagulação; menores de 14 anos (Endofolin®)

Interações: Fenitoína, fenobarbital e primidona (reduzem folato e o folato pode reduzir o efeito delas); metotrexato; pirimetamina; colestiramina, metformina e antiácidos reduzem a absorção

Gestação e lactação: Indicado na gestação com prescrição

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Na gestação, o ideal é começar antes de engravidar. Com metotrexato, seguir exatamente o dia e a dose de folato da receita.

Fonte: Bula do Endofolin® (Marjan) e de ácido fólico genérico, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025 e 2023)

Ácido valproico (valproato) (Depakene®; também Depakote® (divalproato)). Anticonvulsivante de amplo espectro. *Controle especial · C1*

Apresentações: Depakene®: comprimidos revestidos de liberação entérica 300 mg e 500 mg (valproato de sódio); xarope 50 mg/mL, frasco 100 mL. Outras formas conforme o fabricante

Indicações: Epilepsia (crises generalizadas e parciais, ausência); outros usos conforme a bula de cada produto

Adulto: Epilepsia: 10 a 15 mg/kg/dia (ausência: 15 mg/kg/dia), aumentando 5 a 10 mg/kg por semana; pelo menos 2 tomadas por dia

Criança: Mesma dose por kg; Depakene® é contraindicado abaixo de 10 anos (outras marcas conforme a bula)

Dose máxima: 60 mg/kg/dia

Contraindicações: Doença ou disfunção hepática significativa; síndrome de Alpers-Huttenlocher; distúrbio do ciclo da ureia; porfiria; deficiência de carnitina; gestação, salvo sem alternativa

Interações: Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e ritonavir: menos valproato. Carbapenêmicos: queda importante do nível. AAS: mais valproato. Lamotrigina: reduzir a dose dela. Anticoncepcional com estrogênio e dipirona: podem reduzir o nível

Gestação e lactação: Alto risco de malformação e de distúrbio do neurodesenvolvimento: em mulher fértil, só com programa de prevenção da gravidez. Amamentação conforme avaliação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz (comprimido também da umidade)

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias; anticonvulsivante pode ser prescrito para até 6 meses. Engolir o comprimido inteiro. Mulher em idade fértil deve usar contracepção e não engravidar sem planejar com o médico

Fonte: Bula de Depakene® (Abbott), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Albendazol (Zentel® (referência)). Anti-helmíntico benzimidazólico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido mastigável 400 mg (1); suspensão oral 40 mg/mL (frasco de 10 mL, dose única de 400 mg)

Indicações: Ascaridíase, ancilostomíase, tricuríase, enterobíase, estrongiloidíase, teníase, himenolepíase, giardíase (2 a 12 anos), larva migrans cutânea

Adulto: 400 mg dose única (ascaris, ancilostomo, tricúris, enteróbio); estrongiloides, tênia e H. nana: 400 mg/dia por 3 dias; larva migrans: 400 mg/dia por 1 a 3 dias

Criança: Acima de 2 anos: mesma dose do adulto; giardíase (2 a 12 anos): 400 mg/dia por 5 dias

Dose máxima: 400 mg/dia nas indicações usuais (opistorquíase: 400 mg de 12/12 h por 3 dias)

Contraindicações: Alergia a benzimidazólicos; gestação, suspeita de gestação ou plano de engravidar

Interações: Cimetidina, praziquantel e dexametasona aumentam níveis; ritonavir, fenitoína, carbamazepina e fenobarbital reduzem

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação. Lactação: não usar, salvo benefício que justifique

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode mastigar o comprimido ou engolir com água, sem dieta especial. Na oxiuríase, orientar higiene das mãos, unhas curtas e tratamento dos moradores conforme o médico.

Fonte: Bula do Zentel® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Alopurinol (Zyloric® (referência)). Inibidor da xantina oxidase (hipouricemiante). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 100 mg e 300 mg (30)

Indicações: Gota crônica e hiperuricemia; prevenção de cálculo de ácido úrico; hiperuricemia de quimioterapia

Adulto: Iniciar com 100 mg/dia e subir conforme o ácido úrico; leve: 100 a 200 mg/dia; moderada: 300 a 600 mg/dia; grave: 700 a 900 mg/dia; após refeição, com bastante líquido

Criança: Menores de 10 anos: 10 a 20 mg/kg/dia, máximo 400 mg/dia (uso raro: neoplasias e defeitos enzimáticos)

Dose máxima: 900 mg/dia (adulto); acima de 300 mg/dia, pode dividir as doses

Contraindicações: Hipersensibilidade ao alopurinol

Interações: Azatioprina e mercaptopurina (toxicidade grave), varfarina, amoxicilina e ampicilina (exantema), teofilina, ciclofosfamida; tiazídicos e IECA aumentam risco de hipersensibilidade

Gestação e lactação: Categoria C: só sem alternativa mais segura. Não usar na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Uso contínuo, mesmo sem dor. Beber cerca de 2 litros de água por dia. Erupção na pele ou febre: suspender e procurar o médico logo (bula).

Fonte: Bula do Zyloric® (Aspen Pharma), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Alprazolam (Frontal®, Frontal® XR). Benzodiazepínico. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg; liberação lenta (XR) 0,5 mg, 1 mg e 2 mg

Indicações: Transtornos de ansiedade; transtorno do pânico

Adulto: Ansiedade: 0,25 a 0,5 mg 3 vezes ao dia; faixa 0,5 a 4 mg/dia. Pânico: 0,5 a 1 mg ao deitar ou 0,5 mg 3 vezes ao dia, com aumentos de no máximo 1 mg a cada 3 a 4 dias. Idoso: 0,25 mg 2 a 3 vezes ao dia

Dose máxima: Ansiedade 4 mg/dia; pânico até cerca de 10 mg/dia em casos selecionados

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínicos; miastenia gravis; glaucoma agudo de ângulo estreito; menor de 18 anos

Interações: Opioides (inclusive tramadol): sedação profunda, parada respiratória e morte. Álcool e outros depressores. Cetoconazol, itraconazol, fluvoxamina, fluoxetina, macrolídeos, inibidores de protease: mais alprazolam

Gestação e lactação: Avisar o médico se engravidar. Não usar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita. Redução para parar deve ser lenta, em geral até 0,5 mg a cada 3 dias. Não usar com álcool nem com analgésico opioide

Fonte: Bula de Frontal® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 22/01/2026. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Ambroxol (Mucosolvan® (referência)). Mucolítico e expectorante. *Isento de prescrição*

Apresentações: Xarope adulto 6 mg/mL e pediátrico 3 mg/mL; gotas 7,5 mg/mL; cápsula de liberação prolongada 75 mg

Indicações: Secreção respiratória espessa

Adulto: 30 mg 3 vezes ao dia (4 mL das gotas) ou 75 mg (cápsula) 1 vez ao dia

Criança: 2 a 5 anos: 7,5 mg 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos: 15 mg 3 vezes ao dia (ou 0,5 mg/kg 3 vezes ao dia)

Dose máxima: 90 mg/dia no adulto

Contraindicações: Alergia ao ambroxol; xarope: intolerância à frutose

Interações: Sem interações prejudiciais conhecidas

Gestação e lactação: Não recomendado no 1º trimestre nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C; gotas e xarope protegidos da luz

No balcão: Cápsula de 75 mg inteira, sem abrir. Gotas podem ir em inalação com soro fisiológico, conforme a bula.

Fonte: Bula do Mucosolvan® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Amitriptilina (Amytril®). Antidepressivo tricíclico. *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 25 mg e 75 mg

Indicações: Depressão; enurese noturna

Adulto: Depressão ambulatorial: 75 mg/dia divididos ou 50 a 100 mg à noite, até 150 mg/dia; manutenção 50 a 100 mg/dia à noite. Idoso e adolescente: 10 a 50 mg/dia

Criança: Enurese: 6 a 10 anos, 10 a 20 mg ao deitar; a partir de 11 anos, 25 a 50 mg ao deitar. Depressão: só acima de 12 anos

Dose máxima: 150 mg/dia ambulatorial; até 300 mg/dia em internados

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO; uso de cisaprida; infarto nos últimos 30 dias

Interações: Álcool, benzodiazepínicos e outros depressores: sedação. Anticolinérgicos: íleo paralítico. Tramadol e serotoninérgicos: síndrome serotoninérgica. Fluoxetina, paroxetina e outros inibidores do CYP2D6: nível maior. Topiramato: aumento do nível

Gestação e lactação: Na gestação só com orientação médica. Passa ao leite; escolher entre remédio e amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa sonolência, boca seca e intestino preso; tomar à noite e evitar álcool. Guardar longe de crianças: superdose é grave

Fonte: Bula de Amytril® (Cristália), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Amoxicilina (Amoxil® (referência)). Penicilina (aminopenicilina). *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 500 mg (15, 21 ou 30); pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (frasco de 150 mL)

Indicações: Infecções respiratórias (otite, sinusite, amigdalite, pneumonia), urinárias, de pele e partes moles; erradicação do H. pylori em esquema combinado

Adulto: 250 a 500 mg de 8/8 h; casos graves: 3 g de 12/12 h; H. pylori: 1 g de 12/12 h por 7 dias, com IBP e outro antimicrobiano

Criança: Abaixo de 40 kg: 20 a 50 mg/kg/dia divididos de 8/8 h

Dose máxima: Adulto: 6 g/dia. Criança: 150 mg/kg/dia

Contraindicações: Alergia a penicilinas; cautela com história de alergia a cefalosporinas. Suspensão: contém aspartamo (fenilcetonúria)

Interações: Varfarina (INR pode subir), metotrexato (toxicidade), alopurinol (exantema), probenecida; bula recomenda método adicional com pílula anticoncepcional

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação se o benefício justificar. Lactação: passa em quantidade mínima; compatível com orientação

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da umidade. Suspensão reconstituída do Amoxil®: geladeira (2 a 8 °C) por 14 dias; genéricos e similares: conforme a bula do produto

No balcão: Tomar nos horários certos, de preferência às refeições, até o fim do tratamento. Diarreia intensa, manchas na pele ou inchaço no rosto: suspender e procurar atendimento.

Fonte: Bula do Amoxil® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Amoxicilina + clavulanato de potássio (Clavulin® e Clavulin® BD (referência)). Penicilina associada a inibidor de betalactamase. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg + 125 mg e 875 mg + 125 mg; pó para suspensão 250 mg + 62,5 mg/5 mL (100 mL), 200 mg + 28,5 mg/5 mL (70 mL) e 400 mg + 57 mg/5 mL (70 ou 140 mL)

Indicações: Otite, sinusite, infecções respiratórias baixas, urinárias, de pele e partes moles, mordeduras, quando há suspeita de bactéria produtora de betalactamase

Adulto: 875 mg + 125 mg de 12/12 h ou 500 mg + 125 mg de 8/8 h, no início da refeição; não passar de 14 dias sem reavaliação

Criança: Suspensão BD (acima de 2 meses): 25/3,6 a 45/6,4 mg/kg/dia de 12/12 h; infecções graves até 70/10 mg/kg/dia

Dose máxima: Criança: 70/10 mg/kg/dia (BD). Insuficiência renal grave (TFG abaixo de 30 mL/min): comprimido 875 mg não recomendado

Contraindicações: Alergia a betalactâmicos; icterícia ou disfunção hepática prévia associada ao produto ou a penicilinas

Interações: Varfarina e acenocumarol (sangramento), metotrexato, micofenolato, alopurinol, probenecida, dissulfiram; anticoncepcional oral citado na bula

Gestação e lactação: Evitar na gestação, sobretudo no 1º trimestre, salvo indicação médica. Lactação: pode ser usada (bula)

Conservação: Comprimido BD: 15 a 30 °C; após abrir o envelope, usar em 14 dias. Suspensão reconstituída: geladeira (2 a 8 °C) por 7 dias, depois descartar

No balcão: Tomar no começo da refeição para reduzir enjoo e diarreia. A suspensão escurece fora da geladeira; frasco com mais de 7 dias deve ser descartado.

Fonte: Bulas do Clavulin® e do Clavulin® BD (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Anlodipino (Norvasc®). Bloqueador dos canais de cálcio (di-hidropiridínico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg e 10 mg (besilato de anlodipino)

Indicações: Hipertensão; angina estável e vasoespástica

Adulto: 5 mg 1 vez ao dia; pode subir para 10 mg 1 vez ao dia. Idoso e renal: dose habitual

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia a di-hidropiridínicos ou a componente da fórmula

Interações: Sinvastatina: o anlodipino aumenta a exposição, rever a dose da estatina. Cetoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir: mais efeito. Rifampicina e erva-de-são-joão: menos efeito. Toranja: não recomendada

Gestação e lactação: Segurança na gestação e na amamentação não estabelecida; só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Tomar 1 vez ao dia, com ou sem comida. Inchaço (edema), em geral nas pernas, é efeito comum e deve ser relatado ao médico, sem suspender por conta própria

Fonte: Bula de Norvasc® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Apixabana (Eliquis®). Anticoagulante oral inibidor direto do fator Xa. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 2,5 mg e 5 mg

Indicações: Prevenção de AVC na fibrilação atrial não valvar; tratamento e prevenção de recorrência de TVP e embolia pulmonar; prevenção de TEV após artroplastia de quadril ou joelho

Adulto: Fibrilação atrial: 5 mg 2 vezes ao dia; 2,5 mg 2 vezes ao dia se 2 destes: 80 anos ou mais, peso até 60 kg, creatinina a partir de 1,5 mg/dL. TVP/TEP: 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, depois 5 mg 2 vezes ao dia

Dose máxima: 20 mg/dia só na fase inicial de TVP/TEP; depois 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; sangramento clinicamente relevante; doença hepática com coagulopatia. Não recomendada com depuração de creatinina abaixo de 15 mL/min ou diálise

Interações: Cetoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, ritonavir: não recomendado. Rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, erva-de-são-joão: menos efeito. AAS, AINE e outros anticoagulantes: sangramento

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação. Na amamentação, o médico decide entre suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar de 12 em 12 horas, com ou sem comida; esqueceu, toma assim que lembrar e segue o horário. Não usar anti-inflamatório por conta própria. Suspensão antes de cirurgia só com orientação médica

Fonte: Bula de Eliquis® (Pfizer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Atenolol (Atenol®). Betabloqueador cardiosseletivo (beta-1). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; angina; arritmias; prevenção após infarto

Adulto: Hipertensão: 50 a 100 mg 1 vez ao dia (efeito pleno em 1 a 2 semanas). Angina: 100 mg 1 vez ao dia ou 50 mg 2 vezes ao dia. Insuficiência renal: reduzir (depuração 15 a 35 mL/min: 50 mg/dia; abaixo de 15: 25 mg/dia)

Dose máxima: 100 mg/dia (sem benefício adicional acima disso na angina)

Contraindicações: Bradicardia; bloqueio AV de 2º ou 3º grau; doença do nó sinusal; choque cardiogênico; hipotensão; insuficiência cardíaca descompensada; doença arterial periférica grave; feocromocitoma não tratado; acidose metabólica

Interações: Verapamil e diltiazem: bradicardia e hipotensão. Clonidina: rebote ao suspender (o betabloqueador sai antes). Amiodarona e digoxina: condução lenta. AINE (ibuprofeno): menos efeito. Adrenalina: efeito contrário

Gestação e lactação: Usar na gestação e na amamentação só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Não interromper de repente: a suspensão brusca pode piorar angina. O comprimido de 25 mg não deve ser partido. Diabético deve saber que o remédio pode mascarar sinais de hipoglicemia

Fonte: Bula de Atenol® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 17/04/2024

Atorvastatina (Lípitor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg

Indicações: Hipercolesterolemia e dislipidemia mista; prevenção de eventos cardiovasculares

Adulto: 10 a 80 mg 1 vez ao dia, a qualquer hora, com ou sem alimento. Reavaliar lipídeos 2 a 4 semanas após ajuste

Criança: A partir de 10 anos (comprimidos de 10 mg e 20 mg), conforme a bula do produto

Dose máxima: 80 mg/dia; 10 mg/dia se usado com ciclosporina, telaprevir, tipranavir/ritonavir ou glecaprevir/pibrentasvir

Contraindicações: Doença hepática ativa ou transaminases persistentemente acima de 3 vezes o normal; gestação, amamentação e mulher fértil sem contracepção; menor de 10 anos

Interações: Ciclosporina, claritromicina, inibidores de protease, itraconazol e genfibrozila: risco de miopatia. Álcool em excesso: risco hepático

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Pode ser tomada em qualquer horário, sempre o mesmo. Dor muscular inexplicada, sobretudo com febre ou mal-estar, deve ser comunicada ao médico

Fonte: Bula de Lípitor® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Azitromicina (Zitromax® (referência); Azi® suspensão (similar equivalente)). Macrolídeo (azalida). *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (2 ou 3); pó para suspensão oral 200 mg/5 mL (frascos de 600, 900 e 1.500 mg)

Indicações: Infecções respiratórias, otite, pele e partes moles; uretrite e cervicite por clamídia; cancro mole

Adulto: 500 mg 1 vez ao dia por 3 dias (total 1,5 g); clamídia, cancro mole e gonococo sensível: 1 g em dose única

Criança: 10 mg/kg 1 vez ao dia por 3 dias (total 30 mg/kg); comprimido só acima de 45 kg

Dose máxima: 500 mg/dia nos esquemas de 3 dias; total de 1.500 mg por tratamento em crianças

Contraindicações: Alergia a azitromicina, eritromicina, outros macrolídeos ou cetolídeos

Interações: Não tomar junto com antiácidos nem com derivados do ergô; monitorar digoxina, colchicina, varfarina e ciclosporina; cautela com outros fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Só com orientação médica; há dados limitados de maior risco de aborto no início da gestação. Lactação: só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade. Suspensão reconstituída (Azi®): temperatura ambiente por até 5 dias; outras marcas: conforme a bula

No balcão: Uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, com ou sem alimento. Separar de antiácido. O efeito continua dias depois da última dose: não repetir a caixa por conta própria.

Fonte: Bula do Zitromax® (Pfizer Brasil) e do Azi® suspensão (EMS Sigma Pharma), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Bisacodil (Dulcolax® (referência)). Laxante estimulante. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 mg

Indicações: Constipação intestinal; preparo para exames

Adulto: 5 a 10 mg à noite

Criança: Acima de 10 anos: 5 a 10 mg; 4 a 10 anos: 5 mg

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Íleo, obstrução, abdome agudo, dor abdominal grave com vômitos, desidratação intensa; intolerância a galactose ou frutose

Interações: Leite, antiácidos e IBP dissolvem o revestimento; diuréticos e corticoides (perda de potássio)

Gestação e lactação: Só com recomendação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Engolir inteiro à noite, longe de leite, antiácido e omeprazol. Uso diário prolongado: médico.

Fonte: Bula do Dulcolax® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Bromoprida (Digesan® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 10 mg; gotas pediátricas 4 mg/mL (24 gotas/mL)

Indicações: Náusea, vômito, refluxo e distúrbios de motilidade

Adulto: 10 mg a cada 8 ou 12 h

Criança: A partir de 1 ano: 1 a 2 gotas/kg 3 vezes ao dia

Dose máxima: 60 mg/dia

Contraindicações: Hemorragia, obstrução ou perfuração digestiva; epilepsia; fármacos extrapiramidais; feocromocitoma

Interações: Anticolinérgicos e opioides (antagonizam); sedativos e álcool

Gestação e lactação: Sem estudos adequados; só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Mesmo cuidado da metoclopramida com movimentos involuntários. Na doença renal, começar com metade da dose.

Fonte: Bula do Digesan® (Eurofarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Budesonida + formoterol (Symbicort® (referência)). Corticoide inalatório + beta-2 agonista de longa ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Spray (aerossol) 6/100 e 6/200 mcg por inalação, 120 doses; pó inalante (Turbuhaler) conforme a bula do produto

Indicações: Asma e DPOC (6/200)

Adulto: Asma: 2 inalações 1 ou 2 vezes ao dia; DPOC: 2 inalações (6/200) 2 vezes ao dia

Criança: Spray 6/100 de 6 a 11 anos: 2 inalações 2 vezes ao dia

Dose máxima: Asma no adulto: até 4 inalações 2 vezes ao dia por tempo limitado; DPOC e criança: 4 inalações/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Betabloqueadores; inibidores de CYP3A4 (cetoconazol, suco de grapefruit); antiarrítmicos; tricíclicos; IMAO

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, bocal para baixo; usar até 3 meses após abrir o invólucro

No balcão: Enxaguar a boca após o uso (candidíase oral). Uso diário de manutenção: não parar quando melhorar.

Fonte: Bula do Symbicort® Spray (AstraZeneca), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Butilbrometo de escopolamina (Buscopan® (referência)). Antiespasmódico antimuscarínico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Drágea 10 mg; gotas 10 mg/mL (20 gotas/mL)

Indicações: Cólica abdominal, intestinal, biliar e urinária

Adulto: 10 a 20 mg 3 a 5 vezes ao dia

Criança: Lactente: 5 mg (10 gotas) 3 vezes ao dia; 1 a 6 anos: 0,3 a 0,5 mg/kg/dose 3 vezes ao dia; drágea acima de 6 anos

Dose máxima: 100 mg/dia no adulto

Contraindicações: Miastenia gravis; obstrução ou estenose intestinal; íleo; megacólon; criança com diarreia; idoso sensível a antimuscarínicos

Interações: Tricíclicos, anti-histamínicos, antipsicóticos e outros anticolinérgicos; metoclopramida; beta-agonistas (taquicardia)

Gestação e lactação: Evitar na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Dor abdominal persistente, febre ou vômitos: médico. Não usar de forma contínua sem investigar a causa.

Fonte: Bula do Buscopan® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Captopril (Capoten®). Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; disfunção ventricular após infarto; nefropatia diabética

Adulto: Hipertensão: 25 mg 2 vezes ao dia ou 50 mg 1 vez ao dia; pode subir para 50 mg 2 vezes ao dia. Na hipertensão a dose costuma não passar de 150 mg/dia. Tomar 1 hora antes das refeições

Dose máxima: 450 mg/dia (teto da bula)

Contraindicações: Alergia ao captopril ou a outro IECA

Interações: Suplemento de potássio, sal light, diurético poupador de potássio: hipercalemia. AINE (inclusive AAS): menos efeito e risco renal em idosos desidratados. Lítio: toxicidade

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação (lesão e morte fetal); suspender assim que a gravidez for detectada. Na amamentação, suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade. Leve cheiro de enxofre é normal

No balcão: Tomar com o estômago vazio, 1 hora antes das refeições. Tosse seca e inchaço no rosto devem ser comunicados ao médico; inchaço na garganta é urgência

Fonte: Bula de Capoten® (Bristol-Myers Squibb), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Carbamazepina (Tegretol®, Tegretol® CR). Anticonvulsivante (bloqueador de canais de sódio). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos 200 mg e 400 mg; liberação prolongada (CR) 200 mg e 400 mg; suspensão oral 20 mg/mL, frasco 100 mL

Indicações: Epilepsia; neuralgia do trigêmeo e glossofaríngea; mania e prevenção no transtorno bipolar

Adulto: Epilepsia: 100 a 200 mg 1 a 2 vezes ao dia, subindo até 800 a 1.200 mg/dia em 2 a 3 tomadas. Neuralgia do trigêmeo: 200 a 400 mg/dia, até a dor ceder (usual 200 mg 3 a 4 vezes ao dia). Bipolar: 400 a 600 mg/dia

Criança: Início 100 a 200 mg/dia (base 10 a 20 mg/kg/dia), manutenção 400 a 600 mg/dia; adolescente 600 a 1.000 mg/dia. Suspensão contraindicada abaixo de 4 semanas de vida

Dose máxima: Epilepsia: 1.600 a 2.000 mg/dia em alguns casos; neuralgia: 1.200 mg/dia

Contraindicações: Alergia; doença cardíaca grave (bloqueio AV); doença grave do sangue prévia; porfiria hepática; uso de IMAO

Interações: Indutor enzimático: reduz anticoncepcional hormonal (usar método não hormonal), varfarina e muitos outros. Claritromicina, fluconazol e toranja: mais carbamazepina. Álcool: evitar

Gestação e lactação: Risco de malformação; não suspender por conta própria, planejar com o médico. Avaliar com o médico na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C. Comprimido CR partido ao meio vale 7 dias

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias; anticonvulsivante pode ser prescrito para até 6 meses. Tomar durante ou após as refeições. Febre, dor de garganta, manchas ou bolhas na pele exigem procurar o médico logo

Fonte: Bula de Tegretol® (Novartis), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 30/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Carvedilol (Cardilol®). Betabloqueador não seletivo com bloqueio alfa-1. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg

Indicações: Hipertensão; angina; insuficiência cardíaca crônica

Adulto: Hipertensão: 12,5 mg 1 vez ao dia por 2 dias, depois 25 mg 1 vez ao dia; até 50 mg/dia. Insuficiência cardíaca: 3,125 mg 2 vezes ao dia por 2 semanas, dobrando a cada 2 semanas até a dose tolerada

Dose máxima: Hipertensão 50 mg/dia; angina 100 mg/dia; insuficiência cardíaca 25 mg 2 vezes ao dia (50 mg 2 vezes ao dia se acima de 85 kg)

Contraindicações: Insuficiência cardíaca descompensada com inotrópico venoso; insuficiência hepática; asma ou DPOC com broncoespasmo; bloqueio AV de 2º ou 3º grau sem marca-passo; frequência abaixo de 50 bpm; doença do nó sinusal; choque; pressão sistólica abaixo de 85 mmHg

Interações: Digoxina e ciclosporina: níveis aumentados. Amiodarona, fluoxetina e paroxetina: mais carvedilol. Rifampicina: menos efeito. Verapamil e diltiazem: bradicardia. Insulina e antidiabéticos: mascara hipoglicemia

Gestação e lactação: Na gestação só se o benefício justificar. Amamentação não recomendada

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Na insuficiência cardíaca a dose sobe devagar; piora do inchaço ou falta de ar deve ser comunicada ao médico. Não parar de repente

Fonte: Bula de Cardilol® (Libbs), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Cefadroxila (Cefamox® (referência)). Cefalosporina de 1ª geração. *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 500 mg (8); pó para suspensão oral 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções de pele e partes moles, faringoamigdalite estreptocócica, infecções urinárias

Adulto: 1 a 2 g/dia divididos de 12/12 h; em algumas infecções, 1 a 2 g em dose única diária

Criança: 25 a 50 mg/kg/dia divididos de 12/12 h

Dose máxima: 2 g/dia (adulto). Insuficiência renal: 1 g de ataque e 500 mg em intervalo de 12 a 36 h conforme a depuração

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; cautela em alérgicos à penicilina e em história de colite. Suspensão contém açúcar

Interações: A bula não destaca interação medicamentosa específica; desaconselha álcool durante o tratamento

Gestação e lactação: Só se claramente necessário, com orientação médica. Lactação: passa ao leite; usar com cautela

Conservação: 15 a 30 °C, local seco. Suspensão reconstituída: 10 dias em temperatura ambiente ou 14 dias na geladeira (2 a 8 °C); pode amarelar sem perder qualidade

No balcão: Pode ser tomada com alimento para reduzir enjoo. Agitar a suspensão antes de cada dose e usar o dosador da embalagem.

Fonte: Bula do Cefamox® (Bristol-Myers Squibb Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de maio 2024); IN 360/2025, art. 1º

Cefalexina (Keflex® (referência)). Cefalosporina de 1ª geração. *Retenção de receita*

Apresentações: Drágea 500 mg e 1 g; pó para suspensão gotas 100 mg/mL (15 ou 30 mL); suspensão oral pronta 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções de pele e partes moles, faringite estreptocócica, cistite, infecções respiratórias, otite, ósseas

Adulto: Usual 250 mg de 6/6 h; faixa de 1 a 4 g/dia. Faringite, pele e cistite (acima de 15 anos): 500 mg a 1 g de 12/12 h; cistite por 7 a 14 dias

Criança: 25 a 50 mg/kg/dia em doses divididas (de 12/12 h em faringite, pele e ITU leve); otite: 75 a 100 mg/kg/dia em 4 doses

Dose máxima: 4 g/dia por via oral; acima disso, a bula orienta cefalosporina injetável

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; cautela em alérgicos à penicilina. Gotas: contém tartrazina; gotas e suspensão: contêm açúcar

Interações: Probenecida (aumenta níveis); metformina (interação descrita na bula); falso positivo de glicosúria com Benedict ou Fehling

Gestação e lactação: Categoria B: só com orientação médica. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, ao abrigo da luz. Gotas após o preparo: geladeira (2 a 8 °C) por até 14 dias. Suspensão pronta: temperatura ambiente, frasco bem tampado

No balcão: Pode ser tomada com ou sem alimento. Confirmar o horário de 6/6 h ou 12/12 h da receita; não espaçar por conta própria.

Fonte: Bula do Keflex® (Laboratórios Bagó do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de jan. 2026); IN 360/2025, art. 1º

Cefuroxima (Zinnat® (referência)). Cefalosporina de 2ª geração (axetilcefuroxima). *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 mg (10 ou 14) e 500 mg (10, 14 ou 20); pó para suspensão 250 mg/5 mL (50 ou 70 mL)

Indicações: Amigdalite, faringite, sinusite, otite, pneumonia, exacerbação de DPOC, ITU, pielonefrite, pele e partes moles

Adulto: 250 mg de 12/12 h após as refeições; pneumonia: 500 mg de 12/12 h; ITU: 125 mg de 12/12 h. Duração usual de 7 dias

Criança: Suspensão (acima de 3 meses): 10 mg/kg de 12/12 h, máximo 500 mg/dia; comprimido (2 anos ou mais) em otite e pneumonia: 15 mg/kg de 12/12 h

Dose máxima: Adulto: 1 g/dia nas indicações da bula. Criança: 500 mg/dia nas indicações citadas

Contraindicações: Alergia a cefalosporinas; alergia grave (anafilaxia) a qualquer betalactâmico

Interações: Antiácidos e redutores de acidez diminuem a absorção; probenecida não recomendada; anticoagulante oral (INR pode subir); anticoncepcional citado na bula

Gestação e lactação: Dados limitados; só se o benefício superar o risco. Lactação: pequena passagem ao leite; observar diarreia no bebê

Conservação: 15 a 30 °C. Suspensão reconstituída: refrigerar logo após o preparo (2 a 8 °C) por até 10 dias; não congelar

No balcão: Tomar após a refeição, que melhora a absorção. Não partir nem triturar o comprimido; criança que não engole deve usar a suspensão.

Fonte: Bula do Zinnat® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (cefuroxima e axetilcefuroxima)

Cetirizina (Zyrtec® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; solução oral 1 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica e urticária

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 6 anos: 2,5 mg 2 vezes ao dia; 6 a 12 anos: 5 mg 2 vezes ao dia

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia a cetirizina, hidroxizina ou piperazínicos; insuficiência renal grave

Interações: Álcool e depressores do SNC (sonolência adicional)

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode dar sonolência maior que a loratadina. Ajuste na doença renal. Levocetirizina e cetirizina são produtos diferentes no balcão.

Fonte: Bula do Zyrtec® (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cetoconazol (tópico) (Nizoral® creme (referência)). Antifúngico imidazólico tópico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Creme 20 mg/g, bisnaga 30 g; xampu 20 mg/mL. Comprimido: venda sob prescrição

Indicações: Micoses de pele (tinhas, candidíase cutânea, pitiríase versicolor); xampu na dermatite seborreica

Adulto: Creme 1 vez ao dia, por cerca de 4 semanas e alguns dias após sumirem as lesões

Criança: Uso adulto e pediátrico pela bula do creme

Dose máxima: Não se aplica (uso tópico)

Contraindicações: Alergia ao cetoconazol ou excipientes

Interações: Sem interações descritas para o creme

Gestação e lactação: Sem riscos conhecidos no uso tópico; informar o médico

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Lavar e secar bem a pele, aplicar na lesão e ao redor, lavar as mãos. Toalha e roupas separadas.

Fonte: Bula do Nizoral® creme (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cetoprofeno (Profenid® (referência)). AINE (derivado do ácido propiônico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 50 mg; comprimido entérico 100 mg; comprimido retard 200 mg; gotas 20 mg/mL; injetável 100 mg/2 mL

Indicações: Dor e inflamação musculoesquelética e reumática

Adulto: Cápsula: 100 mg 2 vezes ao dia ou 50 mg 3 vezes ao dia; entérico: 200 mg/dia em 2 tomadas; durante ou após refeições

Criança: Gotas a partir de 1 ano: conforme a bula do produto

Dose máxima: 300 mg/dia

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera péptica ou sangramento; insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave; após 6 meses de gestação

Interações: Outros AINE, salicilatos em dose alta, álcool, anticoagulantes, antiagregantes

Gestação e lactação: Não usar após o 6º mês; evitar antes sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Engolir sem mastigar, com meio a um copo de líquido, junto da refeição. Retard e entérico não podem ser partidos.

Fonte: Bula do Profenid® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Cianocobalamina (Injetáveis de 1.000 e 5.000 mcg; associações orais e injetáveis com B1 e B6). Vitamina B12. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução injetável 1.000 mcg e 5.000 mcg (IM); oral isolada pouco disponível, em geral associada a B1 e B6

Indicações: Deficiência de vitamina B12 (anemia megaloblástica, anemia perniciosa, má absorção, dieta vegana, pós-bariátrica)

Adulto: Ataque sem sintoma neurológico: 1.000 mcg IM 3 vezes por semana por 2 semanas, ou 1.000 mcg/dia por via oral. Manutenção: 1.000 mcg IM ao mês ou 1.000 mcg/dia oral (TelessaúdeRS)

Criança: Não há formulação IM autorizada para crianças no Brasil; tratamento oral conforme orientação especializada

Dose máxima: Não fixada; a apresentação de 5.000 mcg IM pode substituir a de 1.000 mcg sem risco de superdose (TelessaúdeRS)

Contraindicações: Alergia a cobalaminas; demais conforme a bula do produto

Interações: Metformina, IBP, antagonistas H2 e anticonvulsivantes são causas de deficiência por uso prolongado; investigar B12 antes de iniciar folato isolado

Gestação e lactação: Deficiência na gestação deve ser tratada logo; via IM preferida (TelessaúdeRS)

Conservação: Conforme a bula do produto

No balcão: Aplicação IM por profissional, em local autorizado. Quem usa metformina ou omeprazol há anos e tem formigamento ou cansaço deve ser encaminhado para dosar B12.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS. Como deve ser feita a reposição de vitamina B12? (atualizado em 2023). Bula de referência brasileira não consultada

---

Ciclobenzaprina (Miosan® (referência)). Relaxante muscular de ação central. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 e 10 mg

Indicações: Espasmo muscular associado a dor aguda musculoesquelética

Adulto: 20 a 40 mg/dia em 2 a 4 tomadas (a cada 12 ou 6 h)

Criança: Uso adulto

Dose máxima: 60 mg/dia; mais de 2 a 3 semanas só com acompanhamento médico

Contraindicações: Glaucoma, retenção urinária, pós-infarto, arritmia, bloqueio de condução, insuficiência cardíaca, hipertireoidismo; IMAO há menos de 14 dias

Interações: Álcool e depressores do SNC; IMAO; ISRS, tricíclicos, tramadol, bupropiona (síndrome serotoninérgica); anticolinérgicos

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação; amamentação só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Causa sonolência e boca seca: evitar álcool e direção. Não partir nem mastigar o comprimido de 10 mg.

Fonte: Bula do Miosan® (Apsen), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Ciprofloxacino (Cipro® (referência)). Fluoroquinolona. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (6 ou 14); genéricos com 250 e 750 mg conforme o fabricante

Indicações: Infecções urinárias, respiratórias (conforme o microrganismo), gonorreia, diarreia bacteriana, osteoarticulares, intra-abdominais

Adulto: 250 a 750 mg de 12/12 h conforme a indicação; cistite não complicada: 250 mg 1 a 2 vezes ao dia; diarreia: 500 mg 1 a 2 vezes ao dia

Criança: Uso restrito na bula (fibrose cística dos 5 aos 17 anos, antraz); não é antibiótico de rotina em pediatria

Dose máxima: 1,5 g/dia (750 mg de 12/12 h)

Contraindicações: Alergia a quinolonas; uso com tizanidina

Interações: Antiácidos, ferro, cálcio, magnésio, zinco e sucralfato: tomar 1 a 2 h antes ou 4 h depois; não tomar só com leite, iogurte ou suco enriquecido com cálcio; teofilina; varfarina; fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Não recomendado na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não tomar com leite, iogurte ou suplemento de cálcio e ferro no mesmo horário. Dor ou inchaço em tendão (calcanhar): parar e procurar o médico.

Fonte: Bula do Cipro® (Bayer S.A.), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Claritromicina (Klaricid® e Klaricid® UD (referência)). Macrolídeo. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 e 500 mg; comprimido de liberação prolongada (UD) 500 mg; grânulos para suspensão 25 mg/mL e 50 mg/mL (60 mL)

Indicações: Infecções respiratórias, de pele e partes moles; erradicação do H. pylori em esquema combinado; micobactérias atípicas

Adulto: Liberação imediata: 250 a 500 mg de 12/12 h. Liberação prolongada: 500 mg 1 vez ao dia com alimento; graves, 1 g 1 vez ao dia

Criança: 6 meses a 12 anos: 7,5 mg/kg de 12/12 h por 5 a 10 dias

Dose máxima: 1 g/dia (500 mg de 12/12 h). Criança: 500 mg por dose

Contraindicações: Alergia a macrolídeos; QT longo ou arritmia ventricular; hipocalemia ou hipomagnesemia; insuficiência hepática grave com renal; menores de 6 meses. UD: contraindicada com depuração de creatinina abaixo de 30 mL/min

Interações: Contraindicada com sinvastatina, lovastatina, colchicina, ergotamina, midazolam oral, cisaprida, pimozida, ticagrelor, ranolazina e lomitapida; muitas outras por inibição do CYP3A4

Gestação e lactação: Usar só se o benefício justificar, com orientação médica. Lactação: passa ao leite em pequena quantidade; segurança não estabelecida

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz. Suspensão reconstituída: temperatura ambiente, sem geladeira, por até 14 dias

No balcão: Perguntar sempre por estatina, colchicina e remédios do coração antes de dispensar. Gosto amargo na boca é comum; a suspensão não vai à geladeira.

Fonte: Bulas do Klaricid® suspensão (Abbott Brasil) e de claritromicina comprimido, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2022 e abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Clonazepam (Rivotril®). Benzodiazepínico. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 0,5 mg e 2 mg; comprimidos sublinguais 0,25 mg; solução oral 2,5 mg/mL, frasco 20 mL (1 gota = 0,1 mg)

Indicações: Epilepsia; transtorno do pânico; ansiedade; fobia social; adjuvante em transtornos do humor; outros usos da bula

Adulto: Pânico: 0,5 mg/dia em 2 tomadas, ajustada pelo médico. Ansiedade em geral: 0,5 a 1,5 mg/dia em 3 tomadas. Epilepsia: início até 1,5 mg/dia em 3 tomadas

Criança: Epilepsia até 10 anos ou 30 kg: 0,01 a 0,03 mg/kg/dia, até 0,05 mg/kg/dia, em 2 a 3 tomadas. 10 a 16 anos: início 1 a 1,5 mg/dia; usual 3 a 6 mg/dia

Dose máxima: Epilepsia: 20 mg/dia

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínico; insuficiência respiratória grave; insuficiência hepática grave; glaucoma agudo de ângulo fechado; pânico com apneia do sono

Interações: Álcool, opioides, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes e hipnóticos: sedação e depressão respiratória. Toranja: mais efeito

Gestação e lactação: Só com indicação absoluta; altas doses no fim da gestação afetam o recém-nascido. Suspender a amamentação se o uso for necessário

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C; solução oral protegida do calor

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita; até 60 dias de tratamento por notificação. Não beber álcool nem dirigir se sonolento. Não parar de repente: a retirada é gradual com o médico

Fonte: Bula de Rivotril® (Roche, registro Blanver), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Clopidogrel (Plavix®). Antiagregante plaquetário (inibidor do receptor P2Y12). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 75 mg

Indicações: Prevenção de eventos aterotrombóticos após infarto, AVC isquêmico ou doença arterial periférica; síndrome coronariana aguda (com AAS); fibrilação atrial em casos selecionados (com AAS)

Adulto: 75 mg 1 vez ao dia. Síndrome coronariana aguda sem supra de ST: ataque de 300 mg e depois 75 mg/dia, junto com AAS

Contraindicações: Alergia ao fármaco; úlcera péptica ou sangramento ativo; hemorragia intracraniana

Interações: Omeprazol e esomeprazol: reduzem a ativação do clopidogrel (desaconselhado; a bula sugere pantoprazol). Varfarina, AAS, AINE e heparinas: sangramento

Gestação e lactação: Na gestação só se claramente necessário. Na amamentação, o médico decide entre suspender o remédio ou a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Não suspender sem falar com o cardiologista, principalmente quem tem stent. Cliente que pede omeprazol junto deve ser orientado a conversar com o médico

Fonte: Bula de Plavix® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Clortalidona (Higroton®). Diurético tiazídico-símile. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 12,5 mg, 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; edema; prevenção de cálculo de oxalato de cálcio com hipercalciúria

Adulto: Hipertensão: 12,5 a 25 mg 1 vez ao dia (faixa usual 12,5 a 50 mg); efeito máximo em 3 a 4 semanas. Insuficiência cardíaca: 25 a 50 mg/dia, até 200 mg/dia

Dose máxima: Hipertensão: 50 mg/dia; insuficiência cardíaca: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia à clortalidona ou a sulfonamidas; anúria; doença hepática grave; gota; potássio ou sódio muito baixos; cálcio alto; gestante hipertensa

Interações: Lítio: toxicidade. Corticoides e anfotericina: hipocalemia. AINE e salicilatos: menos efeito. Outros anti-hipertensivos: efeito somado. Digitálicos: arritmia se o potássio cair

Gestação e lactação: Não usar na gestação nem na amamentação (passa ao leite)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar de manhã, junto de uma refeição. Dieta com frutas e verduras ajuda a repor potássio; restrição rigorosa de sal não é aconselhada pela bula

Fonte: Bula de Higroton® (Novartis), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Clotrimazol (vaginal) (Gino-Canesten® (referência)). Antifúngico imidazólico vaginal. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido e cápsula vaginal 500 mg; creme vaginal 10 mg/g (50 mg/5 g) e 20 mg/g (100 mg/5 g)

Indicações: Candidíase vulvovaginal

Adulto: 500 mg dose única à noite; creme 1%: 6 noites; creme 2%: 3 noites

Criança: Uso adulto

Dose máxima: Dose única (500 mg)

Contraindicações: Alergia ao clotrimazol ou ao álcool cetoestearílico (creme)

Interações: Tacrolimo e sirolimo (aumento de nível)

Gestação e lactação: Só com prescrição; na gestação, inserir sem aplicador

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido protegido da umidade

No balcão: Aplicar deitada, ao deitar. Primeiro episódio, gestante, menor de idade ou sinais de outra infecção: médico.

Fonte: Bula do Gino-Canesten® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Colchicina (Colchis® (Apsen)). Antigotoso (alcaloide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,5 mg (20 ou 30) e 1 mg (30)

Indicações: Crise aguda de gota e prevenção de crises; doença de Peyronie

Adulto: Prevenção: 0,5 mg 1 a 3 vezes ao dia. Crise, pela bula: 0,5 a 1,5 mg e depois 0,5 mg a cada 1 a 2 h até alívio, total habitual até 4 mg. Diretriz EULAR 2016 prefere dose baixa: 1 mg e 0,5 mg após 1 h no 1º dia

Dose máxima: Bula: abaixo de 7 mg/dia; margem de segurança estreita, reduzir ao surgir diarreia, náusea ou vômito

Contraindicações: Alergia; doença gastrointestinal, hepática, renal ou cardíaca grave; gestação

Interações: Claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, ciclosporina, verapamil, diltiazem e suco de toranja (toxicidade fatal relatada); estatinas (rabdomiólise)

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Diarreia é o primeiro sinal de excesso: parar e avisar o médico. Perguntar por antibiótico macrolídeo ou antifúngico em uso antes de dispensar.

Fonte: Bula do Colchis® (Apsen Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); EULAR, recomendações para gota, 2016

Colecalciferol (vitamina D) (Depura® (Sanofi Medley), Addera D3® (Cosmed)). Vitamina D3. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula, comprimido ou orodispersível de 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 e 50.000 UI conforme a marca; gotas em outros registros

Indicações: Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina D; adjuvante em osteoporose, osteomalácia e raquitismo

Adulto: Manutenção (Depura®): 1.000 a 2.000 UI/dia ou 7.000 a 14.000 UI/semana. Ataque: 7.000 UI/dia ou 50.000 UI/semana por 6 a 8 semanas

Dose máxima: Não há teto único na bula; faixa terapêutica de 1.000 a 50.000 UI conforme o esquema e o nível sérico

Contraindicações: Hipervitaminose D; hipercalcemia ou hiperfosfatemia; condições que levam à hipercalcemia (sarcoidose, mieloma, hiperparatireoidismo primário)

Interações: Tiazídicos (hipercalcemia); fenitoína, barbitúricos e rifampicina reduzem o efeito; corticoides; colestiramina; antiácidos com magnésio

Gestação e lactação: Pode ser usado na deficiência, sem exceder a dose diária recomendada; na lactação, sob supervisão médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Conferir se a dose é diária ou semanal: troca de 50.000 UI por dia causa intoxicação. Tomar perto de uma refeição. Produtos de baixa dose podem ter outro enquadramento: ver a embalagem.

Fonte: Bulas do Depura® (Sanofi Medley) e do Addera D3® comprimido (Cosmed), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de abr. 2025)

Dapagliflozina (Forxiga®). Inibidor do SGLT2. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 5 mg e 10 mg

Indicações: Diabetes tipo 2; insuficiência cardíaca; doença renal crônica

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia, a qualquer hora, com ou sem alimento, em todas as indicações

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco. Não iniciar com TFGe abaixo de 25 mL/min/1,73 m² (efeito glicêmico menor abaixo de 45)

Interações: Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia (o médico pode reduzir a dose). Diuréticos: desidratação. Lítio: nível de lítio pode cair

Gestação e lactação: Não usar no 2º e 3º trimestres; não usar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Beber água e manter higiene íntima: o remédio aumenta glicose na urina e o risco de infecção genital. Mal-estar, vômitos e respiração rápida pedem avaliação médica (cetoacidose, mesmo com glicemia pouco alta)

Fonte: Bula de Forxiga® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Desloratadina (Desalex® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 5 mg; xarope 0,5 mg/mL. Consta da lista de isentos, mas o Desalex® consultado traz venda sob prescrição: vale a frase da embalagem

Indicações: Rinite alérgica e urticária

Adulto: A partir de 12 anos: 5 mg 1 vez ao dia

Criança: 6 a 11 meses: 1 mg; 1 a 5 anos: 1,25 mg; 6 a 11 anos: 2,5 mg; 1 vez ao dia

Dose máxima: 5 mg/dia; dose maior não aumenta o efeito e pode dar sonolência

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Sem interações relevantes descritas; não potencializa o álcool

Gestação e lactação: Só com orientação médica; não recomendada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido protegido da umidade

No balcão: Pode ser tomada com ou sem alimento. Não aumentar a dose por conta própria.

Fonte: Bula do Desalex® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 285/2024 com redação da IN 404/2025 (LMIP)

Desogestrel (Cerazette® (referência)). Contraceptivo oral só de progestágeno. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 75 mcg (28 ou 84)

Indicações: Contracepção, inclusive na amamentação e para quem não pode usar estrogênio

Adulto: 1 comprimido ao dia, no mesmo horário, sem pausa entre cartelas; iniciar no 1º dia da menstruação

Dose máxima: 1 comprimido ao dia

Contraindicações: Trombose atual; doença hepática grave sem normalização; câncer sensível a esteroides sexuais (ex.: mama); sangramento vaginal sem diagnóstico; alergia

Interações: Anticonvulsivantes indutores (carbamazepina, fenitoína, topiramato, fenobarbital), rifampicina, antirretrovirais, erva-de-são-joão, carvão ativado: usar método de barreira

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação. Pode ser usado na amamentação (não altera a produção nem a qualidade do leite)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Atraso de até 12 h mantém a proteção. Sangramento irregular é comum e não é motivo para parar por conta própria.

Fonte: Bula do Cerazette® (Organon Farmacêutica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Dexametasona (Decadron® (referência)). Corticoide sistêmico de longa ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,5, 0,75 e 4 mg; elixir 0,5 mg/5 mL

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, endócrinas e outras, conforme prescrição

Adulto: 0,75 a 15 mg/dia, conforme a doença

Criança: Doses reduzidas, guiadas pela gravidade da doença

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; alergia a sulfitos ou componentes; vacinas de vírus vivo

Interações: Fenitoína, fenobarbital, rifampicina, efedrina (reduzem efeito); AAS (cautela)

Gestação e lactação: Só com orientação médica; dose alta: não amamentar

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Comprimido de 0,5 mg e de 4 mg são parecidos no nome: conferir a concentração. Retirada gradual após uso prolongado.

Fonte: Bula do Decadron® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dexclorfeniramina (Polaramine® (referência)). Anti-histamínico H1 de primeira geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg; drágea de liberação repetida; gotas e solução oral

Indicações: Alergias de pele e respiratórias

Adulto: 2 mg 3 a 4 vezes ao dia (gotas: 20 gotas 3 a 4 vezes)

Criança: 6 a 12 anos: 10 gotas 3 vezes ao dia (máx. 6 mg/dia); 2 a 6 anos: 5 gotas 3 vezes ao dia (máx. 3 mg/dia); abaixo de 2 anos contraindicado

Dose máxima: 12 mg/dia no adulto (120 gotas)

Contraindicações: Prematuro e recém-nascido; menor de 2 anos (líquidos) e de 12 anos (comprimido); uso de IMAO

Interações: IMAO; álcool e depressores do SNC; outros anticolinérgicos

Gestação e lactação: Segurança não comprovada; cautela na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Dá sonolência e boca seca: evitar dirigir e álcool. Evitar em idoso.

Fonte: Bula do Polaramine® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Diazepam (Valium®). Benzodiazepínico de ação longa. *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos 5 mg e 10 mg; outras formas conforme o fabricante

Indicações: Ansiedade; adjuvante em espasmo muscular e abstinência alcoólica; outros usos da bula

Adulto: 5 a 10 mg para iniciar; 5 a 20 mg/dia conforme a gravidade. Cada dose em geral não passa de 10 mg. Idoso: doses menores

Dose máxima: 10 mg por tomada (em geral)

Contraindicações: Alergia a benzodiazepínico; glaucoma de ângulo agudo; insuficiência respiratória ou hepática grave; apneia do sono; cautela na miastenia gravis. Não usar sozinho para depressão

Interações: Álcool, opioides e outros depressores: sedação e depressão respiratória. Antifúngicos azólicos, alguns antibióticos, cimetidina e omeprazol: mais efeito. Toranja

Gestação e lactação: Só sob orientação médica. Passa ao leite: sonolência e dificuldade de sucção no bebê

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Notificação de Receita B (azul) com receita. A bula limita o tratamento a 2 a 3 meses, incluindo a retirada. Idoso tem mais risco de queda

Fonte: Bula de Valium® (Roche, registro Belfar), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Diclofenaco (Cataflam® (potássico) e Voltaren® (sódico)). AINE (derivado do ácido fenilacético). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Drágea e comprimido dispersível 50 mg (potássico); comprimido 50 mg e liberação prolongada 75 e 100 mg (sódico); gotas 15 mg/mL. Gel tópico é MIP

Indicações: Dor e inflamação, dismenorreia, crise de gota, doenças reumáticas

Adulto: 100 a 150 mg/dia divididos em 2 ou 3 tomadas; casos leves 75 a 100 mg/dia

Criança: Gotas a partir de 1 ano: 1 a 4 gotas/kg/dia em 2 ou 3 tomadas; comprimidos a partir de 14 anos

Dose máxima: 150 mg/dia (dismenorreia: até 200 mg/dia por indicação médica); gotas: até 300 gotas/dia

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave; 3º trimestre

Interações: Lítio, ISRS, digoxina, diuréticos, IECA, betabloqueadores, outros AINE, corticoide, anticoagulantes

Gestação e lactação: Contraindicado nos 3 últimos meses; evitar no restante sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Drágea e comprimido de preferência antes das refeições, conforme a bula; o dispersível é dissolvido em água. Não associar a ibuprofeno ou nimesulida.

Fonte: Bulas do Cataflam®, Cataflam® gotas e Voltaren® (Novartis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dimenidrinato (Dramin® (referência)). Anti-histamínico antiemético (cinetose). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula mole 25 e 50 mg; com piridoxina (Dramin B6®) conforme a bula do produto

Indicações: Prevenção e tratamento de náusea, vômito e tontura, inclusive cinetose

Adulto: Acima de 12 anos: 50 a 100 mg a cada 4 a 6 h; viagem: 30 minutos antes

Criança: 6 a 12 anos: 25 a 50 mg a cada 6 a 8 h

Dose máxima: 400 mg/dia no adulto; 150 mg/dia de 6 a 12 anos

Contraindicações: Menor de 6 anos; porfiria; alergia aos componentes

Interações: Álcool, sedativos, tranquilizantes, IMAO; pode mascarar ototoxicidade

Gestação e lactação: Informar o médico; avaliar na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Dá sonolência: não dirigir. Para cinetose sem prescrição, a lista de isentos tem meclozina 50 mg.

Fonte: Bula do Dramin® Capsgel (Cosmed), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Dipirona (Novalgina® (referência)). Analgésico e antitérmico (pirazolona). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg e 1 g; efervescente 1 g; gotas 500 mg/mL (20 gotas/mL); solução oral 50 mg/mL

Indicações: Dor e febre

Adulto: Acima de 15 anos: 500 a 1000 mg (20 a 40 gotas) até 4 vezes ao dia

Criança: Gotas por faixa de peso: 5 a 8 kg, 2 a 5 gotas; 9 a 15 kg, 3 a 10 gotas; 16 a 23 kg, 5 a 15 gotas; até 4 vezes ao dia

Dose máxima: 4 g/dia no adulto; na criança, o teto da faixa de peso da bula

Contraindicações: Menor de 3 meses ou 5 kg; alergia a pirazolonas; agranulocitose prévia; doença de medula óssea; porfiria; deficiência de G6PD; gestação e amamentação (bula)

Interações: Reduz níveis de bupropiona, metadona, ciclosporina, tacrolimo, sertralina e valproato (indução enzimática)

Gestação e lactação: A bula do Novalgina® lista gravidez e amamentação entre as contraindicações

Conservação: 15 a 30 °C; comprimido simples protegido da luz e umidade

No balcão: Febre com dor de garganta ou feridas na boca durante o uso: suspender e procurar atendimento (risco de agranulocitose). Cuidado com queda de pressão.

Fonte: Bulas do Novalgina® comprimido e solução oral (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Domperidona (Motilium® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico periférico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; suspensão oral 1 mg/mL

Indicações: Dispepsia, náusea e vômito

Adulto: 10 mg 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições

Criança: Só a partir de 35 kg (comprimido); suspensão acima de 12 anos ou 35 kg

Dose máxima: 40 mg/dia; náusea aguda por até 1 semana

Contraindicações: Prolactinoma; doença hepática; dor de estômago intensa ou fezes escuras; uso de inibidores fortes de CYP3A4 que prolongam QT

Interações: Cetoconazol, itraconazol, eritromicina, claritromicina, amiodarona, ritonavir (arritmia)

Gestação e lactação: Só se justificado, com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Conferir antifúngico ou macrolídeo em uso: risco de arritmia. Palpitação ou desmaio: procurar atendimento.

Fonte: Bula do Motilium® (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Doxiciclina (Vibramicina® (referência)). Tetraciclina. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido solúvel 100 mg (20); comprimido revestido 100 mg (15)

Indicações: Infecções respiratórias, urogenitais (clamídia), acne, doenças por riquétsias, leptospirose, entre outras

Adulto: 200 mg no 1º dia (dose única ou 100 mg de 12/12 h), depois 100 mg/dia; infecções graves: 200 mg/dia todo o tratamento

Criança: Acima de 8 anos e até 45 kg: 4,4 mg/kg no 1º dia, depois 2,2 mg/kg/dia; acima de 45 kg, dose de adulto

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia a tetraciclinas; gestantes e lactantes; menores de 8 anos

Interações: Antiácidos, cálcio, magnésio, ferro e bismuto reduzem a absorção; varfarina (sangramento); álcool, carbamazepina, fenitoína e barbitúricos reduzem o efeito; evitar com penicilina

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Tomar com bastante água e não tomar antes de deitar (risco de ferida no esôfago). Evitar sol forte e usar protetor solar. Separar de leite e suplemento mineral.

Fonte: Bula da Vibramicina® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Empagliflozina (Jardiance®). Inibidor do SGLT2. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg e 25 mg

Indicações: Diabetes tipo 2; insuficiência cardíaca

Adulto: Diabetes: 10 mg 1 vez ao dia, até 25 mg. Insuficiência cardíaca: 10 mg 1 vez ao dia. Com ou sem alimento

Dose máxima: 25 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco. Não recomendada no diabetes com TFG abaixo de 30, na insuficiência cardíaca com TFG abaixo de 20 mL/min/1,73 m², abaixo de 18 anos ou a partir de 85 anos

Interações: Diuréticos tiazídicos e de alça: desidratação e hipotensão. Sulfonilureias e insulina: hipoglicemia. Lítio: nível pode cair

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação salvo necessidade clara; suspender a amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Hidratar-se bem e cuidar da higiene íntima. Tontura ao levantar, sobretudo em quem usa diurético, deve ser relatada ao médico

Fonte: Bula de Jardiance® (Boehringer Ingelheim), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Enalapril (Renitec®). Inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg, 10 mg e 20 mg (maleato de enalapril)

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; disfunção ventricular esquerda

Adulto: Hipertensão: 10 a 20 mg 1 vez ao dia; manutenção usual 20 mg/dia. Insuficiência cardíaca: começa com 2,5 mg/dia e sobe aos poucos até 20 mg/dia em 1 ou 2 tomadas

Dose máxima: 40 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; angioedema prévio com IECA, hereditário ou sem causa; uso com alisquireno em diabéticos; uso com sacubitril/valsartana (intervalo de 36 horas)

Interações: Suplemento de potássio, sal light, diurético poupador de potássio: hipercalemia. AINE: menos efeito e piora renal. Lítio: toxicidade. Sacubitril, vildagliptina, sirolimo, everolimo: angioedema. Antidiabéticos: hipoglicemia

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação (lesão e morte fetal no 2º e 3º trimestres). Passa ao leite em quantidade muito pequena; decisão médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade; tirar do blíster só na hora de tomar

No balcão: A tosse seca persistente é efeito conhecido da classe e deve ser relatada ao médico. Inchaço de lábios, língua ou garganta exige atendimento de urgência. Cuidado com tontura na primeira dose

Fonte: Bula de Renitec® (Organon), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Escitalopram (Lexapro®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 15 mg e 20 mg; solução oral (gotas) 20 mg/mL, frasco 15 mL (1 gota = 1 mg)

Indicações: Depressão; transtorno do pânico; ansiedade generalizada; fobia social; transtorno obsessivo-compulsivo

Adulto: Depressão: 10 mg 1 vez ao dia, até 20 mg. Pânico: 5 mg/dia na 1ª semana, depois 10 mg, até 20 mg

Dose máxima: 20 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO, selegilina, moclobemida ou linezolida; prolongamento do QT ou arritmia; uso de medicamentos que alteram o ritmo cardíaco

Interações: IMAO: esperar 14 dias após IMAO não seletivo e 7 dias após o escitalopram. Fármacos que prolongam o QT: contraindicado. Lítio, tramadol e triptanos: síndrome serotoninérgica. AAS, AINE e varfarina: sangramento

Gestação e lactação: Só após discussão de riscos com o médico; sintomas no recém-nascido se usado no 3º trimestre. Evitar na amamentação salvo indicação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C. Gotas: proteger do calor e da umidade; usar em até 8 semanas após aberto

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Gotas: diluir em água ou suco de laranja ou maçã e tomar na hora. Não suspender de repente

Fonte: Bula de Lexapro® (Lundbeck), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Espironolactona (Aldactone®). Diurético poupador de potássio (antagonista da aldosterona). *Venda sob*

prescrição

Apresentações: Comprimidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; insuficiência cardíaca; edema da cirrose e da síndrome nefrótica; hiperaldosteronismo primário; hipocalemia por diurético

Adulto: Hipertensão: 50 a 100 mg/dia, até 200 mg/dia em casos resistentes. Insuficiência cardíaca: usual 100 mg/dia (faixa 25 a 200 mg). Cirrose: 100 a 400 mg/dia conforme sódio e potássio urinários

Criança: Edema: início com cerca de 3,3 mg/kg/dia em doses divididas

Dose máxima: 400 mg/dia (cirrose e teste diagnóstico)

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência renal aguda ou significativa; anúria; hiperpotassemia; doença de Addison; uso com eplerenona

Interações: IECA, BRA, suplemento de potássio, sal light: hipercalemia. AINE e AAS: menos efeito diurético. Digoxina: meia-vida maior. Outros anti-hipertensivos: efeito somado

Gestação e lactação: Avisar o médico se engravidar. Na amamentação, se o uso for essencial, a bula indica alimentação alternativa para o bebê

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Evitar suplemento de potássio e sal light sem orientação. Aumento ou dor nas mamas pode ocorrer e deve ser relatado ao médico

Fonte: Bula de Aldactone® (Pfizer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Fexofenadina (Allegra® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 60, 120 e 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica e urticária crônica

Adulto: Rinite: 60 mg 2 vezes ao dia, 120 mg ou 180 mg 1 vez ao dia; urticária: 60 mg 2 vezes ao dia ou 180 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 11 anos: 30 mg (5 mL) 2 vezes ao dia; urticária a partir de 6 meses conforme a bula

Dose máxima: 180 mg/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes; comprimido abaixo de 12 anos

Interações: Antiácido com alumínio e magnésio: esperar 2 h; suco de frutas reduz a absorção

Gestação e lactação: Sem estudos; só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C; suspensão válida por 12 meses após aberta

No balcão: Tomar com água, longe de suco de frutas e de antiácido.

Fonte: Bula do Allegra® (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Finasterida (Proscar® (referência, 5 mg)). Inibidor da 5-alfa-redutase. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido 5 mg; genéricos de 1 mg para alopecia androgenética masculina

Indicações: Hiperplasia prostática benigna (5 mg); alopecia androgenética masculina (1 mg)

Adulto: HPB: 5 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento, por tempo prolongado. Alopecia: 1 mg 1 vez ao dia, conforme a bula do produto

Dose máxima: 5 mg/dia (HPB)

Contraindicações: Mulheres e crianças; alergia a componente da fórmula

Interações: Sem interação relevante descrita; reduz o PSA, o que deve ser informado ao médico que pedir o exame

Gestação e lactação: Contraindicada para mulheres. Gestantes não devem manusear comprimido quebrado ou esfarelado (risco ao feto masculino)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Efeito leva meses; não interromper por conta própria. Avisar o médico do uso antes de dosar PSA. Mulher grávida não deve tocar em comprimido partido.

Fonte: Bulas do Proscar® (Merck Sharp & Dohme) e de finasterida genérico, reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2023 e 2020)

Fluconazol (Zoltec® (referência)). Antifúngico triazólico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 100 mg (8) e 150 mg (1 ou 2); solução para infusão 2 mg/mL (uso hospitalar)

Indicações: Candidíase vaginal e balanite, candidíase orofaríngea, dermatomicoses, onicomicose, infecções fúngicas sistêmicas

Adulto: Candidíase vaginal: 150 mg dose única; recorrente: 150 mg 1 vez ao mês por 4 a 12 meses. Dermatomicoses: 150 mg 1 vez por semana por 2 a 4 semanas. Orofaríngea: 50 a 100 mg/dia por 7 a 14 dias

Criança: Infecções graves: 6 mg/kg no 1º dia, depois 3 a 6 mg/kg/dia; demais indicações conforme a bula

Dose máxima: Nas infecções graves, 400 mg/dia (bula); doses maiores só sob indicação médica

Contraindicações: Alergia a azólicos; uso com terfenadina, cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida e quinidina

Interações: Varfarina (sangramento), benzodiazepínicos, ciclosporina, tacrolimo, celecoxibe, amiodarona e outros fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Evitar na gestação, salvo infecção grave; contracepção durante o uso e por cerca de 1 semana após. Lactação: só com orientação médica; amamentação não recomendada após doses repetidas ou altas

Conservação: Cápsulas: 15 a 30 °C, protegidas da luz e da umidade

No balcão: Na candidíase vaginal, a cápsula única basta; sintomas podem levar alguns dias para sumir. Episódios repetidos ou gestante: encaminhar ao médico.

Fonte: Bula do Zoltec® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da lista da IN 360/2025

Fluoxetina (Prozac®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Cápsulas 20 mg; outras formas (comprimido, solução oral) conforme o fabricante

Indicações: Depressão; bulimia nervosa; transtorno obsessivo-compulsivo; transtorno disfórico pré-menstrual

Adulto: Depressão: 20 mg/dia. TOC: 20 a 60 mg/dia. Bulimia: 60 mg/dia. Disfórico pré-menstrual: 20 mg/dia contínuo ou na fase lútea

Dose máxima: Doses acima de 80 mg/dia não foram avaliadas sistematicamente

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO (esperar 14 dias após o IMAO; e 5 semanas após a fluoxetina para iniciar IMAO ou tioridazina)

Interações: IMAO e tioridazina: graves. Inibe o CYP2D6: tricíclicos, metoprolol, carvedilol, alguns antipsicóticos em nível maior. Varfarina, AAS e AINE: sangramento. Tramadol e triptanos: síndrome serotoninérgica

Gestação e lactação: Só se o benefício justificar; sintomas no recém-nascido se usada no fim da gestação. Passa ao leite; cautela

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Tomar de manhã se causar insônia. Como fica muito tempo no corpo, interações podem ocorrer semanas depois de parar

Fonte: Bula de Prozac® (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Fosfomicina trometamol (Monuril® (referência)). Derivado do ácido fosfônico. *Retenção de receita*

Apresentações: Envelope com 8 g de granulado contendo 5,631 g de fosfomicina trometamol (dose de 3 g de fosfomicina); caixa com 1 ou 2

Indicações: Cistite aguda e recorrente, bacteriúria assintomática na gestação, profilaxia de ITU em procedimentos urológicos

Adulto: 1 envelope em dose única, dissolvido em 50 a 75 mL de água, em jejum, à noite após urinar; Pseudomonas, Proteus e Enterobacter: 2 envelopes com 24 h de intervalo

Dose máxima: 2 envelopes por tratamento, com intervalo de 24 h (bula)

Contraindicações: Alergia; insuficiência renal grave (depuração abaixo de 10 mL/min) e hemodiálise; crianças sem orientação médica

Interações: Metoclopramida e outros aceleradores do trânsito intestinal reduzem níveis; alimento retarda a absorção; antibióticos em geral podem alterar o INR de quem usa varfarina

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação com prescrição. Lactação: dose única é aceitável segundo a bula

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade. Tomar logo após dissolver; não guardar a solução

No balcão: Esvaziar a bexiga antes e tomar de estômago vazio, à noite. Os sintomas costumam ceder em 2 a 3 dias; se não melhorar, voltar ao médico.

Fonte: Bula do Monuril® (Zambon Laboratórios Farmacêuticos), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Furosemida (Lasix®). Diurético de alça. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 40 mg; solução injetável 10 mg/mL (ampola 2 mL)

Indicações: Edema de origem cardíaca, renal ou hepática; hipertensão leve a moderada

Adulto: Oral: início 20 a 80 mg/dia; manutenção 20 a 40 mg/dia, de preferência em uma tomada, em jejum

Criança: Oral: 2 mg/kg/dia, no máximo 40 mg/dia

Dose máxima: Adulto: depende da resposta (não fixada na bula). Criança: 40 mg/dia

Contraindicações: Anúria; pré-coma ou coma hepático; hipocalemia ou hiponatremia graves; desidratação ou hipovolemia; alergia a furosemida ou sulfonamidas; lactação

Interações: Aminoglicosídeos, cisplatina: ototoxicidade. Lítio: toxicidade. Digoxina: arritmia por hipocalemia. AINE: menos efeito e risco renal. Outros anti-hipertensivos: hipotensão

Gestação e lactação: Só se estritamente indicada e por curto período. Passa ao leite e inibe a lactação; contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz, na embalagem original

No balcão: O efeito diurético é rápido: tomar em horário que não atrapalhe a rotina, em geral pela manhã. Tontura, cãibra e sede intensa devem ser relatadas ao médico

Fonte: Bula de Lasix® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Glibenclamida (Daonil®). Sulfonilureia. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 5 mg

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: Início ½ a 1 comprimido (2,5 a 5 mg) 1 vez ao dia antes do café da manhã; aumentos de no máximo 2,5 mg a cada 1 a 2 semanas. Usual 5 a 10 mg/dia; acima de 10 mg, dividir antes do jantar

Dose máxima: 15 mg/dia recomendados (até 20 mg/dia só em casos excepcionais); dose única máxima de 10 mg

Contraindicações: Diabetes tipo 1 ou cetoacidose; pré-coma ou coma diabético; disfunção renal ou hepática grave; alergia a glibenclamida; gestação e amamentação; uso com bosentana; criança

Interações: Bosentana: contraindicada (lesão hepática). Insulina e outros antidiabéticos, inibidores do CYP2C9 (fluconazol): hipoglicemia. Álcool: hipoglicemia imprevisível. Betabloqueador: mascara os sinais

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação; trocar por insulina

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz

No balcão: Nunca pular refeição depois de tomar. Ensinar os sinais de hipoglicemia (suor frio, tremor, confusão) e a corrigir com açúcar. Idoso e quem come pouco têm mais risco

Fonte: Bula de Daonil® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Gliclazida (Diamicron® MR). Sulfonilureia de liberação modificada. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de liberação prolongada 30 mg e 60 mg (60 mg é sulcado)

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: 30 a 120 mg em dose única no café da manhã, sempre seguida de refeição

Dose máxima: 120 mg/dia

Contraindicações: Alergia a gliclazida, sulfonilureias ou sulfamidas; diabetes tipo 1; cetoacidose, pré-coma ou coma; doença renal ou hepática grave; uso de antifúngico (miconazol); amamentação; menor de 18 anos

Interações: Miconazol e fluconazol, claritromicina, sulfonamidas, IECA, betabloqueadores, álcool, outros antidiabéticos: hipoglicemia. Corticoides, clorpromazina e salbutamol: hiperglicemia

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação; contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Engolir inteiro (o de 60 mg pode ser partido ao meio no sulco, sem mastigar). Tomar no café da manhã e não pular refeições. Miconazol, inclusive gel oral, exige falar com o médico

Fonte: Bula de Diamicron® MR (Servier), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Hidroclorotiazida (Clorana®). Diurético tiazídico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 25 mg e 50 mg

Indicações: Hipertensão; edema de origem cardíaca, hepática ou renal

Adulto: Hipertensão: a bula indica início com 50 a 100 mg/dia pela manhã, ajustado à menor dose eficaz (há comprimido de 25 mg). Edema: 50 a 100 mg 1 ou 2 vezes ao dia; manutenção 25 a 200 mg/dia ou em dias alternados

Criança: Até 2 anos: 12,5 a 25 mg/dia; 2 a 12 anos: 25 a 100 mg/dia; base usual 2 a 3 mg/kg/dia, sempre em 2 tomadas

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência renal grave (depuração abaixo de 30 mL/min) ou anúria; doença hepática grave; distúrbio grave de eletrólitos; icterícia em criança

Interações: Lítio: toxicidade. Digoxina e antiarrítmicos: a hipocalemia aumenta o risco de arritmia. Antidiabéticos e insulina: piora da glicemia. AINE: menos efeito. Álcool e sedativos: hipotensão postural

Gestação e lactação: Evitar na gestação, sobretudo para edema ou hipertensão gestacional. Passa ao leite e pode reduzir a produção; não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar pela manhã para não levantar à noite para urinar. Cãibra, fraqueza e tontura ao levantar devem ser relatadas ao médico

Fonte: Bula de Clorana® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 01/04/2026

Ibuprofeno (Advil® e Alivium®). AINE (derivado do ácido propiônico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Cápsula 400 mg (MIP); suspensão 30 mg/mL; gotas 50 e 100 mg/mL (MIP); gotas 200 mg/mL do Alivium®: venda sob prescrição na bula

Indicações: Dor, febre, cólica menstrual

Adulto: 400 mg a cada 4 a 6 h, durante ou após refeições

Criança: A partir de 6 meses: dose por peso da tabela da bula, a cada 6 a 8 h, até 4 vezes ao dia (suspensão 30 mg/mL: até 7 mL por dose)

Dose máxima: 1200 mg/dia sem prescrição (Advil®)

Contraindicações: Alergia a AAS ou AINE; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; 3º trimestre de gestação

Interações: Anticoagulantes, outros AINE, AAS, corticoide, IECA, BRA, diuréticos, lítio, metotrexato

Gestação e lactação: Contraindicado no 3º trimestre; evitar no restante da gestação e na amamentação sem orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Não indicar na suspeita de dengue. Não usar para dor por mais de 10 dias nem para febre por mais de 3 dias sem médico.

Fonte: Bulas do Advil® 400 mg (PF Consumer Healthcare) e do Alivium® (Cosmed/Brainfarma), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Insulina humana NPH (Humulin® N, Novolin® N). Insulina de ação intermediária (isofana). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Suspensão injetável 100 UI/mL: frasco-ampola 10 mL; refil 3 mL para caneta

Indicações: Diabetes que requer insulina

Adulto: Dose individual em UI, definida pelo médico conforme glicemia; via subcutânea

Criança: Dose individual em UI (Humulin® N: uso acima de 3 anos)

Contraindicações: Hipoglicemia; alergia à insulina humana ou a componente. Não usar em bomba de infusão

Interações: Aumentam a necessidade: corticoides, tiazídicos, anticoncepcionais, hormônio tireoidiano. Reduzem: outros antidiabéticos, salicilatos, IMAO, IECA, BRA. Betabloqueadores mascaram a hipoglicemia. Álcool: hipoglicemia

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação e na amamentação com ajuste de dose pelo médico

Conservação: Fechada: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar, protegida da luz. Em uso: abaixo de 30 °C, longe de calor e luz, por até 28 dias (Humulin®) ou até 4 semanas entre 15 e 30 °C (Novolin®); refil em uso não volta à geladeira. Congelada: descartar

No balcão: Homogeneizar antes de aplicar rolando entre as mãos e invertendo, sem agitar com força, até ficar uniformemente leitosa. Fazer rodízio dos locais e não reutilizar agulha. Anotar a data de abertura

Fonte: Bula de Humulin® N (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025; Bula de Novolin® N (Novo Nordisk), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Insulina humana regular (Humulin® R, Novolin® R). Insulina de ação rápida (regular). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução injetável 100 UI/mL: frasco-ampola 10 mL; refil 3 mL para caneta

Indicações: Diabetes que requer insulina; controle da glicemia nas refeições e em situações agudas

Adulto: Dose individual em UI, definida pelo médico; via subcutânea antes das refeições conforme prescrição. Via venosa ou muscular só por profissional de saúde

Criança: Dose individual em UI (Humulin® R: uso acima de 3 anos)

Contraindicações: Hipoglicemia; alergia à insulina humana ou a componente

Interações: Iguais às da NPH: corticoides, tiazídicos e anticoncepcionais aumentam a necessidade; salicilatos, IMAO, IECA e outros antidiabéticos reduzem; betabloqueador mascara hipoglicemia; álcool

Gestação e lactação: Pode ser usada na gestação e na amamentação com ajuste de dose pelo médico

Conservação: Fechada: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar, protegida da luz. Em uso: abaixo de 30 °C, longe de calor e luz, por até 28 dias (Humulin® R); refil em uso não volta à geladeira

No balcão: Solução deve estar límpida e incolor; turva ou com partículas, não usar. Aplicar no horário prescrito em relação à refeição e não deixar de comer depois

Fonte: Bula de Humulin® R (Eli Lilly), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Ivermectina (Revectina® (referência)). Antiparasitário (avermectina). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 6 mg (2 ou 4)

Indicações: Estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose, pediculose, oncocercose

Adulto: Cerca de 200 mcg/kg em dose única (oncocercose: 150 mcg/kg), com água; por faixa de peso: 51 a 65 kg, 2 comprimidos; 66 a 79 kg, 2 e meio

Criança: A partir de 15 kg e 5 anos: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1; 36 a 50 kg, 1 e meio

Dose máxima: Dose única de cerca de 200 mcg/kg; repetição só por avaliação médica

Contraindicações: Alergia; meningite ou outras doenças do SNC; menores de 5 anos ou abaixo de 15 kg; uso com barbitúricos, benzodiazepínicos, ácido valproico e oxibato de sódio não recomendado

Interações: Depressores do SNC (benzodiazepínicos, álcool); varfarina (INR pode subir)

Gestação e lactação: Categoria C: só com orientação médica. Lactação: passa em baixa concentração; só se indicado

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz e da umidade

No balcão: Dose calculada pelo peso, tomada de uma vez com água. Na escabiose, a bula orienta retorno ao médico em 1 a 2 semanas para confirmar a cura.

Fonte: Bula da Revectina® (Abbott Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Lactulose (Lactulona®). Laxante osmótico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Xarope 667 mg/mL, frasco 120 mL e sachês de 15 mL

Indicações: Constipação intestinal; encefalopatia hepática (prescrição)

Adulto: Constipação: 15 a 30 mL/dia em 1 tomada

Criança: Lactente: 5 mL/dia; 1 a 5 anos: 5 a 10 mL/dia; 6 a 12 anos: 10 a 15 mL/dia

Dose máxima: Ajustar para 2 a 3 evacuações/dia; encefalopatia: até 150 mL/dia com prescrição

Contraindicações: Intolerância a lactose, galactose ou frutose; obstrução, sangramento intestinal, apendicite; preparo de colonoscopia com eletrocautério

Interações: Antibióticos podem reduzir o efeito; evitar com outros laxantes e antiácidos

Gestação e lactação: Sob orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Pode causar gases nos primeiros dias. Pode ser misturada a suco, leite ou iogurte.

Fonte: Bula da Lactulona® (Daiichi Sankyo), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Levofloxacino (Levaquin® (Janssen-Cilag)). Fluoroquinolona. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 500 mg (7 ou 10); genéricos de 250, 500 e 750 mg

Indicações: Sinusite, exacerbação de bronquite crônica, pneumonia comunitária, ITU complicada, pielonefrite, prostatite, pele e partes moles

Adulto: 500 mg 1 vez ao dia (alguns esquemas com 750 mg 1 vez ao dia), com ou sem alimento; ajustar na insuficiência renal

Criança: Não usar em crianças e adolescentes (bula)

Dose máxima: 750 mg/dia

Contraindicações: Alergia a levofloxacino ou a outras quinolonas

Interações: Antiácidos com cálcio, magnésio ou alumínio, sucralfato, ferro e polivitamínico com zinco: 2 h antes ou 2 h depois; teofilina; varfarina; fármacos que prolongam o QT

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco. Lactação: escolher entre suspender a amamentação ou o tratamento

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, longe de antiácido e de suplemento mineral. Dor em tendão, formigamento ou palpitação: suspender e procurar o médico.

Fonte: Bula do Levaquin® (Janssen-Cilag) e de levofloxacino 750 mg (genérico), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2025); IN 360/2025, art. 1º

Levonorgestrel + etinilestradiol (Nordette® (Pfizer), Microvlar® (Bayer)). Contraceptivo oral combinado. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg (150 mcg + 30 mcg), cartela de 21

Indicações: Contracepção; controle de irregularidades menstruais

Adulto: 1 comprimido ao dia, no mesmo horário, por 21 dias; pausa de 7 dias e nova cartela no 8º dia. Primeira cartela no 1º dia da menstruação

Dose máxima: 1 comprimido ao dia

Contraindicações: Gestação; trombose ou embolia atual ou prévia; AVC ou doença coronariana; trombofilias; doenças valvares e arritmias trombogênicas; fumante acima de 35 anos tem risco cardiovascular acentuado; demais condições conforme a bula

Interações: Indutores enzimáticos (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-joão) reduzem a eficácia; ombitasvir, paritaprevir e dasabuvir (hepatite C) contraindicam o uso simultâneo

Gestação e lactação: Contraindicado na gestação e durante a amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Esquecimento de até 12 h: tomar assim que lembrar e seguir no horário normal. Atraso maior: seguir a bula e usar preservativo. Dor na perna, falta de ar ou dor no peito: atendimento imediato.

Fonte: Bula do Nordette® (Pfizer Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025)

Levonorgestrel 1,5 mg (contracepção de emergência) (Postinor Uno® (Gedeon Richter)). Progestágeno (contraceptivo de emergência). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 1,5 mg (1)

Indicações: Prevenção da gravidez após relação desprotegida ou falha do método

Adulto: 1 comprimido o mais cedo possível, até 72 h após a relação; vômito em até 4 h: repetir a dose

Dose máxima: 1 comprimido de 1,5 mg ao dia, em dose única

Contraindicações: Gravidez confirmada ou suspeita; sangramento genital anormal sem causa definida; alergia; uso por homens

Interações: Indutores enzimáticos (barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, efavirenz, ritonavir) reduzem a eficácia; demais conforme a bula

Gestação e lactação: Não interrompe gravidez já implantada. Lactação: passa ao leite; bulas de genéricos recomendam suspender a amamentação temporariamente

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Quanto antes tomar, maior a eficácia. Não substitui método regular nem protege de IST. Menstruação atrasada mais de 7 dias: procurar o médico (bula).

Fonte: Bula do Postinor Uno® (Gedeon Richter do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2024); bula de levonorgestrel genérico para a lactação

---

Levotiroxina (Puran T4®; também Synthroid® e Euthyrox®). Hormônio tireoidiano (T4 sintético). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de 12,5 mcg a 300 mcg (Puran T4®: 12,5; 25; 37,5; 50; 62,5; 75; 88; 100; 112; 125; 150; 175; 200 e 300 mcg)

Indicações: Hipotireoidismo; supressão do TSH no câncer de tireoide, nódulos e bócio

Adulto: Início 50 mcg/dia (25 mcg em cardiopatas ou hipotireoidismo antigo), subindo 25 mcg a cada 2 a 3 semanas. Manutenção usual 75 a 125 mcg/dia

Criança: Recém-nascido: 5 a 6 mcg/kg/dia. Criança: em geral 3 mcg/kg/dia, guiada pelos exames

Dose máxima: Em geral até 200 mcg/dia; falta de resposta a essa dose sugere má absorção ou má adesão

Contraindicações: Infarto recente; tireotoxicose ou hipertireoidismo não tratados; insuficiência suprarrenal descompensada; alergia a componente

Interações: Antiácidos, carbonato de cálcio, sucralfato, colestiramina: reduzem a absorção (separar o horário). Varfarina: efeito maior. Antidiabéticos e insulina: pode ser preciso ajustar. Indutores enzimáticos: menos efeito

Gestação e lactação: Mantida na gestação, com acompanhamento de exames pelo médico. Compatível com a amamentação (mínima excreção no leite)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Tomar em jejum, com água, 30 minutos a 1 hora antes do café da manhã, todos os dias. Separar de cálcio, ferro e antiácidos. Não trocar de marca sem avisar o médico, porque a dose pode precisar de ajuste

Fonte: Bula de Puran T4® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 05/06/2025

Loperamida (Imosec® (referência)). Antidiarreico (opioide de ação periférica). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 2 mg

Indicações: Diarreia aguda e crônica, sem sangue e sem febre

Adulto: Aguda: 4 mg e depois 2 mg após cada evacuação líquida

Criança: Uso exclusivamente adulto; contraindicado na diarreia da criança

Dose máxima: 16 mg/dia (8 comprimidos)

Contraindicações: Criança; diarreia com sangue ou febre; constipação, distensão; colite

Interações: Ritonavir, quinidina, itraconazol, cetoconazol, genfibrozila, desmopressina oral

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Parar se as fezes ficarem sólidas ou após 24 h sem evacuar. Manter soro de reidratação oral.

Fonte: Bula do Imosec® (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Loratadina (Claritin® (referência)). Anti-histamínico H1 de segunda geração. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; xarope 1 mg/mL

Indicações: Rinite alérgica, urticária e outras alergias

Adulto: 10 mg 1 vez ao dia

Criança: 2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL (5 mg) 1 vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL (10 mg)

Dose máxima: 10 mg/dia

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Suspender 48 h antes de teste cutâneo de alergia

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Pouca sedação. Doença hepática ou renal: procurar orientação antes.

Fonte: Bula do Claritin® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Losartana (Cozaar®). Bloqueador do receptor da angiotensina II (BRA). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; hipertensão com hipertrofia ventricular esquerda; insuficiência cardíaca; nefropatia no diabetes tipo 2 com proteinúria

Adulto: Hipertensão: 50 mg 1 vez ao dia, até 100 mg 1 vez ao dia. Insuficiência cardíaca: começa com 12,5 mg 1 vez ao dia e sobe aos poucos até 50 mg/dia

Dose máxima: 100 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência hepática grave; gestação (evitar no 1º trimestre, contraindicada depois); uso com alisquireno em diabéticos ou renais

Interações: Suplemento de potássio, sal light com potássio, espironolactona, amilorida, trimetoprima: hipercalemia. AINE: menos efeito e piora renal. Lítio: toxicidade. Outros anti-hipertensivos: queda maior da pressão

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação (lesão fetal a partir do 2º trimestre). Não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz

No balcão: Tomar todo dia no mesmo horário, com ou sem comida. Evitar sal light e suplemento de potássio sem falar com o médico. Mulher que engravidar deve procurar o médico logo para trocar o remédio

Fonte: Bula de Cozaar® (Organon), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Metformina (Glifage®, Glifage® XR). Biguanida. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 500 mg, 850 mg e 1 g; liberação prolongada (XR) 500 mg, 750 mg, 850 mg e 1 g

Indicações: Diabetes tipo 2 (isolada ou associada); associada à insulina no tipo 1; pré-diabetes; síndrome dos ovários policísticos

Adulto: 500 mg 2 vezes ao dia ou 850 mg 1 vez ao dia, durante ou após as refeições, com aumento gradual. XR: 1 vez ao dia, no jantar, conforme a bula do produto

Criança: A partir de 10 anos: 500 mg ou 850 mg 1 vez ao dia, até 2.000 mg/dia

Dose máxima: 2.550 mg/dia (comprimido de 850 mg) ou 2.500 mg/dia (500 mg); criança: 2.000 mg/dia

Contraindicações: TFGe abaixo de 30 mL/min/1,73 m²; doença hepática; acidose metabólica ou cetoacidose; desidratação ou infecção grave; insuficiência cardíaca ou respiratória com hipóxia; alcoolismo; cirurgia ou contraste iodado (suspensão temporária)

Interações: Contraste iodado: suspender antes e depois do exame. Álcool: acidose láctica. Diuréticos, corticoides e salbutamol: alteram a glicemia. Cimetidina, verapamil, dolutegravir: mais metformina

Gestação e lactação: Na gestação o tratamento padrão é a insulina. Não recomendada na amamentação (uso só com avaliação médica)

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade (XR também da luz)

No balcão: Tomar com a refeição para reduzir náusea e diarreia, que costumam melhorar com o tempo. Avisar que usa metformina antes de exame com contraste. Vômito ou diarreia intensos são motivo para procurar o médico

Fonte: Bula de Glifage® (Merck), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 10/06/2025

Metoclopramida (Plasil® (referência)). Antiemético e procinético (antagonista dopaminérgico). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Solução oral 1 mg/mL; gotas 4 mg/mL (21 gotas/mL); comprimido 10 mg conforme a bula do produto; injetável (uso hospitalar)

Indicações: Náusea, vômito e distúrbios de motilidade

Adulto: 10 mg 3 vezes ao dia, 10 minutos antes das refeições (10 mL da solução ou 53 gotas)

Criança: Apresentações do Plasil® são de uso adulto

Dose máxima: Conforme a bula do produto

Contraindicações: Hemorragia, obstrução ou perfuração digestiva; epilepsia; uso de fármacos extrapiramidais; feocromocitoma

Interações: Levodopa e agonistas dopaminérgicos; álcool e depressores do SNC; neurolépticos

Gestação e lactação: Pode ser considerada se necessário, com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Movimentos involuntários de face, pescoço ou olhos: suspender e procurar atendimento. Causa sonolência.

Fonte: Bula do Plasil® (Sanofi-Aventis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Metronidazol (Flagyl® (referência)). Nitroimidazólico. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 250 mg (20) e 400 mg (24); suspensão de benzoilmetronidazol (Flagyl® Pediátrico); gel vaginal e injetável em outros registros

Indicações: Tricomoníase, vaginose bacteriana, giardíase, amebíase, infecções por anaeróbios

Adulto: Tricomoníase: 2 g dose única ou 400 mg de 12/12 h por 7 dias. Vaginose: 400 a 500 mg de 12/12 h por 7 dias. Giardíase: 250 mg de 8/8 h por 5 dias. Anaeróbios: 400 mg de 8/8 h por 7 dias

Criança: Preferir a suspensão de benzoilmetronidazol, com dose por peso conforme a bula do produto

Dose máxima: 2 g/dia (amebíase: 500 mg de 6/6 h)

Contraindicações: Alergia a metronidazol ou a outros imidazólicos

Interações: Álcool (reação tipo dissulfiram) durante e por no mínimo 1 dia após; dissulfiram; varfarina; lítio; ciclosporina; fenitoína

Gestação e lactação: Atravessa a placenta; avaliar com cuidado, só com orientação médica. Lactação: conforme a bula do produto

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Nada de bebida alcoólica no tratamento e por pelo menos 1 dia depois. Na tricomoníase, o parceiro também precisa tratar. A urina pode escurecer.

Fonte: Bula do Flagyl® comprimido (Sanofi Medley), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Miconazol (Vodol® (pele) e Daktarin® gel oral). Antifúngico imidazólico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Creme, pó e aerossol 20 mg/g; suspensão tópica 20 mg/mL. Gel oral 20 mg/g (Daktarin®): venda sob prescrição

Indicações: Micoses de pele e frieira; gel oral: candidíase oral

Adulto: Pele: 2 vezes ao dia por cerca de 2 semanas (pés: 4 semanas). Gel oral: 2,5 mL 4 vezes ao dia

Criança: Gel oral de 6 a 24 meses: 1,25 mL 4 vezes ao dia, fracionado

Dose máxima: Não se aplica (tópico); gel oral conforme a bula

Contraindicações: Alergia a imidazólicos. Gel oral: menor de 6 meses, doença hepática, uso de fármacos que prolongam QT, ergot e algumas estatinas

Interações: Varfarina (pode aumentar o efeito, inclusive no uso tópico); gel oral: sinvastatina, lovastatina, midazolam oral, cisaprida

Gestação e lactação: Tópico sem problemas descritos; gel oral com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C; pó protegido da umidade

No balcão: Gel oral em bebê: aplicar em pequenas porções, longe da garganta; nunca no mamilo. Quem usa varfarina deve avisar o médico.

Fonte: Bulas do Vodol® (União Química) e do Daktarin® gel oral (Janssen-Cilag), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Montelucaste (Singulair® (referência)). Antagonista de receptor de leucotrienos. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 10 mg; comprimido mastigável 4 e 5 mg; granulado 4 mg (Baby)

Indicações: Asma (prevenção e manutenção) e rinite alérgica

Adulto: A partir de 15 anos: 10 mg 1 vez ao dia; na asma, ao anoitecer

Criança: 6 a 14 anos: 5 mg; 2 a 5 anos: 4 mg; 6 meses a 2 anos: granulado 4 mg; 1 vez ao dia

Dose máxima: 1 dose a cada 24 h

Contraindicações: Alergia aos componentes

Interações: Sem interações relevantes descritas na bula do paciente

Gestação e lactação: Consultar o médico na gestação e na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade; granulado preparado é para uso imediato

No balcão: Não trata a crise: manter o broncodilatador de resgate. Relatar ao médico mudanças de humor, sono ou comportamento.

Fonte: Bula do Singulair® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Naproxeno (Flanax® (sódico, MIP) e Naprosyn® (prescrição)). AINE (derivado do ácido propiônico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Naproxeno sódico 275 e 550 mg (Flanax®, MIP); naproxeno 250 e 500 mg (Naprosyn®, venda sob prescrição)

Indicações: Dor, febre, cólica menstrual; com prescrição, doenças reumáticas, gota e enxaqueca

Adulto: MIP: 275 mg 1 a 2 vezes ao dia ou 550 mg 1 vez ao dia. Prescrição (Naprosyn®): 500 mg e depois 250 mg a cada 6 a 8 h

Criança: Abaixo de 12 anos só com orientação médica

Dose máxima: 550 mg/dia sem prescrição; uso por até 10 dias

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo; insuficiência cardíaca grave

Interações: Ciclosporina, lítio, metotrexato, outros AINE; pode reduzir o efeito antiplaquetário do AAS em dose baixa

Gestação e lactação: Não usar na gestação, salvo se extremamente necessário com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Meia-vida longa: não repetir antes do intervalo. Quem usa AAS infantil para o coração deve falar com o médico antes.

Fonte: Bulas do Flanax® e do Naprosyn® (Bayer), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nimesulida (Nisulid® (referência)). AINE (sulfonanilida, preferencial COX-2). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 100 mg; comprimido para suspensão 100 mg; gotas 50 mg/mL

Indicações: Dor e inflamação agudas, febre

Adulto: 50 a 100 mg 2 vezes ao dia, após refeições, pelo menor tempo possível

Criança: Todas as apresentações do referência: uso acima de 12 anos

Dose máxima: 400 mg/dia (bula: até 200 mg 2 vezes ao dia em casos excepcionais)

Contraindicações: Alergia a AINE ou AAS; reação hepática prévia; insuficiência hepática; insuficiência renal grave; úlcera ativa; amamentação

Interações: Outros AINE; fármacos hepatotóxicos; álcool; anticoagulantes

Gestação e lactação: Sem dados adequados na gestação; contraindicada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Não somar com outro anti-inflamatório. Procurar médico se surgir pele ou olhos amarelados, urina escura ou se a dor não melhorar em 5 dias.

Fonte: Bula do Nisulid® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nistatina (Micostatin® (referência)). Antifúngico poliênico. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Suspensão oral 100.000 UI/mL; creme vaginal 25.000 UI/g, 60 g com 14 aplicadores

Indicações: Candidíase oral e vaginal

Adulto: Oral: 1 a 6 mL 4 vezes ao dia, bochechar e engolir. Vaginal: 1 aplicador à noite por 14 dias

Criança: Lactente: 1 a 2 mL 4 vezes ao dia (metade em cada lado da boca); prematuro: 1 mL 4 vezes ao dia

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Alergia à nistatina; suspensão contém açúcar

Interações: Sem interações conhecidas

Gestação e lactação: Oral: segurança não estabelecida; vaginal: com orientação médica, sem pressionar o colo

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Manter 48 h após sumirem os sintomas. Creme vaginal pode danificar preservativo de látex.

Fonte: Bulas da nistatina suspensão oral (Prati-Donaduzzi, genérico) e do Micostatin® creme vaginal (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Nitazoxanida (Annita® (referência)). Antiparasitário e antiviral (tiazolida). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg (6); pó para suspensão oral 20 mg/mL (45 ou 100 mL)

Indicações: Gastroenterite por rotavírus e norovírus; helmintíases, amebíase, giardíase, criptosporidíase e outras protozooses intestinais

Adulto: Acima de 12 anos: 500 mg de 12/12 h por 3 dias, com alimento

Criança: Acima de 1 ano: 7,5 mg/kg (0,375 mL/kg da suspensão) de 12/12 h por 3 dias, com alimento

Dose máxima: 1 g/dia (500 mg de 12/12 h)

Contraindicações: Doença hepática ou renal; alergia. Suspensão: menores de 1 ano. Comprimido: menores de 12 anos

Interações: Cautela com fármacos de alta ligação proteica, como varfarina e fenitoína

Gestação e lactação: Só se o benefício justificar, com orientação médica (vale também para a lactação)

Conservação: 15 a 30 °C, local seco. Suspensão preparada: até 7 dias, frasco bem fechado

No balcão: Tomar junto com alimento, que aumenta a absorção. Agitar a suspensão e medir com a seringa; descartar a sobra após 7 dias.

Fonte: Bula do Annita® (Farmoquímica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da LMIP e da IN 360/2025

Nitrofurantoína (Macrodantina® (referência)). Nitrofurano (antisséptico urinário). *Retenção de receita*

Apresentações: Cápsula 100 mg (28, 40 ou 144)

Indicações: Infecção urinária baixa (cistite) por germes sensíveis; profilaxia de longo prazo a critério médico

Adulto: 100 mg de 6/6 h por 7 a 10 dias, com alimento; uso prolongado: 100 mg ao deitar

Dose máxima: 400 mg/dia (100 mg de 6/6 h)

Contraindicações: Alergia; anúria, oligúria ou comprometimento renal moderado a grave; gestação a termo (38 a 42 semanas); hepatopatia prévia pelo fármaco; menores de 1 mês

Interações: Antiácidos com trissilicato de magnésio (reduzem absorção); probenecida e sulfimpirazona; quinolonas urinárias; a bula orienta método de barreira com pílula anticoncepcional

Gestação e lactação: Segurança não estabelecida; contraindicada no fim da gestação. Lactação: avaliar risco e benefício

Conservação: 15 a 30 °C, protegida da luz

No balcão: Tomar com alimento para reduzir enjoo. A urina pode ficar amarelada. Tosse ou falta de ar durante o uso: avisar o médico.

Fonte: Bula da Macrodantina® (Brainfarma), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Omeprazol (Losec Mups® (referência)). Inibidor da bomba de prótons. *Isento de prescrição*

Apresentações: MIP: cápsula 20 mg, caixa de 7 ou 14, só para azia frequente (IN 404/2025). Losec Mups® 10 e 20 mg e demais indicações: venda sob prescrição

Indicações: MIP: azia e queimação 2 ou mais dias na semana. Com prescrição: úlcera, refluxo, esofagite, H. pylori

Adulto: MIP: 20 mg 1 vez ao dia em jejum por até 14 dias. Prescrição: 20 a 40 mg/dia

Criança: A partir de 1 ano, com prescrição: 10 a 20 kg, 10 mg; acima de 20 kg, 20 mg, 1 vez ao dia

Dose máxima: MIP: 20 mg/dia, 14 dias, novo ciclo só após 4 meses

Contraindicações: Alergia a omeprazol ou benzimidazóis

Interações: Clopidogrel, cetoconazol, itraconazol, varfarina, digoxina, diazepam, fenitoína, metotrexato, erva de São João

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da umidade

No balcão: MIP: em jejum, pela manhã. Engolir inteiro; se precisar dispersar, água sem gás ou suco, nunca leite. Sinal de alarme: médico.

Fonte: Bula do Losec Mups® (Biopas), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; IN 404/2025 (LMIP)

Ondansetrona (Vonau Flash® e Zofran®). Antiemético (antagonista 5-HT3). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de desintegração oral 4 e 8 mg; injetável 4 e 8 mg (uso hospitalar)

Indicações: Náusea e vômito, inclusive de quimioterapia e pós-operatório

Adulto: Conforme prescrição; quimioterapia moderada: 8 mg 2 vezes ao dia; alta: 24 mg dose única

Criança: 2 a 11 anos: 4 mg; acima de 11 anos: 4 a 8 mg

Dose máxima: Conforme a bula do produto e a indicação

Contraindicações: Uso de apomorfina; alergia aos componentes

Interações: Apomorfina (contraindicada); serotoninérgicos (síndrome serotoninérgica); reduz efeito do tramadol

Gestação e lactação: Evitar no 1º trimestre (malformação orofacial)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Colocar o comprimido na língua com as mãos secas; dissolve sem água. Vômito com desidratação: soro oral e avaliação.

Fonte: Bulas do Vonau Flash® (Biolab) e do Zofran® (Novartis), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Oseltamivir (Tamiflu® (referência)). Antiviral (inibidor da neuraminidase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Cápsula 30, 45 e 75 mg (10)

Indicações: Tratamento e profilaxia da gripe (influenza A e B)

Adulto: A partir de 13 anos: tratamento 75 mg de 12/12 h por 5 dias, iniciado nas primeiras 48 h; profilaxia: 75 mg 1 vez ao dia por 10 dias após contato

Criança: 1 a 12 anos, de 12/12 h por 5 dias: até 15 kg, 30 mg; 15 a 23 kg, 45 mg; 23 a 40 kg, 60 mg; acima de 40 kg, 75 mg (profilaxia: mesma dose 1 vez ao dia)

Dose máxima: Tratamento: 150 mg/dia (adulto)

Contraindicações: Alergia ao fosfato de oseltamivir ou a componente da fórmula

Interações: Sem interações relevantes descritas com paracetamol, AAS, antiácidos, varfarina ou anticoncepcional

Gestação e lactação: Dados observacionais indicam benefício na gestação, sem ajuste de dose; lactação: conforme avaliação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Começar o quanto antes; tomar com alimento reduz enjoo. A cápsula pode ser aberta e misturada em pouco alimento doce. Comportamento estranho em criança: avisar o médico.

Fonte: Bula do Tamiflu® (Produtos Roche), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Pantoprazol (Pantozol® (referência)). Inibidor da bomba de prótons. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de liberação retardada 20 e 40 mg; injetável 40 mg

Indicações: Refluxo, esofagite, úlcera, H. pylori (com antibióticos)

Adulto: 20 a 40 mg 1 vez ao dia; esofagite leve 4 a 8 semanas

Criança: Acima de 5 anos: 15 a 40 kg, 20 mg; acima de 40 kg, 40 mg; até 8 semanas

Dose máxima: Conforme prescrição

Contraindicações: Alergia a benzimidazóis; 20 mg: menor de 5 anos

Interações: Reduz absorção de cetoconazol; uso prolongado reduz vitamina B12

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Engolir inteiro, antes, durante ou após o café da manhã. Uso por mais de um ano: acompanhamento médico.

Fonte: Bula do Pantozol® (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Paracetamol (Tylenol® (referência)). Analgésico e antitérmico (para-aminofenol). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 e 750 mg; gotas 200 mg/mL; suspensão 100 mg/mL (bebê) e 32 mg/mL (criança)

Indicações: Dor leve a moderada e febre

Adulto: 500 a 1000 mg a cada 4 a 6 h (750 mg: 1 comprimido 3 a 5 vezes ao dia)

Criança: 10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h, até 5 doses/dia; abaixo de 11 kg ou 2 anos: médico

Dose máxima: 4000 mg/dia e no máximo 1000 mg por dose; criança até 75 mg/kg/dia

Contraindicações: Alergia ao paracetamol; cautela em hepatopatia e uso de álcool

Interações: Outros produtos com paracetamol (antigripais); varfarina; flucloxacilina

Gestação e lactação: Gestante ou lactante: consultar o médico antes do uso (bula)

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Somar todo paracetamol do dia, inclusive antigripais. Usar o dosador do próprio frasco: as concentrações pediátricas são diferentes.

Fonte: Bulas do Tylenol® Bebê e Criança (Janssen-Cilag) e do paracetamol 750 mg genérico (Sanofi Medley), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Paracetamol + codeína (Tylex® (referência)). Analgésico: para-aminofenol + opioide fraco. *Controle especial · A2 (adendo: codeína até 100 mg por unidade em Receita de Controle Especial, retida)*

Apresentações: Comprimido 500 mg + 7,5 mg ou 500 mg + 30 mg de fosfato de codeína

Indicações: Dor moderada a intensa

Adulto: 1 comprimido a cada 4 h; dor mais intensa: 2 comprimidos a cada 6 h

Criança: Contraindicado abaixo de 12 anos para dor; abaixo de 18 anos após amigdalectomia ou adenoidectomia

Dose máxima: 8 comprimidos/dia (codeína 240 mg; paracetamol 4000 mg)

Contraindicações: Alergia aos componentes; metabolizador ultrarrápido de CYP2D6; amamentação

Interações: Depressores do SNC, benzodiazepínicos, álcool, outros opioides; inibidores de CYP2D6; outros produtos com paracetamol

Gestação e lactação: Evitar na gestação salvo benefício claro; contraindicado na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Retenção da receita. Não tomar outro remédio com paracetamol. Sonolência extrema ou respiração lenta: procurar atendimento.

Fonte: Bula do Tylex® (Cellera), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Portaria SVS/MS 344/1998, lista A2 e adendos

---

Prednisolona (Predsim® e Prelone®). Corticoide sistêmico (glicocorticoide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 5, 10, 20 e 40 mg; solução oral 3 mg/mL; gotas 11 mg/mL

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, respiratórias e outras, conforme prescrição

Adulto: 5 a 60 mg/dia, conforme a doença

Criança: 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia), em 1 a 4 tomadas

Dose máxima: Conforme prescrição; a bula não fixa teto único

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; infecção não controlada; alergia aos componentes

Interações: Indutores enzimáticos; AINE; diuréticos; antidiabéticos; vacinas de vírus vivo em dose imunossupressora

Gestação e lactação: Só com orientação médica; cautela na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade

No balcão: Na solução oral, 1 mL contém 3 mg; nas gotas, 11 mg/mL. Conferir a concentração e usar a pipeta da caixa.

Fonte: Bulas do Predsim® (Cosmed/Brainfarma) e do Prelone® (Aché), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Prednisona (Meticorten® (referência)). Corticoide sistêmico (glicocorticoide). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 5 e 20 mg

Indicações: Doenças alérgicas, inflamatórias, reumáticas, respiratórias e outras, conforme prescrição

Adulto: 5 a 60 mg/dia, pela manhã, conforme a doença

Criança: 0,14 a 2 mg/kg/dia (ou 4 a 60 mg/m²/dia), conforme a doença

Dose máxima: Conforme prescrição; a bula não fixa teto único

Contraindicações: Infecção fúngica sistêmica; alergia a corticoides

Interações: Fenobarbital, fenitoína, rifampicina (reduzem efeito); AINE e álcool (úlcera); diuréticos que espoliam potássio; antidiabéticos; anticoagulantes

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz

No balcão: Tomar pela manhã, com um pouco de líquido. Uso por mais de alguns dias não pode ser parado de repente: a retirada é gradual.

Fonte: Bula do Meticorten® (Organon), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Pregabalina (Lyrica®). Anticonvulsivante análogo do GABA (ligante alfa-2-delta). *Controle especial · C1*

Apresentações: Cápsulas 25 mg, 75 mg e 150 mg

Indicações: Dor neuropática; fibromialgia; ansiedade generalizada; epilepsia (crises parciais, adjuvante)

Adulto: Início 75 mg 2 vezes ao dia; após 3 a 7 dias, 150 mg 2 vezes ao dia; aumentos conforme resposta. Insuficiência renal: reduzir (início pode ser 25 mg)

Dose máxima: 600 mg/dia (dor neuropática, ansiedade, epilepsia); 450 mg/dia (fibromialgia)

Contraindicações: Alergia ao fármaco

Interações: Opioides (oxicodona), álcool e benzodiazepínicos (lorazepam): sedação, depressão respiratória. Com opioide, constipação e obstrução intestinal

Gestação e lactação: Evitar na gestação (defeitos congênitos no 1º trimestre); mulher fértil deve usar contracepção. Não recomendada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa tontura e sonolência; cuidado ao dirigir. Para parar, reduzir em pelo menos 1 semana, com o médico

Fonte: Bula de Lyrica® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 02/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Propranolol (Genéricos e similares (bula consultada: Propranolol FURP)). Betabloqueador não seletivo. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos de cloridrato de propranolol (bula consultada: 40 mg); outras dosagens conforme o fabricante

Indicações: Hipertensão; angina; arritmias; profilaxia de enxaqueca; tremor essencial; ansiedade com sintomas físicos; tireotoxicose; cardiomiopatia hipertrófica

Adulto: Hipertensão: 80 mg 2 vezes ao dia; usual 160 a 320 mg/dia. Enxaqueca, ansiedade e tremor: 40 mg 2 a 3 vezes ao dia; usual 80 a 160 mg/dia

Criança: Arritmias e tireotoxicose: 0,25 a 0,5 mg/kg 3 a 4 vezes ao dia. Enxaqueca abaixo de 12 anos: 20 mg 2 a 3 vezes ao dia

Dose máxima: Hipertensão 640 mg/dia; angina 480 mg/dia; enxaqueca 240 mg/dia; ansiedade e tremor 160 mg/dia

Contraindicações: Asma ou broncoespasmo; bradicardia; hipotensão; bloqueio AV de 2º ou 3º grau; insuficiência cardíaca descompensada; angina de Prinzmetal; choque; doença arterial periférica grave; jejum prolongado e tendência à hipoglicemia

Interações: Insulina e antidiabéticos: mascara e prolonga a hipoglicemia. Verapamil e diltiazem: bradicardia. Clonidina: rebote. Ergotamina: vasoconstrição. AINE: menos efeito. Colírio betabloqueador: efeito somado

Gestação e lactação: Só se essencial na gestação. Passa ao leite; amamentação não recomendada pela bula

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Não suspender de repente. Asmático com chiado após começar o remédio deve procurar o médico. Pode causar mãos frias e cansaço

Fonte: Bula de Propranolol FURP (Fundação para o Remédio Popular), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Quetiapina (Seroquel®, Seroquel® XRO). Antipsicótico atípico. *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 25 mg, 100 mg e 200 mg; liberação prolongada (XRO) 50 mg, 200 mg e 300 mg

Indicações: Esquizofrenia; mania e depressão do transtorno bipolar; manutenção do bipolar; XRO também como adjuvante na depressão maior

Adulto: Esquizofrenia: 50, 100, 200 e 300 mg nos dias 1 a 4 (2 tomadas), depois 300 a 450 mg/dia (faixa 150 a 750). Depressão bipolar: 50 a 300 mg à noite em 4 dias, até 600 mg

Criança: Esquizofrenia (13 a 17 anos) e mania (10 a 17 anos): titulação de 50 até 400 mg em 5 dias; faixa 400 a 800 mg/dia (esquizofrenia) ou 400 a 600 mg/dia (mania)

Dose máxima: Esquizofrenia 750 mg/dia (adulto); mania 800 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; síndrome do QT longo ou arritmia prévia; amamentação; má absorção de glicose-galactose

Interações: Cetoconazol, macrolídeos e inibidores de protease: mais quetiapina. Carbamazepina, fenitoína, rifampicina e barbitúricos: menos efeito. Fármacos que prolongam o QT. Álcool e sedativos: sonolência

Gestação e lactação: Sintomas de abstinência no recém-nascido se usada no fim da gestação. Contraindicada na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. Causa sono e tontura ao levantar; levantar devagar. O XRO não pode ser partido nem mastigado

Fonte: Bula de Seroquel® (AstraZeneca, registro Pharlab), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 22/07/2026. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Rivaroxabana (Xarelto®). Anticoagulante oral inibidor direto do fator Xa. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 2,5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg

Indicações: Prevenção de AVC na fibrilação atrial não valvar; tratamento e prevenção de recorrência de TVP e embolia pulmonar; prevenção de TEV após artroplastia; 2,5 mg com AAS na doença coronariana ou arterial periférica

Adulto: Fibrilação atrial: 20 mg 1 vez ao dia (15 mg se a função renal estiver reduzida). TVP/TEP: 15 mg 2 vezes ao dia por 3 semanas, depois 20 mg 1 vez ao dia. 15 mg e 20 mg sempre com alimento

Dose máxima: 20 mg/dia na fibrilação atrial (30 mg/dia só nas 3 semanas iniciais de TVP/TEP)

Contraindicações: Sangramento ativo; lesão com alto risco de sangramento; uso com outro anticoagulante (exceto na troca); doença hepática com coagulopatia; gestação e amamentação

Interações: Cetoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, ritonavir, claritromicina: mais efeito. AAS, AINE, clopidogrel, ISRS e IRSN: sangramento. Rifampicina, carbamazepina, fenitoína e erva-de-são-joão podem reduzir o efeito

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, na embalagem original

No balcão: As doses de 15 mg e 20 mg precisam ser tomadas com comida, senão a absorção cai. Não usar AAS ou anti-inflamatório por conta própria. Avisar dentista e médico antes de procedimentos

Fonte: Bula de Xarelto® (Bayer), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 11/06/2025

Rosuvastatina (Crestor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 5 mg, 10 mg, 20 mg e 40 mg

Indicações: Hipercolesterolemia, dislipidemia mista, hipertrigliceridemia; redução de risco cardiovascular

Adulto: Início usual 10 mg 1 vez ao dia (5 mg em populações especiais; 20 mg em hipercolesterolemia grave). Faixa 10 a 40 mg/dia; ajustes a cada 2 a 4 semanas

Criança: Hipercolesterolemia familiar heterozigótica: 6 a 9 anos, 5 a 10 mg/dia; 10 a 17 anos, 5 a 20 mg/dia

Dose máxima: 40 mg/dia; 10 mg/dia na insuficiência renal grave

Contraindicações: Doença hepática ativa; insuficiência hepática ou renal (conforme a bula); gestação ou mulher fértil sem contracepção; amamentação

Interações: Ciclosporina: evitar. Genfibrozila, inibidores de protease (lopinavir, ritonavir), febuxostate: mais rosuvastatina. Varfarina e ticagrelor: cautela (conferir RNI)

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade

No balcão: Engolir inteiro, 1 vez ao dia, em qualquer horário fixo. Dor muscular sem causa deve ser relatada ao médico

Fonte: Bula de Crestor® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Sais para reidratação oral (Hidrafix® e envelopes de SRO). Repositor hidroeletrolítico. *Isento de prescrição*

Apresentações: Envelope de pó para diluir em 1 L (fórmula do Ministério da Saúde); solução concentrada em flaconete de 25 mL para 250 mL (Hidrafix®)

Indicações: Prevenção e tratamento da desidratação por diarreia e vômito

Adulto: Após cada evacuação, a quantidade que aceitar (Plano A); desidratação: Plano B no serviço de saúde

Criança: Após cada evacuação: menor de 1 ano, 50 a 100 mL; 1 a 10 anos, 100 a 200 mL; maior de 10 anos, o que aceitar

Dose máxima: Plano B, no serviço de saúde: 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h, como orientação inicial (cartaz do MS)

Contraindicações: Íleo paralítico, obstrução ou perfuração intestinal, vômitos muito intensos

Interações: Sem interações descritas

Gestação e lactação: Gestante: com orientação médica (bula); manter o aleitamento da criança nos intervalos

Conservação: Pó e flaconete: 15 a 30 °C; solução preparada conforme a bula do produto

No balcão: Diluir exatamente no volume indicado, com água filtrada ou fervida. Sinais de perigo: vômitos repetidos, sangue nas fezes, pouca urina, muita sede.

Fonte: Bula do Hidrafix® (Takeda), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Ministério da Saúde, cartaz Manejo do paciente com diarreia (BVS)

Salbutamol (aerossol) (Aerolin® spray (referência)). Broncodilatador beta-2 agonista de curta ação. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Aerossol 100 mcg/dose, 200 doses; também xarope 2 mg/5 mL e comprimidos 2 e 4 mg

Indicações: Alívio e prevenção do broncoespasmo na asma e na DPOC

Adulto: Crise: 100 a 200 mcg (1 a 2 jatos); antes do exercício: 200 mcg

Criança: 100 mcg (1 jato), podendo ir a 200 mcg; antes do exercício 100 mcg

Dose máxima: Até 200 mcg 4 vezes ao dia; não exceder 4 usos por dia

Contraindicações: Alergia ao salbutamol ou componentes

Interações: Betabloqueadores não seletivos (propranolol)

Gestação e lactação: Só se o benefício superar o risco; não recomendado na amamentação pela bula

Conservação: 15 a 30 °C, longe do sol e do congelamento; frasco pressurizado, não furar nem expor acima de 50 °C

No balcão: Agitar, expirar, disparar no início da inspiração e prender o ar; usar espaçador quando indicado. Precisar de mais jatos que o habitual é sinal de piora.

Fonte: Bula do Aerolin® (GlaxoSmithKline), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Semaglutida (Ozempic® (injetável); também Wegovy® e Rybelsus®). Agonista do receptor de GLP-1. *Retenção de receita*

Apresentações: Ozempic®: caneta com 1,34 mg/mL que libera doses de 0,25 mg e 0,5 mg (1,5 mL) ou de 1 mg (3 mL); outras marcas e doses conforme a bula do produto

Indicações: Ozempic®: diabetes tipo 2. Outras marcas de semaglutida têm indicações próprias, como obesidade

Adulto: Ozempic®: 0,25 mg 1 vez por semana por 4 semanas, depois 0,5 mg 1 vez por semana; pode subir para 1 mg semanal. Subcutânea, mesmo dia da semana, qualquer hora

Dose máxima: 1 mg/semana na bula consultada do Ozempic®; outras apresentações conforme a bula do produto

Contraindicações: Alergia à semaglutida ou a componente

Interações: Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia (pode ser preciso reduzir a dose). Varfarina: monitorar RNI

Gestação e lactação: Não usar na gestação; suspender pelo menos 2 meses antes de gravidez planejada. Não usar na amamentação

Conservação: Antes de abrir: geladeira, 2 a 8 °C, sem congelar. Em uso: abaixo de 30 °C ou na geladeira, tampada, por até 6 semanas. Congelada: descartar

No balcão: Receita em 2 vias, com retenção e escrituração no SNGPC; validade de 90 dias (RDC 471/2021 com redação da RDC 973/2025; IN 360/2025). Náusea é comum no início. Usar agulha nova a cada aplicação e conferir a dose no contador

Fonte: Bula de Ozempic® (Novo Nordisk), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 27/07/2026; regime de venda: RDC 471/2021 (redação da RDC 973/2025) e IN 360/2025, art. 2º

Sertralina (Zoloft®). Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS). *Controle especial · C1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 50 mg e 100 mg

Indicações: Depressão; transtorno obsessivo-compulsivo; transtorno do pânico; estresse pós-traumático; fobia social; transtorno disfórico pré-menstrual

Adulto: Dose única diária, manhã ou noite. Depressão e TOC: em geral 50 mg/dia; pânico, estresse pós-traumático e fobia social: 25 mg/dia na 1ª semana, depois 50 mg. Ajustes até 200 mg/dia

Criança: TOC: 6 a 12 anos, início 25 mg/dia; a partir de 13 anos, 50 mg/dia

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Alergia ao fármaco; uso de IMAO; uso de pimozida

Interações: IMAO, linezolida, azul de metileno: síndrome serotoninérgica (respeitar intervalo). Tramadol, triptanos e outros serotoninérgicos: mesmo risco. AAS, AINE e varfarina: sangramento

Gestação e lactação: Na gestação e na amamentação, só com orientação médica

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Receita de Controle Especial em 2 vias, retida. O efeito antidepressivo leva semanas; náusea e insônia iniciais costumam passar. Não suspender de repente

Fonte: Bula de Zoloft® (Viatris), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026)

Sildenafila (Viagra® (referência)). Inibidor da fosfodiesterase 5. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 25 mg e 100 mg (4); 50 mg (1, 2, 4 ou 8)

Indicações: Disfunção erétil

Adulto: 50 mg cerca de 1 h antes da relação; ajustar para 25 ou 100 mg conforme resposta. Ritonavir: no máximo 25 mg em 48 h. Insuficiência renal grave ou hepática, ou inibidor do CYP3A4: iniciar com 25 mg

Dose máxima: 100 mg por dia, 1 vez ao dia

Contraindicações: Uso de nitratos ou doadores de óxido nítrico em qualquer forma; riociguate; mulheres; menores de 18 anos

Interações: Nitratos (hipotensão grave); alfabloqueadores como doxazosina (hipotensão); cetoconazol, itraconazol, eritromicina, ritonavir, saquinavir e cimetidina aumentam níveis

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e da umidade

No balcão: Perguntar sempre por remédio de angina (isossorbida, nitroglicerina). Ereção persistente e dolorosa exige atendimento de urgência.

Fonte: Bula do Viagra® (Mylan/Viatris), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de jun. 2025)

Simeticona (Luftal® (referência)). Antiflatulento. *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido 40 mg; gotas 75 mg/mL

Indicações: Gases e distensão abdominal

Adulto: 40 mg 3 vezes ao dia com as refeições, ou 13 gotas 3 vezes ao dia

Criança: Lactente: 3 a 5 gotas 3 vezes ao dia; até 12 anos: 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia

Dose máxima: 500 mg/dia (12 comprimidos)

Contraindicações: Distensão ou cólica grave, dor por mais de 36 h, massa abdominal, suspeita de obstrução

Interações: Pode reduzir a absorção da levotiroxina

Gestação e lactação: Só com orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não age sobre dor de outra causa. Dor que persiste mais de 36 h: médico.

Fonte: Bula do Luftal® (Reckitt Benckiser), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026

Sinvastatina (Zocor®). Estatina (inibidor da HMG-CoA redutase). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg

Indicações: Hipercolesterolemia; redução de risco cardiovascular

Adulto: 20 a 40 mg 1 vez ao dia, à noite. A dose de 80 mg não deve ser iniciada; fica só para quem já a usa há 12 meses ou mais sem lesão muscular

Dose máxima: 40 mg/dia para quem inicia (80 mg só nos casos acima)

Contraindicações: Doença hepática ativa; gestação e amamentação; uso com itraconazol, cetoconazol, posaconazol, voriconazol, inibidores de protease do HIV, eritromicina, claritromicina, nefazodona, cobicistate, genfibrozila, ciclosporina ou danazol

Interações: Além das contraindicações: amiodarona, verapamil, diltiazem, anlodipino e fibratos aumentam o risco de miopatia. Varfarina: conferir RNI

Gestação e lactação: Contraindicada na gestação (pode causar malformação) e na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Tomar à noite. Dor ou fraqueza muscular sem explicação, com urina escura, deve ser comunicada ao médico logo. Antibiótico novo (claritromicina, eritromicina) ou antifúngico oral exige conferir interação

Fonte: Bula de Zocor® (MSD), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 21/05/2024

Sitagliptina (Januvia®). Inibidor da DPP-4 (gliptina). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Diabetes tipo 2

Adulto: 100 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento. Insuficiência renal: 50 mg/dia (moderada) ou 25 mg/dia (grave ou diálise)

Dose máxima: 100 mg/dia

Contraindicações: Alergia a qualquer componente

Interações: Poucas interações relevantes. Com sulfonilureia ou insulina, risco de hipoglicemia

Gestação e lactação: Não recomendada na gestação nem na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Dose única diária. Dor abdominal forte e persistente, com ou sem vômito, deve ser avaliada pelo médico (pancreatite é rara)

Fonte: Bula de Januvia® (MSD), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 15/04/2025

Succinato de metoprolol (Selozok®). Betabloqueador cardiosseletivo de liberação controlada. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos revestidos de liberação controlada 25 mg, 50 mg e 100 mg

Indicações: Hipertensão; angina; insuficiência cardíaca crônica; arritmias; após infarto; profilaxia de enxaqueca

Adulto: Hipertensão: 50 mg 1 vez ao dia, até 100 a 200 mg. Insuficiência cardíaca: 25 mg/dia por 2 semanas (12,5 mg em classe III a IV), dobrando a cada 2 semanas até 200 mg/dia ou a dose tolerada

Dose máxima: 200 mg/dia

Contraindicações: Bloqueio AV de 2º ou 3º grau; insuficiência cardíaca instável; bradicardia relevante; doença do nó sinusal sem marca-passo; choque cardiogênico; arteriopatia periférica grave

Interações: Verapamil e diltiazem: bradicardia. Clonidina: não suspender um dos dois sem orientação. Amiodarona, quinidina, antidepressivos (fluoxetina, paroxetina) e outros inibidores do CYP2D6: mais efeito. Álcool: mais metoprolol no sangue

Gestação e lactação: Não usar na gestação nem na lactação, salvo se essencial

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C

No balcão: Dose única diária, com ou sem comida. O comprimido pode ser partido no sulco, mas não mastigado nem triturado. Não confundir com tartarato de metoprolol, que é de liberação imediata

Fonte: Bula de Selozok® (AstraZeneca), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Sulfadiazina de prata (Dermazine® (referência)). Antimicrobiano tópico (sulfonamida). *Retenção de receita*

Apresentações: Creme 10 mg/g (1%), bisnagas de 15, 30, 50 e 100 g

Indicações: Prevenção e tratamento de infecção em queimaduras e feridas

Adulto: Camada sobre a ferida limpa, 1 vez ao dia (2 vezes se muito exsudativa), coberta com gaze, até cicatrizar

Criança: A partir de 2 meses; contraindicada em prematuro

Dose máxima: Não se aplica (tópico)

Contraindicações: Alergia a sulfas; final da gestação; prematuro e menor de 2 meses; não recomendada na amamentação

Interações: Inativa colagenase; cimetidina (leucopenia descrita)

Gestação e lactação: Contraindicada no último trimestre; não recomendada na amamentação

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz e umidade; pode escurecer sem perder segurança

No balcão: Retenção da receita (RDC 471/2021). Não aplicar perto dos olhos. Queimadura extensa, em face, mãos ou genitais: serviço de saúde.

Fonte: Bula do Dermazine® (Cristália), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; RDC 471/2021 e IN 360/2025

Sulfametoxazol + trimetoprima (Bactrim® e Bactrim® F (referência)). Sulfonamida associada a inibidor da di-hidrofolato redutase. *Retenção de receita*

Apresentações: Comprimido 400 mg + 80 mg (20) e F 800 mg + 160 mg (10); suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL (50 ou 100 mL) e F 400 mg + 80 mg/5 mL (100 mL)

Indicações: Infecções urinárias, respiratórias, gastrointestinais e de pele por germes sensíveis; esquemas especiais a critério médico

Adulto: A partir de 12 anos: 800 mg + 160 mg (1 comprimido F ou 2 simples) de 12/12 h, após refeição; tratamento prolongado: metade

Criança: 6 semanas a 5 meses: 2,5 mL da suspensão simples de 12/12 h; 6 meses a 5 anos: 5 mL; 6 a 12 anos: 10 mL (cerca de 30 mg + 6 mg/kg/dia)

Dose máxima: Casos graves: 1.200 mg + 240 mg de 12/12 h (3 comprimidos simples ou 1 e meio F)

Contraindicações: Alergia a sulfonamidas ou trimetoprima; doença hepática ou renal grave; uso com dofetilida; suspensão: prematuros e menores de 6 semanas

Interações: Varfarina, metotrexato, fenitoína, antidiabéticos orais, ciclosporina, digoxina, diuréticos, pirimetamina, amantadina, memantina

Gestação e lactação: Só com orientação médica. Lactação: passa ao leite; evitar salvo orientação médica

Conservação: 15 a 30 °C (comprimido e suspensão)

No balcão: Tomar após a refeição com bastante líquido, pela manhã e à noite. Manchas, bolhas ou feridas na boca: suspender e procurar atendimento no mesmo dia.

Fonte: Bula do Bactrim® (Farmoquímica), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Sulfato ferroso (Genéricos e similares (sem referência única)). Sal de ferro (antianêmico). *Isento de prescrição*

Apresentações: Comprimido revestido com 60 mg de ferro elementar; gotas 25 mg de ferro/mL (1 gota = 1 mg); xarope 10 mg de ferro/mL

Indicações: Prevenção e tratamento da anemia por deficiência de ferro (dieta, gestação, perdas)

Adulto: 1 comprimido (60 mg de ferro) ao dia, 1 h antes ou 2 h depois das refeições; gotas: até 65 gotas ao dia; xarope: 5 mL ao dia

Criança: Gotas: 2 gotas/kg/dia; teto de 15 gotas/dia no lactente e 50 gotas/dia na criança. Xarope acima de 25 kg: 5 mL ao dia

Dose máxima: Conforme a apresentação e a prescrição; tetos pediátricos acima

Contraindicações: Anemias sem deficiência de ferro (hemolítica, falciforme, por chumbo); talassemia; hemocromatose e hemossiderose; hepatopatia aguda; diarreia crônica e retocolite

Interações: Antiácidos e cálcio reduzem a absorção; reduz o efeito de tetraciclina oral e penicilina; quinolonas também precisam de intervalo (ver bula delas)

Gestação e lactação: Categoria A; sem restrição na gestação e lactação com a posologia correta

Conservação: Temperatura ambiente, conforme a bula do produto

No balcão: Fezes escuras são efeito conhecido. Tomar longe de leite e antiácido; se o estômago reclamar, ajustar o horário com o prescritor. Guardar longe de crianças: intoxicação por ferro é grave.

Fonte: Bula de sulfato ferroso (genérico, comprimido, gotas e xarope), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de 2020); enquadramento conforme o módulo de MIP (notificação simplificada)

Tadalafila (Cialis® (referência)). Inibidor da fosfodiesterase 5. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 20 mg (1, 2, 4 ou 8); 5 mg para uso diário em genéricos e outras marcas

Indicações: Disfunção erétil; 5 mg diário também para sintomas da hiperplasia prostática benigna

Adulto: Sob demanda: até 20 mg antes da relação, efeito de 30 min até 36 h. Uso diário: 5 mg 1 vez ao dia, no mesmo horário

Dose máxima: 20 mg/dia, no máximo 1 vez ao dia

Contraindicações: Uso de nitratos (isossorbida, nitroglicerina, propatilnitrato); alergia; uso diário não recomendado na insuficiência renal grave

Interações: Nitratos; alfabloqueadores (doxazosina aumentou a queda de pressão); antifúngicos azólicos e antirretrovirais aumentam níveis; rifampicina reduz; álcool em excesso: tontura e hipotensão postural

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C, protegido da luz, do calor e da umidade

No balcão: Tomar com ou sem alimento. O efeito longo não autoriza nova dose no mesmo dia. Conferir uso de nitrato antes de dispensar.

Fonte: Bula do Cialis® (Eli Lilly do Brasil) e de tadalafila 5 mg (genérico), reproduzidas em consultaremedios.com.br (versões de 2024 e abr. 2025)

Tansulosina (Secotex® (referência)). Alfabloqueador uroseletivo. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido de liberação prolongada 0,4 mg (30); genéricos em cápsula 0,4 mg

Indicações: Sintomas urinários da hiperplasia prostática benigna

Adulto: 0,4 mg 1 vez ao dia, com ou sem alimento, engolido inteiro

Dose máxima: 0,4 mg/dia (bula do Secotex®)

Contraindicações: Alergia; história de hipotensão ortostática; insuficiência hepática grave; uso com inibidor potente do CYP3A4 (ex.: cetoconazol)

Interações: Cetoconazol (contraindicado); eritromicina e outros inibidores moderados (cautela); outros alfabloqueadores e inibidores da PDE5 (hipotensão)

Gestação e lactação: Não indicado para mulheres

Conservação: 15 a 30 °C

No balcão: Não partir nem mastigar. Levantar devagar da cama e da cadeira; tontura ao ficar em pé pede sentar ou deitar. Pode alterar a ejaculação.

Fonte: Bula do Secotex® (Boehringer Ingelheim do Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de maio 2024)

Tramadol (Tramal® (referência)). Analgésico opioide (agonista fraco com ação serotoninérgica e noradrenérgica). *Controle especial · A2 (adendo: até 100 mg por unidade em Receita de Controle Especial, retida)*

Apresentações: Cápsula 50 mg; gotas 100 mg/mL; injetável 50 mg/mL (ampolas de 1 e 2 mL)

Indicações: Dor moderada a grave

Adulto: Acima de 12 anos: 50 a 100 mg por dose (1 a 2 cápsulas ou 20 a 40 gotas); efeito de 4 a 8 h

Criança: A partir de 1 ano (gotas): 1 a 2 mg/kg por dose (4 a 8 gotas por 10 kg)

Dose máxima: 400 mg/dia; criança 8 mg/kg/dia ou 400 mg, o que for menor

Contraindicações: Intoxicação por álcool, hipnóticos ou outros psicotrópicos; IMAO nos últimos 14 dias; epilepsia não controlada; substituto na abstinência de opioides

Interações: IMAO, ISRS e outros serotoninérgicos; benzodiazepínicos, álcool e outros opioides; carbamazepina e ondansetrona reduzem o efeito

Gestação e lactação: Uso crônico na gestação pode causar abstinência no recém-nascido; consultar o médico

Conservação: 15 a 30 °C; gotas válidas por 6 meses após abertas

No balcão: Retenção da receita. Orientar sonolência, náusea e constipação; nunca associar álcool ou calmantes sem o médico saber.

Fonte: Bula do Tramal® (Grünenthal), texto reproduzido em Consulta Remédios, consulta out. 2026; Portaria SVS/MS 344/1998, lista A2 e adendos

---

Valaciclovir (Valtrex® (referência)). Antiviral (pró-fármaco do aciclovir). *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimido 500 mg (10 ou 42)

Indicações: Herpes-zóster, herpes simples (tratamento e supressão), prevenção de CMV após transplante

Adulto: Zóster: 1 g de 8/8 h por 7 dias. Herpes simples: 500 mg de 12/12 h por 3 a 5 dias (episódio inicial, 5 a 10 dias). Herpes labial: 2 g de 12/12 h por 1 dia. Supressão: 500 mg 1 vez ao dia

Criança: A partir de 12 anos, dose de adulto para herpes simples

Dose máxima: Zóster: 3 g/dia; CMV pós-transplante: 8 g/dia

Contraindicações: Alergia a valaciclovir ou aciclovir

Interações: Cimetidina e probenecida (sem ajuste necessário pela bula); micofenolato; outros fármacos nefrotóxicos ou de eliminação renal

Gestação e lactação: Dados limitados; só se o benefício justificar, com orientação médica (vale também para a lactação)

Conservação: 15 a 30 °C, na embalagem original

No balcão: Iniciar nos primeiros sintomas e manter boa hidratação. Na insuficiência renal, a dose é menor: conferir a receita de idosos.

Fonte: Bula do Valtrex® (GlaxoSmithKline Brasil), reproduzida em consultaremedios.com.br (versão de abr. 2025); fora da IN 360/2025

Varfarina (Marevan®). Anticoagulante oral antagonista da vitamina K. *Venda sob prescrição*

Apresentações: Comprimidos 2,5 mg, 5 mg e 7,5 mg (varfarina sódica)

Indicações: Prevenção e tratamento de trombose venosa e embolia pulmonar; prevenção de embolia na fibrilação atrial e em próteses valvares

Adulto: Início com 2,5 a 5 mg/dia; manutenção usual 2,5 a 10 mg/dia, sempre ajustada pelo TP/RNI

Contraindicações: Gestação; sangramento ativo; 24 horas antes ou depois de cirurgia ou parto; aborto incompleto; doença hepática ou renal grave; hipertensão grave não controlada; endocardite bacteriana; aneurisma cerebral ou aórtico; hemofilia; úlcera digestiva ativa

Interações: Aumentam o efeito: AAS e AINE, amiodarona, fluconazol, miconazol, metronidazol, sulfametoxazol-trimetoprima, ciprofloxacino, eritromicina. Diminuem: vitamina K, inclusive de saladas verdes. Qualquer remédio novo, inclusive de venda livre, exige conferir com o médico

Gestação e lactação: Contraindicada (teratogênica). Não foi detectada no leite; bebê amamentado deve ser observado quanto a manchas e sangramentos

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C, protegido da umidade, na embalagem original

No balcão: Fazer o exame de RNI nas datas marcadas. Manter a alimentação estável, sem mudanças bruscas no consumo de verduras. Para dor, evitar AAS e anti-inflamatórios; sangramento de gengiva, urina escura ou manchas roxas devem ser avisados ao médico

Fonte: Bula de Marevan® (Farmoquímica), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 16/04/2025

Zolpidem (Stilnox®, Stilnox® CR). Hipnótico não benzodiazepínico (agonista do receptor GABA-A). *Controle especial · B1*

Apresentações: Comprimidos revestidos 10 mg; liberação prolongada (CR) 6,25 mg e 12,5 mg; outras formas conforme o fabricante

Indicações: Tratamento de curta duração da insônia

Adulto: 10 mg (ou 12,5 mg CR) imediatamente antes de deitar, dose única, sem repetir na mesma noite. Acima de 65 anos ou debilitado: 5 mg (ou 6,25 mg CR)

Dose máxima: 10 mg/dia (liberação imediata); 12,5 mg/dia (CR)

Contraindicações: Alergia ao fármaco; insuficiência respiratória grave ou aguda; insuficiência hepática grave; comportamento complexo do sono prévio; menor de 18 anos

Interações: Álcool, opioides, benzodiazepínicos, antidepressivos sedativos, antipsicóticos e anti-histamínicos: sedação e depressão respiratória

Gestação e lactação: Não recomendado na gestação; afeta o recém-nascido se usado no fim. Evitar na amamentação

Conservação: Conservar entre 15 e 30 °C; comprimido de 10 mg protegido da luz e da umidade

No balcão: Desde agosto de 2024 exige Notificação de Receita B (azul) em qualquer dose. Tomar já deitado e reservar 7 a 8 horas para dormir. Tratamento curto, em geral até 4 semanas; relatar sonambulismo ao médico

Fonte: Bula de Stilnox® (Sanofi Medley), texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, revisão de 28/05/2025. Lista conferida no Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998, Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9/7/2026), sem adendo para o zolpidem

---

Anatomia de uma bula

Parte	Bula do paciente	Bula do profissional
Identificação	Nome comercial, DCB, apresentações, via, USO ADULTO/PEDIÁTRICO, composição	Igual
Indicação	1. Para que este medicamento é indicado?	1. Indicações
Eficácia e mecanismo	2. Como este medicamento funciona?	2. Resultados de eficácia; 3. Características farmacológicas
Quem não pode usar	3. Quando não devo usar este medicamento?	4. Contraindicações
Cuidados	4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	5. Advertências e precauções; 6. Interações medicamentosas
Guarda	5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar?	7. Cuidados de armazenamento
Dose	6. Como devo usar este medicamento?	8. Posologia e modo de usar
Dose esquecida	7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar?	Dentro do item 8, quando houver
Efeitos adversos	8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	9. Reações adversas (por frequência)
Superdose	9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior?	10. Superdose
Dizeres legais	Registro MS, farmacêutico responsável, empresa, CNPJ, SAC, restrição de venda	Igual

Fonte: RDC 47/2009, Anexo I. A bula do paciente não tem os itens de eficácia nem de farmacologia detalhada; a do profissional não tem a pergunta da dose esquecida como item próprio.

Onde está na bula o que o cliente pergunta

Pergunta do cliente	Bula do paciente	Bula do profissional	Embalagem
Serve para o meu problema?	Item 1	1. Indicações	MIP: indicações na caixa
Quanto e de quanto em quanto tempo?	Item 6	8. Posologia e modo de usar	Não
Qual o máximo por dia?	Item 6	8. Posologia (dose máxima)	Não
Posso dar para criança de 2 anos?	Identificação e item 3	Identificação e 8. Posologia	USO ADULTO/PEDIÁTRICO na frente
Posso tomar com meu remédio de pressão?	Item 4	6. Interações medicamentosas	Não
Estou grávida ou amamentando	Itens 3 e 4	5. Advertências e precauções	Às vezes, em frase de alerta
Tomo antes ou depois de comer?	Item 6	8. Posologia e modo de usar	Não
Esqueci a dose, e agora?	Item 7	8. Posologia, quando houver	Não
Isso que senti é do remédio?	Item 8	9. Reações adversas	Não
Meu filho tomou o frasco todo	Item 9	10. Superdose	SAC nos dizeres legais
Guardo na geladeira?	Item 5	7. Cuidados de armazenamento	Lateral: conservação
Quanto tempo dura depois de aberto?	Item 5	7. Cuidados de armazenamento	Às vezes, na lateral
Precisa de receita?	Dizeres legais	Dizeres legais	Faixa e frase de venda na frente
Esse genérico é igual ao outro?	Identificação	Identificação	Faixa amarela; frase do similar intercambiável na bula

Itens da bula conforme RDC 47/2009, Anexo I; embalagem conforme RDC 768/2022, arts. 3º e 5º.

Gotas por mL e concentração nas bulas conferidas

Produto	Concentração	Gotas por mL	Dose usual em gotas (bula)
Novalgina® gotas	500 mg/mL	20	Adulto: 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia
Buscopan® gotas	10 mg/mL	20	Lactente: 10 gotas (5 mg) 3 vezes ao dia
Plasil® gotas	4 mg/mL	21	Adulto: 53 gotas 3 vezes ao dia
Digesan® gotas	4 mg/mL	24	1 a 2 gotas/kg 3 vezes ao dia
Tramal® gotas	100 mg/mL	40 (20 gotas = 50 mg)	Adulto: 20 a 40 gotas por dose
Mucosolvan® gotas	7,5 mg/mL	25 (1 mL = 25 gotas)	2 a 5 anos: 25 gotas 3 vezes ao dia

Valores de cada produto de marca; genéricos e similares podem ter conta-gotas diferente. Conferir sempre na bula do produto entregue.

Orientação a partir da bula

- ◯ Conferir nome, concentração e forma farmacêutica da caixa com a receita ou o pedido
- ◯ Conferir a restrição de idade na face frontal
- ◯ Conferir a frase de venda e se há retenção de receita
- ◯ Confirmar lote e validade, que cubra todo o tratamento
- ◯ Ler o item de posologia da bula do produto entregue, não de outro fabricante
- ◯ Transformar o intervalo em horários reais e escrever na caixa
- ◯ Informar a dose máxima diária e o intervalo mínimo entre doses
- ◯ Explicar a relação com alimentos e com outros medicamentos
- ◯ Mostrar o dosador correto e quantas gotas ou mL por dose
- ◯ Orientar a conservação e o prazo depois de aberto
- ◯ Explicar o que fazer se esquecer uma dose, conforme o item 7
- ◯ Citar os sinais de reação adversa que exigem suspender e procurar atendimento

- ◯ Perguntar sobre gestação, amamentação e outros medicamentos em uso
- ◯ Pedir que o paciente repita como vai tomar

SOS Farmácia Comercial

Cliente volta com problema após usar o medicamento

Cliente relata problema com medicamento comprado ou usado

DECISÃO

Há sinal de gravidade (falta de ar, inchaço de face, bolhas, sangramento, sonolência extrema)?

- **SIM** — Encaminhar de imediato ao serviço de urgência e notificar depois
- **NÃO** — Seguir a avaliação no balcão

DECISÃO

O problema é no corpo da pessoa ou no produto?

- **SIM** — No corpo: suspeita de evento adverso
- **NÃO** — No produto: suspeita de queixa técnica

Evento adverso: conferir na bula se é reação descrita, frequência e conduta

Orientar suspender ou manter conforme o caso e contatar o prescritor

Notificar no VigiMed: paciente, medicamento, lote, evento, datas e desfecho

Queixa técnica: recolher a unidade, guardar embalagem e bula, anotar lote e validade

ATENÇÃO

Separar do estoque as unidades do mesmo lote

Notificar no Notivisa e informar o SAC do fabricante

Registrar a ocorrência no arquivo da farmácia

Cartões: bula, embalagem e bulário

Pergunta	Resposta
Norma que define forma e conteúdo das bulas?	RDC 47/2009, com alterações das RDC 406/2020, 769/2022 e 831/2023.
Quantas perguntas fixas tem a bula do paciente?	Nove, da indicação à superdose.
Em que item da bula do profissional está a dose máxima?	Item 8, Posologia e modo de usar.
Onde a bula do paciente responde sobre dose esquecida?	Pergunta 7.
O que é bula padrão?	Texto modelo para harmonizar bulas; para genéricos e similares, é a bula do referência (RDC 47/2009, art. 4º, VII).
O que mudou com a RDC 831/2023?	Bulas de genérico e similar podem diferir da bula padrão, conforme o registro de cada produto.
O que é a RDC 885/2024?	Projeto-piloto de bula digital; a bula impressa continua garantida a quem pedir.
Prazo para a empresa enviar bula em formato especial?	Até 10 dias úteis após o pedido (RDC 47/2009, art. 41).
Norma vigente de rotulagem de medicamentos?	RDC 768/2022, que revogou a RDC 71/2009.
Frase que identifica o similar intercambiável na bula?	MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA (RDC 58/2014).
O que anotar ao trocar o referência pelo genérico?	A substituição na receita, com carimbo, nome, CRF, data e assinatura (RDC 16/2007, item 2.2).
Sistema para evento adverso a medicamento?	VigiMed.
Sistema para queixa técnica (desvio de qualidade, falsificação)?	Notivisa.
Base legal do dever de notificar do farmacêutico?	Lei 13.021/2014, art. 13, I.
Prazo de uso do Fluimucil® xarope depois de aberto?	14 dias.

Questões: bula, embalagem e farmacovigilância

1. Cliente esqueceu a dose da manhã de um medicamento novo e pergunta o que fazer. Em qual parte da bula do paciente está a orientação específica do produto?

A Pergunta 4: o que devo saber antes de usar

B Pergunta 6: como devo usar este medicamento

C Pergunta 7: o que fazer quando me esquecer

D Pergunta 8: quais os males que pode causar

E Dizeres legais, junto do telefone do SAC

2. Para confirmar a dose máxima diária de ibuprofeno em gotas para uma criança, a fonte mais adequada é:

A o item 8 da bula do profissional do produto dispensado

B a bula do paciente de outro fabricante, já aberta na tela

C a lista de isentos de prescrição, que fixa a dose diária

D a face frontal da embalagem secundária do produto

E o item 2 da bula do profissional, resultados de eficácia

3. Sobre a bula de um medicamento genérico, assinale a correta.

A Deve repetir a do referência palavra por palavra, sempre

B Pode diferir da bula padrão no que o registro aprovou

C Dispensa a lista de excipientes, iguais aos do referência

D É dispensada quando o referência já está no Bulário

E Só entra no Bulário se o genérico não tiver referência

4. Receita de Zyrtec® 10 mg, sem restrição à troca. O cliente pede o genérico. Qual conduta atende à regulamentação?

A Dispensar um similar qualquer, mais barato, sem anotar nada

B Recusar a troca, pois a receita usa o nome de marca

C Dispensar o genérico e anotar a troca, com carimbo e assinatura

D Dispensar o genérico e reter a receita na farmácia

E Dispensar o genérico só após falar com o prescritor

5. Qual frase identifica, na bula, um similar cuja intercambialidade com o referência foi aprovada pela Anvisa?

A Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

B Venda sob prescrição médica, com retenção

C Siga corretamente o modo de usar o produto

D Similar equivalente ao medicamento de referência

E Só pode ser vendido com retenção da receita

6. Atendente encontra duas caixas de desloratadina: uma com a frase de isento de prescrição e outra, do Desalex®, com faixa vermelha. Como proceder?

A Vender as duas sem receita, pois a substância é isenta

B Exigir receita das duas, pois uma delas tem faixa vermelha

C Seguir a categoria impressa na embalagem de cada produto

D Reter a receita apresentada para a compra do Desalex®

E Retirar o Desalex® da venda por rotulagem irregular

7. Na rotulagem vigente de medicamentos (RDC 768/2022), lote, data de fabricação e validade devem constar:

A apenas no texto da bula impressa

B apenas no blíster ou no rótulo do frasco

C somente no código de barras da caixa

D só nos produtos de venda sob prescrição

E nas faces do cartucho, com registro e SAC

8. Mãe relata que a filha de 3 anos ficou com o pescoço torto e os olhos virados depois de tomar gotas de metoclopramida, frasco com USO ADULTO, compradas em outro lugar. A conduta inicial do farmacêutico é:

A dar mais uma dose para aliviar o vômito que persiste

B encaminhar já à urgência e depois notificar no VigiMed

C trocar o frasco por bromoprida em gotas pediátricas

D notificar queixa técnica no Notivisa e liberar a criança

E orientar soro oral e observação da criança em casa

9. Cliente devolve uma caixa de comprimidos manchados e esfarelados, dentro da validade. Qual a conduta correta?

A Descartar a caixa e trocar por outra do mesmo lote

B Notificar no VigiMed como reação adversa ao produto

C Separar o lote e notificar queixa técnica no Notivisa

D Orientar o uso dos comprimidos inteiros que restaram

E Devolver o dinheiro e encerrar o atendimento ali

10. Paciente vai usar budesonida + formoterol spray pela primeira vez. Qual orientação está de acordo com a bula do Symbicort® Spray?

A Guardar o inalador na geladeira depois de aberto

B Usar em até 3 meses após abrir o invólucro de alumínio

C Usar só nas crises, como resgate, sem uso diário

D Furar o frasco no fim para aproveitar o que sobrou

E Guardar o inalador com o bocal voltado para cima

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **C**. A RDC 47/2009 (Anexo I) fixa a pergunta 7 para a dose esquecida. A 4 trata de precauções e interações, a 6 de posologia, a 8 de reações adversas, e os dizeres legais trazem registro, empresa e SAC.
2. **A**. A posologia e os tetos estão no item 8 (Posologia e modo de usar) da bula do profissional (RDC 47/2009). A concentração e o conta-gotas variam entre produtos, por isso vale a bula do produto entregue. A LMIP fixa concentração e indicação, não dose; a face frontal não traz posologia; o item 2 traz estudos.
3. **B**. A RDC 831/2023 alterou o art. 14 da RDC 47/2009 e permitiu diferenças em relação à bula padrão quando houver características aprovadas no registro. Excipientes podem variar e devem constar da identificação; toda bula de medicamento comercializado é publicada no Bulário.
4. **C**. A RDC 16/2007 (Anexo, itens 2.1, 2.2 e 2.4) permite a troca pelo genérico, salvo restrição expressa do prescritor, com registro na receita (carimbo, nome, CRF, data e assinatura) e orientação. Similar só substitui o referência se for intercambiável e listado (RDC 58/2014). Cetirizina não exige retenção.
5. **D**. A RDC 58/2014 prevê a publicação dos similares intercambiáveis, e a frase MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA aparece na Identificação do Medicamento da bula. A frase da Lei 9.787 é do genérico; as demais tratam de categoria de venda e de MIP.
6. **C**. A categoria de venda pertence ao registro. A LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025) inclui a desloratadina, mas a bula do Desalex® consultada ainda traz venda sob prescrição; vale a frase da embalagem (RDC 768/2022). Anti-histamínico não tem retenção e a faixa não indica irregularidade.
7. **E**. O art. 5º da RDC 768/2022 lista, para as demais faces do cartucho, lote, fabricação e validade, registro, empresa, CNPJ, SAC e conservação. A exigência vale para todas as categorias de venda.
8. **B**. Movimentos involuntários sugerem reação extrapiramidal, sinal de gravidade que exige atendimento imediato. A suspeita de evento adverso vai ao VigiMed; o Notivisa recebe queixas técnicas. A bula do Plasil® restringe as apresentações ao uso adulto; trocar por outro antagonista dopaminérgico repetiria o risco.
9. **C**. Desvio de qualidade é queixa técnica, notificada no Notivisa, com a unidade, a embalagem e os dados de lote preservados e o mesmo lote separado do estoque. O VigiMed recebe eventos adversos. Descartar sem registro impede a investigação; a Lei 13.021/2014 (art. 13, I) impõe o dever de notificar.
10. **B**. A bula do Symbicort® Spray manda usar em até 3 meses após abrir o invólucro e conservar a 15 a 30 °C com o bocal para baixo. É tratamento de manutenção, de uso diário, e o enxágue da boca após o uso reduz candidíase oral.